



针灸意外 案例选析

伦新 荣莉 编著

人 民 卫 生 出 版 社

针灸意外案例选析

伦新 荣莉 编著

人民卫生出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

针灸意外案例选析/伦新, 荣莉编著. —北京: 人民卫生出版社, 1997

ISBN 7-117-02733-9

I. 针… II. ①伦… ②荣… III. 针灸疗法-医疗事故-案例 IV. R245

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 11160 号

针灸意外案例选析

伦新 荣莉 编著

人民卫生出版社出版发行

(100050 北京市崇文区天坛西里 10 号)

三河市宏达印刷厂印刷

新华书店经销

850×1168 32 开本 13 印张 355 千字

1997 年 10 月第 1 版 1997 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

印数: 00 001—4 000

ISBN 7-117-02733-9/R·2734 定价: 18.50 元

(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

序

31445/16

针灸疗法是中医学的重要组成部分，由于它适应证广、疗效显著、操作方便，数千年来深受广大群众的欢迎和喜爱。但是，在针灸医疗临床上，若术者操作不慎，或患者配合不当，则不仅会影响其应有的疗效，还会引起意外事故的发生，甚者可危害到患者的健康。余为广东中医医疗事故技术鉴定委员会委员、针灸气功推拿专业组成员，每阅及杂志有关此类报道，无不深感切指揪心之痛，极希望有志之士能将之分门别类、选辑成书，分析其因果，详论其防治，以供医林之借鉴，庶免后人重蹈复辙，实医家之幸事，患者之福音。

伦新、荣莉俩君，均毕业于广州中医药大学，其勤于古训，精于医术，从事针灸临床、教学、科研工作多年。为减少或避免这类不应有的意外事故的发生，特选择了百余种案例。（包括部分推拿意外），编撰成《针灸意外案例选析》，以达到继承和发扬祖国医学遗产，推动针灸医学健康发展的目的。两君之志诚可嘉也！藉此书付梓之际，余欣然为之序焉。

广州中医药大学博士生导师 靳瑞

1996年10月15日

目 录

第一章 概述.....	(1)
一、历史源流.....	(1)
二、针灸意外的成因.....	(5)
三、针灸损伤的分类.....	(7)
四、针灸意外的预防.....	(8)
第二章 头面部腧穴的意外事故	(11)
一、下关穴施术不当致神经损伤	(11)
二、针刺人中穴导致中风患者死亡	(15)
三、针刺人中穴引起神志异常	(18)
四、针刺太阳穴导致脑出血	(21)
五、电针太阳穴致股骨颈骨折	(25)
六、针刺风池穴导致脑出血	(27)
七、针刺风池穴损伤延髓而致死亡	(35)
八、针刺风池穴导致晕针	(37)
九、深刺风府穴导致死亡	(41)
十、针刺风府穴致蛛网膜下腔出血	(44)
十一、深刺风府穴损伤脊髓	(47)
十二、针刺风岩穴致死	(49)
十三、深刺四白穴导致眶周血管出血	(50)
十四、针刺百会穴导致脑出血	(53)
十五、耳穴疗法引起耳部感染	(56)
十六、耳穴贴压引起血压升高	(59)

十七、耳针引起晕针	(61)
十八、针挑舌系带引起败血症	(64)
十九、头部穴位遗针	(67)
二十、针刺哑门穴导致蛛网膜下腔出血	(69)
二十一、深刺哑门穴损伤延髓致死	(74)
二十二、哑门穴药液注射引起严重并发症	(76)
二十三、球后穴注射强的松龙引起过敏反应	(80)
二十四、针刺球后穴导致眼周出血	(83)
二十五、电针颊车穴引起迷走神经反应	(85)
二十六、针刺睛明穴引起眶周出血	(88)
二十七、针刺攒竹穴导致眶周出血	(91)
二十八、针挑眼外角阿是穴引起大脑额叶脓肿	(93)
二十九、激光治疗外眼病引起光针反应	(95)
三十、推拿不当致面部皮肤损伤	(97)

第三章 颈项部腧穴的意外事故..... (100)

一、针刺人迎穴引起迷走神经反应.....	(100)
二、深刺安眠穴导致蛛网膜下腔出血.....	(103)
三、电针安眠穴引起房室传导阻滞.....	(105)
四、电针扶突穴引起迷走神经反应.....	(108)
五、翳风穴位注射导致面瘫.....	(110)
六、针刺翳风穴引起心跳呼吸停止.....	(113)
七、针刺右颈部阿是穴导致感觉丧失.....	(115)
八、针刺不当引起颈总动脉瘤.....	(116)
九、颈项部推拿不当损伤椎-基底动脉系	(118)
十、颈部按摩致腋神经、肩胛上神经损伤.....	(119)

第四章 躯干部腧穴的意外事故..... (122)

一、针刺天突穴引起气胸.....	(122)
二、针刺中府穴导致气胸.....	(128)
三、针刺胸部穴位致气胸.....	(131)

四、针刺缺盆穴导致气胸·····	(136)
五、针刺不当损伤心脏致死·····	(139)
六、针刺不当损伤肝脏·····	(142)
七、针刺不当致胆汁性腹膜炎·····	(145)
八、针刺期门引起主动脉出血致死·····	(150)
九、施术不当致肋间动脉出血·····	(152)
十、躯干穴位拔罐晕罐·····	(155)
十一、针刺腹部膈穴不当造成胃穿孔·····	(157)
十二、针刺不当造成脾破裂·····	(160)
十三、针刺不当引起腹部绞痛·····	(163)
十四、针刺不当致肠穿孔·····	(165)
十五、腹部穴位断针·····	(172)
十六、中脘穴位注射引起晕针·····	(176)
十七、氦氖激光照射发生光针反应·····	(179)
十八、关元穴晕灸·····	(181)
十九、针刺大椎穴导致脊髓损伤·····	(183)
二十、定喘穴针刺不当致气胸·····	(186)
二十一、肩井穴针刺不当导致气胸·····	(189)
二十二、风门穴针刺不当导致气胸·····	(195)
二十三、肺俞穴针刺不当导致气胸·····	(198)
二十四、背部膈穴针刺不当导致气胸·····	(205)
二十五、针刺陶道穴引起脊髓蛛网膜下腔出血·····	(212)
二十六、背部膈穴施术不当导致过敏反应·····	(214)
二十七、消毒不严导致局部感染·····	(217)
二十八、三棱针点刺背部导致皮下血肿·····	(219)
二十九、推拿不当导致肋骨骨折·····	(221)
三十、推拿不当导致腰椎压缩性骨折·····	(223)
三十一、针刺背部穴位导致晕针·····	(225)
三十二、胃俞穴电针折针·····	(228)
三十三、针刺腰骶部阿是穴引起迷走神经反应·····	(232)
三十四、腰阳关穴直接灸导致晕灸·····	(234)

三十五、背部腧穴遗针·····	(236)
三十六、针刺不当损伤肾脏·····	(238)
三十七、推拿不慎致腰部皮肤损伤·····	(240)
三十八、推拿不当导致休克·····	(241)
第五章 四肢腧穴的意外事故·····	(246)
一、针刺肩髃穴导致晕针·····	(246)
二、曲池穴操作不当导致过敏性反应·····	(249)
三、曲池穴位注射不慎损伤桡神经·····	(254)
四、推拿不当导致肩关节脱位·····	(257)
五、曲池穴注射地塞米松感染致死·····	(260)
六、郄门穴注射丹参液引起过敏反应·····	(262)
七、针刺内关穴引起迷走神经反应·····	(265)
八、内关穴施术不当导致正中神经损伤·····	(268)
九、针刺内关穴引起暴瘡·····	(272)
十、外关穴位封闭导致桡神经损伤·····	(274)
十一、列缺穴施术不当致桡神经损伤·····	(276)
十二、神门穴施术不当导致尺神经损伤·····	(278)
十三、神门穴注射氯丙嗪引起手指坏死·····	(281)
十四、针刺合谷穴引起迷走神经反应·····	(284)
十五、合谷穴施术不当导致手部畸形·····	(286)
十六、针挑合谷穴引起动静脉瘘·····	(291)
十七、三棱针点刺八邪穴引起伤口感染·····	(293)
十八、推拿不当致前臂骨折·····	(295)
十九、四肢腧穴施术不慎致晕针·····	(297)
二十、针刺手背折针·····	(300)
二十一、针刺四缝穴引发感染·····	(303)
二十二、针刺不慎引起再度脑出血·····	(305)
二十三、环跳穴位注射引起坐骨神经损伤·····	(307)
二十四、环跳穴位注射引起经络不良反应·····	(311)
二十五、臀部深刺引起臀上动脉破裂出血·····	(313)

二十六、下肢腧穴施术不当导致过敏反应·····	(315)
二十七、推拿不当导致股骨干骨折·····	(318)
二十八、下肢穴位注射不当导致肢端坏死·····	(322)
二十九、足三里穴施术不当致腓神经损伤·····	(326)
三十、委中穴放血导致晕针·····	(331)
三十一、膝部穴位施术不当致晕针·····	(333)
三十二、阳陵泉穴位注射不慎损伤腓总神经·····	(335)
三十三、阳陵泉穴折针·····	(338)
三十四、深刺涌泉穴引起中风患者死亡·····	(340)
三十五、经期针刺三阴交穴引起阴道大出血·····	(343)
附录 常用腧穴简易定位法·····	(348)
一、手太阴肺经常用穴·····	(348)
二、手阳明大肠经常用穴·····	(351)
三、足阳明胃经常用穴·····	(354)
四、足太阴脾经常用穴·····	(362)
五、手少阴心经常用穴·····	(365)
六、手太阳小肠经常用穴·····	(367)
七、足太阳膀胱经常用穴·····	(370)
八、足少阴肾经常用穴·····	(381)
九、手厥阴心包经常用穴·····	(384)
十、手少阳三焦经常用穴·····	(387)
十一、足少阳胆经常用穴·····	(390)
十二、足厥阴肝经常用穴·····	(396)
十三、任脉常用穴·····	(399)
十四、督脉常用穴·····	(404)

第一章 概 述

针灸疗法是祖国医学遗产的重要组成部分。是以中医理论为指导，运用针刺与艾灸防治疾病的方法。是我国劳动人民在长期与疾病作斗争的过程中创造和发展起来的。它具有适应证广、简便经济、疗效显著等特点。据有关资料统计，目前本法已能用来治疗临床上常见的三百多种疾病，对其中某些病症的疗效非常显著。为解除广大人民群众疾苦，为中华民族的繁衍昌盛，作出了巨大的贡献。故几千年来本法深受人民大众的欢迎，成为防治疾病的一种重要手段。

但是，任何事情都是一分为二的。尽管针灸术是比较安全且无毒副作用的，为其他药物疗法所不及。然而，如果针灸临证施治不遵循一定的条件，那么极易出现许多意想不到的情况，这就是所谓“针灸意外”。轻者会给病者遗留一时的不适，增加痛楚；重者则能导致病者终身残疾，甚至立毙人命。鉴于如此严重的后果，努力防止各种针灸意外的发生（包括推拿意外），已逐渐成为各级医生应予高度重视的问题。

一、历史源流

对于针灸的各种意外情况，历代医家都十分重视。他们在大量的临床实践中，对针灸意外已经有了比较深入和全面的认识，积累了许多预防和处理的经验。这对我们学习、掌握针刺意外的发生原因、处理方法和预防等有着很重要的意义。

针灸禁忌在我国中医学典籍——《黄帝内经》中已有颇为详

细的记载，这方面的论述约有 20 余篇，内容较丰富。大致包括病证的禁忌、局部的禁忌、身心方面的禁忌和时间的禁忌等，为后世针灸学的发展奠定了基础。例如，《素问·刺禁论》中讲：“刺中心，一日死，其动为噫。刺中肝，五日死，其动为语”。又说：“刺头中脑户，入脑立死”。这些论述说明古代医家在大量的临床实践中已认识到，刺伤重要的脏器，将可导致病者的死亡。又例如，《灵枢·终始》中讲：“凡刺之禁，新内勿刺，新刺勿内。已醉勿刺，已刺勿醉。……已饥勿刺，已刺勿饥。已渴勿刺，已刺勿渴。大惊大恐，必定其气，乃刺之”。以上记载说明患者不良的情绪状态和机体状态也可导致针灸意外。总之，《内经》的许多论述至今仍有很大的参考价值，对临床了解针灸意外、判别其性质、估计预后、预防其发生等都起到指导作用。

汉代张仲景编撰的《伤寒杂病论》是一部以药物治疗为主的临床医学专著，但是其中也提及一些由于误用火针、艾灸温针不当所致的烦躁、惊狂、咽燥、吐血等并发症，如“烧针令其汗，针处被寒，核起而赤者，必发奔豚”（121 条），这对后世医家有着重要的警示作用。

晋代皇甫谧编撰的《针灸甲乙经》，在总结前人经验基础上提出 36 个禁止针灸的腧穴和部位，为后世研究针灸禁忌开辟了道路。此外，该书还细致的描述了针刺不当造成感染的事故以及后果，如“脐中，神阙穴也……禁不可刺，刺之令人恶疡溃矢出者，死不治”。“渊腋……不可灸，灸之不幸，生肿蚀，马刀伤，内溃者死”。

晋唐时期，许多医家都提倡灸法，这原因之一可能与针具拙劣、消毒乏术、缺乏解剖知识和针灸意外发生较多且后果严重有关。但是，这时期的医家们已开始注意到对针刺意外的积极预防和处理。如防止针刺感染，强调“凡针手足，皆三日勿洗也”，特别是“合谷穴，针后尤慎洗手”（《千金要方·卷二十九》），针对因误伤较大血管血出不止的情况，提出各种急救措施，如“刺舌下两边大脉，血出，勿使刺著舌下中央脉，血出不止杀入”。而一旦遇到血流不止，则可以“烧铁篦令赤……以绝血也”（《千金要

方·卷六上》)。

到宋代，由于针灸意外严重威胁患者的健康和生命安全，医者与病者之间的纠葛也逐渐引起官方的关注，并将其列为法医验尸立罪的一项内容。如宋代著名法医宋慈，在其所著的《洗冤集录·卷之四》中所说：“针灸死，须勾医人验针灸处，是与不是穴道，虽无意致杀，亦须说‘显是针灸杀’，亦可以科医不应为罪”。这一方面说明宋代已开始从法律的高度对针灸意外进行处理，另一方面也说明那时的各种严重的针灸事故较为多见。从而进一步引起医家们的注意，并告诫人们应正确取穴，掌握准确的操作方法，以预防死亡事故的发生。

自金元直至明清，针灸界对针灸意外的认识和体会更加深入。如早期的文献中，只提及胸肩部的某些穴位可刺伤至肺，而在《普济方·卷四百十一（针灸门）》中则明确指出：“胸前诸穴不可伤，伤即令人闷倒。”对于一些临床常见的针灸意外，他们也很重视其救治处理。如对针灸临床中发生率最高的一种意外——晕针，无论是其发生的原因和处理措施都作了全面的探讨。关于晕针的原因，阎明广的《流注指微针赋注》认为：“或匆忙之际，畏刺之人，多感此伤，壮者气行自己，怯者当速救疗”。而在具体的处理上，《金针赋》云：“其或晕针者，神气虚也，以针补之，口鼻气回，热汤与之，略停少顷，依前再施”。总之，后世针灸医家们除了继承古人经验，结合自己或他人的实践经验，对针灸意外的防治作了许多补充和发展。

自1949年建国以来，针灸医学得到了空前的发展，接受针灸治病的人数越来越多，治疗范围越来越广，基础理论和治疗机理的研究也愈益深入，这为针灸的发展提供了广阔的天地。但是，随之而来的由于操作不当而造成各种针灸意外也明显增多。据不完全统计，自50年代迄今，公开报道的针刺意外所致的各类损伤已达800余例之多，而且还存在有大量未作公开发表事故。因此，对之应该引起足够的警惕和重视。一般而言，现代国内所报道的针灸意外，大致有以下3个特点：①涉及脏器较多。因针灸意外导致的损伤几乎涉及全身各个系统，造成后果较为严重的是中枢

神经系统和重要脏器（如肺、心、肝、胆、脾、胃、肾等）的损伤，其中以针刺造成蛛网膜下腔出血、气胸和胆囊穿孔为最多见；②新种类的意外增加。从 50 年代以来，新的穴位刺激法层出不穷，使针灸治疗中又增加不少新种类的意外。如电针治疗仪常导致针具电解、电蚀而发生折针事故；水针疗法的应用，使得近几十年来针灸所致的化学性损伤（这种损伤可涉及血管、肌肉、神经等）大为增加；一般安全性较高的激光针疗法在近几年来也陆续发现一些病人出现各种不良的反应；耳针疗法因消毒不严，而使病人常出现严重的耳软骨膜炎或耳软骨炎，等等；③重视防治规律的探索。自从 50 年代以来，针对不断发生的各种针灸意外，已有不少学者撰文提出其预防和处理的方法，并为此做了大量的工作。如为了防治气胸，从解剖学的角度对成人和小儿胸背部肌肉的厚度进行测定，以确定进针深度，阐述了针刺引起气胸的病理学基础，以及依据临床治疗学提出包括重度、轻度气胸，血气胸，水气胸的内、外科治疗方案，等等。

针灸事故在国外也不少见，美国、英国、法国、澳大利亚、日本、俄罗斯等国都有报道。尤其是日本，由于它使用针灸疗法的时间很长，针灸流派众多，造成的各种意外也就非常多，所以日本针灸界对此也十分重视。《医道の日本》社曾将该刊发表过的有关气胸、折针和猝死的文章汇集成册，且于 1978 年出版，题名为《针灸过误——气胸、折针、猝死》。总的来说，国外所发生的针灸意外，种类上大致和我国类似，但尚有自己的特点：①继发感染出现率高。包括因继发感染引起的骨髓炎、败血症等，而以针刺过程中传播病毒性乙型肝炎最常见；②折针发生率高，尤以日本为最，这大概与日本针灸医家常使用的表面镀银的毫针容易折损有关；③重视实验研究。例如在日本即做了许多有关折针的实验研究（包括电针过程中针的电解、电蚀实验，人工折针的动物实验等）。瑞士学者通过对医源性肝炎的发病规律进行调查后，指出污染的针具可成为感染乙型肝炎的原因。这些工作为针刺意外的预防和处理提供了科学的依据，很值得我们借鉴。

二、针灸意外的成因

针灸意外的临床表现比较复杂，其致成的因素也不尽相同，有的是术者的原因（如技术水平较低，或失于疏忽，或工作责任心不强等），有的是患者的原因（如病人的心理素质、生理状态、病理因素等），从而造成被针灸者机体的意外损伤。一般来说，其主要原因如下：

针刺过深 一般来说，每个腧穴的针刺深浅都是确定的，如果处理不当，不仅会影响疗效，而且还会发生种种意外。《素问·刺要论》说：“病有浮沉，刺有浅深，各至其理，无过其道”。这说明针刺的深浅要根据病者的具体情况并结合穴位所在局部的解剖学特点来决定，灵活掌握。否则，就会造成“过之则内伤，不及则外壅，壅则邪从之。浅深不得，反为大贼，内动五藏，后生大病”（《素问·刺要论》）等不良后果。因此，临床应根据病位深浅、病程长短、病情轻重、疾病性质、年龄体形、脉象虚实、时令节气、腧穴位置等具体情况，决定每一穴位针刺的深浅。

消毒不严 由于一切病原微生物都能引起严重的疾病，危害人体的健康，而在自然环境中细菌又无处不有。人体表面及人体与外界相通的腔道和医疗器械中同样存在细菌。因此，在针灸临床进行具体操作时，必须注意对皮肤、粘膜、器械等进行必要的消毒和灭菌。但是，当今针灸界还有不少医生对消毒和灭菌重视得不够，忽视针具、穴位、医者手指、针具传送过程等4个环节的消毒，结果使病人感染上各种疾病，给他们的健康带来危害。故针灸时必须严格消毒，这点在目前仍有非常重要的意义。消毒和灭菌的方法很多，其具体内容详见后文。

责任心不强 无论做什么事情，都应该具有高度的责任感，特别是针灸医师，一针甫下，不仅能起死回春，也能够毁人于一旦。这一生一杀，全在医生手下。此非危言耸听，本书在以下各章节均有详细的介绍。因此，应该充分认识到毫针虽小，但责任重大，持针操作务必谨慎从事。正如《素问·针解篇》所言，针灸医师施术时应该“手如握虎者，欲其壮也，神无营于众物者，静志观

病人，无左右视也”。其意思是说医师手持毫针，应该把它看作是逮着一只老虎一样，坚定有力而不胆怯，要专心致志观察病人，而不应去注意周围其他事情，否则极易发生各种针灸意外。

手法操作不当 一般来说，凡是选择要施术的穴位或部位，术者首先应当熟悉正常脏器的生理及其解剖位置，必要时应根据病史做相应的检查。同时，在针刺过程中，要正确使用押手，它可以固定穴位，减轻针刺疼痛。但押手使用过紧则易使肌肉凹陷，体表与深部组织或器官之间的距离也相应缩短，特别是胸腹背腰等部，即使用短针或浅刺有时也可以伤及脏器。另外，有的脏器如胃、肠、膀胱等若仅被毫针轻刺激一下后能马上退出，那么损伤则较轻，一般可自行愈合，不致造成严重后果；但如果毫针刺入脏器后，再加反复捻捣，乱插乱提，使其损伤面积加大，程度加深，则后果也就严重了。此外，如果术者操作手法太强，万一患者不堪忍受，不慎移动体位，也足以造成意外。

针具选择不当 在我国古代，针具有9种之多，它们各不同形、各有所宜。如锋针用于放血，铍针用于切割脓疡，圆针用于按摩等。近代，针灸临床一般多用毫针针刺，浅刺用短针，深刺使用长针或芒针，随穴选针，适得其所。但操作时用针太短，深度不够时则不易得气，收不到应有效果。若用针过长控制不好时，则容易刺伤脏器而造成意外。另外，穴位注射选择药液的浓度不当，若浓度过高或刺激性较大，常易导致组织损伤。

患者因素 要完成一项医疗工作，在某些方面是需要病者配合的，针灸治疗更是如此。针灸临床上发生的一些意外，有的是纯属于病者本身的因素所造成。如紧张、恐惧或情绪过分激动等心理因素，饥饿、劳累等生理因素，体质虚弱、大病之后或过敏体质等身体因素，某些脏器因病变而导致体积增大、表面粗糙或组织结构变疏松而易被针具误中等病理因素，以及操作过程中病人体位的突然急剧变动等，这些方面都属于患者本身的原因所致意外。

三、针灸损伤的分类

临床上的针灸意外，大部分应属于医疗事故。就其本质而言，都系针灸所致的损伤。主要包括神经、血管、肌肉、脏腑等损伤，针刺导致晕厥、感染、针刺后遗症等。一般均可分为下列4类：

反应性损伤 在针灸过程中，由于病人心理状态不稳定，饥饿，疲乏，体质过敏等，或由于针灸刺激量过大，时间过长等引起患者一系列机体功能紊乱，常包括晕针、晕灸、晕罐、过敏反应、癔症样反应、激光反应等。目前尚不清楚其本质的经络反应（循经出现的变化、经络皮肤病等）也应归属于此类。

物理性损伤 由于针刺、艾灸、推拿等使用不当，过强的物理刺激（机械刺激或温热刺激）作用于机体，引起组织或器官的解剖完整性的破坏，称为物理性损伤。鉴于目前临床上普遍采用隔物灸，直接灸很少使用，因温热刺激造成的物理性损伤报道不多。而拔罐时间过长，虽可出现水泡等现象，但对机体损伤不大。故物理性损伤中最普遍、危险最大的应是机械性损伤。针刺、推拿造成的机械性损伤的特点是，从损伤后至临床上出现相应症状的时间一般不太长，其因果关系易于确定，且严重程度与所损伤的脏器、肢体有关。一般而言，以损伤中枢神经组织和重要脏器的后果最为严重，往往会导致死亡。

化学性损伤 在针灸治疗过程中，由于在穴位中注射某些化学药物而导致的机体组织的损伤称为化学性损伤，它是伴随着穴位注射疗法的开展而出现的。由于注射部位的不同，大体上可分为3种，即软组织损伤（多发生于前臂和手部的穴位，可造成手的畸形和功能障碍）、周围神经损伤（常见有桡神经、尺神经、正中神经和胫神经损伤）、血管损伤（以血栓性脉管炎的发生率最高）。导致化学性损伤的原因，除术者操作不当外，往往与所注射的药液密切相关，包括药液的性质、酸碱性、浓度和剂量大小等，其后果的严重程度虽不及机械性损伤，但因发生率高，加之近年来不断有新药应用于穴位注射，故对此类损伤切不可掉以轻心。

生物性损伤 它主要是指针刺引起的继发性感染。即通过针

具（毫针、皮肤针、三棱针、穴位注射针头等），将病原微生物带入患者机体内所导致的损伤。一般这类损伤可分为两种，一是针具本身消毒不严，将外界的致病菌带入病者的机体而引起感染，如各种化脓性感染及由此导致的败血症、脓毒血症等；一是通过未经严格消毒的针具将其他病者体内的病原微生物传播给被针者，针具结果成了传播媒介，其中以传播病毒性乙型肝炎最常见（也最危险）。另外，尚有通过针具移植包虫的报道，这种情况较少见。

除了上述4种损伤外，还有一些是属于间接的损伤，如针刺诱发脑出血。虽然不是直接原因，但针灸至少是一个诱因，亦当引起注意。

最后要指出的是，在临床实践中，这几种损伤既可以单独发生，也可以合并发生，因此不仅使造成的后果更为严重，且给诊断和处理带来困难，更应高度警惕。

四、针灸意外的预防

对针灸意外，重点在于预防，现将其要点概述如下，以供同行们参考。至于具体的预防和处理方法，将在后面章节中详细叙述。

加强责任心 不少针刺事故的发生，经常与医务人员的责任心不强、粗心大意有关。所以加强医者的责任心，提高自身的医德修养，树立全心全意为人民大众服务的思想，时刻保持冷静头脑，谨慎处理每一个病人，是尽量减少针灸意外发生的有效措施。

提高业务水平 不断提高针灸医师的医学专业水平，对预防针灸事故有着决定性的意义。一个业务素质较高的针灸医师，不仅仅局限于有较深的针灸及中医学造诣，还须具有现代医学的多方面知识，如必须熟悉人体的解剖情况，了解每个穴位的局部解剖，从而选择出恰当的针刺深度和方向；必须掌握病理学知识，了解某些脏器在病理状况下可能出现体积增大、游动度减小、脆性增加等变化，熟悉它们在病变时的特点和位置，从而避免被毫针误中而引起无法弥补的后果；还必须具有药理学知识，掌握穴位

注射药物的药理、药性和剂量，尽可能避免或减少化学性损伤等。

严格注意消毒 针刺的消毒，一般应包括术者的双手、针具及病者的穴区。临床上应建立起严格的消毒和检查制度，加强针灸操作时的消毒观念，彻底杜绝因消毒不严而导致的各种意外事故。临床常用的消毒方法如下表：

消毒物品		消毒法或消毒剂	浓度	时间	备 注
人 体	手	来苏儿	2%	5 分钟	目前针灸临床上常用的是剪除指甲、洗刷，然后用 75% 酒精棉球拭擦
		酒 精	75%	5 分钟	
		升 汞	1 : 1000	5 分钟	
		新洁尔灭	1 : 1000	5 分钟	
	局部皮肤粘膜	碘 酊	2%		刺激性强，干后即 用 75% 酒精擦去， 此法针灸临床常用
		龙胆紫	0.5%~1%		
		红 汞	2%		
		硫柳汞	1 : 1000		
手术室	空 气	紫外线	15 瓦	20 分钟	针灸临床常用
		甲醛蒸汽			
		苍术、艾叶烟熏	1 两/每 3 米 ³		
常用器械、物品	针灸针、手术刀、剪、缝线等	加压蒸汽或煮沸			被消毒物品应用 纱布包裹，针灸临 床常用
		溶液浸泡新洁尔灭、来苏儿器械液（石炭酸 20 毫升，甘油 26 毫升，95% 酒精 26 毫升，碳酸钠 10 克，加水至 1000 毫升）	1 : 1000 纯	浸 泡 1 小时 以 上	针灸科常用

续表

消毒物品	消毒法或消毒剂	浓度	时间	备 注
玻璃、瓷、搪瓷制品等	加压蒸汽或煮沸			针灸临床常用
塑料有机玻璃制品	甲 醛	10%	浸泡 4 小时	使用前用消毒盐水反复冲洗，针灸临床常用
橡胶类制品	加压蒸汽或煮沸			时间不宜过长，以免影响质量
布单、敷料	加压蒸汽			灭菌后 2 周内有效，针灸临床常用
缝线	加压蒸汽或煮沸 甲 醛	20%	浸泡	棉、丝线品只宜消毒一次，以免失去坚韧性，针灸常用
外用生理盐水	加压蒸汽或煮沸			

遵循操作常规 医者在施术前要注意检查针具的情况、药液的质量；针刺时，要精心体会腧穴每一解剖层次的手感，动作宜轻柔，严禁乱捣猛插，有重要脏器部位更应谨慎，并随时观察病人的神态表情；同时坚决杜绝隔衣进针的操作，因为这样不仅容易引起感染，而且不易正确取穴及掌握针刺方向和深度，极易造成意外的发生。

病人要注意配合 针灸治疗的成功，除了与术者的关系很大之外，在某些方面还需要病人的密切配合。例如，病人应调节好自己的心理状态，消除紧张、恐惧的情绪；避免在劳累、饥饿、烦躁、紧张、大病后马上进行针灸；针灸前尽量取舒适的体位，施术过程中不得随意变动体位等，这些都能减少针灸不良反应的发生机会。

第二章 头面部腧穴的意外事故

分布于头面部的腧穴，占着人体腧穴相当大的比重，它们不仅疗效显著，而且取穴亦方便，所以在临床上的使用频率很高。但是，由于各种各样的原因，如术者医学基础不牢固，对腧穴的解剖结构认识不足，或腧穴的定位不准确，或操作时针刺方向、深度、刺激量等的错误，结果在临床实践中导致不少意外事故的发生，给病者造成不同程度的损害或后遗症。其中，以中枢神经系统（包括脑和脊髓两个部分）的损伤占着相当大的比重，后果也最为严重。而这两者中又以脑损伤为主。一般情况下，大脑为颅骨所保护，对成年人来说针刺不易直接伤及，但在某些部位操作时施术不当，则是可以直接刺伤血管或脑组织的，从而导致蛛网膜下腔出血、小脑及延髓损伤等；或者是针刺作为一种间接性损伤，导致脑出血等。因此，对于这些较为严重的针灸事故，我们必须引起足够的重视。此外，头面部腧穴的意外事故，较常见的还有针刺损伤局部的一些神经干、支，导致神经组织受伤。下面介绍几个较常见的案例。

一、下关穴施术不当致神经损伤

【案例1】

某—女性，50岁。1984年7月5日来诊。患者1周前因右侧牙周红肿疼痛，并Ⅱ度松动，故需给予拔牙治疗。常规消毒患侧下关穴后，术者先用2.5寸毫针刺入该穴行针刺麻醉，得气后继续捻针时，病人右下牙槽及口唇均有触电样麻木感，3分钟便顺利

拔除病牙，但病人右侧面部麻木感仍持续 1 星期未消失。遂前来求诊。检查：上述部位活动尚可，但感觉迟钝。考虑为针刺不当引起下颌神经麻痹。即取同侧大迎、地仓穴，轻刺，每次留针 5 分钟，每天 1 次，5 天后麻木消退^[1]。

【案例 2】

术者采用下关穴注射无水酒精的方法，治疗 20 例下颌神经痛，结果有 3 例患者出现下颌神经运动支麻痹，6 例患者出现下颌神经运动支感觉减弱，另外各有 1 例出现面部烧灼感和面部麻木感^[2]。

【案例 3】

马××，女，30 岁，教师。主诉：右颜面口眼喎斜 5 天。患者因右颞下颌关节疼痛、张闭口障碍、关节弹响 2 月余，被某医生予以氢化可的松 2 毫升加 2% 普鲁卡因 2 毫升混合后，用 6 号注射针头在下关穴处行穴位注射，针刺时患者感右面部灼样疼痛，注射药液时疼痛难忍，拔针后右面部仍觉灼样疼痛，右眼不能闭合，面出现口眼喎斜。经中西药物治疗 4 天，症状无改善而来诊。检查：右额纹消失，右眼裂增大，右眼睑不能闭合，流泪，右鼻唇沟漫平，人中沟、唇颊沟左偏，右口角下垂，舌体左偏，舌前 1/3 味觉消失，右颞颌关节区压痛（+），关节周围肌群压痛（+），张口、咀嚼受限，右面部轻度肿胀，皮肤触觉减退。考虑为面神经麻痹。

予患者口服维生素 B₁、ATP，肌注维生素 B₁₂、加兰他敏，静脉滴注抗生素、能量合剂等，治疗 1 月余，面瘫症状有所好转，右颞颌关节压痛减轻，开口度约 1 横指，仍有弹响。改用针灸、理疗及内服中药等治疗 40 余天，右颞颌关节疼痛消失，弹响消除；右面瘫症状明显好转，但后遗患侧眼裂缩小，上眼睑轻度下垂，鼻唇沟加深，右面肌轻度萎缩^[3]。

【案例 4】

作者曾治疗一位 38 岁女教师，因左颞部跳痛反复发作 2 年多，每次发作时疼痛持续 2~5 分钟，开始时隔数天发作 1 次，近几个月来几乎每日发作 10 次左右，其诱因可能是咀嚼、嗽口、洗

脸、吹风等。曾在多家医院诊治，疗效未显。就诊后以针刺为主，穴取率谷、太阳、下关、合谷等，治疗 10 次后症状减轻。但最后一次用 2.5 寸长毫针全部刺入下关穴，当时其自感有火烧样剧痛，而出针后即感张口困难，左侧根本不能嚼物，经休息 3 天之后始能张口，咀嚼也逐渐恢复。

【分析】

根据现代解剖学资料得知，在下关穴处分布有三叉神经的下颌神经和面神经的颧支。三叉神经为第 5 对脑神经，离开脑桥臂后立即膨大，形成三叉神经节并由此发出三大分支，自颞孔穿出的分支为下颌神经，它分出运动纤维至咀嚼肌，分出舌神经至舌，传导舌的痛觉及温热感觉；该神经的感觉纤维在头面部的分布范围，一般自口裂以下。而面神经为第 7 对脑神经，从脑桥和延髓之间出脑，穿过颅底的骨管，出颅后转向前，穿过腮腺，呈放射状分为 5 个分支（额支、颧支、颊支、下颌缘支、颈支）至面部表情肌。当在下关穴处施术不慎时，极易导致此两对颅神经的损伤。案例 1、4 提示由于术者操作不当，针刺深度过大，导致下颌神经纤维的直接损伤，这种情况临床上较少见。而较常见的类型是案例 2、3，在施行穴位注射时，由于术者选择的药物刺激性较强，在药液的压迫或所产生的理化作用下，导致三叉神经或面神经的损伤。

【临床表现】

一侧三叉神经的下颌神经完全性损伤，主要表现为患侧的咀嚼肌瘫痪，舌的痛觉及温热感觉减弱或消失等。

一侧面神经的损伤，主要表现为额纹消失，不能闭眼，鼻唇沟变浅，不能鼓腮和吹口哨，口角偏向健侧等表情肌瘫痪症状，有些可有舌前 2/3 味觉障碍、泌泪和泌涎障碍等。

【处理方法】

1. 针灸疗法：针刺法，按循经取穴和局部取穴相结合的方法。下颌支损伤者可选取局部的上关、大迎、地仓、夹承浆等，颧支损伤者可选取局部的下关、颧髂、太阳、地仓等，并均可配合远端的合谷、外关等穴，手法一般用轻刺激，留针或不留针，亦可

加用脉冲电刺激（中、弱刺激 15~20 分钟），每天 1 次，10 次为 1 疗程。艾灸法，可用艾条施行温和灸，以患侧局部为主，每次以皮肤充血潮红为度，每天 1~2 次。

2. 理疗：超短波治疗，每日 1 次，每次 15 分钟；或红外线照射局部，每日 1 次，每次 10~15 分钟。尚可用新斯的明离子透入（以 1:2000 新斯的明 1~2 毫升放于正极），每日或隔日 1 次，10 次为 1 疗程。

3. 药物治疗：中药，按熄风、活血、通络之法，用牵正散（白附子、僵蚕、全蝎）加天麻、钩藤、川芎、生地、生甘草等，水煎服，每日 1 剂；或舒筋活络片口服，每次 3 片，每天 3 次；或小活络丸口服，每次 1 丸，每天 2 次。西药，维生素 B₁100 毫克、B₆50 毫克肌注，每日 1 次；或口服维生素 B₁、B₆、B₁₂，辅酶 A 及三磷酸腺苷等；或强的松 5 毫克，每日 1~3 次。

4. 治疗期间可作局部的热敷、按摩，并配合功能锻炼，以助早日康复。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：由三叉神经第 3 支（下颌神经）分布。

2. 皮下组织：内有下颌神经、面神经颧眶支以及面横动、静脉。颧眶支由腮腺上缘穿出，横过横骨，支配眼轮匝肌下部、颧肌及提上唇肌。面横动脉是颞浅动脉的分支，向前穿腮腺面过，横过咬肌表面；面横静脉为下颌后静脉的属支。

3. 腮腺：略呈三角形，其实质内有面神经丛，耳颞神经，颞浅动、静脉，上颌动、静脉等穿过。

4. 咬肌：位于下颌支外侧的皮下，分为浅、深两层纤维，共同止于下颌支外面的咬肌粗隆，受三叉神经的下颌神经分支咬肌神经支配。

5. 颞肌后方与下颌切迹：颞肌起自下颞线和颞筋膜深层的深面，止于下颌骨的冠突，由下颌神经的分支颞深神经支配。下颌切迹是下颌骨冠突与髁突之凹陷。

6. 上颌动、静脉：上颌动脉为颈外动脉分支之一，上颌静脉为下颌后静脉的属支。

7. 翼外肌：位于颞下窝内，由下颌神经的分支翼外肌神经支配。

8. 深部是下牙槽神经、舌神经和脑膜中动脉。

【操作要点】

临床在下关穴施术时，一般要注意以下几个方面：首先，应做好术前准备。术者要熟悉面神经、三叉神经主干及主要分支的分布部位，以及下关穴的局部层次解剖；根据病情合理选用治疗方法。针刺所用毫针多以28号为主，穴位注射所用针头以4号或5号齿科针头为多，而火针、三棱针等刺激方法是不宜使用的。其次，要小心操作，切勿为了获得较好的得气感而在神经干上反复提插探寻，或者进针过深。当病人出现穴区疼痛、发热及上通下达之触电感时，立即将针上提少许，待此类现象消失后，再行手法或注入药物。最后，本症多因穴位注射不慎引起（针刺损伤的情况较少见），故为了减轻药物的理化性刺激，应尽量避免使用药物浓度过高或过低、刺激性太大、酸碱度过高的药物，多选择些浓度适中、刺激性较小、酸碱度接近中性范围的药物。同时，还应避免将药物注入神经干而引起直接损害。

二、针刺人中穴导致中风患者死亡

【案例】

某一女性患者，47岁。其丈夫代诉：患者有高血压史数年，4日前突发中风，出现肢体偏瘫，口角喎斜。证见面色潮红，舌质红而少苔，头晕头痛，舌强，语言不清，四肢抽搐，脉弦细长，血压24.0/16.0千帕（180/120毫米汞柱）。此为阴虚肝旺，水不涵木，风生于经。治拟滋阴潜阳、平肝熄风、活络化痰。方以天麻钩藤饮配九转还魂丹、苏合香丸、生姜汁汤并服。连服3天后，诸症悉减，神志渐清，语言略出，建议其转脑内科进一步诊治，并再三嘱其家属，暂勿施针刺疗法。转诊后第2天上班时，病者家属来门诊，诉说昨晚某朋友来看望病者，并自告奋勇给予针刺以助康复，穴取人中等，结果当刺入该穴不久，病者心跳突然停止，

抢救无效而死亡^[4]。

【讨论】

根据临床实验得知，针灸对人体血压的影响具有双向性的调整作用，即原血压水平较高者针灸有降低血压之功，原血压水平较低者针灸有升高血压之效。这种作用与病者本身的状况有着密切的关系。而针刺升高血压的内在机制，许多学者都认为可能是由于针刺的强烈刺激通过相应穴位传入神经，将冲动传至中枢（主要是脑干网状结构），然后通过植物神经，尤其是交感神经的兴奋，反射性地引起内脏、平滑肌、皮肤血管的收缩，使外周阻力增加，以致血压升高。对于脑血管意外的病者，这种效应会更加明显，如果施术的时机、手法不适当时，极易再次引起中风，严重者将导致死亡。本案例病者经服用天麻钩藤饮等处理后，神志渐清，语言略出，提示其病情已有转机，但尚未稳定。此时若用针灸疗法并无不可（最好是暂时不用），但手法一定宜轻，刺激量要弱，不能用针感较强的穴位和刺激过强的手法，以防在某种情况下促使再次中风。而那位医生正好相反，不仅选取人中等人体最敏感的穴位（实验已证明人中穴有明显的升压效应），而且给予较重手法，使病者血压急剧升高，在原有脑血管病变尚未修复的情况下，导致再次中风且最终死亡。

【临床表现】

本病多出现在针刺过程中或针后不久。一般典型证候为：起病突然，常有头痛、呕吐、抽搐、昏迷、大小便失禁、呃逆等，可伴有高热、四肢软瘫。体征见：血压骤然升高，瞳孔不等大，对光反射、角膜反射减弱或消失，颈硬有抵抗，面肌、舌肌瘫痪，偏瘫，肌张力降低，偏身或交叉性感觉障碍，腹壁反射、提睾反射减弱或消失，腱反射先消失后亢进，同时出现病理神经反射，并有视网膜出血、视乳头水肿。

【处理方法】

1. 保持安静，尽量减少对病者不必要的搬运。躁动者可予以适当镇静剂；血压过高者，可肌注利血平 1 毫克，使血压维持在 20.0~21.3/12.0~13.3 千帕（150~160/90~100 毫米汞柱）之

间；持续低流量吸氧。

2. 降低颅内压：可选用 20% 甘露醇或 25% 山梨醇 250 毫升快速静滴；速尿 20~40 毫克溶于 50% 葡萄糖液 20~40 毫升中静脉推注；10% 甘油葡萄糖 250~500 毫升静滴。上述脱水剂和利尿剂可交替使用，每 6~8 小时使用 1 次为宜。

3. 降温疗法：一般用冰块或冰帽作头部局部降温为主，这样可降低脑代谢率和耗氧量，有利于减轻脑水肿及脑细胞功能的恢复。

4. 防治并发症：注意保持病者呼吸道的通畅，防治胃出血、褥疮、尿道感染和循环功能紊乱等并发症。

5. 维持营养及水、电解质和酸碱平衡：昏迷病者可先禁食 1~2 天，从静脉内补充营养和水分，每日总量 1500~2000 毫升为宜；以后如无呕吐或消化道出血，可酌情开始鼻饲，并随时注意补充电解质、维生素、脑细胞功能活化剂，及时纠正酸碱平衡失调等。

6. 中医治疗：用中药，若闭证可鼻饲至宝丹或苏合香丸，脱证可用参附龙牡汤或独参汤。用针灸，闭证可取涌泉、内关、太冲、曲池、十二井穴等，脱证取关元、神阙、足三里、气海等穴；耳针疗法，可选取耳尖、心、肝、肾、皮质下、相应肢体；水针疗法，穴位选取与体针相同，药物常用当归注射液、复方丹参注射液、田七注射液、维生素 B 族注射液、胞二磷胆碱针剂等。

7. 手术治疗：本法目的在于清除血肿，降低颅内压，缓解脑疝的形成，改善脑部血液循环。因此，当出现脑部手术适应证时，应尽早施行手术。但对高龄、生命体征不稳定、出血部位在丘脑及脑干、脑疝晚期、血压过高未经控制、高热、严重消化道出血或内脏疾病、血压下降过速或休克者，均不宜进行手术治疗。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：由眶下神经分布。眶下神经是三叉神经第 2 支（上颌神经）的终支，经眶下孔穿出至面部，分布于下睑、鼻背外侧及上唇皮肤。

2. 皮下组织：内有上述神经和上唇动、静脉。上唇动脉是面

动脉走至近口角处发出的分支，上唇静脉是面静脉的属支。

3. 口轮匝肌：位于口裂周围的口唇内，上至外鼻，下至颏结节的上方，为椭圆形的扁肌，受面神经的颊支和下颌缘支支配。

【操作要点】

为了预防中风病者针刺人中穴后出现再中的意外事故，术者在操作时要注意几个方面：首先，应谨慎选择病者，除了急救必须急用外，对血压过高且不稳定的有动脉硬化史的病者，尤其是有中风史者，一般应暂勿针刺之，待血压平稳、病情稳定后，再施行针灸疗法。其次，宜注意操作，对于中风病者，针灸时以仰卧位为最佳，穴位的选择要少而精（尽量少用人体较敏感的穴位，如人中、涌泉、十二井穴等），避免进针疼痛（对初次接受针灸或情绪易于波动、有畏惧心理者，针前应多作解释，以消除其思想负担）；施术时手法不可过重过强烈，一般以轻、弱刺激为宜，可间断依法行针数次，留针时间宜短些（10～15分钟左右）；出针时要用干棉球压迫针孔片刻，既可避免穴位出血，又可通过局部按摩来减轻其痛感。最后，在施术过程中，应严密观察病者的反应，若有异常情况，则马上给予处理。

三、针刺人中穴引起神志异常

【案例1】

郝××，女，42岁，干部，于1970年7月12日就诊。患者素体健康，此次为劳作不慎，将腰闪挫，查其腰部活动受限外，余无异常。当即予以针刺人中治疗，进针约0.2寸左右，施行持续的平补平泻捻转，约15分钟后患者即可以正坐，但开始发笑。随即停止手法的操作，嘱其起身活动腰部，患者却置之不理，并大笑不止。再施行强刺激捻转手法约10秒钟，患者笑声仍大发不绝，涕泪皆流，全身震动不已，不能坐稳。故即刻起针，但笑如前，直至半小时后，才从大笑转为低声微笑，继面喜形于色，逐渐平静，前后共计1小时许。之后询问患者，自诉：心中明白，只是想笑^[3]。

【案例2】

— 32 岁男性工人，因与他人口角，心情不畅，饮酒后在家里人睡，至深夜欲饮水时，发现其目直口呆，舌强难言，急得全身汗出而欲言不能。往诊医生给予针刺人中穴后，随即见患者口角出现颤动约 1 分钟许，接着出现不省人事，牙关紧闭。来诊时证见面色基本正常，表情淡漠，舌强不语，牙关紧闭，四肢稍强，舌尖红，苔厚腻，脉弦滑，血压为 16/13 千帕，无偏瘫征。此乃精神刺激，加上饮酒伤肝，肝气郁滞，气壅心胸，清窍不宜，属气厥症。即取四关穴（合谷、太冲），配内关、承浆穴，并外用乌梅擦牙。针后患者牙关松缓，能自述病情，但语言欠流利，吐音亦不清楚。下午复诊，诸症同前，再试针其人中穴，口唇痉挛复作，从而证实昨晚厥证乃因针刺人中所致。得知刺人中之弊后，改用他穴及药物治疗而愈^[6]。

【分析】

根据案例 1 的病情来看，拟是针刺诱发的一种癔症发作，又称“歇斯底里”，是常见的神经症的一种。考虑该病者在疼痛、不适等躯体因素下，由于针刺人中穴（强刺激），引起其疑惧，精神紧张而为本病发生提供了自我暗示的基础，从而出现狂笑不止等类似严重精神病的精神运动性兴奋。当然，针刺诱发癔病发作的原因及其发病机理，仍需进一步探讨。从中医学的角度认为，人中为督脉的腧穴，而督脉是循行于脊里，入络于脑，与脑有密切联系的。故施术不当时，就会导致大笑不止等情志病变。

案例 2 的原作者认为针刺人中有强烈的抑制作用，稍给予捻转，病者则会有强烈的感受，若遇到精神过度紧张，即可引起头颈部肌肉痉挛。国外 Rogers 也提到这种现象，他说“在治疗肌肉痉挛时，在痉挛部位强烈捻转和电刺激，可能造成更严重的痉挛。此时应停止刺激，给予按摩，使痉挛停止。”根据现代解剖学，人中穴处分布有眶下神经（即为三叉神经第 2 支的终支），支配着咀嚼肌的运动功能，加上穴位深部的口轮匝肌，当针刺本穴刺激过强时，将会激起神经反射性肌肉痉挛或肌肉强烈的反射性收缩，从而出现口唇痉挛、牙关紧闭等症。而意识、运动的轻微障碍，这与病者因受强烈的精神刺激，加上饮酒、针刺等诱发因素，导致

癔症的发作有关。

【临床表现】

癔症在临床上表现多种多样，可以模仿任何疾病，主要表现为4方面：

1. 感觉障碍。约17.9%的病人可有不按解剖学分布的感觉缺失区（这与正常感觉区之间界线非常明显），亦可出现皮肤虫爬、麻木、针刺、疼痛等感觉异常。

2. 运动障碍。约33.4%的病人表现为肢体瘫痪，全身性抽搐发作、肢体震颤、多动、舞蹈症等运动异常亦颇多见。

3. 植物神经和内脏功能障碍。约4.5%的病人可有厌食、呕吐、呃逆、尿频、尿闭、肠痉挛或麻痹、假孕等症状。

4. 精神障碍。约28.4%的病人表现为情感爆发（具有尽情发泄及表演特点）、意识障碍（昏睡、木僵或朦胧状态）或精神病状态（如精神运动性兴奋、短暂幻觉、妄想等）。

至于厥证则是一种证候，以突然昏倒、不省人事，或伴有四肢逆冷为主要表现的一种病证，可见于多种疾病之中。现代医学中的休克、中暑、低血糖昏迷，以及精神性疾病等出现厥证表现者均可归属之。

【处理方法】

本病呈发作性，一般持续时间不长，躯体症状如不经及时治疗，可持续数年甚而终生不愈。但总的来说，病者各种症状虽未经治疗，也有60%~80%在病后的不长时间消失。

1. 心理治疗：以解释性心理治疗配合暗示治疗，对大多数病人可取得良好疗效。

2. 针灸治疗：针灸的常取穴位为素髻、内关、百会、十宣、合谷、太冲等，可用针刺或灸法；尚可用耳针，取皮质下、肾上腺、内分泌、交感、心、肝、神门等。

3. 中药可按疏肝解郁、理气止痉之法组方，亦可以逍遥散加减。

4. 西药治疗：可适当给予硝基安定、奋乃静、氯丙嗪等口服。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：由眶下神经分布。
2. 皮下组织：内有眶下神经和上唇动、静脉。
3. 口轮匝肌：椭圆形扁肌，受面神经的颊支和下颌缘支支配。

【操作要点】

人中穴是人体针感较强烈的腧穴之一，因此施术时多选择仰卧位，治疗时要求以轻刺激为主，当患者有局部酸、麻、胀痛感时，一般应停止再继续施术（急救时除外），留针约 20 分钟左右后出针；出针时宜用干棉球按压针孔片刻，并轻轻按摩局部，以减轻其强烈的痛感。

四、针刺太阳穴导致脑出血

【案例】

某男性患者，59 岁，退休干部。有高血压病及左侧偏瘫史。此次再突发脑卒中，经住院治疗 21 天，病情稳定后出院。出院后继续在门诊行针灸治疗，第 1、2 次针后感觉良好，无特殊不适。第 3 次，在针刺太阳等穴位过程中，患者有头晕、出冷汗、胸闷等感觉，拔针后随即出现呕吐（均为胃内容物），约半小时左右进入昏迷状态，大小便失禁，四肢厥冷，3 小时后由急诊收入住院。

体格检查：体温 39℃，血压 25.3/16.0 千帕（190/120 毫米汞柱），脉搏 92 次/分，呈深昏迷，潮式呼吸，有明显的心律不齐。双侧瞳孔不等大，左瞳孔直径 3 毫米，右瞳孔直径 1.5 毫米，对光反射迟钝。双侧巴氏征阳性。急诊腰穿为均匀血性脑脊液。

入院后马上施行脑内血肿简易穿刺引流术，放出鲜红性液 25 毫升，并置硅胶管一根，继续引流，5 小时后又引出血性液体 10 毫升。术后第 2 天又引流出少量血性液，经气管切开、鼻饲、补液支持、脱水、细胞活化剂、控制感染等综合治疗，其病情仍不断恶化。术后第 3 天，仍有陈旧性血液不断流出，双眼球浮动。术后第 4 天，终因呼吸、循环衰竭而死亡^[7]。

【分析】

针灸对血压的升高具有明显的作用。其途径主要是通过相应

的穴位传入神经，将冲动传至中枢（最重要的是脑干网状结构），然后通过植物神经，尤其是交感神经的兴奋，反射性地引起某些小血管的收缩，外周阻力增加，心肌收缩功能加强，而使血压不断升高，加上垂体后叶加压素、抗利尿素和肾上腺皮质激素可能继发地参与作用，进而加强与巩固升压的效应。对于脑血管意外的患者，当针刺人体某些敏感腧穴时，这种升压效应更明显。本例慢性高血压病人，一般来说，在其大脑内外囊、小脑和皮质下白质——中央卵圆孔等部位内，直径50~150微米的穿通动脉（如豆纹动脉）管壁常会发生脂肪玻璃样变（纤维素样坏死）而形成微动脉瘤，这些穿通动脉以垂直方向从主干分出，在变成网状的前毛细血管前不发出分支，很容易直接受到血压波动的影响而破裂。一支小动脉破裂出血压迫周围组织引起邻近穿通动脉管壁坏死变性和破裂出血，汇聚成血肿，脑组织局部出血及血肿形成则引起脑水肿、脑组织受压、推移、软化和坏死等。当脑出血破入脑室系统或脑组织因肿胀，自大脑镰下嵌向对侧或经天幕孔向下嵌压脑干时，将导致脑干缺血、出血和坏死，这常是脑出血的致死原因。本例即是因针刺不当，引起患者的血压过度升高，导致其脑血管破裂而死亡的。

【临床表现】

起病突然，常有头痛、呕吐、抽搐、昏迷、大小便失禁、呃逆等，四肢软瘫，发热或高热；重者则呕吐咖啡样物，大汗淋漓，甚或四肢强直抽搐。

体征：体温升高，脉率增快，血压增高，有潮式呼吸。颈硬有抵抗，瞳孔不等大，对光反射、角膜反射减弱或消失，或见共同偏视。肢体、面肌及舌肌瘫痪，肌张力降低，偏身或交叉性感觉障碍，腹壁反射及提睾反射减弱或消失，腱反射先消失后亢进，同时可出现病理神经反射，视网膜出血及视乳头水肿等。

辅助检查：①周围血象检查：白细胞多在1.5~2.0万/立方毫米，中性白细胞升高，伊红细胞减少；血糖及非蛋白氮增加；②脑脊液多为血性，且压力增高；③脑超声波可显示中线波移位；④脑血管造影可有大脑中动脉移位；⑤头颅CT检查提示出血，水肿及

脑移位。

不同部位出血的症状如下：①内囊及基底节附近的出血：头与眼球偏向出血侧，病灶对侧出现三偏症状（即偏瘫、偏身感觉障碍及偏盲），或可出现失语；②桥脑出血：初起面神经及对侧肢体呈交叉性瘫痪，头眼偏向瘫侧，其后迅速昏迷，四肢呈痉挛性瘫痪，瞳孔缩小如针状，可有高热及呼吸循环衰竭等；③小脑出血：症见眩晕、头痛和频繁呕吐，轻者水平性眼震，共济失调，同侧肢体肌张力降低及腱反射消失，重者昏迷，颈项强直，脉缓，四肢肌张力降低，呼吸循环衰竭。

【处理方法】

1. 防止再出血：保持安静，尽量减少对病者不必要的搬运，躁动者可予以适当镇静剂；调整血压，过高者可肌注利血平 1 毫克（日总量不得超过 3 毫克），将血压维持在 20.0～21.3/12.0～13.3 千帕为宜；亦可根据具体情况短期使用止血药（但目前临床应用中尚有争议），如 6-氨基己酸或抗血纤溶芳酸。

2. 降低颅内压：可选用 20% 甘露醇或 25% 山梨醇 250 毫升快速静滴；速尿 20～40 毫克溶于 50% 葡萄糖液 20～40 毫升中静注；利尿酸钠 25 毫克静脉推注；10% 甘油葡萄糖 250～500 毫升静滴。上述脱水剂和利尿剂可交替使用，每 6～8 小时使用 1 次为宜。

3. 降温疗法：一般以冰水或冰帽作头部局部降温，这样可降低脑代谢率和耗氧量，有利于减轻脑水肿及脑细胞功能的恢复。

4. 防治并发症：注意保持患者呼吸道通畅，防治褥疮、胃出血、尿道感染和循环功能紊乱等并发症。

5. 维持营养及水、电解质和酸碱平衡：昏迷病者可先禁食 1～2 天，从静脉内补充营养和水分，每日总量 1500～2500 毫升为宜；以后如无呕吐或消化道出血，可酌情开始鼻饲，并随时注意补充电解质、维生素、脑细胞功能活化剂，及时纠正酸碱平衡失调等。

6. 中医治疗：若闭证可鼻饲至宝丹或苏合香丸，脱证可用参附龙牡汤或独参汤。针灸治疗，闭证可取人中、涌泉、太冲、内

关、曲池、丰隆、十二井穴，脱证取关元、神阙、足三里、气海等；耳穴可选取耳尖、心、肝、肾、皮质下、相应肢体。尚可配合穴位（同体针）注射，药物常选当归注射液、丹参注射液、田七注射液、维生素B族、胞二磷胆碱等。

7. 血肿穿刺引流：若无开颅手术条件，可行颅骨钻孔血肿穿刺引流术。

8. 手术治疗：本法目的在于清除血肿，降低颅内压力，缓解脑疝，改善脑血液循环。故当出现手术适应证时宜尽早施行手术，但对高龄患者、生命体征不稳定、出血位于丘脑及脑干、脑疝晚期、血压过高未经控制、高热、严重消化道出血或内脏疾病、血压下降或休克者，均不宜进行手术治疗。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：由颧面神经分布。颧面神经是三叉神经第2支（上颌神经）的分支，分布于颊部皮肤。

2. 皮下组织：有上述神经和颧浅动、静脉。颧浅动脉是颈外动脉的终支之一，是颈外动脉在下颌高度向上的直接延续，分支营养腮腺及额、顶、颧部的肌肉和皮肤。颧浅静脉与同名动脉伴行，位于皮下，注入下颌后静脉。

3. 眼轮匝肌：位于眼裂周围的皮下，为椭圆形扁肌，受面神经的颧支和颧支支配。

4. 颧筋膜：起于上颧线，呈坚韧强厚的腱膜状，覆盖于颧肌的表面，向下分深、浅两层，深层止于颧弓的深面，浅层止于颧弓的浅面，两层之间填有脂肪组织。

5. 颧肌：为颧窝皮下一块扇形扁肌，起自下颧线和颧筋膜深层的深面；肌纤维逐渐向下集中，通过颧弓深面止于下颌骨的冠突。颧肌由三叉神经第3支（下颌神经）的分支颧深神经支配。

【操作要点】

为了预防针刺太阳穴导致脑出血的意外事故，术者在操作时要注意以下几个方面问题。首先，应谨慎选择病者，每次施术前要测量血压，对血压过高且不稳定的有动脉硬化史的病人，尤其是有中风史的病人，一般应尽量不用该穴，待血压平稳、病情稳

定后，再选用它。其次，要注意本穴的操作要点：对于中风病人，针刺时可取正坐位或侧卧位，而以后者为多用；避免进针时的疼痛，对初次接受针灸或情绪易于波动、有畏惧心理者，施术前应多作解释，以解除其思想负担；针刺深度为0.5~1寸，多用直刺法，得气后手法不可过重过强烈，一般以轻、弱刺激为宜；出针时可用消毒干棉球压迫针孔片刻，这样既可避免穴位出血，又可通过局部按摩来减轻其酸胀痛感。最后，在施术过程中，应严密观察病人的各种反应，若有异常情况，则应给予及时处理。另外，太阳穴尚可使用三棱针点刺出血的方法，但在中风急性期宜慎用。

五、电针太阳穴致股骨颈骨折

【案例】

某一男性，为慢性精神分裂症患者，40岁，10多年来一直被锁在家中。1979年入精神病疗养院，予氯丙嗪150毫克口服，并电针神聪、安眠等穴，但仍见兴奋不安。后某天改针太阳穴，电流强度为50毫安，通电约3秒钟后仍吵闹不已，3分钟后又重复如上操作1次。半分钟后突然出现全身痉挛发作，持续35秒钟意识才逐渐恢复。但是治疗后患者行走不便，髋部有轻压痛，3天后经X线片证实为因痉挛而造成股骨颈骨折^[8]。

【分析】

股骨颈骨折是指股骨头下至股骨颈基底部的骨折，临床上大多好发于老年人。由于老年人骨质疏松，股骨颈脆弱，故轻微的直接或间接外力，如平地跌倒、床上跌下或下肢突然扭转等，即可引起骨折。按其损伤机制一般可分为内收骨折和外展骨折两大类。本案例患者虽然年龄尚轻，但由于患有慢性疾病，被禁锢在家10多年，体质虚弱，骨质较疏松。在长时间电针治疗的刺激下，病人不堪忍受，刺激过强而引起肌肉（全身）强烈的反射性收缩，全身发生痉挛，对股骨颈产生剪力作用，最终造成股骨颈骨折。正如与使用胰岛素或电休克一样，有时可以产生骨折和牙断等情况。因此，电针突然刺激引起肌肉痉挛而导致股骨颈骨折的现象，即

使临床上较为少见，亦应引以为戒。对久病体弱的患者，针灸治疗时要注意刺激量，尽量吸取这种教训。

【临床表现】

一般说来，对于任何一位中年以上的人，无论受伤外力如何，如在伤后感觉髌部疼痛，大粗隆处有压痛，下肢呈外旋位置，即应考虑股骨颈骨折。即使患者仍能站立，或缓缓步行，也不应除外股骨颈骨折，宜进行X线或CT检查。典型的表现为患肢内收外旋、膝关节轻度屈曲畸形（这是股骨颈骨折的主要体征之一），患者仰卧时患足倒向外侧，局部疼痛多不严重，绝大多数患者在伤后都出现下肢功能障碍。

【处理方法】

1. 一般治疗。用长木板置于患肢外侧或后面，用绷带固定后再搬运。

2. 外展型骨折无明显移位或有嵌顿时，可行持续皮肤牵引。牵引时，患肢中立位外展 30° 角，牵引重量约3~4公斤。8~12周后开始下床扶双拐活动，骨折愈合后离拐负重行走。

3. 内收型或有明显移位时，可行三翼钉内固定术，术后皮肤牵引3~6周，3个月后可扶双拐下地行走，半年后离拐行走。

4. 功能锻炼。整复固定后即应让患者加强全身锻炼，多鼓励患者作深呼吸运动，患侧踝、趾关节可自由活动，逐步做股四头肌锻炼，但不能随便翻身和坐起盘腿。并注意预防因长期卧床而发生的肺部感染、泌尿系感染及褥疮等。解除固定后，可用海桐皮汤薰洗。在床上进行患肢肌肉、关节的不负重锻炼，主要是髌、膝关节的屈伸活动，但要避免髌内翻和外旋。待骨折愈合后，方可离床下地逐步负重行走。

5. 药物治疗。本病的药物治疗甚为重要，因初期瘀血滞留影响骨痂生长和会合，故以破瘀生新为主，如活血祛瘀汤加三七粉；中后期除用大量接骨丹外，还必须注意补肾壮骨、益肝续筋，宜予骨质增生丸或健步壮骨丸。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：由颧面神经分布。颧面神经是三叉神经第2支（上

颌神经)的分支,分布于颊部皮肤。

2. 皮下组织:有上述神经和颞浅动、静脉。颞浅动脉是颈外动脉的终支之一,是颈外动脉在下颌高度向上的直接延续,分支营养腮腺及额、顶、颞部的肌肉和皮肤。颞浅静脉与同名动脉伴行,位于皮下,注入下颌后静脉。

3. 眼轮匝肌:位于眼裂周围的皮下,为椭圆形扁肌,受面神经的颞支和颧支支配。

4. 颞筋膜:起于上颞线,呈坚韧强厚的腱膜状,覆盖于颞肌的表面,向下分深、浅两层,深层止于颧弓的深面,浅层止于颧弓的浅面,两层之间填有脂肪组织。

5. 颞肌:为颞窝皮下一块扇形扁肌,起自下颞线和颞筋膜深层的深面,肌纤维逐渐向下集中,通过颧弓深面止于下颌骨的冠突。颞肌由三叉神经第3支(下颌神经)的分支颞深神经支配。

【操作要点】

此案例因电针引起肌肉痉挛而导致股骨骨折的现象,在针灸临床上极为罕见的,但术者还是应该给予注意。对于体质虚亏、患病多年的病人,在施行针灸治疗时,应遵从以下两个原则,一是取穴要少而精,二是刺激要轻,少用针感强烈的穴位。若是使用电针刺激时,输出电流宜由小到大(切忌大电流),使之慢慢适应。

六、针刺风池穴导致脑出血

【案例1】

一患者,男性,17岁,农民。患者因头晕头痛10余天,于1970年9月14日在本村卫生室诊治,该医生给予针刺治疗,穴取风池等。进针后患者当即晕倒于床上,出现呕吐,自觉颈项强痛。在家休息数日,因头痛不止并伴喷射性呕吐,被其家属送至县人民医院诊治,经腰穿为血性脑脊液而转来我院。患者既往每年夏季有头晕头痛史。查体:神清,血压16.0/9.3千帕(120/70毫米汞柱),颈强,克氏征(+),余无异常。拟诊为蛛网膜下腔出血。住

院后经卧床休息，给予镇静、止血、降颅压、抗感染等治疗，11天后病情明显好转，症状基本消失，故准许患者带药回家继续治疗^[9]。

【案例 2】

一患者，男性，23 岁，工人。因头痛反复发作 20 余天，症状时轻时重，服药打针效果不好，于 1970 年 6 月 3 日在厂卫生所作两侧风池穴针刺治疗，针后患者即感颈项疼痛，头不能扭转，并有短暂意识丧失，随后有恶心呕吐。后曾在当地医院诊治 5 天，因头痛呕吐不止伴发烧转入我院。患者既往健康，入院后查体：颈项强硬，克氏征（+），余未见异常。眼底检查正常。6 月 11 日腰穿检查，脑脊液为淡红色，白细胞 11 个，红细胞未计数，潘氏（-），脑脊液生化检查正常。拟为蛛网膜下腔出血。住院期间低烧 4 天，随后体温恢复正常。经卧床休息、镇静止血、抗感染等治疗，症状逐渐消失，住院 14 天出院^[9]。

【案例 3】

某男，30 岁，工人。患精神分裂症 7 年，久治不愈。于 1978 年 5 月 13 日入院。曾于 5 月 12 日下午约 3 时半在本厂医院行针刺治疗，取双侧风池穴斜向中线进针，留针期间病人自行将右侧的针向深部刺入，未被医生及时发现。30 分钟后拔除右风池穴针时，病人尖叫一声，并诉右眼发亮了--下，1 小时后出现频繁呕吐、呃逆，晚上 8 时出现昏迷，约 11 时 40 分转至医院急诊手术。颈枕部正中切口，寰椎椎板减压，切开硬膜，发现枕大池蛛网膜右上方有一小孔，有血性脑脊液外溢。切开蛛网膜见有血肿 2 毫升，色尚鲜，已凝结，延髓受压，小脑也呈水肿。清除血肿后，硬膜外置橡皮引流一条，关颅，并输血 600 毫升。手术后用抗生素、激素、脱水、止血药等治疗，半天即清醒。2 天拔除引流管，8 天后拆线，创口一期愈合，精神症状也见好转，6 月 29 日出院^[10]。

【案例 4】

一患者，女，30 岁。入院前 7 小时，因患神经性头痛，在当地医院诊治并行针刺治疗，穴取风池为主，进针后当即出现剧烈头痛，伴有恶心呕吐。腰椎穿刺脑脊液呈深粉红色，压力 150 毫

米水柱。即送我院住院。入院检查：神志清楚，体温 36.4℃，脉搏 100 次，血压 14.7/8.0 千帕（110/60 毫米汞柱），颈稍强直，克氏征（±），颅神经、感觉、运动反射未见改变，未引出病理反射。诊断为蛛网膜下腔出血。经卧床休息及对症治疗，7 天后做腰椎穿刺，脑脊液呈黄色透明，压力 130 毫米水柱。21 天后痊愈出院^[11]。

【案例 5】

一患者，男，20 岁。因患神经性头痛，针刺风池穴后突然头痛加重而收住院。检查：神志清楚，体温 36.3℃，脉搏 60 次，血压 17.3/10.7 千帕（130/80 毫米汞柱），眼底正常，颅神经、感觉、运动及反射正常，未引出病理反射，克氏征阳性，颈部抵抗。腰椎穿刺：脑脊液呈浅红色，压力 180 毫米水柱。诊断：蛛网膜下腔出血。入院后经卧床休息及给予安络血、维生素 K 等药物治疗，头痛逐渐好转，颈强减轻，双侧克氏征阳性。7 天后腰椎穿刺，脑脊液呈浅黄透明，压力 130 毫米水柱。13 天后脑膜刺激症状消失，痊愈而出院^[11]。

【案例 6】

王××，女性，19 岁，学生。于 1970 年 11 月 8 日因双视力差来院治疗，经针刺双风池穴 1 小时后出现剧烈头痛、恶心、呕吐而入院。体检：急性病容，神志清，血压、脉搏、体温均在正常范围，呼吸 26 次/分，心音纯，心律齐，心率 64 次/分，双肺正常，颈项强直，巴氏征及克氏征（—）。化验：白细胞 13600/立方毫米，中性白细胞 87%，淋巴细胞 13%；尿蛋白（+），尿糖（++）；腰穿脑脊液呈血性，压力 2.57 千帕（262 毫米水柱），红细胞 26850/立方毫米。诊断：外伤性蛛网膜下腔出血。治疗：抗生素、止血、镇静、能量合剂等对症疗法，20 多天后复查脑脊液正常，症状消失痊愈出院^[12]。

【案例 7】

某女，30 岁，1976 年 6 月 19 日入院。因眼睑肌抽动施行针刺治疗，取穴风池，当进针 1.6 寸时病人自诉头痛难忍，继则呕吐，立即拔针送至本科。查体：16.0/10.7 千帕（血压 120/80 毫米汞柱），体温 37.4℃，神清语明，内科方面未见异常，眼底正常，

项强 4 指，克氏征（+）。针刺后 4 小时做腰穿，脑脊液外观为均匀一致的血性，压力 2.56 千帕（260 毫米水柱）。临床诊断：蛛网膜下腔出血。经镇静、止痛及止血治疗，14 天痊愈出院^[13]。

【案例 8】

某女，40 岁，工人，于 1976 年 7 月 16 日入院，自诉入院前 4 天出现头痛，服“去痛片”稍可缓解。2 天前去卫生所治疗，给予针刺风池穴，进针后觉剧烈头痛，伴频繁呕吐。入院时查体：血压 18.7/10.7 千帕（140/80 毫米汞柱），体温 36.4℃，神志清楚，内科检查无异常，眼底正常，项强 2 指，克氏征可疑。腰穿脑脊液呈血性，压力 210 毫米水柱，诊断为蛛网膜下腔出血。经镇静、止血及镇痛治疗，19 天后痊愈出院^[13]。

【案例 9】

一患者，男性，59 岁，退休干部，有高血压病及左侧偏瘫史。此次再突发脑卒中，经住院治疗 21 天，病情稳定后出院。出院后继续在门诊行针灸治疗，第 1、2 次针后感觉良好，无特殊不适。第 3 次，在针刺风池等穴位过程中，患者有头晕、出冷汗、胸闷等感觉，拔针后随即出现呕吐（均为胃内容物），约半小时左右进入昏迷状态，大小便失禁，四肢厥冷，3 小时后由急诊收入我科。检查：体温 39℃，血压 25.3/16.0 千帕（190/120 毫米汞柱），脉搏 92 次/分，呈深昏迷，潮式呼吸，有明显的心律不齐，双瞳孔不等大，左瞳孔直径 3 毫米，右瞳孔直径 1.5 毫米，对光反射迟钝，双侧巴氏征（+），急诊腰穿为均匀血性脑脊液，拟诊为脑出血。

入院后马上施行颅内血肿简单穿刺引流术，放出鲜红血液 25 毫升，并置硅胶管一根，继续引流，5 小时后又引出血性液 10 毫升。术后第 2 天又引流出少量血性液。经气管切开、下鼻饲、补液支持、脱水、细胞活化剂、控制感染等综合治疗，其病情仍不断恶化。术后第 3 天，仍有陈旧性血液不断流出，双眼球浮动。术后第 4 天，终因呼吸、循环衰竭而死亡^[17]。

【案例 10】

汪××，男性，15 岁，学生，1986 年 6 月 22 日晚 8 点来诊。

患者当日下午放学后，因头痛、发热、怯冷、流清涕，其就职于乡卫生院的胞兄按“感冒”予以针刺治疗。选取合谷、外关、风池、风府穴，在进针后均出现局部胀感，其中风池穴约进针2寸深。留针5分钟后，术者再次捻动右侧风池穴上的针柄催气时，患者突然惊叫一声，诉及“受不了”、“心中难受”，拔出全部针具后，患者双手抱头，表情十分痛苦，自诉头痛剧烈欲炸。注射1支“安痛定”仍无起色。10多分钟功夫，病人倒地，不省人事，呼之不应，遂送来本院急诊。查体：意识丧失，呈深昏迷状态，呼吸深大，16次/分，心率120次/分，双瞳孔不等大，左侧35毫米，右侧15毫米，左眼底视乳头明显水肿，无出血点，右眼底看不清。四肢肌张力尚可，肌力无法查，双侧腱反射消失，弹指试验(+)，巴氏征(+)，其他病理征未引出。疑为脑疝形成。即给予脱水、抗感染等对症治疗，效果欠佳。半小时后病人呼吸停止，心音消失，经抢救无效而死亡。死后作小脑延髓池侧方穿刺，抽出鲜红色脑脊液，从而证实为蛛网膜下腔出血^[4]。

【分析】

根据现代解剖学，风池穴正位于胸锁乳突肌与斜方肌上端会合处的凹陷中，其深层有椎动脉、延髓下端、蛛网膜下腔等重要结构。而蛛网膜下腔是指蛛网膜与软脑膜之间由许多小纤维束互相连结后所构成的空隙，供应脑的血管主支，即附于软脑膜上而在蛛网膜下腔之中，故此处的表面血管极为丰富，在针刺头部的风池诸穴时，如针体进入过深，就可能刺入椎管，损伤腔内血管，引起蛛网膜下腔出血。除案例9之外的所有案例，都是由于术者在施术过程中，由于针刺不当，或针刺过深，或提插捻转幅度过大，使针尖穿过寰枕后膜进入枕骨大孔，刺破椎动脉，引起蛛网膜下腔出血，从而造成严重后果。

案例9则是因针刺风池等穴引起患者血压的进一步升高，颅内流体力学的变化和波动，最终导致脑血管破裂。由于本例患者是慢性高血压病者，其大脑、小脑等部位内，直径50~150微米的穿通动脉管壁常会发生脂肪玻璃样变（纤维素样坏死）而形成微动脉瘤，这些穿通动脉以垂直方向从主干分出，在变成网状的

前毛细血管前不发出分支，故很容易直接受到血压波动的影响而破裂。当针刺风池穴这样的敏感腧穴时，患者的血压明显升高，从而造成许多穿通动脉破裂出血并汇聚成血肿，引起脑水肿，严重者会自大脑镰下嵌向对侧或经天幕孔向下嵌压脑干，导致脑干缺血、出血和坏死而致死亡。

【临床表现】

脑出血的症状和体征：起病突然，常有头痛、呕吐、昏迷、大小便失禁、呃逆等，伴有发热，四肢瘫痪。体征：血压骤然升高，瞳孔不等大，对光反射、角膜反射减弱或消失，颈硬，面肌、舌肌瘫痪，肌张力降低，偏身或交叉性感觉障碍，腹壁反射、提睾反射减弱或消失，腱反射先消失后亢进，同时可出现病理征，视网膜出血及视乳头水肿。检查：脑脊液压力增高，常为血性，脑超声波可显示中线波移位，头颅CT示出血、水肿等。临床上尚需根据不同表现特征，将脑出血分为大脑半球出血、桥脑出血和小脑出血。

蛛网膜下腔出血的症状和体征：起病急骤，突发剧烈头痛，频繁呕吐，伴有面色苍白、全身大汗出、怕光少语，半数病人会出现不同程度的意识障碍，或谵妄，定向力障碍，错觉和幻觉等，部分病例可有局限性或全身性癫痫发作。体征：以脑膜刺激征为主，多有颈项强直且有抵抗，其次为克氏征（+）；眼底检查可发现视网膜前即玻璃体下片状出血；呼吸不规则，脉搏缓慢。检查：脑脊液压力增高，呈均匀血性，2~3天后则逐渐黄变，蛋白量增高；头颅CT可直接确定蛛网膜下腔的凝血块，以及是否存在脑水肿等；周围血象可见轻度白细胞增多，尿检查可有尿糖及蛋白。

【处理方法】

1. 脑出血的治疗：

（1）防止再出血：保持安静，尽量减少对病人不必要的搬动，躁动者可予以适当镇静剂。调整血压，过高者可肌注利血平1毫克，将血压维持在20.0~21.3/12.0~13.3千帕（150~160/90~100毫米汞柱）为宜。可根据具体情况，短期使用止血药（但目前临床对其应用尚有争议），如6-氨基己酸或抗血纤溶芳酸。

(2) 降低颅内压：可选用 20% 甘露醇或 25% 山梨醇 250 毫升快速静滴；速尿 20~40 毫克溶于 5% 葡萄糖液 20~40 毫升中静注；利尿酸钠 25 毫克静脉推注；10% 甘油葡萄糖 250~500 毫升静滴。上述脱水剂和利尿剂可交替使用，每 6~8 小时使用 1 次为宜。

(3) 降温疗法：一般以冰水或冰帽作头部局部降温，这样可降低脑代谢率和耗氧量，有利于减轻脑水肿及脑细胞功能的恢复。

(4) 防治并发症：注意保持患者呼吸道通畅，防治褥疮、胃出血、尿道感染和循环功能紊乱等并发症。

(5) 维持营养及水、电解质和酸碱平衡：昏迷病人可先禁食 1~2 天，从静脉内补充营养和水分，每日总量 1500~2500 毫升为宜；以后如无呕吐或消化道出血，可酌情开始鼻饲，并随时注意补充电解质、维生素、脑细胞功能活化剂，及时纠正酸碱平衡失调等。

(6) 中医治疗：若闭证可鼻饲至宝丹或苏合香丸，脱证可用参附龙牡汤或独参汤。针灸治疗，闭证可取人中、涌泉、太冲、内关、曲池、丰隆、十二井等穴，脱证取关元、神阙、足三里、气海等穴；耳穴可选取耳尖、心、肝、肾、皮质下、相应肢体；尚可配合穴位（同体针）注射，药物常选当归注射液、复方丹参注射液、田七注射液、维生素 B 族注射液、胞二磷胆碱等。

(7) 血肿穿刺引流：若无开颅手术条件，可行颅骨钻孔血肿穿刺引流术。

(8) 手术治疗：本法目的在于清除血肿，降低颅内压力，缓解脑疝，改善脑血液循环，故当出现手术适应证时宜尽早施行手术。但对高龄、生命体征不稳定、出血位于丘脑及脑干、脑疝晚期、血压过高未经控制、高热、严重消化道出血或内脏疾病、血压下降或休克者，均不宜进行手术治疗。

2. 蛛网膜下腔出血的治疗：

(1) 保持安静，绝对卧床休息 4~6 周，避免激动；保持大便通畅，勿用力咳嗽及排便。

(2) 药物治疗：给予止痛剂颅痛定、去痛片，必要时可短程

应用可待因，并同时用镇静剂安定、硝基安定、鲁米那等。其他药物治疗基本同脑出血。如药物治疗效果不佳，头痛难忍又无局限性神经症状者，可适当做腰穿以放出血性脑脊液 6~10 毫升左右。

(3) 手术治疗：经头颅 CT 扫描或脑血管造影证实为血肿者，应及时作血肿清除术。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：较厚，有头发，由枕小神经分布，其纤维来自第 3 颈神经。

2. 皮下组织：较厚，由脂肪组织及纤维结缔组织构成，内有第 3 颈神经的皮支和皮下静脉。

3. 斜方肌外侧：有结缔组织。

4. 头夹肌：其浅面紧靠胸锁乳突肌和斜方肌，由第 2 颈神经至第 5 颈神经后支的外侧支支配。

5. 头半棘肌：位于头夹肌的深面，受相应的胸神经后支支配。

6. 枕下三角：位于头半棘肌的深面，被脂肪结缔组织所填充。枕下神经从其深面穿出。

7. 寰枕关节：位于枕下三角外侧边缘的中点深处，由枕骨髁和寰椎的上关节凹组成。关节囊比较松弛，寰枕后膜位于关节囊的内后方，在关节囊的内侧、寰枕后膜的深面有延髓的起始部位。在关节囊的外侧有椎动脉通过。

【操作要点】

风池穴是临床上十分常用的腧穴之一，由于它所处的位置较特殊，在针刺时如果操作不慎，则容易造成医疗事故。因此，严格掌握本穴的安全针刺方法是非常重要的。一般来说，应注意下列几个方面的情况。首先，要掌握针刺的方向，最佳的选择是针尖向内下朝人中或鼻尖方向深刺，这样针尖仅通过皮肤、皮下组织、肌层到达寰椎后突，就可避免与椎动脉和延髓下段所在部位相接触而不致发生意外情况。而最危险的针刺方向是向上朝对侧眼球方向深刺，因为此方向正好与椎动脉及延髓下段所在部位相对应，如果施治稍有不慎，针尖即有可能进入枕骨大孔，刺伤椎

动脉或延髓，引起蛛网膜下腔出血等事故。其次，要严格限制针刺的深度。由于该穴深面的重要结构主要是延髓和椎动脉，其深度（成年人）距皮肤一般为 1.5 寸以上（山西省杨占林等对 35 具男尸、17 具女尸的风池穴的安全针刺深度进行测量研究，其统计学结果表明，男、女尸的深度都超过 40 毫米，男性为 41.21 ± 3.82 ，女性为 43.88 ± 4.61 ），故针刺深度不超过 1.5 寸时将是较为安全的，超过 1.5 寸后危险系数则相应增加，而 2 寸则是该穴绝对不可逾越的危险深度。最后，术者要仔细体会针下的阻力。由于不同组织具有不同的物理特性，当针尖接触到这些不同组织时就必然会产生不同程度的阻力，故操作者根据自己手下的不同感觉，就可以判断针尖到达某层结构，从而做到有意识地避免针刺意外的发生。例如，当针尖接触该穴皮肤时，针下紧韧，阻力感较大，必须依靠一定的指力才能刺入；继续进针，针尖经过皮下组织和肌层组织，此时针下感觉柔松，阻力较小，较容易通过（针在此层中，有可能刺中枕大神经、枕小神经及分支而使病人出现局部麻木感，也有可能刺伤枕动脉、枕静脉及分支而使病人有疼痛感，但一般都不会引起严重后果）；再继续进针，针尖就接触到寰枕后膜或寰椎后弓，针下即感觉坚韧或坚硬，此处即为该穴安全针刺的最大深度，不能再行刺入。如果术者不慎再深刺，针尖就会穿过寰枕后膜及与之紧密相连的硬脊膜而进入枕骨大孔，经蛛网膜下腔而损伤椎动脉或延髓下段，危及生命。

七、针刺风池穴损伤延髓而致死亡

【案例】

一患者，男性，16 岁。因头痛、头晕、失眠就诊，当地医院医生施行针刺疗法，穴取风池诸穴。针后患者即感头痛加剧，恶心呕吐，并出现神志不清等症状，约 3 小时后呼吸停止。我院紧急会诊后疑为颅后窝血肿，立即行颅后窝开颅术，术中见延髓右侧有蚕豆大小血凝块压迫，即予手术清除血块以减压，但术后呼吸仍未能恢复，血压继续下降，终因抢救无效而死亡^[13]。

【分析】

根据现代解剖学，风池穴正位于胸锁乳突肌与斜方肌上端会合处的凹陷中，浅层有皮肤、枕小神经、项肌、枕大神经及枕动脉，深层有椎动脉、寰枕后膜、蛛网膜下腔、脊髓上端和延髓下端等重要结构。当针尖朝对侧外眼角方向深刺时，针将穿过枕下三角、寰枕后膜而进入枕骨大孔，经蛛网膜下腔（小脑延髓池），刺到延髓下端，从而损伤延髓，导致呼吸中枢、心血管中枢、呕吐中枢等功能失常，出现严重的后果。本例正是由于医生施行针刺时，不慎引起延髓损伤而致患者死亡。

【临床表现】

延髓受到针刺损伤，一开始可以不表现出明显症状，仅见患者有上下放散的触电感，有一定时间的潜伏期。但也可即时出现一系列较为严重的精神、神经症状，如头痛眼花、呕吐、出汗、恐慌惊叫、反应迟钝，随之出现昏迷、呼吸频率改变、循环功能紊乱等威胁病人生命的症状和体征，如不能及时处理，后果极其严重。

【处理方法】

延髓损伤是针刺损伤中最为危险的一种，预后多较凶险。对确诊延髓损伤或疑似此症者，应严密观察其呼吸、血压、脉搏和意识状态，并及时协同有关科室进行积极抢救。如果损伤不重，抢救及时，措施正确，或可得救。

救治处理的原则包括：①人工冬眠低温治疗，以降低脑组织的新陈代谢，提高脑组织的缺氧耐受能力；②保持呼吸道通畅，保证脑组织的氧分供应；③应用脱水剂及激素类，以控制脑水肿；④应用止痉剂以缓解肌张力增高；⑤采用能量合剂，促进脑功能恢复等。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：由枕小神经分布。
2. 皮下组织：由脂肪组织及纤维结缔组织构成，内有第3颈神经的皮支和皮下静脉。
3. 斜方肌外侧：有结缔组织。

4. 头夹肌：由第 2 颈神经至第 5 颈神经后支的外侧支支配。

5. 头半棘肌：受相应的胸神经后支支配。

6. 枕下三角：位于头半棘肌的深面，被脂肪结缔组织所填充，枕下神经从其深面穿出。

7. 寰枕关节：由枕骨髁和寰椎的上关节凹组成。

【操作要点】

风池穴深面的重要结构主要是延髓和椎动脉，它们距皮肤的深度一般在 1.5 寸以上，故术者应该熟悉其局部解剖，要注意进针的角度和深度，才能避免出现损伤延髓的事故。临床上，采用针尖向内下朝人中方向深刺或两侧风池穴横行透刺的方法，均无进颅的危险，故应是较安全的进针角度。而当针尖向上朝对侧外眼角方向深刺的时候（进针深度不超过 1.2 寸，则可避免发生危险），则易通过枕骨大孔后损伤延髓，容易发生意外，很不安全。同时，还要注意细心体会自己的手感，当针尖朝对侧外眼角刺入穴位时，此针将依次通过枕下三角（阻力很小且有松软感）、寰枕后膜（阻力明显增加且有硬韧感）、蛛网膜下腔（有突破感觉）、延髓（非常松软之感）等结构，即进针过程有松软——硬韧——突破——松软的感觉，故术者在施术过程中运针手法不宜过重，应根据不同的手感来决定进退针，以免发生危险。

八、针刺风池穴导致晕针

【案例 1】

周××，女，46 岁，工人。因颈肩肌筋膜炎疼痛 3 天来诊。医生施行针刺疗法，穴取风池等，得气后行平补平泻法，隔日 1 次。于第 4 次就诊施针后半分钟，患者突诉头晕，随即神志丧失，面色苍白，两目上视，四肢抽动，喉间痰鸣。当即起针，使其平卧抬高下肢，约半分钟后病人意识转清，全身汗出。静卧 10 分钟后除胸闷不适外其他症状基本消失。3 天后患者仍诉有轻微头晕，心闷不舒^[16]。

【案例 2】

某男性患者，26 岁，干部。因落枕 1 天而于 1991 年 7 月 29 日来诊。症见右颈项部肌肉疼痛、僵硬，不能俯仰转侧，疼痛向背部放射，局部压痛明显，无红肿或发热。拟诊为颈肌痉挛（落枕）。即予针灸治疗，嘱患者取坐位，针右侧风池穴。针后不到半分钟，患者突然一阵颤抖，扑倒于地，苦笑一下，随即面如死灰，意识丧失。给予嗅氨水，起针后使其平卧，并重掐人中、艾灸百会，约昏睡 10 余分钟后始恢复正常。追询病者，虽无饥饿、劳累等情况，但患者系初次针刺，曾有见血晕厥史。

【分析】

晕针是针灸临床上最常见的一种不良反应，属于反射性晕厥中较为常见的血管抑制性晕厥。承淡安曾说：“在下针捻拔时，神经猝受刺激而反射脑部，先为兴奋，旋即麻痹，血压迅速下降，全身微血管骤然收缩，尤以头部为甚，形成急性脑贫血，意识不清，心脏机能亦急速减退，或竟停止搏动。”虽然在目前对晕针发生机理尚无统一的解释，但大多数人都同意如下观点，晕针主要是由于针刺的强烈刺激，通过迷走神经的反射，引起全身外周血管（尤其是周围肌肉内血管）扩张，外周血管阻力降低，回心血量减少，因而心脏输出量减低，血压下降，造成一时性、广泛性的脑供血不足或脑缺血所致。这两例所选穴位均为风池，是人体最敏感的穴位之一，加上针刺的强烈刺激，病人的精神紧张，它们协同作用，结果出现一种所谓“超限性抑制”，即晕针。

【临床表现】

晕针大多发生于针灸过程中，但也有少数病人在取针后数分钟始出现症状，典型的晕针一般可分为 3 期。

先兆期：病人有各种感觉的错乱，如眼花，耳鸣，头昏，心悸，出冷汗，打呵欠，上腹部或全身不适等，亦有面色苍白，恶心欲呕等。

发作期：轻者头晕胸闷，恶心呕吐，肢体发软发凉，摇晃不稳，或伴瞬间意识丧失；重者突然意识丧失，昏扑在地，唇甲青紫，大汗淋漓，面色灰白，双眼上翻，二便失禁。少数可伴有惊

厥发作。

恢复期：轻症仅有轻度不适，多数患者可有显著疲倦，头昏，嗜睡，汗出及全身不适感，短则几分钟，长则几小时，症状才能逐渐消除。

此外，根据临床症状，亦可将晕针分为轻、中、重三度（临床以前两种多见）。①轻度：针刺过程中患者自诉头晕目眩，胸闷乏力，但呼吸脉搏仍正常；②中度：头晕心慌，恶心欲吐，面色苍白，汗出肢冷，脉搏变细；③重度：全身厥冷，大汗淋漓，血压下降，脉搏细弱，呈昏厥状态。

【处理方法】

1. 常规护理：迅速取下所有的针，将患者扶至空气流通处，并让其仰卧在床上，头低脚高位；及时松解患者衣带，热天注意通风，冷天注意保暖；立刻测量呼吸、血压、脉搏以及心率。

2. 轻者一般静卧片刻即可，如患者仍感不适，可给予温糖水或热茶口服，并注意使之安静和休息，约经 3~5 分钟后即可逐渐恢复正常。

3. 重者可在上述处理的基础上，用指掐或针刺人中、素髻、足三里、涌泉，或艾灸百会、关元、气海等穴；嗅以氨水；必要时可用肾上腺素 1 毫升、阿托品 1 毫克肌注，25% 葡萄糖 40 毫升静脉推注等。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：由枕小神经分布。

2. 皮下组织：由脂肪组织及纤维结缔组织构成，内有第 3 颈神经的皮支和皮下静脉。

3. 斜方肌外侧：有结缔组织。

4. 头夹肌：由第 2 颈神经至第 5 颈神经后支的外侧支支配。

5. 头半棘肌：受相应的胸神经后支支配。

6. 枕下三角：位于头半棘肌的深面，被脂肪结缔组织所填充，枕下神经从其深面穿出。

7. 寰枕关节：由枕骨髁和寰椎的上关节凹组成。

【操作要点】

晕针是针刺异常情况中最常见的一种，虽然多数患者不经任何治疗也可自行恢复（恢复的时间决定于患者的体质和处理的适当），且大都经过短时间的休息后可逐渐复原，不留后遗症。但也不应以晕针的预后是良好的而不予重视，应该尽量避免或减少这种情况的发生，特别对久病体弱者更是如此。一般而言，为了防止晕针，临床上施术时要注意以下几点：

1. 心理预防：对针灸有猜疑、恐惧心理者，或针刺时有哭笑、惊叫战栗、躲避、肌肉痉挛，伴有呼吸、心跳、皮温、面色、出汗等植物神经系统和内分泌功能改变者，均可作预先心理预防。其方法有3种：第1种，语言诱导。进针前，先耐心给患者讲解针刺风池穴的具体方法，说明可能出现的感觉、程度和传导途径，以取得患者的信任和配合；第2种，松弛训练。对好静、压抑、注意力易于集中、性格内向的患者，可令其凝视某个物体，待其完全进入自我冥想状态后，始行针刺；第3种，转移注意力。对急躁、好动、注意力易涣散、性格外向的患者，可向其提出一些小问题，利用其视觉、听觉功能和思维活动等，转移其注意力，促进局部放松。

2. 生理预防：任何年龄者都可发生晕针，但以年老体弱者最为多发。故施术时应尽量采用卧位针刺，且取穴不宜过多，手法亦不宜过强。饥饿病人，针前应适当进食；过度饱食者，亦需待食物有所消化后方可针刺。过度疲劳，或激烈活动后，都应让患者稍加休息，待其体力基本恢复再施术。在针刺风池穴等时，由于针感较强，酸胀感明显，容易引起晕针，因此在操作过程中医生要严密观察患者的神色、表情、脉象等方面的状况，一旦有晕针的先兆症状，即应立即处理。

3. 起针以后，一般应令患者在诊室休息10~20分钟后始可离开，以防延缓性晕针的发生。

九、深刺风府穴导致死亡

【案例 1】

谭××，男性，39 岁。因患精神病于 1953 年 2 月入成都某疗养所医治，发作期间打人毁物，住院后一直未进行特殊治疗。于 1956 年 11 月开始针灸治疗，每隔 2~3 天施术 1 次，其中针刺风府穴共 6 次，在针刺治疗期间，从未进行体格检查。末次针后第 2 天，病人呕吐清水、头痛、微烧、不进饮食，卧床不起；针后第 5 天，病人语言及吞咽均有困难，所喂食物常由鼻孔流出，四肢瘫痪，小便潴留；翌日，病人神志模糊，语言不清，喉间痰鸣，瞳孔缩小，血压 13.3/8.0 千帕（100/60 毫米汞柱），心跳每分钟 40 余次，心脏无肥大及杂音，呼吸每分钟 10 余次，肺部有湿性罗音，双侧软腭瘫痪，四肢瘫痪，肌张力降低，腱反射消失，无病理反射，四肢痛觉消失；针后第 8 天，昏迷 1 次，当时口吐白沫，瞳孔散大，苏醒后感觉胸中难受；针后第 9 天，又突然昏迷，瞳孔散大，呼吸困难，脉搏每分钟约 160 次，急救无效死亡。

尸检：头颅外未见异常，延髓外形变粗变圆，锥体与橄榄界消失。切面，自延髓上端至下端有长达 4 厘米之出血区；在橄榄下核上份切面可见锥体及橄榄下核区出血，左侧较大有直径 0.6 厘米之出血区，右侧较小约 0.2 厘米；在橄榄下核下份切面有 4 处出血，出血区左侧为 0.5 厘米及 0.8 厘米，右侧为 0.3 厘米及 0.3 厘米；在延髓中份切面，出血区最大为 1.2 厘米×1.0 厘米；在延髓下份切面，出血区逐渐变小为 0.2 厘米×0.3 厘米。

显微镜观察：在延髓切片上可见大片出血，其中大部分红细胞清楚可见，部分红细胞已融合成片，在出血区有格子细胞，并含有含铁血黄素。在出血区周围神经组织有严重水肿，血管充血，血管周围有少量单核细胞浸润，神经细胞有蜕变。脑之其他部分切片中可见充血与水肿，无其他改变。

病理诊断：延髓内出血（针刺后所致）。死亡原因为延髓内出血，损及生命中枢^[17]。

【案例 2】

某男，16岁，学生。患精神分裂症2年，屡治不愈，乃试用新针治疗。于1959年8月25日入院，每日针刺1次。9月5日上午10时针刺风府穴，进针较深，行重泻手法，立即呼吸停止，经注射咖啡因，插管人工呼吸，数分钟后呼吸恢复，但仍未清醒，予脱水治疗。下午5时出现呼吸衰竭。即邀会诊，紧急开颅，探查见脑压甚高，硬膜下右小脑半球表面有5毫升血肿，暗红色，局部隐约见刺伤痕，右小脑延髓充血水肿明显。予吸除血肿，自主呼吸一度恢复，但术中并发急性脑膨出，切除右小脑半球外侧脑组织，行颅内减压后关颅。继续应用脱水、呼吸兴奋剂与升压药无效，次日晨4时死亡^[16]。

【案例3】

一患者，女性，23岁，工人。因患神经病在本厂卫生所接受针灸治疗。当针刺入风府诸穴，病人突然由头倾坐位呈强直性抽搐而直立，随之意识丧失，呼吸困难，20分钟后急诊送来我院。在急诊室检查：呼吸心跳已停止。随即行人工呼吸、气管内插管、体外心脏挤压，抢救2小时无效死亡。死后腰椎穿刺：血性脑脊液，含红细胞20万/立方毫米^[18]。

【分析】

风府穴在枕外隆凸直下凹陷处，其局部有项肌、项韧带、颈神经和枕大神经分支、枕动脉和枕静脉分支、棘间静脉丛等，深面依次有寰枕后膜（位于枕骨大孔的后缘与寰椎后弓上缘之间）、硬膜、蛛网膜、小脑延髓池和延髓等重要结构。而人体的血液循环、呼吸器官、消化功能等的反射性调节，只有延髓功能正常的情况下方能实现。当延髓受到损伤之后，就会导致呼吸中枢、循环中枢、呕吐中枢等功能失常，危及患者生命。本案例1、3正是由于术者操作不慎，过度深刺，误入枕骨大孔，经蛛网膜下腔，刺伤延髓，引起延髓出血，压迫生命中枢所致。案例2是因术者针刺穴位过深，加上操作手法过重，针尖经枕骨大孔刺伤右小脑半球，出血并压迫延髓，危及生命。

【临床表现】

延髓受到针刺损伤，一开始可以不表现出明显症状，仅见患

者有上下放散的触电感，有一定时间的潜伏期。但也可即时出现一系列较为严重的精神、神经症状，如头痛眼花、呕吐、出汗、恐慌惊叫、反应迟钝，随之出现昏迷、呼吸频率改变、循环功能紊乱等威胁病者生命的症状和体征，如不及时处理，后果极其严重。

小脑损伤时，可在留针期间或起针后不久，出现后枕部剧烈疼痛，重度眩晕，构音困难，呕吐，步态不稳，共济失调（表现为走路时抬腿过高、迈步过大，握取东西时过度伸开手指，让患者作指鼻试验时动作不准确等），颈项强直。并可进入昏迷状态。

【处理方法】

延髓损伤和小脑损伤，都是针刺损伤中比较危险的意外事故，预后多较凶险，往往因抢救不及而死亡。故对确诊或疑似此类病症者，要严密观察其呼吸、血压、脉搏和意识状态，并及时协同有关科室进行积极抢救。

救治的基本原则包括：①人工冬眠低温治疗，以降低脑组织的新陈代谢，提高脑组织的缺氧耐受能力；②保持呼吸道通畅，保证脑组织的氧分供应；③应用脱水剂及激素类，以控制脑水肿；④应用止痉剂以缓解肌张力增高；⑤采用能量合剂，促进脑功能恢复等。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：较厚，上有头发，由枕大神经和第3枕神经分布（分别来自第2、3颈神经）。

2. 皮下组织：较厚，由疏松结缔组织构成，其中间网络大量的脂肪细胞，内有第2、3颈神经的皮支和皮下静脉。

3. 项韧带：为项部的三角形弹力纤维膜，其结构主要为致密的结缔组织，纤维排列紧密。

4. 深面：依次有寰枕后膜（位于枕骨大孔的后缘与寰椎后弓上缘之间，为致密的结缔组织膜）、硬膜（脑和脊髓的外层被膜，厚而坚韧，由胶原纤维和弹力纤维组成）、蛛网膜（脑和脊髓的中层被膜，是一层薄而透明的结缔组织膜）、软膜（紧贴于脑和脊髓的表面，与蛛网膜之间有一腔隙，为蛛网膜下腔，亦称小脑延髓池）、延髓（为脑干的下部分，在枕骨大孔处下续脊髓，内有各种

内脏活动的调节中枢)。

【操作要点】

风府穴适对颅腔内的延髓和小脑，因此针刺该穴时要十分谨慎，才能防止意外的发生。首先，要严格掌握进针的深度，直刺时男性均值为 36.83 毫米，女性均值为 30.96 毫米；针尖刺向鼻尖方向时，男性均值为 42.22 毫米，女性均值为 40.90 毫米；针尖向口方向刺入时，男性均值为 44.43 毫米，女性均值为 44.46 毫米。因此，本穴的针刺深度以控制在 1 中指同身寸（在一般成年人约相当于 2 厘米）左右为宜，如要超过此数则应极度小心。超过 1.5 同身寸以后其危险系数将不断加大，2 同身寸为针刺该穴位绝对不可逾越的危险深度。其次，要注意针刺的方向，一般来说，针向鼻尖方向较直刺安全；针尖向口部则较直刺和针向鼻尖为安全；而针向喉结时则多会碰在椎骨上不易进入椎管。最后，要仔细体会施术时的手感。在针刺风府穴过程中，一般可遇到两种阻力：一是坚韧而有弹性的阻力，为项韧带、黄韧带或寰枕后膜阻挡之故；然后针下再出现空松感时，即说明针尖已进入椎管内硬膜外腔处，此时不可轻易深刺，应缓慢送针；二是紧接空松感之后（深约 1.5 寸时），如针下再遇到柔软的阻力时，即说明针尖已刺到硬脊膜处，病人可能出现上下放散的酸、胀感，此时不宜再深刺，应立即停针。

十、针刺风府穴致蛛网膜下腔出血

【案例 1】

一患者，男性，36 岁，干部。于 1970 年 3 月 24 日下午因头晕、头痛行针刺治疗，以毫针刺入风府穴，在行针捻针时，患者突感“头脑一轰”并伴有剧烈头痛，继而疼痛沿背脊下行，此时立即拔针，而头痛继续加重。经注射吗啡 1 支，头痛未止而卧床不起，当晚又出现恶心呕吐。次日来我院就诊，经门诊腰穿为血性脑脊液，以蛛网膜下腔出血（针刺所致）而入院。体检：神清，血压为 18.0/12.0 千帕（134/90 毫米汞柱），颈项强硬，克氏征

(+), 余未见异常。治疗: 经卧床休息, 镇静止痛, 止血, 定时降颅压等处理, 自觉症状和体征逐渐减轻, 消失, 住院 12 天出院^[9]。

【案例 2】

一患者, 女, 35 岁, 干部。因长期患神经衰弱症而在某诊所接受针刺治疗。医生用长毫针刺入患者后颈部的风府穴, 当第 1 针刺入后患者即觉从左肩窜向左上下肢呈电击样感觉, 随之四肢软弱无力, 眼发黑, 恶心呕吐, 并有排便感, 头痛呈进行性加重, 针刺后 2 小时急诊入院治疗。体检: 神志清楚, 痛苦面容, 颈项僵硬, 颅神经正常, 右侧上下肢肌力弱, 深反射降低, 感觉检查正常。腰椎穿刺: 压力正常, 血性脑脊液含红细胞 5 万/立方毫米, 蛋白 90 毫克%。诊断为针刺引起蛛网膜下腔出血。治疗: 经综合性治疗, 包括镇静、止痛、止血、神经恢复剂, 以及卧床休息, 症状逐渐消失, 痊愈出院^[18]。

【分析】

风府穴位于枕外隆凸直下凹陷处, 其深层依次有寰枕后膜、硬膜、蛛网膜、软膜和延髓等重要结构。而蛛网膜下腔是指蛛网膜与软脑膜之间由许多小纤维束互相连结后所构成的空隙, 供应脑的血管主支, 即附于软脑膜上而在蛛网膜下腔之中。故蛛网膜下腔的表面血管极为丰富, 在针刺风府穴时, 若针尖进入过深, 就可能刺入椎管, 损伤腔内血管, 引起蛛网膜下腔出血。本节 2 个案例, 正是由于术者在操作过程, 由于针刺不当, 或提插捻转幅度过大, 使针尖穿过寰枕后膜进入枕骨大孔, 刺入蛛网膜下腔, 导致蛛网膜下腔出血, 从而造成严重的后果。

【临床表现】

在针刺过程中或退针之后, 患者突发剧烈的头痛、频繁呕吐, 伴有面色苍白、全身大汗出、畏光少语, 半数病人会出现不同程度的意识障碍, 或谵妄, 定向力障碍, 错觉和幻觉等。部分病例可有局限性或全身性癫痫发作。

体征: 以脑膜刺激征为主, 多有颈项强直且有抵抗, 其次为克氏征(+); 眼底检查可发现视网膜前即玻璃体下片状出血; 呼

吸不规则，脉搏缓慢。检查：脑脊液压力增高，呈均匀血性，2～3天后则变黄，蛋白量增高；头颅CT可直接确定蛛网膜下腔的凝血块以及是否存在脑水肿等；周围血象可见轻度白细胞增多，尿检查可有尿糖及蛋白。

【处理方法】

1. 保持安静，绝对卧床休息4～6周，尽量减少搬动，以防继续出血或再发出血，使破裂血管得以充分恢复。特别是要注意避免情绪激动和突然用力，也不宜过早下床活动。应用轻泻药保持患者的大便通畅。

2. 有意识障碍和脑水肿、颅内压明显增高者可用脱水剂，如快速静脉滴入20%甘露醇250毫升，每6～8小时1次。或速尿20毫克加50%葡萄糖50毫升静注。或地塞米松10～20毫克静注。有高血压者，可选用利血平1毫克或25%硫酸镁10毫升肌注，使血压保持在20.0～21.3/12.0千帕（150～160/90毫米汞柱）左右为宜；头痛剧烈或躁动不安者，可给予止痛镇静剂。

3. 应用止血剂。选用纤维蛋白溶解抑制剂，目的在于阻止动脉破裂处凝血块的溶解，防止再出血和缓解脑血管痉挛。可选用：①6-氨基己酸4～6克，加入10%葡萄糖500毫升内静脉滴注，每日1～2次，连用2～3周；②抗血纤溶芳酸每次量200～400毫克，用法同上。亦可选用安络血、凝血质、仙鹤草素、止血敏、三七粉和云南白药等。

4. 外科治疗。对有外科手术指征的患者，应在情况许可时尽快施行手术治疗。

【穴位层次解剖】

同前。

【操作要点】

风府穴适对着颅腔内的蛛网膜下腔（即是蛛网膜和软脑膜之间的空隙），为防止针刺致蛛网膜下腔出血意外事故的发生，在施术时一定要十分谨慎。首先，必须注意针刺的方向，以向口部方向针刺时最安全，向鼻尖方向针刺则次之，而直刺最危险。其次，要掌握进针的深度。本穴的针刺深度以控制在1中指同身寸（成

年人约相当于2厘米长)左右为宜,超过1.5同身寸以后其危险系数将不断加大,2同身寸为该穴位绝对不可逾越的危险深度。

十一、深刺风府穴损伤脊髓

【案例】

某一男性患者,31岁。因患精神分裂症(猜疑型)数年,曾做过胰岛素休克和电休克等几十次,但仍有自杀企图和对女性缺乏礼貌等症状。予针刺疗法,穴取风府等,每天施术1次,每次均要求刺及脊髓,患者自杀症状已不明显,但针后发生左脚跛行,3个月未恢复,尿潴留3天^[19]。

【分析】

脊髓是中枢神经系统的一部分,位于椎管内,呈前后稍扁的圆柱形,外包以被膜。上端在枕骨大孔处与延髓相连,下端尖削呈圆锥状止于终丝。从脊髓实质到椎管壁之间有软脊膜、脊髓蛛网膜、硬脊膜3层,而从椎管壁至体表还分别有黄韧带、棘间韧带、脊上韧带、皮下组织等结构。所以临床针刺时进针应以黄韧带为限,否则有伤及脊髓的可能。根据解剖学知识,风府穴的深层依次有寰枕后膜、硬膜、蛛网膜、软膜和延髓等重要结构。当进针深度过大时(本病例为有意深刺,以期获得较好的疗效),针尖就会穿过黄韧带和寰枕后膜,进入枕骨大孔,然后穿破硬脊膜、蛛网膜、软脊膜,到达并损伤脊髓,从而引起脊髓功能障碍,出现一系列严重的症状。

【临床表现】

脊髓针刺损伤所出现的症状、体征与脊髓损伤的程度有关。

如仅触及脊髓,损伤较轻者多表现为脊髓震颤,如全身酸痛、胀麻、四肢无力,甚则头晕或暂时性知觉丧失、瘫痪等脊髓一过性传导障碍。经数分钟、数小时或数日之后即能完全恢复。

如针体直接刺入脊髓,造成较大的损伤,则出现脊髓挫裂伤,而呈一侧或双侧下肢不完全性瘫痪,病人不能行走或呈跛行步态及感觉迟钝等。如脊髓损伤严重,则见损伤部位所支配的肌肉出

现麻痹，大、小便失禁，各种反射消失，感觉消失，体温升高，血压下降，脉搏频数等脊髓休克症状。

【处理方法】

1. 头晕、四肢乏力时，应让患者平卧休息，并饮以热茶或糖水等。

2. 伴高热头痛者，可用解热镇痛药，如扑热息痛、安乃近等。

3. 肢体运动功能的恢复，需时约数周或数月，可配合理疗或针灸疗法，取穴以局部和邻近为主。

4. 为促进恢复，可给复合维生素 B 10 毫克，1 日 3 次；或舒筋活络丸，每次 1 丸，1 日 3 次。

如脊髓损伤严重，有脊髓休克或脊髓内外血肿，症状逐渐加重者，应请有关科室给予综合治疗。

在脊髓损伤恢复期，临床上还可根据患者下肢运动的情况，作出观察恢复时间的参考。据陈钟舜、田从豁报道：如搀扶行走时，一侧下肢运动困难，但向前迈步能超过健侧足尖时，一般可在 1~3 天内恢复正常；一侧完全无力行动时，则 3~5 天内恢复；两侧下肢运动障碍，但膝关节能向前用力时，一般在 1~2 周即可恢复；若双下肢完全瘫痪而无力活动时，则须 1 个月左右方能恢复。不过，如脊髓损伤严重，也可出现永久性损害，终身残疾。

【穴位层次解剖】

同前。

【操作要点】

风府穴的深面有脊髓上段，针刺时要注意进针的深度，稍有疏忽，极易损伤脊髓，故临床上一般以 1.5 寸为限，如要超过此数则应极度小心。深刺风府诸穴治疗精神分裂症，确有较好的疗效，但其具体操作应由有经验的医师施行，务必谨慎从事。其次，术者要熟悉风府穴不同层次的手下针感，一般可有两种阻力感：一是坚韧面有弹性的阻力，为项韧带、黄韧带或寰枕后膜阻挡之故，然后针下再出现空松感时，即说明针尖已进入椎管内硬膜外腔处；二是紧接空松感之后（深约 1.5 寸时），如针下再遇到柔软的阻力时，即提示针尖已刺到硬脊膜处，病人可能出现上下放散的酸胀

感，此时应立即出针，不应再深入或施行手法。最后，凡精神躁动病者，针刺风府穴时应固定体位，谨慎操作，尽量不留针；当病人有挣扎或拒针时，最好不要强用此穴。

十二、针刺风岩穴致死

【案例】

高××，男性，37岁，干部。因精神失常于1971年1月24日住某医院精神病科，诊断为精神分裂症。4月14日由两名护士做针刺治疗，选穴为风岩和合谷，留针数分钟，捻转后起针。当时病人感到头痛、乏力等不适，随即跌倒在地上，呼吸困难，意识不清。经针刺人中穴后稍有好转。但很快病情恶化，呈深昏迷状态，呼吸时有暂停，经抢救无效死亡。死后腰穿为陈旧性血性脑脊液。尸检所见：在延髓、桥脑部有 $4\times 3\times 3$ （厘米）大小之血肿，沿针刺通过部位有一陈旧性血道至血肿处，完全证实为施行针刺导致延髓、桥脑部血肿而致死^[19]。

【分析】

风岩穴属经外奇穴，它位于颈后上部，在耳垂下缘与哑门穴连线的中点前0.5寸处。根据现代解剖学，风岩穴的邻近深层有椎动脉、延髓下端、蛛网膜下腔等重要结构。当术者在临床操作时，由于针刺角度不当，或针刺深度过大，使针尖穿过寰枕后膜进入枕骨大孔，经蛛网膜下腔，刺到延髓下端，从而损伤延髓、桥脑，导致刺伤而出血，则影响呼吸中枢、循环中枢、呕吐中枢等功能，出现严重后果。

【临床表现】

延髓、桥脑受到针刺损伤，一开始可以不表现出明显症状，仅见患者有上下放射的触电感，有一定时间的潜伏期。但也可即时出现一系列较为严重的精神、神经症状，如头痛眼花、呕吐、出汗、恐慌惊叫、反应迟钝，随之出现昏迷、呼吸频率改变、循环功能紊乱等威胁病者生命的症状和体征，如不及时处理，后果极为严重。

【处理方法】

延髓、桥脑受损伤是针刺意外中最为危险的一种，预后多较凶险。对确诊延髓、桥脑损伤或疑似此症者，应严密观察其呼吸、血压、脉搏和意识状态，并及时联系有关科室进行积极抢救。如果损伤不重，抢救及时，措施正确，就可得救。

救治处理的原则是：①人工冬眠低温治疗，以降低脑组织的新陈代谢，提高脑组织的缺氧耐受能力；②保持呼吸道通畅，保证脑组织的氧分供应；③应用脱水剂及激素类，以控制脑水肿；④应用止痉剂以缓解肌张力增高；⑤采用能量合剂，促进脑功能恢复等。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：较厚，由耳大神经、枕小神经分布，其纤维来自第2、3颈神经。

2. 皮下组织：由脂肪组织及纤维结缔组织构成，内有第2、3颈神经和耳后动、静脉的分支和属支。

3. 胸锁乳突肌：其内、外两头分别起自胸骨柄的前面和锁骨的内侧端，斜向后上方止于颞骨的乳突，由副神经脊髓根及第2、3颈神经前支支配。

4. 头夹肌：位于胸锁乳突肌的深面，受颈中部脊神经后支的外侧支支配。

【操作要点】

风岩穴由于所处的位置较特殊，故针刺操作过程中，如果施术不当则会造成医疗事故，一定要掌握好本穴的安全针刺方法。一般说来，针刺的最佳方向是向下朝人中穴方向刺入，勿向后正中线（即脊柱方向）斜刺过深，以防将针刺入颅腔，损伤延髓、桥脑及血管，从而避免意外的发生。

十三、深刺四白穴导致眶周血管出血

【案例】

某一女性，23岁，埃及开罗大学学生。患者因右上、下眼睑

间歇性跳动已半年，来亚丁中国医疗队就医。脑神经检查未发现异常，视力正常，眼球运动及眼睑闭合良好。遂用1寸长毫针，刺入右侧四白穴深3分，留针5分钟。拔针后眶下出现李子大小之血肿，急按压及轻揉后血肿消失。第2天复诊时，见眶下及眼外角皮肤呈一片乌黑色。7天后出血全部被吸收，视力正常，未留遗任何后遗症^[1]。

【分析】

四白穴在眶下缘中点直下约1厘米，其深面正对着眶下孔，此孔为眶下动、静脉主干穿出眶下管处，加上眼眶内及周围血管分布相当丰富，这些血管纵横交错，形成血管网，位置表浅。如果在针刺眼周的四白诸穴时，术者不够谨慎，则容易伤及（因为动、静脉在眶下管内移动较困难而极易被刺伤），造成出血。如《铜人腧穴针灸图经》云：“四白……若针深则令人目乌色”，即明确说明了这一点。本案例正是由于术者未能因人施治，施术时针刺四白穴过深，刺入眶下管内而伤及眶下动、静脉，引起血管破损而致出血。

【临床表现】

临床症状的轻重与出血量有密切关系，而出血量则随损伤血管的大小、部位和损伤程度不同而有所区别。浅表小静脉、毛细血管损伤，主要表现为较小的出血斑块或少量的血液流出，很快可自行停止；如损伤小的动脉，则起针后有血液流出，或积于皮下形成血肿；如针刺伤及深层的血管，特别是动脉血管，往往会引起较大的内出血。现就四白穴针刺损伤眼周血管导致眼部血肿的症状做简单介绍。

轻症（系刺破浅层血管或较细小的动静脉分支所致）：多在拔针后，针孔有出血现象，当时局部未见异常；数小时后，穴区周围显现青紫色的瘀斑。

重症（为损及深层血管或重要的眼区动、静脉所致）：常在取针后数秒钟至半分钟内发生，出血侧眼睑迅速肿胀闭合，无法睁开；从第2日起，肿胀可逐渐消退，青紫色瘀斑据出血量多少，可波及整个眼睑或全部眼周区域。半月至20余日始可全部消退，一

般不影响眼的视觉和功能。

【处理方法】

轻症的浅表点滴出血，只需用消毒干棉球压迫针孔1~2分钟即可，可不予特殊处理。局部瘀斑亦可用热毛巾外敷，促进其消退。

重症的出血期应给予冷敷，以纱布蘸蒸馏水或冷开水冷敷局部15~20分钟，这有利于止血；血止后，可嘱患者用热毛巾热敷眼区，促进溢出血液的吸收，每次20~30分钟，每天2~3次。平时可盖上消毒的纱布眼罩，待眼睑肿胀消退后，去除眼罩，改为每日热敷1次，直至瘀斑完全消失。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：较薄，有三叉神经第2支——上颌神经的分支眶下神经分布。

2. 皮下组织：有眶下神经和面神经颧支的分支。血液供应主要来自眶下动脉的分支，也有面动脉的分支；静脉则与同名动脉伴行。

3. 眼轮匝肌与提上唇肌：穴位区为眼轮匝肌下部纤维（受面神经的颧支及颧支支配）与提上唇肌起始部纤维（受面神经颊支支配）交错之处。

4. 提口角肌：位于提上唇肌的深面，其起始部在取穴点略下方。

5. 眶下孔或上颌骨。

【操作要点】

四白穴的常规进针深度为0.2~0.3寸，一般针刺0.5寸即可刺到眶下孔，如需继续深入眶下管时，则应按45°角朝上、75°角朝外的角度向眶腔进针，但不宜刺入过深，若超过1寸可能刺伤眼球。为防止刺破眶下动脉，一般应选用细针，最好用30号或32号毫针；进针时宜用轻手法，如欲深刺要求缓慢送针，禁止采用提插或捻转手法，正常情况下不运针；出针时要缓慢退针，以分段退针法较佳（即退一段后略作停顿，再继续外退）；起针后，应用较干的酒精棉球按压片刻，以防出血。若针孔有血，更应延长按

压时间（经验表明，按压时间长可减轻眼周出血的程度）。此外，还要注意选择些体直、光滑、有弹性、无折痕锈蚀、针尖不带钩毛的毫针。对有止、凝血机制障碍的病人（如血友病）不盲目针刺，这些都可避免针刺四白穴导致眼周出血事故的发生。

十四、针刺百会穴导致脑出血

【案例】

某男性患者，59岁，退休干部。有高血压病及左侧偏瘫史，此次突发脑卒中，经住院21天，病情稳定后出院继续门诊针灸治疗。第1、2次针后感觉良好。第3次在针刺百会等穴过程中，患者突感头晕、出冷汗，拔针后随即出现呕吐，半小时左右即发生昏迷，尿失禁。3小时后由急诊收入我科。体格检查：体温39℃，血压25.3/16.0千帕（190/120毫米汞柱），脉搏92次/分。已陷入深昏迷，陈—施氏呼吸，明显心律不齐；左瞳孔直径3毫米，右瞳孔直径1.5毫米；双侧巴氏征（+）。急诊腰穿为均匀血性脑脊液。

立即施行脑内血肿简易穿刺引流术，放出鲜红色血性液25毫升，并置硅胶管一根，继续引流，5小时后又引出血性液10毫升。术后第2天，又引流出少量血性液。经气管切开、鼻饲、补液支持、脱水、细胞活化剂、控制感染等综合治疗，病情仍不断恶化。术后第3天，仍有陈旧性液不断流出，双眼球浮动。术后第4天，终因呼吸、循环衰竭而死亡^[7]。

【分析】

百会穴位于巅顶部，具有回阳固脱的作用。据实验研究表明，针刺百会穴具有明显的升高血压作用。其途径是通过相应的传入神经，将冲动传至脑干网状结构，然后通过植物神经，尤其是交感神经的兴奋，反射性地引起某些脏器的小血管收缩，外周阻力增加，心脏收缩功能加强，而使血压上升。但由于本例患者是慢性高血压病者，在其大脑、小脑等部位内，直径50~150微米的穿通动脉管壁常会发生脂肪玻璃样变（纤维素样坏死）而形成微动脉瘤，这些穿通动脉以垂直方向从主干分出，在变成网状的前

毛细血管前不发出分支，故很容易直接受到血压波动的影响而破裂。当针刺百会穴时，由于本穴的升高血压作用而使病人的血压明显增高，这样就造成病人的许多穿通动脉破裂出血并汇聚成血肿，引起脑水肿，严重时会自动从大脑镰下嵌向对侧或经天幕孔向下嵌压脑干，导致脑干缺血、出血和坏死而死亡。

【临床表现】

在针刺过程中或针后不久，患者突然出现头痛、头晕，出冷汗，频繁呕吐，重者呕吐物呈栗壳色，随即意识丧失而转入昏迷，面色潮红或苍白，呼吸深沉而有鼾音，大小便失禁，偶见抽搐，同时出现口角歪斜，肢体瘫痪。若抢救不及时，则能迅速导致死亡。

体征：血压骤然升高，瞳孔不等大，对光反射、角膜反射减弱或消失，颈硬，面肌、舌肌瘫痪，腹壁反射、提睾反射减弱或消失，偏身或交叉性感觉障碍，肌张力降低，腱反射先消失后亢进，同时出现病理征，视网膜出血及视乳头水肿。辅助检查：脑脊液压力增高，常为血性。脑超声波可显示中线波移位。头颅CT示出血、水肿等。

此外，尚需根据临床上的不同表现特征，将脑出血分为大脑半球出血、桥脑出血和小脑出血。

【处理方法】

1. 防止再出血：保持安静，尽量减少对病人不必要的搬动，躁动者可予以适当镇静剂。调整血压，过高者可肌注利血平 1 毫克，将血压维持在 20.0~21.3/12.0~13.3 千帕（150~160/90~100 毫米汞柱）为宜。可根据具体情况，短期使用止血药（但目前临床应用尚有争议），如 6-氨基己酸或抗血纤溶芳酸。

2. 降低颅内压：可选用 20% 甘露醇或 25% 山梨醇 250 毫升快速静滴；速尿 20~40 毫克溶于 5% 葡萄糖液 20~40 毫升中静注；利尿酸钠 25 毫克静脉推注；10% 甘油葡萄糖 250~500 毫升静滴。上述脱水剂和利尿剂可交替使用，每 6~8 小时使用 1 次为宜。

3. 降温疗法：一般以冰水或冰帽作头部局部降温，这样可降低脑代谢率和耗氧量，有利于减轻脑水肿及脑细胞功能的恢复。

4. 防治并发症：注意保持患者呼吸道通畅，防治褥疮、胃出血、尿道感染和循环功能紊乱等并发症。

5. 维持营养及水、电解质和酸碱平衡：昏迷病者可先禁食1~2天，从静脉内补充营养和水分，每日总量1500~2000毫升为宜；以后如无呕吐或消化道出血，可酌情开始鼻饲，并随时注意补充电解质、维生素、脑细胞功能活化剂，及时纠正酸碱平衡失调等。

6. 中医治疗：若闭证可鼻饲至宝丹或苏合香丸，脱证可用参附龙牡汤或独参汤。针灸治疗，闭证可取人中、涌泉、太冲、内关、曲池、丰隆、十二井等穴，脱证取关元、神阙、足三里、气海等穴。耳穴可选用耳尖、心、肝、肾、皮质下、相应肢体；尚可配合穴位（同体针）注射，药物以当归注射液、复方丹参注射液、田七注射液、维生素B族注射液、胞二磷胆碱等。

7. 血肿穿刺引流：若无开颅手术条件，可行颅骨钻孔血肿穿刺引流术。

8. 手术治疗：本法目的在于清除血肿，降低颅内压力，缓解脑疝，改善脑血液循环，故当出现手术适应证时宜尽早施行手术。但要注意手术的禁忌症。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：有颅前部来的眶上神经、颅后部来的枕大神经和颅两侧来的耳颞神经。眶上神经是三叉神经第1支（眼神经）的分支，经眶上孔或眶上切迹至额部皮下，分布于额顶部的皮肤；枕大神经为第2颈神经后支的内侧支，分布于颅顶部皮肤；耳颞神经为三叉神经第3支（下颌神经）的分支，分布于外耳道、耳郭及颞区的皮肤。

2. 皮下组织：内有眶上神经、枕大神经、耳颞神经和枕动静脉、颞浅动静脉的吻合网，并有许多垂直的纤维束把脂肪分成无数小格（这些纤维束上连皮肤，下连帽状腱膜）。枕动脉为颈外动脉的分支，分布于颅顶的后部；枕静脉与枕动脉伴行，注入颈外静脉；颞浅动脉是颈外动脉的终支之一，为颈外动脉在下颌颈高度向上的直接延续，它分支营养腮腺及额、顶、颞部的肌肉和皮

肤；颞浅静脉与同名动脉伴行，位于皮下，注入下颌后静脉。

3. 帽状腱膜：为坚韧致密的结缔组织膜，前连枕额肌额腹，后连枕额肌枕腹，两侧逐渐变薄续于颞筋膜浅层。帽状腱膜与皮下组织、皮肤紧密愈着，合称为头皮。

4. 腱膜下疏松结缔组织：为头皮与颅骨外膜之间的一薄层疏松结缔组织，又称腱膜下隙，此隙前至眶部，后达上顶线，范围较广。

5. 颅骨外膜及颅骨：颅骨外膜薄而致密，与颅顶骨作疏松连结，针尖在此穴所碰及的颅骨为顶骨。

【操作要点】

本穴在操作过程中，患者最好取正坐位或仰卧位，术者进针时手法要轻重适宜；针尖可向前、后、左、右平刺，深度为0.5~1寸，一般都有胀、重、痛感，得气后不宜用力提插和捻转。退针后应该用干棉球按压片刻，以防出血（由于本穴深处的皮下组织中有丰富的纤维束和血管，针尖进入此层时易伤及血管而致出血）。此外，对血压过高且不稳定的有动脉硬化的病人，特别是有中风史者，可暂勿针刺。待血压平稳后，再施针灸疗法，以免发生严重的意外事故。

十五、耳穴疗法引起耳部感染

【案例1】

某一男性患者，30岁。原有慢性肝炎，在内科用耳针穴位注射治疗。但由于消毒不严，造成双耳甲腔处感染，病情进展很快。检查见局部极度肿胀潮红，疼痛剧烈，已有脓点出现（仍未破溃）。即请五官科会诊，及时给患者进行手术扩创，将腐烂组织彻底清除，并见两耳壳相当于胃部穴位约有花生米大小之软骨已遭破坏。术后行紫外线照射，局部涂多花野牡丹药膏消炎，全身控制感染用抗生素及中药清热解毒汤剂（蒲公英、金银花、穿山甲、白芷、甘草等酌情加减），每日1剂。经过30天的治疗，痊愈出院，未发现畸形^[20]。

【案例 2】

某患者，因不慎扭伤腰部而在当地诊所行针刺疗法，选取左耳穴为主。但由于消毒不严，病者左耳于术后两天即发炎，局部红肿疼痛并化脓，伴全身发热。1 星期后在当地某医院行切开术，因病情有增无减而住院治疗。1 个月内先后扩创 4 次，曾用多种抗生素，仍未控制，因被建议割除患耳，乃转中医治疗。其时全身发热已退，左耳红肿疼痛，连及耳壳背部，耳腔内及耳垂处共有疮口 6 个，伴有脓血性分泌物。经扩创排脓、艾熏、中药等疗法，2 次后局部红肿疼痛已退，但疮口脓水仍多，至第 8 日疮口愈合 4 处，第 14 日全部愈合^[21]。

【案例 3】

某一女性患者，47 岁，职员。在当地进行减肥治疗时，于右耳埋入一耳针，之后出现耳部红肿疼痛。开始，患者自己用过氧化氢清洗患部，并敷以消炎软膏，但此法并不奏效。于是到医院检查，诊断为耳软骨炎。白细胞计数达 20000/立方毫米。即住院治疗，给予注射庆大霉素（有青霉素过敏史），并采用清创术、引流等。2 周后炎症控制，但耳部软骨组织已大部分纤维化^[22]。

【分析】

自耳针疗法广泛开展以来，它越来越受到患者的欢迎，但由于消毒不严等原因引起的耳郭感染（最主要的是耳壳感染和耳软骨膜炎）这一针刺意外，亦不断有所发生，应予以足够的警惕。耳郭是由弹性软骨和少量的脂肪及结缔组织所构成，外覆以皮肤。虽然耳郭表面普遍地存在着微生物，但由于人体具有局部和全身的防御功能，所以在正常情况下并不致病。当针刺损伤了皮肤表面时，致病菌即能趁虚侵入耳郭，引起该处组织发生炎症反应，局部血管通透性和血清蛋白渗出增加，从而出现红、肿、热、痛等感染的临床表现。由于耳郭凹面的皮肤与软骨紧贴，皮下组织甚少，血液循环也较差，在感染后血肿或渗出物则难于自然吸收，故耳部感染不易治疗，若波及软骨就更难治愈。严重者可导致软骨坏死、萎缩而畸变。因此，对耳穴局部皮肤进行严格消毒，是耳针疗法避免发生感染的前提条件。

【临床表现】

耳部感染可分为浅表感染和软骨（膜）炎两类。

1. 浅表感染：针眼处局部皮肤红肿，表皮破损，周围皮肤充血，有轻微疼痛，并伴有少量渗出液等症状，一般都没有明显的全身症状。

2. 耳软骨（膜）炎：施术部位有明显的红、肿、热、痛，严重者整个耳郭发红肿胀，最后形成脓肿，伴有功能障碍。常有明显的全身症状，如发热、头痛、全身不适、乏力、食欲减退和白细胞计数增高等。

【处理方法】

1. 浅表感染：耳郭感染一旦发生，应积极采取治疗措施（可防止病情的进一步发展）。只要处理及时，一般3~5天后即可获得痊愈。其方法是：①局部涂擦2.5%碘酒，每日3次，或用蜂蜜涂敷锡类散，每日2~3次；②用芙蓉膏外敷，每日换1次。或用新鲜乌敛梅洗净捣烂外敷，每日换2~3次；③局部热敷，或用氦氖激光局部照射，每日1次，每次3~5分钟，稍事休息后再用肤轻松软膏外敷，每日3次；④可施行针刺疗法，穴取神门、合谷，予中等量刺激，每日1次。

2. 耳软骨（膜）炎：临床上以耳软骨膜炎多见，而耳软骨炎更为严重，治疗也比较困难。现将其主要治疗方法介绍如下：①磁疗：可用钐钴、铈钴等磁片（磁场强度以1500高斯为宜，因为两块磁片异名极若吸力过大，在夹住耳壳时易引起耳郭血液循环障碍，疼痛加剧，甚则可发生软骨压迫性坏死），先用一层薄棉花或纱布包好磁片，异名极对置于病变部位，即夹贴于耳郭腹背两侧，然后用胶布固定，开始隔2~3天来诊1次，以后可改为每周复诊1次。至于磁片的大小，则根据病变范围而选用，磁片表面面积不宜过小，最低要和病变范围相等，或最好略大一些，否则会影响疗效；②艾灸：用点燃的艾条，直接灸烤耳郭炎症最显著处，距离以患者能耐受为度，每次15~20分钟，每天2~3次，直至病灶液体全部吸收，炎症消失为止。若为化脓病灶，则先经消毒后用血管钳扩大伤口，将脓液全部排出后再行灸烤；③如果病情较

重，或上述两法无效时，则需要用手术治疗，包括清创、引流等法；单纯采用切开、引流之法，仍不能有效地阻止炎症的发展，可试用耳郭方格切除术；④中药治疗：用紫花地丁 30 克、半边莲 15 克、银花 15 克、连翘 9 克、黄芩 9 克、夏枯草 9 克、山栀 9 克、甘草 9 克、赤芍 9 克、丹皮 9 克，每日 1 剂，水煎服；同时，要配合外治法，在患耳红肿热痛处用蜂蜜将如意金黄散调成糊状外敷，或用黄连膏纱布将九一丹盖贴于创口处，均为每日换药 1 次。

【操作要点】

在进行耳针疗法之前，术者必须严格执行消毒制度，如耳针针具都要高温消毒；施术前应先以棉签蘸 2.5% 碘酒消毒整个耳郭，然后用 75% 酒精棉球脱碘，待皮肤表面干燥之后，再作针刺。这是预防耳郭感染的关键。此外，要了解各种不同方法操作的注意事项，如耳穴压丸是一种简单安全的方法，但揉按时间过长或手法过重，亦可造成皮肤破损而发炎，故应该注意避免（一般认为以有节奏的单纯按压手法较好）；耳穴毫针针刺后，应及时用消毒干棉球轻轻揉按针孔，并嘱患者注意局部清洁，谨防感染；施行三棱针点刺或手术刀割治，则不宜刺入过深，一般划破表皮即可；施行耳穴埋针术后，应用小块胶布（医用）固定，埋针时间不宜过长，2~3 天要换 1 次，夏天还要缩短（若埋针 1~2 天，患者自觉局部胀痛不适，或按压时特别疼痛，则要及时请医生取下，检查有否红、肿等现象，不可误以为耳针刺刺激愈痛愈好，贻误治疗时机）。

十六、耳穴贴压引起血压升高

【案例 1】

某一男性高血压患者，49 岁。按治疗分组常规贴敷磁珠，2 小时后自觉头昏、心中不适加重，至 48 小时的时候，头痛欲裂，血压由治疗前 25.3/13.3 千帕（190/100 毫米汞柱）增至 30.7/16 千帕（230/120 毫米汞柱）。随即取下磁珠，用拔罐法迅速降压，该

副作用即时解除，半小时后血压仍为 25.3/13.3 千帕^[23]。

【案例 2】

平××，男，47 岁，干部。1983 年 3 月因工作繁忙及情志不畅等原因，导致头痛、眩晕等，查体时血压为 29.3/13.3 千帕（220/100 毫米汞柱），诊为高血压。即刻在患者耳背的降压沟行压豆降压疗法，2 分钟后，患者自述左耳部有灼热感，压豆处跳痛，继而出现胸闷、烦躁不安、面色暗红、口唇紫绀，头痛头晕明显加重，颈静脉及颞浅静脉怒张，马上测血压为 33.3/17.3 千帕（250/130 毫米汞柱），速将压豆取去，5 分钟后患者则平静如初，测血压为 28.0/13.3 千帕（210/100 毫米汞柱）^[24]。

【案例 3】

刘××，女性，45 岁，工人。患高血压病 10 余年。行耳穴压豆治疗，选取肝、肾、三焦、心诸穴，并停服降压药物，血压维持在 18.7/12.0 千帕（140/90 毫米汞柱）左右。某次加取降压沟压豆后 5 分钟，患者自觉头痛、头晕、眼花、耳鸣，伴心烦不安，测血压为 24.6/17.3 千帕（186/130 毫米汞柱），速去降压沟耳豆，并在肝阳₁、肝阳₂两穴各压 1 豆，10 分钟后患者自觉诸症减轻，测血压为 20.0/14.0 千帕（150/106 毫米汞柱）^[24]。

【分析】

耳穴贴敷治疗高血压病，据临床观察大部分病人都能收到降压的效果，其疗效已被证实。但是，也有少数病人在施术后反而引起血压明显升高，必须对此给予足够的重视。耳贴疗法导致升压的机理目前尚未清楚，极可能与迷走神经耳支的作用有关。耳甲腔和外耳道的后壁及下壁由迷走神经耳支分布，而迷走神经为混合性神经，起自延髓的迷走神经背核。当冲动通过传入神经传至大脑时，可使大脑皮质兴奋和抑制过程的平衡失调，以至不能正常行使调节和控制皮质下中枢的功能。如皮质下血管舒缩中枢出现相对固定的以发放收缩血管冲动为主的兴奋时，则可引起全身小动脉痉挛，周围阻力增加，血压升高。以上仅为笔者的观点，仅供同道参考，以共同探讨耳穴贴敷的双相治疗作用及其机理。

【临床表现】

在施术过程中，患者突觉头痛（多发在枕部）、头晕、头胀，伴有眼花、耳鸣、烦闷、心悸、乏力，四肢麻木，亦可有注意力不集中、颈部扳住感等；血压显著升高，舒张压多持续在 17.3 千帕（130 毫米汞柱）或更高。

【处理方法】

高血压的诊断一经确立，即应考虑给予处理，其步骤是，马上去除引起血压升高的耳穴贴敷，并让患者卧床休息。烦躁不安者可适当口服少量镇静剂（如安定 2.5 毫克，温水冲服），一般 10 分钟左右症状即可缓解。如果血压依然没有降低，可给予心痛定 10 毫克含服，或肌注利血平 0.5 毫克，配合针刺曲池、足三里穴即可。

十七、耳针引起晕针

【案例 1】

一家庭妇女，患更年期高血压 6 年。服药、针灸效果均不佳，后改用耳针疗法，血压波动在 23.0~25.7/13.5 千帕（170~190/100 毫米汞柱）水平。1972 年 9 月 6 日再次施行耳针时，选取心、交感、降压点穴，留针 15 分钟后，患者感到头晕、眼花、胸闷、恶心等，即立刻拔针。让患者平卧，喝热开水一杯，片刻诸症消失，但大汗一身，心率每分钟 56 次，此时血压降至 14.9/10.8 千帕（110/80 毫米汞柱）。随访半年，患者未服任何降压药或针灸治疗，其血压仍维持在 16.2~18.4/9.5~10.8 千帕（120~136/70~80 毫米汞柱）之间^[25]。

【案例 2】

吴××，女性，51 岁，干部。因左肩部及左侧足趾痛多年，于 1990 年 4 月 5 日就诊。患者有风湿病史，平素对针灸有畏惧感，这次在朋友的劝说及陪同下前来治疗。拟诊为痹证，施行耳针疗法。按常规消毒后，选取左耳的神门、肩、肘、趾、皮质下诸穴，刚把毫针刺入所有穴位，患者即诉头晕、胸闷，见其面色苍白、神

色不安、发音含糊，右手频频摇动。立刻拔针，让其平卧抬高下肢，艾灸百会穴。约7分钟后患者面色逐渐正常，言语转清晰，诸症消失。半个月后随访该患者，未见异常。

【案例3】

某男性患者，42岁，干部。因患胆结石症2年（经省×医院临床物理检查确诊），反复发作多次，曾先后4次住院治疗，但未根除。经人介绍来诊，行耳穴压豆治疗。当治疗到第2次（轮换到左耳时），按压耳穴施予强刺激时，病人感觉心慌、气短、上腹疼痛、恶心欲吐，伴乏力，血压下降致休克状态。立即给予硫酸阿托品1毫克、杜冷丁50毫克肌肉注射，再肌肉注射升脉散4毫升，1个多小时后病情好转，患者口唇及颜面转淡红，四肢温暖，神志清楚，血压12.0~14.7/6.7~10.7千帕（90~110/50~80毫米汞柱），脉搏64次，除体倦乏力外其他正常。当晚，患者再次按压刺激上述穴位时，亦出现上述同样情况，重复使用上述治疗后缓解^[26]。

【分析】

晕针，在针灸临床上颇为常见，属于反射性晕厥中的血管抑制性晕厥。虽然目前对晕针发生机理的解释尚有分歧，但大多数学者都认为，这种情况主要是由于针刺对人体的强烈刺激，通过迷走神经的反射（耳郭主要是由迷走神经耳支分布），引起全身外周小血管的扩张，外周血管的阻力降低，回心血量明显减少，加上心跳的减慢、减弱，因而心脏输出量降低，血压下降，造成一时性、广泛性的大脑供血不足或脑缺血所致。本节3个案例都是在刺激耳穴时，反射性地刺激迷走神经兴奋，引起血压下降，脑部发生短暂性缺血而晕针。

【临床表现】

晕针一般发生在耳针疗法的施术过程中，典型的晕针一般可分为三期。

先兆期：病人有各种感觉的错乱，如眼花、耳鸣、头昏、心悸、上腹部或全身不适等，亦有面色苍白、恶心欲吐等。

发作期：轻者出现头晕胸闷，恶心呕吐，肢体发软发凉，摇

晃不稳，或伴瞬间意识丧失；重者突然昏迷，扑倒于地，唇甲青紫，大汗淋漓，面色灰白，双眼上翻，二便失禁。少数可伴有惊厥发作。

恢复期：轻者仅有稍微不适，多数患者可有显著的疲倦，头昏，嗜睡，汗出及全身不适感，短则几分钟、长则几个小时，症状才能逐渐消除。

此外，临床上还有另一分法，即根据症状表现将晕针分为轻、中、重三度。①轻度：针刺过程中患者自诉头晕目眩，胸闷乏力，但呼吸、脉搏仍正常；②中度：头晕，心慌，恶心，呕吐，面色苍白，汗出肢冷，脉搏变细；③重度：全身厥冷，大汗淋漓，血压下降，脉搏细弱，呈昏厥状态。

【处理方法】

1. 常规护理：迅速拔出所有的毫针或压豆，将患者扶至空气流通处，并让其仰卧在床上，头低脚高位；及时松解患者衣带，热天注意通风，冷天注意保暖；立刻测量呼吸、血压、脉搏以及心率。

2. 轻者一般静卧片刻即可，如果患者仍感不适，可给予温糖水或热茶口服，并注意使之安静和休息，约经3~5分钟即可逐渐恢复。

3. 重者可在上述处理的基础上，用指掐或针刺人中、素髌、足三里、涌泉，或艾灸百会、关元、气海等穴；嗅以氨水；必要时可用肾上腺素1毫升、阿托品1毫克肌注，25%葡萄糖40毫升静脉推注等。

【操作要点】

晕针是针灸意外中最常遇到的一种类型，虽然大多数患者的预后是良好的，不会留有后遗症，但仍应给予足够的重视，尽量避免或减少这种情况的发生。一般而言，为了防止耳针的晕针，临床施术时要注意：首先，做好心理预防，对那些对耳针有猜疑、恐惧心理的患者，可通过语言诱导、转移注意力、松弛训练等方法，使其紧张情绪得以放松，以取得患者的信任和配合；其次，努力做好预防工作，饥饿者施术前应适当进食，过度疲劳或激烈活动

后者应稍加休息再施术，对年老体弱者取穴不宜过多、操作手法亦不宜过强，这样才可减少晕针的产生。

十八、针挑舌系带引起败血症

【案例】

一出生 80 天的女婴，为第 1 胎，足月顺产。因“舌系带过短”，由某人用未消毒针头挑拨舌系带，当时即有出血，次日发高烧（体温 39℃），第 3 天出现气急、惊厥、口吐白沫而入院。体检：体温 39℃，脉搏每分钟 160 次，呼吸每分钟 60 次，呈昏迷状态，营养发育中等，面色苍白，反应差，口唇紫绀，气急，皮肤及巩膜轻度黄染，瞳孔对光反应迟钝，舌系带有伤痕，颈软，两肺痰鸣音，心音低无杂音，肝肋下 4 厘米，剑突下 1.5 厘米，四肢发冷，脉细速。红细胞为 $3.56 \times 10^{12}/L$ ，血色素 110g/L，白细胞 $11 \times 10^9/L$ ，中性 0.65，淋巴 0.35，血培养出金黄色葡萄球菌，凝固酶阳性。诊断为败血症及中毒性脑病。入院后静注氨苄青霉素、先锋霉素、激素、血浆等措施，抢救 7 小时无效死亡^[27]。

【分析】

败血症是致病菌或条件致病菌侵入人体血循环而发生的全身性感染，病原菌在血循环中可生长、繁殖，产生内毒素、外毒素等。一般情况下，正常人体具有广泛而有效的防御和免疫功能，能防止细菌入侵，或迅速将侵入的细菌杀灭。细菌入侵后是否会引起感染或败血症，虽与细菌的毒力、数量等有密切关系，但主要取决于人体防御、免疫功能的完整性。而完好的皮肤和粘膜是防止细菌侵入机体的天然屏障，破损后则易于导致细菌感染，加上皮肤和粘膜的血管和淋巴管很丰富，细菌也易通过淋巴径路或直接侵入血循环中，引发败血症。本案例正是由于术者的消毒观念淡薄，操作时使用未经消毒的针具，结果在针挑婴儿的舌系带后，破坏了局部的防御功能，细菌乘机侵入并迅速进入血液（因为口腔粘膜下层的血管和淋巴管特别丰富），导致败血症的发生。此外，由于婴儿的中枢神经系统尚未发育完全，免疫功能低下，网状内

皮系统和白细胞的吞噬作用薄弱，且淋巴结局限细菌的效能也不强，所以败血症所造成的后果亦非常严重，容易并发脑、心等迁徙性损害。

【临床表现】

多数病者都在施行针挑疗法后不久急骤起病（无明显的潜伏期），反复出现高热寒战（热型多为弛张热或间歇热，也有稽留热、不规则热或持续低热），表现出不同程度的大汗出、脉搏快速、体温波动幅度大、头痛、全身痛等明显中毒症状，并伴有关节疼痛、皮肤瘀点、脾肝肿大等；严重者可出现神志障碍、谵妄、昏迷及休克，以及迁徙性损害或脓肿等。部分患者可发生黄疸、鼻衄、惊厥等。

实验室检查：血象中白细胞及中性粒细胞明显增加，带有明显核左移及白细胞内中毒颗粒，嗜酸性粒细胞减少或消失；年老体弱者或机体反应低下以及部分革兰阴性细菌感染者，白细胞总数可正常或稍减少。血及脊髓培养阳性（血培养分离病原菌最为重要），如与局部病灶分泌物（脓液、尿液、胸水、脑脊液等）培养所得细菌一致，则更可确诊。

【处理方法】

1. 一般治疗：卧床休息，给予足量的营养和维生素 B、C；补充适量液体，注意水、电解质和酸碱平衡；增强机体抵抗力，酌情输血、血浆、白蛋白，亦可肌肉注射丙种球蛋白；加强护理，注意患者口腔卫生，预防褥疮，如有感染灶应彻底清除。

2. 对症治疗：毒血症症状严重者，在足量有效的抗菌药物应用的同时，可短程静滴肾上腺皮质激素，如氢化可的松 100～300 毫克/日。伴有感染性休克或 DIC、心或肾功能不全者，则应及时作相应的处理。

3. 抗生素治疗：病原菌尚未分离出而病情比较危重者，可根据感染途径及临床表现估计用药。估计为革兰阳性球菌者，首选大剂量青霉素 G 静注，每日 1000～2000 万单位，并可联合庆大霉素或链霉素应用；估计为革兰阴性杆菌者，首选庆大霉素 16～24 万单位，或卡那霉素 1.4～1.5 克（均为每日用量），与羧苄青霉

素联合静脉滴注。如果致病菌的种类基本肯定或已得到阳性培养结果，则可根据临床实践经验，并参考药敏试验而选用抗生素。例如金葡菌败血症可首选红霉素加氯霉素联合用药，大肠杆菌败血症可采用氨基糖苷类中的一种与氯霉素、四环素族抗生素等联合用药，产碱杆菌败血症可大剂量静滴青霉素G，厌氧杆菌败血症可用氯林可霉素或氯霉素静滴。抗生素应用时开始剂量要求大些，疗程一般为3~4周，或在体温恢复正常、临床症状消失后续用2周。

4. 局部病灶的处理：脓性病灶需及时切开引流，化脓性心包炎、脓胸及化脓性关节炎等可在穿刺引流后在局部注入一些抗生素，胆道或泌尿道感染具有梗塞者应考虑手术治疗。

5. 中药治疗：各种致病菌导致的败血症，辨证后配合中药治疗，则可缩短病程、提高疗效，特别对应用抗生素无效的败血症更有意义。如热毒炽盛型，方选五味消毒饮合黄连解毒汤或清热地黄汤；湿热蕴结型，方选茵陈蒿汤合黄芩滑石汤；热毒伤阴型，方选增液汤或竹叶黄芪汤合黄连解毒汤；阳气虚弱型，方选透脓散、托里消毒散加减。

【操作要点】

针挑疗法是针灸临床上疗效较佳的一种治疗方法，可以用来治疗多种常见病，但由于忽视消毒而引起感染并造成严重后果的事故，却屡有发生。因此在施术时一定要注意消毒的问题，尽量杜绝感染的发生。为了预防针刺感染，应做好以下几点：首先，必须树立严格的无菌观念，对针具的消毒给予足够的重视，操作时要使用消毒干净的针，而用过的针具再次使用前一定得重新消毒（目前临床上多采用高压消毒，其具体方法是将针具用纱布包裹好，放在高压蒸气锅内，在15磅汽压、120℃高温下，保持15分钟以上。在条件不具备或应急的情况下，可将针具置于净水锅内，煮沸后再煮15分钟以上，或采用75%酒精浸泡20~30分钟）；其次，做好每个针挑部位的消毒，一般是每个穴位用一个酒精棉球消毒（棉球不可太干或太湿，亦不可撕开再用），不要一个棉球消毒数个穴位。在舌系带、眼眶等部位消毒更应严格，施术一定要待酒精完全蒸发后才可进行；再次，要消毒好术者的手指，其方

法是先用左手持镊子夹住酒精棉球，自右手指尖擦拭至指根部，换一棉球再依法消毒其余部分，待酒精蒸发干后，右手持酒精棉球消毒左侧手指；最后，施术完毕后，由于针挑术遗留针孔较大，故应用一较干的消毒棉球轻轻按压片刻，并嘱患者注意保持局部清洁，谨防感染。

十九、头部穴位遗针

【案例 1】

男性，65 岁。于 1958 年 12 月因头昏、右手痛接受针刺治疗（以往无高血压史）。嘱患者取坐位，针右侧外关、百会穴，常规消毒后用 1 寸毫针刺入，留针 20 分钟后起针。患者当时戴帽子回家，并未注意，抵家脱帽时才感头顶处不适，用手摸之，方发现百会穴（即头顶）上的针仍在头上，遂自行将针拔出，第 2 天带回^[1]。

【案例 2】

张××，女性，59 岁，1992 年 3 月 19 日初诊。自述左偏头痛 4 天。病史：4 天前生气后出现左侧偏头痛及面部窜痛，痛甚时欲呕，用手按压痛处稍可缓解，伴头晕、眠差多梦，平素有左侧耳鸣时重时轻，胃纳可，大便调，尿黄，舌红，苔黄略腻，脉沉滑，血压 24/12 千帕。既往有高血压病及糖尿病，现服降糖药维持。辨证：素有湿热内蕴，此次因五志过极，肝郁化火，夹胆火循经上犯，而致偏头疼痛。予针刺治疗，穴取足临泣、外关、太冲为主，配左侧太阳和风池。针后头痛头晕症状即减轻，血压降低（22/12 千帕）。连续针治 7 次，头痛头晕消失，睡眠转佳，左耳鸣轻微，仍不时有头胀感。依法再调治 1 疗程。第 10 次针刺完毕后，因术者临时有急事，故嘱某实习生拔针，结果遗留风池穴处的针未起出，患者起身照镜时发现，方予拔出。

【案例 3】

时×，男性，45 岁，1993 年 6 月 17 日初诊。家属代诉：行走不利，伴言行失常 1 年。病史：缘于 1992 年 5 月突然昏倒，不

省人事，CT示：“蛛网膜下腔出血”，经抢救神清，但继则出现狂躁等精神神经症状，双下肢行走不利，西医诊断为脑血管病引起的痴呆、行为冲动状态。1993年初磁共振提示：“双额叶、颞叶梗塞；脑萎缩”。经多方诊治，进步不大。现症见：行走呈小步慌张步态，姿势笨拙，起步及停止较困难，言语滑稽，出语冲人，词不达意，口干欲饮，睡眠及胃纳尚可，二便调，舌红偏暗，苔厚微黄，脉细弱。辨证：肝肾亏虚，筋脉失养，虚阳上扰神明。取穴：四神聪、率谷、大椎、身柱、命门、曲池、后溪、阳陵泉、申脉、风池，隔日针刺1次。针4次后，走路姿势明显好转，留针时情绪较安静；继续调治10余次，步态渐稳，能大步向前行走，起步及停止速度加快，神情较安逸，多语渐少，已可自控，思维较正常。第15次施术完毕后，患者起身穿戴衣帽时，其爱人突然发现他的头顶处四神聪穴仍遗留有一针，方请医生取出。

【分析】

遗针是指术者在针灸治疗完毕后，将针遗忘在病人身上而未拔尽。这种情况的发生，主要原因有两种：①医生的责任感不强，没有充分认识到“毫针虽小，责任重大”的道理，退针时不是专心致志观察病人，而是去注意周围的其他事情，结果将刺在毛发遮蔽部位的毫针遗忘，造成遗针的意外；②术者在毫针留针之后，或当人多忙乱之际，或由他人代为起针时，由于事先未予留意或说明留针的数目，结果仍有一、二根毫针遗留于病人头部，待病人自己触及时才发现。本节3个案例都是由于上述原因而导致遗针的。

【临床表现】

患者于针刺完毕后，在梳理头发、行走跑跳、睡觉时头部贴枕，或作某种活动时，突然感觉到某处（曾经施行针刺过的地方）疼痛，用手触及时才发现有针遗留。而这遗针的部位，多在毛发密长、腰背尾骶或衣物遮蔽的地方。

【处理方法】

当发现有遗针时，患者不应慌张失措，若仍在医院，则可请施术的医生将针取出；若患者已回到家里，则可请家属帮忙，轻

轻顺着针刺的方向将针拔出，并用干棉球按压针孔片刻，以防出血。

二十、针刺哑门穴导致蛛网膜下腔出血

【案例 1】

陈××，男性，40岁，工人。患双侧完全性耳聋，诊断为神经性耳聋，曾予针灸及维生素B₁穴位注射治疗，3个月未见效果。于1972年6月27日由某团卫生队卫生员继续施行针刺治疗。在第4次针刺哑门穴后，病人当即自觉针感不好，继而头痛，但还能忍受，缓解后仍能帮助生产队收麦及打铁两天。第3天工作时出现头痛加剧，伴有呕吐、面色苍白，马上来卫生队门诊，给予一般处理。次日凌晨又来急诊，病情加重，考虑为脑血管意外，经抢救无效死亡^[10]。

【案例 2】

一患者，女性，35岁，因6天前瘧病发作而来诊。医生予针刺哑门穴，当即感到颈部酸胀，约3小时之后出现剧烈头痛、频繁呕吐。检查：神志清楚，血压18.7/13.3千帕（140/100毫米汞柱），脉搏每分钟73次，呼吸每分钟28次，眼底正常，双侧瞳孔等大，对光反射灵敏，眼球活动良好，四肢活动正常，但颈部有抵抗，腰椎穿刺脑脊液呈均匀血性，压力2.35千帕（240毫米水柱），红细胞计数2.625/立方毫米。诊断为外伤性蛛网膜下腔出血。当即住院治疗，经卧床休息、对症治疗12天，腰椎穿刺脑脊液黄色透明，压力1.27千帕（130毫米水柱），16天后痊愈出院^[15]。

【案例 3】

某一男性患者，24岁，因聋哑在当地医院行针刺治疗。于1968年12月17日上午11时左右，在针刺哑门穴后，患者即感头部不适、疼痛，约1小时后头痛明显加重，伴恶心、呕吐，又返回医院复诊。给链霉素治疗后嘱回家休息。两天后病情继续加重，且不能进食而收住我院。体检：神清，聋哑，表情痛苦，体温37.2℃，

血压 16.0/10.7 千帕 (120/80 毫米汞柱), 颈强, 克氏征 (+), 内科及神经系统检查余无异常, 腰椎穿刺脑脊液呈均匀血性, 不凝固, 压力 2.26 千帕 (230 毫米水柱)。诊断: 蛛网膜下腔出血。经卧床休息、镇静止痛、降颅压、抗感染等处理, 症状逐渐消失, 住院 24 天痊愈^[9]。

【案例 4】

某 15 岁的女性患者, 为治疗聋哑, 用 3 寸长毫针针刺哑门穴, 予强刺激手法, 针感极为明显。当日下午病者表示头昏、头痛, 症状逐渐加重, 3 天后出现恶心呕吐而收住院。检查: 体温 37.4℃, 脉搏每分钟 80 次, 血压 14.7/10.7 千帕 (110/80 毫米汞柱), 神志清楚, 查体合作, 因聋哑不能答话。颈硬有抵抗, 12 对颅神经及肌张力检查正常。腱反射存在, 跟腱反射亢进, 腹壁反射较灵敏, 克氏征 (+), 余病理反射未引出。腰椎穿刺脑脊液呈淡红色, 压力 1.45 千帕 (148 毫米水柱), 血象见白细胞 10040, 中性 85%, 单核 3%, 淋巴 12%。诊断: 蛛网膜下腔出血。入院后经卧床休息, 肌肉注射安络血、维生素 K, 静脉滴注青霉素、链霉素等, 18 天后症状全部消失, 检查神经系统无阳性体征, 痊愈出院^[11]。

【案例 5】

某患者, 男, 27 岁, 于 1978 年 3 月 2 日入院, 患者入院前 5 天因酒后说话不清, 喝水呛及咽下困难, 到某医院诊治, 医生给予针刺治疗, 穴取哑门。针刺后病人感到颈部不适, 头痛, 恶心欲吐, 遂转来本院。既往体健。检查: 体温 36℃, 血压 20.0/10.7 千帕 (150/80 毫米汞柱), 神志清楚, 内科检查无异常发现。眼底正常, 构音欠清, 饮水返呛, 软腭上举对称, 咽反射消失, 四肢肌力及肌张力正常; 项强, 克氏征阳性。腰穿脑脊液为均匀一致血性, 离心后上清液为浅黄色, 压力 1.77 千帕 (180 毫米水柱), 镜下红细胞部分皱缩, 蛋白 212 毫克%, 糖 67 毫克%。临床诊断: ①蛛网膜下腔出血; ②球型格林巴利综合征。经镇静、止血和激素治疗 17 天后病情明显恢复, 复查腰穿脑脊液外观为浅黄色, 压力正常, Pandy 试验 (±), 红细胞 4, 白细胞 19, 单核多于多核, 蛋白 55 毫克%, 糖 47 毫克%。住院 20 天痊愈出院^[13]。

【案例 6】

某患者，男，60 岁，工人。因左面部顽固性阵发性痉挛，在某卫生所接受针刺治疗。开始两次用毫针针刺无不适反应，第 3 次改用自制钢丝粗针行颈后哑门诸穴针刺。病者为头前倾坐位，当针刺入深部后，病人突觉全身电击样麻痛及四肢软弱无力，继之头痛，恶心呕吐，进行性加重，意识由清醒变为嗜睡，针刺后 5 小时收住我院。检查：病人呈嗜睡状，颈项僵硬，四肢软瘫，生命体征尚平稳，深反射均低下，病理反射未引出。初次腰椎穿刺脑脊液呈鲜红色，压力 1.18 千帕（120 毫米水柱），含红细胞 195 万/立方毫米，白细胞 1250 万，中性 94%，淋巴 6%，潘氏反应（++），蛋白 511.5%；5 天后又行第 2 次腰椎穿刺，脑脊液呈粉红色，含红细胞 5 万/毫米³（大量陈旧红细胞），蛋白 297.6 毫克%；2 周后又行腰椎穿刺，脑脊液呈无色透明，未见红细胞，蛋白 60 毫克%。前后共治疗 20 天，患者意识恢复，头痛消失，肢体功能改善，痊愈出院^[13]。

【案例 7】

李××，女，11 岁。因针刺哑门穴后头痛、呕吐，血性脑脊液，于 1981 年 3 月 26 日住院。患儿自幼为非完全性聋哑，有听觉，能吐简单单词，3 月中旬始在外院针刺治疗聋哑。3 月 25 日下午 2 时第 3 次就诊，在针刺哑门穴后患儿即显烦躁不安。指示头部难受（头痛），又面色苍白、大汗淋漓，当即去附近医院就诊，予静注高渗葡萄糖等对症处理，回家后症状未缓解，头痛、胸闷、烦躁加重，并出现呕吐，当晚来院急诊。因患儿颈项强直，克、布氏征阳性而行腰穿，见脑脊液呈均匀血性，压力 2.16 千帕（220 毫米水柱），潘氏反应（+++），红细胞 24 万，白细胞 400，中性 74%，淋巴 26%，糖 65.5 毫克%，蛋白 187.4 毫克%，氯化物 690 毫克%；血象：血红蛋白 9.4 克，白细胞 15400，中性粒细胞 74%，淋巴细胞 24%，单核细胞 2%；出血时间 1 分钟，凝血时间 2 分钟。诊断为外伤性蛛网膜下腔出血收住院。入院后体检：体温 37℃，脉搏每分钟 84 次，血压 16.0/12.0 千帕（120/90 毫米汞柱），发育正常，营养稍差，神清，不完全性耳聋，皮肤无皮疹出

血点，头部无破溃及疤痕，颈项强直，心肺正常，无颅神经定位体征，四肢感觉、运动无障碍，克、布氏征阳性。入院后予止血药、抗生素、脱水剂、镇静剂治疗，症状逐渐好转。入院后第3天复查脑脊液：初压1.57千帕（160毫米水柱），终压0.686千帕（70毫米水柱），潘氏反应（+），红细胞12.5万，白细胞8800，脑脊液培养无细菌生长。住院1周出院。5月20日门诊复查，脑脊液常规和生化均完全恢复正常。随访2年，无后遗症^[28]。

【分析】

哑门穴位于第2颈椎棘突下，其深层依次有寰枢后膜、硬膜、蛛网膜、软膜和脊髓等重要结构。而蛛网膜下腔是指蛛网膜与软脑膜之间由许多小纤维束互相连结所构成的空隙，供应脑的血管主支，即附于软脑膜上而在蛛网膜下腔之中，故蛛网膜下腔的表面血管极为丰富，在针刺颈项部穴位时，如果进入过深，就可能刺入椎管，伤及腔内血管，引起蛛网膜下腔出血。本节7个案例正是由于施术过程中，由于术者的针刺角度不当，或提插捻转的幅度过大，或针体粗大，使针尖穿过寰枢后膜及其深面结构，伤及蛛网膜和脊髓，导致蛛网膜下腔出血，从而造成严重后果。

【临床表现】

在哑门穴的针刺过程中，患者突然感到一种“电击样”的全身触电感，随即出现剧烈头痛、频繁呕吐，伴有面色苍白、全身大汗淋漓、畏光少语，半数病人会有不同程度的意识障碍，或谵妄，定向力障碍，错觉和幻觉等，部分病例可有局限性或全身性癫痫发作。

体征：以脑膜刺激征为主，多有颈项强直且有抵抗，其次为克氏征阳性；眼底检查可发现视网膜即玻璃体下片状出血；呼吸不规则，脉搏缓慢。辅助检查：脑脊液压力增高，呈均匀血性，2~3天后则变黄，蛋白量增高；头颅CT可直接确定蛛网膜下腔的凝血块以及是否存在脑水肿等；周围血象可见轻度的白细胞增多，尿检查可有尿糖及蛋白。

【处理方法】

1. 保持安静，绝对卧床休息4~6周，尽量减少搬动，以防继

续出血或再发出血，使破裂血管得以充分复原。特别是要注意避免情绪激动和突然用力，也不宜过早下床活动，并用轻泻药保持患者的大便通畅。

2. 有意识障碍和脑水肿、颅内压明显增高者可用脱水剂，如快速静脉滴入 20% 甘露醇 250 毫升，每 6~8 小时 1 次，或速尿 20 毫克加 50% 葡萄糖 50 毫升静注，或地塞米松 10~20 毫克静注；有高血压者，可选用利血平 1 毫克或 25% 硫酸镁 10 毫升肌注，使血压保持在 20.0~21.3/12.0 千帕（150~160/90 毫米汞柱）左右为宜；头痛剧烈或躁动不安者，可给予止痛镇静剂。

3. 止血剂应用：选用纤维蛋白溶解抑制剂，目的在于阻止动脉破裂处凝血块的溶解，防止再出血和缓解脑血管痉挛。可选用：① 6-氨基己酸 4~6 克，加入 10% 葡萄糖 500 毫升内静脉滴注，每日 1~2 次，连用 2~3 周；② 抗血纤溶芳酸，每次量 200~400 毫克，用法同上。尚可选用安络血、凝血酶、仙鹤草素、止血敏、三七粉和云南白药等。

4. 外科治疗。对有外科手术指征的患者，应在情况许可时尽快施行手术治疗。

5. 中药治疗。肝阳上亢型，方用镇肝熄风汤、天麻钩藤饮加减；肝火热盛型，常用羚羊角汤或羚羊钩藤汤加减化裁；湿热内阻型，方用黄连温胆汤加味；痰蒙清窍型，方用涤痰汤加味。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：较厚，有头发，分布有枕大神经和第 3 枕神经，其神经纤维分别来自第 2 颈神经和第 3 颈神经。

2. 皮下组织：较厚，主要由疏松结缔组织和脂肪组织组成，并分布有枕大神经和第 3 枕神经以及皮下静脉。

3. 斜方肌。

4. 项韧带：三角形弹力纤维膜，主要为致密的结缔组织，纤维排列紧密。

5. 头夹肌：分为左右两块肌肉，由颈神经后支支配。

6. 头半棘肌：分为左右两块肌肉，由颈神经后支支配。

7. 深面：从浅入深依次有寰枢后膜（位于寰椎和枢椎之间，薄

而宽阔)，硬脊膜（为脊髓的外层被膜，厚而坚韧，由胶原纤维及静脉丛组成），脊髓蛛网膜（为脊髓的中层被膜，是薄的网状结缔组织膜，与其深面的软脊膜组成蛛网膜下腔，由脑脊液填充），软脊膜（紧贴于脊髓表面，为富有血管的薄膜），脊髓（位于椎管内，主要由神经元的胞体及上下神经传导束组成，是中枢神经的低级部分，其上端在枕骨大孔处续为延髓）。

【操作要点】

哑门穴的深面有蛛网膜、脊髓等重要结构，故针刺时要注意安全，才能预防各种意外的发生。首先，要注意针刺的方向，一般施术时应嘱患者头向前微俯，针尖向口唇方向直刺最安全。针尖偏向两侧或斜向下刺入亦可。切勿朝鼻的方向，否则针可通过寰椎后结节上方的寰枕后膜、延髓的被膜而损伤延髓；其次，要严格掌握进针的深度。临床上哑门穴的进针深度以1寸左右为宜，最深不能超过1.5寸（瘦人在此尺寸时已刺到硬脊膜）。根据杨占林解剖成人哑门穴的深度标准，针向口直刺时男性均值为44.92毫米±4.42，女性均值43.32毫米±5.49；针向鼻尖斜刺时男性均值为42.42毫米±4.06，女性均值为40.99毫米±5.32。由此可见，针向口直刺1.5寸之内（约相当于两个中指身寸）是较安全的，常规下不会出现上述蛛网膜下腔出血等现象。最后，术者要细心体会操作过程中的手感，一般针刺哑门穴时可遇到两种阻力：一是坚韧而有弹性的阻力，为项韧带、黄韧带或寰枕后膜阻挡之故，尔后针下再出现空松感时，即说明针尖已进入椎管内硬膜外腔处，此时不可轻易深刺，应缓慢送针；二是紧接空松感之后（深约1.5寸时），如针下再遇到柔软的阻力时，即说明针尖已刺到硬脊膜处，病人可能出现向上下放散的酸、胀感，此际不宜再深刺，应立即停针或退针。

二十一、深刺哑门穴损伤延髓致死

【案例】

一患者，女，22岁，工人。因患神经病在某卫生所接受针灸

治疗。当针刺入哑门穴时，病人突然由头倾坐位呈强直性抽搐而直立，随之意识丧失，呼吸困难，20 分钟后急诊送来我院。在急诊室检查：呼吸、心跳已停止。随即行人工呼吸，气管内插管，体外心脏挤压，抢救 2 小时无效死亡。死后腰椎穿刺：血性脑脊液，含红细胞 20 万/立方毫米^[18]。

【分析】

哑门穴位于第 2 颈椎棘突下，其深面有蛛网膜、脊髓等重要结构，该穴上方的深面正对着延髓。人体的血液循环、呼吸功能、消化功能等的反射性调节，只有在延髓功能正常的情况下方能实现。当延髓受到损伤之后，就会导致呼吸中枢、循环中枢、呕吐中枢等功能失常，危及患者生命。本案例由于术者的操作不慎，针尖向内上方刺入，加上病者头前倾位未固定好，进针过深，通过寰椎后结节上方的寰枕后膜、延髓的被膜而刺入延髓，造成延髓损伤，特别是针刺入深部后病人突然强直性抽搐面站立，又进一步加重损伤，从而危及其生命。

【临床表现】

延髓受到针刺损伤，一开始可以不表现出明显症状，仅见患者有上下放散的触电感，有一定时间的潜伏期。但也可即时出现一系列症状，根据其损伤程度不同而表现为头痛眼花、呕吐汗出、恐慌惊叫，呼吸浅快、不规律，血压降低，脉搏频数，肢体瘫痪，肌张力增高，腱反射亢进，浅反射消失，或语言不清，吞咽困难等，并可进入深昏迷状态，常因呼吸、心跳先后停止而死亡。

腰椎穿刺时压力多不高，脑脊液可为血性。

【处理方法】

延髓损伤是针刺损伤中最危险的意外事故，预后多较凶险，往往因抢救不及而死亡，故对确诊或疑似此类病症者，要严密观察其呼吸、血压、脉搏和意识状态，并及时协同有关科室进行积极抢救。

救治的基本原则包括：①人工冬眠低温治疗，以降低脑组织的新陈代谢，提高脑组织的缺氧耐受能力；②保持呼吸道通畅，保证脑组织的氧分供应；③应用脱水剂及激素，以控制脑水肿；④应

用止痉剂以缓解肌张力增高；⑤采用能量合剂，促进脑功能恢复等。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：较厚，有头发，分布着枕大神经和第3枕神经。
2. 皮下组织：较厚，主要由疏松结缔组织和脂肪组织组成，并分布有枕大神经、第3枕神经和皮下静脉。
3. 斜方肌。
4. 项韧带：三角形的弹力纤维膜，主要为致密的结缔组织。
5. 头夹肌和头半棘肌：分别是左右各两块肌肉，均由颈神经后支支配。
6. 深面：从浅入深依次有寰枢后膜、硬脊膜、脊髓蛛网膜、软脊膜和脊髓。

【操作要点】

由于哑门穴的上方深面有延髓等重要结构，故为了预防刺伤延髓的事故发主，进针时针尖千万不可朝向鼻尖的方向，而以向口唇方向直刺最安全。其次，要严格掌握进针的深度，临床实践中以进针1寸左右为宜，最深不能超过1.5寸（体形瘦长者在此尺寸时已刺到硬脊膜）。此外，术者还要细心体会针下的手感，根据不同的感觉来决定进针或退针（一般进针过程中会有松软—硬韧—突破—松软的感觉），以免发生危险。

二十二、哑门穴药液注射引起严重并发症

【案例1】

一女性患者，9岁，因脑炎后遗症——左上下肢瘫痪就诊。患儿取前屈侧卧位，医生用5号4厘米长的注射针穿刺哑门，深3.2厘米，注入10%葡萄糖、维生素B₁混合液5毫升。术毕，患儿立即出现头痛、腹痛、烦躁不安、语言不清，继而昏迷，呈张口呼吸、逐渐呼吸变浅，45分钟后呼吸停止，血压13.3/5.33千帕（100/40毫米汞柱），心率每分钟140次，各种深、浅反射消失，四

肢瘫痪。

在呼吸将停止时，曾作气管插管给氧，人工呼吸，以电针刺激膈神经，改善缺氧现象，并用人工冬眠、物理降温、脱水、纠正酸碱平衡等综合措施。当呼吸停止6小时以后曾用回苏灵16毫克，溶于10%葡萄糖内静脉滴注。出现头面部肌肉严重抽搐，眼压增高，结膜水肿，即加大冬眠灵用药量及苯巴比妥钠肌注，抽搐逐渐停止，但自主呼吸仍未恢复，继续使用甘露醇和50%葡萄糖脱水治疗。当排尿总量达1100毫升时，出现低血容量，血压9.33/6.67千帕（70/50毫米汞柱），心率每分钟39~50次，心电图示窦性心动过缓，Q-T间期延长。立即静脉输入血浆180毫升，0.3%氯化钾200毫升后，心率及血压均恢复正常。在呼吸停止12小时20分钟时，发现患儿头动3次，逐渐出现自主呼吸每分钟4~14次。

自主呼吸出现后，使用静脉滴注美解眠，呼吸幅度逐渐增大，同时出现瞳孔对光反射和睫毛反射，刺激四肢，肌张力增强，巴氏征阳性，膝腱反射恢复。2小时后，呼吸频率及幅度均接近正常，遂停止膈神经刺激和停用呼吸兴奋剂。第3天出现频繁的双吸气，心率较慢，眼底视神经盘色淡，境界模糊，视网膜呈乳白色水肿，仍有脑水肿存在，除定时给脱水剂及氟美松外，又用利尿酸钠，迅速排尿400毫升后，呼吸又逐渐恢复正常，眼底视网膜水肿改善。第5、6日静脉滴入苏醒剂氨乙基异硫脲1次。第7天意识逐渐清醒，应答反应恢复，开始口服给药，流质饮食，去除气管插管，呼吸良好。於4月10日痊愈出院^[1]。

【案例2】

据报道：用5%681注射液（即卤碱注射液）或100%当归液于哑门穴穴位注射数千人，有7例因注射部位过深，都在2同身寸以上，发生不良反应，其中脑性瘫痪6例，头痛1例。出现反应的时间，多数在半小时至1小时之间，个别在3小时之后。其临床表现为神志清楚，嗜睡，面色苍白，颈项软或有抵抗，四肢软弱无力，不能站立；有的针刺后突然摔倒，四肢发凉；有的脊柱疼痛并向上下放射，或有震颤，腹壁反射多数消失，膝反射消

失、存在或亢进，恶心，呕吐，头痛，重者不能进食。体温 38℃ 左右，脉搏、呼吸稍快，心律齐；1 例有血压升到 24/16 千帕（持续 1 天后恢复正常）；1 例尿失禁，2 例尿潴留。一般经 1 天左右未予用药即恢复，严重者用抗生素预防感染，并用镇静药、镇吐药、输液以及补充营养。1 例 3 天痊愈，1 例 9 天痊愈，尿潴留、尿失禁者都在 1~2 天内恢复^[29]。

【分析】

哑门穴位于第 2 颈椎棘突下，在其深面的上部为延髓、下部为脊髓，这些重要结构若被深刺的针尖所损伤时，将会引起极其严重的后果。案例 1 的患者为 9 岁儿童，按照常规哑门的针刺深度一般为 1~1.5 同身寸，那末最多也只能刺入 1.5~2.25 厘米（儿童的 1 同身寸可作为 1.5 厘米计算），而本例的穿刺深度为 3.2 厘米，显然超过安全限度，故注药后发生严重的并发症。据该作者报道，事后曾以同样位置、深度模拟原来位置，给患儿复制 X 光片，表明穿刺针已达椎管的深部，结合临床症状，部分药物已注入延髓池或蛛网膜下腔，出现脑脊髓液高糖；另一部分注入延髓或脊髓，引起局部组织水肿，出现占位病变，导致呼吸停止。由于血管受压，脑组织供血不足而缺氧，导致脑水肿，中枢神经功能障碍，昏迷，四肢软瘫，深浅反射消失等，所幸抢救及时有效，才免于死亡。案例 2 亦是由于术者施行穴位注射的过程中注射部位过深，伤及哑门穴深处的蛛网膜、延髓或脊髓，加上刺激性较强的“681”注射液，触及神经后引起各种程度不同的症状，尤以脊髓损伤的症状最明显。

【临床表现】

损伤延髓时，一开始可以不表现出明显症状，仅见患者有上下放射的触电感，有一定时间的潜伏期。但也可即时出现一系列症状，根据其损伤程度不同而表现为头痛眼花、呕吐汗出、恐慌惊叫，呼吸浅快、不规律，血压降低，脉搏频数，肢体瘫痪，肌张力增高，腱反射亢进，浅反射消失，或语言不清，吞咽困难等，并可进入深昏迷状态。常因呼吸、心跳先后停止而死亡。

脊髓损伤较轻者，多表现为脊髓震颤，患者主诉为全身酸痛、

胀麻、四肢无力，甚者头晕或暂时性知觉丧失、瘫痪等脊髓一过性传导障碍，但经数分钟、数小时或数日之后即能完全恢复。如果针体直接刺入脊髓而造成较大损伤的，则会出现一侧或双侧下肢不完全性瘫痪，不能行走或呈跛行步态及感觉迟钝等症状，严重者可见损伤部位所支配的肌肉出现麻痹，大小便失禁，各种反射消失，感觉消失，体温升高，血压下降，脉搏频数等脊髓休克症状。

【处理方法】

延髓、脊髓损伤是针灸意外中最危险的一种，预后多较凶险，因此当事故发生后就应及时会同有关科室进行积极抢救。

延髓损伤的救治原则是：①人工冬眠低温治疗，以降低脑组织的新陈代谢，提高脑组织的缺氧耐受能力；②保持呼吸道通畅，保证脑组织的氧分供应；③应用脱水剂及激素，以控制脑水肿；④应用止痉剂以缓解肌张力增高；⑤采用能量合剂，促进脑功能恢复等。

脊髓损伤的治疗，可根据症状表现给予处理：①头晕、乏力时，可让患者平卧休息，并饮以热茶或糖水等；②伴高热头痛者，可用解热镇痛药，如扑热息痛等；③肢体运动障碍的恢复，需时约数周或数月，这期间可配合理疗或针灸疗法，取穴以局部和邻近为主，并配合复合维生素 B 10 毫克，1 日 3 次口服；④脊髓损伤严重，有脊髓休克或脊髓内外血肿，症状逐渐加重者，则应请有关科室予以综合治疗。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：较厚，有头发，分布着枕大神经和第 3 枕神经。
2. 皮下组织：较厚，主要由疏松结缔组织和脂肪组织组成，并分布有枕大神经、第 3 枕神经和皮下静脉。
3. 斜方肌。
4. 项韧带：三角形的弹力纤维膜，主要为致密的结缔组织。
5. 头夹肌和头半棘肌：分别是左右各两块肌肉，均由颈神经后支支配。
6. 深面：从浅入深依次有寰枢后膜、硬脊膜、脊髓蛛网膜、软脊膜和脊髓。

【操作要点】

该穴深面有脊髓等重要结构，故施术时一定要注意安全。一般来说，操作时应嘱病者头部向前微俯、项肌放松，针尖沿第2颈椎棘突上缘向口唇方向直刺，进针1寸以后要缓慢送针，最深不能超过1.5寸（瘦人在深刺1.5寸时即已刺到硬脊膜，项肌发达者也不可超过1.8寸），否则针可通过寰枢后膜及其深层结构而刺伤脊髓的颈段。针刺时亦切勿朝鼻的方向深刺，因为其深面正对延髓，针尖可通过寰椎后结节上方的寰枕后膜、延髓的被膜而进入延髓，造成延髓损伤。此外，术者在操作过程中还要细心体会针刺该穴时遇到的两种阻力：一是坚韧而有弹性的阻力，为项韧带、黄韧带或寰枕后膜阻挡之故，然后针下再出现空松感时，即说明针尖已进入椎管内硬膜外腔处，此时不可轻易深刺，应缓慢送针；二是紧接空松感之后（深约1.5寸时），如针下再遇到柔软的阻力时，即说明针尖已刺到硬脊膜处，病人此时可能出现上下放射的酸、胀感，此时不宜再深刺，而应立即停针。

二十三、球后穴注射强的松龙引起过敏反应

【案例】

一35岁男性患者，因右眼前固定圆形阴影5天，诊断为右眼中心性浆液性视网膜炎。行右眼球后穴注射醋酸强的松龙0.5毫升，4天后又同样注射，2次皆无反应。第3次又注射同药，半小时右眼皮肤感觉瘙痒，眼周皮肤水肿，3小时后大片水肿，上至眉弓，下至下颌，内至鼻梁，外至耳际，又发展至额部、对侧眼睑及下颌，遂收入院。给0.1%肾上腺素0.5毫克肌注，静滴10%葡萄糖500毫升，氢化考的松100毫克，维生素C2克。住院5天出院时，水肿症状已消退。眼底右黄斑部水肿比以前明显，左黄斑部也有水肿，醋酸强的松龙皮试阳性^[30]。

【分析】

过敏反应是一种变态反应性疾病，针灸疗法本身是一种物理

疗法（即针的机械性刺激或灸的温热性刺激），一般是不会引起过敏的。但随着针灸医学的迅速发展，现代的电、磁、激光、埋线、某些药物制剂也逐渐成为刺激腧穴的手段，它们为针灸医学充实了内容，促进了针灸的发展，却同时带来一些新的副作用，过敏反应就是其中之一。针灸临床上所见到的过敏反应，主要来自某些药物的穴位注射，这些药物大多数本身并不是抗原，其过敏反应的发生是由于药物与机体内蛋白质结合而获得抗原性的，属于Ⅰ、Ⅱ型变态反应。本病例正是由于致敏抗原强的松龙进入人体内后，诱发产生IgE类抗体，并与血管周围肥大细胞和血循环中嗜碱性细胞结合，当抗原（强的松龙）再次侵入并与细胞表面IgE特异性结合后，引起肥大细胞膜层结构稳定性改变及其内部一系列生化变化，促使脱颗粒和过敏介质的释放如组胺、激肽、慢反应性物质、肝素等引起血管通透性增高，毛细血管扩张，产生水肿、瘙痒等一系列症状。

【临床表现】

由药物引起的过敏反应的证据是：有潜伏期，再次用药发疹快；用小剂量可引起严重反应；皮疹表现与本药的药理作用所引发的症状不同；某些药物做皮内试验在少数人可引起阳性反应；用皮质类固醇制剂一般有效。因为穴位注射所用的药物种类较多，所以本病表现的形态也较为复杂，临床上常见的有以下几种：

1. 固定性红斑：皮疹每次发病都在固定的部位，一般好发于四肢远端皮肤、粘膜和皮肤、粘膜交界处，损害为圆形、水肿性紫色红斑，严重的可发生水疱糜烂，病人有瘙痒、灼热和刺痛感，若损害广泛者常伴有发热。

2. 麻疹样红斑：全身发出针帽大小的鲜红色丘疹，在大腿可以是出血性的。

3. 猩红热样红斑：全身呈弥漫性红斑，但其症状没有猩红热严重，也不只发于儿童。

4. 剥脱性皮炎：较为少见，是一种严重威胁生命的反应，潜伏期较长。开始皮疹像麻疹样或猩红热样；继而皮肤迅速出现浮肿、水疱、糜烂、流水，面如满月，高热，心、肝、肾均有损害；

以后渗出减少，大量脱皮，手足心大量皮肤脱落，病程可持续2个月左右，如不及时治疗则可危及生命。

【处理方法】

1. 原则上应马上停用一切可疑药物（如果有些药必须用而致敏性较小时则可继续使用，但须密切观察），并多饮开水，或注射高渗葡萄糖加强排泄。

2. 西医治疗：脱敏时可予苯海拉明25~50毫克口服，每日2~3次；或静脉注射10%葡萄糖酸钙1~2克，稀释于50%葡萄糖液20毫升中，每日1次。严重者还要给予激素治疗，如强的松10毫克，每日3次；或氢化考的松100~200毫克加入5%葡萄糖溶液500毫升中静脉滴注，待病情好转后逐渐减量。

3. 中药治疗：以清热凉血、利湿解毒为原则。方用鲜生地30克，丹皮9克，赤芍9克，蒲公英30克，板蓝根30克，苦参、茯苓、山栀、车前子各12克，生甘草3克。皮疹鲜红者，将鲜生地改为50克；便秘者，加大黄9克（后下）；热甚者，加黄连3克，紫草9克；伤阴者，加玄参12克，麦冬9克，鲜石斛9克。水煎服，每日1剂。亦可用蒲公英、车前草各30克，煎汤代茶喝。

4. 皮肤损害的治疗：急性渗出，糜烂，大疱皮损以清洁、减少渗出、消炎为主，可用3%硼酸水和次醋酸铝液1:20倍稀释湿敷，每次30分钟，次数视病人及条件而定。通过湿敷可以去除污痂、脓液等，然后外用硼酸氧化锌糊剂，有继发感染须用抗生素。亚急性皮炎期以丘疹，红斑，脱屑为主，应消炎、止痒，外用炉甘石洗剂，皮肤干燥时可改用炉甘石擦剂或10%~30%氧化锌油。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：由眶下神经（即三叉神经第2支的终支）分布。

2. 皮下组织：有眶下神经的纤维和眶下动、静脉的分支或属支。

3. 眼轮匝肌：为位于眼裂周围皮下的椭圆形扁肌，由面神经的颧支和颧支支配。

4. 眶脂体：为填充于眼球、眼球诸肌、眶内骨膜之间的脂肪团块。

【操作要点】

为预防球后穴位注射引起过敏反应的发生，术者在操作前应仔细询问病史，了解有无对所用药物的过敏史，或者是否有穴位注射的过敏史。在穴位注射时，应按肌肉或皮下注射常规进行，对一些已知可引起过敏反应的药物，均应先作过敏试验，证明无反应者方可使用。此外，在穴位注射过程中，一旦出现过敏反应先兆（如发生全身性或对称性皮炎），应立即停止施术，停用有关药物，及早给予观察，及时给予抗过敏治疗处理。

二十四、针刺球后穴导致眼周出血

【案例 1】

某一患者，因患中心性视网膜炎前来求治。术者取球后等穴进行针刺。由于其手法不当，起针后右眼流泪、疼痛，不能睁眼，视物不清，眼球向外突出。急请眼科会诊，意见为球后出血。遂给予湿敷、止血、镇静等对症治疗，半个月后才告痊愈^[31]。

【案例 2】

某一男性患者，25 岁，因视神经萎缩前来要求针刺治疗。穴取球后、养老穴为主，用 30 号毫针深刺入球后穴约 1.5 寸，为获得较好的得气感，笔者曾作小幅度提插探寻。留针 20 分钟，在此期间于球后穴未运用任何手法（养老穴处施行补法手法），病人亦未觉眼部有什么异常。退针后病人自行回家。第 2 天复诊时，病人自诉右下眼睑沉重不适，睁开不便。见右眼下部肿胀、青紫，此为刺伤较深部血管所致。约经 20 余天始恢复。

【分析】

球后穴位于眼眶下缘的外侧 1/4 处，即下睑板下缘及眼球之间的空隙内。而眼眶是一个尖端向后内侧的锥形腔隙，眶内及其周围血管分布相当丰富，在内眦部有内眦动、静脉，下方有眶下动、静脉，这些血管纵横交错，形成血管网，位置表浅，稍不注意即易伤及。本节 2 个案例正是由于术者操作手法不当，刺入球后穴之后，针尖伤及眼周的血管网（以眶下动、静脉为主），从而

引起出血，出现上述的一系列眶周水肿的症状。

【临床表现】

轻症：多在拔针后，针孔有少许出血现象，当时局部未见异常，数小时后，穴区周围显现青紫色的瘀斑（系刺破浅层血管或较细小的动静脉分支所致）。

重症：常在取针后数秒钟至半分钟内发生，出血侧眼睑迅速肿胀闭合，无法睁开，从第2天起肿胀可逐渐消退；青紫色瘀斑根据出血量多少，可波及整个眼睑，或全部眼周围区域。半个月至20余日始可全部消退，一般不影响眼区的功能和视觉（系损及深层血管或较重要的眼部动静脉所致）。

【处理方法】

轻症的浅表点滴出血，只需用消毒干棉球压迫针孔1~2分钟即可，可不予特殊处理。局部瘀斑亦可用热毛巾外敷，促进其消退。

重症的出血期应给予冷敷，以纱布蘸蒸馏水或冷开水冷敷局部15~20分钟，这种处理有利于止血。血止后，可嘱患者用热毛巾热敷眼区，促进溢出血液的吸收，每次20~30分钟，每天2~3次。平时可盖上消毒的纱布眼罩，待眼睑肿胀消退后，去除眼罩，改为每日热敷1次，直至瘀斑完全消失。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：由眶下神经（为三叉神经第2支——上颌神经的终支）分布，它经眶下孔穿出至面部，分布于下睑、鼻背外侧及上唇的皮肤。

2. 皮下组织：内有眶下神经的纤维和眶下动、静脉的分支或属支。眶下动脉为上颌动脉的分支，与眶下神经伴行由眶下孔至面部，营养颧部、上唇及上颌牙齿和牙龈；眶下静脉为上颌静脉的属支。

3. 眼轮匝肌：位于眼裂周围皮下的椭圆形扁肌，由面神经的颧支和颧支支配。

4. 眶脂体：为填充于眼球、眼球诸肌、眶内骨膜之间的脂肪团块，对眼球起支持作用。

5. 下斜肌：为眼外肌，由动眼神经下支支配。

【操作要点】

球后穴是眶周穴位中针刺难度较大的一个。施术时先嘱患者闭眼（患者一般多取仰卧位），术者用押手将眼球轻轻向上推按固定，另一只手拿着毫针（多数情况下应选用较细的毫针，以30~32号、长1.5~2寸的毫针最佳），针尖刺入皮肤0.5寸时，即下压针柄呈30度角，使针尖向内上方，由眼球绕到眼球后方，朝视神经孔方向深刺，通过下斜肌外方至外直肌后端；针刺深度以1.5寸为宜，若超过2寸时，容易刺伤视神经、海绵窦、颅内动脉及垂体等重要结构；进针宜缓慢，遇到阻力较大或病人有刺痛感时，应退针少许，调整方向再刺，一般不宜捻转和提插，以免损伤眼眶内的结构；出针时用消毒干棉球按压针孔1~2分钟，以免出血。若病人有眼球发胀和外突感，即提示可能已有出血，应退针并压迫局部2~3分钟（时间稍长些），以防继续出血，其处理方法如上述。

二十五、电针颊车穴引起迷走神经反应

【案例】

徐××，男性，57岁，竹架工。患者于1960年发现患有高血压，至1979年因高血压被迫停止工作。血压波动在21.3~24/12~14.7千帕（160~180/90~110毫米汞柱）之间。同年11月7日因脑血栓形成致右面瘫及同侧半身不遂，言语不清，走路、握物均不便，遂来本科门诊。检查：神清合作，言语不清，右侧肢体不完全性瘫痪，上肢肌力Ⅱ级，下肢Ⅱ级，腱反射稍亢进；心脏听诊无杂音， $A_2 > P_2$ ，脉率80次/分，律齐，血压22.7/13.3千帕（170/100毫米汞柱），血清胆固醇160毫克%（4.2mmol/L）， β -脂蛋白330毫克%，甘油三脂175毫克%（2mmol/L）。取穴：风池、颊车、曲池、外关、足三里、阳陵泉，轮流针刺，皆取坐位。每次留针15~20分钟，中等刺激，有时通以低频脉冲电流。共针45次，无不良反应。治疗后面瘫好转，上下肢肌力Ⅳ级，能正常

走路、握物，言语较为清晰。又于1980年1月30日上午9时针刺，取穴颊车等，通疏密波低频脉冲电流，坐位，至9点17分，被一医生发现患者头部低下，神志丧失，血压测不到，心脏听诊发现心跳已完全停止，脉搏消失，呼吸减弱，眼球固定，瞳孔稍扩大，唇、指尖紫绀，面呈灰土色。即马上扶病人平卧，揉按人中、内关，正准备注射药液时，忽然病人打了一个呵欠，心跳开始恢复，脉搏出现，呼吸增大，眼球开始转动，血压恢复至22.7/12千帕（170/90毫米汞柱）。整个心跳停止历时1分钟。其后病人复打一个呵欠，问话便能正确对答，诉说心里并不感难受，10分钟后坐起，35分钟后一切恢复正常，独自步行1公里路回家。第2天复诊时，血压为24/14.7千帕（180/110毫米汞柱）。4个月后随访无不适，血压24/14.7千帕（180/110毫米汞柱），心律齐，但于8个月后再次发生脑出血而死亡^[1]。

【分析】

心脏骤停是循环突然完全停止的状态，可由多种疾病、多种原因所致，但其发生的病理生理可归纳为3个方面：缺氧，代谢和化学异常，神经系统功能不全。其中，神经系统功能不全主要为迷走神经功能亢进。由于迷走神经的分支心上支与心下支会合于心丛后，再由心丛分支至心脏和心血管，司理它们的活动和感觉，故在某种原因的刺激下，引起迷走神经兴奋，会发生窦性心动过缓、房室传导阻滞，甚至心跳停止。本案例正是针刺颊车后，由于该穴分布有三叉神经第3支的分支及耳大神经分支等，故电针的刺激冲动经半月神经节传至第四脑室三叉神经的感觉主核，联合核上皮质来的神经纤维，将刺激冲动直接传到迷走神经核，再沿迷走神经传出冲动，止于心肌组织，引起心跳突然发生完全性抑制所致。

【临床表现】

迷走神经反应在症状上出现的都是效应器官变化，发作突然，表现凶险，病情进展快。临床表现以神经和循环系统的症状最为明显，其症状和体征可依次出现：①心音消失；②脉搏扪不到，血压测不出；③意识突然丧失，或在一短阵抽搐（这种抽搐常为全

身性，持续时间长短不一，可长达数分钟）之后出现意识丧失，多发生于心脏停搏后 10 秒钟内；④呼吸断续，呈叹息样，以后呼吸停止，多发生在心脏停搏后 20～30 秒钟内；⑤昏迷，多发生于心脏停搏 30 秒后；⑥瞳孔散大，多在心脏停搏后 30～60 秒钟出现。

【处理方法】

临床上一旦出现迷走神经反应症状，应立即停止治疗，将针起出，并及时进行抢救。这样就有可能恢复，否则会造成脑和全身器官组织的不可逆的损害而导致死亡。

一般临床上对心脏骤停的复苏处理可划分为 3 个时期：第 1 期，支持基础生命活动，特别是迅速给脑组织以氧合的血流，其步骤包括畅通气道、人工呼吸和人工胸外挤压；第 2 期，进一步支持生命活动，恢复自动心搏。包括进一步维持有效的换气和循环，建立和维持静脉滴注的通道和碱性药物（常规用 5% 碳酸氢钠，首剂按 1mEq/kg 计算，在有效循环恢复之前每 10 分钟予首剂之半量维持）的应用，心电图监测和抗心律失常治疗（药物可用利多卡因、阿托品等，电技术可采用电击除颤和电起搏），增加心排血量和维持血压（药物可选用盐酸肾上腺素、去甲肾上腺素、多巴胺、阿拉明、氯化钙等）；第 3 期，心搏恢复后的处理，包括防治引起心脏骤停的原发疾患，继续维持有效的循环、呼吸，防治脑水肿，防治急性肾功能衰竭，维持水、电解质和酸碱平衡，防止继发感染。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：分布有耳大神经（它是颈丛皮支中最大的分支），由第 2～3 颈神经纤维组成。
2. 皮下组织：内有耳大神经和面神经下颌缘支的分支。
3. 咬肌：为长方形扁肌，位于下颌支外侧的皮下，分为浅、深两层纤维，它们共同止于下颌支外面的咬肌粗隆，受三叉神经第 3 支（下颌神经）的分支咬肌神经支配。

【操作要点】

用于治疗面瘫时，颊车穴应直刺 0.3～0.5 寸，或斜刺透地仓 2～3 寸，使局部有酸胀感，并向周围扩散即可。一般不宜予强刺

激。加电时，要求电流量应以病人能耐受为度，不可太过强人。

二十六、针刺睛明穴引起眶周出血

【案例 1】

某医生为一面神经麻痹患者针刺右睛明穴，当日上午 9 时治疗，下午 4 时左右发现右上眼睑肿胀、青紫、不适，急诊于眼科。诊断为外伤性眼睑出血，经清创及内服抗感染药，3 天后症状消失^[32]。

【案例 2】

一患者因中心性视网膜炎求治，取睛明等穴。由于手法不当，起针后右眼流泪、疼痛、不敢睁眼、视物不清、眼球向外突出。急请眼科会诊，意见为眼睑出血，遂给予湿敷、止血、镇静等对症治疗，半月后方告痊愈^[31]。

【案例 3】

王××，女性，28 岁，1972 年 3 月 10 日初诊。主诉两眼红肿、畏光两月余，伴有头痛，诊断为慢性结膜炎。取穴：睛明、瞳子髎、阳白、合谷，留针 20 分钟。起针时，右睛明穴未用干棉球压迫，当即穴内出血，逐渐加重，在几秒钟内，整个右上眼睑全部肿胀，眼裂不能撑开，外观似半个乒乓球大小，具有饱满感。处理：当即冷敷 2 小时；次日开始用热敷，每次 1 小时，每日 2 次，连敷 3 日。眼睑运动自如，瞳孔正常，结膜不充血，只是右眼睑留有青紫色，经半月余始消退^[33]。

【案例 4】

王××，女性，21 岁，台港针灸学习班学生。患者因左侧上、下眼睑间歇性颤动已半年前来就诊。脑神经检查未发现异常，视力正常，眼球运动及眼睑闭合良好。遂用 1.5 寸 30 号毫针，缓慢刺入左侧睛明穴 1.2 寸，得气后留针 15 分钟，这期间有一位进修生曾 2 次给予捻转手法，退针后自觉左眼微胀不适，急按压及轻揉后好转。第 2 天复诊时眼内角皮肤呈一片乌黑色，即嘱其回家

后用热敷，每次 30 分钟，每天 2 次。5 天后出血全部被吸收，视力正常，未遗留任何后遗症。

【分析】

睛明穴位于内眦上方 0.1 寸处，即眶内缘中点稍上方与眼球之间的腔隙中。在睛明穴的水平切面上，眶腔前宽后窄，呈锥体形，眼球位于眶腔前半部，眼球与内侧壁之间的空隙较大，眼球周围有眼肌、血管、神经和脂肪、结缔组织等结构。而睛明穴处的皮下组织内血管很丰富，分布有来自眼动脉的眶上动脉和来自面动脉的终支内眦动脉所发分支，以及其伴行的静脉。它们纵横交错，形成血管网，位置表浅，稍不谨慎施术则容易伤及。本节几个案例正是由于术者的操作不当，刺入睛明穴之后，针尖伤及上述血管，引起不同程度的皮下瘀血或血肿，局部呈青紫色等一系列症状。

此外，针刺睛明穴除了造成出血意外，尚可出现以下几个事故：①刺中眼球：进针时未按压眼球，或进针部位过于贴近眼球均可发生。眼球壁外层巩膜十分坚韧，刺中表层即有滞针感，只要进针不过快，则不易刺穿。但最危险的地方是眼球左右横径最大处（即眼球的“赤道”处），因它是巩膜最薄的部位，仅有 0.4~0.5 毫米。若疑有刺中眼球时，应立即转科治疗；②刺中总腱环及视神经：若针刺过深，超过 45 毫米（1.8 寸）时，在进针的直后方则易刺中围绕视神经孔的总腱环并可累及视神经。因视神经传导由光线刺激转化的神经冲动，外面又有由硬脑膜延续来的坚韧的纤维膜包裹，刺中时针感粘滞，病人主诉眼内火花闪发（视神经受刺激症状）、头痛、头晕，严重的有恶心、呕吐等。应立即退针，对症治疗；③伤及眶上裂及其深部结构：若针尖过分朝后外方向刺入，并且深度超过 2 寸（男性平均 50 毫米，女性平均 48 毫米）时，则针尖可直达眶上裂。眶上裂是眶腔与颅中窝的最大通路，针尖不仅可能刺中穿行于眶上裂中的动眼、滑车、外展神经及三叉神经第 1 支眼神经，进而可透过眶上裂而伤及颅中窝内的海绵窦，以致损伤大脑颞叶前端，造成颅内出血，引起剧烈头昏、头痛、恶心、呕吐，甚至休克、死亡。因此，针刺深度越深、手

法越重，其危险性就越大。

【临床表现】

轻症：多在拔针后，针孔有少许出血现象，当时局部未见异常，数小时后，穴区周围显现青紫色的瘀斑（系刺破浅层血管或较细小的动静脉分支所致）。

重症：常在取针后数秒钟至半分钟内发生，出血侧眼睑迅速肿胀闭合，无法睁开，从第2天起肿胀可逐渐消退；青紫色瘀斑据出血量多少，可波及整个眼睑，或全部眼周围区域。半个月至20余日始可全部消退，一般不影响眼区的功能和视觉（系损及深层血管或较重要的眼部动、静脉所致）。

【处理方法】

轻症的浅表点滴出血，只需用消毒干棉球压迫针孔1~2分钟即可，可以不予特殊处理。局部瘀斑亦可用热毛巾外敷，促进其消退。

重症的出血期应给予冷敷，以纱布蘸蒸馏水或冷开水冷敷局部15~20分钟，这有利于止血；血止后，可嘱患者用热毛巾热敷眼区，促进溢出血液的吸收，每次20~30分钟，每天2~3次。平时可盖上消毒的纱布眼罩，待眼睑肿胀消退后，去除眼罩，改为每日热敷1次。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：上睑皮肤极薄，约0.1毫米。分布于上睑内侧部的皮神经由滑车上神经支配，它来自三叉神经第1支——眼神经的分支额神经。此皮神经在眶内从额神经分出后，经内侧的额切迹分布至上睑内侧皮肤。

2. 皮下组织：由疏松结缔组织构成，其中缺乏脂肪组织的填充。内有皮神经分布。皮下组织内血管较丰富，有来自眼动脉的眶上动脉及来自面动脉的终支内眦动脉所发分支分布，其伴行的静脉则大部在睑的内侧汇入内眦静脉，再经眶内的眼上静脉回流。

3. 眼轮匝肌：位于上、下眼睑皮下，属于表情肌，受面神经的颞支及颧支支配。

4. 眶脂体：由填充于眶内器官如眼球、眼肌与眶骨膜之间的

脂肪组织构成，其作用宛如眼球的弹性软垫，有缓冲作用。

5. 眼内直肌：起始在位于眶尖的总腱环，向前止于巩膜内侧面，受第3对脑神经——动眼神经下支支配，使瞳孔转向内侧。

【操作要点】

睛明穴的局部有许多重要结构，故针刺时要慎之又慎。进针前要先嘱患者将眼睛闭上，术者用押手将眼球推向外侧固定，以增加进针间隙，避免刺中眼球，另一只手拿着毫针（临床上多数情况应选用较细的毫针，以30~32号、长1.5~2寸的毫针最佳），针尖接近眶内侧壁（但勿紧贴），以80度角朝外、朝下进针，缓慢刺入，针尖依次通过皮肤及皮下组织→上睑板上缘的内侧端→眼球与眶内侧壁之间、直达眼球内后方，进入内直肌后端；针刺深度一般以1.5寸为宜，不要过于深刺。若超过1.8寸以上时，容易刺伤视神经、眼动静脉及颅中窝大脑颞叶等重要结构；进针要缓慢，遇到阻力较大（可能已刺到眶壁）或病人有刺痛感（可能刺到眼球壁）时，应退针少许，调整方向再刺，一般不宜施行提插和捻转手法，以免损伤眼眶内的结构；退针时也要缓慢，并用消毒干棉球按压针孔1~2分钟，以免出血。本穴临床上是不用灸法的。

二十七、针刺攒竹穴导致眶周出血

【案例1】

医者于1974年，治疗过一例中心性视网膜炎患者。以28号毫针深刺攒竹穴，从眶上孔刺入约1寸左右，为获得较好的得气感，曾作小幅度提插探寻，留针20分钟，在此期间未运用任何手法，病人亦未觉眼部有何异常。当针刚一取出，病人突然诉说右眼上睑如闸门般沉重，无法睁开。只见右眼周围已出现明显血肿，上眼窝凹陷部已完全消失。经20余天始恢复^[34]。

【案例2】

某医生，1990年5月中旬曾为一重症肌无力之上眼睑下垂的患者施行针刺疗法，穴取攒竹穴。当日上午10时治疗，下午2时

左右发现左上眼睑肿胀、青紫、不适，即急诊于眼科。诊断为外伤性眼睑出血。经清创及内服抗感染药，4天后症状消失。

【分析】

攒竹穴位于眉毛的内侧端，即眶上切迹处。该穴的皮下组织处分布有眶上动脉（它来自眼动脉）和眶上静脉，位置较表浅，稍不小心则易伤及，引起出血。本节2个案例正是由于术者的不当，或针具选择过粗，或进针深度过大，刺入攒竹穴之后，针尖损伤上述血管，从而引起不同程度的皮下瘀血或血肿。

【临床表现】

轻症：多在拔针后，针孔有少许出血现象，当时局部未见异常，数小时后，穴区周围显现青紫色的瘀斑。

重症：出血侧眼睑迅速肿胀闭合，无法睁开，青紫色瘀斑据出血量多少，可波及整个眼睑，或全部眼周围区域。半个月至20余日始可全部消退，一般不影响眼区的功能和视觉。

【处理方法】

轻症的浅表点滴出血，只需用消毒干棉球压迫针孔1~2分钟即可，可以不予特殊处理。局部瘀斑亦可用热毛巾外敷，促进其消退。

重症的出血期应给予冷敷，以纱布蘸蒸馏水或冷开水冷敷局部15~20分钟，有利于止血；血止之后，可嘱患者用热毛巾热敷眼区，促进溢出血液的吸收，每次20~30分钟，每天2~3次。平时可盖上消毒的纱布眼罩，待眼睑肿胀消退后，去除眼罩，改为每日热敷1次。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：由额神经支配，它是三叉神经第1支（眼神经）的分支，分布于额部皮肤及上睑。

2. 皮下组织：分布有额神经和眶上动、静脉。

3. 眼轮匝肌：由面神经的颞支和颧支支配。

4. 皱眉肌：位于眼轮匝肌眶部及枕额肌额腹的深面，两侧眉弓之间，肌纤维起自额骨鼻部，斜向外上，终于眉部皮肤，受面神经的颞支支配。

5. 额骨及其骨外膜。

【操作要点】

嘱患者取仰靠位或仰卧位。术者用毫针直刺 0.3~0.5 寸，或向下斜刺透睛明穴（治眼病常用）0.3~0.5 寸，或横刺透鱼腰（治面神经麻痹或头痛时用）1~1.5 寸，使局部及眼眶周围有胀痛感。为预防局部出血，一般施术时不宜深刺，出针时应用消毒干棉球按压针孔片刻。此外，本穴一般禁灸。

二十八、针挑眼外角阿是穴引起 大脑额叶脓肿

【案例】

一患者，女，28 岁，5 天前因右眼发红不适，在农村用针挑眼外角的阿是穴，第 3 天即出现高烧、谵语、躁动，急诊入院。体检：体温 39.2℃，脉搏每分钟 114 次，呼吸每分钟 25 次，血压 14.6/9.5 千帕（108/70 毫米汞柱）。发育中等，营养一般，急重病容，神志不清，皮肤无黄染，颈部有抵抗，两眼及面部红肿，右眼球结膜高度充血水肿，突出于睑裂之外，其他均无异常发现。外眦部皮肤有针挑伤数处，因其神志不清，未能作眼球转动检查。血象：红细胞 $3.74 \times 10^{12}/L$ ，血色素 116g/L，白细胞 $66 \times 10^9/L$ ，中性 0.80，淋巴 0.16，单核 0.01。入院诊断：右眼眶蜂窝织炎，败血症，脑膜炎。即用青、链霉素及磺胺嘧啶治疗，病情未控制，呈弛张热，昏迷。第 3 天作血培养，有金黄色葡萄球菌生长，对庆大霉素、红霉素、氯霉素高度敏感。遂用庆大霉素 12 万单位加入到 10% 葡萄糖液内静滴。3 天后开始清醒，体温降到 39℃ 以下，但颈仍强硬。血象：白细胞 $15.8 \times 10^9/L$ ，中性 0.9。第 13 天体温又升至 39℃ 以上，颈强直，改用新霉素静滴。第 15 天出现频发头痛，右瞳孔中等散大，但两眼底未见异常。腰穿时脑脊液压力增高，呈涌出状，色清，潘氏试验阳性，细胞数 2，氯化物 820 毫克，蛋白 166 毫克，糖 100 毫克，无细菌生长；第 26 天再次腰穿检查，潘氏试验阳性，细胞数 628，中性 76%，单核 24%，蛋白 105 毫克，

氯化物 570 毫克。因治疗无效，脑部症状日益加重，遂转至河南医学院，诊断为大脑额叶脓肿，经手术切除后逐渐治愈^[35]。

【分析】

脑脓肿为化脓性病原体侵入脑组织内形成的单个或多个脓肿灶，其主要的感染途径是邻近感染灶和血行播散（血源性脑脓肿）两种。正常情况下，人体具有广泛而有效的防御和免疫功能，可防止细菌入侵或杀死细菌，而完好的皮肤是机体防止细菌入侵的天然屏障。皮肤破损后则易于导致细菌感染。当人体抵抗力降低时，细菌易由邻近的感染灶通过血液循环进入颅内，发生脑膜的急性炎症，局部炎症细胞浸润，小血管脓毒性静脉炎或动脉被感染性栓子阻塞而使局部脑组织软化、坏死，进而局限液化区不断扩大汇合成脓腔，邻近脑组织严重水肿，产生脑脓肿。本案例因右眼不适，由乡下村民在未经严格消毒情况下，于眼外眦施行针挑，导致金黄色葡萄球菌感染，引起眼眶蜂窝织炎，病情未能控制，又通过眼静脉向内扩散，形成脑膜炎、脑脓肿。

【临床表现】

一般在施行针挑疗法后不久急骤起病，没有明显的潜伏期，主要表现为颅内占位性病变的症状。感染侵入颅内时，病人可有急性高热、头痛、呕吐、嗜睡或癫痫发作等，生化检查见血象中粒细胞增高，脑脊液中性粒细胞增多和蛋白质增高。随病变的渐渐局限化，感染现象减轻，病情稍缓解。少数病人因病初就及时接受大剂量抗生素治疗，感染及时控制而未形成脓肿，炎症反应消退后可完全恢复正常；若是病人的感染并未完全控制，形成脓肿并逐渐增大，而出现脑占位性损害的症状（与相应部位的脑瘤相似）。脑电图对半数以上大脑半球脓肿有定位意义；脑 CT 扫描检查的诊断意义最大。

【处理方法】

当脑脓肿尚未局限时或脓肿较小而未引起对颅内结构的压迫时，迅速采用抗生素及脱水剂治疗，如大剂量青、氯霉素或根据药敏给予相应的抗生素，一般需连续治疗 6 周。治疗期间应密切随访病情及复查 CT，如病情恶化或 CT 所见脓肿增大则应考虑手

术治疗。

对位置深或脓肿位于重要功能区或不能耐受开颅术者，采取穿刺抽脓术并注入抗生素，可能需要反复多次才能奏效。如脓肿包膜已形成的浅表脓肿，应予脓肿摘除术。不管脓肿包膜是否形成，当病情迅速发展，开始出现意识障碍，经脱水及穿刺未好转时，也应在发生脑疝前紧急行脓肿切除术或将急性炎症性坏死脑组织切除并行减压术。

【操作要点】

针挑疗法可用来治疗多种常见病，但屡有发生因消毒不严而引起感染并造成严重后果的事故，所以在操作时一定要注意做好消毒工作。其要点有以下几个方面：首先，树立严格的无菌观念，对针具的消毒给予足够的重视，施术时要使用消毒干净的针具，而已用过的针具再次使用前一定得重新消毒（目前临床上常采用高压消毒法，具体方法是将针具用纱布包裹好，放在高压蒸气锅内，在 15 磅汽压、120℃ 高温下，保持 15 分钟以上。若条件不具备或紧急的情况下，可将针具备于净水锅内，煮沸后再煮 15 分钟以上，或采用 75% 酒精浸泡 20~30 分钟）；其次，做好每个针挑部位的消毒，一般是先用 2% 碘酊自穴位中点向外消毒，再用 75% 酒精脱碘，在眼眶、舌系带等部位消毒更应严格，施术一定要待酒精完全蒸发后才可进行；再次，要消毒好术者的手指，其方法是先用左手持镊子夹住酒精棉球，自右手指尖擦拭至指根部，换一棉球再依法消毒其余部分，待酒精蒸发干后，右手持酒精棉球消毒左侧手指；最后，施术完毕后，由于针挑遗留针孔较大，故应使用一较干的消毒棉球轻轻按压片刻，并嘱患者注意保持局部清洁，谨防感染。

二十九、激光治疗外眼病引起光针反应

【案例】

刘××，男性，27 岁，于 1980 年 1 月 14 日来诊，诊断为外

麦粒肿（右上）。患者既往体健，否认有家族病史、精神病史及过敏史。采用 HN-2 型氦-氖激光针灸仪治疗。患者取半坐卧位，病灶正对激光光束，距离 90 毫米，光斑直径 2 毫米，功率 5 毫瓦。上午 10 时 35 分，接受激光治疗，10 时 40 分自觉恶心欲呕，胸闷，冷汗，心慌。患者因求治心切，未告诉医生。10 时 45 分，发现患者面色苍白，头部软弱而歪向一侧，双眼球上翻，身体自动下滑。立即关机停照，并速将患者扶至平卧位，询问病人时他已不能应答，查脉搏缓而无力，每分钟 45 次，呼吸尚可。10 时 47 分，患者出现尿失禁，立即行双内关穴按摩；10 时 50 分，神智清醒，但颜面仍苍白，口唇青紫，精神萎靡，少语。于 10 时 55 分静注 50% 葡萄糖 60 毫升加维生素 C 1 克，症状有所缓解；11 时 20 分完全恢复正常，事后追问患者并非空腹就诊^[36]。

【分析】

本例为重度全身性激光反应，症状类似重度晕针，但目前尚未阐明光针反应的确切原因和发病机理。笔者认为主要是由于氦-氖激光针灸仪高功率的照射，对人体产生了强烈的刺激，通过迷走神经的反射，引起全身外周小血管的扩张，外周血管阻力降低，回心血量明显减少，从而导致心脏输出量降低，血压下降，造成一时性、广泛性的大脑缺血所致。

【临床表现】

临床症状既可于照射后立即发生，也可在 2~10 小时内出现。一般分为局部反应和全身反应两种。局部反应：多在头面部照射时出现，如头昏、头胀痛、眼干、口干，鼻粘膜刺激症，耳内胀痛，牙胀痛，面部及口唇麻木等。全身反应：恶心、心慌、烦躁、胸闷，出冷汗，面色苍白，甚至口唇青紫，意识障碍及小便失禁等；女性患者，尚可有月经不调。全身反应一般持续半小时至 2 小时，亦有数日才消失的。

【处理方法】

1. 常规护理：迅速关机，并将患者扶至空气流通处，让其平卧于床上，松解衣带，注意呼吸、血压、脉搏、心率等情况。
2. 轻症：多不需处理，静卧片刻即可，或给予热水口服。如

局部麻木不适，持久不消，可服用B族维生素等药物。

3. 重症：可在上述处理的基础上，用指掐或针刺人中、素髻、涌泉、足三里，或艾灸百会、关元、气海等穴；必要时可用肾上腺素1毫升、阿托品1毫克肌注，或50%葡萄糖液40毫升加维生素C1克静脉推注等。

【操作要点】

激光穴位照射治疗疾病的方法，相对而言是比较安全的，而且还有无痛、无菌、无损害等优点，故深受患者喜爱。但随着这一疗法的普遍开展，发现它也会引起机体的不良反应（其发生率在2.25%~4.7%之间），因此临床上要给予足够的重视。一般来说，为了预防光针反应，在不影响疗效的情况下应尽量采用较低的功率输出，注意掌握其强度，尤其是在头面部照时；其次，要控制照射时间，注意询问病人有无不适，随时注意其异常情况，一旦出现上述临床症状即应暂停治疗；最后，不是非常必要的情况，一般光针疗法不要合用其他疗法，以便减少不良反应的发生率。

三十、推拿不当致面部皮肤损伤

【案例】

姜××，女性，26岁，工人。因右侧颞颌关节疼痛、弹响，吃饭、漱口不便2个月余而来诊。本症在进餐咀嚼、特别是食硬质食品时，疼痛明显加重。检查：局部虽无明显肿胀，但压痛较甚，张口时仅能容纳一指；双侧颞颌关节张口、闭口位X线摄片未见明显骨质病变。拟诊：颞颌关节功能紊乱。推拿治疗：在下关、颊车等穴用推法、指揉法治疗后，即发现局部皮肤有0.5厘米×0.5厘米大小的破损^[37]。

【分析】

皮肤是人体的一个重要器官，对保障机体健康起着重要的屏障作用，故当皮肤损伤时不仅有碍于正常的推拿治疗，若处理不当还会引起伤口的继发感染，痊愈后甚至会遗留下疤痕（尤其面部的表皮层损伤），给病人带来极大的烦恼，故术者必须小心谨慎。

本案例术者在操作过程中，由于指法运用不当，如推法过于生硬，只注意到拇指的掌指、指间屈伸运动，而忽略了前臂作主动的摆动，和前臂、掌指、指间诸部的协调运动；或过久的指揉法，对穴位刺激时间过长，均可使局部皮肤受到损伤。

【临床表现】

在手法治疗的局部，病者往往先有一阵较明显的灼热感或剧痛，即刻就可以发现皮肤的表层有不同程度的破损，继而在伤口处可见有组织液的渗出，呈红色（由于表皮层内没有血管，故破损后不会出血）。

【处理方法】

对皮肤的表皮损伤，一般无需特殊处理，但是一定要保持伤口的清洁，以防继发感染。若组织液渗出较多时，可外涂紫药水或红药水，不要包扎，数日后即可获痊愈。

【操作要点】

术者平时应加强手法基本功训练，提高手法的熟练程度，正确掌握各种手法的动作要领。操作时，若在面部使用推法或指揉法，则应加用治疗巾保护，以免不慎损伤面部皮肤。

参 考 文 献

- [1] 高忻洙，等．针灸意外及其防治 湖南科学技术出版社，1993年7月（第1版）
- [2] 方都．天津医药 1977；（8）：35
- [3] 管遵惠．福建中医药 1991；（3）：22
- [4] 王文荣．广西赤脚医生 1978；（3）：24
- [5] 郝习武．北京中医学院学报 1986；（6）：29
- [6] 张治洲，等．湖北中医学院学报 1983；（2）：8
- [7] 周天祺，等．新疆中医药 1985；（4）：24
- [8] 李玉明，等．精神神经疾病杂志 1980；（3）：6
- [9] 陆彬如．河南赤脚医生杂志 1980；（12）：17
- [10] 刘信基．神经精神病杂志 1981；（5）：317
- [11] 史正修．人民军医 1981；（8）：60
- [12] 刘生祥．山西医药杂志 1980；（6）：53

- [13] 包礼平, 等. 精神神经疾病杂志 1984; (1) : 45
- [14] 周建伟. 四川中医 1988; (10) : 52
- [15] 丁育基. 赤脚医生杂志 1980; (1) : 10
- [16] 府剑英, 等. 江苏中医杂志 1985; (7) : 36
- [17] 黄克维, 等. 中医杂志 1957; (7) : 353
- [18] 刘宗惠, 等. 人民军医 1984; (12) : 51
- [19] 施永康. 人民军医 1979; (7) : 78
- [20] 韩辉. 中西医结合资料 (山西省中医研究所内部刊物) 1980; (16) : 62
- [21] 陈巩荪. 耳针研究 江苏科技出版社, 1982
- [22] Glenn Ailison et al, Acricular chonedritis Secondary to Acupuncture, New Eng J of Med. 1975; (293) : 780
- [23] 唐敬邦译. 中医药研究参考 1978; (4) : 57
- [24] 徐以径, 等. 山东中医杂志 1988; (5) : 38
- [25] 金观源. 江西中医药 1981; (2) : 63
- [26] 赵树桢, 等. 河北医药 1987; (3) : 195
- [27] 罗星照, 等. 中国农村医学 1983; (6) : 24
- [28] 苏渊, 等. 上海针灸杂志 1990; (1) : 22
- [29] 抑孝先. 新中医 1974; (3) : 37
- [30] 刘导语. 遵义医学院学报 1983; (4) : 58
- [31] 陈世谋. 中医杂志 1980; (7) : 49
- [32] 李天东, 等. 中华外科杂志 1960; (4) : 406
- [33] 杨元德. 陕西中医 1986; (7) : 319
- [34] 张仁, 等. 针灸意外预防及处理 上海科学技术文献出版社, 1988 年 7 月 (第 1 版)
- [35] 田德会, 等. 南阳市科技报·耳鼻喉科专辑 1978; (3) : 70
- [36] 曹国政, 等. 新医学 1980; (1) : 379
- [37] 刘岚庆, 等. 推拿意外的预防及处理 上海科学技术出版社, 1991 年 8 月 (第 1 版)

第三章 颈项部腧穴的意外事故

颈项部腧穴的针灸意外事故,临床上最常见的就是刺伤血管、脊髓或延髓。因此,为了防止各种意外的发生,医者要熟悉穴位的解剖结构,注意准确定穴,严格遵守针灸操作的宜忌,这样才能避免事故的发生。

一、针刺人迎穴引起迷走神经反应

【案例】

某患者,女,26岁,工人。1963年8月因慢性盆腔炎由本院妇产科转来,按期在月经前后多次进行针灸治疗。既往无心血管及癫痫病史。体检见发育营养佳,咽腔慢性充血,扁桃体不肿大,心肺听诊无特殊发现。诊断:慢性盆腔炎;慢性咽炎。本次下班后,骑2.5公里路的自行车前来我科,未作任何休息即行针灸治疗。病人卧位,穴取关元、气海、交信等,予平补平泻,留针20分钟,出针后病人无任何不适。后因病人要求治疗咽喉部不适和疼痛,遂加刺双侧人迎穴,进针深约0.8寸,针下得气后,病人当即惊叫一声,眼向上翻,四肢抽搐,不省人事。立即出针,此时脉搏测不到,面色青紫,听诊心率极度缓慢无力,继之心跳、呼吸停止,一切反应消失。即强刺人中,胸外心脏挤压,请内科医师会同急救处理,肌肉注射可拉明1支无效,继之静脉推注50%葡萄糖40毫升加阿托品1毫克。3分钟后心跳开始恢复,听诊心率20~25次/分,律不整,继之出现频繁早搏,脉短促;5分钟后病人逐渐清醒,心率、呼吸逐渐恢复正常。观察2.5小时,除有

窦性心率不齐，早搏 4~5 次/分外，均恢复正常，遂与其爱人一同回家。第 2 天工作如常。15 年后随访，慢性盆腔炎已愈，但自 1968 年以来常感心悸、胸闷、气急，心电图提示窦性心动过速（心率 116 次/分），近两年来心悸、胸闷等未复发^[1]。

【分析】

针刺引起迷走神经反应，主要是指针刺的机械性刺激，可以兴奋迷走神经，致使迷走神经的反射亢进，通过迷走神经传出系统，作用于其效应器官而产生一系列症状。如引起冠状血管痉挛和心脏传导障碍，甚至使心跳骤停，或支气管痉挛而造成呼吸困难，以及恶心、呕吐等内脏反应。本案例正是由于操作不慎，针尖刺中迷走神经，因迷走神经中包含有最重要的支配心脏活动的副交感纤维，当受到刺激时即严重抑制心脏的活动，使冠状血管收缩，产生窦性心动过缓、房室传导阻滞，严重者出现心跳停止。

【临床表现】

迷走神经反应在症状上出现的都是效应器官变化，发作突然，表现凶险，病情进展快。临床表现以神经和循环系统的症状最为明显。其症状和体征可先出现心率减慢、血压下降、面色苍白、出汗，然后依次出现：①心音消失；②脉搏扪不到，血压测不出；③意识突然丧失，或在一短阵抽搐（这种抽搐常为全身性，持续时间长短不一，可长达数分钟）之后出现意识丧失，多发生于心脏停搏后 10 秒钟内；④呼吸断续，呈叹息样，以后呼吸停止，多发生在心脏停搏后 20~30 秒钟内；⑤昏迷，多发生于心脏停搏 30 秒钟后；⑥瞳孔散大，多在心脏停搏后 30~60 秒钟出现。

【处理方法】

临床上一旦出现迷走神经反应症状，应立即停止刺激，将针起出，并及时进行抢救，这样才有可能使病人恢复正常，否则会造成脑和全身器官组织的不可逆损害而导致死亡。

本症是由迷走神经对机体产生的强有力作用所致，故使用阻断迷走神经作用的药物很有作用。最常用的是阿托品，每次可肌注 1~2 毫克或静脉注射 1 毫克。另外，还可肌注肾上腺素，用量为 0.5~1 毫克。大部分病人经此治疗便可恢复。

如果出现心脏骤停，应及时进行抢救。一般临床上的复苏处理可划分为3个时期：第1期，支持基础生命活动，特别是迅速给脑组织以氧合的血流，其步骤包括畅通气道、人工呼吸和人工胸外挤压；第2期，进一步支持生命活动，恢复自动心搏。包括进一步维持有效的换气和循环，建立和维持静脉滴注的通道和碱性药物（常规用5%碳酸氢钠，首剂按1mEq/kg计算，在有效循环恢复之前每10分钟予首剂之半量维持）的应用，心电图监测和抗心律失常治疗（药物可用利多卡因、阿托品等，电技术可采用电击除颤和电起搏），增加心排出血量和维持血压（药物可选用盐酸肾上腺素、去甲肾上腺素、多巴胺、阿拉明、氯化钙等）；第3期，心搏恢复后的处理，包括防治引起心脏骤停的原发疾患，继续维持有效的循环、呼吸，防治脑水肿，防治急性肾功能衰竭，维持水、电解质和酸碱平衡，防治继发感染等。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：分布有颈横神经，该神经是来自颈丛的皮神经，神经纤维来自第2、3颈神经。
2. 皮下组织：有上述皮神经分布，皮下组织内还有受面神经颈支支配的皮肤——颈阔肌。
3. 颈深筋膜浅层：为包绕胸锁乳突肌的深筋膜在该肌前缘融合而成，其深面紧邻颈动脉鞘。
4. 咽缩肌：主要附着于甲状软骨，并构成咽壁的肌组织，其运动受迷走神经的咽支支配。

【操作要点】

施术时病人以仰卧位为最佳，这种体位既可预防晕针的发生，又有利于术者的操作。由于本穴深处有颈总动脉、颈内静脉，故进针时要避开血管，在其前方或略向内直刺，细心体会手下针感，免伤颈总动脉（若进针感到粘滞，且有明显的搏动感，则应退针，调整方向再刺）；进针深度一般为0.3~0.5寸，最深不宜超过1寸，而且不提倡施行捻转提插手手法，否则容易刺伤迷走神经（位于颈总动脉、颈内静脉之间的后方），导致严重后果。总之，本穴针刺时进针切不可偏外、过深以及手法过重。此外，本穴禁灸。

二、深刺安眠穴导致蛛网膜下腔出血

【案例】

某一男性患者，32岁，因失眠、头痛多时来诊，即予针灸治疗。用4寸长毫针经常规消毒后深刺入安眠穴，患者突感全身发麻、电击样感及后头部痛，继而呕吐、头痛加重，后颈痛剧烈。既往无类似发作史。经检查为蛛网膜下腔出血。经卧床休息、镇静、止痛、止血及降颅内压等处理，2周后痊愈^[2]。

【分析】

蛛网膜下腔的表面血管极为丰富，在针刺颈项部穴位时，如果进针过深，就可能刺入椎管，伤及颅腔内血管，引起蛛网膜下腔出血。本例的术者在追求“深刺高效”的过程中，由于不注意该穴的内部重要结构，加上针刺方向错误，进针过深，使针尖穿过寰枕关节，伤及其深面结构蛛网膜、脊髓等，导致蛛网膜下腔出血，造成严重的后果。

【临床表现】

在针刺过程中，患者突然感到一种“电击样”的全身触电感，随即出现剧烈头痛、频繁呕吐，伴有面色苍白、大汗淋漓、畏光少语，半数病人会有不同程度的意识障碍，或谵妄，定向力障碍，错觉和幻觉等，部分病例可有局限性或全身性癫痫发作。

体征：以脑膜刺激征为主，多有颈项强直且有抵抗，其次为克氏征阳性；眼底检查可发现视网膜即玻璃体下片状出血；呼吸不规则，脉搏缓慢。脑脊液压力增高，呈均匀血性，2~3天后则变黄，蛋白量增高；头颅CT可直接确定蛛网膜下腔的凝血块以及是否存在脑水肿等；周围血象可见轻度的白细胞增多，尿检查可有尿糖及蛋白。

【处理方法】

1. 保持安静，绝对卧床休息4~6周，尽量减少搬动，以防继续出血或再发出血，使破裂血管得以充分恢复。特别是要注意避免情绪激动和突然用力，也不宜过早下床活动，并用轻泻药保持

患者的大便通畅。

2. 有意识障碍和脑水肿、颅内压明显增高者可用脱水剂，如快速静脉滴入 20% 甘露醇 250 毫升，每 6~8 小时 1 次，或速尿 20 毫克加 50% 葡萄糖 50 毫升静注，或地塞米松 10~20 毫克静注；有高血压者，可选用利血平 1 毫克或 25% 硫酸镁 10 毫升肌注，使血压保持在 20.0~21.3/12.0 千帕（150~160/90 毫米汞柱）左右为宜；头痛剧烈或躁动不安者，可给予止痛镇静剂。

3. 应用止血剂。选用纤维蛋白溶解抑制剂，目的在于阻止动脉破裂处凝血块的溶解，防止再出血和缓解血管痉挛。可选用：① 6-氨基己酸 4~6 克，加入 10% 葡萄糖 500 毫升内静脉滴注，每日 1~2 次，连用 2~3 周；② 抗血纤溶芳酸，每次量 200~400 毫克，用法同上，尚可选用安络血、凝血酶、仙鹤草素、止血敏、三七粉和云南白药等。

4. 外科治疗。对有外科手术指征的患者，应在情况许可时尽快施行手术。

5. 中药治疗。肝阳上亢型，方用镇肝熄风汤、天麻钩藤饮加减；肝火热盛型，常用羚羊角汤或羚羊钩藤汤加减化裁；湿热内阻型，方用黄连温胆汤加味；痰蒙清窍型，方用涤痰汤加味。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：分布有耳大神经、枕小神经。耳大神经属颈丛皮支，由第 2、3 颈神经纤维组成；枕小神经亦属颈丛皮支，由第 2 颈神经纤维组成。

2. 皮下组织：有上述神经纤维和枕动、静脉的分支或属支。

3. 胸锁乳突肌：斜列于颈部两侧的长条形肌，以内、外两头分别起自胸骨柄的前面和锁骨的内侧端，斜向后上方止于颞骨的乳突，由副神经脊髓根及第 2、3 颈神经前支支配。

4. 头夹肌：位于胸锁乳突肌的深面，是一不规则的三角形扁肌，受颈中部脊神经后支的外侧支支配。

【操作要点】

针刺时嘱患者取俯伏位或侧坐位，常规消毒穴位（在翳风穴与风池穴连线之中点处），取 30~32 号长 1.5 寸毫针，缓慢直刺

入穴位 0.5~1 寸。勿进针过深，且针尖勿向内上方斜刺，否则易伤及深部的蛛网膜、脊髓等重要结构，产生严重的后果；若针刺过深，还易损伤其深部的枕动、静脉以及更深处的椎动脉，导致出血等意外。

三、电针安眠穴引起房室传导阻滞

【案例】

笔者共收治 17 例精神病患者，施行电针疗法。采用福建泉州医疗电器厂生产的 7010-2 型电针休克治疗机，穴取双侧安眠穴，直刺进针深约 1~1.2 寸，加电（其机的电压为 10V，输出电流 30~35mA，频率 60 次/分）治疗。此期间患者会出现头部肌肉痉挛，屏气，面部呈青紫等缺氧征，时间约 1~5 秒，然后立即将输出电量减少或停止，使病人肌肉放松，呼吸恢复，面色正常。过 30~60 秒后再行第 2 次刺激，连续冲击 5~6 次。每天治疗 1 次，6 天为 1 个疗程。结束疗程后复查心电图，出现心电图异常应立即终止治疗。

全部病例先后出现程度不同的房室传导阻滞，其中 I 度房室传导阻滞 12 例，II 度房室传导阻滞 5 例。其心电图变化特征：I 度房室传导阻滞中，P-R 间期 0.22 秒者 2 例，0.24 秒者 8 例，0.26 秒者及 0.28 秒者各 1 例；II 度房室传导阻滞中，全部为一型（文氏现象），其中 5:4 者 2 例，4:3 者 3 例。出现房室传导阻滞的时间，第 1 疗程后 8 例，第 2 疗程后 6 例，第 3 疗程后 2 例，第 4 疗程 1 例。停止治疗后，心电图恢复的时间，第 1 周 12 例，第 2 周 3 例，3~4 周各 1 例，仅有 1 例未能恢复^[3]。

【分析】

房室传导阻滞又称房室间传导障碍。从解剖生理的角度看，房室结、房室束与束支的近端为传导阻滞的好发部位。临床上传导阻滞可分为生理性与病理性两大类，传导系统的不应期和应激性正常，由于冲动到达过早所引起的传导阻滞，称为生理性传导阻滞；由于传导系统的应激性病态降低，不应期病态延长所致的传

导阻滞，称为病理性传导阻滞，可由传导系统的器质性或功能性改变引起。本案例是因电针强刺激安眠穴引起房室传导阻滞，其机理目前尚未明确。笔者认为与本法引起迷走神经功能亢进有关。在解剖学上安眠穴与迷走神经的关系较密切，该穴的水平位置深部迷走神经干发出一个细小分支——心上支，分布到心脏的窦房结或房室结（以后者为主），司理心脏的运动和感觉。因此，当电针安眠穴给予强刺激时，会使迷走神经兴奋，心跳减慢、减弱，导致房室传导阻滞情况的发生。

【临床表现】

I度房室传导阻滞多无症状，听诊时可有第1心音减弱。Ⅱ度I型房室传导阻滞病人可无症状或仅有心搏脱漏感觉，听诊时有心音脱漏，第1心音强度可随P-R间期改变而改变；Ⅱ度Ⅱ型病人如因脱漏频繁而致心室率明显减慢时，其症状类似Ⅲ度房室传导阻滞，甚至出现阿-斯综合征，听诊心律整齐或有心音脱漏。Ⅲ度房室传导阻滞，心室率较快时可仅有活动时心悸、气促，心室率慢时则有头晕、乏力、气促、胸闷，严重时发生心功能不全和阿-斯综合征（心室停搏超过15秒时可出现昏厥、抽搐和青紫等情况），甚至可发生猝死。听诊心律慢而规则，第1心音强弱不等，响亮者称为“大炮音”；颈静脉搏动频率快于心率，也可闻及肺动脉瓣区收缩期喷射性杂音和第3心音。此外，尚可有收缩压增高、脉压增宽等表现。

心电图表现：①I度者P-R间期 >0.2 秒；②Ⅱ度I型者，P-R间期逐渐延长，R-R间期逐渐缩短，直至有1个P波不能下传至心室，脱漏后第1个P-R间期缩短，如此周而复始，形成3:2、4:3、5:4等不同房室比例的阻滞；Ⅱ度Ⅱ型者，P-R间期固定，每2个或数个P波后脱漏1个QRS波群，形成2:1、3:2、4:3等不同房室比例的阻滞；③Ⅲ度房室传导阻滞又称完全性房室传导阻滞，全部P波不能下传心室而形成房室分离，心房率 $>$ 心室率。心室心律由交界区（房室结内阻滞）或心室自主起搏点（希氏束分支以下阻滞）维持，前者心率每分钟约40~60次，QRS波群不增宽；后者心率每分钟约30~40次，QRS波群增宽且畸形。

【处理方法】

房室束分支以上阻滞形成的Ⅰ～Ⅱ度房室传导阻滞，不影响心脏功能，主要针对病因治疗。房室束分支以下阻滞，不论是否引起房室传导阻滞，均必须结合临床表现和阻滞的发展情况，慎重考虑电起搏治疗的适应证。

1. 病因治疗：停止电针，马上起针，停止对迷走神经的强刺激；予阿托品 0.3 毫克口服，每 4 小时 1 次，必要时肌肉或静脉注射，每 4～6 小时 0.5～1 毫克。

2. 增快心率和促进传导：选取交感神经药，如常用异丙肾上腺素每 4 小时舌下含 5～10 毫克，或麻黄素口服 0.03 克，每日 3～4 次；碱性药物（碳酸氢钠或乳酸钠），一般用克分子溶液静脉滴注或推注。人工心脏起搏的治疗，心室率缓慢并影响血流动力状态的Ⅱ～Ⅲ度房室传导阻滞，尤其是阻滞部位在房室束分支以下，并发生在急性心肌炎、急性心肌梗塞时，均为其治疗指征。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：分布有耳大神经、枕小神经。耳大神经属颈丛皮支，由第 2、3 颈神经纤维组成；枕小神经亦属颈丛皮支，由第 2 颈神经纤维组成。

2. 皮下组织：有第 2、3 颈神经纤维和枕动、静脉的分支或属支。

3. 胸锁乳突肌：斜列于颈部两侧的长条形肌，以内、外两头分别起自胸骨柄的前面和锁骨的内侧端，斜向后上方止于颞骨的乳突，由神经脊髓根及第 2、3 颈神经前支支配。

4. 头夹肌：位于胸锁乳突肌的深面，是一不规则的三角形扁肌，受颈中部脊神经后支的外侧支支配。

【操作要点】

由于安眠穴的水平位置深部有迷走神经干，故针刺治疗时勿刺入过深，其深度以 0.5～1 寸为宜。施行电针疗法时，电针休克治疗机的输出电流勿太大，否则过强的刺激、过大的刺激量，极易使迷走神经兴奋，导致房室传导阻滞的发生。此外，凡是心脏病、高血压患者，或者年龄偏大、体质虚弱患者，施行电针强刺

激该穴时，均应特别慎重，这样才能尽量避免上述情况的发生。

四、电针扶突穴引起迷走神经反应

【案例】

何××，女性，38岁，因甲状腺功能亢进症施行手术。术前心尖区有轻度收缩期杂音，心界稍大，心率每分钟90次，双肺听诊无异常，基础代谢率+23%。术前静脉注射鲁米那0.1克，行针刺麻醉。取双侧扶突穴，进针约1寸，又取右侧合谷、内关穴，用上海G-6805型治疗仪通电，频率每分钟170次。通电后，发现病人面唇青白、出冷汗，但神志尚清，脉搏从82次/分降到54次/分，血压从21.2/12千帕降至16.5/10.1千帕，并出现期前收缩。立即将扶突穴的针退出约1厘米，电针频率减至每分钟150次，病人情况即好转，脉搏回升到80次/分，期前收缩消失。后顺利在针麻下施行了甲状腺次全切除术，术后情况良好。

另外还有1例男性患者，23岁，在施行结节性甲状腺肿手术时，也发生同样反应，经同样处理而愈^[4]。

【分析】

本例所用的扶突穴，其解剖位置相当于颈丛神经，深层属运动神经并与交感、副交感神经形成的吻合网，迷走神经干亦在此部位下行。如果在该穴处针刺过深或通电量过大，即可直接或因电流扩散而刺激迷走神经，发生迷走神经反应，出现心跳减慢、血压下降、出冷汗等症状。

【临床表现】

迷走神经反应在症状上出现的都是效应器官变化，发作突然，表现凶险，病情进展快。临床表现以神经和循环系统的症状最为明显。可先出现心率减慢、血压下降、面色苍白、出汗等，然后依次出现：①心音消失；②脉搏扪不到，血压测不出；③意识突然丧失，或在一短阵抽搐（这种抽搐常为全身性，持续时间长短不一，可长达数分钟）之后出现意识丧失，多发生于心脏停搏后10秒钟内；④呼吸断续，呈叹息样，以后呼吸停止，多发生在心脏

停搏后 20~30 秒钟内；⑤昏迷，多发生于心脏停搏 30 秒钟内；⑥瞳孔散大，多在心脏停搏后 30~60 秒钟出现。

【处理方法】

临床上一旦出现迷走神经反应症状，应立即停止刺激，将针起出，并及时进行抢救，这样才有可能使病者恢复正常，否则会造成脑和全身器官组织的不可逆性损害而导致死亡。

本症是由于迷走神经对机体产生的强有力作用所致，故使用阻断迷走神经作用的药物很有意义。其最常用的是阿托品，每次可肌注 1~2 毫克，或者静脉注射 1 毫克。另外，还可肌注肾上腺素，用量为 0.5~1 毫克，大部分病人经此治疗便可恢复。

如果病人出现心脏骤停，则应及时进行抢救。一般临床上的复苏处理可划分为 3 个时期：第 1 期，支持基础生命活动，特别是迅速给脑组织以氧合的血流，其步骤包括畅通气道、人工呼吸和人工胸外挤压；第 2 期，进一步支持生命活动，恢复自动心搏。其包括进一步维持有效的换气和循环，建立和维持静脉滴注的通道和碱性药物（常规用 5% 碳酸氢钠，首剂可按 1mEq/kg 计算，在有效循环恢复之前每 10 分钟予首剂之半量维持）的应用，心电图监测和抗心律失常治疗（药物可选用利多卡因、阿托品等，电技术可采用电击除颤和电起搏），增加心排出血量和维持血压（药物可选用盐酸肾上腺素、去甲肾上腺素、多巴胺、阿拉明、氯化钙等）；第 3 期，心搏恢复后的处理，包括防治引起心脏骤停的原发疾病，继续维持有效的循环、呼吸，防治脑水肿，防治急性肾功能衰竭，维持水、电解质和酸碱平衡，防治继发感染等。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：分布有颈横神经，它属颈丛的皮支之一，由第 2、3 颈神经组成。

2. 皮下组织：内有颈横神经、面神经的颈支以及颈阔肌。颈阔肌位于颈前外侧部皮下，为一菲薄宽阔的长方形皮肤，和皮肤紧密结合，受面神经颈支的支配。面神经颈支，由腮腺下端穿出，在下颌角前方入颈部，支配颈阔肌。

3. 胸锁乳突肌：斜列于颈部两侧的长条形肌，以内、外两头

分别起自胸骨柄的前面和锁骨的内侧端，斜向后上方止于颞骨的乳突。它由副神经脊髓根及第 2、3 颈神经前支支配。

4. 深面：为颈血管鞘的后壁，颈血管鞘内包有颈总动脉、颈内静脉和迷走神经。

【操作要点】

施术时病者取仰卧位为最佳，这样既利于术者的针灸操作，又可预防晕针情况的发生。由于本穴的深面有颈总动脉、颈内静脉和迷走神经，故进针深度一般为 0.5~1 寸，最深不宜超过 1.5 寸，而且也不提倡施行捻转提插补泻手法，否则容易刺伤颈总动脉（刺中时会感到针下有粘滞感，且有明显的搏动）和迷走神经，引起较严重的后果。

五、翳风穴位注射导致面瘫

【案例 1】

王××，女性，42 岁，1989 年 9 月 1 日诊。自诉右面部肌肉抽搐 2 年余，频繁发作，情绪紧张时加重，1986 年曾患过面瘫，后治愈。查体可见右口角及下眼睑部肌肉阵发性抽搐，头部 CT 及 SEP（脑干诱发电位）正常，曾用中西药物治疗，效果不佳。拟诊为面肌痉挛症。用穴位注射治疗。穴位选患侧翳风等，药物用鲁米那 0.1 克加注射用水 1.5 毫升溶解，再加 2% 盐酸普鲁卡因 0.5 毫升。方法：病人卧位，穴位常规消毒后，用 5 号或 5.5 号注射针头，快速刺入穴位 1~1.5 厘米深，待有针感后，先把药物缓慢注入翳风穴约 1 毫升左右，其余注入其他穴位。注射后约 10 分钟左右，病人自述面部麻木，说话时右侧活动不灵活。查见口角歪向左侧，右侧鼻唇沟变浅，皱眉右侧额纹变少，右眼睑闭合无力。当即诊为周围性面瘫，给予维生素 B 族药物、理疗等，1 周后恢复^[5]。

【案例 2】

赵×，女，58 岁，1989 年 10 月 5 日诊。该病人患左侧面肌痉挛症 3 年，发作频繁，曾用高热射频仪治疗，稳定半年又复发。

曾做头 CT、脑电图等检查，无异常。拟诊为面肌痉挛。用穴位注射方法，选翳风穴等，用 5 号或 5 $\frac{1}{2}$ 号注射针头，抽取鲁米那 0.1 克（加注射用水 1 毫升溶解）和 2% 普鲁卡因 0.5 毫升，常规消毒穴位后快速刺入 1~1.5 厘米深，待有针感后缓慢注入药液 1 毫升左右。注射后约 6~7 分钟即发生面瘫，后给予理疗、扩血管药及维生素 B 族药物，口服中药牵正散加减，半月恢复。

孙××，女性，41 岁，1990 年 5 月 6 日诊。患左侧面肌痉挛症半年，曾用中西药物及维生素 B₁、B₁₂ 面部穴位注射，效果不明显。用上述方法治疗，5 分钟左右即发生面瘫，后经治疗，10 余天恢复^[5]。

【案例 3】

张××，女性，67 岁，1993 年 4 月 8 日就诊。该患者头痛 2 日，当时诊为血瘀型头痛，给予当归注射液 1 毫升注射左侧翳风穴（针头 5 号），约 2 分钟后患者自觉左侧面颊部麻木，口眼喎斜，不能鼓腮等。当即给予按摩面部后，1 天恢复正常^[6]。

【分析】

穴位注射是针灸科常用的治疗方法，对多种原因引起的疾病有着良好的治疗效果，但因穴位注射而造成神经损伤的事故亦不少。究其原因可能有两种：一是注射用穴距神经干很近，针尖刺入穴位后直接损伤神经干；二是注射用药的药理作用，导致对局部神经的不同程度的损伤。因此，在穴位注射时，要注意选择注射的穴位和药物，才能尽量减少造成神经损伤的人为因素。本节几个案例所选用的穴位均为翳风，从现代解剖学来看，翳风穴的位置正处在面神经从茎突孔出颅的地方。面神经从茎突孔出颅后，穿过腮腺才分出分支，故当该穴针刺过深时，极易损伤深面的神经干。加上注射药物（如普鲁卡因、鲁米那、当归注射液）对局部神经干的药理作用，导致面神经麻醉的发生。

【临床表现】

面神经针刺损伤按其损伤部位、轻重有所不同。若主干损伤，主要表现为伤侧表情肌瘫痪，角膜反射消失，听觉过敏，舌前 2/3

味觉障碍，泌泪和泌涎障碍；若面神经管外损伤，则出现患侧表情肌瘫痪的症状——额纹消失，不能闭眼，鼻唇沟平坦，不能鼓腮和吹口哨，口角偏向健侧等。

【处理方法】

1. 理疗：超短波治疗，每次 15 分钟，每日 1 次；或新斯的明离子透入，以 1：2000 新斯的明 1~2 毫升放于正极，每日或隔日 1 次，10 次为 1 个疗程。

2. 针刺：以局部穴位为主，配合循经远取，如阳白、鱼腰、下关、地仓、合谷、风池等，每日 1 次。开始先用轻刺激，不留针，1 周后刺激量逐渐加强，配合留针、电针、拔罐、梅花针等。治疗期间令病人每天用手掌揉搓患侧面部 3~4 次，每次 3~5 分钟，务使面部发热。

3. 中药：牵正散加减，每日 1 剂；小活络丸口服，每次 1 丸，每日 3 次。

4. 西药：维生素 B₁100 毫克加维生素 B₆50 毫克肌注，每日 1 次；或维生素 B₁、B₆ 各 10 毫克口服，每日 3 次。还可用地巴唑 10 毫克或烟酸 50 毫克，每日 3 次。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：分布有耳大神经，它为颈丛皮支，由第 2、3 颈神经组成。

2. 皮下组织：内有上述神经纤维。

3. 腮腺：略呈三角形，位于外耳道前下方、咬肌后缘和下颌后窝内，腮腺的表面包以腮腺咬肌筋膜，腮腺内有颈外动脉、下颌后静脉、面神经和耳颞神经经过。

4. 深面：从浅至深依次分布有胸锁乳突肌、头夹肌、头最长肌、二腹肌后腹。

【操作要点】

为预防翳风穴穴位注射引起面神经麻醉的事故，临床上应尽量不选用翳风穴来做穴位注射的腧穴。如果一定要使用该穴位，则要求操作时术者的动作要轻柔，进针不宜超过 1 寸深，待局部有酸胀感后，缓慢将药液推入；而且，穴位注射的药物要选择一些

对神经刺激性较小的药品，注意掌握药物的剂量及理化特性。总之，临床上施行穴位注射时，一定要注意以下原则：准确取穴，针刺后应尽量避免反提插捻转；不宜选用刺激性较强的药液；不宜直接在神经干或在其分支上注射；注射时应力求缓慢推液。

六、针刺翳风穴引起心跳呼吸停止

【案例】

叶×，男性，26岁，职工。诉左眼深处近乳突部疼痛，酸胀不适，影响学习、工作和生活，前来求助针刺治疗。医者让患者取坐位，先针刺左侧翳风穴，向对侧翳风穴方向进针，深约2寸，行手法，得气不明显，遂留针。随即又从右侧翳风穴刺入一针，当进针深至2寸左右时，还没有来得及施行手法，患者自诉心中不适，恶心欲吐。话音刚落，即突然意识丧失，面色苍白，唇色紫绀，手足厥冷，心跳呼吸停止。医者见此情况，迅速取针，扶患者平卧，进行抢救。先针刺人中、按压内关，约1分钟后，患者恢复心跳、呼吸，神志逐渐清醒；然后悬灸百会，静脉给予高渗糖，休息半小时，可站立行走。事后患者补述：当时只觉得恶心欲吐，心中难受至极，突然就什么也不知道了，一切抢救过程全然不晓^[7]。

【分析】

根据现代解剖学理论，翳风穴后内方的深面有迷走神经（它位于颈内动、静脉的后方），主要含副交感纤维成分，分布于颈、胸、腹部的内脏器官及腺体，特别是分布于心脏和肺脏。当深刺该穴的时候，其机械性刺激可使迷走神经的兴奋性增强，通过迷走神经传出系统，作用于其效应器官而产生一系列症状。

【临床表现】

迷走神经受刺激后的表现很凶险，发作极突然，病情进展快，临床上以神经和循环系统的症状最为明显。其症状和体征可先出现面色苍白，大汗出、心率减慢、血压下降等。然后依次出现；心音消失；脉搏扪不到，血压测不出；意识突然丧失，或在一短阵

抽搐（这种抽搐常为全身性，持续时间长短不一，可长达数分钟）之后出现意识丧失，多发生于心脏停搏后 10 秒钟内；呼吸断续，呈叹息样，以后呼吸停止，多发生在心脏停搏后 20～30 秒钟内；昏迷，多发生在心脏停搏 30 秒钟内；瞳孔散大，多在心脏停搏后 30～60 秒钟出现。

【处理方法】

临床上一旦出现迷走神经反应症状，应立即停止刺激，将针起出，并及时进行抢救。这样才有可能使病者恢复正常，否则会造成脑和全身器官组织的不可逆性损害而导致死亡。

本症是由于迷走神经对机体产生的强有力作用所致，故使用阻断迷走神经作用的药物很有意义。其中最常用的是阿托品，每次可肌注 1～2 毫克，或静脉注射 1 毫克。另外，还可肌注肾上腺素，用量为 0.5～1 毫克，大部分病人经此治疗便可恢复。

如果病者出现心脏骤停，则应及时进行抢救，其复苏处理可参考前述。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：分布有耳大神经，它为颈丛皮支，由第 2～3 颈神经组成。

2. 皮下组织：内有上述神经纤维。

3. 腮腺：略呈三角形，位于外耳道前下方，咬肌后缘和下颌后窝内，腮腺的表面包以腮腺咬肌筋膜，腮腺内有颈外动脉、下颌后静脉、面神经和耳颞神经经过。

4. 深面：从浅至深依次分布有胸锁乳突肌（由副神经脊髓根及第 2、3 颈神经前支支配）、头夹肌（由第 2～5 颈神经后支支配）、头最长肌（由第 1～8 颈神经后支支配）、二腹肌后腹（由面神经支配）。

【操作要点】

施术时病人以俯坐位或仰卧位为好，这样不仅有利于术者的针灸操作，而且有利于预防晕针情况的发生。一般而言，该穴的针刺深度为 0.5～1 寸左右，达到 1.5 寸时则不可再深刺，否则就有刺中迷走神经的可能（迷走神经的位置较深，正常情况下不容

易刺到)，从而导致严重后果。

七、针刺右颈部阿是穴导致感觉丧失

【案例】

吕××，男性，32岁，小学教师。1978年8月18日初诊。自诉10年来头皮发紧，双眼有烧灼感，记忆力减退，失眠，多梦。半年来曾针灸过5次，经治疗后左半侧头部症状消失，但左手中指、无名指及小指感到无力，左下肢从膝关节以下亦感乏力，近来右半侧头痛。检查神经系统未发现异常。初诊印象：神经衰弱，神经性头痛。因其右侧头顶部有一敏感压痛点Ⅱ度（具体位置不明），左侧对应处则无，故在右侧该点行针刺治疗，刺入约0.6~0.7寸深。当针进入体内时，患者突觉左腿出现针感，向下传至脚部，有麻木抽动感，左侧头顶部区域一片汗出。行针半小时后，头部疼痛完全消失，自感头目清爽。4月20日左腿麻木感仍未消失。4月21日仍在原点针刺，复出现同样针感，但经针后出汗消失。5月6日左下肢依然麻木不适，由左侧第8肋间以下直达脚趾，全部肢体痛觉缺失，但触觉存在，运动自如。痛觉缺失区边界非常清楚，前后皆至正中中线为分界处，在该缺失区，虽用三棱针刺之出血，也毫无疼痛感觉。神经系统检查：患者神清合作，多汗，颅神经未见异常，肌张力正常，腱反射亢进。知觉：上述部位痛觉消失，温觉减退，触觉对称存在，自体感觉存在。停止针刺后，患者知觉逐渐恢复，痛觉缺失区逐步缩小。经1年8个月，至1978年2月8日复查，患侧痛觉始完全恢复至常态，与健侧相同，唯冷热感仍然低下^[6]。

【分析】

针刺引起人体感觉大面积减退或缺乏，在循经感传研究中亦有研究者发现此现象，其机理不甚清楚。据推测可能与中枢痛觉感受器受抑制有关，即强烈的机械性变形刺激，由感觉传入纤维经后根进入脊髓后角，继续上行至丘脑，终止于腹基复体，从而起到抑制作用。此外，还有一种观点认为，皮肤和其他组织中的

感觉感受器(伤害感受器)是有髓和无髓纤维的游离神经末梢,强烈的机械性刺激和极度的温度性损伤,都能使伤害感受器受到激动,且造成局部组织的损害,释放出化学物质,从而使机械性和温度性伤害感受器的激动阈值增高,因此原来无害的机械性刺激亦可引起机体的痛觉减退或缺失。

八、针刺不当引起颈总动脉瘤

【案例】

一患者,女性,33岁,农民,因右侧颈部搏动性肿块20余天于1977年8月14日急诊入院。患者于入院前20多天,因嗓子痛,在当地行右颈部针刺治疗,针刺后即起一蚕豆大小的肿块,并逐渐增大,疼痛发胀,呼吸窘迫,咽下困难,口流唾液。既往无颈部肿块及颈部外伤史。体检:发育正常,营养中等,神志清楚,头颈部向左偏斜,活动受限,右颈部有一约 $1.5\times 10\times 5$ (厘米)大小之搏动性肿块,气管受压极度左移,张口及伸舌均困难。肿块压痛明显,有震颤感,听诊可闻及响亮的吹风样杂音。胸腹部及四肢无异常。因该肿块直接发生于针刺之后,故诊断为创伤性右颈总动脉瘤。经右侧肱动脉选择性造影,见右锁骨下动脉后右侧椎动脉显影,右颈总动脉未显影。于8月10日行气管内插管,插管时因气管移位而出现困难,在静脉复合麻醉下,取右胸锁乳突肌前缘切口,行右颈总动脉瘤切除术。术中见右颈总动脉前壁位于颈内动脉与颈外动脉分叉处,有一 0.4 厘米 $\times 0.3$ 厘米之缺损,遂结扎颈外动脉,用无损伤血管之缝针及尼龙线缝合血管,恢复颈内动脉血管,切除瘤壁,缝合颈动脉鞘,放置橡皮引流条,逐层缝合切口。术后2小时,患者出现喉头水肿,呼吸困难,急行气管切开术,使呼吸改善。于8月22日拔除气管切开导管之后,患者又出现声音嘶哑、进食呛咳,用间接喉镜检查,咽反射差,右披裂水肿,向前隆起,不能活动,疑有披裂关节脱位,可能为插管困难所造成。用前连合喉镜试行复位术,经置放胃管鼻饲营养,对症治疗,于9月28日拔除鼻饲管,自己能经口进食,同年11月

4日痊愈出院^[9]。

【分析】

本例是由于针刺造成颈总动脉损伤所致。根据解剖学知识,颈总动脉是头颈部的动脉干,右侧发自头臂干,左侧发自主动脉弓,然后自胸锁关节后方,斜向外上,升至甲状软骨上缘高度分为颈内动脉和颈外动脉,位于胸锁乳突肌的深面。当针刺颈部人迎、扶突、天鼎、水突、天窗等穴位时,一定要慎重操作,否则易损伤颈总动脉,引起外伤性假性动脉瘤(动脉瘤在病理上分真性与假性两种)。因为当针刺损伤血管时,会致其血液溢出,而周围组织即对溢出的血液包围、限制并形成一个搏动性血肿,其中血小板、纤维蛋白进行机化包裹,形成瘤壁。由于血压的关系,血液可继续流出,瘤体不断扩大,所以形成越来越大的动脉瘤。

【临床表现】

一般均有颈部穴位深刺史(在颈总动脉附近),针治后出现一搏动性肿块,且逐渐增大,局部压痛明显,严重者可伴见吞咽困难、呼吸窘迫等。局部检查有收缩期震颤,听诊可闻及响亮的吹风样杂音。另外,选择性动脉造影术,对判明动脉瘤的起源,侧支循环的代偿情况有一定帮助。

【处理方法】

当发现有出血征象、临床症状表现较轻时,应冷敷,亦可加压包扎,并注意病情变化。若出血不止者,诊断明确以后应尽快施行手术治疗,并进行对症处理。

【操作要点】

在针刺治疗中,为避免伤及颈部的血管,操作时应注意以下几点:首先,要注意尽量避开血管,凡是那些容易摸到或肉眼可见的血管,针刺时应用押手拇指将血管推开,针尖沿指甲进针,而不易观察的深部血管只得借助于解剖知识;其次,要仔细选择和检查针具,最好使用体直、光滑、有弹性、无折痕锈蚀、针尖不带钩毛的毫针,一般不宜采用针体过粗、头部太尖的注射针头或缝衣针等;最后,颈部穴位出针后,一般应使用消毒干棉球揉按针孔片刻,使之闭合,以预防出血。如发现有出血征象时,则应

及时给予处理，并密切观察其病情的变化。

九、颈项部推拿不当损伤椎-基底动脉系

【案例 1】

男性，32 岁。因头痛要求做手法治疗。既往无高血压病史，体检时发现颈 3 椎棘突有偏移。对患者颈部做按脊复位治疗后，立即发生意识丧失，并在 48 小时后死亡。尸体解剖中发现基底动脉、左小脑下前动脉和右小脑下后动脉血栓形成^[10]。

【案例 2】

女性，35 岁。因颈痛 3 日求医于手法治疗。术前未作详细检查，即进行颈部按脊疗法，手法后即刻出现头痛、眩晕，不能端坐和站立，1 天后发生意识障碍，待送入医院数小时后死亡。经尸体解剖发现在基底动脉、右侧椎动脉和左小脑下后动脉有血栓形成^[10]。

【案例 3】

女性，22 岁，因颈部不适于 1973 年 6 月在某卫生院接受推拿治疗（数月前也接受过推拿）。在施行颈部推拿治疗后不久，患者忽然感觉四肢麻木，继而站立不稳而昏倒，后因并发褥疮而在医院死亡（未做尸体解剖）^[11]。

【分析】

根据现代解剖学，椎动脉左右各 1 条，起于锁骨下动脉，向上穿行于 6 个颈椎的横突孔，经枕骨大孔入颅，然后由延髓外侧向上，走向前内侧，至脑桥下缘汇合在一起，构成基底动脉，而基底动脉走行于脑桥正中的基底沟内，到脑桥上缘处分成两条大脑后动脉而终。椎动脉、基底动脉及其分支，合称椎-基底动脉系。当颈部的推拿治疗不当时，如强烈的颈部手法，或超越限度的颈部被动运动等，则易造成椎动脉血供不足或椎动脉损伤，尤其是与椎动脉并存的骨结构有先天性异常或退行性改变者，或有动脉粥样硬化的血管病变者，或一侧椎动脉的形态异常者，在接受治疗后更易致椎-基底动脉系损伤。由于椎-基底动脉分布于小脑、脑

干，故当该动脉系受伤发生病变后，即刻或不久就会出现小脑和脑干症状，甚至很快死亡，故一定要严格掌握推拿规范，以防不测。

【临床表现】

1. 椎-基底动脉一过性损伤发作的主要症状：①发作性眩晕、耳鸣、呕吐；②四肢、颜面、口唇周围有麻木感；③有四肢乏力、吞咽困难等，或短暂性发作性意识障碍；④视力障碍或同侧偏盲，眼球震颤，复视和共济失调症。

2. 椎-基底动脉闭塞的主要症状：①突然意识障碍，继而深昏迷；②头部疼痛，眩晕，呕吐；③双侧瘫痪（一侧较重），呈去大脑性强直；④部分闭塞时，出现瞳孔异常（缩小或散大），眼球震颤，复视，同向偏盲，共济失调等多种症状。

【处理方法】

主要是针对椎-基底动脉系病变的情况施行治疗，详见有关章节。

【预防要点】

1. 了解病者的既往病史，对有动脉硬化病变的要谨慎医治（因该病史患者可因粥样斑块的脱落而致管腔中形成溃疡，溃疡表面粗糙易形成血栓，血栓又可加重管腔的狭窄甚至引起闭塞）。

2. 颈项部手法治疗要有规范，被动运动要在生理范围以内，避免损伤椎动脉和影响椎-基底动脉。

十、颈部按摩致腋神经、肩胛上神经损伤

【案例】

邹××，男性，45岁，医师。1988年秋初诊。颈部疼痛不舒数日，左右转侧欠灵活，无明显外伤史和上肢放射性疼痛，就医于推拿治疗。专科检查：体健，头部轻微向左侧倾斜，左侧颈项部肌肉张力增高，伴有压痛，棘突、棘旁均无明显压痛及上肢放射痛，椎间孔挤压试验阴性，臂丛神经牵拉试验阴性。拟诊：落枕。即给予推拿治疗。先在颈部施行揉法、按揉法、拿法，同时

也做些较小幅度的颈项部被动运动；而后强行做了一次颈椎侧屈的被动运动。此手法后病员即刻感觉左侧肩、臂部一阵放射性剧痛、发麻，左臂沉重无力，2日后肩关节外展运动功能明显丧失，颈部活动严重受限，呈强迫体位。颈椎X线摄片提示：颈椎生理弧度变直，轻度向右侧突，诸椎体及附件未见明显骨质改变，椎间隙存在未见狭窄，钩椎关节正常，颈椎略有退行性改变。2周后发现左侧三角肌较明显萎缩，冈上肌较右侧平坦。经肌电图检查左侧三角肌、冈上肌电压明显降低。提示：左侧腋神经、肩胛上神经损伤^[11]。

【分析】

根据现代解剖学，腋神经是臂丛锁骨下部分支，由第5、6颈神经前支组成，它在腋窝发自臂丛后束，穿过四边孔间隙，绕行于肱骨外科颈至三角肌下间隙部，其肌支支配三角肌和小圆肌，皮支（即臂外侧上皮神经）由三角肌后缘穿出，分布于肩部和臂后部的皮肤；肩胛上神经属臂丛锁骨上部分支，由第5、6颈神经前支组成，起自臂丛上干，向后经肩胛骨上缘入冈上窝，转至肩峰下方入冈下窝，支配冈上肌、冈下肌。而颈椎因有其钩椎关节这一特殊的解剖结构，既增加了颈椎的侧向稳定性能，又限制了其侧弯运动，但是可在屈伸运动中引出向前滑与向后滑的“向导”运动。当颈椎侧弯时，对侧钩椎关节角度增大，关节囊张开，椎间孔增大，而同侧钩椎关节角度则缩小，关节囊挤压，椎间孔缩小，此时髓核被挤向侧弯的对侧。由于颈椎4、5、6活动较多，受伤机会亦多，易发生退行性改变，所以在急剧的颈椎侧屈运动时，容易使颈4、5、6神经根或相应同侧的关节囊遭受挤压伤，而对侧的关节囊遭受牵扯伤。本例所介绍的是属于闭合性的挤压伤，出现了同侧腋神经、肩胛上神经损伤症状。

【临床表现】

颈项部施行推拿手法后，患者立即出现单侧肩、臂部阵发性疼痛、麻木，肩关节外展功能受限，肩前、外、后侧的皮肤感觉消失；时间长后，三角肌、冈上肌可出现废用性萎缩。

【处理方法】

对周围神经闭合性损伤，一般均先采用非手术疗法，多数可恢复神经功能。2~3 个月后，如有部分功能恢复，可再继续非手术治疗。

常用的非手术疗法：①充分休息，便于受伤神经功能的恢复；②局部轻手法推拿受损肌群，被动活动各关节，尽量减少肌肉萎缩并预防关节挛缩；③应用维生素类药物。维生素 B₁ 或 B₆ 10 毫克口服，每日 3 次；维生素 B₁₂ 500 微克肌注，每天 1 次；④三磷酸腺苷（ATP）20~40 毫克口服，每日 3 次。

如经 3 个月的非手术治疗后，病情仍无恢复征象，则应行手术探查。

【预防要点】

1. 颈部推拿治疗时，要避免颈部侧屈的被动运动，尤其是猛烈而急剧的侧屈运动。

2. 颈椎侧屈运动的幅度不宜过大，在做侧屈加旋转运动的活动度只有 45°（我们要记住椎体侧弯与旋转的综合运动这一概念，因为钩椎关节的单纯性侧弯运动并不存在，它经常与旋转及伸展运动并存），做颈侧屈被动运动时绝不可超过这一界限。

参 考 文 献

- [1] 张文亮. 危重晕针 3 例报道（内部资料）
- [2] 北京工农兵医院耳鼻喉科. 资料汇编（北京工农兵医院内部资料）
1975；（12）：17
- [3] 张平根，等. 江西中医药 1992；（3）：41
- [4] 广西百色地区医院针麻协作组. 新医学 1972；（12）：9
- [5] 孙申田，等. 针灸学报 1993；（1）：38
- [6] 李尊桂. 贵阳中医学院学报 1993；（4）：38
- [7] 聂绪发，等. 湖北中医杂志 1990；（5）：39
- [8] 沙络. 山西医药杂志 1978；（6）：31
- [9] 陈世谋. 中医杂志 1980；（7）：49
- [10] Schwerz GA al; Arch, Intern Med, 97 : 352, 1956
- [11] 刘岚庆，等. 推拿意外的预防及处理 上海科学技术出版社 1991 年
（第 1 版）

第四章 躯干部腧穴的意外事故

躯干部分布有许多重要且常用的腧穴，临床上使用频率极高。而体腔内存在有人体的重要器官，针灸操作不慎时很易被伤及，如针刺胸、背、肩部及颈前锁骨附近的穴位过深，易刺伤肺脏可引起创伤性气胸，有的还伴有皮下气肿、水胸、血胸或脓胸，以及刺中胸腔的心脏；腹部穴位针刺过深或方向错误，则可损伤腹腔内脏（肝、胆、脾、胃、肾、膀胱等），或引起化脓性腹膜炎等。为了防止此类事故的发生，便于各位同仁吸取教训，现将有关的意外案例介绍如下。

一、针刺天突穴引起气胸

【案例1】

一患者，男性，26岁，于1959年9月8日入院。自诉4天前因突受寒冷，支气管哮喘发作，咳嗽、气喘明显，即在当地某诊所医治。当时医者以粗针在患者胸部进行针刺，共刺3针，一针刺入胸正中上方凹陷中、两针刺入胸部上方两侧（约相当于天突、气户穴部位），进针不久，患者一阵剧烈咳嗽，即感到有气体自颈下针刺部位冒出。立即起针，接着又是数阵剧咳，咳后即有气体冲出。约1小时之后，觉左颈部和左胸部渐渐隆起柔软肿块，逐渐增大，很快向颈部、胸部和全身蔓延，最后以致全身肿胀，尤以面部、颈部和胸部为剧，即来医院诊治。体检：发育良好，神志清楚，急性病容。气管居中，颈围43厘米，呼吸短促，全肺散布干、湿性罗音，头、面、颈、胸、腹、背部和四肢呈广泛性弥

慢性重度肿胀，以面、颈、胸、腹部最剧，触之如“握雪感”。在相当于“天突”及双“气户”穴处，各见一约0.1厘米×0.1厘米大小的结痂点。X线颈、胸部摄片检查：颈部皮下及诸层肌肉间，均见高度积气征；胸部皮下气体甚多，纵隔障可见明显气体，二侧气胸，二侧肺均压缩约10%。临床诊断：全身广泛性皮下气肿、气胸、纵隔障气胸。

治疗经过：急诊手术治疗，在局麻下行颈部和二侧胸部软组织切开减压排气术，并引流。术后患者当即呼吸舒畅，症状明显改善，数小时后颈围由43厘米缩小至37厘米，呼吸已不感困难。术后24小时X线检查，纵隔和两侧胸腔已不见气体，颈胸皮下和肌间气体已明显减少。病情逐日好转，术后12天皮下气肿完全消失，17天痊愈出院^[1]。

【案例2】

王××，女性，50岁。因患支气管炎行天突诸穴针刺治疗。拔针后即感胸闷、气憋、呼吸困难，于1981年8月6日急诊入院。既往健康，无心肺疾病。检查：体温37℃，脉搏90次/分，呼吸30次/分，血压18.7/10.7千帕（140/80毫米汞柱），发育营养一般。端坐呼吸，口唇无发绀，气管居中，甲状腺不大。左胸呼吸动度减弱，语颤降低，左上胸部叩诊呈鼓音，6肋间以下叩诊呈浊音，呼吸音明显减弱。心尖搏动不明显，心音弱，心律整，无杂音。腹平软，肝脾未触及。化验：血红蛋白13克，白细胞9200，中性82%，淋巴18%，血小板25万，出凝血时间各2分。心电图检查正常。胸部X线透视：左上部气胸，肺组织压缩约20%；左6肋间以下密度增高，可见液面。诊断：液气胸。入院后给予抗生素控制感染，胸腔穿刺，抽出气体1000毫升、血性积液800毫升。修正诊断：血气胸。观察1周后症状消失，查体正常。胸部X线透视除见左肋隔角变钝外，余无异常。痊愈出院^[2]。

【案例3】

丁×，男，56岁，酒厂工人。患咳喘病2年余，发病时常有胸闷作胀、呼吸困难、头晕眼花等症状，休息3~5天即能缓解。为根治咳喘病，而求医于×县针灸培训班。医生根据病情，诊断

为咳喘病，配穴处方：天突↓，肺俞↓，百会×，内关↓，期门↓。针刺期门穴留针15分钟，深度在8厘米以上，患者感觉不适，要求停针。施针者又针天突穴，平刺进针，针深在6厘米以上，留针至10多分钟，患者连呼“不行、不行！”方出针，患者呼吸极度困难，不到2分钟，又呈现面色苍白，全身痉挛，角弓反张，口唇、爪甲青紫，口出惨叫，肢冷汗出，大小便失禁，阴囊胀大，不省人事……。旋即给予针刺内关穴、注射强心剂等抢救无效而死亡。

尸检查明死者发育正常，营养一般，体格较瘦弱，颜面、口唇紫绀，两眼睑结膜有帽针头大散在性出血点，瞳孔散大，直径0.6厘米，左右等圆。牙龈组织有散在性针尖状出血点。喉头有大量血性痰液涌塞。颈部甲状软骨下缘近第3环状软骨上有毫针孔1个，周围轻度红肿，大小为 3×2.8 （厘米）。胸部左右乳头内侧3厘米处，各有毫针孔1个，左侧孔口并结有小血痂，左前臂尺侧有毫针孔1个，孔口有血痂，右前臂尺侧有毫针孔1个，两手绀紫^[4]。

【案例4】

王×，女性，65岁。咳喘多年，近日明显加重，于1989年11月17日就诊，给予针刺治疗。由于针刺天突穴的方向和深度有误，病情没能好转反而见重，呼吸困难、胸闷不安。第2天住院治疗，确诊为慢性支气管炎、肺气肿、肺心病并发急性呼吸道感染和气胸。经1个月的抗炎、给氧等治疗，病情缓解出院^[1]。

【分析】

气胸，在物理性损伤中的发病率占首位。针灸临床上因针刺损伤引起气胸的意外情况屡见不鲜，而造成气胸的多是缺乏针灸学和解剖学知识的术者。天突穴位于胸骨上窝凹陷正中，是在颈静脉切迹正中上方约0.5寸凹陷处进针的。该穴的左右为胸锁乳突肌，深层为胸骨甲状肌，皮下稍深有颈静脉弓，再深为甲状腺下静脉，深部为气管；向下在胸骨柄后方有左无名静脉，主动脉弓、无名动脉和左颈总动脉，两侧有胸膜前界和肺的前缘，当操作时直刺过深，则针尖易刺中气管软骨，穿透气管壁而伤及气管

粘膜，但退针且休息片刻后，一般均可恢复而不致引起严重后果。如果针尖朝胸骨柄后面刺入过深或向两侧偏离，则会刺中胸膜和肺的前界，空气进入胸膜腔形成气胸；当同时刺破胸壁血管、肺血管或主动脉弓等大动脉，则使血液与空气一并进入胸膜腔形成血气胸。上述几个案例，正是由于针刺方向错误或刺入过深，而导致意外的发生。

【临床表现】

针刺所致的气胸，其症状出现的时间不一，大多数在针刺过程中或针后即刻出现，亦有在针后的半小时至数小时内发作，甚至还有报道在针后 24 小时始产生典型的气胸症状。而气胸症状的轻重，往往取决于气胸发生的快慢、空气进入量的多少及气胸的类型（一般分为闭合性及张力性两类），有无并发症，及两肺原来的功能状况及全身状况等。根据症状和体征，本病可分为轻、中、重 3 型。

轻度气胸：一般无明显的自觉症状，或有胸闷、咳嗽，活动时胸部有牵拉样痛。

中度气胸：胸肋刺痛，胸闷不舒，呼吸困难，持续剧烈的咳嗽，心悸不宁，尚有相应的肩背部、上肢沉痛及活动受限等。

重度气胸：病者突然感到被针侧胸背部剧烈刺痛，并可向同侧的肩部、手臂放射或向上腹部放射，接着出现气促、呼吸困难，并随着气体的进入而胸内压上升逐渐加重，还有紫绀、烦躁、出汗、肢冷、昏迷等。体检见呼吸频率加快，心率加快，可有鼻翼煽动；气管偏向健侧，患侧肋间隙饱满，呼吸活动度及语颤减少；叩诊呈过清音或浊鼓音；呼吸音减弱或消失，健侧呼吸音增强。X 线检查，气胸部分透亮度增加，无肺纹，肺向肺门收缩，成透明团块，其边缘可见发线状阴影的脏层胸膜，肺萎缩程度可从 10%~90% 不等。

若伴有胸腔内出血，更有呼吸表浅，随着病情的发展伴有出血性休克现象，如面色苍白，心慌气急，口渴，脉搏细数，血压下降等。体检时在患侧积液处叩诊呈实音，X 线检查可见液平面。

【处理方法】

临床上根据胸腔积气及肺脏被压缩的情况而有所不同。

轻度气胸：肺萎缩在 10%~20% 之内，而肺部无肺气肿等病变者，其气急症状一般不严重，荧光透视积气较少。可在严密观察下，令病人休息数天，不作特殊治疗，或据症酌予镇咳、止痛剂。为防止胸膜腔内发生感染，可考虑予以适量的抗生素。假如病情不再发展，少量的气体多可自行吸收而痊愈。

中、重度气胸：肺萎缩在 20% 以上，或伴有肺气肿等病症者，应马上令病人卧床休息，保持安静，并用人工气胸器测压抽气。其方法是，在患侧的锁骨中线第 2 肋间，或腋前线第 4~5 肋间，常规消毒后穿刺排气，每次不必全部排尽，抽气量的多少以胸腔内压力降至“0”上下为准，必要时可重复抽气。如果无人工气胸器，为了抢救病人的生命，可在上述部位用 50 毫升消毒空注射器抽气，以缓解气急症状；或用较粗的注射针头，消毒后从上述部位插入胸腔，让气体从针尾部排出。经过以上处理，但气胸症状仍不减轻者，应请有关科室会诊处理，必要时应予手术治疗。

血气胸的治疗，则在排气的同时，应积极止血，如出现休克症状，可配合输血、抗休克等治疗。止血的方法是，轻者可先采用温灸涌泉穴或七星针叩击颈动脉区，或用脑垂体后叶素 5~10 个单位加入 25% 葡萄糖 20~40 毫升内，缓慢静脉注射（但孕妇、心脏病、高血压等患者不宜使用）；如果出血不止者，可手术寻找和结扎破裂的血管。血止后，可多次抽液，并在胸膜腔内注入青霉素和链霉素，以防感染及胸膜肥厚粘连，影响以后肺的功能。

气胸或血气胸，如发现及时，迅速治疗，一般均能治愈。临床一旦发现针刺导致气胸，则应立即在当地就医，不要长途转送，因为旅途颠簸，可使轻者变为严重，且可延误抢救时机，使病情进一步恶化，甚至导致生命危险。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：较薄，由两侧的颈横神经分布，其纤维来自第 2、3 颈神经前支。

2. 皮下组织：为疏松结缔组织，含脂肪量因人而异，分布有上述皮神经，血液供应来自甲状腺下动脉。

3. 颈白线或胸骨甲状肌：皮下组织后面即为颈白线，此白线较为致密，是由两侧的覆盖舌骨下肌群的深筋膜在中线交织融合而成。

4. 气管前间隙：指位于舌骨下肌群与气管颈段间的间隙，由疏松结缔组织填充。

5. 胸腺：是一个兼有内分泌功能的淋巴器官，位于气管前方及两侧。在成人已多转变为脂肪组织，血液供应贫乏。腺体的神经支配有来自迷走神经及交感干的分支，其被膜的感觉神经纤维来自膈神经。

6. 毗邻结构：有气管，主动脉弓、头臂干及左颈总动脉，胸膜前界与肺的前缘等。

【操作要点】

天突穴是在颈静脉切迹正中上方 0.5 寸凹陷处进针。临床上有两种刺法：一是胸骨柄后刺法，即先直刺 0.2~0.3 寸进入皮下，然后朝下沿胸骨柄后方正中深刺，针尖刺到无名静脉及主动脉弓前方，正当两侧胸膜前界及两肺之间，此法相对来说安全系数较低，若针刺过深则易损伤大血管，若向左右偏刺则易损伤胸膜和肺；二是气管前刺法，即捏起皮肤进针 0.1~0.2 寸，通过皮下组织、舌骨下肌、气管前筋膜，然后针尖朝下，沿气管前壁前方，向下缓慢直刺 1.5 寸，此时针尖已到无名静脉、主动脉弓后方与气管之间的狭窄空隙内，如继续深刺达 2 寸时，病人胸部可出现热、胀等反应，此时应立即停针不再深入。

在天突穴的针刺操作过程中，术者一定要细心体会手下的针感，以及病人的不同反应，及时调整针刺的方向或深度。如果直刺过深时，针尖易穿透气管壁而伤及气管粘膜，此时可出现硬而有轻度弹性的针感，同时病人有气管作痒而欲咳嗽的现象，针体亦随咳嗽动作剧烈颤动，故应立即退针 2~3 分，嘱病人休息片刻，然后再向前方斜刺。如果偏后深刺（一般深度均超过 1.5 寸），则易刺中无名静脉或主动脉弓等大血管，此时可出现柔软而有弹力的针感，针感搏动十分明显，同时病人会自觉胸闷、疼痛等，故应马上退针而不宜再深刺，这样一般不致刺透引起出血，但要密

切观察其变化。如果针尖向两侧偏刺或朝胸骨柄后面刺入过深,则易刺中肺前界导致气胸,病人有逐渐加重的呼吸困难,此时应立即出针,对症治疗,按疑有气胸处理。

二、针刺中府穴导致气胸

【案例 1】

王子玉报道的 5 例气胸中,有 1 例是在胸骨左右锁骨下窝偏外(约相当于中府穴)施行针刺的,用毫针刺入 5~8 分,留针 20~30 分钟。起病很急骤,出现明显的呼吸困难与干咳,有气胸体征。经治疗后痊愈出院^[5]。

【案例 2】

贾如宝报道的 6 例气胸中,有 2 例是由于在双侧锁骨下窝偏外的中府穴处施术不当所致。患者均有程度不同的呼吸困难、紫绀、干咳、冷汗等症状,神志短时模糊,患侧听、叩物理检查可有气胸征,X 线示左右肺脏分别压缩 50%、20%。意外发生后即嘱病者立即卧床休息,并吸氧、肌注青链霉素 3~5 天;予闭式插管负压吸引或针管吸引抽气;还给予镇咳、止血、止痛等对症处理。2 例均痊愈出院^[6]。

【案例 3】

胡全轩报道的 7 例创伤性气胸中,有 1 例是在左前胸部(约相当于中府穴处)施术不慎所致的。患者于针刺后不久即感胸痛、胸闷不适,气短及不同程度的呼吸困难;体检见呼吸急促,心率增快,气管向健侧移位,触诊患侧语颤减弱或消失,叩诊患侧呈鼓音,听诊患侧肺部呼吸音减弱或消失,心尖区心音遥远;X 线检查证实肺萎陷和气胸的存在。入院后,经对症处理痊愈出院^[7]。

【分析】

胸腔正常情况下是一个密闭的、呈负压状态的体腔,而针刺引起的创伤性气胸,主要是由于胸部腧穴针刺过深,刺破胸膜脏层,使气体从肺脏流入胸腔所致;随着气胸的发生,胸腔负压降低,则必导致肺萎缩。针刺引起的气胸,临床上大多数为闭合性气胸,少数严重者可为张力性气胸。而中府穴正位于胸前壁的外

上方，距前正中线旁开6寸，平第1肋间隙处，如果该穴直刺过深，则针尖可随病人的呼吸运动而划破胸膜、肺、肺泡，空气则从肺的裂口进入胸膜腔，造成肺萎陷，发生气胸。

【临床表现】

针刺引起的气胸，其发病的缓急和临床症状的轻重，均取决于肺组织损伤的程度、肺萎陷的程度、病人的敏感度及其原来的肺功能状况，一般临床上将它分为轻、中、重3型。

轻度气胸：无明显的自觉症状，或有轻微的胸闷、咳嗽，活动时胸部有牵拉样痛。

中度气胸：胸肋刺痛，胸闷不舒，呼吸困难，持续剧烈的咳嗽，心悸不宁，尚有相应的肩背部、上肢沉痛及活动受限等。

重度气胸：病人突然感到被针侧胸背部剧烈刺痛，并可向同侧的肩部、手臂放射或向上腹部放射，接着出现气促、呼吸困难，并随着气体的进入而胸内压上升逐渐加重，还有紫绀、烦躁、出汗、肢冷、昏迷等。体检见呼吸频率加快，心率加快，可有鼻翼煽动；气管偏向健侧，患侧肋间隙饱满，呼吸活动度及语颤减少；叩诊呈过清音或浊鼓音；呼吸音减弱或消失，健侧呼吸音增强。X线检查，气胸部分透亮度增加，无肺纹，肺向肺门收缩，成透明团块，其边缘可见发线状阴影的脏层胸膜，肺萎缩程度可从10%~90%不等。

【处理方法】

气胸发生后，要及时给予治疗，切不可抱任何观望或侥幸的态度，以免贻误病情。临床上根据胸腔积气的情况和肺脏被压缩的程度，而采取不同的治疗方法。

轻度气胸：肺萎缩在10%~20%之内，而肺部无肺气肿等病变者，其荧光透气积气较少。可在严密观察下，令病人体息数天，不做特殊治疗，或据症酌给予镇咳、止痛剂。为防止胸膜腔内发生感染，可考虑予以适量的抗生素。假如病情不再发展，少量气体多可自行吸收痊愈。

中、重度气胸：肺萎缩在20%以上，或伴有肺气肿等病症者。应马上令病人卧床休息，保持安静，并用人工气胸器测压抽气。其

方法是，在患侧的锁骨中线第2肋间，或腋前线第4~5肋间，常规消毒后穿刺排气，每次不必全部排尽，抽气量的多少以胸腔内压力降至“0”上下为准，必要时可重复抽气。如果无人工气胸器，为了抢救病人的生命，可在上述部位用50毫升消毒空注射器抽气，以缓解气急症状；或用较粗的注射针头，消毒后从上述部位插入胸腔，让气体从针尾部排出。经过以上处理，但气胸症状仍不减轻者，应请有关科室会诊处理，必要时应予手术治疗。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤和皮下组织：有锁骨上中间神经分布，它由第4颈神经前支纤维组成。

2. 三角肌前缘：三角肌位于肩部皮下，呈底向上、尖向下的三角形，其后缘游离，前缘借三角胸肌间沟与胸大肌的锁骨部相隔（进针时针尖在三角肌前缘上部通过）。该肌由腋神经支配，其神经纤维是第5、6颈神经前支。

3. 胸大肌：位于胸廓的前上部皮下，为一扇形的扁肌，由胸前内、外侧神经支配，其纤维来自第5至第8颈神经和第1胸神经。

4. 胸小肌：位于胸大肌的深面，受胸前内侧神经支配，其纤维由第5至第8颈神经和第1胸神经组成。

5. 喙肱肌和肱二头肌短头：喙肱肌是一长梭形肌，贴于肱二头肌短头上半的内侧。而肱二头肌短头位于喙肱肌的外侧，与喙肱肌共同起于肩胛骨的喙突。此二肌均受肌皮神经支配，至喙肱肌的是第5至第7颈神经纤维，至肱二头肌短头的是第5、6颈神经纤维。

【操作要点】

施行针刺操作前，嘱病人取仰卧位或正坐位，以前者位置最佳（在立位或其他不能持久的体位进针，因体位难以固定，刺入组织内的针体在肌肉的牵拉收缩下也随之活动，易损伤及肺而致气胸）。进针后针尖可向肋缘斜刺至骨，约0.5~1寸，微微退出后施行手法，使其酸胀感向前胸及上肢扩散；如果必须直刺，则应缓慢送针，只可进3~5分（根据解剖学的观察和测量，乳头以

上的胸壁组织厚度是,成人为1.2~1.5厘米,儿童为0.7~1.0厘米,故直刺深度宜比上述解剖厚度稍减),体质强壮者也不得超过5分深,有针感后即出针。若针感不显时也不可再深刺,可稍留针候气,3~5分钟后用小幅度捻转手法来激发针感。出针后要稍按压针孔片刻,如有条件,则应让病人在诊室内休息15~30分钟再走。

三、针刺胸部穴位致气胸

【案例1】

李×,男,27岁,住院号8360。因患风湿性关节炎,在针灸科继续治疗数月余。1958年1月20日第17次针刺,取穴大包、京门。针左侧大包穴时,深至5分,突感胸痛、气促、恶心,不能平卧,即作X线胸部透视未发现异常。1月29日,胸痛增剧,来院门诊,经X线胸部照片,发现左侧液气胸,左肺压缩约10%,收住院治疗。住院期间,曾行胸腔穿刺,抽出少量脓液,因其自觉微寒、发热,予抗生素治疗。2月15日X线胸部透视,液气胸吸收,体温正常,出院^[8]。

【案例2】

方×,女,40岁,本院护士长。左乳腺癌根治术后疤痕疼痛,于1959年2月18日第4次针刺,取穴有气户、天溪、臑中、神藏等。患者取仰卧位,进针后有酸困感觉,留针半小时,顺序起针。起神藏穴针时,她觉胸痛难忍,呼吸困促,不能起身。经X线胸部透视并照片,证实左侧气胸,左肺压缩30%。休息3周后,气胸吸收治愈^[8]。

【案例3】

一患者,女,47岁,住院号10958。患者因感上腹部不适,于1960年3月3日赴某诊所接受针刺治疗。术者在左胸部取穴施治,针后病人当夜即感气喘,呼吸困难,身出大汗,于第2天入院治疗。检查:其左胸上部皮下有气肿,左胸壁(胸骨旁、锁骨下与乳房)有多处针刺痕迹,左胸语颤及呼吸音均减低。X线透视

胸部左侧气胸，肺被压缩30%，经对症治疗20余日，痊愈出院^[9]。

【案例4】

-20岁男性患者，4天前因哮喘而接受针刺治疗。术者用粗针刺入胸部的气户诸穴，进针不久，一阵剧咳，病者即感到有气体自颈下针刺部位冒出，立即起针，接着又是数阵剧咳，咳后即有气体冲出。约1小时后，自觉左颈部和左胸部渐渐隆起柔软肿块，逐渐增大，且很快向颈部、胸部和全身蔓延，最后以致全身肿胀，尤以面部、胸部为甚。体检：发育良好，急性病容，气管居中，颈围43厘米，呼吸短促，全肺布满干、湿性罗音，头、面、颈、胸、腹、背部和四肢均呈广泛性、弥漫性重度肿胀，而以面、颈、胸、腹部最著，触之有“握雪感”，双侧气户穴处各有 0.1×0.1 （厘米）大小之结痂点。X线片示：颈部皮下及诸层肌肉间，均见高度积气征，胸部皮下气体甚多，纵隔障可见明显气体，二侧气胸，二侧肺均压缩约10%。即行颈部和二侧胸部软组织切开减压排气术。其方法是在颈部下方正中作一个8厘米长之切口，切开皮肤、皮下组织和深筋膜，分离疏松含气的结缔组织，沿二侧胸锁乳突肌分离，放出气体后，又置橡皮管引流；左侧胸部气肿严重处各作一长5厘米之切口，切开软组织，放出气体，又各置橡皮管2根引流。手术后病人呼吸改善，数小时后颈围由43厘米缩小到37厘米。术后24小时X线检查，纵隔和胸腔已不见气体，颈胸皮下气体已减少。术后12天气肿消失，17天痊愈出院^[11]。

【案例5】

田×，男性，43岁。因畏寒发热、全身不适4天，于1965年4月17日下午行针灸治疗。穴位取合谷、幽门、神封。患者于当夜出现咳嗽，伴有右胸内刺痛，且逐渐加重，至半夜气促气喘，难于平卧，第2天求诊而收入院。住院检查：X线片示右肺呈一片光区，右肺向内压缩约50%，左肺野清晰，心脏正常。诊断为右侧气胸。当即于右侧胸腔穿刺，抽出气体600毫升（无液体），呼吸喘急现象顿时减轻，后给予氨茶碱等对症处理。第2天复诊胸部透视，右肺压缩仅有10%~20%。10天后胸部摄片检查，心、肺完全正常，无任何痕迹或病灶^[16]。

【案例 6】

魏××，男性，43岁，农民。患者因患慢性咳嗽、伴气短，于1964年12月15日下午，找一民间医生扎针治疗。经该医生诊断为肺胀咳嗽，并用缝衣针刺胸部秘穴6处（针刺部位相当于锁骨下、两侧肋弓下沿乳腺处、中腕穴旁1指等），深度达3.5厘米以上。入针后患者即觉胸闷、气短、呼吸困难，起针后呼吸迫促，不能走路和平卧，随即抬送来院急救。此时症见颜面苍白，冷汗淋漓，四肢厥冷，端坐呼吸，口唇发绀，烦躁，言语不清；检查血压与脉搏均不清楚，胸呈桶状，双肺呼吸音减弱，并有干湿性罗音，叩诊呈明显鼓音，心律减弱而整齐，每分钟189次，无杂音，肺动脉音亢进，其他无异常。由于病情危剧，不及抢救，突然窒息死亡。死后经追问扎针经过，尸体勘察和穿刺试验，其胸腔内有大量气体存在，诊断为针刺引起张力性气胸而死亡^[11]。

【案例 7】

据报道，在其所遇的针刺所致6例气胸中，有1例是针刺期门穴引起的。其经过情况是：术者用不锈钢毫针，捻转直刺入穴位约6~8分，退针后急骤发病，表现为呼吸困难、紫绀、干咳、冷汗、烦躁等，听诊双肺呼吸音减弱，叩诊呈明显鼓音，X线胸透见肺脏压缩30%。即让病者立即卧床休息、吸氧，并肌注青、链霉素3~5天，镇咳、止血、止痛等对症处理，行闭式插管负压吸引。经治疗后症状和体征完全消失，胸透肺脏复张正常^[6]。

【案例 8】

谭××，女性，54岁，住院号761号。因患胃下垂而接受针刺治疗，取穴鸠尾（稍偏左），进针约1.5寸。患者当即感下胸部刺痛，随后左胸痛胀；胸部有紧迫感，症状逐渐加重，进而呼吸困难，嘴唇发绀，神智恍惚，小便失禁，历时约半小时。检查：气管右移，左肺呼吸动度降低，叩诊鼓音，左肺呼吸音消失。胸部X线透视，左肺压缩约40%~50%。诊断为左胸张力性气胸。即收入院，卧床休息，持续吸氧，行胸腔闭式引流，病情缓解^[12]。

【案例 9】

据报道，在其所遇的针刺所致7例创伤性气胸中，有1例是

针刺左前胸第3肋间引起,1例是在胸部多处进针、具体致伤部位不明的。患者多于针刺实施之当时或不久以后即感胸痛、胸闷不适,有轻重程度不等的气急;体检时一般均可发现呼吸速率加快及心率增加,其气管及心尖搏动均移向健侧,患侧语颤减弱或消失,叩诊呈过清音或浊鼓音;X线检查可证实肺萎陷和气胸。其中气胸不甚严重,肺压缩在30%左右或更少,一般情况尚可者,仅予观察而未作特殊处理,以后经X线复查证实气体已吸收,肺完全复张;而气胸较严重,肺压缩在30%以上,自觉症状较明显者,经患侧锁骨中线第2或第3肋间予以胸穿抽气治疗(尽量抽尽积气,必要时可反复多次进行),并可投用适当的抗生素控制或预防感染^[13]。

【案例10】

据报道,在其所遇的针刺致18例气胸中,有3例是针刺前胸部穴位引起的。患者有的于施针过程中即发生心悸、汗出、憋气、紫绀、血压下降等,有的于拔针后即觉胸痛、憋气、呼吸困难等;一般体检均可发现呼吸急促,听诊呼吸音消失或低下,叩诊患侧呈鼓音或过清音;X线检查可见不同程度的肺萎缩。在治疗方面,肺压缩小于30%者未作特殊处理,数天后积气自行消失;肺压缩大于30%者,行胸腔闭式引流,严重者可先行急诊胸穿抽气,再行闭式引流。经治均获痊愈^[14]。

【分析】

在针灸临床上,因针刺损伤肺脏引起气胸等意外情况屡见不鲜,这主要是由于术者未能掌握局部解剖基础知识以及胸部穴位投影与脏器的关系,操作时针刺过深或方向错误,或者施术时病人体位不当,当进针深达脏层胸膜及肺脏后,毫针作为异物反复刺伤胸膜和肺脏,致使空气经裂口进入胸膜腔而产生气胸。根据现代解剖学,肺脏位于胸腔内,外形为半圆锥体状,上端为肺尖,向上突出于第1肋,下面为肺底,接触膈肌之穹窿面,外侧面紧贴于胸壁,内侧面与纵隔相贴;肺脏在体表的投影,其上界前面在锁骨上2~3厘米,下界可随呼吸运动而改变,正常人吸气时于锁骨中线的第6肋间,腋中线的第8肋间。而肺脏的表面由胸膜

所覆盖，胸膜分为脏层和壁层，两层之间形成一密闭负压的腔隙即胸膜腔，当针刺过深时，针尖易穿透胸膜伤及肺脏，从而导致气胸的发生，所以术者一定要细心谨慎从事。临床上，由于肺脏体积很大，许多穴位，如任脉的天突、膻中、鸠尾，肾经的步廊、神封、灵墟、神藏、或中、俞府，胃经的缺盆、气户、库房、屋翳、膺窗、乳中、乳根，脾经的食窦、天溪、胸乡、周荣、大包，肝经的期门，胆经的渊腋、辄筋、日月，心包经的天池，心经的极泉等等，它们皆位于肺脏的投影区内，故针刺时应注意安全。

【临床表现】

针刺引起的气胸，其发病的缓急和临床症状的轻重，均取决于肺组织损伤的程度、肺萎陷的程度、病人的敏感度及其原来的肺功能状况，一般临床上将它分为轻、中、重3型。

轻度气胸：无明显的自觉症状，或有轻微的胸闷、咳嗽，活动时胸部有牵拉样痛。

中度气胸：胸肋刺痛，胸闷不舒，呼吸困难，持续剧烈的咳嗽，心悸不宁，尚有相应的肩背部、上肢沉痛以及活动受限等。

重度气胸：病者突然感到被针侧胸背部剧烈刺痛，并可向同侧的肩部、手臂放射或向上腹部放射，接着出现气促、呼吸困难，并随着气体的进入而胸内压上升逐渐加重，还有紫绀、烦躁、出汗、肢冷、昏迷等。体检见呼吸频率加快，心率加快，可有鼻翼煽动；气管偏向健侧，患侧肋间隙饱满，呼吸活动度及语颤减少；叩诊呈过清音或浊鼓音；呼吸音减弱或消失，健侧呼吸音增强，X线检查，气胸部分透亮度增加，无肺纹，肺向肺门收缩，成透明团块，其边缘可见发线状阴影的脏层胸膜，肺萎缩程度可从10%~90%不等。

【处理方法】

轻度气胸：肺萎缩在10%~20%之内，而肺部无肺气肿等病变者，可在严密观察下，令病人体息数天，不做特殊治疗，或据症酌给予镇咳、止痛剂。为防止胸膜腔内发生感染，可考虑予以适量的抗生素。假如病情不再发展，少量气体多可自行吸收痊愈。

中、重度气胸：肺萎缩在20%以上，或伴有肺气肿等病症者。

应马上令病人卧床休息，保持安静，并用人工气胸器测压抽气。或用较粗的注射针头，消毒后从上述部位插入胸腔，让气体从针尾部排出。经过以上处理，但气胸症状仍不减轻者，应请有关科室会诊处理，必要时应予手术治疗。

四、针刺缺盆穴导致气胸

【案例 1】

据报道，在其所遇的针刺所致 5 例气胸中，有 2 例是针刺锁骨上窝（即缺盆穴处）引起的。患者起病均急骤，出现明显的呼吸困难与干咳，有窒息状态和气胸体征，X 线胸片均示肺萎陷各 40%、90%。治疗方法采用胸腔穿刺排气测压。经治后痊愈^[5]。

【案例 2】

据报道：其所遇的针刺所致 6 例气胸中，有 1 例是因针刺左锁骨上窝相当缺盆穴引起的，其经过情况是，术者用不锈钢毫针，捻转直刺入穴位约 6~8 分，退针后急骤发病，表现为呼吸困难、紫绀、干咳、冷汗、烦躁等。听诊双肺呼吸音减弱，叩诊呈明显鼓音，X 线胸透见肺脏压缩 30%。即让病者立即卧床休息、吸氧，并肌注青、链霉素 3~5 天，予镇咳、止血、止痛等对症处理，行闭式插管负压吸引。经治病者症状和体征完全消失，胸部 X 光透视示肺脏复张正常^[6]。

【案例 3】

胡大仁报道，在其所遇的针刺所致 7 例创伤性气胸中，有 5 例是针刺锁骨上窝（左侧 1 例，右侧 4 例）引起的。患者多于针刺实施之当时或不久以后即感胸痛、胸闷不适，有轻重程度不等的气急；体检时一般均可发现其呼吸速率加快及心率增加，气管及心尖搏动均移向健侧，患侧语颤减弱或消失，叩诊呈过清音或浊鼓音；X 线检查可证实肺萎缩和气胸。其中若气胸不甚严重，肺压缩在 30% 左右或更少，一般情况尚可者，仅予观察而未作特殊处理，以后经 X 线复查证实气体已吸收，肺完全复张；而气胸较严重，肺压缩在 30% 以上，自觉症状较明显者，经患侧锁骨中线第

2 或第 3 肋间予以胸穿抽气治疗(尽量抽尽积气,必要时可反复多次进行),并可投用适当的抗生素以控制或预防感染^[13]。

【案例 4】

据报道,在其所遇的针刺致 7 例创伤性气胸中,有 3 例是针刺锁骨上凹(相当于缺盆处)引起的。患者多在针刺实施之当时或不久之后,即感胸痛、胸闷不适,气短及不同程度的呼吸困难。体检时一般可见呼吸急促,呼吸次数增多及心率增快;气管向健侧移位;触诊患侧语颤减弱或消失,叩诊患侧呈鼓音,听诊肺部呼吸音减弱或消失。X 线检查,可证实肺萎陷和气胸的存在,以及严重程度。在治疗上,若肺压缩 30% 而一般情况尚可者,可严密观察,休息后可获缓解好转;若肺压缩 30%~50% 而自觉症状较明显、临床体征较显著者,可于患侧锁骨中线或第 3 前肋间行胸腔穿刺抽气;若肺压缩 50% 以上且有中、重度呼吸困难者,应立即于患侧第 2 前肋间施胸腔闭式引流术,排气减压^[7]。

【分析】

根据现代解剖学知识,肺脏位于胸腔内,在纵隔的两侧分为左、右两叶,其外形为半圆锥体状,上端为肺尖,向上突出于第 1 肋,其上界前面在体表的投影是在锁骨上 2~3 厘米。而覆盖于肺脏表面的胸膜之壁层,则突出于胸廓上口形成胸膜顶,其内容纳有肺尖。至于胸膜顶突出的程度和形状,主要与胸廓的形状有关,若胸廓为狭长形,则胸膜顶呈高圆锥体,其上端可高出锁骨内侧半上 2~3 厘米;若胸廓为宽短形,则胸膜似半球形,其顶部稍高于胸骨内侧半。由于缺盆穴正位于锁骨上窝中央之凹陷处,如果针刺方向不当或刺入过深,将会如上述的诸多案例,针尖易穿透胸膜,刺入胸腔,损伤肺脏,造成气胸。

【临床表现】

针刺引起的气胸,其发病的缓急和临床症状的轻重,均取决于肺组织损伤的程度、肺萎陷的程度、病人的敏感度及其原来的肺功能状况,一般临床上将它分为轻、中、重 3 型。其表现已如前述。

【处理方法】

气胸发生后，要及时给予治疗，切不可抱任何观望或侥幸的态度，以免贻误病情。临床上根据胸腔积气的情况和肺脏被压缩的程度，而采取不同的治疗方法。

轻度气胸：肺萎缩在 10%~20% 之内，而肺部无肺气肿等病变者，其荧光透气积气较少。可在严密观察下，令病人休息数天，不做特殊治疗，或据症酌给予镇咳、止痛剂。为防止胸膜腔内发生感染，可考虑予以适量的抗生素。假如病情不再发展，少量气体多可自行吸收痊愈。

中、重度气胸：肺萎缩在 20% 以上，或伴有肺气肿等病症者。应马上令病人卧床休息，保持安静，并用人工气胸器测压抽气。如果无人工气胸器，可在上述部位用 50 毫升消毒空注射器抽气，以缓解气急；或用较粗的注射针头，消毒后从上述部位插入胸腔，让气体从针尾部排出。经过以上处理，但气胸症状仍不减轻者，应请有关科室会诊处理，必要时应予手术治疗。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：由锁骨上神经分布，其来自第 3、4 颈神经。
2. 皮下组织：内有上述神经和颈阔肌等结构。颈阔肌为一皮肤，由面神经颈支支配。
3. 斜方肌：位于锁骨上后方，该肌为背部浅层肌之一，由副神经的脊髓根和第 3、4 颈神经前支支配。
4. 锁骨下肌：锁骨下肌由臂丛锁骨上部的分支——锁骨下肌神经支配，到该肌的神经纤维来自第 5、6 颈神经。
5. 肩胛上动、静脉：肩胛上动脉由甲状颈干分出，斜过臂丛的前方，进入冈上窝，后绕肩胛颈至冈下窝，沿途分支营养冈上、下肌和肩胛骨等。肩胛上静脉与肩胛上动脉伴行，最后汇入锁骨下静脉。

【操作要点】

施行操作前，嘱病者取正坐位或仰卧位，若在其他不能持久的体位进行针刺，因体位难于固定，刺入组织内的针体在肌肉的牵拉收缩下会随之活动，易损伤肺尖而致气胸。进针时应直刺，深度以 0.3~0.4 寸左右为宜，不应盲目向下深刺，否则针可穿过前

锯肌、肋间肌、壁胸膜、胸膜腔、脏胸膜，从而刺伤肺脏，引起气胸。一般临床上本穴操作手法完成后即可出针，很少留针。本穴可用灸法。

五、针刺不当损伤心脏致死

【案例 1】

一 9 岁男孩，患咳嗽、气促、吐痰、疲乏等症状，某医院诊断为肺结核、心脏病。另院某医师按患儿家属要求，给予针灸治疗，隔日 1 次。在第 6 次扎针时，术者持金针由上腹部隔衣刺入，当时患儿大声叫痛，哭诉不能忍受，并见显露于衣外的针柄一上一下地摆动。不久将针退出，即见患儿呼吸困难，口唇发绀，两手握拳弯曲，表现出极度痛苦。立即行人工呼吸，终因抢救无效，迅即死亡。

尸检发现其剑突下 2 厘米及 3.5 厘米偏左处各有针眼 1 个。胸腔内部见心脏体积显著增大，心包膜极为紧张饱满，整个心脏占满了大部分胸腔，除右侧胸腔内肺脏稍显露外，其他肺脏被挤压萎缩得几不可见；心脏的体积右界在右侧肋软骨外缘，左侧充满于左侧胸腔内；心包膜呈淡青绿色，并有明显针眼 1 个。近胸骨剑突下横膈膜而有针孔 1 个，周围有充血现象，膈膜上之肌肉间，亦有明显可见之针孔，并有较大面积之溢血斑块。切开心包膜，其内充满血液及血凝块共有 430 毫升。除去积血及血块，见右心室前壁有一不规则的破裂孔，大约为 0.6×0.4 （厘米），孔的周围有 3×1.5 （厘米）大小充血发红处，此孔距心尖约 0.5 厘米^[15]。

【案例 2】

某 28 岁男性患者，因左胸针刺伤（按：原文未注明具体穴名），伤后 2 小时感到胸闷、心慌、全身不适，当时未作任何处理。伤后 10 小时，患者出冷汗、口渴、四肢厥冷，血压为 9.3/5.3 千帕（70/40 毫米汞柱），脉搏每分钟 136 次，心音遥远、单调。急诊入院时心跳已经停止。开胸后，见心包极度膨胀，内有积血约

700 毫升，左心室前壁有 3 处喷血小洞，经抢救无效而死亡^[16]。

【案例 3】

女性 19 岁患者，农民。因患精神分裂症，于 1970 年 3 月 21 日入院。每日针刺 1 次。3 月 28 日下午 3 时，针刺鸠尾穴时，取 2 寸针在剑突下半寸垂直进针后，再向胸骨正中线平刺 1 寸，用 G6802 型治疗仪通电，连接曲池和鸠尾针柄，见鸠尾针跳动明显。数分钟后病人忽尖叫一声，头后仰，眼上翻，呕吐。迅即拔针，见患者口唇已紫绀，呼吸心跳均已停止。经开胸按摩心脏，心跳呼吸先后恢复，但仍持续昏迷。终因肺部严重感染于 4 月 17 日死亡^[17]。

【分析】

心脏为心血管系统的中枢，也是循环系统的中心动力器官，临床上如因针刺误伤心脏（这种意外在我国的发生率尚较低），则会导致严重的后果，甚至危及生命。根据现代解剖学知识，心脏是呈前后略扁的圆锥形空腔器官，位于胸腔的偏左方，正常人心脏在体表的投影，一般可按下列 4 点的连线加以确定：左上点在左侧第 2 肋软骨下缘，距胸骨左缘约 1.2 厘米处；左下点为心尖点，在左侧第 5 肋间隙、锁骨中线内侧 1~2 厘米处；右上点在右侧第 3 肋软骨上缘，距胸骨右缘约 1 厘米处；右下点在右侧第 6 胸肋关节处。这 4 点的连线，是心脏在胸腔的大致范围，在此体表投影区域内，除前面有胸骨和肋软骨保护，后有脊柱、食道等，不易受针刺直接损伤外，其余部位的穴位（如左侧胃经的乳根、乳中，肾经的神藏、灵墟、神封、步廊、幽门，脾经的食窦、天溪，心包经的天池，任脉的鸠尾等穴），如刺之不当，均有可能伤及心脏。案例 1 所刺部位为上腹部穴，虽不在心脏投影区内，但因向上隔衣朝胸腔刺入，进针太深，误中心脏，造成机械性的心脏破裂伤，血液大量迅速地流入心包腔内，使心包内压力骤然增高，阻止心脏的正常舒张，心脏终因缺血而停止搏动，循环功能急剧障碍，病人随即死亡。案例 2 则是因在左胸部针刺不慎，进针太深，导致心脏的损伤，由于心脏的不断收缩和舒张，使心壁上的创口逐渐扩大，从而引起病人血液循环障碍。案例 3 则是术者针刺鸠尾穴

时，由于针刺角度和深度掌握不当，导致心脏被针刺所伤而死亡。

【临床表现】

针刺损伤心脏，主要是刺伤心脏上的重要血管和直接刺破心壁两个方面。它既可因大出血而易造出血性休克、心肌缺血、心包填塞和心力衰竭，也可因刺伤心内结构而引起心律失常、心输出量降低、肺水肿等心功能障碍，故本病的后果极为严重。

一般而言，患者多于针刺损伤后即刻或不久，出现胸前区剧烈疼痛，面色苍白，出冷汗，呼吸困难，紫绀，昏厥（发作时可出现四肢抽搐、呼吸暂停等）或休克，呈极度痛苦貌，严重者甚则死亡。

如为心包填塞，可表现为面色苍白，气急如窒，烦躁不安，脉搏细弱，心音遥远、轻微，X线可示有心影增大，心包饱满，心搏微弱。如心功能损害，则见严重心律失常，心悸，胸闷，以至心力衰竭。如果不及时采取有效措施，病情可在短期内急剧恶化，最后导致死亡。

【处理方法】

术者在针刺心脏投影区内穴位时，一旦出现心脏损伤的临床症状，则应立即出针，并施行内科抢救，包括绝对卧床、镇静、吸氧、应用强心利尿药物，限制水分摄入等，防止心力衰竭。当发生休克，宜进行抗休克处理。如损伤严重，出血不止，病人常会在数小时内死亡，故需速转胸外科，必要时行开胸手术，修补损伤的胸壁及清除心包内积血等，绝大多数病者的预后较凶险。

【操作要点】

为了预防后果严重的本类意外事故，术者在临床的操作中，一定要充分注意以下几个方面：首先，针刺心脏投影区域及其周围穴位前，要对患者进行叩诊检查，以确定心脏的大小，既应熟悉其正常情况，又宜了解各种病变时心脏大小和位置的变异，以免在针刺中发生意外；其次，要严格控制针刺的深度和角度。虽然心脏距胸部有一定的距离，但如果没有掌握好正确的深度和角度，那么是很容易损伤心脏的。一般前胸诸穴，都以沿皮刺为宜，深度在0.5～0.8寸之间，避免直刺和进针过深；最后，要密切注意

留针情况，一般留针时间不宜过长，最好不要超过15分钟；而且在留针期间，应嘱患者保持原有体位，不可随意变更，呼吸节律宜平稳匀称，如有咳嗽、打喷嚏等，应退针至皮下。一旦见到针尾出现节律性摆动，或者体针有与脉搏或呼吸运动相应之往返性刮擦时，则示针尖已和心脏相触，应该急速退针。此外，还要注意避免隔衣进针，有精神躁动症状者最好少用或不用此类部位穴位（必要时只沿皮浅刺不留针），慎用穴内埋针法等。

六、针刺不当损伤肝脏

【案例】

某一女性患者，40岁。因腹部急性疼痛已12小时，于1963年8月9日急诊入院。患者在入院前夕，曾因食后胃痛至某卫生所施行针灸治疗，在上腹部针刺鸠尾、上脘、中脘穴，进针与留针时，患者均感到剧烈疼痛（性质如刀割样）。起针后服药片2粒（药名不详），疼痛一时缓解而入睡；夜间因腹痛而醒，全腹呈弥漫性持续性疼痛，自觉呼吸困难，口渴、恶心。患者曾在1960年患过无黄疸型传染性肝炎。

入院时，见其口唇苍白，烦躁不安，全腹稍隆起，剑突下有3个针孔，无溢血和血肿。全腹壁较紧张，有广泛的压痛及反跳痛，腹壁反射消失。血压10.7/8.0千帕（80/60毫米汞柱）；血象为白细胞 $16 \times 10^9/L$ （1600/立方毫米），中性分叶核0.80（80%）、杆状核0.20（20%），淋巴0.18（18%），红细胞 $2.02 \times 10^{12}/L$ （202万/立方毫米），血红蛋白50克/L（5克%）；出凝血时间皆在正常范围内，血小板 $250 \times 10^9/L$ （25万/立方毫米）。腹腔穿刺，抽出新鲜血液。剖腹探查示：腹腔内积有鲜血，肝在右锁骨中线季肋下4~5厘米，剑突下5~6厘米，质地柔软，表面光滑。将腹腔内血液清拭以后，发现肝左叶（即剑突下）有 0.5×0.5 （厘米）大小的出血灶3处，排成一行，鲜血喷射；病灶周围组织坏死。遂将肝左叶切除后，充分止血缝合。术后经输血、补液、控制感染及保肝药物治疗，于9月30日痊愈出院。分别在3个月、半年及

1 年后来门诊复查，情况良好^[18]。

【分析】

本案例所取的 3 个穴位中，鸠尾穴位于脐上 7 寸处，其深部正为肝脏左叶；上脘穴位于脐上 5 寸，深部为肝脏下缘和胃幽门部；而中脘在脐上 4 寸，深部相当于幽门和横结肠部位，虽然正常情况下与肝脏有一定的距离，但由于该病人有肝炎病史，存在肝脏肿大的情况，医生在术前又失于检查，加上针刺时病人呼叫疼痛仍未被重视，结果 3 穴的针刺均伤及肝脏，造成出血不止，出现危急的症情。根据解剖知识，肝脏呈楔形，左右径约 25 厘米，前后径约 15 厘米，大部分位于右季肋部和上腹部，小部分延伸至左季肋部。肝脏在人体表面的投影是，以右侧腋中线第 7 肋间为一点，右锁骨中线第 5 肋间为一点，左侧锁骨中线第 5 肋为一点，前正中线平剑突与胸骨体交接处为一点，上述 4 点连接起来形成一稍凸的连线即是肝脏的上界；下界以右侧腋中线平第 11 肋间处为起点，沿右侧肋弓下缘至右侧第 8、9 肋软骨结合部离开肋弓，在前中线突出于剑突下方约 3 厘米左右处，斜向左上方经左侧第 7、8 肋软骨结合处进入左季肋部，连于上界的左端。正常情况下，成人肝脏除剑突下有时可触及外，其余部分均被肋弓遮掩，故伤及肝脏不易，但万一损伤时则后果往往非常严重，所以对此要十分重视。一般面言，在肝脏投影区内的腧穴，如任脉的鸠尾、巨阙，胃经的乳根、不容（右侧），胆经的日月（右侧），肝经的期门（右侧），均可直接刺入肝脏；而肝脏周围的腧穴，如任脉的上脘、中脘，胃经的承满、梁门，胆经的京门、带脉，肝经的章门，肾经的神封、步廊、幽门、通谷，脾经的食窦、天溪等，当进针的角度和深度不当时，也同样可以伤及肝脏。

【临床表现】

轻症：无明显的腹膜刺激症状，主要表现为肝区胀痛，或有轻压痛，胀痛可向背部故散，触诊肝脏可有肿大。

重症：表现为弥漫性腹膜炎，如剧烈的腹痛和右侧腹肌紧张，有压痛和反跳痛，甚则有右肩牵拉痛，伴见恶心、呕吐、呃逆、发热、口唇苍白等。严重者呼吸困难，心慌气短，口渴欲饮，

烦躁不安，而进入休克状态。检查：叩诊右腹有浊音和移动性浊音，X线示肝阴影扩大和膈肌升高，实验室检查红细胞计数、血红蛋白和红细胞压积等都提示进行性贫血。此时如不及时采取有效措施，病情便可逐渐加重，表现为全身衰竭，甚至死亡。

【处理方法】

在针刺时，如患者有可疑的肝脏损伤症状，则应严密观察，力求早期诊断。若患者症状较轻时，可采用保守疗法，嘱病人静卧休息，适当应用止血剂和止痛剂，配合保护肝脏的药物，控制饮食，必要时应用抗生素。但如肝脏持续增大或出现进行性贫血，则应立即请有关医生会诊或转外科检查治疗，及时进行抢救，包括切除坏死的肝组织，清除腹腔内的血块和胆汁，修补缝合伤口，充分的止血和可靠的引流。并发休克时，宜先进行抗休克治疗，快速输血和止血，待休克好转后，再予以手术治疗。

肝脏损伤的预后与其损伤程度和及时正确的治疗密切相关，故一旦诊断为针刺损伤，则必须迅速判断症状的轻重，给予及时、合理的救治，患者一般可望得到恢复。

【操作要点】

肝脏被针刺误伤的后果往往很严重，故为了避免出现这种意外，术者在操作过程中要十分慎重。一般来说，施术时应当注意以下几点：首先，若要针刺肝区及其邻近穴位，应事先做好体格检查，用触诊和叩诊的方法检查肝脏的大小情况，以确定其投影区域，尤其是肝肿大或肝硬化的患者更应注意其投影区的穴位；其次，为了防止因呼吸、体位变动等情况致使肝脏位置下降，在针刺鸠尾等肝区穴位时，宜令病人平卧、去枕、两手臂向上屈曲抱头，以期抬高膈肌和肝脏的位置，求得安全；同时，还要严禁隔衣针刺的错误操作；最后，操作时要慎重，正常情况下针刺深度应掌握在腹壁各层之间，决不可超过腹膜壁层；刺入皮下后，进针速度应变缓慢，一经出现针感（病者有酸、胀、重等感觉，术者手下有粘滞紧涩感），即可停止，如果针感不明显，也应在腹壁内各层慢慢操作，肝区的穴位严禁快速深刺、强烈捻捣等；当进针后或留针时，病者自觉局部疼痛，而持针进出有脱空感，此时

应立即退针，另换穴位施治。

七、针刺不当致胆汁性腹膜炎

【案例 1】

一患者，男，35 岁，农民。因上腹部疼痛 2 天入院。患者在 2 天前早饭后，突然感到胃区疼痛，呈持续性发作，初期不甚剧烈，并于发病的当天下午 2 时许，在当地诊所于上腹部（相当于梁门、上脘部位）施行针灸治疗，针长 3 寸左右，全部刺入腹腔内，留针约 30 分钟。患者术后腹痛无减轻，并于当晚 5 时许觉右下腹部持续性绞痛，继而转至全腹部。入院后行剖腹探查术，术中发现腹腔内含有多量之胆汁液，胆囊体部内侧发现有两处粟粒大小之穿孔，两孔相距 0.5 厘米，呈斜行排列，于穿孔处见胆汁外溢；胆囊呈 $7 \times 5 \times 5$ （厘米）大小，囊壁柔软，没有发现坏死及明显炎症，胆道无异常发现。术后经过良好^[19]。

【案例 2】

崔××，男性，33 岁。因右侧胸前下部针刺治疗后引起急性腹痛 1 天多，于 1958 年 5 月 22 日急诊入院。患者自诉常有心口疼痛，故请当地医生针灸治疗，第 1 次针治后心口疼痛稍微减轻，但照常劳动半天后仍觉疼，于是又行第 2 次针灸。起针后觉右上腹部隐痛，逐渐波及全腹，并向右肩放射，腹部逐渐隆起发胀，疼痛转剧。伴有发烧发冷感，视物发黄，于第 2 天午夜来院。检查：发育正常，营养中等，面容憔悴，半昏迷状态，可低声对答。体温 37.9°C ，脉搏每分钟 100 次，血压 13.3/9.3 千帕（100/70 毫米汞柱），头颈部正常，淋巴系统正常，巩膜及皮肤轻度黄染。双肺正常，心律快而弱，无明显的病理性杂音。上腹部两肋缘下，约相当于期门、日月穴处有针痕数个；腹部膨胀，紧张，抵抗，有显著触痛（以右肋下最明显）；腹腔内有波浪冲击感，墨非征阳性，肠鸣音消失。血象：白细胞 20400/立方毫米，中性分叶 73%，杆状核 12%，淋巴 14%，大单核 1%，血红蛋白 90%，红细胞 485 万/立方毫米；尿检：尿胆原阳性，尿蛋白（+）。X 线腹部透视：

左侧肋膈角变钝，运动明显减弱，腹部未见游离气体，但可见扩张积气的肠管及液面。拟诊断为弥漫性腹膜炎。即在乙醚麻醉下，施行剖腹探查术。剪开腹膜后有大量草绿色液体溢出，腹膜内壁及大网膜充血，总共吸出腹水约 800 毫升。在胆囊底部的前壁有一中等缝衣针孔大小的穿孔（穿孔边缘整齐无外翻及炎症浸润现象），胆汁从漏孔仍继续外溢，胆囊大小及颜色正常。扩大漏孔，吸出胆汁，搜刮胆囊内部，正常，无结石，遂行胆囊造瘘，烟卷引流，缝合腹壁。术后胃肠减压 2 天，胆囊内引流管留置 8 天，黄染退，饮食可，第 7 天拆线，第 8 天抽出引流管，术后 20 天痊愈出院^[20]。

【案例 3】

温××，男性，60 岁，木工。因右上腹反复疼痛，伴有呕吐、吐酸水而住某院治疗。1 天前，患者在相当于右侧期门、日月、不容等穴位施行针刺治疗，针后自觉腹痛加剧，数小时后波及全腹，呈休克征，当时血压为 8.0/5.3 千帕（60/40 毫米汞柱），体温 38.8℃，脉搏每分钟 120 次。经会诊，疑为胃穿孔合并全腹性腹膜炎而转我院治疗。经 X 线透视未见游离气体，腹腔穿速抽得 5 毫升淡黄色胆汁性液体，故确认为胆囊穿孔所致胆汁性腹膜炎。经输血、输液、抗生素、去肾上腺素等抗体克治疗后，即施行剖腹探查术，吸出胆汁约 200 毫升，肝肿大在右肋下缘 4 指，胆囊肿大似成人拳头大小，胆囊壁充血水肿，囊底有帽针头大小穿孔，并见有胆汁继续外流，其穿孔部位与针刺体表穴位一致。在施行胆囊切除术中，发现胆总管有花生米大小的石块 3 枚，蛔虫 1 条，在胃小弯处有 1.5 厘米无穿孔之溃疡，溃疡未做处理，总胆管做“T”引流和腹腔引流术。3 星期后痊愈出院^[21]。

【案例 4】

赵××，男性，62 岁。于 1975 年 3 月 28 日入我院。患者有近 20 年的气管炎病史，入院前 3 天在当地经某医生用针灸治疗，其中一针刺在右上腹部，当即疼痛难忍，要求出针，但医者仍予留针约 1 小时，起针后患者觉腹痛不减，并向全腹部蔓延，伴有恶心、呕吐，呕吐物为胃液及黄水，治疗无效后来我院诊治。检

查：体温38.2℃，脉搏每分钟120次，血压为17.3/12.0千帕（130/90毫米汞柱），腹部平坦，全腹有压痛、反跳痛和肌紧张，尤以右上腹部明显，肠鸣音减弱，其他（-）。血象，血红蛋白13克%，红细胞490万/立方毫米，白细胞14900/立方毫米，中性粒细胞86%，淋巴细胞14%。X线透视：两肺纹理增粗，膈下未见游离气体，腹部无液平。入院后即予大量抗生素、输液及输血300毫升。腰麻下行剖腹探查，术中发现腹腔有大量黄绿色液体；胆囊肿大为9×5×5（厘米），表面充血，有片状坏死区及脓痂包裹，在胆囊底部有一针刺点，并贯通胆囊侧壁，直达肝、十二指肠韧带外缘；阑尾无明显病理变化。作胆囊切除术，术中经过顺利，术后40天痊愈出院^[22]。

【案例5】

女性，31岁。因胃脘部疼痛3年，于1979年4月3日上午请某医生治疗时，以火针3枚刺入天枢、期门、中脘穴，拔针后5分钟即感右上腹持续性疼痛，并逐渐扩散至全腹，呕吐两次，均为胃内容物，4小时后急诊入院。查体：体温36.3℃，脉搏每分钟90次，血压为13.3/9.3千帕（100/70毫米汞柱）。心肺正常。全腹肌紧张、压痛、反跳痛，肠鸣音减弱。血液化验：白细胞7000/立方毫米。腹部X线透视未发现异常。诊断为胆囊穿孔，胆汁性腹膜炎。患者不同意手术，17小时后血压降至9.3/6.7千帕（70/50毫米汞柱），体温36.4℃，白细胞8400。即紧急行剖腹探查术，术中见全腹膜黄染、水肿，胆囊与大网膜轻度粘连，钝性分离后，见胆囊颈部有一个0.5厘米长的裂口，随呼吸运动仍有新鲜胆汁溢出，穿孔与火针伤痕对应。随即行胆囊摘除术，术中经过顺利，切口Ⅰ期愈合^[23]。

【案例6】

男性，59岁。因右上腹部疼痛30小时入院。患者因颈椎病而针刺上脘、中脘、天枢，拔针后约10分钟即感右上腹隐痛，约1个半小时后腹痛加剧，并向右肩背放射，伴有恶心，无发热发冷。8年前因患十二指肠溃疡行胃大部切除，胃空肠吻合术，术后无不适。查体：体温36.8℃，脉搏每分钟76次，血压18.7/10.7千帕

(140/80 毫米汞柱)，呈急性病容。心肺正常，全腹肌紧张、压痛、反跳痛，以右上腹为著，肝浊音界存在，肠鸣音消失，无移动性浊音。右下腹穿刺抽出透明黄色胆汁样液 1 毫升，镜检见白细胞 2.0、红细胞 1~2。腹部 X 线透视，膈下无游离气体。血象，白细胞 13200/立方毫米，中性粒细胞 87%。诊断为胆汁性腹膜炎。急行剖腹探查，术中见腹腔内有中等量黄色透明液体，胆囊增大过脐，与中线腹膜粘连，胆囊底、体部浆膜下呈墨绿色，表面有大网膜粘连，分离粘连见胆汁外溢，行胆囊摘除术，术中经过顺利。病理报告：胆囊呈慢性炎症，各层水肿，浆膜层呈急性炎症^[23]。

【分析】

临床上因针刺误伤胆囊，导致胆囊穿孔的事故绝非少见，而且都易导致严重后果，应当引起针灸工作者的高度警惕。一般而言，针刺是不易伤及胆囊的。因为胆囊所在部位较深（呈梨形的胆囊在肝下面的胆囊窝内，上面借疏松结缔组织与肝相贴，下面游离，覆以腹膜，其腹面和两侧面由肝包膜反折加以遮盖），体积较小（长约 8~12 厘米，宽 3~5 厘米），表面圆滑而有一定张力，以及前有肝脏等脏器覆盖。但在胆囊充盈和胆囊本身罹病的情况下，由于针刺过深，则会刺伤胆囊。本节的案例基本上都是由于术者在针刺过程中，进针的深度和角度不当，加上施以反复的提插捣动手法，造成针刺贯穿胆囊，引起急性胆汁性腹膜炎。因此，针刺胆囊体表投影区内的穴位时一定要谨慎。在正常情况下，在胆囊投影区内及邻近的穴位有，右侧的不容、承满、期门、章门、日月等，它们较易导致损伤胆囊；此外，肝脏肿大或胆囊本身病变肿大，亦会造成体表投影的位置变化，使涉及的穴位增多，如梁门、鸠尾等。所以针刺前要详细询问病史，仔细体格检查，以明确胆囊下伸的大小和位置。

【临床表现】

针刺误伤胆囊，临床上可根据患者的体质，胆囊穿孔的大小、胆囊是否有病变，胆汁外流的程度，分为胆囊周围炎、局限性腹膜炎及弥漫性腹膜炎数种，症状上有轻重之别。一般而言，可分为下面两种类型。

轻症：起针后见右上腹部疼痛，并有轻压痛，可伴有恶心、呕吐等。但有些病人在 24~36 小时内不出现症状，故要注意观察。

重症：留针时期或退针后，病人出现右上腹部剧烈疼痛，逐渐加重，扩散至全腹，并可向右肩部放射，腹肌紧张，局部压痛明显，有反跳痛，伴有恶心呕吐，肠鸣音消失，全身可呈发热、脉速、呼吸浅快等中毒症状。腹腔穿刺多可抽出淡黄色胆汁，这有助于诊断。血象：白细胞计数增加至 15000/立方毫米以上，中性粒细胞增高。

【处理方法】

可根据针刺情况、症候表现、炎症范围及全身状态而采取不同治疗方法。

轻症：若全身状况好、原无胆囊病变者，可采取保守疗法。即卧床休息，口服清热解毒、疏利气机的中药以及消炎止痛的西药；必要时，宜禁食及胃肠减压，并输液以补充足够的水、糖、电解质、维生素等。

重症：一般情况差、全身中毒症状较重，或用非手术疗法不见好转者，则应迅速转外科处理，以手术为妥。手术方式有胆囊修补术和摘除术两种，胆囊穿孔多以后者处理为好，既彻底又安全（因为行修补术后，由于胆囊内压力增加，仍有可能使胆汁沿手术缝合结扎孔溢出，故本法仅适用于轻者）。但病情严重者，暂不宜作切除，应行胆囊造瘘术。

胆囊穿孔，只要诊断明确、治疗得当及时，一般都可治愈。

【操作要点】

为了避免误伤胆囊的意外事故，要求术者应了解胆囊的解剖学特点。在胆囊体表投影区内针刺时，尽量以浅刺或斜刺为主，不可刺破腹膜，切忌盲目过深针刺，切忌大幅度乱捣乱插；留针时间一般不宜太长，约 10~15 分钟，并要求患者注意保持原来体位，不可随意变动；起针后，应让病人在诊室内稍事休息，以观察有无不良反应，并嘱病者回家后要留意各种异常现象。对于有胆囊及肝脏病史的患者，则应仔细体格检查，以明确胆囊下伸的大小和位置，在此范围内取穴应谨慎，对经验不足者来说，最好远道

取穴或右病左取。

八、针刺期门引起主动脉出血致死

【案例】

吉××，男性，64岁，农民。有胸闷史。此次因胸闷、两胁疼痛、四肢乏力、手臂酸麻、头微痛，到中医×××处求治。该医生查明其神志清楚，精神正常，应答自如，检查合作，脉象细弱，手发冷，嘴唇微青紫，决定给予针灸治疗。取穴太阳、合谷、肩中俞、期门，手持1.5寸长的毫针，施行刺治。当针刺期门穴时，进针后约1分钟，患者即喊“不行”，随即便坐不稳而躺倒床上，两手抓胸，连说：“不好，不好，心内似有个气流上升……”。继则不省人事，大汗淋漓，小便失禁，旋即出针，并会同吉的胞兄一道给予心脏按摩、人工呼吸、针刺人中等抢救约15分钟无效而死亡。

尸检见：吉××发育正常，营养中等，体格一般，体态较胖。颜面苍白，两目闭合，眼球结膜无出血点。双侧颞前部、两肩胛内侧、两手拇食指间的掌骨缘中点及左乳头内侧2.7厘米、右乳头内侧3.3厘米处，各有一针孔，孔口积有芝麻大小血痂。经分层切开并剥离胸部皮肤、肌层，查见左乳头内侧针孔斜行进入各肌层、纵隔、心包，直达主动脉弓根部，主动脉根部被刺破，进针与主动脉弓根部刺破口夹角约为72°。心包稍扩大，腔内积血约400毫升，心脏大小（自主动脉根至心尖及心室基底部水平面）为13×10.5×6（厘米），心外膜下脂肪沿血管周围和组织间隙向外扩散，覆盖面积占80%。尤以右心耳为甚，脂肪厚度为0.13厘米，有向心肌深层浸润，压迫心肌纤维的趋向，各瓣膜周径均在正常值范围内，无病变，无畸形，左前壁、侧壁、膈面、心尖、中隔以及心内膜下等心肌梗塞好发区，均未见明显异常。胸膜无粘连，双肺大小正常，无血气胸。腹腔各脏器完好无损，游离液透明，量约20毫升^[24]。

【分析】

刺破体内的重要动脉或其分支，引起大量出血，在针刺事故中并不少见，而且往往因抢救无效而发生死亡，故对此类事故必须给予重视。本节案例是由于医生施术方法不当，用1.5寸长的毫针在错误的位置（乳头内侧2.7厘米处相当于神封、步廊穴之间，而期门穴的位置应在乳头直下平第6肋间隙）上进针，过度斜刺（因病者坐着接受针刺，刺入口与主动脉弓受伤部夹角约72度）约4厘米以上，致使毫针刺破主动脉弓的根部，引起体内大出血，导致循环衰竭而死亡。

【临床表现】

因针刺损伤的程度、血管的类型及其所处部位的不同，临床症状各不相同。

浅表小静脉、毛细血管损伤，主要表现为较小的出血斑块或少量的鲜血自针孔流出，但很快可自行停止。

血管位于肌肉深层，则可短时间积于皮下形成血肿。血管愈粗大，血肿程度愈明显，并能产生压迫症状，如在颈部则会因压迫气管而出现呼吸困难，如在臀部则会造成行走不便。

胸腹部血管，破裂后血液将流入胸腹腔，引起内出血症状。血胸主要表现为呼吸表浅，心慌气急，而色苍白，四肢厥冷，紫绀，脉搏细速，血压下降等，在患侧积液处叩诊可呈实音，X线可见液体阴影及液平面，胸腔穿刺见到血液。腹腔内积血，则表现为腹部剧烈疼痛、压痛、腹肌强直等急性腹膜炎症状，并因失血过多而呈头晕眼花，口渴烦躁，汗出心悸，而色苍白，血压降低甚至休克。严重者可导致死亡。

【处理方法】

浅表点滴出血，只需用消毒干棉球压迫针孔数分钟，一般即可止住，无需特殊处理。皮肤局部出现瘀肿，应先给予冷敷，待出血止住后再用热毛巾外敷，每次20分钟左右，以促进溢出血液消散吸收。瘀肿一般在3~5天，最多7~10天内自行吸收。

对体腔内的出血，如症状表现较轻，则可在严密的观察下选用药物止血，如用安络血、止血敏等。如果血管较重要或裂口较大，出血量较多，用一般止血方法不奏效时，则需转外科手术结

扎或修补以止血。当病人出现明显的休克症状时，则要马上进行积极的抗休克治疗，紧急输血或血浆、右旋糖酐等补充血容量，使用升压药物，以及针刺人中、素髻、足三里、百会等措施。

针刺所导致的血管损伤，绝大部分病人经及时处理后均可以止血，但也有治疗失当而死亡者。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：由第6肋间神经分布。

2. 皮下组织：分布有第6肋间神经和第6肋间动、静脉，它们共同走于第6肋间隙内，其排列的顺序是自上而下为静脉、动脉和神经，分布于第6肋间隙与胸骨剑突平面的皮肤和浅筋膜。

3. 腹外斜肌：该肌的外半部分为肌腹，内半部分为腱膜，受下6对胸神经前支支配。

【操作要点】

本穴临床施术时，患者可取坐位或仰卧位，以后者体位最佳。进针时要控制好针刺的方向、角度和深度，一般情况下是斜刺0.5~0.8寸，局部有酸胀并向腹后壁放散即可。若过深针刺，针尖可通过肋间外、内肌、膈肌、腹膜及腹膜腔而刺伤肝脏（右侧期门穴）、横结肠或胃（左侧期门穴），或者进针位置有误而损伤主动脉弓等，故临床操作时要小心谨慎。

九、施术不当致肋间动脉出血

【案例1】

患者××，因呼吸困难、腹痛半天而入院。自诉半年来觉两季肋部胀痛不适，食欲减退，饭后上腹部胀满明显，诊断为肝炎。入院当天中午，患者曾在外院接受针刺治疗，施术过程中有咳嗽，出针后自觉气短，腹痛逐渐加重，右侧卧时疼痛更为明显，有过呕吐、腹泻，吐出物为酸水，无血性物质。当晚10时由他院转来，脉搏虚弱，每分钟140次，呼吸每分钟36次，血压听不清；发育正常，营养差，神清，而色苍白，烦躁不安，喜向右侧卧，轻度紫绀，眼结膜苍白；胸部对称，呼吸音清晰，心律规则无杂音；腹

部膨隆，无肠型及蠕动波，剑突下及两侧后胸部有针刺样痕迹，全腹部有中等肌紧张，明显压痛，轻度反跳痛，肝脾未触及，有明显腹水征，肠鸣音消失，肝浊音界存在。血红细胞 129 万/立方毫米 ($1.29 \times 10^{12}/L$)，血红蛋白 63% ，腹腔穿刺有血性液体。入院后即输入葡萄糖、右旋糖酐，注射肾上腺素等，吸氧，准备输血，但患者于入院后 4 小时许心跳、呼吸停止而死亡。尸检：开腹时有大量血液外溢，腹腔内积血共约 2700 毫升，肝、脾、肠管、肠系膜等均无损伤，右侧腹膜后可见 4×14 (厘米) 大小之腹膜后血肿，位于右侧第 10 肋骨下缘，与体表章门穴的针刺痕迹一致，左侧对称部位见 3×3 (厘米) 大小之瘀血斑，心、肝、脑等外表贫血征。最后诊断：肋间动脉破裂引起腹腔内大出血，休克死亡^[25]。

【案例 2】

某女性患者，26 岁。患右乳房急性炎症 3 天就诊。医生用未消毒的三棱针直刺红肿明显处，刺后剧痛，拔针时从针孔流出鲜红色血液，短小时内流出约 200 毫升，病者当时感到头昏、眼花、口渴、出汗、心慌及将要昏倒感，后经强力压迫出血方止住。次日又出血，痛更剧。第 4 天又出血，先后 3 次共约 500 毫升。既往无出血史。入院体温 37.8°C ，脉搏每分钟 90 次，血压 $14.7/9.3$ 千帕 ($110/70$ 毫米汞柱)，神清，心肺正常。两乳房对称，右乳房上方有一个 3×4 (厘米) 大小的硬块，局部红肿、压痛，硬块中心可见针孔，检查时流血约 5 毫升。出血时间 1 分钟，凝血时间 2 分钟；血象：白细胞 $9.5 \times 10^9/L$ (9500)，中性 0.72 (72%)，红细胞 $4 \times 10^{12}/L$ (400 万/立方毫米)，血红蛋白 95 克/L (9.5 克)。入院后行压迫法，不再出血。次日下午因咳嗽再出血约 50 毫升，因此采取手术治疗。切开皮肤后，见一核桃大囊腔，内由凝固性血块充满，取出血块，见有鲜红色血液从第 5 肋间下缘射出，喷射与心脏搏动一致。检查证实为肋间动脉破裂，出血部位与针刺部位相重叠，后经缝合结扎而愈^[26]。

【分析】

根据现代医学知识，肋间动、静脉主要行于肋骨下缘的肋沟内，而肋间动脉的前下支则沿上缘外行，故为了避免针刺肋间穴

位时不慎伤及血管，进针部位宜选在肋间中点，决不可在肋骨的上下缘针刺。本节案例 1、2 正是由于术者施术失当，损伤肋间动脉，引起大量出血，而导致严重的后果（例 1 为血液在横膈下部贯通腹腔，血流至腹腔而成血性腹膜炎，休克而死亡；例 2 则是肋间动脉虽被刺破，但未贯通体腔，血液从针孔处流出，或形成较大的血肿）。因此，针灸工作者要对此类事故给予重视，不断加强自己的医学修养，避免不幸事故的发生。

【临床表现】

根据肋间血管损伤的程度，其症状表现不一。较轻者，可见有鲜血自针孔流出或呈喷射之状，有的可积于皮下形成血肿。严重者，血液会流入胸腹腔，引起内出血症状。血胸主要表现为呼吸表浅，心慌气急，面色苍白，四肢厥冷，口唇紫绀，脉搏细速，血压下降等，在患侧叩诊呈实音，X 线可见液体阴影及液平面，胸腔穿刺可见到血液；腹腔内积血，则表现为腹部剧烈疼痛、压痛、腹肌强直等急性腹膜炎症状，并因失血过多而呈头晕眼花，口渴烦躁，汗出心悸，面色苍白，血压降低甚至休克。有的病人甚至会导致死亡。

【处理方法】

轻症：用消毒干棉球压迫针孔数分钟，一般即可止住。若皮肤局部出现瘀肿，应先予冷敷，待血止住后再用热毛巾外敷，每次 20 分钟左右，以促进溢出血液消散吸收，瘀肿一般在 3~5 天、最多 7~10 天内可自行吸收。

重症：可先在严密的观察下，选用药物（如安络血、止血敏等）止血。如果裂口较大，出血量较多，用一般止血方法不奏效时，则需转外科手术结扎或修补以止血。当病人出现明显的休克症状时，则要马上进行积极的抗休克治疗，紧急输血或血浆、右旋糖酐等补充血容量，使用升压药物，以及针刺入中、素髀、足三里、百会等。

【操作要点】

为了避免针刺损伤肋间血管，施术时应注意以下几点：首先，正确选取胸部的腧穴，如有可能应尽量少用易伤及血管的穴位；其

次，针具多选用28~30号的毫针、三棱针、火针、芒针等应慎用或不用；再次，进针要慢，手法要轻，须细心体会手感，一般以浅刺、沿皮刺为宜，不要斜向肋骨的上、下缘；最后，施术前应该详细询问病史和检查病人，对有止、凝血机制障碍的病人，如血友病、白血病等，不能草率针刺。

十、躯干穴位拔罐晕罐

【案例1】

李××，男性，32岁，农民。1977年6月1日诊。5天前与他人开玩笑，被其用拳头触击左肋腔，继后出现呼吸、咳嗽、曲伸、转侧均感异常疼痛，曾服止痛片、三七药酒无效。患者素体壮实无病，左肋无红肿青紫现象，舌脉正常。检查见第6肋骨弓处的周围有如掌大一块疼痛，压痛明显。诊断为气滞血瘀之挫伤。遂用拔罐疗法：取患侧渊腋穴，2号玻璃罐，用投火法拔罐。5分钟后局部皮肤起红晕，未曾起罐，病者自觉恶心欲吐、头昏乏力，由坐位而突然仆地。遂即去罐，扶其平卧，继而见其大汗淋漓，面色苍白，肢冷脉伏，呼吸气微，不省人事，形同死人。当即指掐人中、合谷，并灌以热汤。随即患者又吐饮食物一大堆，10分钟后仍未回复，又用艾条重灸百会、气海、神阙3穴，约10分钟后逐渐肢温脉起，仅觉倦怠乏力，嘱其回家休息。7天后随访，自称从此以后肋痛已痊愈，无其他不适^[27]。

【案例2】

据报道，在其临床中曾有11例痛痹证病者，经针灸后加拔火罐，均在拔吸后10分钟左右出现晕罐（拔罐部位多为躯干部或近大动脉处，均为坐位）。轻者静卧片刻，或给予温热糖水饮服，即能迅速恢复；重者针补内关、足三里，即可渐苏。

病例介绍：徐××，男性，34岁，农民，1992年8月2日初诊。挑水致腰部扭伤2天，不能直立，第4、5腰椎棘间疼痛，俯仰转侧受限。经推拿夹脊、针灸委中后，起床坐位拔罐。10分钟后，患者渐感心慌、头昏，面色苍白，出冷汗，即迅速起罐，平

卧 5 分钟，自行恢复。腰痛明显减轻，步行返家^[28]。

【分析】

拔火罐晕罐者临床上较为少见，故易为医生所忽视，但临证之时不可不慎。究其发生的机理，主要是由于突然受到外界拔罐吸引力之刺激，通过迷走神经的反射，引起全身外周血管（尤其是周围肌肉内血管）扩张，外周血管阻力降低，回心血量减少，因而心脏输出量减低，血压下降，造成一时性、广泛性的脑供血不足或脑缺血所致。本节两个案例正是由于患者精神紧张，加上坐位拔罐，致使其阴阳气机逆乱，阳气下陷，阴失所依，阴阳气机顿失平衡而致昏厥出现。

【临床表现】

晕罐大多发生在针灸操作过程中，典型的病者一般可分为 3 期。先兆期：病者有各种感觉的错乱，如眼花，耳鸣，头昏，心悸，出冷汗，打呵欠，恶心欲呕等；发作期：轻者头晕胸闷，恶心呕吐，肢体发软发凉，摇晃不稳，或伴瞬间意识丧失；重者突然意识丧失，昏仆在地，唇甲青紫，大汗淋漓，面色灰白，双眼上翻，二便失禁，少数可伴有惊厥发作；恢复期：轻症仅有轻度不适，多数患者可有显著疲倦、头昏，嗜睡，汗出及全身不适感，短则几分钟，长则几小时，症状才能逐渐恢复。

【处理方法】

1. 常规护理：迅速将火罐取掉，扶患者至空气流通处，并让其仰卧在床上，头低脚高位；及时松解患者衣带，热天注意通风，冷天注意保暖；立刻测量呼吸、血压、脉搏以及心率。

2. 轻者一般静卧片刻即可，如患者仍感不适，可给予温糖水或热茶口服，并注意使之安静和休息，约 3~5 分钟后即可逐渐恢复。

3. 重者可在上述处理的基础上，用指掐或针刺人中、素髻、足三里、涌泉，或艾灸百会、关元、气海等穴；嗅以氨水；必要时可用肾上腺素 1 毫升、阿托品 1 毫克肌注，25% 葡萄糖 40 毫升静脉推注等。

【操作要点】

晕罐现象属于针刺意外中较少见的一种，且一般不会留有后遗症，但仍需我们提高警惕，尽量避免这种情况的发生。临床操作时应注意以下几个方面：首先，要做好心理预防工作，对初诊或精神过度紧张的病人，医者应事先解释清楚，说明拔罐疗法并无痛苦，用闪火法亦不会烫伤皮肤，使之消除顾虑，以期医患合作；其次，要选择好拔罐的体位，一般多以卧位为最佳，而由卧位针灸后即改坐位拔罐者，往往易使患者产生短暂的脑缺血缺氧致晕罐；再次，若患者先施行针灸，则宜休息片刻后，方可再予拔罐，火罐吸力应适中，尤其对体弱、精神紧张的病人，吸力更勿太强。另外多罐拔吸时还要注意保持一定距离（勿令太近，否则易致机体皮肤过分牵拉产生疼痛）；最后，留罐时间亦不宜太久，而且在这个过程中要严密观察患者的神色、表情、脉象等状况，一旦有晕罐的先兆症状，即应立即处理。

十一、针刺腹部腧穴不当造成胃穿孔

【案例 1】

据报道，南京华东军区医院外科，从 1949 年 6 月至 1950 年 10 月间，共收治 40 例腹部穿刺伤的病例，其中被金针刺穿伤 4 例。开腹时，发现有 1 例患者为胃壁受损伤，流有少量血液，余均未伤及内脏其他器官^[29]。

【案例 2】

据报道，曾收治 2 例腹痛患者，均经针刺腹部穴位（穴名不详）后病情加重求诊。其中有 1 例因针刺不慎导致胃穿孔性腹膜炎，手术时发现胃有 4 处穿孔；另 1 例幽门梗阻性腹膜炎，手术时见有渗出、充血、水肿，前壁与大网膜粘连、幽门梗阻等，认为均与针刺伤有关^[30]。

【案例 3】

王××，男性，20 岁。因其饮酒后觉腹部不适，请当地医生针刺中脘穴，约 10 分钟之后，全腹呈持续性剧痛，半小时后查白细胞总数达 18000/立方毫米，中性粒细胞占 82%。于发病后 10 小

时，由急诊收入院，既往身体健康，无胃痛史。体格检查：体温 38.6℃，心率 88 次/分，呼吸 22 次/分，血压 16.0/10.7 千帕（120/80 毫米汞柱）。呈屈曲卧位，腹式呼吸消失，腹部呈板状，全腹有压痛及反跳痛，肠鸣音消失。肝脾触诊不满意，肝浊音界消失，未叩出移动性浊音。实验室检查：血红蛋白 13.3 克%，白细胞计数 18500/立方毫米，中性粒细胞 84%。腹部透视：双膈下见半月形游离气体，左腹中上部可见多个小液平面；部分肠管胀气。诊断：胃穿孔并发腹膜炎。入院 1 小时后，即行剖腹探查术。术中见胃及结肠胀气，左肝区及髂窝处有白色粘稠脓液约 100 毫升；胃小弯处可见 4×4（厘米）大小之血肿，局部网膜充血，穿孔已被网膜覆盖；其他脏器未见异常。荷包缝合修补穿孔处，吸净脓液，于右肝区及髂嵴处，分置香烟引流两根。术后切口一期愈合，第 11 天痊愈出院^[31]。

【分析】

胃是腹部的空腔器官，由于腹壁肌层较厚，而且胃本身又有一定的收缩能力，当受到刺激后会主动收缩、蠕动而退让，加之表面很光滑，故一般而言胃受到针刺损伤的机会要少些；即使针刺所致较小的创口，也可因胃壁肌肉（由外纵、中环、内斜 3 层平滑肌所组成）的收缩而自行闭合，不致出现明显的症状。但是，如果针刺对胃的损伤较严重，则会出现胃壁出血或胃穿孔等意外情况。例 1 因金针仅伤及胃壁，未造成穿孔，只有少量流血，故愈合较易；例 2、3 则是因针刺不当，导致胃穿孔造成腹膜炎，所以腹部穴位不可盲目深刺。根据现代解剖学，胃位于腹腔左上方，其前壁、右侧与肝相邻，左侧与膈相邻，为左肋弓所掩盖，前壁中间部直接与腹壁相贴，胃的具体位置、大小、形态可随其充盈的情况和体位的变化而改变，还可因年龄、性别、体型等不同而有所差异。正常情况下，胃在空虚时呈管状；中度充盈时大部分位于左季肋部，小部分位于腹上部；过度充盈时，可达脐或脐以下，而正常人的胃大弯下极一般在髂嵴连线上、下约 5 厘米范围以内。而在正常的胃投影区内，胃经的不容、承满、梁门、关门，肾经的阴都、通谷、幽门，任脉的中脘、上脘、巨阙、建里等穴

均与之密切相关，故操作时要慎重。

【临床表现】

根据针刺损伤程度和原有病变情况的不同，可分为轻重二症。

轻症（一般为针刺损伤轻、穿孔小，而胃本身无器质性病变，创口能自行闭合者）：仅在针刺以后的1~2天内出现局限性腹痛不适、纳差，局部有轻压痛，或伴有低热等症状，往往会被误认为是疾病本身的加剧。

重症（胃壁裂口较大，特别在胃扩张或饱食时损伤，故胃内容物大量流出者）：剧烈的腹痛，且逐渐扩散至全腹，伴有恶心、呕吐（呕吐物多含血液），发热等。检查见腹肌强直（尤以上腹部显著）、压痛、反跳痛，肠鸣音减弱或消失，肝浊音界消失，X线透视可见膈下有游离气体，实验室检查见白细胞计数升高。

【处理方法】

穿孔小、损伤轻、全身情况良好者，可令其卧床休息，注意饮食，必要时针刺足三里、上巨虚等穴，内服清热解毒、疏肝理气的中药。如因穿孔渗出少量内容物，引起局限性感染者，则根据证候情况，采取禁食、胃肠减压、输液，并据感染程度给予抗生素（如四环素、庆大霉素、卡那霉素等）。穿孔大、内容物渗出多，症状明显及全身情况差者，应及早转外科进行手术治疗，包括探查腹腔、对损及的血管进行结扎和缝合裂口等。

【操作要点】

为了预防针刺损伤于胃，临床操作时一定要注意以下几点：首先，当选择腹部腧穴时，以仰卧位为最佳，这样不仅患者能放松腹肌，且利于长时间保持体位，术者亦便于施术，容易体会针刺深度和感应；其次，针刺时多用28~30号2寸毫针，尽量不选用芒针或粗针；进针时要掌握好针刺深度，应限制在腹膜壁层以上的各层组织之中，此时即使未出现针感或针感不强，也只应在腹壁各层间缓慢提插捻转，或停针候气之后再行操作（腹部针感特点是，当针尖刺入肌层后，即有沉重之感，略加操作便现酸胀，如深刺至腹膜壁层，患者即感疼痛，呈向外放射样刺痛，术者手感如针尖触及一坚韧之膜，则不宜再深刺，可轻轻作小幅度提插，略

将针退出 0.1 寸左右；如有突然的落空感，则说明针尖已进入腹腔，则应立即退针至腹壁层)；最后，要因人施针，如有胃溃疡、胃炎等疾病的患者，应检查是否已有穿孔存在，针刺手法也不可过重过猛；有肿瘤时，应检查肿瘤的大小和位置，以及与肠胃的关系；有过腹部手术的病人，应考虑是否有粘连存在；在饱食时或急性胃扩张等情况下，应尽量少选或不选胃区穴位，对必须选择的穴位，宜严格遵守操作常规施术。

十二、针刺不当造成脾破裂

【案例 1】

辛××，女性，17 岁，学生。于 1957 年 2 月 17 日入院，住院号 521。主诉：腹痛 1 年余，2 天前行针灸治疗后症状加重。自诉原有腹部隐痛及左上腹部不明显包块史 1 年多，4 个月前因着凉后觉上腹部疼痛，伴有发冷发烧，持续数天而愈。入院前 2 天，又觉上腹及脐周围疼痛明显，伴有恶心呕吐，呕吐物为食物及酸水，当即请本村医生诊治，于左上腹作针刺治疗，共刺入 4 针，留针约 15 分钟，未感特殊不适，但拔针后不久即感左上腹疼痛加重，并蔓延至全腹，且渐觉腹胀，口渴，呼吸困难，这两天来卧床不起，食欲不振，夜间不能安眠，小便次数减少色深黄，大便正常。体格检查：体温 37.7℃，脉搏每分钟 134 次，呼吸每分钟 26 次，血压 13.0/9.3 千帕 (98/70 毫米汞柱)，急性病容，面色及口唇苍白，有轻度脱水征。双肺正常，心音快而弱，无杂音。腹部稍膨隆，于左上腹相当于梁门、关门、太乙及滑肉门穴处各有一针眼，触诊全腹肌紧张，有抵抗、压痛及反跳痛，以左上腹为著，未触及肿物，叩诊有移动性浊音，肝浊音界正常，脾浊音区扩大，上达第 7 肋间，下达肋缘，巴兰司 (Ballance) 征阳性，肠鸣音略亢进。其他器官正常。实验室检查：红细胞 350 万/立方毫米，血红蛋白 9.5 克%，白细胞计数 22100/立方毫米，中性 82%，淋巴 14%，酸性 2%，单核 2%。出血时间 3.5 分钟，凝血时间 3 分钟。血涂片未找到利什曼小体及疟原虫，康氏反应 (±)。血沉每小时

35 毫米。尿淀粉酶试验 32 个单位。

入院后作腹腔穿刺抽出鲜红色血液，故诊断为脾破裂，遂转外科手术治疗。在全麻下行左侧 T 形切口，切开腹膜后即有鲜血涌出，在脾区尚有多量的凝血块。脾较正常大几近 2 倍，无粘连，在凸面近下极有一 $2.0 \times 0.5 \times 0.1$ （厘米）之伤口，向外涌血，此正对第 1 针眼（梁门穴）。切除脾脏，尽吸腹内余血约有 1000 毫升，探查肝、胆囊、胆管、胃等器官正常。术后恢复顺利，伤口一期愈合^[32]。

【案例 2】

张××，男性，36 岁，农民。8 年前患有血吸虫病，其后在左上腹部有一肿块，逐渐增大。自诉：入院前 3 天，因上腹部疼痛而在当地卫生所施行针灸治疗 2 次，针刺部位为一穴在心窝部（剑突下），另一穴在上腹部。第 2 次针刺时，留针 10 分钟，针时略有咳嗽，拔针后自觉腹部疼痛加剧，数小时后遍及全腹，且有口干、心慌等症状。经临床检查，符合脾破裂内出血诊断。立即予以抗休克治疗，并开腹探查，共吸出腹腔鲜血 800 毫升。术中发现脾脏较正常大一倍半，左上腹有一针孔，正对脾脏破裂面，裂口长约 2 厘米，深约 1 厘米，创口继续出血，行脾切除术。术后康复顺利，痊愈而出院^[20]。

【讨论】

脾脏位于左上腹腔深部膈肌之下，尽管处于正常位置的脾脏，其体表投影区域内无经穴分布，但在病理状态下，脾脏常因某种疾病如疟疾、血吸虫病、黑热病等而发生肿大，此时不仅游离程度低于正常，而且脆度明显增加，当不慎被针刺损伤，则极易造成脾破裂大出血。本节案例的 2 个例子，都是由于患者本身有脾肿大（均较正常大约 1.5~2 倍），术者操作前未能仔细检查，进针时针刺过深，留针时间过长，结果造成脾破裂而出血不止。根据现代解剖学，成人正常的脾脏约掌心大，外形似蚕豆样，位于左上腹腔深部膈肌之下，被 9、10、11 肋所遮盖，腹周围的腹膜皱襞与附近脏器相连，形成各条韧带，对脾脏起支持和固定作用。一般情况下，脾脏在体表投影区无经穴分布，针刺不易伤及；但

在脾肿大的情况下，它向上伸展可抬高膈肌，向下可伸入左上腹，有时甚至能达左髂部，故在其邻近的腧穴，如梁门、章门、腹哀、京门、胃上穴等施术不慎即易导致损伤。

【临床表现】

根据脾脏损伤的程度、范围及出血情况，其临床症候可分为两种。

轻症（单纯为针尖穿透伤，无裂口，也能自行闭合者）：一般无明显的自觉症状，部分患者仅觉左上腹部（多位于针刺处附近）有不适或胀痛感，或在患处触及有压痛的肿块。这里须提醒注意的是：毫针损伤脾脏常会造成它的中央型破裂（破在脾实质深部）和被膜下破裂（破在脾实质周边部分），形成张力性血肿，这时病人可没有任何症状，然而脾脏却仍在出血，张力性血肿可继续增大，当压力达到一定程度时，积血将突破被膜形成真性破裂，引致腹腔内大出血，病人会迅速休克，甚至未及抢救而死亡。此种情况多于受伤后 1~2 周左右出现。

重症（脾脏损伤后有较大的撕裂或大的针孔，可引起急性大出血）：剧烈的腹部疼痛，以左上腹最显著，可有左肩放射痛，伴恶心、呕吐、腹胀，出现腹膜刺激症状（腹壁板硬、压痛、反跳痛）。出血量过多者，患者可出现面色苍白，口渴心悸，出冷汗，神志淡漠，脉搏微细，血压下降，进入低血容量性休克。实验室检查，红细胞、血红蛋白呈进行性下降，白细胞计数上升。超声波检查，发现腹腔内有积液，脾脏体积增大。X 线检查，可见左膈抬高，活动受限；平片示脾影消失或变形。腹腔穿刺，如吸出不凝固血液，结合左上腹有针刺史及其他临床症状，即可诊断为脾破裂。

【处理方法】

轻症：无明显临床症状的患者，可静卧休息，并给予止血药物等进行对症治疗。对此类病人，均要求必须严密观察 2~3 周，一旦病情恶化而出现内出血，应马上转科治疗。

重症：绝大部分病人一旦确诊，则应积极采取抢救措施，迅速转入外科，在快速输血、补液等抗休克的同时，施行外科手术

处理（脾切除术）。一般情况下，只要术者处理及时、得当，病人都是可以恢复的。

【操作要点】

为了防止针刺损伤脾脏的意外事故发生，临床在脾脏投影区（包括病理性脾脏）内操作时，应注意以下几个方面：首先，应熟悉脾脏的正常解剖位置，针刺治疗前还要详细询问病史，对引起脾脏肿大的疾病（如伤寒、败血症等急性传染病引起的脾肿大多为轻度的，血吸虫病、疟疾、黑热病等慢性传染病和肝硬变等引起的脾脏肿大多为中度的，而 Bant 脾、慢性白血病、肿瘤等所引起的脾肿大可为高度的）要加以重视，通过腹部触诊了解脾脏是否肿大及肿大的范围；其次，施术操作要慎重，针刺时应采用适当的深度和角度，不可向脾脏方向斜刺或深刺，避免伤及正常的脾脏，对于脾肿大者更宜取浅刺或横刺法，针尖须保持在肌层中。如果不慎刺入腹腔，针尖触及脾脏被膜，医者手感常会有一定阻力，此时即须退针，切不可再深刺，或施以提捣之法；最后，留针期间，应密切观察患者反应，如其自觉针处出现疼痛不适，则应马上退针；如其有剧烈咳嗽时，脾脏会随膈肌运动幅度的增大而增加移动度，所以此时应将针体退出少许。

十三、针刺不当引起腹部绞痛

【案例 1】

赵××，男性，33 岁，司机。长期慢性胃痛，腹部胀满、疼痛，在本单位诊所施行针刺治疗。某次穴取天枢、上脘、中脘、足三里等，均予中等刺激手法。起针 3 小时后，患者腹痛加剧，冷汗淋漓，伴面色苍白，口唇紫绀，呼吸浅表，气息奄奄，脉象微弱而数，全腹部压痛呈强阳性。随之注入强心、镇静、缓解平滑肌痉挛的药物，疼痛逐渐停止而全身症状亦消失^[33]。

【案例 2】

袁××，43 岁，男性，农民。因患胃痛、腹胀，消化不良 6 年来诊，予针刺治疗。穴位选取天枢、中脘、足三里，得气后均

用强刺激手法。针后4小时左右，自诉腹部剧痛，全身寒战，伴见脸色苍白，口唇紫绀，鼓颌叩齿，哼叫不停，精神焦躁，脉象微弱。全腹部均有显著压痛。予肌注维他康福5分钟后，全身寒战停止，但腹痛仍剧。又予注射吗啡，经过3小时的观察，症状未见好转，腹痛如旧，体温37.9℃。又肌注水溶青霉素40万单位和鲁米那0.2克顿服，虽经上述消炎、催眠、镇痛等处理，腹部绞痛依然未止。请内科会诊，认为有刺破内脏及血管造成内出血、腹膜炎等急腹症的可能，但化验结果未能支持：血红蛋白9克%，红细胞450~500万/立方毫米，白细胞计数7800/立方毫米，血压17.3/13.3千帕（130/100毫米汞柱）。经进一步会诊，最后结论为因针刺过深、手法过强而引起的肠系膜神经和腹部神经高度痉挛所致。给阿托品2毫升肌注，约15~20分钟后，患者自觉腹部轻松，疼痛明显减轻，又投以莨菪酊等内服药，共3天，始恢复正常^[33]。

【案例3】

张××，女性，40岁。其下腹部有一拳头大小的包块，本来没有任何痛感，但经针刺局部穴位后，反而引起剧烈疼痛。经剖腹探查，发现有黄色液体200毫升和少许血块，证明肿物为一巨大多房性卵巢囊肿，表面破溃并与大网膜相粘连^[30]。

【讨论】

针刺引起腹部绞痛，一般多与刺伤腹部脏器有关，但上述3个病例则较为特别。前面2例主要是由于针刺腹部穴位时进针太深、手法过重，以致在不同的病人身上，刺激腹部脏器的感觉神经末梢，引起有关器官功能紊乱，出现剧烈的痉挛状态而导致急性腹绞痛。此类腹痛归属于功能性急性腹痛，临床上较为少见。最后1例是由于直接刺到肿块本身（多数腹腔内肿块是不宜直接针刺的，否则易发生各种危险），结果囊肿被刺破引起局限性腹膜炎而粘连，囊液外漏而产生绞痛不止，故临床上不可盲目乱刺“痞块”。需要提醒注意的是，在鉴别针刺所致的腹痛时应特别慎重，只有在充分排除内脏器质性损伤的前提下，才可能考虑为功能性的，以免误诊而导致严重后果。

【临床表现】

一般都在针刺后不久即出现腹部持续性的剧烈疼痛，有腹膜刺激征出现（腹壁紧张板硬，局部压痛），多数伴见面色苍白，口唇紫绀，大汗淋漓，精神焦躁等，严重者出现休克。但本症的腹部X线检查和腹腔穿刺均无特殊发现，血常规检查基本正常，体温正常或仅有低热，血压多无改变，应用解痉剂后一般有效。

【处理方法】

针刺后所引起的腹绞痛一经诊断明确，为减轻病人的痛苦，应马上采取解痉止痛措施，如用阿托品 0.5~1 毫克皮下或肌肉注射，或山莨菪碱（654-2）10~20 毫克肌肉注射，一般可很快缓解平滑肌痉挛，达到止痛目的。亦可采用针刺四肢相应穴位（如合谷、足三里、地机等），或耳穴（如神门、交感、腹、相应部位、皮质下等）的方法，能获良好的效果。

【操作要点】

一般来说，若针刺腹部的穴位，病人最好取仰卧位，并尽量放松腹肌，以便于操作。临床施术时，以获得针感为度（病人若有局部的酸、麻、胀感最佳），千万不可追求过度的深刺和过强的刺激。对于精神紧张的病人，必须预先做好解释工作，以解除其顾虑。

十四、针刺不当致肠穿孔

【案例 1】

有一男性患者，27 岁，农民。入院时主诉为脐周阵发性疼痛 2 天。在 3 天前晚饭后 2 小时，开始脐周出现阵发性腹痛及腹胀，无恶心呕吐，无排气排便，惟进食即吐。入院前曾作腹部针刺治疗，症状有所减轻，而现在腹胀剧烈。检查：体温 38.1℃，血压 12.0/8.0 千帕（90/60 毫米汞柱），脉率每分钟 144 次。急性病容，有脱水征，腹部膨隆显著，上腹与右下腹有针刺痕数个，左下腹压痛，但腹肌紧张不明显，肝浊音界消失，有移动性浊音，肠鸣音减弱。化验室检查：红细胞 527 万，白细胞 21600。胸部透视，

两侧膈下有大量游离气体，膈肌升高，腹部可见液平及气体滞留。即行外科手术，术中见腹膜充血，切开腹膜时，有大量气体及混浊白色脓液外溢，肠管极度充气且充血。依次探查，发现距回盲部约 20 厘米处，肠管有一针刺穿孔，正在溢出气与液体，同时发现回盲部肠系膜呈顺时针方向扭转，阑尾正常，予整复，修补穿孔，吸净腹腔内脓液，置链霉素 1 克并缝合腹壁，术中病人情况稳定。术后患者病情渐趋恶化，术后第 2 天高热达 40.3°C ，且烦躁不安，呈现昏迷，血压降至 $5.3/2.7$ 千帕 ($40/20$ 毫米汞柱)，多方抢救无效，终于在术后 36 小时因毒血症死亡。术后诊断：肠扭转，外伤性肠穿孔，腹膜炎。死亡原因：术后毒血症^[34]。

【案例 2】

邓××，男性，农民。患右侧腹股沟疝已有 1 年，平时能自行还纳，但入院前 7 天，该肿块突出不能还纳，伴有腹痛、呕吐，不能排便、排气等症状。入院前 5 天，经当地医生针刺腹部约 10 个穴位，并在留针期间，经常提上插下和左右捻转，其中有些穴位在脐旁两侧，有的在两下腹及上腹正中部。针刺当晚即见持续腹痛，按之痛剧，伴有发热，以后日渐加重，4 天后来院求治。X 线腹部透视为两侧横膈升高，至第 7 肋后，右侧膈下可见游离气体，肠曲胀气，下腹部见有数个液平面。临床检查符合右腹股沟嵌顿疝、腹膜炎。

经过一般保守治疗后，施行疝修补术，并作剖腹探查术，发现腹腔内有大量粪臭样气体和脓液，共吸取脓性渗出液约 100 余毫升，在脐旁及脐上两侧、左下腹部等处肠袢间，有粘连脓疡 7 处，其脓液量自数毫升至数十毫升不等。仔细检查脓疡部位之肠管，均可见有毫针粗细之穿孔，少至 1 个，多至数个，且均与腹部施针部位相符。将肠壁穿孔处逐一修补，并在耻骨上置以引流，腹腔内放入青霉素 24 万单位及链霉素 1 克。术后 18 天痊愈出院^[20]。

【案例 3】

一患者，女性，50 岁，农民。因腹部疼痛八个月，无肛门排气及排便 3 天入院。患者在发病第 2 日晨，于当地在上腹部进行针灸治疗，毫针长 3~5 寸，进入深度为 $2/3$ 针长，留针 20 余分

钟，除上腹部剑突下采用如上长针 3 枚外，余均采用短针，针数不详。当日下午 4 时，原上腹部疼痛转至两下腹部，疼痛加剧并感腹胀。第 3 日在某县医院行双侧肾区封闭，疼痛未能缓解。第 5 日服中药汤剂，当晚排气 1 次，此后疼痛一直没有缓解，无排气排便。于第 8 天来我院。入院后行剖腹探查术，术中发现游离盲肠，并移行至右下腹部，呈逆时针方向扭转 320 度，盲肠无坏死。小肠普遍扩张，上段回肠可见 4×3 及 2×3 （厘米）之两处坏死穿孔；位置相当于剑突与脐之间，发现中段回肠有两处绿豆大小之圆形穿孔并列，两穿孔相距 2 厘米左右。附近肠管组织无坏死及明显充血炎症。术后经过良好^[17]。

【案例 4】

唐××，男性，51 岁，于 1973 年 8 月 20 日上午 11 点半因全腹痛、恶心呕吐而急诊入院。入院前 15 小时患者开始出现上腹不适，按之疼痛，约 1 小时后腹痛逐渐呈持续性、阵发性加剧，伴恶心呕吐，不排便，曾在公社卫生院注射过止痛剂（药名不详）。既往有胃痛史。体格检查：体温 36°C ，脉搏每分钟 86 次，血压 $17.3/9.3$ 千帕（130/70 毫米汞柱），急性病容，表情痛苦，意识清醒。腹部稍膨隆，腹式呼吸轻度受限，全腹有中等度肌紧张、压痛及反跳痛。肝脾未触及，叩诊呈鼓音，有可疑移动性浊音，肝浊音界消失，肠鸣音弱。实验室检查：血红蛋白 11 克%，红细胞 396 万/立方毫米，白细胞计数 8300/立方毫米，中性 86%，淋巴 14%。X 线检查：膈肌运动减弱，右膈下可见高约 0.5 厘米之游离积气。胃泡在左膈下约 2 横指处，左腹及右下腹可见有充气及带液平之肠襻。当时诊断为胃、十二指肠溃疡急性穿孔并发弥漫性腹膜炎。

于入院后 2 小时，行剖腹探查。术中发现回肠上段顺时针扭转 360 度，随即迅速给予复位。进一步检查时，在回肠系膜缘之肠壁有 0.8×0.6 （厘米）的新鲜瘀血区，该区的中央可见一小孔，挤压时有气体自该孔溢出，遂予间断缝合，关闭腹腔。经追问病史，方知患者于腹痛后，曾在公社卫生院作过腹部穴位的针刺治疗（穴位不明），故知该患者原系回肠扭转，针刺过深致刺破肠管，

造成肠管内气体顺针孔外溢^[35]。

【案例 5】

孟××，女性，38 岁。脐周突然阵发性绞痛，伴频繁呕吐及肛门停止排便、排气 12 小时。曾在当地施行腹部针刺治疗（共进针 10 余次），但针后疼痛更加剧烈，急来我院就诊。体检：血压 14.7/13.3 千帕（110/100 毫米汞柱），脉搏 100 次/分，急性病容，四肢厥冷，腹部隆起，腹肌紧张，上腹部可见针眼 10 多个，满腹均有压痛和反跳痛，肝浊音界消失，可闻及气过水声。腹部透视：可见大小不等之阶梯状液面 5~6 个，膈下有游离气体。诊断：①急性机械性肠梗阻；②肠穿孔；③弥漫性腹膜炎。住院后在连续硬膜外麻醉下行剖腹探查术。术中见回肠末端顺时针扭转 180 度，肠管高度充气，呈暗红色，迅速复位后，仔细检查小肠，发现有 12 个针眼，其中 5 个针眼仍不断外溢气体及液体，形成肠穿孔，逐个缝合后关腹。术后 14 天病人痊愈出院^[36]。

【案例 6】

安××，男性，28 岁。脐周突发阵发性绞痛，伴剧烈呕吐（吐出物为大量黄绿色液体）及肛门停止排便、排气 10 小时，曾在当地行腹部针刺治疗（约扎针 5~6 次），未见好转，疼痛反而扩散至全腹，急来我院就诊。体检：血压 14.7/10.7 千帕（110/80 毫米汞柱），脉搏 100 次/分，腹部隆起，可见肠型，腹肌紧张，并有压痛和反跳痛，以脐周为重，未扪及腹部肿块，可闻及气过水声。腹部透视：可见多个液平面，膈下无游离气体。诊断：①急性机械性肠梗阻；②弥漫性腹膜炎。

入院后在连续硬膜外麻醉下行剖腹探查术。术中见肠系膜根部顺时针扭转 360 度，并有 3 处 3×3（厘米）的出血斑，肠管普遍充气、水肿，距十二指肠悬韧带约 20 厘米之肠管上可见 3 个针眼痕迹，挤之无气体及液体溢出，故未作处理，整复及常规减压后关腹。术后病情逐渐好转^[36]。

【案例 7】

高××，男性，42 岁。因患肠痉挛，行中脘、天枢、神阙、足三里穴针刺治疗，取针后即感疼痛加重并发热 3 天，于 1969 年 8

月2日入院。既往健康。检查：体温38℃，脉搏86次/分，呼吸27次/分，血压13.3/9.3千帕（100/70毫米汞柱）。痛苦病容，双肺呼吸音清，肺肝浊音界于第6肋间。心律整，无杂音。腹平无肠型蠕动波，全腹肌紧张，压痛及反跳痛明显，肝脾未扪及，无移动性浊音，肠鸣音弱。化验：血红蛋白14克，白细胞15000，中性88%，淋巴12%；二氧化碳结合力45容积单位。印象：化脓性腹膜炎。

入院后，即给胃肠减压，大剂量抗生素，补充水、电解质等保守治疗。住院第2天病情进一步加重，血压下降至6.7/5.3千帕（50/40毫米汞柱），脉搏100次/分，手足发凉，示中毒性休克。在上述治疗基础上，增加血管活性药，待血压升至12.0/8.0千帕（90/60毫米汞柱），即行剖腹探查术，见腹腔充满黄色浑浊液体，有粪臭味，用吸引器吸出约750毫升；在回肠中段见一针尖大小孔，孔周壁覆盖黄白色脓苔。将孔行荷包缝合，包埋关闭，外加浆肌层间断缝合。进一步探查腹腔无其他异常后，用生理盐水冲洗腹腔，置放引流，关闭腹腔。术后继续应用大剂量抗生素，加强支持治疗。1周拆线，半月后恢复健康，痊愈出院。出院诊断：肠穿孔并化脓性腹膜炎^[2]。

【案例8】

方××，女性，71岁，于1986年9月12日入院。患者于入院前20天，因患菌痢在某医院住院治疗，约1周后脓血便消失，但仍发热伴腹痛，经抗炎、对症医治不见缓解。并于入我院前5日，由某院中医行腹部深针疗法（主穴为中脘、关元、气海等），当即病人突感腹部剧痛，呈持续性发作，拒按，伴腹胀，经治疗无效，随来我院求治，门诊以“泛发性腹膜炎，中毒性休克”的诊断，收入院。查体：体温39.4℃，脉搏128次/分，血压9.3/6.7kPa，呼吸34次/分，脉象细数，舌白苔。发育中等，营养欠佳，表情淡漠，面色苍白呈脱水外观，口唇发绀，皮肤及粘膜无黄染。心界不大，心音低钝，心律不齐（频发早搏），心率140次/分，各瓣膜未闻及杂音。腹部膨胀，腹式呼吸受限，肝脾触不清，全腹均有明显之压痛及反跳痛，腹肌似板状硬，叩之鼓音，肠音消失，移

动性浊音不明显。四肢活动自如，双下肢有凹陷性水肿。化验室检查：血红蛋白 11.3 克，红细胞 390 万/立方毫米，白细胞 3200/立方毫米，杆状 3%，分叶 70%，淋巴 23%，尿素氮 55mg%，二氧化碳结合力为 46 容积，钾 2.6mEq%，钠 136mEq%，氯 104mEq%。心电图提示：阵发性心房纤颤，右束支不完全性传导阻滞。

即刻于全麻下行急诊剖腹探查术。术中所见，腹腔内可见混浊、恶臭、黑褐色液体约 400 毫升；结肠与小肠明显胀气，小肠内有黑色粪便（似陈旧性出血）。探查回盲部见与侧腹壁粘连，其浆膜层有出血点，横结肠中部有 4 处小穿孔，最大穿孔直径约为 0.2 厘米，穿孔周围之肠壁呈炎性水肿。又探查小肠部分，见回肠有 9 处小点状穿孔，挤压肠管有气体溢出。全部肠管未见原发性炎性改变，肠系膜淋巴结不肿大。术中诊断：肠道多发性锐器伤（穿孔），泛发性腹膜炎。行常规肠穿孔缝合修补，腹腔冲洗引流术。患者手术后翌日死亡。死因：肠管多处穿孔致泛发性腹膜炎，中毒性休克，多器官衰竭^[37]。

【讨论】

针刺损伤肠道导致肠穿孔，严重者引起急性腹膜炎，有的甚至因抢救不及而死亡的事故，在临床上并不罕见。据不完全统计，从建国以后迄今已报道近 20 例，所以要正确理解针灸界“腹部深如井”的俗语，慎重操作而不可掉以轻心。虽然肠道表面坚韧光滑，当针尖轻轻触及肠管时不一定会造成损伤，加上肠管蠕动可自动躲避，故一般不易被刺中；即使万一针尖已经刺入肠管，若不乱捻乱捣面及时出针，因针孔细小也往往能自行闭合，不致发生较严重的后果。但是，在肠道病变（如肠扭转、肠梗阻、肠道炎症、肿瘤等）的情况下，由于肠道蠕动缓慢，收缩力下降，针尖刺激时避让困难，加上病理状态时肠管多扩张，表面张力增高，故深刺腹部穴位不仅容易刺入肠管，针孔很难闭合，且易使内容物溢入腹腔，发生急性腹膜炎。以上的病例，大都为肠扭转造成肠梗阻，有充血、充气，肠失去了正常的蠕动和收缩功能，肠壁变薄，内压增大，针刺易于穿孔，穿孔后内容物外溢，造成严重

的腹膜炎等后果。因此，针刺治疗急腹症时要慎重。肠包括小肠和大肠两个部分，小肠上端与胃的幽门相接，下端与盲肠相连，分十二指肠、空肠、回肠 3 个部分，盘曲于腹腔的中、下部；大肠是消化管中最末的一段，接续回肠，又分盲肠、结肠、直肠 3 个部分，如方框样围绕在空肠与回肠的周围。由于小肠、大肠几乎占据了全部腹腔，因此，整个腹部都是肠道的投影区域，在针刺腹部腧穴时，如胃经的归来、水道、大巨、外陵、天枢、滑肉门、太乙、关门、梁门，脾经的府舍、腹结、大横、腹哀，肾经的大赫、气穴、四满、中注、育俞、商曲、石关、阴都，胆经的五枢、维道、带脉、日月，肝经的章门、期门，任脉的中极、关元、石门、气海、阴交、神阙、水分、下脘、建里、中脘等，均应小心谨慎。

【临床表现】

针刺引起的大、小肠损伤，在临床特点上两者有较多的相似之处，故常将它们合在一起讨论。针刺造成肠穿孔，多出现逐渐加重的腹痛，向全腹扩散，伴有恶心、呕吐、发热等症。体检：腹部压痛明显，有反跳痛，腹肌强直，肠鸣音减弱或消失。X 线检查：腹腔内有多量游离气体（单纯肠道损伤者腹腔内积气很少）。实验室检查：白细胞计数增高。如损害严重，患者则多表现有休克的现象。

提醒注意：有时，小肠穿孔，尤其是回肠末段穿孔，在伤后早期，患者全身情况可能良好，而在数小时之后，会出现显著的腹膜炎症状，病情迅速恶化。其次，结肠穿孔，因其内容物较干，含细菌甚多，感染力较小肠为强，但刺激性则较小，故早期症状往往不显，可是感染的危险性很大，切不可疏忽大意。

【处理方法】

应根据损伤程度，采用不同的疗法。

如果单纯肠道穿孔，一般情况良好，症状极轻而无继续恶化倾向者，可以采取保守治疗。其主要措施是：①采用前倾 30~45° 体位，半卧位休息；②禁食、胃肠减压；③输液以纠正脱水和电解质紊乱；④预防和控制感染，可予庆大霉素、卡那霉素等；⑤对

症处理，在已明确诊断和不影响观察的前提下，可酌情使用杜冷丁、鲁米那等镇痛药；⑥配合针灸疗法，常用足三里、上巨虚、合谷、阳陵泉等穴，以止痛、消炎，促进漏出物的包裹和吸收，发热者加大椎、曲池，呕吐者加内关、公孙。

如果症状开始就很严重，例如严重的肠道穿孔（包括多处穿孔）引起急性弥漫性腹膜炎，或合并肠梗阻、肠扭转等，或经上述治疗反而加重者，须立即转外科手术处理，包括切除坏死或损伤过重的肠段、进行牢固的缝合等，以免贻误治疗时机。本病如及时诊断，有效治疗，一般可以治愈，否则可以危及生命。

【操作要点】

在腹部的腧穴施行针灸时，病者一般应以仰卧位为佳，并注意因人施针。如肠道病变所致的急腹症（急性肠梗阻、肠扭转、肠套叠等）时应慎选腹部穴位，有溃疡病的病人应检查是否已有穿孔存在，有肿瘤史病人应检查肿瘤的大小和位置及与肠的关系，有过腹部手术的病人应注意是否已有粘连存在等。施针的针具，一般以2寸左右的28号毫针为宜，如用火针者仅能用于浅表点刺，芒针不要用于腹部深刺，三棱针不宜使用。进针时多用斜刺或平刺透穴法，若直刺则切忌盲目深刺，应正确估计患者的腹壁厚度，使针刺深度不超过腹膜壁层。如果进针过程中有突然的落空感，则提示针尖已进入腹腔，则应立即退针至腹壁层；操作时要求刺激量宜小，速度宜慢，手法一般要轻，切忌深刺和反复捻捣、提插；留针时间要适宜，不应为寻求过强的针感或明显的疗效，而长时间的留针。

十五、腹部穴位断针

【案例1】

某患者，女，30岁。月经不调、白带多已8年，于1966～1968年间曾接受针灸治疗，以后病者自行针刺1年余。1970年4月11日自行针刺右上腹部时，因体位移动不慎将针折断，未能取出，次日感右下腹疼痛，曾去某医院急诊。经腹部X线摄片检查，显示

在骨盆右侧内有约长5~6厘米的不透光金属异物1根。体检：脐右侧有纵行排列针痕4个，局部均有出血点，每针痕处皮色发青，直径约有1厘米，腹部无压痛及反跳痛，肠鸣音存在，无移动性浊音。入院后，曾2次X线腹部摄片，均发现异物在左侧骨盆处。第3次腹部平片则显示异物部位有变化，遂决定在腰麻下开腹探取异物，但术中未找到异物（断针），腹腔内脏器均无异常。又将左侧下腹部的肠管全部暴露于手术野，在手术室摄X线腹部平片，发现异物在左侧骨盆处。最后用手指伸入肛门内，取出6厘米长之残针，术后经过良好^[38]。

【案例2】

张××，女性，50岁，农民。系精神分裂症患者。4月17日，患者在武汉市一家私人诊所行针刺治疗，取内关、中脘、鸠尾诸穴。当医生在中脘穴捻针过程中，毫针从针柄连接处折断，残端不见于体表。当时，医生和患者都十分紧张，慌乱中医生竟以酒精棉球消毒的水果刀在折针处作一小切口，希望能把残端找到取出，但由于忙中出错，切口偏上（约在实际断针处上方3厘米的上脘穴），终因没有发现目标，未能如愿。遂送××中医学院附属医院外科门诊，请求手术取针。

先试图在X线透视下取针，因腹部组织较厚，针体太细，看不到残端踪影。后经拍全腹部（以腰椎为中心）的正、侧位片，可见第1腰椎平面有一针形金属异物，与患者身体呈70°~80°角，根部位于前腹壁，走行向后，长约3厘米左右（X线片号：86—002793）。于是在局麻下，以中脘穴为中心作一长约2.5厘米的纵行切口，在肌层腹白线处探到并取出断针，为1.5寸长的针具，表面光滑、明亮，未见腐蚀、锈损^[39]。

【案例3】

某女性患者，55岁。因间断性腹痛6年，近1年来右腹脐旁可触到包块，疼痛加重，于1990年5月15日入院。自诉15年前因腹痛在村卫生所曾针刺过3次。体检：发育正常，右中腹脐旁可触到鸡卵大之肿物，移动性较差。B超提示：右中腹脐旁可探及55×45（毫米）略强回声光团，境界不清，其后无声影。术前诊

断：腹腔肿物。于5月18日在连续硬膜外麻醉下行剖腹探查术，术中见大网膜与横结肠交界处一鸡卵大之肿物，并与腹膜粘连，肿物累及结肠致结肠壁肥厚，肠腔变窄。即行肿物及结肠部分切除。结肠端端吻合。肿物重51克，色暗红色。术后取肿物标本切开时发现其内有长2.5厘米弯曲生锈的针灸针1枚。病理报告：炎性肿物。术后7天拆线，痊愈出院^[40]。

【讨论】

断针是针刺过程中发生的针身折断现象，属于针灸临床的意外事故之一。虽然由于现代针具质量的提高，这种情况不常发生，但仍有个别陆续报道，故临床对断针仍应注意。究其发生的原因，不外乎以下几个方面：针具质量粗劣，缺乏韧性，易于锈蚀，如上述例3所见；术者操作不熟练，动作粗暴、手法过重，加上进针时不按规定，将针身全部刺入体内，结果导致断针的发生，如上述例2所见；病人在留针过程中，体位突然移动，引起肌肉剧烈的痉挛收缩而导致针体折断，如上述例1所见。此外，针具使用过久或次数过频，或用酒精长期浸泡或高压消毒次数较多，使针的质量发生变化，发硬变脆；使用电针时，由于脉冲电流的作用，引起毫针电解而溶蚀、变细、生锈、发脆，甚至折断；患者思想紧张恐惧，或因针刺时不能耐受强烈的酸胀感等，亦均可引起折针，因此临床上宜谨慎从事。

【临床表现】

在非重要脏器或关节部位断针：一般多不产生严重后果。其共同特征是，断针局部有压痛，并逐渐减轻。有时断针处有重压感，活动时偶可出现疼痛，但往往无运动障碍。当断针涉及周围神经，则局部疼痛明显，其末梢处麻木、感觉减退。

关节内断针：不论在大小关节内断针，都会呈现严重的运动障碍和疼痛。如肋间关节断针，多可出现呼吸困难，胸痛；脊柱关节断针，长时间活动后有剧烈的疼痛及运动障碍。

脏器内断针：此类情况往往比较严重，常因脏器的不同，和断针部位的不同，可引起程度不同的功能障碍和疼痛。若肺部断针，则有咳嗽频数，呼吸困难，并有肋间神经痛发作样疼痛；心

脏断针，则有剧烈的心绞痛样疼痛，呼吸困难，并可迅速进入休克状态；膀胱内断针，则可引起小便短数，排出困难，或有血尿。如果针断入于血管，则可能随血液流动，自动脉血管进入较小血管，而现疼痛或有栓塞的危险。

一般说来，断针常有两种情况，一是针身折断、残端尚露在皮肤之外；二是残端完全陷入皮肉内。其结局亦大致有4种：一是断针移动后，引起有关脏器组织疼痛或功能障碍，最后只能以手术取出，或于断针后即用手术或其他非手术方法取出；二是自动向体外排出，皮肤和结缔组织的断针，许多情况下能自行从体表或从肠道和粪便一起排出；三是在体内各种理化因子的作用下，逐步发生溶解，这一般需要相当长的时间；四是断针位于机体内相对静止的部位，或因刺激周围组织发生感染，针体可为结缔组织或纤维组织所包裹，长期留在体内不变。

【处理方法】

当断针发生时，患者不可惊慌乱动，医者更不能紧张失措，而应嘱患者尽可能保持原有体位，以免针体向肌肉深层陷入，给处理造成困难。这时医生保持镇静、沉着是重要的。

如果断针残端尚在体外，则可用手指或镊子夹住取出；若残端与皮肤表面相平，肉眼可见而又不能用指甲捏出时，可用手指将断针两旁的皮肤向下按压，使残端充分露出体外，然后用镊子取出；若断针在上肢或小腿部位，如内关、外关、昆仑、太溪穴等处，针体已完全陷入肌肉内，而针尖已达对侧皮肤，则还可用手或其他物品用力按压断端针孔，使针从对侧穿透皮肤而出。

如果针体折断在重要脏器附近，或虽非重要脏器而患者自觉不适伴有功能障碍者，或由于针具、穴位皮肤消毒不严，断针带入细菌而在针道内生长繁殖已成为脓肿者，应请外科会诊，以手术取出为宜。因断针本身的重量和患者躯体的活动情况，血流动力的影响，脏器的蠕动，以及咳嗽、呼吸等情况，有时能促使断针在体内移位，故在决定手术前应作好充分估计，以X线透视或摄片（拍正、侧位片）准确定位，然后用手术寻获。

【操作要点】

为了预防断针情况的发生，在进行针灸疗法时，应从以下两个方面做好工作：第1，要加强针前的准备。定期更换使用时间过长的毫针，不使用弯曲、生锈或有其他损伤的针具，进针前要仔细检查；应用电针疗法前，对电针仪应作选择，尽量不用直流电针仪，使用新的电针仪器及仪器使用过一段时间以后，应检查是否有直流成分混入；第2，要强化操作规范，进针手法以双手进针法为佳，在刺入或拔针过程中，遇到滞针、弯针等情况，不宜强行进针或拔出，可细心缓慢改变针的方向刺入或稍待片刻再拔针；针刺到所需深度后，无论是行针还是留针，都不能将针体全部插入穴内，至少应留0.5厘米以上于皮肤外面；使用电针仪时，对其输出的电流强度、频率和波型，都应该注意给予调节，而作长时间的电针治疗，则在通电约1~2小时以后，应将同组输出的两根导线极性交换一下，交换通电的时间大致相仿。此外，医生和病人应密切配合，对精神紧张或不乐意接受针刺治疗者，应予细心解释，解除其心理负担，争取合作；针刺前应充分揉按穴区，以使局部肌肉松弛，切忌突用暴力；凡欲留针，则必须告诉病人不得随意改变体位，以免引起断针。

十六、中脘穴位注射引起晕针

【案例】

周××，女性，31岁，营业员。胃脘部疼痛10年加重半个月，经纤维胃镜检查示：“慢性浅表性胃炎伴胆汁返流”。患者时觉胃脘胀痛，尤以夜间明显，纳谷不香，形体消瘦，头晕失眠，经用黄芪注射液4毫升加当归注射液4毫升加胎盘注射液2毫升混合，分别注射双侧肝俞、胃俞、足三里等穴治疗，症状有所缓解。但在次日复诊中，用局麻针头将上述药物混合注射入中脘穴，其方法是进针约1寸，提插后取得较强针感，注药2毫升。出针后患者即觉胃脘疼痛加重，伴有胸闷心慌，呼吸急促，四肢厥冷且轻度抖动。心率120次/分，呼吸30次/分，血压17/12kPa，神清，紫绀不明显，腹软，剑突下压痛，无明显反跳痛及肌紧张。立即

吸氧，并针内关、足三里，艾灸神阙，约半小时后胃脘疼痛缓解，胸闷气急消失^[41]。

【讨论】

晕针是针灸临床上最为常见的一种不良反应，它虽然不会造成对机体的器质性损害，但也应引起足够的注意。临床上引起晕针的原因很多，如患者的体质虚弱、营养不良，或者过于饥饿、疲劳，或者大病初愈、元气亏虚，或者精神紧张、惶恐不安，或者术者操作手法过重、超过病人所能接受的限量，或者操作时病人的体位不适（多数发生于坐位或立位，卧位极少见）等，均可导致晕针。上述案例的病者，由于患有慢性疾病，平素身体虚弱，加上施行药物穴位注射时，有可能医者手法过重，给予过大的刺激量而致。究其发生的机理，主要是由于穴位注射刺激通过神经反射，引起全身外周血管（尤其是周围肌肉的血管）扩张，外周血管阻力降低，回心血量减少，因而心脏输出量减低，血压下降，造成一时性、广泛性的脑供血不足或脑缺血所致。

【临床表现】

晕针大多发生于针灸过程中，但也有少数病人在取针后数分钟始出现症状。典型的晕针一般可分为3期。

先兆期：病人有各种感觉的错乱，如眼花，耳鸣，头昏，心悸，出冷汗，打呵欠，恶心欲吐等。但也有些病人先兆期不甚明显。

发作期：轻者出现胸闷，头晕，恶心呕吐，肢体发软发凉，摇晃不稳，或伴瞬间意识丧失；重者突然昏仆在地，唇甲青紫，大汗淋漓，面色灰白，双眼上翻，二便失禁，少数患者可伴有惊厥发作。

恢复期：轻症仅有轻度不适，多数患者可有显著疲倦，头昏，嗜睡，汗出及全身不适感，短则几分钟，长则几小时，症状才能逐渐恢复。

此外，根据临床症状，又可将晕针分作轻、中、重3度，以轻度和中度晕针多见。轻度晕针：针刺时患者自诉头晕目眩，胸闷乏力，但呼吸脉搏仍正常。中度晕针：头晕心慌，恶心欲吐，脸

色苍白，汗出肢冷，脉搏变细。重度晕针：患者全身厥冷，大汗淋漓，血压下降，脉搏细弱，呈现昏厥状。

【处理方法】

1. 常规护理：迅速将针取出，扶患者至空气流通处，并让其仰卧在床上，头低脚高位；及时松解患者衣带，热天注意通风，冷天注意保暖；立刻测量其呼吸、血压、脉搏以及心率，了解其生命体征。

2. 轻者一般静卧片刻即可，如患者仍感不适，可给予温糖水或热茶口服，并注意使之安静和休息，约 3~5 分钟后即可逐渐恢复。

3. 重者可在上述处理的基础上，用指掐或针刺人中、素髻、足三里、涌泉，或艾灸百会、关元、气海等穴；或嗅以氨水；必要时可用肾上腺素 1 毫升、阿托品 1 毫克肌注，或 25% 葡萄糖液 40 毫升静脉推注等。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：由第 8 肋间神经分布。

2. 皮下组织：内有第 8 肋间神经和胸腹壁浅静脉（它是腋静脉的属支）。

3. 腹白线或腹直肌：腹白线位于腹部正中线上，由两侧腹直肌鞘纤维彼此交织而成，上起自剑突，下止于耻骨联合上缘。腹直肌位于腹直肌鞘内，该肌由肋间神经支配。

【操作要点】

晕针是针刺意外中最常遇到的一种类型，虽然大多数患者的预后是良好的，不会留有后遗症，但我们仍应给予足够的重视，尽量避免或减少这种情况的发生。一般而言，为了防止穴位注射时出现晕针，操作时要注意以下几点：

1. 心理预防：对针灸有猜疑、恐惧心理者，或操作时有哭笑、惊叫战栗、躲避、肌肉痉挛，伴有呼吸、心跳、皮温、面色、出汗等植物神经系统和内分泌功能改变者，均应作心理预防，其方法一共有 3 种，即语言诱导、松弛训练和转移注意力（具体详见第二章）。

2. 生理预防：任何年龄都可发生晕针，但以年老体弱者最为易发，故施术时应尽量采用卧位，且手法不宜过强。饥饿者，穴位注射前应适当进食；过度饱食者，亦需待食物有所消化后方可操作。过度疲劳，或激烈活动后，都应让患者稍加休息，待其体力基本恢复再给予治疗。

3. 起针以后，一般应令患者在诊室休息 10~20 分钟后始可离开，以防延缓性晕针的发生。

十七、氦氖激光照射发生光针反应

【案例】

荆××，女性，78 岁。患者腹部及左侧腰部疼痛，进行性加重 5 天，夜间因疼痛不能入睡，前天开始局部皮肤出现红疹，既往有冠心病史。检查：少腹部及左侧季肋部、腰部见有片状红斑、丘疹，上布密集米粒至绿豆大小成簇水泡，基底发红灼热。诊断为带状疱疹。治疗：取坐位，用 JG-1 型氦氖激光治疗机，输出功率 25 毫瓦，散焦照射皮损部位，照射距离 1 米左右。每处皮损部位各照射 5 分钟。12 月 15 日复诊，昨天照射后少腹部疱疹颜色已变紫暗，少数疱疹已干涸，余证依然，激光治疗方法同昨天。当照射至 15 分钟将要结束治疗时，病者出现心慌、头昏、眼黑、出冷汗、欲吐等症状。立刻停止照射，让病者平卧在床上，头低足高位。查体：面色苍白，心率 46 次/分，心音低，血压 10/4kPa，脉沉极微。病者仰卧 10 分钟后，诸症消失，血压 16/8kPa。16 日三诊，激光治疗同前，未出现反应，照射后加三棱针点刺左蛇眼穴放血。17 日四诊，治疗同前，当照射 10 分钟时，病人又出现上述晕针现象。处理与前次相同。18~23 日照射时取侧卧位，均未出现任何反应。前后共照射 10 天，疱疹大部分干涸结痂，疼痛基本控制^[42]。

【讨论】

低功率激光治疗是被誉为“光纤维素”和“生物过程的催化剂”的新型疗法，自 70 年代在临床应用以来，已被证实具较佳的

疗效和广阔的应用前景。但氦氖激光照射引起的全身性激光反应，临床上亦时有报道，这可以说是治疗中的意外情况。其反应症状类似晕针。引起光针反应的确切原因和发病机理，目前尚未有一致的看法。笔者认为这主要是由于氦氖激光治疗机的长时间照射，对人体产生了强烈的刺激，通过迷走神经的反射，引起全身外周小血管的扩张，外周血管阻力降低，回心血量明显减少，从而导致心脏输出量降低，血压下降，造成一时性、广泛性的大脑供血不足所致。

【临床表现】

临床症状既可于照射后马上发生，也可在2~10小时内出现反应。一般分为局部反应和全身反应两种。局部反应：多以局部病变处不适为主。全身反应：恶心，胸闷，心慌，烦躁，出冷汗，面色苍白，甚至口唇青紫，意识障碍及小便失禁等，女性患者尚可导致月经不调。全身反应一般持续半小时至2个小时，亦有数日才消失的。

【处理方法】

1. 常规护理：迅速关机，并将患者扶至空气流通处，让其平卧于床上，松解衣带，注意呼吸、血压、脉搏、心率等情况。

2. 轻者多不需处理，静卧片刻即可，或给予热水口服。如局部麻木不适且持久不消的，可服用B族维生素等药物。

3. 重者可在上述处理的基础上，用指掐或针刺人中、素髻、涌泉、足三里，或艾灸百会、关元、气海等穴；必要时可用肾上腺素1毫升、阿托品1毫克肌注，或用50%葡萄糖液40毫升加维生素C1克静脉推注等。

【操作要点】

激光穴位照射治疗疾病的方法，相对而言是比较安全的，而且还有无痛、无感染、无损害等优点，但它也有引起机体不良反应的可能（发生率在2.25%~4.7%之间），因此临床使用时要给予足够重视。一般来说，为了预防光针反应，在不影响疗效的情况下，多主张采用较低功率的输出，注意掌握其强度，尤其是在头面部、腹部等处照射时；其次，要控制照射时间，注意询问病

人有无不适，随时注意其异常情况，一旦出现上述临床症状即应暂停治疗；最后，不是非常必要的情况，一般光针疗法不要合用其他疗法，以便减少不良反应的发生率。

十八、关元穴晕灸

【案例】

谭××，男性，14岁，学生，1989年4月8日来诊。患者于1天前因饮食不洁而致腹泻，每天约7、8次，泻下脓血便，里急后重，肛门灼热，舌红苔黄，脉滑数。给予艾条用固定式熏灸器灸关元穴，熏灸至1小时之时，患者突觉头昏，心慌，恶心欲呕，面色苍白，大汗出，脉搏加快。当即停灸，给予针刺双内关穴，约5分钟后心慌减轻，留针20分钟，诸症消失^[43]。

【讨论】

晕灸是临床上较为少见的针灸意外事故，究其发生的机理，主要是艾灸的刺激过强，引起超抑制所致。即因艾灸的强刺激，通过迷走神经的反射，引起全身外周血管（尤其是周围肌肉的血管）扩张，外周血管阻力降低，回心血量减少，因而心脏输出量减低，血压下降，造成一时性、广泛性的脑供血不足或脑缺血所致。本节案例的患者因腹泻，导致水谷精微生化不足，气血虚亏，滋养心神之力不足，神气随之亦虚，加上术者采用位置固定、作用集中的艾条熏灸，从而发生超限刺激，导致晕灸。

【临床表现】

晕灸多数发生于针灸过程中，典型者可分为3期，先兆期：病人有各种感觉的错乱，如眼花，耳鸣，头昏心悸，出冷汗，打呵欠，恶心欲吐等，但也有些病人的先兆症状不明显。发作期：轻者出现胸闷，头晕，恶心呕吐，肢体发软发凉，摇晃不稳，或伴瞬间意识丧失；重者突然昏仆在地，唇甲青紫，大汗淋漓，面色灰白，双眼上翻，二便失禁，少数患者可伴有惊厥发作。恢复期：轻症仅有轻度不适，多数患者可有显著疲倦，头昏，嗜睡，汗出及全身不适感，短则几分钟，长则几小时，症状才能逐渐恢复。

【处理方法】

1. 常规护理：迅速停止施灸，扶患者至空气流通处，并让其仰卧在床上，头低脚高位；及时松解患者衣带，热天注意通风，冷天注意保暖；立刻测量其呼吸、血压、脉搏、心率，了解其生命体征。

2. 轻者一般静卧片刻即可，如患者仍感不适，可给予温糖水或热茶口服，并注意使之安静和休息，约3~5分钟后即可逐渐恢复。

3. 重者可在上述处理的基础上，用指掐或针刺人中、素髻、足三里、涌泉，或艾灸百会、关元、气海等穴；或嗅以氨水；必要时可用肾上腺素1毫升、阿托品1毫克肌注，或用50%葡萄糖液40毫升静脉推注等。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：由肋下神经前皮支的内侧支分布。

2. 皮下组织：分布有肋下神经前皮支的内侧支和腹壁浅动、静脉。腹壁浅动脉为股动脉的分支，越腹股沟韧带的前面上升至脐平面，分布于腹前壁皮肤和浅筋膜。腹壁浅静脉为大隐静脉的属支。

3. 腹白线或腹直肌：腹白线位于腹部正中线上，由两侧腹直肌鞘纤维彼此交织而成，上起自剑突，下止于耻骨联合上缘。腹直肌位于腹直肌鞘内，该肌由肋间神经（第6至第12胸神经组成）支配。

【操作要点】

晕灸现象在临床上比较少见，且多数患者不经任何特殊治疗也可自行恢复，但平时施灸时仍需尽量避免，特别对久病体弱者更是如此。一般来说，临床上应注意以下几点：首先应考虑病人的体质与疾病情况，是否适合艾灸治疗。对平素身体虚弱，或疲劳过度，或处于饥饿、大吐、大泻、大汗、大出血情况下的患者，施行艾灸疗法应慎重；其次，对初诊或紧张的病人，宜做好解释工作，解除其对艾灸的顾虑，以期使患者能接受并做好配合；再次，施灸时尽量采用卧位，且施灸部位不宜长时间固定于某处，以

局部皮肤潮红为限度，临床上以移动式悬灸较稳妥；最后，在整个治疗过程中，医生要严密观察患者的神色、表情、脉象等方面的状况，一旦有晕灸的先兆症状，即应立即处理。

十九、针刺大椎穴导致脊髓损伤

【案例 1】

某一患者，男性，31 岁。患精神分裂症（猜疑型），曾做过胰岛素休克和电休克等数 10 次，尚有自杀企图和对女性缺乏礼貌等行为。曾在当地医院诊治，予针刺大椎、无名、风府、身柱各多次，均刺及脊髓，自杀行为已不明显，但针后发生左脚跛行，3 个月未恢复，尿潴留 3 天^[44]。

【案例 2】

李××，女性，30 岁。1969 年下半年开始有精神不正常表现，但未介意。1970 年 3 月因精神症状发展严重，出现幻听、幻视、幻嗅面入院治疗，诊断为幻想型精神分裂症。入院后擅自外出，追回后由一非正式执业的医生用粗大针灸针，于大椎穴强行刺入。针入后，患者立即昏倒，神志不清，四肢瘫痪，经 3 小时后逐渐清醒，50 天后左上肢活动逐渐恢复，稍能握物，100 天后稍能起床活动，臀部有多处大块褥疮，大小便一直失禁，下肢麻木，右侧为重，走路蹒跚，起坐困难，但精神症状却依然未减。自 1971 年 4 月至 1980 年 10 月，先后住院 11 次，曾用氯丙嗪、奋乃静、中药等治疗均无显效，步履移动缓慢。

1980 年 10 月 20 日体检：病者仍住精神病院，表现为情感幼稚，生活散漫而不能自理，思维内容凌乱，有时答非所问，无自制力。走路缓慢，尿失禁，大便有时不能自控。双膝反射亢进，巴氏征阳性，无髌及踝阵挛，肱二、三头肌及桡反射活跃，腕踝关节以下肌肉明显萎缩，皮肤体温较低。1982 年冬季随访，已是脊髓刺伤后第 13 年，肢体活动同上始终没有恢复，精神症状如前^[45]。

【案例 3】

某一女性患者，30 岁。患精神分裂症 7 年，于 1970 年 1 月 3

日入院。2月3日11时10分，行第7次针刺治疗，于大椎穴进针，通电0~3毫安，约3~4分钟仍无反应。因故暂停，后又将电流增至6~7毫安，并行节律性刺激4~5次，再通电3~4分钟。突然发现病者四肢软瘫，紫绀，急取针翻身急救，12时40分死亡。尸解发现在颈、胸脊髓正中有一针刺小孔，未见出血，局部脊髓外观无其他异常^[17]。

【讨论】

脊髓是中枢神经系统的一部分，位于椎管内，呈前后稍扁的圆柱形，外包以被膜，上端在枕骨大孔处与延髓相连，下端尖削呈圆锥状止于终丝。从脊髓实质到椎管壁之间有软脊膜、脊髓蛛网膜、硬脊膜3层，而从椎管壁至体表还分别有黄韧带、棘间韧带、肌肉、皮下组织等结构，故临床进针时应以黄韧带为限，否则有伤及脊髓的可能。当针体刺入大椎穴的深度过大时，针尖则易先后穿过硬脊膜、脊蛛网膜、软脊髓而伤及脊髓。上述3个案例，正是由于过度追求深刺以期获得较好疗效，加上精神病患者常不能正确反映针感，结果导致脊髓的损伤，从而引起脊髓功能障碍的一系列严重表现。

【临床表现】

脊髓针刺损伤所出现的症状、体征与脊髓损伤的程度有关。

如仅触及脊髓、损伤较轻者，多表现为脊髓震颤，如全身酸痛、胀麻，四肢无力，甚则头晕或暂时性知觉丧失、瘫痪等脊髓一过性传导障碍，但经数分钟、数小时或数日之后即能完全恢复。

如针体直接刺入脊髓，造成较大的损伤，则会出现脊髓挫裂伤，呈一侧或双侧下肢不完全性瘫痪，病人不能行走或呈跛行步态及感觉迟钝等症状。如果脊髓损伤严重，则可见损伤部位所支配的肌肉出现麻痹，大小便失禁，各种反射消失，感觉亦消失，体温升高，血压下降，脉搏频数等脊髓休克症状。

【处理方法】

1. 头晕、四肢乏力时，应让患者平卧体息，并饮以热茶或糖水等。

2. 伴高热头痛者，可用解热镇痛药，如扑热息痛、安乃近等。

3. 肢体运动障碍的恢复，需时约数周或数月，可配合理疗或针灸疗法，取穴以局部和邻近为主。

4. 为促进恢复，可给予复合维生素 B₁₀ 毫克，1 日 3 次；或舒筋活络丸，每次 1 丸，1 日 3 次。

如果脊髓损伤严重，有脊髓体克或脊髓内外血肿，症状逐渐加重者，应请有关科室给予综合治疗。

在脊髓损伤的恢复期，临床上还可根据患者下肢运动的情况，作出观察其恢复时间的参考。据报道：如病人搀扶行走时，一侧下肢运动困难，但向前迈步能超过健侧足尖时，一般可在 1~3 天内恢复正常；一侧完全无力行动时，则在 3~5 天内恢复；双侧下肢运动障碍，但膝关节能向前用力时，一般在 1~2 周即可恢复；若双下肢完全瘫痪而无力活动者，则须 1 个月左右方能恢复。不过，当脊髓损伤极其严重时，也可出现永久性损害，终身瘫痪，甚至死亡。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：由第 8 颈神经后支的皮支分布。
2. 皮下组织：有上述皮神经的分支通过。
3. 斜方肌腱：两侧的斜方肌腱于此处汇合并附着，斜方肌由副神经及第 3、4 颈神经前支支配。
4. 棘上韧带：由第 8 颈神经后支的内侧支分布。
5. 第 7 颈椎棘突与第 1 胸椎棘突间的棘间韧带：由第 8 颈神经后支的内侧支分布。

【操作要点】

大椎穴的深面有脊髓，针刺时要掌握好进针的深度，稍有疏忽则极易损伤脊髓。临床一般宜针刺 0.5~1 寸，以微斜向上直刺为佳，务必谨慎从事；其次，术者要熟悉大椎穴不同层次的手下针感，因为当针刺过深面穿过弓间韧带（黄韧带）后，将会有针尖阻力突然消失的空松感，此时即是进针的深度极限，应立即停止进针，否则易损伤脊髓；再次，当病人的脊髓被刺中后，病人会有强烈的触电感（正常针感是局部酸胀且向下或向两肩部扩散），并有神志惊恐、惊跳，这时要马上退针，切勿再作提插捻转，

并注意观察病人变化；最后，凡精神躁动病人，针刺该穴时应固定体位，谨慎操作，尽量不留针；当病人有挣扎或拒针时，最好不要强用此穴。

二十、定喘穴针刺不当致气胸

【案例 1】

姚××，女性，25 岁。因哮喘反复发作 2 年，于 1975 年 3 月 5 日来我室治疗。取双侧定喘穴，每日针刺 1 次。在第 6 次针后 10 余分钟，患者自觉胸闷、气短，听诊左肺呼吸音减弱。胸透：左侧胸腔外带有 1/4 气体。诊断：左侧外伤性气胸。收住院治疗^[46]。

【案例 2】

赵××，男性，57 岁。因哮喘反复发作 10 余年，于 1969 年 4 月 15 日来我室治疗。取双侧定喘穴，当针右定喘穴出针后，患者即感右侧胸痛，呼吸困难。检查：口唇发绀，叩诊右胸呈过度清音，右肺呼吸音明显减弱。胸透：右胸腔有 2/3 气体。诊断：右侧外伤性气胸。收住院治疗^[46]。

【案例 3】

李××，女性，26 岁。于 1970 年 5 月 6 日因患支气管炎，行定喘等穴针刺治疗，取针后即感胸闷、气短而急症入院。既往健康。检查：体温 36.5℃，脉搏 84 次/分，呼吸 33 次/分，血压 17.3/10.7 千帕（130/80 毫米汞柱）。发育营养好，气喘状态，口唇无发绀，气管偏右，甲状腺不大。左侧胸部呼吸动度弱，语颤降低，叩诊呈鼓音，呼吸音明显减弱。心浊音界消失，心音弱，心律整，未闻及杂音。腹平软，肝脾未触及。化验：血红蛋白 15 克，白细胞 7000，中性 70%，淋巴 30%。胸部 X 线透视：左侧高度透明，肺纹理影消失，仅在肺门部见被压缩的肺组织边缘，肺组织压缩约在 90%，纵膈向右侧移位。诊断：气胸。入院后给予卧床休息，抗生素控制感染，闭式插管排气治疗。3 天后症状消失，查体正常，胸部 X 线透视左肺复张，痊愈出院^[2]。

【案例 4】

李××，女性，59岁。因慢性支气管炎而咳嗽、咯痰，要求为之针刺治疗。即予针定喘诸穴，约15分钟左右，患者诉胸闷，头晕，当时未引起医者重视。出针后再于背部吸罐，患者渐现呼吸急迫，唇紫，以为是晕针所致，遂开窗通风、摇扇等，症状有增无减，才疑气胸。放射科透视见右肺压缩50%，急送上级医院救治，终因抢救无效而于当天死亡^[47]。

【讨论】

针刺不当引起气胸，是针灸科临床上最常见的意外事故之一。上述4个案例，主要原因均是由于术者操作时针刺角度不当、针刺过深，针尖深入达脏层胸膜和肺脏，从而损伤胸膜和肺脏，致使空气经其裂口进入胸膜腔而产生气胸。根据现代解剖学，肺脏位于胸腔内，外形为半圆锥体状，上端为肺尖，向上突出于第1肋，下面为肺底，接触膈肌之穹窿面，外侧面紧贴于胸壁，内侧面与纵隔相邻；肺脏在体表的投影，其上界前面在锁骨上2~3厘米，下界可随呼吸运动而改变，正常人吸气时于锁骨中线的第6肋间，腋中线在第8肋间。而肺脏的表面由胸膜所覆盖，胸膜分为脏层和壁层，两层之间形成一密闭负压的腔隙即胸膜腔，当深刺时针尖则易穿透胸膜伤及肺脏，导致气胸的发生。故针刺定喘穴时，应熟悉所在的解剖位置，掌握好针刺的方向、角度和深度，提插幅度也不宜太大，以防出现针刺意外。

【临床表现】

针刺引起的气胸，其发病的缓急和临床症状的轻重，均取决于肺组织损伤的程度、肺萎陷的程度、病人的敏感度及其原来的肺功能状况，一般可将它分为轻、中、重3型。

轻度气胸：无明显的自觉症状，或有轻微的胸闷、咳嗽，活动时胸部有牵拉样痛。

中度气胸：胸肋刺痛，胸闷不舒，呼吸困难，持续剧烈的咳嗽，心悸不宁，尚有相应的肩背部、上肢沉痛以及活动受限等。

重度气胸：病人突然感到被针侧胸背部剧烈刺痛，并可向同侧的肩背、手臂放射或向上腹部放射，接着出现气促、呼吸困难，并随着气体的进入而胸内压上升逐渐加重，还有紫绀、烦躁、出

汗、肢冷、昏迷等。体检见，呼吸频率加快，心率加快，可有鼻翼煽动；气管偏向健侧，患侧肋间隙饱满，呼吸活动度及语颤减少；叩诊呈过清音或浊鼓音；呼吸音减弱或消失，健侧呼吸音增强。X线检查，气胸部分透亮度增加，无肺纹，肺向肺门收缩，成透明团块，其边缘可见发绒状阴影的脏层胸膜，肺萎缩程度可从10%~90%不等。

【处理方法】

气胸发生后，要及时给予治疗，切不可抱任何观望或侥幸的态度，以免贻误病情，临床上根据胸腔积气的情况和肺脏被压缩的程度，而采取不同的治疗方法。

轻度气胸（肺萎缩在10%~20%之内，肺部无肺气肿等病变者）：在严密的观察下，令病人休息数天，不做特殊治疗，或根据症状酌给予镇咳、止痛剂。为防止胸膜腔内发生感染，可考虑予以适量的抗生素。假如病情不再发展，少量气体多可自行吸收、痊愈。

中、重度气胸（肺萎缩在20%以上，或伴有肺气肿等病症者）：应马上令病人卧床休息，保持安静。并用人工气胸器测压抽气，即在患侧的锁骨中线第2肋间，或腋前线第4~5肋间，常规消毒后穿刺排气，每次不必全部排尽，抽气量的多少以胸腔内压力降至“0”上下为准，必要时可重复抽气。如果无人工气胸器，为了抢救病人的生命，可在上述部位用50毫升消毒注射器抽气，以缓解气急；或用较粗的注射针头，消毒后从上述部位插入胸腔，让气体从针尾部排出。若经过以上处理，但气胸症状仍不减轻者，应请有关科室会诊处理，必要时应给予手术治疗。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：由第8颈神经后支的内侧支支配。
2. 皮下组织：有上述皮神经的分支通过。
3. 斜方肌腱：由副神经及第3、4颈神经前支支配。
4. 菱形肌：该肌由肩胛背神经支配，到该肌的神经纤维由第4、5颈神经组成。
5. 颈夹肌：由第2、3、4、5颈神经后支的外侧支支配。

6. 上后锯肌：由第 1、2、3、4 肋间神经支配。

7. 竖脊肌：由脊神经后支节段性支配，到穴区肌肉的神经主要是第 8 颈神经后支的外侧支和第 1 胸神经后支的外侧支。

【操作要点】

施行针刺前，宜嘱病者取坐位或俯卧位，尽量固定其体位，否则刺入体内的针体会因患者体位的改变，在肌肉的牵拉收缩下随之活动，而损伤及肺脏。进针时，应向内斜刺 0.5~1 寸，勿直刺或向外斜刺（因为穴区深面及外侧部肌肉较薄，针尖易经肋间隙刺穿胸壁而造成气胸）。施术手法不宜过重过强，有针感后即可出针。若针感不明显时可稍留候气，或用小幅度内捻转手法来激发针感。出针后要稍按压针孔片刻，如有条件，则应让病人在诊室内休息 15~30 分钟后，没有不适情况再走。

二十一、肩井穴针刺不当导致气胸

【案例 1】

某一女性患者，41 岁，患有头痛 20 余年。某日在当地卫生所求治，医师即以两枚长约 4.5 厘米之毫针，隔衣自两侧“肩峰中点”（即肩井穴）刺入。数小时呼吸困难，心窝处跳动，脉搏 25 次/分。赴医院途中死亡。尸检主要发现：左右肩峰点有 0.2 厘米大小之紫红色针刺点。分离胸前皮肤，其间注以清水，刺破胸壁，见两侧胸腔有大量气泡冒出。两肺显著萎缩。死因：隔衣进针，刺破胸膜脏层，发生两侧气胸，因窒息而死亡^[48]。

【案例 2】

辛×，男性，27 岁。患者因颈肌痛在针灸科接受治疗，针灸 2 次后症状明显减轻。第 3 次针刺，取穴头维、听会、新设、肾俞、志室、肩井（均左侧），嘱取俯卧位，垂直捻转进针，针深 4~5 厘米，予中等刺激，留针半小时。针后数日，逐渐出现左胸痛、气短、咳嗽，来内科就诊。X 线照片发现左侧气胸，左肺压缩 20% 左右，肺野未见异常病变，诊断为针刺所致创伤性气胸。当即给予止痛药，嘱回家休息。2 周后，气胸全部吸收^[8]。

【案例 3】

张×，男性，36 岁。因左肩痛、左上肢发麻在针灸科治疗，穴取大椎、风池、肩髃、曲池、肩井等，取俯坐位，当针刺左肩井穴时，患者左肩耸了一下，随即感觉心跳、气促，类似出现休克症状。即起针，数分钟后见好转。次日，以左胸痛、咳嗽、气促来院复诊，经 X 线胸部照片，发现左侧气胸，肺组织压缩约 10%，住院治疗。入院后除给予止咳药，未作特殊处理。6 天后，症状减轻出院。1 月后复查，气胸吸收痊愈^[8]。

【案例 4】

某患者，因左肩背针刺后，左胸持续性疼痛，呈进行性加重 26 小时入院治疗。入院前 1 天因左上肢、肩背、胸部麻木、疼痛，于当地卫生所针刺左肩井、肺俞、肩髃、肩髃、天宗等穴，后又行梅花针及拔火罐。半小时后左胸更痛，呼吸时尤甚，但无畏寒、发热、咳嗽、咯痰等，2 个小时后胸透未见异常，留所观察。胸痛逐渐加重，出现憋气，不能平卧。次日上午听诊呼吸音减弱，透视左胸腔少量积液，肋膈角变钝，可见气液平面，入院诊断：少量液气胸。体检：血压 17.3/8.0 千帕（130/60 毫米汞柱），呼吸每分钟 22 次，脉搏每分钟 92 次，急性痛苦病容，端坐位，神清合作，唇不绀紫，颈静脉充盈正常，颈动脉搏动无异常，气管轻度右移，左胸下部稍饱满，呼吸运动减弱，压痛明显，左前胸第 5 肋间以上呈过清音，左肺底实音。左肩背皮肤可见多个针刺点及密集梅花针刺小点。血色素 10.2 克。

入院当晚血压 13.3/9.3 千帕（100/70 毫米汞柱），呼吸每分钟 26 次，脉搏 92 次/分，面色苍白，大汗淋漓，脉细速弱，心音弱，心慌。第 3 日上午胸透发现左胸腔积液平第 6 肋间，积气甚少，血红蛋白 8.2 克，下午于左腋后线第 9 肋间抽出全血 1300 毫升，立即输血 400 毫升，补液 1300 毫升。第 4 日上午行超声波探查，左腋后线 8~10 肋间探及 5 厘米液平段，血红蛋白 6.3 克，红细胞 200 万/立方毫米。当即开胸探查，左胸腔内有鲜血及血凝块 1200 毫升，胸腔顶部，第 1 肋间肩胛骨内侧有一针眼，其周围组织水肿、糜烂，有少量渗血；肺尖部有一直径 0.5 厘米之肺胸膜

损伤，未见漏气及出血，给以缝合止血。术后情况良好，伤口一期愈合。住院1个月，经多次胸透未见异常后出院，血色素恢复正常^[49]。

【案例5】

胡全轩报道，在其所收治的7例创伤性气胸中，有2例分别是针刺左右肩井穴引起的。均见有胸痛、胸闷、气短及不同程度的呼吸困难；体检一般均见呼吸次数增多，心率增快，气管向健侧移位，触诊患侧语颤减弱或消失，叩诊患侧呈鼓音，听诊患侧呼吸音减弱。经治疗获痊愈^[7]。

【案例6】

李××，女性，26岁。于1970年5月6日因患支气管炎，行肩井等穴针刺治疗，取针后即感胸闷、气短而急症入院。既往健康。检查：体温36.5℃，脉搏84次/分，呼吸33次/分，血压17.3/10.7千帕（130/80毫米汞柱）。发育营养好，气喘状态，口唇无发绀，气管偏右，甲状腺不大。左侧胸部呼吸活动度弱，语颤降低，叩诊呈鼓音，呼吸音明显减弱。心浊音界消失，心音弱，心律整，未闻及杂音。腹平软，肝脾未触及。化验：血红蛋白15克，白细胞7000，中性70%，淋巴30%。胸部X线透视：左侧高度透明，肺纹理影消失，仅在肺门部见被压缩的肺组织边缘，肺组织压缩约在90%，纵隔向右侧移位。诊断：气胸。入院后给予卧床休息，抗生素控制感染，闭式插管排气治疗。3天后症状消失，查体正常，胸部X线透视左肺复张，痊愈出院^[2]。

【案例7】

王××，女性，50岁。因患支气管炎行肩井、肺俞、天突诸穴针刺治疗，拔针后即感胸痛、气憋、呼吸困难，于1981年8月6日急症入院。既往健康，无心肺疾病。检查：体温37℃，脉搏90次/分，呼吸30次/分，血压18.7/10.7千帕（140/80毫米汞柱）。发育营养一般，端坐呼吸，口唇无发绀，气管居中，甲状腺不大。左胸呼吸动度减弱，语颤降低，左上胸部叩诊呈鼓音，6肋间以下叩诊呈浊音，呼吸音明显减弱。心尖搏动不明显，心音弱，心律整，无杂音。腹平软，肝脾未触及。化验：血红蛋白13克，

白细胞 9200，中性 82%，淋巴 18%，血小板 25 万，出凝血时间各 2 分。心电图检查正常。胸部 X 线透视：左上气胸，肺组织压缩约 20%；左 6 肋间以下密度增高，可见液面。诊断：液气胸。入院后给予抗生素控制感染，胸腔穿刺，抽出气体 1000 毫升、血性积液 800 毫升。观察 1 周后症状消失，查体正常，胸部 X 线透视除见左肋膈角变钝外，余无异常。痊愈出院。修正诊断：血气胸^[2]。

【案例 8】

据报道，在其收治的针刺致气胸 18 例患者中，因针刺肩井穴及肩部穴位引起气胸的有 5 例，其临床表现各有不同，多出现于施针过程中或拔针后不久。经对症处理，均获痊愈^[14]。

【案例 9】

张××，女性，50 岁。左肩关节痛 2 周，经查为肩关节周围炎，在当地隔毛衣、衬衣针刺肩井、肩髃、曲池、合谷等穴，入针后不久即感胸闷、气促而出针。X 线透视见左肺压缩约 20%，诊为气胸。

另，吴××，女性，62 岁。右颈肩部酸痛月余，一针灸医生下乡巡回医疗路经田头，嘱患者站立于田边，为之针刺肩井、风池、后溪。因患者觉脱衣不雅，故仅将衣领后拉，即针肩井，2 小时后诉胸部闷痛渐剧，经 X 线摄片为气胸，右肺压缩 20%^[47]。

【案例 10】

宋×，女性，45 岁，助理工程师。患有慢性支气管炎和冠心病，于 1988 年 10 月 5 日来诊。由于针刺肩井方向和深度失当，翌日复诊时病人觉得病情不见好转，反而心烦不安，未引起医生注意。又针肺俞和肾俞等穴，病人仍不见好转。终因救治失误而死亡。解剖后发现有多脏器损伤^[1]。

【案例 11】

某男性患者，21 岁，工人。因针刺后左侧胸痛，呼吸困难 4 小时，于 1982 年 6 月 29 日入院。患者因晚上睡眠时左侧颈部“落枕”，次日上午作针刺治疗，以 2.5 寸长的针一根，取风池、肩井等穴，并在肩井穴留针，局部加艾灸，留针 15 分钟后，在捻转起针时，患者突然感到左侧胸痛，且向左肩背部放射，伴胸闷、心

悸、呼吸困难。体检：心率100次/分，血压16.0/10.7千帕(120/80毫米汞柱)，呼吸稍急促，无紫绀，气管居中，心脏正常，左侧背部呼吸音减弱。经X线摄片诊断：左侧气胸，肺组织压缩20%。即收入院观察，给予抗感染、止咳等对症处理。于当晚12时呼吸困难进行性加重，血压下降为12.7/9.3千帕(96/70毫米汞柱)，心率120次/分，血红蛋白8克%，不能平卧，轻度紫绀，气管向右移，左侧背部呼吸音消失，左背部第2肋以下叩诊浊音。胸片提示：左侧液气胸，左肺压缩95%，液平面在左第2前肋间。临床诊断：左侧外伤性气胸。即给吸氧、止血，输血600毫升，并在左腋前线第4前肋间穿刺，抽出血样液体800毫升，气体200毫升，自觉症状好转。但第2天胸片复查，血气胸仍无好转，为使肺组织尽早复张，在左腋前线第6前肋间作胸腔闭式引流，当即又流出血样液体800毫升和大量气体，同时输血500毫升，症状好转。晚上胸片复查，左肺已复张，肺组织仅压缩5%。于第3天拔除引流管，再次胸片复查，仅留有左下胸膜粘连，于1982年7月30日痊愈出院^[5]。

【讨论】

肺是呼吸系统最重要的部分，因针刺损伤肺脏引起气胸的意外情况屡见不鲜，在物理性损伤中，它的发生率占首位，近几年来国内外的有关报道约有1百多例。以上所提11个案例，都是由于术者操作不当的原因，使患者的胸膜和肺脏被针尖所损伤，导致空气经其裂口进入胸膜腔面产生气胸，有的甚至伤及肺背段血管而引起严重的血气胸。根据现代解剖学，肺脏位于胸腔内，外形为半圆锥体状，上端为肺尖，向上突出于第1肋，下面为肺底，接触膈肌之穹窿面，外侧面紧贴于胸壁，内侧而与纵隔相邻；而肺脏在体表的投影，其上界前面在锁骨上2~3厘米，下界可随呼吸运动而改变，正常人吸气时位于锁骨中线的第6肋间，腋中线在第8肋间。而肺脏的表面由胸膜所覆盖，胸膜分为脏层和壁层，两层之间形成一密闭负压的腔隙即胸膜腔，当深刺时针尖则易穿透胸膜伤及肺脏，导致气胸的发生。故针刺肩井穴时，要熟悉其所在的解剖位置，掌握好针刺的方向、角度和深度，以防发生意

外。临床上，由于肺脏的体积很大，除肩井穴外尚有许多穴位（背部），如膀胱经的大杼、风门、肺俞、厥阴俞、心俞、督俞、膈俞、肝俞、胆俞、脾俞、胃俞、附分、魄户、膏肓、神堂、谿谿、膈关、魂门、阳纲、意舍，小肠经的肩中俞、肩外俞，三焦经的天髻，经外奇穴的定喘、胃管下俞等，它们皆位于肺脏的投影区内，针刺时亦需小心谨慎。

【临床表现】

针刺引起的气胸，其发病的缓急和临床症状的轻重，均取决于肺组织损伤的程度、肺萎陷的程度、病人的敏感度及其原来的肺功能状况，一般可将它分为轻、中、重度3型。具体请参见前文。

如为血气胸，随着病情的发展可伴出血性休克现象，如呼吸表浅，面色苍白，紫绀，心慌气急，四肢厥冷，脉细数，血压下降等。体检见，患侧肺下端叩诊呈实音，上端呈过清音或鼓音。X线检查见肺下部有液体阴影及液平面。胸腔穿刺可见到血液。

【处理方法】

气胸发生后，要及时给予治疗，切不可抱任何观望或侥幸的态度，以免贻误病情，临床上根据胸腔积气的情况和肺脏被压缩的程度，而采取不同的治疗方法，详细内容请参见前文。

对于血气胸，则在排气的同时，应积极止血。轻者可先采用温灸涌泉穴或七星针叩击颈动脉区，或用脑垂体后叶素5~10个单位加入25%葡萄糖20~40毫升内，缓慢静脉注射（但孕妇、心脏病、高血压等患者不宜使用）；血止后，可多次抽液，并在胸膜腔内注入青霉素和链霉素，以防感染及胸膜肥厚粘连。如出血不止者，可手术寻找和结扎破裂的血管。若出现休克症状，应注意配合输血、抗休克治疗。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：由锁骨上外侧神经分布。
2. 皮下组织：内有上述皮神经的分布，其血液供应主要来自颈横动脉。
3. 斜方肌：形成肩部之隆起，由副神经支配。在其深面有前

锯肌。

4. 肋与肋间隙：在前锯肌的深面，自后向前（同时略自下而上）分别为第2肋、第1肋间隙及第1肋，肋间隙内有肋间外、内肌及其中间的血管、神经。

5. 胸膜顶及肺尖：衬覆于肋及肋间隙内面的为壁层胸膜及与之相贴的肺上叶，而在针刺方向的前内侧，胸膜顶及肺尖高于第1肋。

【操作要点】

针刺肩井穴导致气胸的发生，主要是因术者经验缺乏、操作不慎所致，故临床上施术时要注意以下几个方面：首先，应令患者取伏坐位或俯卧位，并于针刺入后不得任意移动体位，同时针具要求平直、光洁、细小，多用28~30号毫针；其次，要注意掌握好肩井穴的针刺深度和角度，一般可直刺0.5~0.8寸，千万不可过深，并要反复体会手感；若进针朝前下方过深，则有可能刺中第1肋或第2肋，针感坚硬，当穿透第1肋间隙，则可伤及其深面的胸膜壁层及肺上叶；若进针朝前内方过深，经第1肋之上方，则可能刺穿胸膜顶及肺尖；再次，在留针过程中，病人不得随意改变体位，以免针体在肌肉的牵拉收缩下随之活动而伤及肺脏；施用温针时，术者宜一手扶住针体，一手捻上艾炷，防止针体深移；一般不要针后加罐，如为肺气肿患者，更要禁止；最后，应重视针后的观察，凡针该穴的病人，在可能的条件下，尽可能让其在诊室内体息15~30分钟才走，以便及时发现各种不适情况。

二十二、风门穴针刺不当导致气胸

【案例1】

张×，男性，36岁，住院号2865。因左肩痛、左上肢发麻在针灸科接受治疗，穴位取风门、大椎、风池、肩井、肩髃、曲池等，当针刺脊椎左旁风门穴时，患者左肩耸了一下，随即感觉心跳、气促，类似出现休克症状。马上起针，数分钟后见好转。次

日，患者又以左胸痛、咳嗽、气促来院复诊，经X线胸部照片，发现其左侧气胸，肺组织压缩约10%，即予收入院治疗。入院后，除给予止咳药外，未作特殊处理。6天后，症状减轻出院。1个月后复查，气胸吸收自愈^[8]。

【案例2】

吕××，女性，68岁。患者因胸背酸胀疼痛，咳嗽，纳呆，颈部不适，于1978年10月18日上午就诊。予针刺疗法，取穴风门、肺俞、膏肓、脾俞等。当日下午自觉胸闷、胸痛，次晨加重，疼痛剧烈，憋气明显，再来门诊。经胸部透视，左侧气胸。当天即收住院观察治疗。查体：体温37.6℃，呼吸每分钟24次，血压17.3/10.7千帕（130/80毫米汞柱），急性病容，半卧位，气管向右偏移，呈桶状胸，呼吸动度大，左肺叩鼓音，听诊左肺呼吸音消失，右胸呼吸音弱，心音远，心律规整，心率104次/分，无明显杂音。腹软，肝脾未触及。实验室检查：血红蛋白11.7克%，白细胞总数为10700/立方毫米，中性83%，淋巴15%，单核1%，嗜伊红1%，大小便常规正常。胸部拍片示：胸廓不对称，左胸饱满，右胸纹理增多，中内带示片状密度增高影，左肺中外带示纹理消失，肺组织压缩70%，心脏纵隔（一）。入院诊断：左侧气胸，右肺炎症。入院后给予吸氧、抗感染等中西药物治疗，当天下午用人工气胸箱抽气1000毫升，抽气后憋气缓解，症状好转。经54天治疗，复查血象正常，胸部拍片示双肺纹理多，左侧气体已吸收，痊愈^[52]。

【案例3】

王××，男性，45岁。因背部酸楚板滞而作针刺治疗，取俯卧位隔衬衣进针，取胸1~5夹脊及风门、肺俞、大杼诸穴，针上加艾炷温针，艾炷才点燃不久，患者即诉头晕、胸闷，见呼吸急迫，唇色微紫。急出针，送放射科检查，左肺已压缩40%^[47]。

【讨论】

针刺不当引起气胸，是针灸科临床上最常见的事故，近几年来国内外的有关报道屡见不鲜。上述病例中的第1、2例，主要是由于术者针刺角度、深度不当，加上刺入后病者活动使针内陷

(例1), 刺伤肺脏而导致创伤性气胸; 例3则是术者不按操作规范而隔衣进针, 由于衣服的厚度、衣服与体表之间的距离等因素, 使术者难以掌握进针方向和深度, 使针尖刺伤胸膜, 空气进入胸腔所致。根据现代解剖学知识, 肺脏位于胸腔内, 为半圆锥体状, 其上端为肺尖, 向上突出于第1肋, 下面为肺底, 接触膈肌之穹窿面, 外侧面紧贴于胸壁, 内侧面与纵隔相邻。其表面由胸膜所覆盖, 胸膜分为脏层和壁层, 两层之间形成一密闭负压的腔隙, 即胸膜腔。当风门穴深刺时, 针尖易穿透胸膜而伤及肺脏, 导致气胸的发生。所以临床施术时一定要掌握好针刺的方向、角度和深度。

【临床表现】

针刺引起的气胸, 其发病的缓急和临床症状的轻重, 均取决于肺组织损伤的程度、病人的敏感度及其原来的肺功能状况, 一般可将它分为轻、中、重度3型, 详细内容请参见前文。

【处理方法】

气胸发生后, 要及时给予治疗, 以免贻误病情。临床上可根据胸腔积气的情况和肺脏被压缩的程度, 采取不同的治疗方法, 具体可参见前文。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤: 由第2胸神经后支的内侧支分布。
2. 皮下组织: 有上述皮神经的分支通过。
3. 斜方肌: 由副神经及第3、4颈神经所支配。
4. 菱形肌: 该肌由肩胛背神经支配, 到该肌的神经纤维由第5颈神经组成。
5. 上后锯肌腱膜: 上后锯肌由第1、2、3、4肋间神经支配。
6. 竖脊肌(骶棘肌): 该肌由脊神经后支节段性支配, 到穴区肌肉的神经主要是第2、3胸神经后支的外侧支。该肌的深面有背深部的横突棘肌等小肌肉。

【操作要点】

为了尽量避免针刺风门穴引起气胸, 术者在施治时应注意: 患者应努力保持一舒适且固定的体位, 临床上多取伏坐位或俯卧位,

并要求留针过程中不得随便改变原有体位，以免针体在肌肉的牵拉收缩下会随之活动而伤及肺脏；术者要牢记“背部薄如饼”的古训，在针刺风门穴时应根据病者的体位、胖瘦及穴区局部解剖等情况，严格掌握好针刺的深度、方向及角度，一般以向内斜刺或平刺 0.5~1 寸为安全（根据测量，成年人从体表至胸腔后壁的距离，风门穴左侧为 4.99 厘米，右侧为 5.01 厘米），因内侧的肌肉较丰厚些，而穴区深面及外侧部肌肉较薄，故直刺或向外斜刺易经肋间隙刺穿胸壁，造成气胸；施术过程中手法不宜太重，亦不宜反复提插、捻转，若用温针时术者应一手扶住针体，一手捻上艾炷，以防止针体深移；出针后要注意观察，凡针刺本穴的病人，在可能的条件下，应尽量让其在诊室内休息 15~30 分钟才走，以防万一。

二十三、肺俞穴针刺不当导致气胸

【案例 1】

赵××，男性，32 岁，运输工人。于 1958 年 6 月间抬木头，不慎右侧胸部挫伤，当时有麻木感，但不肿不痛，后转为肩关节及右侧背痛，用西药治疗无效，于 1959 年 5 月间转我院治疗。经胸透无异常所见后，给予针灸治疗，历经 1 星期逐渐好转，又转原地治疗。于本年 6 月 2 日用 4 枚毫针刺于背部及肩部，当时感到进最后一枚针于右侧脊柱旁（相当于肺俞穴）时，伴随继续进针疼痛逐渐加重，甚者不敢吸气及活动，患者忍耐 20 余分钟，当起针后疼痛更加严重。以后引起频发性咳嗽约 7 小时，初吐两口血沫子，后转吐白沫痰，呼吸短促，胸内窜痛约 2 小时后，发现背及腋下皮肤压之有握雪感，因痛而不能翻身又来我院治疗。既往体格健康，无可特殊记载。体格检查：营养佳良，骨骼肌肉发达，体格正常，脉搏 84 次/分，血压 14.7/9.3 千帕（110/70 毫米汞柱），精神正常。胸廓正常，右侧胸部叩诊有轻度鼓音，压之腋下及背部有散在性握雪感，相当于肺俞穴处可见一处针孔。腹平坦柔软无压痛。实验室检查：血沉 1 小时 4 毫米，2 小时 7 毫米，

白细胞 9400，红细胞 422 万，血红蛋白 88%，分叶 68%，大单核 3%，淋巴 27%，嗜酸性 2%。胸透：右侧胸部外压所见 20 厘米宽之带状透明区，其中肺纹理不清，透明区之内缘呈明显规整之条状境界。诊断为：外伤性气胸^[53]。

【案例 2】

一患者，女性，22 岁，于 1959 年 8 月 21 日因呼吸困难 4 小时而急症入院。患者 3 天前感右胸部麻木、疼痛，约于 5 小时前在某保健室行针刺治疗。当时医者以 5 支毫针，由右前胸和背部刺入，拔针后当即感觉呼吸困难，右胸部胀痛，随即来院医治。体检：发育良好，神志清楚，右侧胸部呼吸较左侧为弱，呼吸音较低；右胸部可见 5 处针刺痕迹，1 处相当右“肺俞”穴，4 处分布于后胸和前胸第 5 肋间部位（即阿是穴处）。临床诊断：针刺损伤性气胸。治疗经过：入院后立即行胸腔测压和吸气，直至胸腔压力恢复为 -2~4 厘米水柱。后行胸部 X 线检查，右肺完全舒张，呼吸平稳。其后又经过两次胸部 X 线检查，气体完全消失。住院 2 日，痊愈出院^[1]。

【案例 3】

一患者，男性，56 岁。患者哮喘已 50 年，去某医院针灸治疗，在肺俞穴垂直刺入 0.5~1 寸，留针拔罐 10 分钟。去罐后，针身有所增加。针后病者回家，约 3 时许，突然心慌、气促、胸背刺痛，大汗淋漓。入院体检：患者呈急性病容，左肺上、中呼吸音消失，左肺俞穴处有 0.1~0.2 厘米大小之新鲜出血瘀点，四周压痛。X 线检查证明左肺创伤性气胸。治疗：经过输氧抢救，空针抽气，并用养阴润肺、降气平喘的中药调治，住院 51 天痊愈出院^[54]。

【案例 4】

一患者因左肩针刺后，左胸持续性疼痛，呈进行性加重 26 小时入院治疗。入院前 1 日因左上肢、肩背及胸部麻木、疼痛，在当地卫生所针刺左侧肺俞、肩井、肩髃、肩髃、天宗等穴，后又行梅花针及拔火罐。半小时后左胸更痛，呼吸时尤甚，但无畏寒、发热、咳嗽、咯痰等，2 小时后胸透未见异常，留所观察。胸痛逐渐加重，出现憋气，不能平卧，次日上午听诊呼吸音减弱，透视

左胸腔少量积液，肋膈角变钝，可见气液平面。入院诊断：少量液气胸。体检：血压 17.3/8.0 千帕（130/60 毫米汞柱），呼吸每分钟 22 次，脉搏每分钟 92 次，急性痛苦病容，端坐位，神清合作，唇不绀紫，颈静脉充盈正常，颈动脉搏动无异常，气管轻度右移，左胸下部稍饱满，呼吸运动减弱，压痛明显，左前胸第 5 肋间以上呈过清音，左肺底实音。左肩背皮肤可见多个针刺点及密集梅花针刺小点。血红蛋白为 10.2 克。

入院当晚血压 13.3/9.3 千帕（100/70 毫米汞柱），呼吸每分钟 26 次，脉搏每分钟 92 次，面色苍白，大汗淋漓，脉细速弱，心音弱，心慌。第 3 日上午胸透发现左胸腔积液平第 6 肋间，积气甚少，血红蛋白 8.2 克，下午于左腋后线第 9 肋间抽出全血 1300 毫升，立即输血 400 毫升，补液 1300 毫升。第 4 日上午行超声波探查，左腋后线 8~10 肋间探及 5 厘米液平段，血红蛋白 6.3 克，红细胞 200 万/mm³。当即开胸探查，左胸腔内有鲜血及血凝块 1200 毫升，胸腔顶部第 1 肋间肩胛线内侧有一针眼，其周围组织水肿、糜烂，有少量渗血；肺尖部有一直径 0.5 厘米之肺胸膜损伤，未见漏气及出血。给予缝合止血，术后情况良好，伤口一期愈合。住院 1 个月，经多次胸透未见异常后出院，血红蛋白恢复正常^[49]。

【案例 5】

据报道，在其所收治的 6 例针刺创伤性气胸中，有 1 例是用不锈钢毫针刺入肺俞穴所致的。当时患者有呼吸困难、紫绀、剧痛、冷汗等症状，并有患侧听、叩物理检查体征，胸透提示有气胸，经对症处理痊愈出院^[6]。

【案例 6】

吕××，女性，68 岁，患者因胸背酸胀疼痛，咳嗽，纳呆，颈部不适，于 1978 年 10 月 18 日上午就诊，予针刺疗法，取穴肺俞、风门、膏肓俞、脾俞等。当日下午自觉胸闷胸痛，次晨加重，疼痛剧烈，憋气明显，再来门诊，经胸部透视示左侧气胸。当天收住院治疗观察。查体：体温 37.6℃，呼吸 24 次/分，血压 17.3/10.7 千帕（130/80 毫米汞柱），急性病容，半卧位，气管向右偏移，呈

桶状胸，呼吸动度大，左肺叩鼓，听诊左肺呼吸音消失，右胸呼吸音弱，心音远，心律规整，心率104次/分，无明显杂音。腹软，肝脾未触及。实验室检查：血红蛋白11.7克，白细胞总数10700/立方毫米，中性83%，淋巴15%，单核1%，嗜伊红1%，大小便常规（-）；胸部拍片示胸廓不对称，左胸饱满，右胸纹理增多，中内带示片状密度增高影，左肺中外带示纹理消失，肺组织压缩70%，心脏纵隔（-）。入院诊断左侧气胸，右肺炎症。入院后给予吸氧、抗感染等中西药物治疗，当天下午用人工气胸箱抽气1000毫升。抽气后憋气缓解，症状好转。经54天治疗，复查血象正常，胸部拍片示双肺纹理多，左侧气体已吸收，痊愈出院^[32]。

【案例7】

李××，女性，26岁。于1970年5月6日因患支气管炎，施行针刺治疗。穴取肺俞、肩井、定喘等，出针后即感胸闷、气短而急症入院。既往健康。检查：体温36.5℃，脉搏84次/分，呼吸33次/分，血压17.3/10.7千帕（130/80毫米汞柱）。发育营养良好，气喘状态，口唇无发绀，气管偏右，甲状腺不大。左侧胸部呼吸动度弱，语颤降低，叩诊呈鼓音，呼吸音明显减弱，心浊音界消失，心音弱，心律整，未闻及杂音。腹平软，肝脾未触及。化验：血红蛋白15克，白细胞7000，中性70%，淋巴30%。胸部X线透视：左侧高度透明，肺纹理影消失，仅在肺门部见被压缩的肺组织边缘，肺组织压缩约在90%，纵隔向右侧移位。诊断：气胸。入院后给予卧床休息，抗生素控制感染，闭式插管排气治疗。3天后症状消失，查体正常，胸部X线透视左肺复张，痊愈出院^[2]。

【案例8】

王××，女性，50岁。因患支气管炎行肺俞、肩井、天突等穴针刺治疗，拔针后即感胸痛、气憋、呼吸困难，于1981年8月6日急症入院。既往健康，无心肺疾病。检查：体温37℃，脉搏90次/分，呼吸30次/分，血压18.7/10.7千帕（140/80毫米汞柱）。发育营养一般，端坐呼吸，口唇无发绀，气管居中，甲状腺不大。左胸呼吸动度减弱，语颤降低，左上胸部叩诊呈鼓音，6肋

间以下叩诊呈浊音，呼吸音明显减弱，心尖搏动不明显，心音弱，心律整，无杂音。腹平软，肝脾未触及。化验：血红蛋白 13 克，白细胞 9200，中性 82%，淋巴 18%，血小板 25 万，出凝血时间各 2 分钟。心电图检查正常。胸部 X 线透视：左上气胸，肺组织压缩约 20%；左 6 肋间以下密度增高，可见液面。诊断：液气胸。入院后给予抗生素控制感染，胸腔穿刺，抽出气体 1000 毫升、血性积液 800 毫升。观察 1 周后症状消失，查体正常，胸部 X 线透视除见左肋膈角变钝外，余无异常。痊愈出院。修正诊断：血气胸^[2]。

【案例 9】

据报道，在其所收治的 18 例针刺致气胸中，有 5 例是因针刺肺俞穴不慎所致的。多数患者会在拔针后即觉憋气、汗出、心悸、呼吸困难等，胸部叩诊患侧呈鼓音或过清音，听诊呼吸音消失或低下，胸部 X 线均示有气胸存在，经处理后均获痊愈^[14]。

【案例 10】

李××，女性，59 岁。因慢支咳嗽咯痰而为之针刺肺俞、定喘穴，针约 15 分钟许，患者诉胸闷、头晕，未引起医者重视。出针后再于背部拔罐，患者渐现呼吸急迫，口唇青紫，以为是晕针所致，遂开窗通风、摇扇等，病情有增无减，才疑为气胸。放射科透视见右肺压缩 50%，急送上级医院救治，终因抢救无效而于当天死亡^[47]。

【案例 11】

于×，女性，53 岁，家庭主妇，因患慢性支气管炎并发肺气肿，于 1988 年 10 月 6 日就诊。施行针刺疗法，穴取肺俞穴等，但由于针刺的方向和深度欠妥，加上俯卧位时盖在身上的衣服不断给针以压力，病人在留针中就觉得突然胸痛，却未能引起医生的警惕，当天夜里气短和胸痛加重，无法安卧入睡。翌日复诊时，经 X 线检查确诊为气胸。经住院给氧和抗炎等治疗后缓解，1 周后康复出院^[4]。

【案例 12】

王×，男性，39 岁，干部。患支气管哮喘，于 1988 年 9 月 25

日来诊。施予针刺治疗。因操作时肺俞穴的针刺方向和深度不妥，患者当即觉得气短和心悸，经 X 线胸透未见异常，诊断为胸膜休克。经过精神安抚和投少量镇静剂，翌日方恢复。

另有一女性患者，宋×，45 岁，助理工程师。因患慢性支气管炎和冠心病，于 1988 年 10 月 5 日前来要求针刺疗法治疗。由于施术时针刺肩井穴的方向和深度失当，翌日复诊时病人觉得病情不见好转，反而心烦不安，但病人的异常情况并未引起医生注意，又针肺俞、肾俞等穴，病者仍不见好转。终因救治失误而死亡。解剖后发现多脏器损伤^[4]。

【讨论】

肺是呼吸系统最重要的部分，因针刺损伤肺脏而导致气胸的事故，是针灸科临床最常见的意外，在物理性损伤中，它的发生率占首位。以上所提到的十几个案例中，都是因为术者缺乏基本解剖知识或是因为术者施针不谨慎，未能根据患者体格的胖瘦选用适当的长短针，或是选针过粗，或是隔衣针刺而深浅掌握不准，进针后针尖伤及患者的脏层胸膜及肺脏，加上留针时毫针作为异物随呼吸运动而反复刺伤它们，致重复损伤或裂口增大，产生程度轻重不同的气胸，有的甚至伤及肺背段血管而致严重的血气胸。根据解剖学知识，肺脏位于胸腔内，外形为半圆锥体状，上端为肺尖，向上突出于第 1 肋，下而为肺底，接触膈肌之穹窿面，外侧而紧贴于胸壁，内侧面与纵隔相邻；而肺脏在体表的投影，其上界前面在锁骨上 2~3 厘米，下界可随呼吸运动而改变，正常人吸气时在锁骨中线的第 6 肋间，在腋中线的第 8 肋间。肺脏的表面由胸膜所覆盖，胸膜分为脏层和壁层，两层之间形成一密闭负压的腔隙即胸膜腔，当深刺时针尖易穿透胸膜伤及肺脏，导致气胸的发生。所以针刺肺俞穴时一定要掌握好施术的方向、角度和深度。临床上，由于肺脏的体积很大，除肺俞穴外背部尚有许多穴位，如膀胱经的大杼、风门、厥阴俞、心俞、督俞、膈俞、肝俞、胆俞、脾俞、胃俞、附分、魄户、膏肓、神堂、譩譩、膈关、魂门、阳纲、意舍，胆经的肩井，小肠经的肩中俞、肩外俞，三焦经的天髻，经外奇穴的定喘，胃管下俞等穴，它们皆位于肺脏

的投影区内，故针刺时均需小心谨慎。

【临床表现】

针刺引起的气胸，其发病的缓急和临床症状的轻重，均取决于肺组织损伤的程度、肺萎陷的程度、病人的敏感度及其原来的肺功能状况，一般可将它分为轻、中、重度3型，具体请参见前文。

【处理方法】

气胸发生后要及时给予治疗，以免贻误病情。临床上，可根据胸腔积气的情况和肺脏被压缩的程度，而采取不同的治疗方法，详细操作请参见前述。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：由第3胸神经后支的内侧皮支分布。
2. 皮下组织：有上述皮神经的分支通过。
3. 斜方肌：该肌由副神经和第3、4颈神经支配。
4. 菱形肌：该肌由肩胛背神经支配，到该肌的神经纤维由第5颈神经组成。
5. 上后锯肌腱膜：上后锯肌由第1、2、3、4肋间神经支配。
6. 竖脊肌（骶棘肌）：该肌由脊神经后支节段性支配，到穴区肌肉的神经主要是第3、4胸神经后支的外侧支。

【操作要点】

针刺肺俞穴不慎刺伤肺脏而引起气胸，是针灸临床上最常见的意外事故之一，故针刺时必须谨慎，应注意以下几个方面：首先，要求患者应努力保持一个舒适且固定的体位，临床上多取伏坐位或俯卧位，并在留针过程中不得随便改变原有体位，以免针体在肌肉的牵拉收缩下会随之活动而易伤肺脏；其次，术者要牢记“背部薄如饼”的古训，在针刺肺俞穴时应根据病人的体位、胖瘦及穴区局部解剖等情况，严格掌握好针刺的深度、方向及角度，一般以向内斜刺或平刺0.5~1寸为安全（根据测量，成年人的肺俞穴从体表至胸腔体壁，厚度约为4.3厘米左右，故从背侧向前直刺3~5分或斜刺8分深是安全的），因其内侧的肌肉较丰厚些，而穴区深面及外侧部肌肉较薄，故直刺或向外斜刺易经肋间隙刺

穿胸壁，造成气胸；再次，施术过程中手法不宜太重，亦不宜反复提插、捻捣，若用温针时术者应一手扶住针体，一手捻上艾炷，以防止针体深移；最后，出针后要注意观察，凡针刺本穴的病人，应尽量让其在诊室内休息 15~30 分钟才走，以防万一。

二十四、背部腧穴针刺不当导致气胸

【案例 1】

郑××，男性，44 岁。患者 5 年前曾患咳嗽，逐渐加重，近 3 年来已不做较剧烈的工作，这两个月来又患大咯血，每在发作时不能仰卧，必须坐起呼吸，经过剧烈的喘咳后，吐出多量痰涎后方感轻快。检查：体温 36.2℃，脉搏 108 次/分，呼吸困难，胸廓左右不对称，左侧显著萎缩，而右侧呈显著代偿性扩张，在背部膈关、魂门两处有压痛。治疗：取双侧肺俞、右侧膏肓、左侧膈关和魂门穴，用 1.5 寸毫针刺入 3~5 分，患者即感疼痛，5~6 分钟后要求起针，出针后患者马上出现呼吸困难，汗出，发绀。为急救计又刺水沟及天突穴，并注射强心针，但未效而于 10 分钟后死亡。

尸检诊断：①右侧气胸，右肺下叶后面有新鲜针刺孔，纤维性胸膜炎及充血，肺气肿；②右侧高度纤维性结核性胸膜炎，脓胸，肺萎缩，肺气肿，轻度小叶性肺炎，慢性支气管炎；③慢性风湿性心瓣膜炎（二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣），心肌间质结缔组织增生，心尖的右心室前面有新鲜针孔。死亡原因：针刺刺伤肺脏，形成气胸，发生窒息而死亡^[16]。

【案例 2】

姚××，男性，60 岁。于 1957 年 1 月 4 日以主诉呼吸短促，左侧胸痛 1 周而住院。患者因左背肩胛下部肌肉酸痛，断续性发作已 20 多天，无发热、咳嗽等，于 1 周前到某医院针灸科求治，在左肩下（肩贞穴）及左背肩胛下角下方（阿是穴）共刺入 3 针。当针毕，病人即感左侧胸部疼痛，呼吸不顺，全胸束缚感，未加处理而返家休息。病人在家的 1 周里，左腋下仍有持续性疼痛，稍

深吸气疼痛即加剧，左季肋部及左背肩胛下方针灸处亦有痛感，但无寒热及紫绀等症状。病人素体健康。入院时体检：发育营养均佳，神清合作，尚能平卧，呼吸 20 次/分，体温 37.1℃。颈软，气管略偏右。左侧胸部呼吸运动减弱，呼吸音减弱，左腋中线下端可听得磨擦音，左侧胸背部叩音均呈较高之清音，左背肩胛下角下部有压痛，无皮下气肿及皮肤青紫，心浊音界右移。胸部透视：左胸外侧有气影，肺部被压缩约 60%，左肋膈角有液平，心脏右移，右肺无异常；透视下吸气时，见纵隔向患侧摆动，呼气时则相反。化验室检查：无异常。诊断：左侧水气胸（可能因针灸而引起）。

治疗经过：自针灸日到住院已过 1 周，病状如旧，考虑是非开放性与张力性气胸，未予排气，但按保守疗法及对症疗法，病状日见好转。1 周后再次透视，证实左侧气胸吸收颇多，约剩 40%，左肋膈角仍有少许积液。1 月 16 日拍片发现与前两次相同，左肺更见扩张。1 月 19 日左侧作胸腔探试穿刺，抽出淡黄色液 5 毫升，细胞总数约 9200，中性 75%，淋巴 25%。于 1 月 22 日症状基本消失，出院体养；18 天后透视复查，左侧仅余气少许，心脏已完全复位，左膈运动稍差，据称症状已完全消失；3 月 12 日最后 1 次透视，左肺已完全扩张，患者称出院后旬日，即开始劳作，无何不适^[50]。

【案例 3】

赵×，女性，70 岁，住院号 733。于 1961 年 2 月 28 日因中风后遗左侧肢体运动障碍半年而入院。病人入院后以针刺治疗为主，每次取穴多采用局部（患肢）配穴，应用手法为平补平泻，连续针治 4 天，肢体运动障碍症状好转。3 月 5 日上午，病者自觉心悸不宁，故就诊医生除针刺局部穴位外，又增加心俞、肾俞两穴。当针刺后病者咳嗽增多，在出针后 2 小时，患者发作呼吸困难，不能平卧，左胸刺痛，听诊呼吸音减弱，叩诊呈鼓（右侧），体温 37℃，白细胞总数 10100。胸部 X 线检查，右肺约 1/3 部分有透亮带，此部分看不到肺组织阴影。诊断为右侧外伤性气胸。当时令病人安静，控制感染，投青霉素 20 万单位，供肌肉注射。于本日晚病者

咯血一口，呼吸困难症状仍然加重。晨起咯血两口，病者自述胸部胀闷痛。当时上午于右侧腋前线第6肋间隙，做胸腔穿刺发出气体250毫升（因为针头阻碍而中断），呼吸困难稍有改进；但第4天（18日）病人呼吸困难再次增剧，体温37.6℃，当时经X线检查诊断为水气胸。经过中药治疗，于4月8日痊愈出院^[55]。

【案例4】

某男性患者，24岁，助教。因患慢性类风湿性脊椎关节炎而至××医院接受针刺治疗，穴取身柱、膈俞、膈关、曲池等，针后患者即感呼吸困难，起床不易，休息后行路仍感气喘。隔1日复至该院，针刺陶道、肺俞、天宗、太渊，但无效，当日下午来我院门诊，胸部透视说明有左侧气胸，肺被压缩90%，住院治疗。给予抽气处理，经过12日，气体吸收完全而出院^[9]。

【案例5】

某一女性患者，47岁，工人。于1960年3月4日入院。患者住院前1日感上腹部不适，曾赴某诊所行针刺治疗，在左胸及其背部取穴，针后当夜病者即感气喘，呼吸困难，身出大汗，于次日入我院治疗。检查：左胸上部皮下有气肿，左胸壁及背部有多处针刺痕迹，左胸语颤及呼吸音均减低。透视胸部左侧有气胸，肺被压缩30%。经治疗20余日，病人痊愈出院^[9]。

【案例6】

俞××，男性，41岁，农民，1959年3月14日初诊。主诉：咳嗽，气急，胸痛、胸闷，已有7天。病史：患者在3月7日尚能参加劳动，因感疲乏而休息，在第2日上午至当地某针灸医生处诊治，在背部、肩胛间部及其下方针刺后，当即发生气奔样难过，呼吸急促，症状逐渐加剧，平卧时更感气急。有慢性咳嗽史10多年，近3、4年来加重，痰中带血，有时下午发热，除注射过两瓶链霉素外，未服过抗痨药或其他药物。体格检查：发育、营养中等，慢性病容，呼吸急促，轻度发绀，无黄疸，咽无充血，颈静脉充盈，气管偏左，胸呈桶形。右侧胸及背部均明显膨隆，呼吸动度减弱，叩诊呈高清音，肝浊音界消失，呼吸音减弱或消失；左侧肺上部有管状呼吸音，腋下可闻少许湿性罗音，心音很低，心

律规则，心音界不明显。腹胀满，肝在肋下2横指。X线胸透：有结核病灶，右侧下肺野外侧有透明较均匀之阴影。化验检查：血红蛋白82%，红细胞440万，白细胞20100，中性76%，淋巴18%，酸性6%。治疗经过：入院后，即以人工气箱抽气700毫升，气急缓解；嘱病人绝对卧床休息及服用氨茶碱、止咳剂等药物，咳嗽、气急等症状消失，于4月5日出院^[56]。

【案例7】

吕×，女性，29岁。有浸润型肺结核病史，因胸痛以多种药物治疗无效而作针刺治疗。取穴膏肓（针5分，约1.6厘米）、肩中俞（针3~6分，约1~2厘米）、合谷（针3~7分，约1~2厘米），用捻针法，予弱刺激。某次进针2~2.5厘米，针刺时病人有数声轻微的咳嗽，随之感胸痛剧烈，即拔针，半小时后气促、胸痛，不能行走。当日下午胸部透视，发现右侧气胸，肺压缩50%。即给可待因等镇咳药，并改为全护理，绝对卧床休息。5天后部分肺膨胀，肺仍压缩30%；23天后右肺已完全膨胀，气胸已痊愈，出院^[57]。

【案例8】

据报道，在其所收治的6例针刺致气胸中，1例是针刺背部第5胸椎棘突下凹窝左右旁开约2寸（相当于心俞穴）引起气胸。针后出现呼吸困难、紫绀、剧痛、冷汗、干咳等症状，患侧听、叩物理检查体征，胸透示肺脏被压缩，经治疗痊愈^[6]。

【案例9】

据报道，在其收治的7例针刺导致创伤性气胸中，3例是针刺背部膈穴（左侧2例，右侧1例）引起，均于针刺实施之当时或不久之后，即感胸痛、胸闷不适，气短及不同程度的呼吸困难等，触诊患侧语颤减弱或消失，叩诊呈鼓音，听诊肺部呼吸音减弱或消失，胸透示肺脏被压缩。经治疗痊愈^[7]。

【案例10】

吕××，女性，68岁，患者因胸背酸胀疼痛，咳嗽，纳呆，颈部不适，于1978年10月18日上午就诊，予针刺疗法，穴取膏肓俞、脾俞、肺俞等。当日下午自觉胸闷、胸痛，次晨加重，疼痛

剧烈，憋气明显，再来门诊。经胸部透视，左侧气胸。当天收住院治疗观察。查体：体温 37.6℃，呼吸 24 次/分，血压 17.3/10.7 千帕（130/80 毫米汞柱），急性病容，半卧位，气管向右偏移，呈桶状胸，呼吸动度大，左肺叩鼓音，听诊左肺呼吸音消失，右胸呼吸音弱，心音远，心律规整，心率 104 次/分，无明显杂音。腹软，肝脾未触及。实验室检查：血红蛋白 11.7 克%，白细胞总数 10700/立方毫米，中性 83%，淋巴 15%，单核 1%，嗜伊红 1%，大小便常规（-）。胸部拍片示胸廓不对称，左胸饱满，右胸纹理增多，中内带示片状密度增高影，左肺中外带示纹理消失，肺组织压缩 70%，心脏纵隔（-）。入院诊断：左侧气胸，右肺炎症。入院后给予吸氧、抗感染等中西药物治疗，当天下午用人工气胸箱抽气 1000 毫升，抽气后憋气缓解，症状好转。经 54 天治疗，复查血象正常，胸部拍片示双肺纹理多，左侧气体已吸收，痊愈出院^[52]。

【案例 11】

杜××，男性，41 岁，工人。因腰背部疼痛去医务室针刺治疗，于背部扎针后，当即感到心慌，气急，出冷汗，迅即意识不清，医者误认为“晕针”，片刻清醒后诉气闷、胸痛，不能平卧，喜右侧卧位。回家休息 3 天仍不见好转，转来我院。体检：气管向右侧移位，左侧胸廓稍隆起，语颤音降低，叩诊呈鼓音，呼吸音降低。胸透证实为左侧气胸，肺被压缩约 75%。入院后经 3 次胸腔穿刺抽气，分别抽出气体 2200 毫升、2800 毫升、3200 毫升，4 天后肺全部复张，10 天后病愈出院^[58]。

【案例 12】

某一男性患者，33 岁。近日因右背部胀痛不适，由本村医生针刺背部穴位，留针 30 分钟，针后自觉胸闷、气短、头晕、心悸，呈进行性加重，来院急诊。门诊以血气胸并发出血性休克，于 1981 年 8 月 12 日急收住院。体格检查：体温 36℃，呼吸 24 次/分，心率 108 次/分，血压 10.7/8.0 千帕（80/60 毫米汞柱）。急性病容，贫血貌，呼吸急促，气管左移，右侧肋间饱满，呼吸活动度及语颤减弱，右胸上部叩诊呈鼓音，右腋中线第 6 肋间以下叩诊为实

音，右肺呼吸音消失，左肺呼吸音增强。背部右肩胛线第8肋间可见两个针孔痕，两针斜形相距2.5厘米。化验室检查：血红蛋白12克%，红细胞420万。胸透：右侧胸腔大量积液，可见液平。

治疗经过：马上在右锁骨中线第2肋间穿刺抽气2000毫升左右，仍继续漏气。在抢救休克的同时，再行胸腔闭式引流，插管后自引流管涌出血性胸液350毫升。血压下降至8.0/5.3千帕（60/40毫米汞柱），予输新鲜血液600毫升，2个小时后血压回升至14.7/10.0千帕（110/78毫米汞柱），继续输液、吸氧，纠正酸中毒，给止血剂，抗感染等综合处理，3小时后血压升至16.0/11.8千帕（120/88毫米汞柱）。次日又引流血性胸液300毫升，输血300毫升，血压平稳。第3日胸透示，右胸腔中等量积液，侧位透视液体靠后形成包裹。又自腋后线第7肋间穿刺抽出血性液体达1000毫升，血压亦降至13.3/9.3千帕（100/70毫米汞柱），遂决定手术治疗。开胸后，自右胸腔中取出鲜血及血块达1500毫升，肺表面、肺裂、肋隔角及心隔角等均有大量凝血块和纤维素块包裹。右肩胛线第8肋间之壁层胸膜，可见2个针孔，周围充血水肿及轻度糜烂，右肺下叶背段有一直径为0.2×0.1（厘米）的脏层胸膜损伤，其深处为背段血管。破损之肺组织予以修补，鼓肺无漏气，冲洗胸腔，下闭式引流关胸。术后平稳，一般情况好，多次胸透仅示右膈角有少量粘连，19天后痊愈出院^[59]。

【案例13】

据报道，在其所收治的18例针刺致气胸中，4例是针刺背部腧穴不慎引起的，多在针刺实施之当时或不久之后，即感胸闷不适、呼吸困难、气短、紫绀等，胸部叩诊患侧呈鼓音或过清音，听诊呼吸音低下或消失，胸透示肺脏被压缩。经治疗均获痊愈^[14]。

【案例14】

吕××，女性，28岁。因落枕致颈部不适，已接受针刺治疗3次，第4次复诊时仍隔衣取背俞穴，针后加拔火罐。骑车回家，途中感到胸部闷痛，以后症状渐加重，翌晨去某院诊治，摄片见左肺压缩70%，肋脊角变钝，伴少量积液。据针治的医生称，取穴为大椎、大杼、肩中俞、风池，经多方鉴定，其中有一针刺痕

迹位于肺俞穴上 0.2~0.3 厘米处^[47]。

【案例 15】

刘×，男性，56 岁，工人，于 1989 年 8 月 6 日初诊。慢性支气管炎 6 年，并发肺气肿 1 年，目前病情较稳定。是日因胸 4、5 椎脊间韧带损伤，予以阿是穴、膈俞（双）梅花针叩刺，拔罐，但在起罐后患者即感胸痛，胸闷，憋气。检查见胸部叩诊呈过清音，听诊呼吸音低下，X 线示左胸肺压缩 20%。拟为气胸，予以对症处理。约 20 天后，积气吸收^[60]。

【案例 16】

施××，女性，26 岁，于 1989 年 10 月 9 日入院。缘患者于前天上午因右肩酸痛，在某医院接受针灸治疗，穴取患侧之风池、肩贞、曲垣、曲池 4 穴，针毕后约 3 小时左右，开始出现胸闷气急，右侧胸背部疼痛并向腹部放射，咳嗽时疼痛更甚。症状进行性加重，半小时后停止发展，因其尚能忍耐，故未予重视。今晨症状仍未改善而来诊。体格检查：体温 37℃，脉搏 84 次/分，呼吸 21 次/分，血压 21.3/10.7 千帕（160/80 毫米汞柱）。呼吸稍促，唇无紫绀，气管轻度左移。右肺中外侧语颤减弱，呼吸音减弱，叩诊过清音。X 线摄片示，右肺压缩 30%。即收入病房。经镇咳、抗炎等对症处理，观察 1 周胸痛已除，余症如初，胸透示气胸无明显吸收。即抽气 500 毫升，胸腔测压由抽气前的 +2~-4 毫米水柱降到 -1~-8 毫米水柱，随即症状缓解。2 天后摄片复查，示气胸消失，痊愈出院。随访两个月无复发。

【讨论】

背部的许多穴位皆在肺脏的投影区内，针刺不当时极易穿透胸膜伤及肺脏，导致气胸的发生。以上的十几个案例，主要是因为术者缺乏基本解剖知识或是因为术者施针不慎，未能根据患者体格的胖瘦选用适当的长短针，以及针刺的深浅掌握不准，或是未能根据患者的病变情况而施以重叩手法，导致不同程度的气胸发生。

【临床表现】

针刺引起的气胸，其发病的缓急和临床症状的轻重，均取决于肺组织损伤和肺萎陷的程度、病人的敏感度及其原来的肺功能

状况，一般可将它分为轻、中、重度3型，具体请参见前述。

【处理方法】

气胸发生后，要及时给予治疗，以免贻误病情。临床上，可根据胸腔积气的情况和肺脏被压缩的程度，而采取不同的治疗方法（参见前述）。

【操作要点】

气胸的发生，主要为术者操作不慎，或缺乏经验进针过深所致，故预防的关键在于术者针刺肺脏投影区内及其周围的腧穴时，一定要严格掌握针刺的深度，根据病人的具体情况而定（如病者的体位、胖瘦及穴区局部解剖等）；其次，施术过程中手法不宜太重过强，不应反复提插、捻捣，直刺不要留针，也不要针上拔罐（肺气肿患者尤须注意），若需用温针时术者应一手扶住针体，一手捻上艾炷，以防止针体深移；再次，出针后要注意观察，凡怀疑有气胸可能者，应及时给予确诊和处理，既不能隐瞒，也不能存有侥幸心理，以免延误治疗；最后，初学者应尽量少选背腧穴，可用远道取穴法代之，若一定要使用肺脏投影区内及其周围的穴位，则要小心谨慎。

二十五、针刺陶道穴引起脊髓蛛网膜下腔出血

【案例】

陈××，男性，17岁，学生。1991年5月20日深夜就诊于某院急诊室。主诉：双下肢不全瘫5小时。现病史：昨天，因觉颈项酸痛在校医室经某医生用针深刺后背上部第1脊柱间隙约1.5寸，出针后又在穴上拔罐5分钟，当时仅觉后背不适，但一直不见好转，当晚感觉双下肢麻木，活动受限，后背及后颈部疼痛，轻微头痛，近5~6小时二便未行。体格检查：神志清楚，问话回答准确，瞳孔等大正圆，眼球运动良好，光反射正常，伸舌正中，无面瘫。双上肢活动正常，双下肢不完全瘫，肌力Ⅲ级，双下肢痛觉正常，深感觉减退，腱反射正常，巴氏征（+），霍夫曼征

(一), 颈强 (+)。当即行腰穿, 见有血性脑脊液, 压力 2.7 千帕 (275 毫米水柱)。诊断: 脊髓蛛网膜下腔出血。经过 3 日治疗, 患者基本恢复正常, 只有颈强, 屈颈略疼痛, 能独立行走, 亦能自行排尿、排便。遂转回当地医院治疗观察。1 个月后, 诸证尽愈, 无后遗症。

【讨论】

脊髓是中枢神经系统的一部分, 呈前后稍扁的圆柱形, 外包以被膜, 位于椎管内而与脊柱的弯曲度一致。从脊髓实质到椎管壁之间有软脊膜、脊髓蛛网膜、硬脊膜 3 层; 从椎管壁至体表还分别有黄韧带、棘间韧带、肌肉、皮下组织等结构。由于椎管是由椎体构成, 椎体与椎体之间有椎间隙, 因此针尖有由椎间隙直接伤及脊髓的可能, 故位于第 1、2 胸椎棘突间的陶道穴, 其针刺深度只可达及黄韧带, 若深刺时针尖可穿破硬脊膜到达脊髓蛛网膜, 引起其周围的小血管出血, 最终导致意外的发生。本例正是由于术者使用较粗的 26 号针具, 刺入穴位达 1.5 寸深 (正规操作是向上斜刺 0.5~1 寸), 引起脊髓蛛网膜的小血管出血, 再加上 5 分钟的拔罐, 更促进出血, 并经腰穿确诊 (因患者无外伤史, 仅轻头痛, 无脑膜刺激征), 是针刺后引起的脊髓蛛网膜下腔出血。

【临床表现】

脊髓被针刺损伤所导致的脊髓蛛网膜下腔出血, 其临床症状主要表现为脊髓挫裂伤而引起的脊髓功能障碍, 即呈一侧或双侧下肢不完全性瘫痪, 病人不能行走或呈跛行步态, 明显的感觉迟钝, 损伤节段以下的肌张力降低, 直肠和膀胱括约肌的功能障碍, 各种反射消失; 以及蛛网膜下腔出血的某些表现, 如轻微头痛, 腰穿见脑脊液压力增高, 呈均匀血性, 但无明显的脑膜刺激征。一般临床上起病较急骤, 有针刺史, 且通常可在几周后症状消退, 但仍遗留有某些后遗症。

【处理方法】

1. 保持安静, 绝对卧床休息, 并注意大便通畅, 勿用力咳嗽及排便。

2. 肢体运动障碍的恢复需时约数周或数月, 可配合理疗或针

灸疗法，取穴以局部和邻近为主。亦可采用高压氧疗法等。

3. 为促进恢复，可给复合维生素 B10 毫克，1 日 3 次；或舒筋活络丸，1 日 3 次，每次 1 丸。

4. 症状明显者，可采用脱水疗法（尿素、甘露醇）以消除脊髓水肿，激素治疗（糖皮质激素为主）以及低温疗法等。若症状仍逐渐加重者，则应请有关科室会诊治疗。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：由第 1 胸神经后支的内侧支分布。
2. 皮下组织：有上述皮神经的分支通过。
3. 斜方肌腱：两侧斜方肌腱于此处汇合并附着，斜方肌由副神经和第 3、4 颈神经支配。
4. 棘上韧带：由第 1 胸神经后支分布。
5. 第 1、2 胸椎棘突间的棘间韧带：由第 1 胸神经后支分布。

【操作要点】

为了避免针刺陶道穴不慎导致意外的发生，术者在操作时应注意以下两个方面：要掌握好针刺的深度与方向，一般陶道穴的针刺尺寸是 0.5~1 寸，即先直刺 0.2~0.3 寸，然后略向上刺 0.5~0.8 寸，不宜深刺，更不应为了盲目寻求“触电感”而深刺猛刺；术者应熟悉不同层次的手下针感，即当刺入皮肤后手下有空松感觉，随着毫针继续缓慢进入深部组织则手下有涩滞感（这种感觉与毫针在聚乙烯泡沫海绵中提插时相同），当毫针进一步下插时则手感阻力加大而有坚韧感，当毫针继续下插且穿破黄韧带时，手下就会出现突破感，则应立即停止进针。此外，对于不合作病人，操作时更要谨慎，一般不留针，若确因治疗需要而留针时，应密切观察，以防不测。

二十六、背部腧穴施术不当导致过敏反应

【案例 1】

某一女性患者，43 岁，工人。因坐骨神经痛用维生素 B₁、B₁₂

各1支，穴位注射于左侧大肠俞、环跳、委中，施术完毕后在回家途中，即感双手心发痒、发红、胸闷、腹痛、恶心呕吐，伴头晕、出冷汗，继而不能支持，到家时离注射后已20分钟，送回科内复诊。体检：急性痛苦面容，呻吟不止，辗转卧位，心音低钝，律齐，双肺正常，呼吸略急促，腹软，脉微速，血压16.6/11.3千帕（125/85毫米汞柱）。即针双内关穴，并用25%葡萄糖水40毫升加维生素C500毫克静脉注射，致敏过程约2小时，患者恢复常态，自走回家。以后改用针刺疗法治疗。1周后又重复应用维生素B₁、B₁₂穴位注射于左侧肾俞、承扶、承山穴，注射后3分钟，患者即诉不适，急于平卧，脉细弱而数不清，面色苍白，冷汗淋漓，四肢发冷，立即皮下注射肾上腺素1支，患者仍呻吟不止，掌心发麻，吐出胃内容物两大碗，腹痛，有便意。又静脉注射25%葡萄糖40毫升，约1个小时后脉转平稳，心率每分钟80次，下午仍有双手震颤，过敏达10小时之久，诸症消失^[61]。

【案例2】

有一男性患者，54岁，工人。因右肩关节疼痛、屈伸障碍而接受针灸治疗，穴取右肩井、肩三针诸穴，直刺0.5寸，得气后用电针法。但通电后不到1分钟，即见其面部、四肢、胸腹等处皮肤上突然发生大小不等、形态不一的风团。瘙痒难忍，立即断电停止治疗，约10分钟后症状自行消失^[62]。

【案例3】

某一女性患者，46岁，教师。因患冠心病、心功能不全来门诊求治，于当日及次日在心俞穴、膈俞穴各注射复方丹参液4毫升（每次取双侧一穴）。次日先觉咽喉部发痒，至下午发现注射部位红肿，当晚下半身出现大片荨麻疹，奇痒难忍。患者未用过其他药物。第2天皮疹逐渐消退，2天后消失。后作过敏试验，证明该患者对复方丹参液呈阳性反应。

【讨论】

过敏反应是一种变态反应性疾病，针灸疗法本身仅是一种物理疗法（即针的机械性刺激或灸的温热性刺激），一般是不会引起过敏反应的。但是，随着针灸医学的迅速发展，现代的电、磁、激

光、埋线、某些药物制剂也逐渐成为刺激穴位的手段，它们既给针灸医学充实了内容，促进了针灸的发展，又同时带来了一些新的副作用，过敏反应就是其中之一。例1和例3正是针灸临床常见的因穴位注射导致的过敏反应，属于Ⅰ、Ⅱ型变态反应。其主要由于致敏抗原（维生素B₁、B₁₂或复方丹参液）进入人体后，诱发产生IgE类抗体，并与血管周围肥大细胞和血循环中嗜碱性细胞结合，当致敏抗原再次侵入体内并与细胞表面IgE特异性结合后，引起肥大细胞膜层结构稳定性改变及其内部一系列生化变化，促使脱颗粒和过敏介质的释放（如组胺、激肽、慢反应性物质、肝素等），引起血管通透性增高，毛细血管扩张，产生过敏反应。而例2则是由电针疗法所引起的（因患者自诉以往曾多次接受过针刺治疗，均无类似反应，而本次用电针后即出现过敏反应的症状）。虽然临床上极少见，但当患者本身具有过敏体质时，电流有时亦可成为致敏原，诱发某些患者产生IgE类抗体，进而使人体内部发生一系列生化变化，引起血管通透性增高，产生水肿、风团、瘙痒等过敏症状。

【临床表现】

以过敏性皮疹最为常见，即局限性（穴位周围区域）的红色小疹，或全身性的风团样丘疹，往往瘙痒难忍，浑身发热，重者可伴有胸闷、呼吸困难，甚至面色苍白，大汗淋漓。一般临床症状多发生于施术过程中或施术完毕后不久。

【处理方法】

有局部或全身过敏性皮疹者，一般于停止该疗法后不久可自然消退，在此期间应多饮水，并可用抗组胺、维生素C等药物，或注射高渗葡萄糖以加强排泄。如兼奇痒、口干、发烧、烦躁不安等症状时，可适当应用皮质激素，如强的松10毫克，每日3次；中药清热凉血、消风解毒方剂效果亦不错，如方用鲜生地20克，丹皮9克，赤芍9克，蒲公英30克，板蓝根30克，苦参、茯苓、山栀、车前子各12克，生甘草3克，水煎服。

当表现为面色苍白，大汗淋漓，脉象细微时，除了肌肉注射抗组胺药物外，还可肌注或静注肾上腺素，必要时注射肾上腺皮

质激素等药物。

【操作要点】

为了预防施术过程中引起过敏反应的发生，医者在操作前应仔细询问病史，了解病人有无对该药或该法的过敏史。对一些已知可引起过敏反应的药物，均应先作过敏试验，证明无反应者方可使用。此外，在施术过程中要注意观察，一旦出现过敏反应的先兆（如发生全身性或对称性皮疹），应立即停止治疗，及时给予相应的处理。

二十七、消毒不严导致局部感染

【案例 1】

王××，女性，24 岁。2 年前顺产一男孩后，腰骶部经常反复酸痛，1 个月前加重。于半月前因腰骶部酸痛难忍而作针刺治疗，在左右腰臀部各扎 3 针，相当于膀胱经之次髎、小肠俞、秩边穴，针刺过程良好。右侧出针后，有一针孔出血，随即自己用手擦出血处，其后该处略有肿胀、疼痛，且肿胀范围日益增大，疼痛加剧。1 周后，伴有畏寒发热、食欲减退及全身不适。经连续数日用青霉素、磺胺类药物，局部热敷及休息等综合治疗，未见好转，局部肿块约 8×8（厘米）大小，波动明显。后在大量抗生素应用下，住院作切开排脓术，放出脓液达 65 毫升。10 天后痊愈出院^[63]。

【案例 2】

陈××，男性，32 岁，教师。因咳嗽 2 周就诊。自诉开始时头痛发热，四肢酸楚，鼻流清涕，继则喉痒作咳，吐痰清稀，曾用消炎止咳药无效，近来咳嗽增剧，且咽喉作痛，声音嘶哑，胸部隐痛，背部板滞不舒，舌苔薄白，脉浮紧。此为风寒束表，肺气不宜。治拟疏风解表，宣肺化痰。穴取肺俞、阿是（背部）、合谷、外关、丰隆等穴，均用泻法。期间因气候寒冷，肺俞、阿是两穴予隔衣进针，第 4 天患者自觉背部针刺处痒痛，并有粟粒大小的皮肤隆起，但未予介意。1 周后局部疼痛加剧，遂发现针孔周

围明显红肿，直径约3厘米左右。后按炎症处理，5天后痊愈^[45]。

【讨论】

因针灸导致的感染，是临床上最为常见的针灸意外之一，它包括了针刺损伤所致的外科感染和针刺传播（即指针刺工具作为媒介物传播致病微生物）两类，这里主要是讨论前者。正常情况下，人体具有局部和全身的防御功能，而皮肤是保护机体的天然屏障，病原微生物是无法侵入机体导致病变的。当针刺损伤了皮肤表面时，如果使用的针具消毒不严或针刺后局部保护不妥，则致病菌会从穴位创口直接进入机体，在局部组织和全身抵抗力比较低的情况下造成感染，引起局部组织发生炎症反应，如创口感染、急性蜂窝织炎、脓肿等。例1是由于术者手指消毒不严，又不能保护好针刺局部，导致局部的化脓性感染；例2则是由于术者使用隔衣进针法，未能进行穴位皮肤消毒，致使针刺过程中将体表的致病微生物带入较深层的组织内而引起炎症反应。

【临床表现】

因感染的程度、性质等的不同，而有较大差异，一般可分为局限化脓性感染和全身化脓性感染。

局限化脓性感染：开始在针孔周围发生硬结，颜色潮红，并有轻微疼痛。如果治疗不及时，可继续扩大，并伴有全身不适、发热等症状，局部出现波动，硬结逐渐变软，中央有黄色的脓头。如果感染发生在深部，则波动感不明显，但脓肿表面有水肿和显著的局部压痛，全身症状也较明显。

全身化脓性感染（局限化脓性感染未能控制，或病人体质虚弱、机体免疫能力低下，大量毒力强的病原菌在血中繁殖、产生毒素而引起）：起病急骤，高热（可达40~41℃），头痛、头晕，食欲不振，恶心呕吐，关节痠痛，呼吸急促或困难。病情若继续发展，可出现感染性休克。实验室检查：白细胞计数增加（可达2~3万），中性粒细胞在80%以上，幼稚型白细胞明显增多。

【处理方法】

局限化脓性感染的处理：宜令病人患部休息少动，以减少疼痛及炎症扩散，并不得挤压患处。可用鱼石脂软膏或金黄膏外

敷，日换1次，局部及其周围尚可配合热敷、理疗（多用艾条熏灸，痛者以灸至不痛为度，未化脓者能予消散，将化脓者可促使化脓，已成脓者可促使破溃）。适当应用消炎止痛、清热解毒的中西药，如中药用五味消毒饮煎服，日1剂；或牛黄解毒片，成人每次4~5片，日3次；西药用青霉素，成人每次80万单位肌注（先作皮试），每日2次，或四环素每次0.25克口服，每日4次。一旦脓肿成熟，应立即切开引流排脓，并可辅以去腐生肌之中药。

全身化脓性感染的处理：应选择抗菌谱广的抗菌药物，或两种抗生素联用，要求剂量宜大、疗程应长，并可加用清热解毒、养阴凉血的中药汤剂。注意给患者充分补充水分、蛋白质和营养，纠正电解质代谢失调和酸中毒，必要时输入新鲜血液。病情严重者，宜考虑使用冬眠疗法或激素治疗。此外，病人应卧床休息，减少活动，注意患处的护理。

【操作要点】

一般来说，针具和穴位的消毒是预防针刺感染的重要一关，任一环节的忽略都极易导致感染，故术者应建立正确的无菌观念，执行严格的消毒制度。杜绝隔衣进针，谨防感染。在有感染病灶的部位，应尽量避免针刺。出针后如遗留针孔较大或有出血现象，应用消毒干棉球轻轻揉按，使其止血及闭合。针刺部位要注意保持清洁，在2个小时内不要用生水洗涤。若已有感染则患处切忌挤压、针刺，或过早切开排脓，以防止毒素或细菌侵入血液。对感染应该尽早治疗，防止其扩散。除用药物治疗外，同时还要注意支持疗法，以增强病人抵抗力，早日消除炎症。

二十八、三棱针点刺背部导致皮下血肿

【案例】

某一女性患者，45岁，农民，患十二指肠溃疡已10年余，起始为有规律性疼痛，近1年来已失去规律性，夜间时常痛醒，饮食减少，身体瘦弱，神倦，苔薄白，脉弱。背部在肝俞与膈俞之间有压痛，并有条索状反应物。治疗用三棱针从压痛区中点，点

刺入皮下，上下行针，间歇操作约1分钟后，右侧出现皮下血肿，如鸭蛋大小，急出针。当时未予压迫，当作自血疗法，1周后血肿完全吸收。以后针刺足三里等穴，患者腹痛减轻^[45]。

【讨论】

因针刺不慎引起皮下血肿，是临床上较为常见的意外事故之一，虽然它不会造成严重的后果，但仍会给病人工作、生活造成极大的不便，亦会引起病人的精神紧张，故应尽量避免。从解剖学得知，人体的表皮内无血管，真皮和皮下组织的血管却十分丰富，有两组平行排列的血管丛，浅血管丛位于真皮乳头层与网状层之间，深血管丛位于真皮和皮下组织之间。在针刺时，行浅刺法，针尖停留于血管丛区，而且予捻转、提插等手法，完全可以伤及这些血管而引起出血。若皮下血管丛出血，如针具较粗，针孔未能闭合，血流可流出于体表；若针孔闭合，出血量少则形成小血肿或瘀斑，出血量大则形成大的血肿。本节案例正是由于术者的错误，选择粗且锐利的三棱针作单针操作，误伤了背部皮肤的血管，而导致皮下血肿的发生。

【临床表现】

轻症：在拔针后，针孔有少许出血现象，当时局部多未见异常，数小时后于穴区周围显现出青紫色的瘀斑（系刺破浅层血管或较细小的动静脉分支所致）。

重症：血管表浅、肌层较薄处，鲜血可自针孔流出或呈喷射之状；血管位于肌肉深层，则可依其损伤程度而出现大小不一的血肿，并能产生压迫症状（如在颈部会因压迫气管而出现呼吸困难，如在臀部则会造成行走不便等）；胸腹部的血管破裂后，血液会流入胸腹腔而引起内出血症状，严重者出现缺血性休克。

【处理方法】

浅表点滴出血：仅需用消毒干棉球压迫针孔1~2分钟即可，一般不予特殊处理。皮肤瘀血斑可在出血停止后，用湿热毛巾外敷，每次20分钟左右，促进溢出血液的消散吸收，斑块多数在3~5天最多7~10天内可自行吸收。

较大的血肿：急性时期应予冷敷（如用纱布蘸蒸馏水或冷开

水冷敷局部 15~20 分钟，这利于止血），或用注射器抽吸；如出血已停止，可改用热敷以助吸收，一般 10 天左右可以消散。若损伤四肢较大的动脉或裂口较大而血出不止者，则在针孔处加压包扎，仍然不止者可转外科手术结扎或修补。

体腔内的出血：症状表现较轻者，可以在严密的观察下选用药物止血，如用安络血、止血敏、仙鹤草素等；如果出血量较大，病人出现明显的休克症状，则在止血的同时应进行抗休克治疗（紧急输血或血浆，用升压药物等），并可配合艾灸人中、百会，针刺素髻、足三里、涌泉等，必要时进行外科手术。

【操作要点】

在针刺治疗中，为了避免伤及血管，应注意以下几点：首先，要认真选择和检查针具，一般多用体直、光滑、有弹性、无折痕锈蚀、针尖不带钩毛者，注射针、三棱针、缝衣针等因头部太锐利、针体过粗，针刺时易引起出血，故较少用；其次，要细心避开血管。因为人体的许多穴位都处在血管之上，在血管附近的穴位那就为数更多了，故针刺的时候应该注意。凡是那些容易摸着或肉眼可见的血管，针刺时应用左手拇指将血管推开后，针尖沿指甲刺入；深部的血管则不易观察，只有借助于解剖知识以避开；再次，切忌为盲目寻求针感，针刺深度过大，或提插捻转的手法过重，或取穴不准等而误伤血管。术者一定要细心体会手感，如针尖遇到有坚韧光滑的阻力感，或病人自诉疼痛明显时，即宜退针变换方向后再施术；最后，针刺前还应详细、严格询问病史和检查病人，对有血管病变者，应尽量少选用可能伤及主要血管的穴位；对有凝血机能障碍等的出血性疾病患者，不宜针刺，应劝其采取别的中西医疗法治疗。

二十九、推拿不当导致肋骨骨折

【案例】

龚××，女性，55 岁，农民，1968 年夏日门诊。慢性腰背疼痛 10 余年，每遇劳累、受寒冷刺激后其背痛加剧，不能耐劳，伴

有沉重感，近数月来因腰背部疼痛已不能从事正常农田劳动，经药物、针灸、理疗等医治无效，来门诊推拿。专科检查：双侧骶棘肌痉挛，肌张力增高伴较广泛压痛，皮肤毛孔增粗，轻度圆背畸形，颈、腰椎运动功能基本正常。拟诊：腰背风湿痹痛。采用局部手法推拿加热敷治疗。在某一次推拿治疗时，病者取俯卧体位，医师先在两侧骶棘肌用掌根按揉法和擦法，而后双手重叠在背部重力向下按压，瞬间听到骨断裂的响声，病人呼痛不止。经X线摄片确实为右侧第6肋骨腋中线处骨折，移位不明显。用胶布固定而愈^[63]。

【讨论】

人体共有12对肋骨，上7对肋骨借助软骨直接附着于胸骨，第8至10肋借第7肋软骨间接附着于胸骨，最后2对肋骨前缘游离，不与胸骨或上位肋软骨相接；肋骨头与胸椎相关节，结节与胸椎横突相关节。肋骨体的后1/4呈圆柱形，前3/4呈扁平。正常情况下，肋骨本身富有弹性，有缓冲外力的作用，不容易发生骨折，尤其第1至第3对肋骨（因其短小，又被肩胛骨、锁骨及上臂所保护）和浮肋（因其弹性最大）是最不易受伤的，而以较长的第4至第9肋最常发生损伤。本案例的患者为老年人，其肋骨已逐渐失去弹性，肋软骨也常有骨化，在推拿治疗时因术者双手重力挤压胸廓后部，使患者胸腔的前后径短缩，左右径增长，致使她的肋骨侧部发生断裂，从而造成骨折。

【临床表现】

在推拿过程中病人突然感觉局部疼痛，当深呼吸、咳嗽、喷嚏或转动躯体时疼痛加剧，有明显的压痛，偶尔可摸到骨擦音，两手前后位或左右位挤压胸廓均可引起骨折处剧痛。骨折部软组织可能见有血肿、瘀血等受压痕迹。若病人出现胸闷、气急、呼吸短浅、咯血、皮下气肿时，应考虑肋骨骨折产生胸部并发症。若出现胸壁下陷，在呼吸运动时与正常胸廓步调不一致，出现反常呼吸，则属多根肋骨多处骨折所造成。

胸部X线摄片检查，可以明确骨折的部位、根数，而且可对有无胸内并发症提供依据。

【处理方法】

单纯肋骨骨折，因有肋间肌固定，很少发生移位，所以可用胶布固定胸壁，限制胸壁呼吸运动，让骨折端减少移位，以达到止痛目的。其胶布固定法是（临床上多用于5~9肋少数肋骨一处骨折，对多根骨折、老年、肥胖及皮肤有过敏的病人不宜使用）：每条胶布宽5~7厘米，长度为胸廓的半周加10厘米。病人取坐位，两臂外展或上举，当呼气之末即胸围最小时，先在后侧超过中线5厘米处贴紧胶布，由后绕向前方跨越前正中线5厘米，第1条贴在骨折部，而后以叠瓦状（重叠1厘米）向上和向下各增加2~3条，以跨越骨折部上、下两肋为宜。

若病人出现有胸部损伤的并发症，应及时请胸科会诊，排除险情。

【操作要点】

为了预防推拿治疗时肋骨骨折的发生，术者应注意以下几个方面：首先，要了解年龄情况，由于儿童和青年时肋骨富有弹性，不易折断，但成年及老年人的肋骨已逐渐失去弹性，肋软骨也常有骨化，容易发生骨折，所以对老年病人要慎用背部按压手法；其次，要详细了解病情，当肋骨有病理变化，如骨营养不良、原发性或转移性恶性肿瘤等，无需明显暴力也会发生骨折，若对这些病情不掌握，施用背部按压手法是极其容易造成医源性、病理性骨折的；最后，要掌握好手法的使用，由于推拿治疗床是硬质铁木类结构，所以上背部俯卧位推拿时，要慎重选用挤压手法，尤其是双手重叠较重型的掌根按压法宜慎用，若是必需使用者，宜注意手法的力量不可以过重和过于持续。

三十、推拿不当导致腰椎压缩性骨折

【案例】

某一男性患者，55岁，工人。因慢性下腰部疼痛、乏力数年，前俯后仰活动不便，且缠绵不愈，每当劳累或受凉后腰部疼痛即加重而来诊。专科检查：腰椎平坦，未见明显侧突，腰部前屈20°，

后伸 10° ，左右侧屈各 15° ，直腿抬高试验大于 60° ，直腿抬高加强试验阴性，膝、踝反射对称，棘突、棘旁无明显压痛及下肢放射痛，骶棘肌张力增高，双侧腰₃棘突旁均有压痛，以左侧为甚。腰椎 X 线提示：腰椎有不同程度的骨质增生和骨质疏松，诸椎间隙和椎体形态属基本正常。推拿治疗时以揉法和按揉法为主，经 1 疗程医治，腰痛有一定程度缓解。然而在某次推拿治疗时，为了改善腰部前屈的运动功能，在病员仰卧位时，做急躁剧烈地双下肢屈髋屈膝加腰部前屈的被动运动，病人急呼腰痛似裂，动弹不得。经腰部 X 线摄片提示：第 1 腰椎呈明显楔形改变，拟诊为第 1 腰椎压缩性骨折。按单纯性腰椎体压缩性骨折处理而愈^[33]。

【讨论】

脊柱在全身骨骼中占有重要的地位，人体任何部分的负重，受到冲击与压迫，其力量均可传达到脊柱。由于脊柱是许多内脏的附着点或保护器，脊柱管腔包围脊髓（起保护作用），且四肢与头颅均直接或间接的附着在脊柱上，因此，脊柱的损伤可严重影响内脏，更能造成脊髓损伤，必须引起高度警惕。本病例所采用的双下肢屈髋曲膝运动，临床上常用来解除腰骶后关节滑膜的嵌顿和缓解骶棘肌的痉挛，一般是不会发生意外的。当病人仰卧位而过度地双下肢屈髋曲膝时，首先会使腰脊椎生理弧度消失，并逐渐发生腰椎前屈，胸腰段椎体前缘明显挤压，在此基础上再骤然增加屈髋，则腰部急躁前屈的冲击力量，就由下向上传达到胸腰段（胸椎活动度小，腰椎活动度大）的交界部位，很容易导致该部位的压缩性骨折。

【临床表现】

推拿治疗造成腰椎压缩性骨折损伤后，脊柱即有局限性自发性疼痛，脊柱运动障碍和活动时疼痛明显加重；体检可发现脊柱局部有向后成角畸形、血肿、压痛、叩击痛。另外，还要注意有无伴脊髓损伤（多表现为部分或全部脊髓的暂时性的传导障碍，包括节段性感觉障碍、运动障碍及直肠和膀胱括约肌障碍，各种反射消失等），一旦发现脊髓有压迫现象，应及早解除压迫，以利脊髓神经功能的康复。

X线摄片检查，可以确诊，用以确定脊柱骨折损伤的部位、程度、类型和治疗方法。

【处理方法】

1. 搬运要确当。若搬运不当，常可引起脊髓不可挽回的严重损伤，即使对于脊柱损伤的可疑患者，也应按脊柱损伤的病人搬运。其搬运的正确方法：先将侧卧或仰卧的病人四肢理直，让其上肢贴附在胸壁两侧，再将担架（最好用木质担架，亦可用铺板或门板代用）置于病人的一侧，搬运时以4人为佳，应一人扶头、一人抬脚、中间两人用宽布带托住脊柱骨折部，避免屈曲，抬起或放下病人时务求4个人的动作保持一致。

2. 治疗要及时、正确：①对于单纯性椎体压缩性骨折（指椎体压缩变形小于 $1/2$ ，无脊髓损伤者），可采用非手术治疗。其方法是，让病人仰卧于木板床上，在损伤椎局限性后凸畸形处垫一小枕头，使之逐渐得以伸展，待疼痛稍有缓解，即可开始做腰背肌锻炼。这样不但能使压缩的椎体复原，而且由于早期功能锻炼不致于产生骨质疏松现象，同时还能增强背伸肌的力量，避免慢性腰痛后遗症的发生。②对于脊柱不稳定损伤（指椎体压缩变形大于 $1/2$ ，同时伴有棘上、棘间韧带损伤或附件骨折者，或伴有脊髓损伤者），应以手术治疗为主。

【操作要点】

在做双下肢屈髋曲膝的被动运动时，只要不再附加腰部前屈的冲击力，一般情况下是完全可以避免发生腰椎压缩性骨折的。此外，还要注意了解情况，对老年人或有骨质疏松的病人，不宜随便使用此类手法，以免造成医源性骨折。

三十一、针刺背部穴位导致晕针

【案例1】

周××，女性，46岁，工人。因颈肩肌筋膜炎疼痛3天来诊。穴取风池、肩井、肩外俞等，得气后予平补平泻法，隔日1次。患者于第4次就诊施针后半分钟，突诉头晕、心悸，随即神志丧失，

面色苍白，两目上视，四肢抽动，喉间痰鸣，立即撤针，使其平卧并抬高下肢，约半分钟后意识转清，全身汗出，静卧10分钟后除胸闷不适外其他症状基本消失。3天后仍诉有轻微头晕，心里不舒^[64]。

【案例2】

陈××，男性，19岁，农民。主诉：右胫外侧麻木，胫骨嵴外侧小腿下2/3麻木，长约15厘米，宽约3.3厘米，皮肤微黄，苔白薄，脉缓濡。膝腱反射、运动情况、皮肤触觉检查以及大小便均正常。病前3个月，曾因上山为草刺伤后形成溃疡，愈后感麻木。印象为胫外侧浅神经麻痹。常规针灸4次，收效甚微，总是针后稍轻，1~2日后复故。第5诊取命门、肾俞，采取横肱俯伏坐位，针入仅3分，感觉到达足跟，出针后，患者诉头晕、眼黑，旋即出现面唇紫绀、呼吸迫促、两眼上翻、两脚伸直、两手挛缩、鼻出粘涕、无汗、脉搏沉数难以触到、神志丧失。即针人中、合谷，灌热茶……不醒，拿肩井、腋下，针三阴交，逐渐苏醒。晕针过程为15分钟，醒后5分钟又晕，仅神志不清，全身瘫痪，拿三阴交、肩井，持续10分钟始苏醒，并卧床休息半小时后返家。5天后复诊，自诉效果显著^[65]。

【案例3】

徐××，男性，38岁。平素身体健康，无晕厥史及心血管病史，于1971年10月5日因腰痛来作针灸治疗。当时检查诊断为腰部扭伤，乃予以在两侧腰骶部取阿是穴进行针刺，两侧各扎3针，中等刺激量，留针约25分钟，病人感觉良好，无任何不适，出针后又予以贴活血止痛膏两块。刚贴好，病人即诉内心难过，马上让其平卧，继之面色苍白，额部冷汗，脉搏细弱，神志不清。立即肌注可拉明1支，不见好转，迅即呼吸、心跳完全停止，大汗淋漓，面呈灰土色，唇指严重紫绀，一切反应消失。当即进行心脏按摩，同时肌注1:1000肾上腺素1毫升，非那根2毫升，继续按摩3分钟，患者突然一阵呕吐，心跳、呼吸开始恢复，神志慢慢转清，继给予高渗葡萄糖40毫升静脉注射，并以5%葡萄糖盐水500毫升静滴，约2个小时后，患者始下床，吃干饭半碗，完

全恢复健康^[66]。

【案例 4】

汪××，男性，22岁，泥瓦匠。于1972年7月15日下午2时就诊。患有风湿性心脏病，心尖区有Ⅱ级吹风样收缩期杂音，心界无明显扩大，也无心慌、气喘，能操重劳动，此外关节炎经常发作已有3年余。患者自觉腰部疼痛，左肾俞穴处有明显压痛点，遂卧位取该穴，用1寸毫针轻轻刺入约0.7寸，有酸胀感。此时患者自觉胸中不适，突然酸胀至全身，如坠五里雾中，好像一切都要吐出来似的，面色灰白，冷汗出，不能自动，神志清，脉弱，脉搏105次/分，血压12.0/8.0千帕（90/60毫米汞柱）。急拔针，让其平卧，休息约60分钟之后汗渐止，脉搏减至88次/分，但仍感头昏，全身无力，也不能坐起，3小时后仍不能坐起。其家住本村，扶持回家后睡下未起，第2天仍卧床不起，乏力、头昏，至第3天下午症状才逐渐消失，起床劳动^[45]。

【讨论】

晕针是针灸临床上最常见的意外事故之一，虽然目前对晕针的发生机理尚无统一解释，但大多数人都同意它应属于血管抑制性晕厥。以上4例都是由于术者施术手法不慎，加上患者自身的各种因素，互相协同作用于机体，结果导致了一种所谓“超限性抑制”——晕针。此外，晕针的预后是良好的，多数患者不经任何治疗也可自行恢复。但对患者来说或多或少都是不舒服的，有时还有一定的痛苦，所以临床上应尽量避免。

【临床表现】

晕针大多发生于针灸过程中，但也有少数病人在取针后数分钟始出现症状，典型的晕针一般可分为3期，如前所述。

此外，根据临床症状，亦可将晕针分为轻、中、重三度（临床上以前两种多见）。①轻症：针刺过程中患者自诉头晕目眩，胸闷乏力，但呼吸和脉搏仍正常；②中度：头晕心慌，恶心欲吐，面色苍白，汗出肢冷，脉搏变细；③重度：全身厥冷，大汗淋漓，血压下降，脉搏细弱，呈昏厥状态。

【处理方法】

1. 常规护理：迅速拔出所有的针，将患者扶至空气流通处，并让其仰卧在床上，头低脚高位；及时松解患者衣带，热天注意通风，冷天注意保暖；立刻测量呼吸、血压、脉搏以及心率。

2. 轻者一般静卧片刻即可，如患者仍感不适，可给予温糖水或热茶口服，并注意使之安静和休息，约经 3~5 分钟后即可逐渐恢复。

3. 重者可在上述处理的基础上，用指掐或针刺人中、素髻、足三里、涌泉，或艾灸百会、关元、气海等穴；嗅以氨水；必要时可用肾上腺素 1 毫升、阿托品 1 毫克肌注，25% 葡萄糖 40 毫升静脉推注等。

【操作要点】

晕针多数情况下不经任何治疗也可自行恢复（恢复的时间决定于患者的体质和处理的适当否），且不遗留有各种后遗症。一般而言，为了防止晕针，临床上操作时要注意以下几点：首先，要做好心理预防工作，对那些对针灸猜疑、有恐惧心理者，或针刺时有哭笑、惊叫战栗、躲避、肌肉痉挛，伴有呼吸、心跳、皮温、面色、出汗等植物神经系统和内分泌功能改变者，均应做好语言诱导、转移其注意力、松弛训练等工作；其次，要预防各种容易导致晕针的诱因，如饥饿病人针前应适当进食，过度饱食者亦需待食物有所消化后方可施术；过度疲劳或激烈活动后，都应让患者稍加休息待其体力基本恢复才用针；大病后或大汗后病人，在针灸时要注意掌握刺激量，手法不宜过强，取穴亦不宜过多，并尽量采用卧位针刺；最后，起针以后，一般要令病者在诊室休息 10~20 分钟后方可离开，在此段时间内，一旦发现有晕针的情况出现，即应马上处理。

三十二、胃俞穴电针折针

【案例】

孙××，男性，61 岁。诊断为胃小弯溃疡，于 1975 年 6 月 16 日于针麻下施行胃次全切除术，胃空肠吻合术。手术结束拔针时，

发现在胃俞穴一根针断入肌肉内，针孔皮肤有一烧焦点，直径约0.1厘米，针身的上端也有烧坏点。当时即行手术切开，但未能找到断针。事后透视模糊不清，经摄片，针在第12胸椎与第1腰椎间，移动位置不大，故未再做处理。术后病人恢复情况良好，但诉说有时当吸气时背部有隐痛感，术后40天痊愈出院，以后定期摄片复查和随访。本例取穴至阳、筋缩、双侧胃俞、足三里、皮肤切口针（双）。背部均选用1.5寸长毫针，足三里用2.5寸针、皮肤切口用2寸针，都是新针且无扭曲。夹脊穴进针深2.5~3厘米，胃俞为2厘米左右，并以小纱布包裹针身后，使之倒向一侧，以胶布固定，避免针身与皮肤、电线接头与皮肤之间直接接触。电极接法为至阳与筋缩为一组，双侧胃俞为一组，皮肤切口针为一组，采用交流电电针治疗机，频率约为12000~14400次/分。此次断针，事后检查电针机时发现：①电线插座相线和中线（地线）在插错的情况下，电针机外壳有电，这种电流在一定条件下，会导致病人机体上有短路现象，这可能是由于病人背部流汗潮湿导电现象增强而致；②电压不稳，输出电流时强时弱；③变压器温度增高达126.5度，出现短路，并一电子管已坏^[67]。

【讨论】

断针是指针刺过程中发生的针身折断现象，属于针灸临床的意外事故之一。虽然由于现代针具质量的提高，这种情况不常发生，但仍有例陆续报道，故临床对此仍应加以注意。究其原因，临床上常见的有针具质量粗劣，发硬变脆，或术者操作粗暴，手法过重，或病人思想紧张恐惧，肌肉剧烈收缩，或留针过程中病人体位突然改变等。而本节案例主要是由于电针原因引起的，这亦是常见的导致断针发生的原因之一。目前使用的电针仪多数为脉冲电针，所输出的电流是一种经脉冲变压器隔去直流成分而仅使交流成分（只有交流成分对人体有治疗作用）通过的脉冲电流，即它的直流成分很少。但当电针机使用时间过长，或自制的电针仪的输出变压器未经严格检查，则可造成脉冲输出的波形中混有直流成分。当毫针进入人体以后，由于人体内部的体液是良好的电解质，故混入的直流成分将与人体的电解质形成直

流回路，这时两根毫针就好比电解电极，作为正极一方的毫针中的金属离子将离开毫针，通过体液向负极一方运动，从而引起两根毫针中的一根因电解而溶蚀、变细、生锈、发脆，甚至在体内断折。

【临床表现】

非重要脏器或关节部位断针：一般多不产生重大后果，其共同特征是，断针局部有压痛，并逐渐减轻。有时断针处有重压感，活动时偶可出现疼痛，但往往无运动障碍。当断针涉及周围神经时，则局部疼痛明显，其末梢处有麻木感，痛觉减退。

关节内断针：不论在大小关节内断针，都会呈现严重的运动障碍和疼痛。如肋间关节断针，多可出现吸呼困难，胸痛；脊柱关节断针，长时间活动后有剧烈的疼痛及运动障碍。

脏器内断针：此类情况往往比较严重，常因脏器的不同，和断针部位的不同，而引起程度不等的功能障碍和疼痛。若肺部断针，则有咳嗽频数，呼吸困难，并有肋间神经痛发作样疼痛；心脏内断针，则有剧烈的心绞痛样疼痛，呼吸困难，并可迅速进入休克状态；膀胱内断针，则可引起小便短数，排出困难，或有血尿。如果针断入于血管，则可能随血液流动，自动脉血管进入较小血管，出现疼痛或有栓塞的危险。

一般说来，断针常有两种情况，一是针身折断、残端尚露在皮肤之外，二是残端完全陷入皮肉内。其结局亦大致有4种类型：一是断针移动后，引起有关脏器组织疼痛或功能障碍，最后只能以手术取出，或于断针后即用手术或其他非手术的方法取出；二是自动向体外排出，皮肤和结缔组织的断针，许多情况下多能自行从体表或从肠道和粪便一起排出；三是在体内各种理化因子的作用下，断针逐步发生溶解，但这通常需要相当长的时间；四是断针位于机体内相对静止的部位，或因刺激周围组织发生感染，针体可为结缔组织或纤维组织所包裹，长期留在体内不变。

【处理方法】

当断针发生时，患者不可惊慌乱动，医者更不能紧张失措，而应嘱患者尽可能保持原有体位，以免针体向肌肉深层陷入，给处

理造成困难，这时医生保持镇静、沉着是重要的。

如果断针残端尚在体外，则可用手指或镊子夹住取出；若残端与皮肤表面相平，肉眼可见而又不能用指甲镊出时，可用手指将断针两旁的皮肤紧紧向下按压，使残端充分露出体外，然后用镊子取出。如果针体折断在重要脏器附近，或虽非重要脏器而患者自觉不适伴有功能障碍者，或由于针具、穴位皮肤消毒不严，断针带入细菌而在针道内生长繁殖已成为脓肿灶者，应请外科会诊，以手术取出为宜。另外，由于断针本身的重量和患者躯体的活动情况，血流动力的影响，脏器的蠕动，以及咳嗽、呼吸等情况，有时能使断针在体内发生移位，故在决定手术前应作好充分估计，以X线透视或摄片（正侧位片）来准确定位，然后才用手术寻获。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：分布有第12胸神经后支的皮支。

2. 皮下组织：有上述皮神经的分支通过。

3. 胸腰筋膜浅层、背阔肌腱膜和下后锯肌腱膜：胸腰筋膜浅层为腰背部的深筋膜，在腰部特别发达增厚，位于竖脊肌浅面，也是背阔肌的起始肌膜，由胸背神经和相应的腰神经后支分布。

4. 竖脊肌（骶棘肌）：该肌由脊神经后支节段性支配，到该穴区肌肉的神经主要是第12胸神经后支的内侧支和第1腰神经后支的内侧支。此外，在竖脊肌的深面有横突棘肌等背深部小肌肉。

【操作要点】

为了预防电针断针的意外发生，在施术时要注意以下几点：首先，对电针治疗仪应作好检查，尽量不用直流电针仪。而使用新的电针仪器及仪器使用过一段时间以后，都要检查是否有直流成分混入，若发生这种情况时则应及时作修理或调换（检查方法是，将电针仪器输出端的两根电线分别联接在浸于生理盐水的两根毫针上，毫针下端浸入盐水约2/3，两针相隔2~3厘米，然后将电针仪的输出电流强度及频率开至最大，通电约4小时左右，再观察盐水是否变为橙色，或有絮状沉淀析出，毫针是否生锈、变细等，即可判断）；其次，使用电针仪时要注意调节输出的电流强度（电流强度愈大，愈易发生断针，一般电针输出电压应在10V以

下)，通电的时间（以不超过 30 分钟为宜，否则通电时间愈长愈容易发生断针），以及输出电流的频率和波形（低频通电易断针，以高频刺激较好；而波形则应选择无腐蚀性波，如交流电的矩形波形）；最后，在作长时间的电针治疗或时间较长的针麻手术时，则在电针通电 1~2 小时以后，将同组输出的两根导线极性交换一下（在交换前应先将输出强度旋钮置于“0”位，然后关机，交换连接后，重新开机，直至病人感到舒适为宜），交换通电的时间应大致相仿。此外，还要求应定期更换使用时间过长的毫针，不使用弯曲、生锈或有其他损伤的针具，正确处理滞针、弯针等情况等。

三十三、针刺腰骶部阿是穴引起迷走神经反应

【案例】

某一男性患者，38 岁，汽车司机。于 1970 年 10 月 5 日因腰痛而作针灸治疗。检查一般情况良好，心肺无特殊，脊柱正常，腰扭伤后两侧腰肌有压痛。即在两侧腰骶部阿是穴针刺，每侧各扎 3 针，中等刺激，留针 25 分钟，感觉良好，无不适。出针后贴活血止痛膏 2 张，刚贴毕，患者诉说心里难过，扶其平卧，见面色苍白、冷汗、脉细、神志不清，肌注可拉明不见好转，很快呼吸、心跳停止，大汗淋漓，面呈土色，口唇紫绀，一切反应消失。即行胸外心脏挤压，肌注 1:1000 肾上腺素 1 毫升，非那根 25 毫升，持续挤压 3 分钟后，患者突然一阵呕吐，心跳、呼吸开始恢复，2 小时后恢复常态，3 小时后驾驶汽车返回。随访半年无特殊^[66]。

【讨论】

针刺引起迷走神经反应，是针灸临床上意外事故中较为凶险的一种类型，如果救治失时，措施不力，往往会造成严重后果。迷走神经是脑神经中最长和分布最广的一对混合神经，含有感觉、运动与内脏神经 3 种纤维成分，运动纤维分布于喉肌，感觉与内脏纤维分布于胸、腹腔脏器，管理它们的运动与感觉。当机体受到

针刺的机械性刺激时，可以兴奋迷走神经，致使迷走神经反射亢进，通过迷走神经传出系统，作用于效应器官而产生一系列症状。本节案例正是由于针刺阿是穴时刺激量过大，直接刺激迷走神经，发生迷走神经反应，出现冠状血管痉挛和心脏传导障碍，以致引起心跳骤停，支气管痉挛造成呼吸困难，还可见到恶心、呕吐等内脏反应。

【临床表现】

迷走神经反应在症状上的表现都是效应器官变化，发作突然，症状凶险，病情进展快。一般而言，临床表现以神经系统和循环系统的异常最为明显，其症状和体征可依次出现：①心音消失；②脉搏摸不到，血压测不出；③意识突然丧失，或在一短阵的抽搐（这种抽搐常为全身性，持续时间长短不一）之后出现意识丧失，这多发生在心脏停搏后 10 秒钟内；④呼吸断续，呈叹息样，以后呼吸逐渐停止，这多发生在心脏停搏后 20～30 秒钟内；⑤昏迷，多发生在心脏停搏 30 秒钟后；⑥瞳孔散大，多在心脏停搏后 30～60 秒钟出现。

【处理方法】

临床一旦出现迷走神经反应症状，即应马上停止刺激，将针起出，并及时进行抢救，这样就有可能使病人得到恢复，否则会造成脑和全身器官组织的不可逆损害而导致死亡。

当发生迷走神经反应时，应马上肌注阿托品（胆碱能阻滞剂，可解除迷走神经对心脏的抑制），每次用量 1～2 毫克，亦可静脉注射阿托品 1 毫克；还可肌注肾上腺素（能兴奋心脏，升高血压），用量为 0.5～1 毫升；并可针刺人中、素髻、十宣、涌泉、足三里等穴，进行抢救治疗。大部分病人经此治疗一般便可恢复。

如果出现心脏骤停，应及时采取下列急救措施：①以中等力量拳击心前区 1～3 次；②胸外心脏挤压术，成年人以每分钟 60～80 次的频率为宜，并需同时配合有效的人工呼吸（分口对口人工呼吸法和加压人工呼吸法两种），给予心脏内用药（一般在挤压 30 秒钟后，若心跳仍未恢复者，即应心脏内注入 1‰ 肾上腺素 1 毫升，然后再予挤压，可重复注射）。依然无效者，可施行胸内心脏

挤压术；③呼吸兴奋剂的使用，以 500 毫升的 5% 葡萄糖溶液中，加入山梗菜硷 15～30 毫克静脉滴注，或静脉推注尼可刹米 0.375～0.5 克/次、戊四氮 0.1～0.2 克/次等。

【操作要点】

迷走神经反应的症状与晕厥有些相似，故要求医者要细心观察，一边对症处理，一边明确区别，以积极抢救、防止意外。临床上预防迷走神经反应的方法较少，主要依靠临床细心观察和体会。下面介绍一个检查迷走神经功能是否亢进的方法（此法并不一定完全可靠）：根据心眼反射的原则，术者可在针刺治疗前，用自己的拇、食指缓慢压迫患者闭合的双眼，逐渐增加手指的压力，在 10 秒钟后脉搏减少超过 10 次/分者，则表示迷走神经亢进，针前就应有所警惕，施术时小心谨慎。

三十四、腰阳关穴直接灸导致晕灸

【案例】

董××，女性，46 岁。因患功能性子宫出血，腰阳关穴压痛（++），即采用直接灸法。当灸至 5 壮时，患者自诉心慌，眼发黑，四肢轻度颤抖，面色苍白，脉细弱。马上停灸，约半小时后复原。第 2 天仍在原穴先注入 2% 普鲁卡因 2 毫升，再采用直接灸，无不良反应，当灸至 7～8 壮时，下腹出现热感；灸至 10 余壮时，左腹及阴部热感增大，共灸 30 壮，出血被控制。40 余日后，灸疮愈合，血未再出。（录自《周楣声医话》，为未发表资料）

【讨论】

晕灸是临床上较为少见的针灸意外事故，究其发生的机理，主要是艾灸的刺激过强，引起超限抑制所致。即由于艾灸的强刺激，通过迷走神经的反射，引起全身外周血管（尤其是周围肌肉的血管）扩张，外周血管阻力降低，回心血量减少，因而心脏输出量减低，血压下降，造成一时性、广泛性的脑供血不足或脑缺血所致。本节案例的患者因患功能性子宫出血，出血时间延长，经量增多，表现为突然大量出血或淋漓不断，血之既虚，滋养心神之

力不足，神气随之亦虚，术者采用直接灸法，作用集中，刺激过强，从而引起超限抑制。

【临床表现】

晕灸多数发生于操作过程中，典型者可分为3期。先兆期：病人有各种感觉的错乱，如眼花、耳鸣、头昏，心悸，出冷汗，打呵欠，恶心欲吐等，但也有些病人的先兆症状不明显。发作期：轻者出现胸闷，头晕，恶心呕吐，肢体发软发凉，摇晃不稳，或伴瞬间意识丧失；重者突然昏仆在地，唇甲青紫，大汗淋漓，面色灰白，双眼上翻，二便失禁，少数患者还可有惊厥发作。恢复期：轻症仅有轻度不适，多数患者可有显著疲倦，头昏，嗜睡，汗出及全身不适感，短则几分钟，长则几小时，症状才能逐渐消除。

【处理方法】

1. 常规护理：迅速停止施灸，扶患者至空气流通处，并让其仰卧在床上，头低脚高位；及时松解患者衣带，热天注意通风，冷天注意保暖；立刻测量其呼吸、血压、脉搏、心率，了解其生命体征。

2. 轻者一般静卧片刻即可，如患者仍感不适，可给予温糖水或热茶口服，并注意使之安静和休息，约3~5分钟后即可逐渐恢复。

3. 重者可在上述处理的基础上，用指掐或针刺人中、素髻、足三里、涌泉，或艾灸百会、关元、气海等穴；或嗅以氨水；必要时可用肾上腺素1毫升、阿托品1毫克肌注，或用50%葡萄糖液40毫升静脉推注等。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：由相应的腰神经后支内侧皮支所分布。

2. 皮下组织：内有上述皮神经的分支。

3. 胸腰筋膜：该筋膜包裹竖脊肌，可分为浅、深两层。浅层在竖脊肌的表面，向内侧附着于棘突，其腰部明显增厚与背阔肌的腱膜紧密结合；深层位于竖脊肌深面。

4. 棘上韧带或竖脊肌：该韧带在此处宽面肥厚，十分强韧，深面与棘间韧带相愈合。竖脊肌为背部深层肌，由脊神经后支支配。

5. 棘间韧带：较薄，沿棘突尖至根部，深面与弓间韧带相愈合，连结相邻两个棘突之间。

6. 弓间韧带：又称黄韧带，该韧带位于相邻两个椎弓之间，由弹力纤维构成。

【操作要点】

晕灸现象在临床上虽然少见，且多数患者不经任何特殊治疗亦可自行恢复，但是平时操作时仍要谨慎。为了避免晕灸的发生，在施术时要注意几个方面：①要根据病人的体质和病情来决定是否适应艾灸疗法，对于平素身体虚弱，或疲劳过度，或处于饥饿、大吐、大泻、大汗、大出血等情况下的病人，施行艾灸时应慎重；②对于初诊或精神紧张的病人，宜做好解释工作，解除其顾虑，以期使病人能接受治疗并做好配合；③操作时病人尽量采取卧位，且施灸部位不宜长时间固定于一处，以局部皮肤潮红为度，临床上多用移动式悬灸；④整个治疗过程中，医生要严密观察病人的神色、表情、脉象等方面的状况，一旦发现有晕灸的先兆症状，则应立即处理。

三十五、背部腧穴遗针

【案例 1】

某女性患者，45 岁，因腰背痛已 3 年，活动受限而来诊。X 线摄片示：腰_{4~5}椎体边缘有骨质增生肥大征，局部压之钝痛。取俯卧位，针刺大肠俞及阿是穴（左秩边附近）。因为病人穿长裙子，针后因裙边上移，遮盖了阿是穴这根针，起针时被遗忘，在她下床穿鞋子时，感到秩边穴附近处不便，似有阻碍，未予注意，当开门扭转腰部时，顿觉腰痛，摸之有针，自行拔出^[45]。

【案例 2】

赵××，女性，28 岁，已婚，于 1991 年 3 月 5 日就诊。患者因月经不规则、头痛已 2 个月，近 2 天来头痛明显，尤其是前额部呈红肿并有压痛。第 1 次针两侧曲池和印堂后，头痛完全消失。3 月 8 日晨起突然呕吐，上腹胀痛，胸闷心烦，至 9 日晨共吐 4 次。

检查心肺正常，上腹部压痛，体温 36.5℃，当时印象为急性胃炎。取右内关及左足三里交叉配穴法，加中脘，针后呕吐停止，腹部疼痛也显著缓和。于 3 月 17 日又来门诊，自述月经适来 4 天，尚未干净，下腹轻微胀痛，腰痠痛厉害，遂配用双侧肾俞、大肠俞，用强刺激手法，留针 25 分钟，兼灸 10 分钟。患者感到舒适，出针时因作者有事离开，嘱实习学生代替取针，病人回家后自觉左肾俞穴处疼痛，用手掀开毛衣发现此处尚留有 1 根毫针，遂取出于复诊时带回。

【讨论】

遗针情况的发生，主要有两个原因：第一，医生的责任感不强，没有充分认识到“毫针虽小，责任重大”的道理，退针时不是专心致志观察病人，而是去注意周围的其他事情，结果将被衣物遮蔽的毫针遗忘，造成遗针的意外；第二，术者在毫针留针之后，或当人多忙乱之际，或由他人代为起针时，由于事先未予留意或说明留针的数目，结果导致退针后仍有几根毫针遗留于病人身体上，待病人自己触及时才发现。以上 2 个案例，正是因起针时不够细心，结果导致遗针案的发生。

【临床表现】

病人在针刺操作结束后，于整理衣服、行走活动时，突然感觉到某处（即曾经施行过针刺的部位）有疼痛，用手触及时才发现有毫针遗留。而遗针的部位，多见于毛发密长、腰背尾骶或衣物遮蔽的地方。

【处理方法】

当发现有遗针时，病人不要慌张失措，若仍在医院，则可返回原诊室，找施术的医生，请他将针取出；若患者已回到家里，则请家属帮忙，轻轻顺着针刺的方向将针拔出，并用干棉球按压针孔片刻，以防出血。

【操作要点】

遗针是临床上较为常见的一种情况，虽然尚未见有因遗针未取而造成意外的报道，但这种可能性是存在的，故应引起每位针灸医生的重视。应加强自己的责任心，认真做好起针这最后一个

工序，仔细地将所刺在病人身上的毫针全部回收，细心复查其数目，并注意检查那些毛发密长、腰背尾骶或衣物遮蔽的地方，以防有所遗漏。此外，若是因有事而不得不请他人代为起针时，应事先交代清楚留针的部位和数目，并要求在出针完毕后应复查清楚，方可让病人离开诊室。

三十六、针刺不当损伤肾脏

【案例】

曲××，男性，37岁，职员。住院号46388，X线摄片号31401。因右腰痛及肿块已23天，于1956年7月20日入院。患者由于上腹痛及胃痛行针灸疗法，开始取穴为中脘、足三里，至第2、3次治疗时，因尚伴有腰部酸痛故在肾区左右各刺2针。于6月27日针灸后3日，入某院检查，发现右下腰处有肿块，诊断为肾周围炎，用大量青霉素注射，发热消退，肿块缩小。此次入院前6天，又出现发热、腰疼，且有小便频数，以青霉素、链霉素控制后，转来本院。7月23日，作逆行造影术，仅见右肾稍向外下方移位，其他正常。24日行右肾区穿刺，抽出200毫升陈旧血液。26日，体格检查时发现，右肾区肿块又复出现，大小与未穿刺前近似，乃于28日行右肾探查术。术中见肾被膜内潴留陈旧血液约100余毫升，肾内上方有胡桃大囊肿1个，内亦有血性液体；肾后面中部有横裂口一处，长约6~8厘米，深约0.5~1厘米，流血已停止；肾周围粘连较重。行右肾连同周围肥厚之被膜一并切除，于8月6日痊愈出院^[68]。

【讨论】

肾为成对的实质性器官，在调节体液和维持电解质平衡中起着重要的作用。正常情况下，肾在腹腔内腹膜的后方，位于脊柱两侧，紧贴腹后壁，男性成人肾平均长11.5厘米，宽5.5厘米，厚3~4厘米，女性稍小于男性。肾脏在体表投影区，以左侧第11胸椎下缘为上界，第2腰椎下缘为下界（因第12肋斜过左肾中部，故常以此为肾定位标志），两界之间距后正中线约3.5~10厘米之

间的范围皆是；在右侧，右肾低于左肾约1~2厘米，即下移半个椎体左右。另外，肾的位置可因呼吸、体位等情况的影响而上下稍有移动，但不超过1个椎体。一般而言，针刺是不可能从腹部刺中肾脏的（因前面有腹腔脏器覆盖），多于背部取穴治疗时误伤。而较易导致肾脏损伤的穴位为膀胱经的意舍、胃仓、盲门、志室等，可能损伤肾脏的穴位是胃俞、脾俞、三焦俞、肾俞、气海俞、京门、腰眼等。本案例肾体中部的大裂口正是针刺所伤，由于针刺时刺入过深或方向错误，针尖刺伤肾脏，病人因疼痛而用力呼吸，或病人因疼痛而移动体位，术者把持针过紧，则会造成比较大的裂伤，导致被膜下血肿和肾周围炎。

【临床表现】

因肾脏损伤的程度不同，症状亦有轻重的区别。

轻症（针尖仅及肾包膜或肾实质浅层，尚未贯穿肾盏、肾盂，局部小血管破裂）：症状多不明显，仅于针后见肾区轻度疼痛，可持续数日，有全身乏力，显微镜下见到尿中有红细胞。

重症（肾实质部分破裂或受到多处刺伤）：腰部疼痛，且常扩散到肩部，有压痛，有时尚可扪及包块，腰肌强直。出血较多而出现肉眼可见的血尿，伤及肾蒂则出血更明显，甚至导致休克。肾破裂后尿液可外渗，在肾周围形成肿块。合并感染者，可出现高热寒颤，全身中毒等症状。尿常规、X线检查和同位素扫描，均有助于确诊和判明其损伤程度。

【处理方法】

轻症：绝对卧床休息3~4周。根据病情，给予止血药物，可选用对羧基苄胺、安络血、凝血酶等，并可服云南白药或中药小蓟饮子加减；为预防感染亦可配合使用抗生素，如四环素0.25克口服，每日4次，或青霉素80万单位肌注，每日2次；严密观察，定时测血压、脉搏，每日测定红细胞数、血红蛋白、红细胞压积，观察血尿变化。轻者经上述治疗，一般均可获愈。

重症：一般要转外科作手术治疗，包括肾缝合修补术、肾切除术等。转科指征为，损伤后并发休克，经输血、输液无好转；明显的肉眼血尿，经24~48小时不见显著改善；肾周围包块继续增

大，有感染体征者。

【操作要点】

为了预防针刺损伤肾脏的医疗事故，在操作时要注意以下几个方面：首先，在针刺肾区及其周围穴位前，应详细询问病史和进行体检，以免在肾脏扩大或下垂的病人身上施术时发生意外；其次，要掌握好针刺的深度和方向，一般在肾脏投影区域内的穴位，应向脊柱方向斜刺1~1.5寸；或直刺0.5~0.8寸，不可向外侧斜刺或垂直深刺；最后，应细心体会手下感觉，当毫针穿过腰背肌膜时，若突然抵抗消失，并有空落感，则表明针尖已入肾囊；若针尖触及肾脏表面，则手下如有刺在胶布上样的感觉。此外，针刺前述穴位，病人最好取卧位，以防体位变动；针后病人如出现腰痛加剧、腰肌强直等症时，应及时作进一步的检查。

三十七、推拿不慎致腰部皮肤损伤

【案例】

程××，男性，35岁，工人。慢性腰部持续性疼痛近10年，反复发作，每遇劳累或天气变化时，腰痛则明显加剧，无下肢放射痛。体格检查：腰椎平坦，未见侧突，腰部运动基本正常，局部皮肤毛孔增粗，棘旁无压痛及下肢放射痛，双侧腰₃横突均有明显压痛，直腿抬高试验大于60°，膝、踝反射对称。腰椎X线摄片未见明显骨质病变。实验室检查，血沉、抗“O”、粘蛋白均属正常范围。拟诊：腰肌劳损。给予推拿治疗，当治疗到最后，想以产热较高的擦法结束，由于手法的要领掌握不好，又过于粗暴，结果致一侧腰部造成1×2.3（厘米）大小的皮肤损伤^[63]。

【讨论】

皮肤是人体的一个重要器官，对保障机体健康起着重要的屏障作用，当皮肤受损时，不仅妨碍正常的推拿治疗，若处理不当还会引起伤口的继发感染，给病人带来更大的痛苦。本案例显系术者由于擦法运用不当，手法要领掌握不好且过于粗暴，以身体带动手的往返，或小幅度急速而又不均匀的摩擦皮肤，从而造成

皮肤的擦伤。

【临床表现】

在推拿手法治疗的局部，病人往往先有一阵较明显的灼热感或剧痛，不久就可以发现该处皮肤的表层有不同程度的破损，继而在伤口处可见有红色的组织液渗出（由于表皮层内没有血管，故破损后不会出血）。

【处理方法】

对皮肤的表皮损伤，一般无需特殊处理，但是一定要保持伤口的清洁，以防继发感染。如果伤口的组织液渗出较多时，则可外涂紫药水或红药水，无需包扎，一般数日后即可获痊愈。

【操作要点】

术者平时应加强手法基本功的训练，提高手法操作的熟练程度；正确掌握各种手法的动作要领。如属摩擦类常用手法的擦法，操作时应成直线，以上臂带动手的往返，要求手的压力不宜过大，动作宜均匀、连续，切不可进气；在使用擦法、揉法等时，一定要加油膏、滑石粉等介质，以便保护局部的皮肤。此外，术者还应勤修指甲，以免不慎划伤病人皮肤。一般来说，只要注意到以上几点，就能减少或避免损伤穴位及其周围皮肤的意外。

三十八、推拿不当导致休克

【案例1】

某男性患者，26岁，工人。因患腰椎间盘突出症半年余，在门诊由进修医师持续推拿2个多月，仍然有较明显的坐骨神经性侧突，和下肢放射性（至小腿外侧）疼痛，行走困难，日夜无休。检查：直腿抬高只有30°，加强试验阳性。当常规推拿治疗无效的情况下，带教医师想改用踩跷法进行试治。病人十分艰难而又痛苦地以胸、股垫枕头，腹部腾空、俯卧于治疗床上，踩跷法一开始，病人即频频呼痛，但是为了治病，强忍阵阵剧痛坚持接受治疗，可治疗医师却一味强求疗效，并没有顾及对病人的观察，重踩不舍，当病人的呼痛声由强转弱、渐渐低微，直至其呼声停止

后方才结束踩跷治疗。此时才发现病人的面色苍白，周身大汗淋漓，四肢厥冷，反应迟钝，脉搏细而快，已经发生痛性休克^[63]。

【案例2】

某一女性患者，43岁，工人。颈背部疼痛数年，时轻时重，劳累后疼痛加重，颈部转侧欠灵活，上背部十分沉重伴板滞感觉。经颈、胸椎X线摄片检查，提示为：脊椎有退行性改变，颈_{4,5}椎间隙略有狭窄。结合临床表现，拟诊：①颈椎病；②背肌劳损，给予推拿治疗。因为该病人工作单位远离医院，故她提前1小时下班，急匆匆赶来接受推拿治疗。嘱其取俯卧位，上背部用揉法、压痛点弹拨法治疗，不足5分钟之后，病人即叫胸闷、心慌、头晕，视物不清，即立刻停止治疗。改为仰卧体位，发现她面色苍白，额面冷汗，脉细而弱，言语迟钝等，若不及时发现，极可能会发生低血糖昏迷^[63]。

【讨论】

休克是由于急性微循环功能障碍，导致组织器官血液灌注不足，从而引起代谢紊乱、器官功能低下、出血等一系列严重的变化，属于推拿中极为严重的不良反应。案例1显系因带教医师盲目选用踩跷法这类重手法，在治疗中粗暴蛮干，给病人持续的重刺激，没有考虑病人能够忍受的程度，结果造成痛性休克；案例2则是因病人在空腹及剧烈活动后（骑车近20公里而急匆匆赶到），接受推拿治疗，导致血糖的来源不足，而血糖是脑细胞能量的主要来源，当血糖浓度明显降低时，将会造成脑功能障碍。

【临床表现】

一般均有接受比较强烈推拿手法治疗的病史。休克早期脑缺氧较轻而表现为激动、烦躁；脑缺氧严重后则转入表情淡漠、意识模糊，甚至昏迷，伴有皮肤苍白、发绀、湿冷，脉搏细速，血压下降，脉压差变小，呼吸浅快，尿量明显减少等。眼底检查：早期动脉痉挛，晚期则动脉扩张。

【处理方法】

1. 病因治疗：当发生休克后原则上要立即终止重手法的不良刺激，缓解由暴力所造成的机体代谢紊乱。

2. 一般处理：让病人仰卧，头低足高位休息，适当保温或降温；要求尽量少搬动，并注意空气流通；设法保持呼吸道通畅，尽早建立静脉给药途径。

3. 抗休克治疗：如补充血容量，维持水、电解质和酸碱平衡，合理使用血管扩张剂或血管收缩剂，维持心、脑、肺、肾正常功能等。

4. 中医治疗：予独参汤、参附汤、四逆汤等中药汤剂服用；针刺足三里、人中、涌泉或耳针针交感、肾上腺、心、皮质下等穴位；配合开天门、分阴阳、揉内关、掐中冲等推拿手法。

【操作要点】

推拿治疗后出现休克现象多是由于手法刺激量过大，或是病人饥饿、情绪紧张所造成，因此为了预防推拿过程中发生休克，应注意以下原则：饥饿空腹、过度疲劳或剧烈运动后的病人，一般不宜施行推拿治疗，更不能给予重手法推拿；不要盲目地应用重手法，除非该疾病确实需要重手法刺激，而且使用重手法时无论是力量、幅度和频率都必须以病人能忍受为度，不能凭医生的个人主观臆断乱作决定。此外，对于踩跷法的使用，应注意选择好治疗对象，以年轻体壮、无明显脊椎骨质病变、无内脏器质性病变者为宜，在施术过程中要密切观察病人的变化，脚踩的力量一定要由轻到重，踩跳的幅度由小到大，踩动的频率由慢到快，逐渐增加，恰到好处，不可粗暴蛮干。

参 考 文 献

- [1] 许学铭. 上海中医药杂志 1963; (4) : 28
- [2] 段群录, 等. 河北中医 1984; (1) : 36
- [3] 朱汲. 江苏中医杂志 1986; (2) : 28
- [4] 张传英, 等. 黑龙江中医药 1992; (1) : 38
- [5] 王子玉. 山西医学杂志 1966; (2) : 23
- [6] 贾如宝. 陕西新医药 1979; (3) : 26
- [7] 胡全轩. 中级医刊 1983; (4) : 36
- [8] 彭仁罗, 等. 广东医学 (祖国医学版) 1963; (1) : 27
- [9] 阎林肯, 等. 中医杂志 1962; (5) : 35

- [10] 沈德培. 针灸杂志 1966; (2) : 41
- [11] 佟玉杰, 等. 浙江中医杂志 1966; (3) : 36
- [12] 蒋东贵. 重庆医药 1980; (6) : 47
- [13] 胡大仁. 江西中医药 1981; (4) : 29
- [14] 杨俊, 等. 中国针灸 1989; (4) : 47
- [15] 叶廷珖. 中医杂志 1956; (8) : 437
- [16] 张继有. 北京中医 1955; (4) : 32
- [17] 刘信基. 神经精神病杂志 1981; (5) : 317
- [18] 冯立忠. 中级医刊 1965; (9) : 585
- [19] 周霆. 针灸杂志 1966; (2) : 41
- [20] 刘锡铜, 等. 中华外科杂志 1959; (7) : 1036
- [21] 陈汉威, 等. 中医杂志 1963; (4) : 26
- [22] 周俊升. 天津医药 1976; (1) : 封4
- [23] 郑波声, 等. 中国农村医学 1983; (3) : 44
- [24] 朱汲. 上海针灸杂志 1990; (2) : 31
- [25] 叶廷珖. 兰州医学院学报 (中医专号) 1964; (10) : 63
- [26] 邵廷彬. 天津医药 1977; (12) : 613
- [27] 杨介宾. 四川中医 1986; (7) : 49
- [28] 吴有宽. 上海针灸杂志 1994; (2) : 75
- [29] 蒋孝慈. 上海中医药杂志 1951; (1) : 8
- [30] 刘玉书. 上海中医药杂志 1982; (2) : 40
- [31] 肖雪塘. 中国农村医学 1985; (1) : 9
- [32] 孙国良, 等. 中级医刊 1958; (2) : 101
- [33] 程绍恩. 天津医药杂志 1964; (4) : 323
- [34] 张逢吉. 陕西医药卫生杂志 1959; (3) : 255
- [35] 赵九相. 广西赤脚医生 1978; (4) : 34
- [36] 薛志强. 赤脚医生杂志 1979; (10) : 474
- [37] 魏中哲, 等. 黑龙江中医药 1988; (4) : 33
- [38] 天津市河北区金刚桥医院外科. 天津医药 1977; (11) : 556
- [39] 王启才, 等. 湖北中医杂志 1988; (9) : 29
- [40] 陈启明, 等. 上海针灸杂志 1992; (1) : 32
- [41] 夏晨. 针灸临床杂志 1993; (2、3) : 75
- [42] 丁渡明. 针灸临床杂志 1994; (4) : 44
- [43] 李尊桂. 四川中医 1990; (5) : 52

- [44] 邓汉光, 等. 新中医 (第八卷) 第 11 期
- [45] 高忻洙, 等. 针灸意外及其防治 湖南科学技术出版社 (第 1 版), 1993 年 7 月
- [46] 徐笨人, 等. 赤脚医生杂志 1979; (10) : 23
- [47] 蒋国华. 浙江中医杂志 1991; (5) : 174
- [48] 彭万才, 等. 中医杂志 1962; (8) : 32
- [49] 李伯宁. 成都中医学院学报 1978; (2) : 66
- [50] 郭寿钰, 等. 福建中医药 1957; (3) : 29
- [51] 郑培德. 中医杂志 总 352 期 : 32
- [52] 王秀英. 山东中医杂志 1983; (6) : 20
- [53] 凌德志. 黑龙江医刊 1959; (8) : 45
- [54] 林通国. 浙江中医杂志 1965; (6) : 12
- [55] 夏玉卿. 哈尔滨中医 1962; (2、3) : 26
- [56] 盛燮荪. 江苏中医 1960; (7) : 26
- [57] 海淑洁. 护理杂志 1964; (2) : 118
- [58] 宗文九. 上海针灸杂志 1984; (1) : 24
- [59] 常进一. 河北中医 1984; (3) : 48
- [60] 朱慎勇. 上海针灸杂志 1994; (3) : 109
- [61] 沈维素. 安徽省针灸学会交流资料 (1981 年)
- [62] 彭玉格. 江西中医药 1982; (3) : 49
- [63] 刘岚庆, 等. 推拿意外的预防及处理 上海科学技术出版社 (第 1 版), 1991 年 5 月
- [64] 府剑英, 等. 江苏中医杂志 总 292 期 : 36
- [65] 赵正山. 上海中医药杂志 1957; (9) : 33
- [66] 关乃理. 新医学 1972; (10) : 28
- [67] 马鞍山钢铁公司医院皖南针刺麻醉汇编 (未发表) 1975 : 83~84
- [68] 刘士怡. 中级医刊 1957; (10) : 11

第五章 四肢腧穴的意外事故

针灸临床上，四肢腧穴的意外事故，最常见的是周围神经损伤、周围血管损伤和肌肉挛缩。曾有人用解剖学的方法对 324 个穴位进行了研究，发现与神经有关者就有 323 穴，约占 99.6%，说明穴位与周围神经的关系非常密切，在实施操作时刺及或伤及到神经的可能性是很大的。而人体的血管分布也非常丰富，于身体各部位纵横交错、无处不有，故在大量的针刺实践中，对周围血管是很容易造成机械性损伤或化学性损伤的。加上由于施术不慎，也会导致四肢肌肉组织受到损伤，从而引起肌肉拘挛、萎缩，甚至功能障碍。以上几种类型是针刺治病过程中极易发生的意外，因此在四肢腧穴进行施术时，一定要小心谨慎。

一、针刺肩髃穴导致晕针

【案例 1】

刘××，男性，74 岁，1980 年 10 月 15 日来诊。主诉：近日因生气，自觉头痛、头晕，伴左侧肢体麻木，行动不便，前来我院求诊。诊断为中风先兆。治疗：令病人平坐，俯伏于桌面，暴露出针刺部位，常规消毒后，取左侧上肢的肩髃、曲池，下肢的环跳、阳陵泉等。由于病人年龄大，施术手法又过重，故刺入时间不久，患者即感觉难受，大汗淋漓，恶心欲吐，有大小便之意。迅速拔掉所刺之针，抱病人平躺于床上，此时病人已不省人事，急刺人中、少商、中冲、足三里穴。约 1 小时后病人恢复正常，便送其离院回家^[1]。

【案例 2】

炎夏正午，某一搬动工人因左侧肩周炎，在数里外车站工作后，冒烈日赶来求治。因见其气喘嘘嘘，全身汗湿，嘱稍事休息后再行治疗，但患者尚有急事，连连催促，故取坐位针刺。当刺入肩髃穴时，患处疼痛旋即缓解，连呼舒服，留针期间要求术者再次行针，待稍加捻转提插后，患者即自诉头晕、恶心，旋即两眼发呆，冷汗淋淋，面色苍白，脉细弱，扶卧休息后始愈。

【案例 3】

Mohmed Ali，男性，45 岁，教师。1981 年 10 月就诊。因颈椎骨质增生压迫神经而引起右臂及手指发麻，书写不便，检查感觉和运动障碍不大明显，脉搏正常。用体针 4 次效果不明显，遂试用电针，取卧位，针刺右侧肩髃及曲池后，刚一接上正负电极，只听患者大叫一声“要我的命”，随即出现昏晕、冷汗、面色苍白、肢冷脉伏等一系列晕针症状，经休息 5 分钟后自动恢复。事后发现，此次晕针是因电针机在上次用后并未关机，输出强度调节未曾回复“0”位，所以刚接上电极，因突然刺激太强，患者不能忍受所致。这个教训，应引起临床注意^[2]。

【讨论】

晕针是针灸临床上最常见的意外事故之一。以上案例 1 系因病人年龄偏大，体质较虚弱，加上针刺时手法过重取穴亦较多，诸种因素共同作用而产生晕针现象；案例 2 系因病人大劳之后立即接受治疗，而针前又不能充分休息，又不采用卧位，故施术后极易引起晕针；案例 3 则是由电针引起的晕针，因电针机输出电钮并没有关闭在零点上，当电源开关被突然打开时，产生突然的强大电流刺激，从而导致晕针意外。

【临床表现】

晕针大多发生在于针灸过程中，但也有少数病人在取针后数分钟始出现症状，典型的晕针一般可分为 3 期，详见前述。

此外，根据临床症状，尚可将晕针分为轻、中、重 3 度（临床上以前两种多见）。①轻度：针刺过程中患者自诉头晕目眩，胸闷，体倦乏力，但呼吸和脉搏仍正常；②中度：头晕心慌，恶心

欲吐，面色苍白，汗出肢冷，脉搏变细；③重度：全身厥冷，大汗淋漓，血压下降，脉搏细弱，呈昏厥状态。

【处理方法】

1. 常规护理：迅速拔出所有的针，将患者扶至空气流通处，并让其仰卧在床上，头低脚高位；及时松解患者的衣带，热天注意通风，冷天注意保暖；立刻测量其呼吸、血压、脉搏以及心率，了解生命体征。

2. 轻者一般静卧片刻即可。如患者仍感不适，可给予温糖水或热茶口服，并注意使之安静和休息，约经 3~5 分钟后即可逐渐恢复。

3. 重者可在上述处理的基础上，用指掐或针刺人中、素髻、足三里、涌泉，或艾灸百会、关元、气海等穴；嗅以氨水；必要时可用肾上腺素 1 毫升、阿托品 1 毫克肌注，25% 葡萄糖 40 毫升静脉推注等。

【穴位层次解剖】

1. 直刺法：

(1) 皮肤：由锁骨上外侧神经分布，到达该穴区的神经纤维由第 4 颈神经组成。

(2) 皮下组织：有上述皮神经的分支通过。

(3) 三角肌：针刺处为三角肌中部上份，该肌由腋神经支配，到该肌的神经纤维由第 5、6 颈神经组成。

(4) 三角肌下囊：为三角肌深面与肱骨大结节之间的滑液囊，常与肩峰下囊相通。

(5) 冈上肌腱：此肌腱附着于肱骨大结节上端。冈上肌由肩胛上神经支配，到该肌的神经纤维由第 5 颈神经组成。

2. 向内斜刺法：

(1) ~ (3) 同直刺法。

(4) 肩峰下囊：为肩峰下方与冈上肌之间的滑液囊，常与三角肌下囊相通。

(5) 冈上肌：该肌为外展肩关节的始动肌，由肩胛上神经支配，到该肌的神经纤维由第 5 颈神经组成。

3. 向下斜刺法:

(1) ~ (4) 同直刺法。

(5) 针贯穿三角肌下囊后, 再次刺入三角肌中。

【操作要点】

晕针虽然多数情况下不经任何治疗也可自行恢复(恢复的时间长短决定于患者的体质和处理的适当), 不留有各种后遗症, 但是还是应该尽量避免这类情况的发生。因此, 为了防止晕针的发生, 临床上施术时要注意以下几点: 首先, 要做好心理预防工作, 对于那些对针灸猜疑、恐惧者, 或针刺时有哭笑、惊叫战栗、躲避、肌肉痉挛, 伴有呼吸、心跳、皮温、面色、出汗等植物神经系统和内分泌功能改变者, 均应做好语言诱导、转移其注意力、松弛训练等预防工作; 其次, 要注意预防各种容易导致晕针的诱因, 如饥饿病人针前应适当进食, 过度饱食者亦需待食物有所消化后方可施术, 过度疲劳或激烈活动后都应让病人稍加休息待其体力基本恢复才用针, 大病后或大汗后病人, 在针灸时要注意掌握刺激量, 手法不宜过强, 取穴亦不宜过多, 并尽量采用卧位针刺; 再次, 正确掌握本穴的针刺法。一般临床上常用3种方法, 直刺法(与皮肤垂直进针, 深约0.5~0.8寸)、向内斜刺法(与穴位下外的皮肤呈50度夹角, 向内稍偏下斜刺1.5~2寸)和向下斜刺法(与穴位上内的皮肤呈50度夹角, 向下斜刺1.5~2寸, 亦可向前内下及后内下进行透刺); 最后, 起针以后, 最好让病人在诊室休息10~20分钟后再离去。在此段时间内, 一旦发现有晕针的情况出现, 即应马上给予处理。

二、曲池穴操作不当导致过敏性反应

【案例1】

某一男性患者, 35岁, 农民。主诉右臂及肘关节麻痛两月余, 多次医治无效, 要求采取穴位注射疗法。用复方当归液1支(上海制药厂出品, 内含红花、川芎、归身), 常规消毒后, 于曲池穴垂直进针, 至有胀麻感时, 注入上述药液1毫升。完毕后刚拔出

针头，患者自觉心慌，浑身发热，瘙痒难忍，片刻后有急需大便感，往厕所时即跌倒，此时患者面色苍白，大汗淋漓，四肢厥冷，脉微欲绝。即肌注肾上腺素1支，5分钟后，病情逐渐好转，饮糖水1碗，20分钟之后症状消失^[3]。

【案例2】

某一男性患者，54岁，工人。因右肩关节疼痛、屈伸障碍来接受针灸治疗。取曲池、肩三针等穴，直刺0.5寸，但通电后不到1分钟，即见面部、胸腹、四肢等皮肤上突然发生大小不等、形态不一的风团，瘙痒难忍。马上断电，10余分钟后风团自行消失^[4]。

【案例3】

柳××，54岁，干部。患者自诉左肩关节疼痛、伸屈障碍已半年余，经中西医会诊是肩关节周围炎，曾先后打针、服中西药治疗效果不明显，于1982年2月10日转本室治疗。体格检查：发育正常，营养中等，神清答对，心肺正常，腹软无异常肿块，右肩关节无明显肿胀，有压痛，不能上举，屈伸受阻。治疗取穴左曲池、肩井、肩三针等，直刺0.5寸，通电后不到1分钟，即见面部、四肢等处皮肤突然发生大小不一的红色风团，瘙痒难忍，马上停止电针疗法，退针，约5分钟后症状消失。

【案例4】

某一男性患者，33岁。因感冒发热由其母亲陪同下来我科就诊。查体：体温38.5℃，心率100次/分，血压16/10千帕，双肺呼吸音较粗，未闻及干湿性罗音，心脏及腹部查体未见异常。既往体健，无哮喘病史，无药物过敏史。拟诊断为上呼吸道感染。给予柴胡注射液4毫升穴注双侧曲池，刚退针，患者即觉头昏不适，胸部憋闷，约1分钟后，自觉症状加重，呼吸急促，口唇发绀，随即出现哮喘样发作，呼吸明显加快，频率30次/分，听诊双肺满布哮鸣音，心率150次/分，律齐。立刻给予吸氧，并给氟美松5毫克、非那根25毫克肌注，氨茶碱0.25加入50%葡萄糖40毫升静推，氢化考的松300毫克加入5%葡萄糖500毫升中静脉滴注。约5分钟后，病人症状缓解，呼吸减慢，双肺哮鸣音减少。10分

钟之后，上述症状、体征消失^[5]。

【案例 5】

某一男性患者，25 岁，因感冒发烧来我院就诊。查体：体温 39℃，心率 100 次/分，血压 16/10 千帕，双肺呼吸音较粗，未闻及干湿性罗音，心脏及腹部查体未见异常。既往体健，无药物过敏史。诊断为上感，给予柴胡注射液 4 毫升注射双侧曲池。穴注完毕后 5 分钟，患者觉头昏、胸闷，嘱其平卧，约 1 分钟后出现呼吸急促，口唇发绀，呼吸 30 次/分，心率 156 次/分，律整。立即给予吸氧，并给地塞米松 5 毫克、非那根 25 毫克肌注，氨茶碱 0.25 加入 50% 葡萄糖 40 毫升静推，氢化考的松 200 毫克加入 5% 葡萄糖静滴。约 5 分钟后症状缓解，15 分钟后上述症状、体征消失^[6]。

【案例 6】

患儿祝某，男性，5 岁。于 1993 年 7 月因发热（体温 38℃）1 天来我院就诊。入院诊断为上呼吸道感染，给予双侧曲池穴位注射柴胡注射液 2 毫升。约 1 分钟左右，突然全身皮肤潮红，继之憋喘、烦躁、哭闹、抽搐。急查体：呼吸急促，吸气三凹征明显，鼻煽，皮肤潮红，口周苍白，口唇紫绀，双目凝视，四肢肌张力增高。心率 160 次/分，心律齐；两肺吸气性哮鸣音。诊断：Ⅲ°药物过敏性喉梗阻。立即吸氧，针刺人中、合谷等穴，同时肌肉注射非那根，静脉注射地塞米松，约 5 分钟后，症状缓解，呼吸平稳，安然入睡。

【讨论】

过敏反应是一种变态反应性疾病，针灸疗法本身仅是一种物理疗法（即针的机械性刺激或灸的温热性刺激），一般是不会引起过敏反应的。但是，随着针灸医学的迅速发展，现代的电、磁、激光、埋线、某些药物制剂等也逐渐成为刺激穴位的手段，它们既给针灸医学充实了内容，促进了针灸学的发展，又同时带来了一些新的副作用。过敏反应就是其中较常见的情况之一。案例 1、4、5、6 系因穴位注射而导致过敏反应，这是针灸临床上最为常见的，属于 I、Ⅲ型变态反应。其病理基础是，由于致敏抗原（复方丹

液、柴胡注射液)进入人体后,诱发产生IgE类抗体,并与血管周围肥大细胞和血循环中嗜碱性细胞结合,当致敏原再次与细胞表面IgE特异性结合后,将引起肥大细胞膜层结构稳定性改变及其内部的一系列生化改变,促使脱颗粒和过敏介质的释放(如组胺、激肽、肝素等),导致机体有效循环血量绝对或相对减少,组织血液灌流不足,细胞缺氧和重要器官损害,产生各种综合病征。案例2、3的过敏反应则是由于电针疗法所导致的(因两例均在停止电针疗法后不久,过敏症状自行消失),它在临床上虽然少见,但当患者本身具有过敏体质时,电流有时亦可成为致敏原,诱发某些患者产生IgE类抗体,进而使人体内部发生一系列生化变化,促使组胺、肝素、激肽等过敏介质的释放,引起血管通透性增高,毛细血管扩张,产生风团、瘙痒等症状。

【临床表现】

一般情况下,过敏反应多发生于施术过程中或施术完毕后不久(如穴位注射法、电针疗法所致者),临床表现以过敏性皮疹最常见(亦是最轻反应),即穴位周围区域的局限性红色小疹,或全身性的风团样丘疹,病人往往浑身发热,瘙痒难忍。根据形态的不同,临床上多将过敏性皮疹分为固定性红斑、麻疹样红斑、猩红热样红斑、剥脱性皮炎等几种。

严重者可出现过敏性休克(大多数病人的症状会在给药后的5分钟以内出现)。常见有呼吸道阻塞感,胸口紧缩、喉头堵塞、呼吸急促、哮喘、面色潮红或青紫等,并伴有濒危感,又有口干、头晕、眼花、脸及四肢麻木等。或有继发循环衰竭症状,如畏寒、冷汗、面色苍白或发绀,烦躁不安,脉搏细弱,血压下降等。还可见中枢神经系统症状,如意识丧失,神志昏迷,抽搐,大小便失禁等。另外可见手、面浮肿,注射局部水肿、奇痒,全身荨麻疹等症。若处理不当,病人可在数分钟内死亡。

【处理方法】

1. 停止一切可疑因素对机体的继续刺激,因电针疗法所致者应马上切断电流,因穴位注射所致者应马上停止注射未注完的药液;同时让病人平卧,多饮开水,或注射高渗葡萄糖液以加强排

泄。

2. 过敏性皮疹者，可给予苯海拉明 25~50 毫克口服，每日 2~3 次；或静脉注射 10% 葡萄糖酸钙 1~2 克（应稀释于 50% 葡萄糖液 20 毫升中），每日 1 次。严重者还应配合激素治疗，如强的松 10 毫克口服，每日 3 次；或氢化考的松 100~200 毫克加入 5% 葡萄糖液 500 毫升中静脉滴注，待病情好转后逐渐减量。

3. 过敏性休克者，则应强刺入中、涌泉、井穴、足三里等穴进行抢救，并立即皮下或肌肉注射 0.1% 肾上腺素 0.5~1 毫升（危急时可自静脉注入），同时用氢化可的松 100 毫克或地塞米松 10 毫克加入 50% 葡萄糖液 40 毫升内静注；肌肉注射抗组胺药物，如异丙嗪 25~50 毫克，亦可静脉缓注 10% 葡萄糖酸钙 1~2 克或 5% 氯化钙 10~20 毫升；应用升压药，如去甲肾上腺素 1~2 毫克加入生理盐水或 5% 葡萄糖液 100 毫升内静滴。如有呼吸抑制、心跳停止者，要立即进行胸外心脏挤压、口对口人工呼吸等。

4. 中药治疗，以清热凉血、利湿解毒为原则，可用自拟方，如鲜生地、蒲公英、板蓝根各 30 克，苦参、茯苓、山栀、车前子各 12 克，丹皮、赤芍各 9 克，生甘草 3 克，水煮服，每日 1 剂。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：分布有前臂后皮神经，到达穴区的神经纤维由第 6 颈神经组成。

2. 皮下组织：有上述皮神经的分支通过。

3. 桡侧腕长伸肌及桡侧腕短伸肌：两肌共同起自肱骨外上髁上方，均由桡神经支配，到该肌肉的神经纤维由第 6、7 颈神经组成。在此处，两肌的深面紧贴肘关节囊前壁。

4. 肱桡肌：该肌由桡神经支配，到该肌的神经纤维由第 5、6 颈神经组成。

5. 桡神经干及桡侧副动、静脉前支：桡神经干在肱桡肌、肱二头肌腱及肱肌之间下行。桡侧副动脉为肱深动脉的终支之一，在肘关节附近分前后两支参与肘关节网的组成，有同名静脉与之伴行。

6. 肱肌：该肌由肌皮神经支配，到该肌的神经纤维由第 5、6

颈神经组成。

【操作要点】

为了预防针灸过程中发生过敏反应，术者在施术前应仔细询问病人的病史，了解有无过敏史，特别是对穴位注射、电针或艾灸等是否过敏；对一些已知可引起过敏反应的药物，如青霉素、链霉素、普鲁卡因等，均应先作过敏试验，证明无反应者方可使用。这里要特别指出，某些中药制剂（如复方当归液、柴胡注射液）引起的过敏者，临床上亦较常见，应该提高警惕；在治疗过程中，要求注意观察病人，一旦出现过敏反应的先兆时，宜马上停止治疗，及时给予相应处理。

三、曲池穴位注射不慎损伤桡神经

【案例 1】

某一女性患儿，4 岁。因高热用复方奎宁行双侧曲池穴穴位注射，每穴 1 毫升，当注射左侧穴位时患儿啼哭很厉害，次日发现左手腕下垂。检查：左腕下垂，左拇指内收，不能背伸和外展，前臂下段桡侧及大鱼际侧知觉过敏。给予红外线、按摩、断续直流电治疗，以及肌注加兰他敏，口服呋喃硫胺、地巴唑等，经过 1 个半月的治疗后痊愈^[2]。

【案例 2】

某男性患者，38 岁。3 个月前因感冒发烧 2 天，当地医生在曲池穴注射复方氨基比林 2 毫升，在注射时患者即感手腕无力、不能抬起，拇指屈曲，不能伸直。后虽经当地医院中、西药物治疗，均未见明显好转，遂来本科求治。检查：见前臂举起时腕呈下垂状态，前臂背面及虎口处皮肤呈感觉障碍，肌肉可见轻度萎缩，拇指不能伸直。诊断：桡神经损伤。即予针刺手三里、外关等穴，中等刺激量。嘱患者回本地区后请针灸医生坚持治疗，但预后不明^[2]。

【案例 3】

某男，22 岁。因吃母猪肉后，自觉头昏、脑胀、恶心、呕吐、

腹痛，全身出现团疹、发痒。体温 39.2°C ，血压 $14.7/11.3$ 千帕 ($110/85$ 毫米汞柱)，心率每分钟 110 次。拟诊断：变应性荨麻疹。治疗：异丙嗪 250 毫克，在曲池穴封闭；并予泼尼松 10 毫克口服，每日 2 次。次日痊愈。但右腕关节软弱无力，右手不能抬起，右手拇、食两指有麻木感，肱二、三头肌反射尚存，垂腕强阳性，检查见桡神经支配区感觉迟钝。诊断为穴位注射引起的右桡神经损伤。转至中国医科大学第一附属医院，用针灸、理疗等综合疗法，治疗约 6 个月左右，桡神经的功能基本恢复，各症状基本消除^[8]。

【讨论】

桡神经是臂丛神经的最大分支，由颈 5～胸 1 组成，不但支配上肢后群肌肉运动，并司上肢后面皮肤的感觉。它从后束发出，在腋窝内位于桡动脉的后方，并与肱动脉一同行向外下，在肱三头肌长头与内侧头之间进入肱骨肌管，在管内贴附骨面并旋向外下，达肱骨外上髁的上方，下行至肘窝，在肱桡肌与肱二头肌之间分为深浅两支。桡神经浅支与桡动脉伴行，向下绕至手背，分布于外侧两个半手指的皮肤；桡神经深支穿在前臂背侧，支配前臂伸肌。因桡神经的分布区域较广，故针刺易损伤。而由于上臂肌肉较为丰满，桡神经干循行深伏，及至前臂方走行浅表，所以桡神经损伤多见于前臂诸穴施术时。这类腧穴包括了肺经的尺泽、孔最、列缺、经渠、太渊、鱼际，大肠经的曲池、手三里、温溜、偏历、阳溪、合谷，三焦经的外关、支沟、会宗等。案例 1 所选择的复方奎宁，对皮肤、肌肉的局部刺激性很大，对神经的刺激性更大；案例 2 所用的复方氨基比林，其 pH 值为 $5.4\sim 5.9$ ，与人体血液 pH 值 7.35 比较，两者差距较大，而酸碱度过高则可以使蛋白质变性或凝固，直接导致神经组织损伤。将其注于曲池穴，从而损伤了该穴深层的桡神经干。

【临床表现】

当桡神经受到损伤时，在该神经分布区可出现感觉障碍，包括麻木、发热、疼痛、触觉及温痛觉减退等，并可出现一种向手指末端放散的触电感。同时，有程度不同的运动功能障碍，如不

能伸腕和伸指，上肢不能旋后，典型者还见有腕垂征（患肢腕部下垂，无力上抬，握拳时更为明显）。

【处理方法】

临床上一旦确诊，应立即治疗（即应在损伤后 24 小时内采取措施），可根据损伤情况选用下列治疗方法。

1. 因穴位注射引起者，可采用湿热敷法，或新斯的明离子透入法，或直流碘离子透入法，以促进注入药物的吸收。

2. 针灸：以损伤部位周围的穴位为主，配以循经远道取穴，可用毫针刺法（手法用轻刺激），或电针法（弱刺激量），或灸法。常用穴位有肩髃、肩髃、外关、手三里、合谷、阳池等，每次 15～20 分钟，每日 1 次，10 次为 1 个疗程。

3. 理疗：治疗期间应注意功能锻炼及局部按摩，以助早日恢复。并可采用超短波治疗，每次 15 分钟，每日 1 次。

4. 中药：按活血、理气、通经之治则，拟方为当归 9 克、白芍 12 克、川芎 9 克、羌活 12 克、桂枝 9 克，水煎服，每日 1 剂。

5. 配合维生素类药物、辅酶 A 及三磷酸腺苷等口服，以营养损伤的神经，争取康复。

若病情严重，经上述治疗 2～4 周仍未见好转，则应请有关科室会诊处理。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：分布有前臂后皮神经，到达该穴区的神经纤维由第 6 颈神经组成。

2. 皮下组织：有上述皮神经的分支通过。

3. 桡侧腕长伸肌及桡侧腕短伸肌：两肌共同起自肱骨外上髁上方，均由桡神经支配，到该肌肉的神经纤维由第 6、7 颈神经组成。在此处，两肌的深面紧贴肘关节囊前壁。

4. 肱桡肌：该肌由桡神经支配，到该肌的神经纤维由第 5、6 颈神经组成。

5. 桡神经干及桡侧副动、静脉前支：桡神经干在肱桡肌、肱二头肌腱及肱肌之间下行。桡侧副动脉为肱深动脉的终支之一，在肘关节附近分前后两支参与肘关节网的组成，有同名静脉与之伴

行。

6. 肱肌：该肌由肌皮神经支配，到该肌的神经纤维由第 5、6 颈神经组成。

【操作要点】

为了预防损伤桡神经，临床上使用穴位注射时要注意下面几个问题：①术者应熟悉桡神经的解剖部位，以及曲池穴局部的层次解剖，根据病情合理选用治疗方法；②穴位注射应选择好注射针头，一般浅表用 4 号、深部用 5 号齿科针头，不宜使用较粗针头，否则易伤及神经干；③要小心操作，切勿为了获得较好的得气感而反复提插探寻，如病人出现穴区疼痛、发热及上通下达之触电感时，千万不可再提插，而应将针体稍上提，待此类现象消失后再注入药物。这里必须分清激发出循经感传现象与刺中神经干之间的区别。循经感传是一种特殊的酸、胀、麻、热的感觉，并按一定路线（多循古典经线）缓慢地行进（速度在 20 厘米/分钟左右）；而刺中神经干者，则是刺痛麻热感沿神经线路迅速传导；④应合理选用穴位注射药物，为了减轻药物的理化刺激，在穴区深部和周围有神经干或分支作注射时，要选择浓度适中及刺激性较小的、酸碱度接近中性范围的药物，尽量避免使用刺激性大、酸碱度过高、药物浓度过高或过低的药物，如安乃近、异丙嗪、酒精、复方奎宁、氯丙嗪、醋酸可的松、青霉素、普鲁卡因等。若必须选择上述药物时，应适当减少剂量，或使药液浓度与组织液渗透压相接近（一般而言，药液浓度过高时可用注射用水稀释，浓度过低时适当用生理盐水增加浓度）。

四、推拿不当导致肩关节脱位

【案例 1】

符××，男性，55 岁，工人。右侧肩关节疼痛，运动障碍近半年，无明显外伤史，但是其肩痛和功能障碍有逐渐加重的趋势，经门诊检查后，拟诊为肩关节周围炎。经多次推拿医治无效，决定用关节内普鲁卡因麻醉下推拿治疗。在关节腔内注入局麻药后，

医师双手紧握患肢的远端，用力作牵引和多方位的关节运动，以松解关节的粘连，最后再作较快且幅度较大的肩关节外展、外旋被动运动，当医师认为关节已无阻力、粘连已获松解后，就结束了手法治疗。午后患者觉肩痛明显加剧，运动倍受限制，次日因肩部剧痛前来复查，体检时发现右侧肩关节呈方肩畸形，有空虚感，X线摄片确诊为肩关节孟下脱位。随即手法复位，1次成功^[9]。

【案例2】

龚××，男性，56岁，干部。左侧肩关节周围炎半年余，经20余次推拿治疗后，肩关节的运动功能已开始有一定的恢复，肩痛程度亦有所减轻，特别是夜间因体位受压而被迫痛醒的现象明显减少。但是，医生出于求效心切，想早日为病人解除痛苦，所以在推拿治疗时，加大关节运动的幅度。一手按住病人肩峰，另一手紧握患肢的远端，双手同时用力，快速地使肩关节产生较大幅度的环转，终于因用力过猛，肩关节的阻力突然消失，局部剧痛，呈方肩畸形，经肩部X线摄片诊断为肩关节前脱位合并大结节骨折^[9]。

【讨论】

肩关节由肱骨头与肩胛骨关节盂构成，是典型的球窝关节。肱骨头大，有半球形的关节面，关节盂却浅而小，它们之间仅有1/4~1/3的接触，因此肩关节可作较大幅度的运动。但是肩关节的关节囊薄而松弛，其下方缺少肌肉的附着，成为关节的薄弱处，在做过度外展肩关节被动运动时，在以肩峰为支点的杠杆作用下，关节囊下部易遭撕裂，致肱骨头向前脱位。而在外伤性肩关节前脱位中，约有40%左右的病例合并大结节骨折，这主要是因肩周炎的患者大多数超过50岁，病程较长，其关节因粘连活动度明显减少，故患肢局部肌肉可出现废用性萎缩（尤其是三角肌），局部骨质密度降低，疏松，皮质变薄，脆性增加，经受不了较大的外力。若手法过于粗暴、猛烈时，被动运动的杠杆力量过大，必然会导致肩部骨的损伤。案例1、2均是由于术者推拿不慎、操之过急，做无规范的外旋、外展等被动运动，超越了正常的生理范围，从而造成组织的医源性损伤。

【临床表现】

当发生脱位时，则出现肩关节疼痛、功能障碍，局部失去正常圆形膨隆的外观而变为平坦的方肩，肩峰下部有空虚感，如旋转肱骨干时，可在脱出处打到滑动的肱骨头，杜格征阳性（即患手不能触及健侧肩部）。肩关节X线摄片，可以明确脱位的类型，和有无骨折并发症。

当合并骨折时，一般应有明确的致伤病史，肩部剧痛肿胀，活动功能障碍，方肩畸形，肩峰下部明显空虚感，伤臂呈 $25^{\circ}\sim 30^{\circ}$ 外展固定位不敢移动。若是大结节或孟唇骨折，则可出现骨性交锁，即上臂呈轻度外展，不能与胸侧壁接触，手掌摸不到对侧肩部。X线摄片亦可明确诊断。

【处理方法】

单纯性脱位者，以手牵足蹬法复位为主。即嘱患者取仰卧位，术者立于患侧，用双手握住患肢腕部，并用足底伸入患者腋下（左肩用左足，右肩用右足），缓缓地作纵向牵引拔伸患肢，并同时逐渐向外旋转患肢。此时可将肱骨头自前方（锁骨下，喙突下，孟下）离开，从关节囊的破裂口滑入关节孟内，完成整复。

合并骨折者，其处理方法与单纯性脱位者几乎相同。由于多数病例骨折块较大，且以骨膜与肱骨头紧密联系，若无移位的话，只要脱位一经整复后，骨折块亦随之复位，然后将上臂放于内收、内旋位，屈肘 90° ，胸前壁固定，4个星期即可。

【操作要点】

术者一定要熟悉肩关节的解剖结构，了解肩关节正常运动幅度（前屈为 $70^{\circ}\sim 90^{\circ}$ ，后伸为 40° 左右，外展为 $80^{\circ}\sim 90^{\circ}$ ，内收为 $20^{\circ}\sim 40^{\circ}$ ），明白肩周炎的治疗是需要一定时间的，决不能操之过急。对肩周炎做外展、外旋位被动运动时，患者以仰卧位为好，且要求一切的被动运动，只能在正常的生理范围之内，在做肩关节外展、外旋被动运动时肩部不宜再加压力。肩关节环转运动是结合围绕3个轴的基础运动而成的，即矢状面的屈曲和伸展，额状面的内收和外展，水平面臂外展屈肘 90° 时屈曲内旋和伸展外旋的运动，即是屈、伸、内收、外展、内旋、外旋的复合运动，所

以在被动运动时尤需注意这一点，以免误伤。另外，做肩部环转运动时，术者双手要注意各自的要领和相互配合，肩部一手相对固定起支点作用，不要用过大的按压力量；握患肢远端的手，宜轻而不宜重，更不要握死，在做环转时幅度由小到大，顺势而行，绝不可急速、猛烈、强行操作。

五、曲池穴注射地塞米松感染致死

【案例】

其女孩5岁，不久前因感冒、发热，经个体开业医生于曲池穴处注射地塞米松，3天后肘部肿胀疼痛，经热敷局部及口服红霉素琥珀酸干糖浆，肿势日益增大，疼痛加剧。7天后出现发热，经用地塞米松、安痛定，体温稍降后又迅速回升，9天后溃破流脓，体温波动在 $38.5^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ 之间，病情日益加重，只好去省城大医院求治。查体：体温 41°C ，意识模糊，呼吸急促，右肘部曲池穴处有 1×2 （厘米）溃口，有多量脓性分泌物流出，周围皮肤及右前臂红肿。化验检查，白细胞计数 $35.7\times 10^9/\text{L}$ 。马上给予吸氧，静脉输入青霉素1000万单位、庆大霉素8万单位，切开排出灰白色脓液约800毫升，刮除大量腐烂组织。后经少量多次输血，联合应用氨苄青霉素、红霉素、万古霉素等抗生素，终因病情危重3天后死于脓毒败血症。

【讨论】

败血症是致病菌或条件致病菌侵入人体血循环而发生的全身性感染，病原菌在血循环中生长、繁殖，产生内毒素、外毒素等。正常情况下，人体具有广泛而有效的防御和免疫功能，可防止细菌入侵，或迅速将侵入的细菌杀灭，故细菌感染后是否会引起败血症，既与细菌的毒力、数量等有密切关系，又与人体防御、免疫功能有关。本案例中的个体开业医生为乡镇游医，卫生条件较差，注射器、棉球等消毒不严格，而且注射技能低下，对穴位注射的深浅度掌握不准，过深或过浅均会使药液蓄积于筋膜或脂肪层内，不易吸收而继发感染。加上地塞米松抗炎而不能抗菌，又

未同足量有效的抗生素联合应用，引起机体的防御能力降低，使细菌在体内大量繁殖生长，造成原有感染活动化或扩散，使病情更为严重，最后死于脓毒败血症。

【临床表现】

开始于针孔周围发生硬结，颜色潮红，并有疼痛，若治疗不及时，其范围可继续扩大，局部出现波动，硬结逐渐变软，中央有黄色的脓头，伴有全身不适、发热等症状。当病人体质虚弱、机体免疫能力低下，或局限的化脓性感染未能控制时，大量毒力强的病原菌则会在血中繁殖、产生毒素而引起全身化脓性感染。见起病急骤，高热（可达40~41℃），头痛、头晕，食欲不振，恶心呕吐，关节酸痛，呼吸急促或困难。病情发展，可出现感染性休克，甚至死亡。化验：白细胞计数增加（可达2万~3万），中性粒细胞在80%以上，幼稚型白细胞增多。

【处理方法】

1. 一般护理：宜嘱病人患部休息少动，以减少疼痛及炎症扩散，严重者应卧床休息，注意环境的清洁、通风。同时让病人抬高肢体，以促进回流，减轻肿胀。不要随便挤压患部。

2. 外治法：可用鱼石脂软膏或金黄膏外敷局部，或用千捶膏外贴，每日1次。亦可用新鲜蒲公英、紫花地丁、芙蓉花叶、马齿苋、乌刘梅等，任选1~2种，捣烂外敷，日换2~3次。局部及其周围尚可用艾条熏灸，痛者以灸至不痛为度，未化脓者能予消散，将化脓者可促使化脓，已化脓者可促使破头。一旦脓肿成熟，应立即切开排脓，切口应选择在脓肿低位，使引流通畅。

3. 内治法：可按消炎止痛、清热解毒的原则选择适当的中西药物，汤剂可用五味消毒饮（即银花、野菊花、紫花地丁、天葵子、蒲公英），水煎服，每日1剂；中成药用牛黄解毒丸，每次1粒，每天2次；西药可用四环素0.25克，每日4次，或青霉素80万单位肌注（先作皮试），每日2次。如果病情严重，全身感染症状明显者，应选择抗生谱广的抗生素静滴，或两种抗生素联用，剂量宜大，疗程应长；注意补充热量、水分和蛋白质，纠正电解质代谢失调和酸中毒；必要时可输入新鲜血浆或全血；亦可考虑

用冬眠疗法或激素。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：分布有前臂后皮神经，到达该穴区的神经纤维由第6颈神经组成。

2. 皮下组织：有上述皮神经的分支通过。

3. 桡侧腕长伸肌及桡侧腕短伸肌：两肌共同起自肱骨外上髁上方，均由桡神经支配，到该肌肉的神经纤维由第6、7颈神经组成。在此处，两肌的深面紧贴肘关节囊前壁。

4. 肱桡肌：该肌由桡神经支配，到该肌的神经纤维由第5、6颈神经组成。

5. 桡神经干及桡侧副动、静脉前支：桡神经干在肱桡肌、肱二头肌腱及肱肌之间下行。桡侧副动脉为肱深动脉的终支之一，在肘关节附近分前后两支参与肘关节网的组成，有同名静脉与之伴行。

6. 肱肌：该肌由肌皮神经支配，到该肌的神经纤维由第5、6颈神经组成。

【操作要点】

树立无菌观念、严格消毒制度，是预防针刺感染的关键。其中针具和穴位的消毒是预防针刺感染的最重要一关。任何一个环节的忽略都极易导致感染。在有感染病灶的部位，应尽量避免施术。出针后如遗留针孔较大或有出血现象，应用消毒干棉球轻轻揉按，使其止血及闭合；施术部位要注意保持清洁，在2个小时内不要用生水洗涤。感染患处切忌挤压、针刺，或过早切开排脓，以防止毒素或细菌侵入血液。感染者应尽早治疗，防止其扩散，除用药物治疗外，同时还要注意支持疗法，增强其抵抗力，早日消除炎症。

六、郄门穴注射丹参液引起过敏反应

【案例】

某一女性患者，40岁，工人。因患风湿性心脏病、心功能不

全来门诊求治。于当天及次日在郗门穴各注射丹参液 2 毫升。次日先觉咽喉部发痒，至下午见注射部位红肿，当晚下半身出现大片荨麻疹，奇痒难忍。患者此期间未用过其他药物。至 11 日皮疹逐渐消退，4 天后消失。后作过敏试验，证明该患者对丹参注射液呈阳性反应^[10]。

【讨论】

过敏反应是一种变态反应性疾病，针灸疗法本身仅是一种物理疗法（即针的机械性刺激或灸的温热性刺激），一般是不会引起过敏反应的。但是，随着针灸医学的迅速发展，现代的电、磁、激光、埋线、某些药物制剂等也逐渐成为刺激穴位的手段，它们既给针灸医学充实了内容，又同时带来了一些新的副作用，过敏反应就是其中较常见的情况之一。本案例系因穴位注射而导致过敏反应，主要是由于致敏抗原（丹参注射液）进入人体后，诱发产生 IgE 类抗体，并与血管周围肥大细胞和血循环中嗜碱性细胞结合，当致敏原再次与细胞表面 IgE 特异性结合后，将引起肥大细胞膜层结构稳定性改变及其内部的一系列生化改变，促使脱颗粒和过敏介质的释放（如组胺、激肽、肝素等），导致血管通透性增高，毛细血管扩张，产生风团、瘙痒等过敏反应症状。

【临床表现】

一般情况下，过敏反应多发生于施术过程中或施术完毕后不久，临床表现以过敏性皮疹最常见（亦是最轻程度的反应），即穴位周围区域的局限性红色小疹，或全身性的风团样丘疹，往往浑身发热，瘙痒难忍。根据形态的不同，临床上又可将他们分为固定性红斑、麻疹样红斑、猩红热样红斑、剥脱性皮炎等几种。严重者可伴有胸闷，呼吸困难，面色苍白，大汗淋漓等，甚则出现过敏性休克。

【处理方法】

有局部或全身过敏性皮疹者，一般于停止该疗法后不久可自然消退，在这期间应多饮水，并可用抗组胺、维生素 C 等药物，或注射高渗葡萄糖以加强排泄。若兼见奇痒、口干、发烧、烦躁不安等症状时，可适当用皮质类激素，如强的松 10 毫克，每日 3 次；

或中药清热凉血、祛风止痒方剂效果亦不错，拟方为鲜生地 20 克，丹皮、赤芍各 9 克，蒲公英、板蓝根各 30 克，苦参、茯苓、山栀、车前子各 12 克，生甘草 3 克，水煎服，每日 1 剂。

当表现为面色苍白，大汗淋漓，脉象细微时，除了肌肉注射抗组胺药物外，还可肌注或静注肾上腺素，必要时注射肾上腺皮质激素等药物。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：分布有前臂外侧皮神经，到达该穴区的神经纤维由第 6 颈神经组成。

2. 皮下组织：有上述皮神经的分支和前臂正中静脉通过。

3. 桡侧腕屈肌：该肌由正中神经支配，到该肌的神经纤维由第 6、7 颈神经组成。

4. 指浅屈肌：该肌由正中神经支配，到该肌的神经纤维由第 7、8 颈神经及第 1 胸神经组成。

5. 正中神经干及正中动脉：正中神经干行于指浅屈肌与指深屈肌之间，针刺到它时应立即停止（伤及该神经干后会产生向指端放射的强烈触电感）。正中动脉由尺动脉的分支——前臂骨间前动脉发出，伴正中神经下行，主要营养正中神经。

6. 指深屈肌：针刺部为指深屈肌的桡侧半，由正中神经的分支——骨间前神经支配，到该处的神经纤维由第 7、8 颈神经和第 1 胸神经组成；该肌的尺侧半，由尺神经支配，到该处的神经纤维由第 8 颈神经和第 1 胸神经组成。

7. 前臂骨间膜掌侧面：有正中神经的骨间前神经支配，该神经与同名动、静脉伴行于骨间膜浅面。

【操作要点】

为了预防针灸过程中发生过敏反应，术者在施术前应仔细询问病人的病史，了解有无过敏史，特别是对穴位注射是否过敏；对一些已知可引起过敏反应的药物，如青霉素、链霉素、普鲁卡因等，均应先作过敏试验，证明无反应时方可使用。这里要特别指出，某些中药制剂（如丹参注射液）引起的过敏反应，临床上亦较常见，故使用时也应该小心谨慎。在治疗过程中，要求注意观

察病人情况，一旦出现过敏反应的先兆时，宜马上停止穴位注射，及时给予相应处理。

七、针刺内关穴引起迷走神经反应

【案例】

某一男性患者，57岁。因头晕7年来诊。曾在他院检查，系高血压病，血压最高时达28.0/14.7千帕(210/110毫米汞柱)，有时又可降至正常。此次检查，血压17.3/12.0千帕(130/90毫米汞柱)，心尖搏动在左第6肋间锁骨中线上，无震颤，叩诊心界向左下扩大，听诊心尖区及主动脉瓣区有Ⅰ级收缩期吹风样杂音。胸透：主动脉增宽，左心室向左扩大。化验：血清胆固醇2.32mmol/L，甘油三酯3.65mmol/L， β -脂蛋白692毫克%。心电图：窦性心率，每分钟65次，P-R间期0.22秒，提示房室传导延缓。临床诊断为高血压病Ⅰ期。采用针刺治疗，患者仰卧位，取左侧内关穴，进针时患者无不适，进针后采用提插加捻转手法运针，得气感循左上肢达左肩。患者当即头晕，胸闷，心跳慢，面色苍白，双手发青，皮肤凉，脉迟缓。心电图见窦性P-R间期延长达1.36~2.12秒，心率每分钟28~44次，伴交界性逸搏及逸搏心率；有心室夺获与窦性节律，形成不全性房室脱节。遂起针，约10余分钟后，上述症状全部消失，针刺后18分钟心电图恢复至针前状况。

【讨论】

针刺引起迷走神经反应，往往表现为发病急速、症候凶险，如果救治失时，措施不力，则会造成严重后果，故针灸医师应给予足够的重视。迷走神经是脑神经中最长和分布最广的一对混合神经，含有感觉、运动与内脏神经3种纤维成分。运动纤维分布于喉肌，是管理喉肌运动的主要神经；感觉与内脏纤维分布于胸、腹腔脏器，控制平滑肌、心肌和腺体活动，管理脏器的运动与感觉。当机体某些器官、组织、内脏等受到机械性刺激时，可以兴奋迷走神经，导致迷走神经反射亢进。出现冠状血管痉挛和心脏传导

障碍，以致引起心跳骤停；支气管痉挛造成呼吸困难；咽喉感觉障碍和肌肉瘫痪引起声音嘶哑，语言困难，发呛，吞咽障碍；还可见恶心、呕吐等内脏反应，另外还有血压突然下降，面色苍白，冷汗淋漓等一系列症状。本案例显因术者在内关穴施行手法过重，其针感由支配内关的神经传入，再通过相应的脊髓节段及脊髓以上的更高级神经中枢，作用于植物神经系统，再由心脏传出神经作用于心脏，即迷走神经影响所致，由其胆碱纤维作用，引起心率减慢及其他症状。

【临床表现】

迷走神经反应在症状上出现的都是效应器官的变化，发病突然，表现凶险，进展迅速。临床上以神经系统、循环系统的症状最为明显，其症状和体征可依次出现：①心音消失；②脉搏扪不到，血压测不出；③意识突然丧失，或在一短阵抽搐（这种抽搐常为全身性，持续时间长短不一，可长达数分钟）之后出现意识丧失，多发生于心脏停搏后 10 秒钟内；④呼吸断续，呈叹息样，以后呼吸停止，多发生在心脏停搏后 20～30 秒钟内；⑤昏迷，多发生在心脏停搏 30 秒钟之后；⑥瞳孔散大，多在心脏停搏后 30～60 秒钟出现。

【处理方法】

临床上一旦出现迷走神经反应症状，则宜马上将针退出，停止任何刺激，并及时进行抢救，这样才有可能使病人得到恢复，否则易造成脑和全身器官组织的不可逆性损害，甚至死亡。

本症出现后马上使用阻断迷走神经作用的药物意义很重大，所用药物主要是阿托品（为胆碱能阻滞剂，可解除迷走神经对心脏的抑制，很适用于迷走神经反射刺激所致的心跳停止），每次用量可肌注 1～2 毫克，或静注 1 毫克。另外，还可肌注肾上腺素（兴奋心脏，升高血压），用量为 0.5～1 毫克。大部分病人经此处理便可恢复。

如果出现心跳骤停，应及时进行抢救，一般可采取下列措施：①心前区拳击术；②心脏挤压术，包括胸外心脏挤压术和胸内心脏挤压术；③人工呼吸，包括口对口人工呼吸和加压人工呼吸，以

及呼吸兴奋剂的使用(山梗菜碱,每次静注3~6毫克;尼可刹米,每次静注0.375~0.5克;戊四氮,每次静注0.1~0.2克)。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤:由前臂内侧皮神经及前臂外侧皮神经双重分布,到达该穴区的神经纤维由第7颈神经组成。

2. 皮下组织:有上述皮神经的分支通过。

3. 桡侧腕屈肌腱与掌长肌腱之间:两肌均由正中神经支配,到桡侧腕屈肌的神经纤维由第6、7颈神经组成,到掌长肌的神经纤维由第7、8颈神经及第1胸神经组成。

4. 指浅屈肌:该肌由正中神经支配,到该肌的神经纤维由第7、8颈神经及第1胸神经组成。

5. 正中神经干及正中动脉尺侧:正中神经干在指浅屈肌的深面,行于拇长屈肌及指深屈肌间的沟内。正中动脉由尺动脉的分支——前臂骨间前动脉发出,伴正中神经下行,主要营养该神经。

6. 指深屈肌:针刺部位为该肌的桡侧半,由正中神经的分支——骨间前神经支配,到该处的神经纤维由第7、8颈神经和第1胸神经组成;该肌的尺侧半由尺神经支配,到该处的神经纤维由第8颈神经和第1胸神经组成。

7. 旋前方肌:由正中神经的分支——骨间前神经支配,到该肌的神经纤维由第7、8颈神经和第1胸神经组成。

【操作要点】

迷走神经反应的症状与晕厥有些相似,故要求医者要细心观察,注意内关穴的针刺深度、刺激量大小,若出现意外时要一边对症处理,一边明确区别以进行抢救。临床上预防迷走神经反应的方法较少,这主要依靠临床实践经验与细心体会。下面介绍一个检查迷走神经功能是否亢进的方法(此法并不一定完全可靠),根据心眼反射的原则,术者可在针刺治疗前,用自己的拇、食指缓慢压迫患者闭合着的双眼,逐渐增加手指的压力,在10秒钟后脉搏减少超过10次/分钟者,则表示其迷走神经功能亢进,针前就应有所警惕,施术时宜小心谨慎。

八、内关穴施术不当导致正中神经损伤

【案例 1】

某男性患者，40 岁，工人。因鼻塞、流涕、头痛、胸闷、体倦 2 天，前来接受针灸治疗。经针刺内关、列缺穴后，患者即感局部酸、胀、麻感，并有触电感上至上臂下达拇指，针后 1 个月之久，患者的拇食两指仍有沉重感，以及该二指皮肤痛触觉丧失，拇指外展、上举功能欠佳。后患者经理疗约 1 个月，痊愈^[11]。

【案例 2】

某一女性患者，68 岁。因患慢性支气管扩张症，曾用××合剂、青霉素、金霉素等药物治疗，症状一度好转，但近日加剧。医生取双侧内关、天突穴，行链霉素穴位注射，每穴 0.1 克，隔日 1 次。每次注射时患者均感双侧内关穴部位有明显的酸麻感觉。第 4 次，当注射针头刺入右侧内关时，患者即觉有强烈触电样感传至中指和无名指，医生却无视这一情况，马上推注药物，致使局部产生胀痛感觉，嗣后胀痛感不仅不减，反而逐渐加重，不敢触及中指及无名指，夜间更明显，影响睡眠。经用一般止痛剂治疗无效，遂予以针灸治疗。

检查：右手肤色正常，无浮肿，中指及无名指呈半弯曲位置，触及或伸直时感刺痛，并牵连及前臂内侧，双侧内关穴处有密集针痕，腕、指关节能随意活动，触摸右手中指及无名指较其他手指有胀满之感觉。经针灸治疗 9 次后，患指可以自如活动，中指、无名指触及时不感疼痛，但间或有麻木感或不适感。3 个月后随访，右手无名指仍有麻木感存在^[12]。

【案例 3】

据未公开发表资料报道：中山医学院附一院理疗科用内关穴药物注射引起正中神经损伤 2 例，1 例因失眠用冬眠灵在左内关穴位注射致使左侧正中神经损伤，1 例因食道癌用石上柏注射液作双内关注射而致使双侧正中神经损伤；上海第一医学院×××医生，也曾在内关穴位注射苯妥英钠及杜冷丁，而致正中神经损伤 1 例。

【案例 4】

王黎报道，其在临床中曾遇见两例针刺内关穴引起手肌挛缩的病例。这两例患者均为在治疗过程中，医者用 1.5 寸的 28 号毫针针刺内关穴，进针 1.2 寸左右，行大幅度提插捻转，并出现“触电感”、“烧灼感”，但未引起医者注意，仍反复行针，并留针 15 分钟。其中 1 例针后出现手指屈曲，伸直困难，经艾条悬灸、电按摩 30 分钟后恢复常态，另一例针后出现手指僵硬，屈曲握拳，不能伸指，活动受限，患肢皮温及痛、温觉明显低于健肢，经艾条灸，针刺合谷透后溪，并配合主动与被动运动，加强功能锻炼，治疗 1 周后方愈^[13]。

【案例 5】

谭××，男性，22 岁，战士。于 1964 年 11 月 7 日初诊。主诉：双手麻木、不能活动 2 日。患者曾因阵发性干咳 2 周，于 11 月 5 日下午行内关、天突穴小剂量穴位封闭，每穴 0.25% 普鲁卡因 1.5 毫升。在注射内关穴时，患者感到酸麻感传至手指，注射后局部有酸麻胀痛，30 分钟后呈灼样持续性疼痛，上肢温度下降，夜间疼痛更剧，不能入睡。次日送往某院。

检查：双手臂皮肤颜色正常，无畸形，无浮肿。左前臂内侧腕横纹上 6.5 厘米处，桡侧腕屈肌腱和掌长肌腱之间，有一针痕；右前臂内侧腕横纹上 8 厘米处，桡侧腕屈肌腱桡侧有一针痕。病变部位双侧均从针痕起向指端呈套式分布，套式区内温度较低，温觉、触觉、痛觉均消失，双侧桡动脉搏动减弱，尚可计数。腕指不能随意活动，但可做被动活动，腕呈不屈不伸之自然位置，各指关节功能位屈曲，拇指不能内收，肱二、三头肌反射及桡骨膜反射存在。治疗经过：11 月 7 日始采用艾灸及电针治疗，3 次后疗效不理想，又加用理疗、普鲁卡因静脉封闭等，治疗 28 次后双手功能基本恢复正常。3 个月后随访，双手活动功能正常，左臂仍感酸困不适^[4]。

【讨论】

正中神经是臂丛的锁骨下部分支之一，由臂丛的内、外侧束的各一部分在腋动脉的前面合成。在上臂与肱动脉伴行，沿肱二

头肌内侧沟下降至肘窝，位置较深，经肱二头肌腱之后、肱肌之前到达前臂，穿过旋前圆肌，进入前臂浅、深两层屈肌之间，沿中线降至腕部。在腕上方，正中神经位于桡侧腕屈肌和掌长肌腱之间，位置浅表，继而穿过腕管在掌腱膜深面到达手掌。由于正中神经主要循行于前臂前面中间，与手厥阴心包经循行径路相合，故心包经的曲泽、郄门、间使、内关、大陵穴，经外奇穴的二白、臂中、郄上等，均处在该神经部位或与之紧邻，针灸不慎则易伤及。本节几个案例都是由于毫针针刺或穴位注射（尤其以后者情况更常见，更应引起注意）时，由于术者的操作欠妥、手法过重，刺激过强，导致正中神经的损伤。

【临床表现】

在针刺过程中，如果仅是针尖误中正中神经时，当即会出现一种向中指端放射的触电感。一旦造成损伤，在正中神经分布区（主要是手掌外侧半及掌面外侧3个半手指的皮肤）将出现感觉障碍，包括麻木、发热、疼痛、触觉、温觉、痛觉减退等。同时，还有不同程度的功能障碍。如不能屈指（小指除外），手腕无力，前臂不能旋前，不能对掌，出现“猿手”等。

【处理方法】

临床上一旦确诊，应马上给予治疗（最好在损伤后的24小时内采取措施），可根据损伤情况选用下列治疗方法。

1. 若因穴位注射引起正中神经损伤者，可采用湿热敷法，或新斯的明离子透入法，或直流碘离子透入法，以促进药物的吸收。

2. 针灸治疗以心包经穴为主，并配以邻近穴位，可用毫针刺法（手法用轻刺激），或电针法（中、弱刺激量），或艾灸法。常用穴位有间使、外关、四渎、大陵、手三里、合谷、曲泽等，每次15~20分钟，每日1次，10次为1个疗程。

3. 治疗期间应注意功能锻炼及局部按摩，以助早日恢复。可配合超短波治疗，每次15分钟，每日1次。

4. 中药可按行气活血、通经活络之治则，拟方为当归9克、白芍12克、川芎9克、羌活12克、桑枝12克、鸡血藤20克，煎服，每日1剂。

5. 西药,可配合维生素类药物、辅酶 A 及三磷酸腺苷等口服,营养损伤的神经,以利早日康复。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤:由前臂内、外侧皮神经双重分布,到达穴区的神经纤维由第 7 颈神经组成。

2. 皮下组织:有上述皮神经的分支通过。

3. 桡侧腕屈肌腱与掌长肌腱:两肌均由正中神经支配,到桡侧腕屈肌的神经纤维由第 6、7 颈神经组成,到掌长肌的神经纤维由第 7、8 颈神经及第 1 胸神经组成。

4. 指浅屈肌:由正中神经支配,到该肌的神经纤维由第 7、8 颈神经及第 1 胸神经组成。

5. 正中神经干及正中动脉尺侧:正中神经干在指浅屈肌的深面,行于拇长屈肌及指深屈肌间的沟内。正中动脉由尺动脉的分支——前臂骨间前动脉发出,伴正中神经下行,主要是营养该神经。

6. 指深屈肌:针刺部位为该肌的桡侧半,由正中神经的分支——骨间前神经支配,到该处的神经纤维由第 7、8 颈神经和第 1 胸神经组成;该肌的尺侧半由尺神经支配,到该处的神经纤维由第 8 颈神经和第 1 胸神经组成。

7. 旋前方肌:由正中神经的分支——骨间前神经支配,到该肌的神经纤维由第 7、8 颈神经和第 1 胸神经组成。

【操作要点】

为了预防施术时损伤正中神经,应注意下面几个问题:①术者应熟悉正中神经的解剖部位,以及内关穴局部的层次解剖,根据病情合理选用治疗方法;②选择的针具要细小,毫针以 28 号为宜,注射针头一般是浅表用 4 号,深部用 5 号齿科针头,尽量不用较粗的毫针或针头,否则易伤及神经干;③要小心操作,毫针运针时切忌手法过重、刺激时间过长,穴位注射时切忌为获得较好的得气感而反复探寻提插。如果病人出现穴区疼痛、发热及上通下达之触电感时,千万不可再提插,应将针体稍上提少许,待此类现象消失后再继续施术;④要选择合适的穴位注射药物,为

了减轻药物的理化刺激，在穴区深部和周围有神经干或分支作注射时，应使用些浓度适中及刺激性较小的、酸碱度接近中性范围的药物，尽量避免那些刺激性大、酸碱性过高、药物浓度过高或过低的药物。

九、针刺内关穴引起暴瘖

【案例 1】

姚××，女性，46 岁。因右侧胸痛 5 天，于 1974 年 8 月 6 日门诊治疗。根据疼痛呈针刺样、呼吸或咳嗽时加重，无外伤史和慢性呼吸道感染史等，诊断为肋间神经痛。由于她已服去痛片、维生素 B₁ 等无效，故予针刺治疗。患者仰卧位，取双侧内关穴，当针刺入右内关穴约 0.5 寸深（左侧尚未针），行较强的捻转时，患者突然目瞪口呆，神情十分紧张，急以左手摆动示意，但不能言语，询之落泪、烦躁不答。立即出针，局部无出血，患者右手不能握拳，仅以手指指着咽喉部，即予静卧休息，饮开水半杯，留室观察。约 4 小时后，始能以耳语声说话，仍不能发音。翌日，虽能发音，但声音嘶哑，历 3 日而愈。患者无精神异常及晕针史^[15]。

【案例 2】

某一女性患者，36 岁，农民。因患顽固性呃逆 3 年，曾用生姜、萝卜煎汁服之无效，服阿托品、莨菪片等亦无效，乃于 1974 年 10 月 11 日接受针刺治疗。既往有胃痛史，无精神异常，体检时亦无特殊阳性体征可见。穴位选取足三里、中脘、合谷，刺入后无异常反应。10 月 12 日症状略有好转，又取双侧足三里、中脘、内关，刺入足三里、中脘时无反应，当刺入右侧内关后，即以较重手法捻转，患者当时强烈咳嗽数声，继而频咳不停，声如犬吠，连说胸闷、心慌，即将针全部退出。此时患者咳嗽声嘶，咽部现轻度充血，神态正常，听诊心肺无异常发现。既往无类似病史，无晕针史，不畏针。至 18 日上午声音完全恢复正常^[15]。

【讨论】

针刺导致瘖哑，《铜人腧穴针灸图经》早有记载，说：“脑户

禁不可针，针之令人哑不能言。”这个观点古今针灸医家亦相沿承袭。而王树藩的报道，正说明了针刺确可使人致哑，尽管是暂时性的。但这次致哑的穴位是内关，而不是脑户、哑门等穴。内关穴使人致哑的原因，原作者认为内关为心包经的络穴，心包为心之外围，职能代君主心行事，善治心胸诸疾，根据中医学理论，“心开窍于舌”，“舌为心之苗”，当刺激心包经的内关穴，能影响到喉舌部，故临床上可见针刺内关而影响到喉及声带导致发音改变者，这种影响的程度因刺激的强度及个体感应情况而异。另外，也有人曾报道（《赤脚医生杂志》1978；（7）：20），针刺内关将暴怒失音症治愈。因此，出现这一针刺致瘖反应，也可以看作是经气调节过程中的一种劣性效应。至于真正致瘖的原因，还需进一步探讨。

【临床表现】

针刺过程中突然发病，患者声音不扬，甚至嘶哑失音，可伴喉痛、咳嗽、咯痰等，还能见到发热、体倦不适等全身症状。专科检查：间接喉镜下见喉粘膜弥漫性充血、肿胀，声带呈淡红或鲜红色，有的出现粘膜下出血。

【处理方法】

1. 局部治疗：用复方安息香酊蒸气吸入；或青霉素40万单位加入注射用水20毫升中溶解，再加入强的松龙2毫升，将药液装入雾化器内行雾化吸入，每日1次。亦可用薄荷、藿香、佩兰、菊花、苏叶等各适量煎水，作蒸气吸入，每日1~2次，每次20~30分钟；或用冰硼散、珠黄散等药吹喉，每天5~6次。

2. 全身治疗：一般护理方面，应嘱患者少讲话，尤忌大声呼叫，禁烟、酒，禁食辛燥刺激及苦寒食物。要及时应用抗生素、磺胺药。中药以疏风、利喉、开音为原则，选用疏风清热汤加蝉衣、千层纸。

3. 针灸疗法：可用毫针法，穴位选取合谷、尺泽、列缺、天突等，针用泻法。亦可配合耳针疗法，选取神门、咽喉、口、肺、肾上腺、皮质下等穴，每次2~3穴，进针后留针15~20分钟，每天1次。

十、外关穴位封闭导致桡神经损伤

【案例 1】

鄢××，女性，42岁。于1984年3月10日就诊。患者5年来经常头痛，每月发作1~2次，每次持续时间为2~10天，需卧床休息，但无视物旋转、呕吐或耳鸣。血压16/9.3kPa，神经系统检查无特殊发现，头皮松软增厚，攒竹穴压痛明显，同时见到左手发绀。病人自诉，于1年前因头痛剧烈发作，当地医生在双手外关等穴用生理盐水穴位封闭，每穴注液约2毫升，注射后右手无恙，左手当时即感麻痛，经3个月之后，疼痛自消，麻木感一直存在，冬季颜色青紫、乏力、发凉，未予治疗。从腕关节以下，皮肤紫绀，微呈浮肿状，感觉迟钝，肌力近Ⅳ，左手直举、平放、下垂时紫绀皆不消失，左侧尺动脉摸不着，而右侧摸及桡动脉搏动较弱。此为药液注射致使经气受阻所致，治以通经活络。在第1、3、5指指尖用三棱针点刺放血，各挤血3~5滴。2次以后因故停诊1周，自觉症状显著减轻，以后又来复诊，用同样方法放血3次，症状完全消失。4个月后随访，仍保持上述效果^[16]。

【案例 2】

陈××，男性，32岁，干部。1992年5月5日来诊，患者形体偏瘦，因左侧口眼歪斜，接受针灸治疗，诊断为周围性面瘫（风热型）。选取左侧风池、地仓、下关、阳白、内庭、外关穴，刺入穴位得气后用泻法，留针20分钟。其中外关穴针刺1.5寸，针后即感左手指麻木，腕部上抬乏力，但无明显功能障碍，并伴前臂酸胀，随即马上出针，予上下循按，不适感稍减轻。其后每次门诊，不再针刺该穴，同时局部配合循按推拿及理疗，半个月后症状基本消除。

【讨论】

因桡神经的分布区域较广，故针刺易发损伤。而由于上臂肌肉较为丰满，桡神经干循行深伏，至前臂方走行浅表，所以损伤多发生于前臂诸穴。这类腧穴包括肺经的尺泽、孔最、列缺、经

渠、太渊、鱼际，大肠经的曲池、手三里、温溜、偏历、阳溪、合谷，三焦经的外关、支沟、会宗等。本案例所用注射液为生理盐水，其浓度过高，对神经的刺激性极大，当穴位注射于外关时，造成对桡神经的损伤。

【临床表现】

当桡神经受到损伤时，在该神经分布区可出现感觉障碍，包括麻木、发热、疼痛、触觉、温觉、痛觉减退等，并可出现一种向手指末端放射的触电感。同时，伴有程度不同的运动功能障碍，如不能伸腕和伸指，上肢不能旋后，典型者还见有腕垂征（患肢腕部下垂，无力上抬，握拳时更为明显）。

【处理方法】

一旦确诊，应立即治疗（一般宜在损伤后 24 小时内采取措施），可根据损伤情况选用下列治疗方法。

1. 若因穴位注射引起神经损伤者，可采用湿热敷法，或新斯的明离子透入法，或直流碘离子透入法，以促进药物的吸收。

2. 针灸：以损伤部位周围的穴位为主，配以循经远道取穴，可用毫针刺法（手法刺激量宜轻），或电针法（弱刺激量），或灸法。常用穴位有颈臂、肩髃、曲池、手三里、合谷、阳池等，每次 15～20 分钟，日 1 次，10 次为 1 疗程。

3. 理疗：治疗期间要注意功能锻炼，以及局部按摩，以助早日恢复。并可采用超短波治疗，每次 15 分钟，每日 1 次。

4. 中药：以行气活血、通经活络为治则，拟方为当归 9 克、川芎 9 克、白芍 12 克、羌活 12 克、桂枝 9 克，水煎服，每日 1 剂。

5. 西药：可配合维生素类药物、辅酶 A 及三磷酸腺苷等口服，以营养损伤的神经。

如果桡神经损伤较严重，经上述治疗 2～4 周仍未见好转，则应请有关科室会诊处理。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：由前臂后皮神经分布，到达该穴区的神经纤维由第 7 颈神经组成。

2. 皮下组织：由上述皮神经分布。

3. 小指伸肌和指伸肌：两肌并列，前者位于尺侧，后者位于桡侧。两肌均由桡神经的分支——骨间后神经支配，到肌肉的纤维由第6、7、8颈神经组成。

4. 骨间后神经及同名动、静脉：骨间后神经及同名动、静脉位于尺侧，若针稍偏向尺侧则可刺及神经。骨间后动、静脉为同名神经的伴行血管。

5. 拇长伸肌及示指伸肌：两肌并列，前者位于桡侧，后者位于尺侧，它们由桡神经的分支——骨间后神经支配，到该两肌的神经纤维由第6、7、8颈神经组成。

【操作要点】

为预防损伤桡神经，临床上使用穴位注射时要注意以下几个方面：术者应熟悉桡神经的解剖部位以及外关穴的局部层次解剖，操作时要尽量避免伤及；同时，宜选择好注射针头，一般浅表用4号，深部用5号齿科针头，不用粗针头。要小心操作，切勿为了获得较好的得气感而反复提插探寻，如病人出现穴区疼痛、发热及上通下达之触电感时，千万不可再行提插，而应将针体稍上提，待此类现象消失后再注入药物。特别指出的是，必须分清激发出循经感传现象与刺中神经干之间的区别，循经感传是一种特殊的酸、胀、麻、热的感觉，并能按一定路线（多循古典经线）缓慢行进，而刺中神经干者则是刺痛麻热感沿其神经线路迅速传导。应合理选择穴位注射的药物，为了减轻药物的理化性刺激，在穴区深部和周围有神经干或分支作注射时，要选择那些浓度适中及刺激性较小的、酸碱度接近中性范围的药物，尽量避免使用刺激性大、酸碱度过高、药物浓度过高或过低的药物。

十一、列缺穴施术不当致桡神经损伤

【案例1】

某一男性患者，35岁，搬运工人。因右手腕酸痛、无力接受针灸治疗。当地医生以中药制剂（药名不详）于右手列缺穴位注射之后，引起病人右伸指总肌完全性麻痹，肌电图表示有轻度失

神经作用。诊断为外伤性桡神经麻痹。经用电兴奋、按摩等治疗，3 个月后症状完全消失，痊愈。

【案例 2】

— 40 岁的男性干部，因肝炎接受针灸治疗。取穴内关、列缺，当针刺列缺穴时，患者立即感到酸胀麻木和触电样感觉向上臂放射，并下达拇指。这种感觉在针灸治疗后 1 个多月仍不减，活动受碍。检查：拇指外展、背屈功能欠佳，拇食指间皮肤痛觉和触觉丧失。经热敷、电疗、内服维生素 B 等治疗，1 个月后逐渐有所好转^[11]。

【案例 3】

某一女性患者，52 岁，教师。因神经性头痛而针刺左侧头维、列缺穴。当第 2 次治疗后，患者感到左手桡骨茎突及前臂伸侧桡侧缘，有麻痛并向肘关节放射。给予按摩及艾灸，1 周后麻痛消失，左手腕关节功能正常^[16]。

【讨论】

由于桡神经的分布区域较广，故针刺时容易损伤。而因上臂肌肉较丰满，桡神经干循行深伏，至前臂方走行浅表，所以损伤多发生于前臂诸穴。上述几个案例所用穴位为列缺穴，其深层有前臂外侧皮神经和桡神经浅支经过，当施术不慎时，极易损伤深部神经，从而导致一系列后遗症出现。

【临床表现】

当桡神经受到损伤时，在该神经分布区可出现感觉障碍，包括麻木、发热、疼痛、触觉、温觉、痛觉减退等，并可出现一种向手指末端放射的触电感。同时，伴有程度不同的运动功能障碍，如不能伸腕和伸指，上肢不能旋后，典型者还见有腕垂征（患肢腕部下垂，无力上抬，握拳时更为明显）。

【处理方法】

一旦确诊，应立即给予治疗（一般应在损伤后 24 小时内采取措施），可根据损伤情况选用前述方法。

如果桡神经损伤较严重，经上述治疗 2~4 周仍未见好转，则应请有关科室会诊处理。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：由前臂外侧皮神经及桡神经浅支分布，到达穴区的神经纤维由第6颈神经组成。

2. 皮下组织：有上述皮神经的分支通过，穴区稍后方有头静脉通过。

3. 拇长展肌腱：拇长展肌由桡神经的分支——骨间后神经支配，到该肌的神经纤维由第6、7颈神经组成。

4. 肱桡肌腱：肱桡肌由桡神经支配，到该肌的神经纤维由第5、6颈神经组成。

5. 旋前方肌：该肌由正中神经的分支——骨间前神经支配，到该肌的神经纤维由第7、8颈神经和第1胸神经组成。

【操作要点】

为了预防损伤桡神经，临床上施术于列缺穴时，应注意以下几个方面：①要选择好针具，选用毫针或注射针头以细为佳，毫针以28号为宜；注射针头，浅表用4号，深部用5号齿科针头；②应小心操作，切勿为了获得较好的得气感而反复提插探寻，如病人出现穴区疼痛、发热及上通下达的触电感时，千万不可再提插捻转，应马上将针体稍上提，待此类现象消失后再继续操作或注入药物；③术者要细心体会针感情况，正确分清激发出循经感传现象与刺中神经干之间的区别；④在进行穴位注射时，为了减轻药物的理化性刺激，多选择那些浓度适中、刺激性较小的、酸碱度接近中性范围的药物。此外，尚应掌握好药物的用量，以及穴位注射时的推注速度等；⑤在桡神经干上及其周围的穴位，操作时最好不用或少用对组织损伤较重的方法，如割治、结扎、火针等，以免造成桡神经的直接伤害。

十二、神门穴施术不当导致尺神经损伤

【案例1】

王××，男性，45岁。于1970年1月28日初诊。1周前因

失眠就诊，某医生采用针刺治疗，由神门穴斜向深刺，约透至太渊穴处，在针刺过程中行强刺激捻法，患者当时痛不可忍，要求退针，起针后感全身乏力，身体不支，经休息1小时后才慢慢走回家中。此后自感右腕以下手掌及五指皆麻木，活动尚可。3天后麻木逐渐减退，仅剩下小指及无名指外侧麻木感，历时1月，仍不能恢复，遂来我科求治。即取少泽、内关穴，予轻刺激，每天1次。针至4次，症状有明显改善，以后未再复诊^[2]。

【案例2】

某女性患者，42岁。于1984年3月10日就诊。患者5年来经常头痛，每月发作1~2次，每次持续时间为2~10天，需卧床，但无视物旋转、呕吐或耳鸣。血压16.0/9.3千帕（120/70毫米汞柱），各系统检查无特殊发现，头皮松软增厚，攒竹穴压痛明显，同时见左手发绀。依病人所述，于1年前因头痛剧烈发作，当地医生曾在双手神门、外关、太渊穴用生理盐水穴位封闭，每穴注液约2毫升。注射后右手无恙，左手当时即感麻痛，经3个月之后，疼痛自消，但麻木感一直存在，冬季颜色青紫、乏力、发凉，未予治疗。现从腕关节以下，皮肤绀紫，微呈浮肿状，感觉迟钝，肌力近Ⅳ°，左手直举、平放、下垂紫绀皆不消失，左侧尺动脉摸不着，而右侧摸及，桡动脉搏动亦较弱。此为药液注射使经气受阻所致，治以通经活络。以第1、3、5指指尖用三棱针点刺放血，各挤血3~5滴，2次以后因故停诊1周，自觉症状显著减轻。以后又来复诊，用同样方法放血3次，症状完全消失，4个月后随访，仍保持治疗效果^[2]。

【讨论】

尺神经是臂丛神经的锁骨下部分支之一，既是手肌和前臂尺侧半屈肌的主要运动神经，也是手尺侧半皮肤的感觉神经。它起于内侧束，在肱动脉的内侧下行，降至三角肌止点以下则穿过内侧肌间隔至臂后面，在肘关节后方，恰位于尺神经沟内（即在肱骨内上髁与鹰嘴之间，此处位置浅表，贴近骨面，易于损伤），向下穿行于尺侧腕屈肌两头之间，转至前臂前面经尺动脉内侧降达腕部，在腕部豌豆骨的外侧，经腕横韧带浅面和掌腱膜深面进入

手掌。尺神经的表面投影，在上臂为肱骨内侧缘中点至肱骨内上髁后面（内上髁与鹰嘴之间）的连线，在前臂则为肱骨内上髁后面与豌豆骨桡侧的连线。因此，损伤多发生于手少阴心经（如极泉、青灵、少海、灵道、通里、阴郄、神门等）和手太阳小肠经（如小海、养老、支正等）的腧穴。以上2个案例，正是因术者操作不规范，盲目追求透刺强刺（案例1），或穴位注射时用药量偏大、推注速度过快（案例2），导致尺神经受到损伤（案例2则是造成尺、桡、正中神经同时损伤）。

【临床表现】

当尺神经受到损伤时，在该神经分布区可出现感觉障碍，包括麻木、发热、疼痛、触觉及温觉、痛觉减退等，有的人可出现一种向手指末端放射的触电感。同时，伴有程度不同的运动功能障碍，屈腕力弱，小指和无名指不能收展，拇指不能内收，典型者手部小鱼际肌明显萎缩，肌肉拘挛，表现为“爪形手”。

【处理方法】

临床上一旦确诊，最好立即给予治疗（一般应在损伤后24小时内采取措施），可根据尺神经损伤程度选用下列方法。

1. 针灸：选穴以心经、小肠经穴为主，并配以损伤部位周围的穴位，可用毫针刺法（要求手法的刺激宜轻、弱），或电针法（刺激量以中、弱为宜），或灸法。常用穴位有少海、支正、灵道、合谷、内关、养老等，每次15~20分钟，每日1次，10次为1个疗程。

2. 理疗：治疗期间要注意功能锻炼，以及配合局部按摩，以助早日恢复。并可采用超短波治疗，每次15分钟，每日1次。

3. 若因穴位注射引起神经损伤者，可采用湿热敷法，或新斯的明离子透入法，或直流碘离子透入法，以促进注入药物的吸收。

4. 中药：按行气活血、通经活络之治则，拟方为当归9克、川芎9克、白芍12克、桑枝10克、桂枝9克，水煎服，每日1剂。

5. 西药：可配合口服维生素类药物、辅酶A及三磷酸腺苷等，以营养受损伤的神经。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：由前臂内侧皮神经及尺神经掌支双重分布，到达穴

区的神经纤维由第8颈神经组成。

2. 皮下组织：有上述皮神经的分支通过。

3. 尺侧腕屈肌腱：尺侧腕屈肌由尺神经支配，到该肌的神经纤维由第8颈神经和第1胸神经组成。

4. 尺神经干及尺动、静脉：尺神经干在此处位置较表浅，若针尖稍偏向桡侧即可刺中。尺动脉为肱动脉的两大终支之一，尺静脉为其伴行静脉。

【操作要点】

为预防尺神经受到损伤，在神门穴施术时要注意：①应选择好操作的针具，选用毫针或注射针头要细，毫针以28号为宜；注射针头若浅表用4号，深部用5号齿科针头；②在尺神经分布区域内操作应小心，切勿为了获得较好的得气感而直接持续地强刺激尺神经干。当病人出现穴区疼痛、发热及上通下达的触电感时，千万不可乱捣乱刺，应马上将针稍上提，待此类现象消失后再继续操作或注入药物；③术者要细心体会针感的情况，正确分清激发出循经感传现象与刺中神经干之间的区别；④在神门穴进行水针治疗时，为了减轻药物的理化性刺激，多选择浓度适中、刺激性较小的、酸碱度接近中性范围的药物；同时，还要掌握好注射药物的用量，以及注射时的推注速度等；⑤在尺神经干上及其周围的穴位，操作时最好不用或少用对组织损伤较重的方法，如割治、结扎、火针等，以免造成神经的直接伤害。

十三、神门穴注射氯丙嗪引起手指坏死

【案例】

徐××，男性，5岁，住院号25737。因高热、嗜睡伴惊跳3天，于1965年7月4日入院。临床诊断为流行性乙型脑炎（重型），给予复方氯丙嗪臀部肌注等治疗，6天后停药。以后患儿出现失语，吞咽不能，肢体震颤，肌张力增强，四肢屈曲，右腕关节内屈等后遗症。即给予针刺、按摩等治疗，但效果欠佳，四肢震颤加重。乃于8月9日以小剂量氯丙嗪行双侧神门穴封闭，每

穴注射未经稀释之 2.5% 氯丙嗪溶液 0.16 毫升 (4 毫克), 每日 1 次, 连续注射 3 天, 于 3 月 11 日停药, 每侧总剂量 12 毫克。停药后次日下午, 见右前臂中段以下直至指端显著浮肿, 注射部位皮肤呈紫红色、坏死、起泡, 组织坏死沿尺侧掌面达小指及无名指, 该两指末端呈紫黑色。右侧桡动脉搏动存在, 但较对侧为弱。第 2 天病情恶化, 浮肿加重, 延及右肘部, 坏死不但波及整个小指及无名指, 且累及食、中两指末节, 拇指掌面皮肤亦见散在紫红斑。起病后即考虑为腕部尺侧动脉血栓形成。当即抬高肢体, 局部冷敷, 静脉滴注肝素, 0.25% 普鲁卡因右上臂环封, 并应用抗生素, 局部用无菌纱布包扎以防继发感染。4 天后浮肿逐渐消退, 皮肤紫红斑消失, 坏死局限。20 天后右手小指、无名指及食指、中指末呈干性坏死, 而行截指术^[17]。

【讨论】

穴位注射引起血栓闭塞性脉管炎, 最终导致肢端坏死, 这种情况虽然所见不多, 但由于其往往给病人带来终身痛苦 (大多数病人常须作截指术), 因此临床上必须予以高度重视。究其产生的原因, 以下面 3 种情况最多见: 一是穴位原因, 因穴区内有较大血管通过或周围分布较丰富的血管, 或刺激位于多肌腱、韧带等致密组织附近的腧穴, 妨碍了药物吸收, 刺激着血管壁, 引起血管内膜炎症, 形成血栓, 血管管腔变闭塞, 最后导致肢端坏死; 二是药物原因, 由于穴位注射所选用的药物刺激性过大, 可反射性地引起局部供血障碍, 或注射量偏大, 或反复在一个穴位注射, 亦可刺激血管壁, 形成全血管炎并形成血栓, 导致肢端坏死; 三是操作原因, 主要是施术时未按常规, 引起血管痉挛, 产生非感染性的血管全层性炎症, 管腔内血栓形成并逐步机化, 最后血管闭塞, 肢体坏死。本案例显系在未稀释的情况下 (因氯丙嗪 pH 值在 4~4.5 之间, 是酸性较强的药物), 直接注射于神门穴, 由于药物的刺激作用, 其局部可能形成炎症, 促使局部血管痉挛, 或压迫血管使血管闭塞, 继而出现血流缓滞等血液动力及血液流变学的改变, 形成动脉血行障碍, 局部缺血, 而导致肢体坏死。

【临床表现】

初期在注射部位可出现肿胀、疼痛，穴区皮肤呈紫红、潮红或苍黄色，皮肤表面干燥，局部压痛明显，肢端苍白、发凉、麻木。患肢动脉搏动减弱以至消失，夜间往往因持续性剧痛而不能入睡。随着血液循环障碍的愈来愈重，上述症状逐步加重，患肢趾或指端发黑、干瘪、坏疽。一般来说，因穴位注射不当所致的，病程较短且进展快，可在短时间内出现坏疽现象，故值得医者特别重视。

【处理方法】

1. 药物治疗：应用扩血管药物，如妥拉苏林、烟酸等，以及静脉滴注 2.5% 硫酸镁溶液，以扩张血管，缓解痉挛和促进侧支循环。低分子右旋糖酐，可改善微循环和防止血栓延伸，并改善侧支循环，但在初期病情急性发展时不宜使用；在急性期，尚可酌量应用激素；当有局部或全身感染时，要使用抗生素。中药治疗也有明显效果，如应用四妙勇安汤加减，当归注射液、复方丹参注射液等。

2. 辅助疗法：嘱患者平卧，抬高患肢到 45° ，维持 1~2 分钟，再令患肢下垂 2~5 分钟；同时向上、下、内、外等运动 10 分钟，再将患肢放平休息 2 分钟。重复 5 次以上，每日数回。有吸烟史者应戒烟。

3. 局部处理：干性坏疽者，应加以保护，并使之干燥，待坏疽边界清楚时，可在无菌条件下截除患趾，或作清创术。如坏疽严重，继发感染不断扩大而无法控制时，则须作高位截肢，以抢救生命。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：由前臂内侧皮神经及尺神经掌支双重分布，到达穴区的神经纤维由第 8 颈神经所组成。

2. 皮下组织：有上述皮神经的分支通过。

3. 尺侧腕屈肌腱：尺侧腕屈肌由尺神经支配，到该肌的神经纤维由第 8 颈神经和第 1 胸神经组成。

4. 尺神经干及尺动、静脉：尺神经干在此处位置较表浅，针尖若稍偏向桡侧即可刺中。尺动脉为肱动脉的两大终支之一，尺

静脉为其伴行静脉。

【操作要点】

为了避免因穴位注射的失误，招致患者被迫截肢，造成终身残疾事故发生，术者在操作时一定要特别提高警惕，须注意下列几点：①要合理使用药物，避免选用刺激性强烈的药物（如清热镇静药、油剂等）作穴位注射，亦应避免用高浓度的药物（如氯丙嗪、氯霉素等）直接注射。如果必须使用时，也要通过稀释等法，使药物浓度适中（正常情况下，穴位注射应比其他肌肉注射所用浓度要低），其酸碱度接近人体内酸碱度，并减少注射剂量，尤其是在肌层较薄又有较大血管通过的穴位，应使用最小剂量（常用剂量之1/5）；②应严格掌握操作规程，除了取穴准、针刺方向正确外，还应减少将药液误注于血管内的可能性。每次注射前要回抽一下，在无回血的情况下，才能将药物缓慢推入。此外，术者还要注意针感，当针尖触及动静脉血管壁时，患者往往有疼痛感，此时须将针上提少许，变换方向刺入再操作；③要注意穴位的选择，尽量少用穴区内有较大血管通过或周围分布较丰富血管的腧穴，或位于多肌腱、韧带等致密组织附近的腧穴（因为此类组织会影响血运，妨碍药物吸收）；同时，千万不要在同一穴位反复注射刺激性过大的药物，如氯丙嗪、氯霉素等。尤其是小儿患者，因其组织娇嫩，发生意外的可能性更大；④治疗期间应认真观察异常情况，注射部位一旦出现红肿等现象，则要作进一步的检查，不可马虎从事当作一般感染处理，以免贻误病情。

十四、针刺合谷穴引起迷走神经反应

【案例】

某一男性患者，38岁，工人。因头痛来求治。一般情况良好，但有无心血管病史不详。嘱患者卧位，选取合谷穴，进针得气后不久，患者即出现面色苍白，两手抽动一下，头歪向一侧，此时脉搏测不出，听诊心音不清，呼吸微弱，神志丧失。当即出针，并强刺入中，予胸外心脏挤压，经1分钟后，心跳、呼吸开始逐渐

恢复正常。观察 1 小时后无变化，遂步行回家。随访半年未见异常^[18]。

【讨论】

针刺引起的迷走神经反应，往往表现为发病快速、症候凶险，如果救治失时，措施不力，则会造成严重后果，故针灸医师应给予足够的重视。本节案例显系术者施术手法不当，刺激了神经末梢感受器，反射性地引起迷走神经高度兴奋，抑制了窦房结，导致阿-斯综合征样反射出现。

【临床表现】

迷走神经反应在症状上出现的都是效应器官的变化，发病突然，表现凶险，进展迅速。临床上以神经系统、循环系统的症状最为明显，其症状和体征可依次出现：①心音消失；②脉搏扪不到，血压测不出；③意识突然丧失，或在一短阵抽搐（这种抽搐常为全身性，持续时间长短不一，可长达数分钟）之后出现意识丧失，多发生于心脏停搏后 10 秒钟内；④呼吸断续，呈叹息样，以后呼吸停止，多发生在心脏停搏后 20～30 秒钟内；⑤昏迷，多发生在心脏停搏 30 秒钟之后；⑥瞳孔散大，这种情况多在心脏停搏后 30～60 秒钟出现。

【处理方法】

临床上一旦出现迷走神经反应症状，则应马上将针退出，停止任何刺激，并及时进行抢救，这样才有可能使病人恢复，否则易造成脑和全身器官组织的不可逆性损害，甚至死亡。

本症出现后应马上使用阻断迷走神经作用的药物，主要是阿托品（胆碱能阻滞剂，可解除迷走神经对心脏的抑制，很适用于迷走神经反射性刺激而引起的心跳骤停），每次用量为，肌注 1～2 毫克或静注 1 毫克。另外，还可肌注肾上腺素（兴奋心脏，升高血压），用量为 0.5～1 毫克。大部分病人经过治疗后便可恢复正常。

如果出现心跳骤停，应及时进行抢救，其措施请参见前述。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：由桡神经浅支分布，到达穴区的神经纤维由第 6 颈

神经组成。

2. 皮下组织：有上述皮神经分支通过。在穴区附近，还有手背静脉网汇成的头静脉起始部。

3. 第1骨间背侧肌：该肌起于第1掌骨间隙内骨面，止于食指近侧节指骨底桡侧，由尺神经深支支配，到该肌的神经纤维由第8颈神经和第1胸神经组成。

4. 拇收肌：该肌由尺神经深支支配，到该肌的神经纤维由第8颈神经和第1胸神经组成。

【操作要点】

迷走神经反应的症状与晕厥有些相似，故要求术者应细心观察，注意掌握合谷穴的针刺深度、刺激量大小。若出现意外时要一边对症处理，一边准确鉴别病情，给予及时的救治。临床上预防迷走神经反应的方法较少，这主要依靠临床实践和细心体会。检查迷走神经功能是否亢进的方法可参见前述。

十五、合谷穴施术不当导致手部畸形

【案例1】

××，女性，5岁，住院号188695。4年前因上感发烧，曾在双手合谷穴区多次针刺，且每次均穴位注射安替匹林0.5毫升，当时无特殊表现，但1年后发现双手合谷区有硬条索状肿块，拇指活动不便，4年后来我院检查。检查发现：拇指外展及指掌关节伸直均受限，第1指蹼间可扪及条形硬块。予以手术，术中见双侧拇收肌在拇指指掌关节抵止部附近，有白色瘢痕，左侧为 $0.6 \times 0.5 \times 0.3$ （厘米），右侧为 $0.5 \times 0.3 \times 0.2$ （厘米）。切除后，患儿拇指被动活动达正常范围。病理检查为瘢痕组织。2个月后随访，双手功能已恢复正常^[19]。

【案例2】

杨宇璇等报道，因热性疾病在合谷穴注射安乃近、青霉素、链霉素、百乃定等药物，引起手部畸形有29例共41只手，左手22只，右手19只，年龄在9~16岁之间，平均为10.9岁。部分病

儿在注射后第2天局部有红肿反应。手畸形最早出现在注射后3个月，多在5~6岁始受到注意。41只手的畸形可分为4种类型，Ⅰ型为单纯拇指内收畸形计33只手，Ⅱ型为单纯食指桡偏、掌指关节轻度屈曲畸形计3只手，Ⅲ型为拇指内收合并食指桡侧畸形计3只手，Ⅳ型为拇指内收伴有掌指关节半脱位计2只手。以上4型均有明显功能障碍，而以Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型最重，如握笔、拿筷子均极为困难。所有病例全部用手术治疗。术后2个月到1年半复查，拇指主动外展在 $50^{\circ}\sim 90^{\circ}$ 之间，距手术时间越长者，外展度数越大，原内收畸形严重者则外展度数较差。食指畸形全部均矫正；拇指主动内收、食指主动外展与正常无明显差别，拇、食指握物功能基本恢复。1例严重拇指内收畸形病例，因术中渗血较多，术后虎口部位加压过紧，以致局部发生粘连，使屈拇动作部分受限；2例伴掌指关节半脱位者，经石膏固定后，仍未完全复位^[20]。

【案例3】

邓德芳报道，在1974年~1980年间，共收治因合谷穴药物注射引起以拇内收肌为主的手内收肌瘢痕挛缩，导致拇指或食指功能障碍和畸形，甚至继发第1掌腕关节或掌指关节半脱位者共67例，计有81只手。发病年龄在12岁以下者46例（62.6%），12岁以上者21例（37.4%）。注射退热药物者56例（83.5%），其他药物及电针强烈刺激者11例（16.5%）。发病时间越长、年龄越大则畸形越严重，拇外展 30° 为80%，外展 $45^{\circ}\sim 50^{\circ}$ 之间者为20%。均采用拇收肌切断“Z”成形术，除1例因继发血肿感染而致手术失败外，其余病例畸形均得到矫正，术后拇外展均达到或超过 90° ^[21]。

【案例4】

胡谱绵报道，从1975年1月至1978年12月期间，共诊治因合谷穴位药物注射（除2只手是由于穴注氯丙嗪引起外，其余均为注射0.1毫升安乃近后造成的）而造成手部畸形的患者101例，共110只手，其中左手34例，右手58例，双手9例。发病年龄，除1例为44岁外，其余都是6~16岁的学龄儿童，平均9.9岁。手部出现畸形一般在注射后1个月至数年不等。110只手的畸形

可分为3种类型，Ⅰ型为手部小肌肉挛缩仅局限于深层之拇内收肌，造成拇指内收及掌指关节屈曲畸形，计74只手（67.3%）；Ⅱ型为手部小肌肉挛缩局限于浅层之第1背侧骨间肌，导致食指桡偏畸形，计10只手（9.1%），其中7只手尚伴食指掌指关节屈曲畸形；Ⅲ型为拇内收肌及第1背侧骨间肌均发生挛缩，患者兼有拇指内收、掌指关节屈曲畸形和食指的桡偏畸形，计26只手（23.6%），其中14只手还伴有食指的掌指关节屈曲畸形。全部病例均在门诊施行矫形手术，术后畸形纠正，手功能恢复。作者还曾对术后半年以上的病例进行随访，在58只手中，42只手的形态和功能完全正常（占72.4%），16只手比术前明显好转（占27.6%），未发现无改变或反而恶化者^[22]。

【案例5】

欧良树等报道，从1983年以来，共收治针刺合谷穴引起拇内收畸形患儿12例，男4例，女8例；年龄最小3岁，最大11岁，平均年龄为7.5岁；9例有水针合谷穴史，用药如安乃近、氨基比林、复方奎宁等，3例有针刺合谷穴史；出现畸形大多在针刺后1年左右，最长5年；畸形部位，右侧6例，左侧2例，双侧4例。这12例均行矫形术治疗，9例术后病理报告为拇内收肌纤维化，其余3例肉眼观呈纤维化变，故未做病理检查^[23]。

【案例6】

舒敬宗等报道，曾先后收治3例合谷穴注射引起拇、食指畸形者，均因发热经乡村医生在双侧合谷穴注射安痛定（药量不详）、百乃定0.5毫升、安乃近0.3毫升，而分别于注射后半年、1年、4个月发现拇、食指功能障碍，检查确诊为拇、食指内收畸形（1例仅为右手），经整形外科手术治愈^[24]。

【讨论】

针刺不慎导致手部畸形，是指在针刺治病过程中，包括穴位药物注射、电针、割治等疗法，致手内在肌肉组织受到损伤，并于损伤后形成瘢痕，从而造成手部挛缩畸形，甚至功能障碍的一种意外情况。这种情况一般有两种类型：一是因针刺伤及某神经干，致使该神经干发生功能障碍，日久受其支配的肌肉失去神经

营养而逐渐萎缩；另一种是因针刺手法过强，肌肉损伤过大，或注入有强烈刺激性的药物，使肌肉产生缺血、变性等病变，继而出现肌肉纤维性硬化致畸形。从现有资料看，手部畸形几乎全部都是由注射或针刺合谷穴之故。合谷穴的使用频率相当之高，它位于第1、第2掌骨之间，其浅层为第1骨间背侧肌，深层为拇内收肌横头，由于手部的肌肉比较小而娇嫩（尤其小儿更是如此），穴位局部的理化刺激，很容易波及这两块肌肉，使其产生化学性炎症，炎症波及拇内收肌和第1背侧骨间肌，使其血管痉挛，肌肉缺血，肌纤维变性，形成瘢痕挛缩而成本病。以上几个病例正是因合谷穴施术不当，导致穴区内肌肉挛缩、畸形，从而造成功能障碍的。

【临床表现】

合谷穴在穴位注射或针刺后，局部出现红肿疼痛，1周左右肿痛会逐步消失，但却渐渐出现拇指外展不便和手部畸形（手部畸形发生的时间，可以从注射后1周到数年不等）。其主要症候是：拇指呈内收状，外展功能明显障碍，部分患者合并有掌指关节屈曲或指关节过伸畸形，亦有伴食指桡偏畸形；绝大多数患者可在拇收肌附近扪得条索状硬结；病程久者，大鱼际肌群有不同程度萎缩；尚有些患者，因第1掌指关节及掌腕关节在拇内收肌屈曲畸形下发育，久之可形成病理性半脱位。

病理检查：绝大部分患者该部位肌纤维萎缩，且多为中、重度萎缩，被增生纤维所代替。肌内膜细胞增生，少数病例尚有肌纤维坏死。病变区普遍有纤维组织增生，纤维增生的程度与肌萎缩变化的程度相一致。

【处理方法】

本病一旦发生，应尽早采取有效措施，努力做到早期发现、早期治疗，以避免或减轻手部畸形变化。一般可根据病情选用下列方法。

1. 针灸：在萎缩肌肉局部选用1~2个穴位，作浅刺、轻刺；并循经远取1~2穴，手法可略强。起针后，局部加艾条温灸，每次10~20分钟。每日1次，5~7次为1个疗程，间隔休息3~5

天，多需 3~4 个疗程。

2. 理疗和锻炼：急性期可用红外线照射，也可用普鲁卡因离子透入，或用超短波治疗，每日 1 次，10 次为 1 个疗程。同时，如拇指出现功能障碍，应指导患者及早加强功能锻炼，采取被动运动和主动运动相结合方式，可减轻或避免手部畸形发生。

3. 药物治疗：维生素 B₁10 毫克，维生素 B₆10 毫克，口服，每日 3 次。此外，尚可用中药熏洗，方用川芎、红花各 15 克，细辛 9 克，当归、桂枝各 10 克，水煎后熏洗局部。

4. 如果经以上治疗 3~6 个月后效果不显，局部功能不能改善，或已出现手内在肌瘢痕挛缩导致手部畸形，则需要外科手术治疗。手术原则为：切断病变拇收肌或第 1 骨间背侧肌的止点部，以解除挛缩（成人瘢痕多局限于肌腹的一部分）。在切除瘢痕后一般多可恢复功能。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：由桡神经浅支分布，到达穴区的神经纤维由第 6 颈神经组成。

2. 皮下组织：有上述皮神经分支通过。在穴区附近，还有手背静脉网汇成的头静脉起始部。

3. 第 1 骨间背侧肌：该肌起于第 1 掌骨间隙内骨面，止于食指近侧节指骨底桡侧，由尺神经深支支配，到该肌的神经纤维由第 8 颈神经和第 1 胸神经组成。

4. 拇收肌：该肌由尺神经深支支配，到该肌的神经纤维由第 8 颈神经和第 1 胸神经组成。

【操作要点】

为预防因合谷穴施术不当而导致手内在肌损伤，术者在操作时应注意以下几个问题：①术者应具有比较完整的解剖知识，熟悉合谷穴的局部层次解剖情况，尽量避免施术时误伤桡、尺神经，或拇内收肌、第 1 骨间背侧肌；②术者操作手法要合适，在穴位注射或针刺时，手法应做到尽量轻柔，不要盲目为了寻求较好的得气感，反复上下提插或往不同方向探寻等；此外，应用电针时，应采用中等以下的强度和较慢的频率（若所通电流强度过大，刺

激频率过快，较易造成损伤)，小儿患者不适宜在本穴施行电针疗法（这与小儿组织娇嫩、手部肌肉较小，易于受伤有关）；③要注意选择好穴位注射的药物，避免在合谷穴注入刺激性强及难以吸收的药物，更不可反复注射。据有关资料的统计，因注射安乃近和复方奎宁所致的手部畸形，约占其发生率的90%以上，因此这两种药物应禁止在合谷穴注射，特别是12岁以下的小儿更须严格禁忌；④合谷穴虽为临床常用穴，但婴幼儿应尽可能少选，因为小儿的各种组织尚在发育之中（尤其是神经、肌肉组织），解剖标志不清，腧穴定位不易准确，加之恐惧针刺而常哭闹挣扎，所以使用该穴不仅难以取得预期的治疗效果，而且容易导致意外。

十六、针挑合谷穴引起动静脉瘘

【案例】

某一女性患者，38岁。因头颈部疼痛难忍，由本地一社员以粗缝衣针挑刺合谷穴与落枕穴，并用手指挤压针挑部位。挑刺后，合谷穴出血较多，按压即止。次日，针挑处呈片状皮下瘀血。月余后，左手背逐渐出现表浅静脉曲张，中指、无名指发绀，功能障碍，且逐渐加重。1973年12月左手中指不慎扎一小刺，拔除后血流不止，血色鲜艳，并感染不愈，疼痛严重。即前来求诊。化验：肝功正常，出凝血时间各1分钟。体检：左手肿胀，手背的中、无名指浅表静脉曲张并紫绀，挤握后血管变细，松开即充盈。中指指尖处有一直径为1厘米的皮肤变黑区，甲沟有少量脓性分泌物。合谷穴处可扪及明显的持续性震颤，听诊有持续性杂音，心脏收缩期此杂音增强。X线摄片示，中指末节呈骨髓炎样改变，动脉造影未成功。诊断：动静脉瘤。以瘘处四头结扎并行截指术而告愈^[25]。

【讨论】

动静脉瘘又称动静脉瘤，是动脉和静脉之间存在的异常通道。后天者经常因外伤引起。合谷穴处有手背静脉网，为头静脉的起始部，且穴位近侧正当桡动脉从手背穿向手掌之处，亦较表浅，故

选穴不准或刺入过深，可伤及动静脉造成穿透性损伤，创口出血形成或大或小的血肿，而来自动脉的血液大部分经瘻口分流入近侧静脉。血肿的机化过程中，在动脉和静脉压力差异的影响下，即可形成一贯通于动、静脉间的囊或瘻。如不予治疗，肢体的继发性静脉曲张明显，供应瘻的动脉近端支逐渐扩大，经过一段时间可变为扭曲和呈动脉瘤样，体外压迫患部暂时阻断通过动静脉瘻的血流，可以使脉率立即降低，即出现布兰汉征。本例患者针挑后合谷穴出血较多，呈片状皮下瘀血，显系已损及局部血管，由于治疗不及时，病情逐步发展而成为动静脉瘻。

【临床表现】

在外伤后立即或经数日乃至数周后出现，患肢肿胀、疼痛、麻木、乏力和运动功能障碍。体表有明显的浅静脉曲张，皮肤色素沉着或伴有肢体溃疡，偶可发生肢端坏疽。在瘻的部位一般无肿物，可扪到明显的持续性震颤，听诊时有持续性“机器隆隆声”样杂音，此杂音在心脏收缩期增强，并沿着血管近侧和远侧传播。

【处理方法】

一旦诊断确定，即须外科手术治疗，以恢复损伤部位动静脉的连续性，使局部血运正常。只要及时治疗，预后还是良好的。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：由桡神经浅支分布，到达该穴区的神经纤维由第6颈神经组成。

2. 皮下组织：有上述皮神经分支通过。在穴区附近，还有手背静脉网汇成的头静脉起始部。

3. 第1骨间背侧肌：该肌起于第1掌骨间隙内骨面，止于食指近侧节指骨底桡侧，由尺神经深支支配，到该肌的神经纤维由第8颈神经和第1胸神经组成。

4. 拇收肌：该肌由尺神经深支支配，到该肌的神经纤维由第8颈神经和第1胸神经组成。

【操作要点】

为预防动静脉瘻的意外发生，操作时术者要注意：①应熟悉合谷穴的局部解剖情况，由于它正处于头静脉的起始部，针刺的

时候应该尽量避开血管,尤其应该防止动静脉同时受到损伤;②细心体会术者手下的感觉,毫针刺入穴位时速度要缓慢些,提插捻转的幅度不宜过大,如针尖遇到有坚韧光滑的阻力感,或病人主诉疼痛时,即应退针变换方向再刺;③要谨慎选用较粗的针具,临床上三棱针仅用于浅部肌表的散刺或丛刺,禁止作单针深刺;毫针多选择 28 号毫针为宜。

十七、三棱针点刺八邪穴引起伤口感染

【案例】

Mania, 女性, 59 岁, 北也门籍。于 1982 年 1 月 5 日就诊。左臂反复发红并逐渐肿胀不消 20 年, 诊断为橡皮病。检查: 右臂肘尖以下 10 厘米处周径为 20 厘米, 而左侧该处为 50 厘米, 肘关节以上稍肿胀, 但组织较松软。因外科不同意手术治疗, 遂用针刺放液及绷带包扎法。穴取患侧八邪等, 用细三棱针点刺, 针点让组织液自流, 不流则挤, 待组织液停流后则包扎。每 5 天 1 次, 经治 9 次之后, 左臂周径缩小 15 厘米, 组织相应略变松软。但于最后 1 次针后, 第 2 天即发烧, 皮肤红痒, 第 3 天出现数个脓疱疹, 第 5 天前臂布满大小不同的脓疮, 至肘关节为止。体温持续 5 天在 $39\sim 39.5^{\circ}\text{C}$ 之间, 白细胞总数 $18000/\text{mm}^3$, 中性 90%, 淋巴 10%。以往无类似病史。外科及皮肤科会诊, 认为因针刺后并发淋巴管炎及皮肤脓疱疹, 与针孔大而多, 张开时间过久有关。经用青、链霉素 14 天后脓疱疹消失, 但橡皮肿周径却增加到 58 厘米, 八邪穴处呈溃疡状。又 2 周后创口基本愈合, 但原肿胀未消^[2]。

【讨论】

因针刺不慎导致的感染, 是临床上较为常见的针灸意外之一, 此处主要讨论的是针刺损伤所致的外科感染。正常情况下, 人体具有局部和全身的防御功能, 而皮肤则是保护机体的天然屏障。当针刺损伤了皮肤表面后, 如果所使用的针具消毒不严或针刺后局部保护不妥, 则致病菌会从穴位创口直接进入机体, 在局部组织和全身抵抗力比较低的情况下造成感染, 引起局部组织发生炎症

反应，如创口感染、脓肿等。本案例显系三棱针点刺的针孔过大，数量亦较多，且张开暴露的时间过长，未能保护好针刺局部，而引发皮肤脓疱疹及淋巴管炎。

【临床表现】

因机体感染的程度、性质等的不同，临床症状有较大的差异，一般可分为局限性化脓性感染和全身化脓性感染两种类型。

局限性化脓性感染：开始时于针孔周围发生硬结，颜色潮红，并有轻微疼痛。如果治疗不及时，可继续扩大，并伴有全身不适、发热等症状，局部出现波动，硬结逐渐变软，中央有黄色的脓头。如果感染发生在深部，则波动感不明显，但脓肿表面有水肿和显著的局部压痛，全身症状也较明显。

全身化脓性感染（局限性化脓性感染未能控制，或病人体质虚弱、机体免疫能力低下，大量毒力强的病原菌在血中繁殖、产生毒素而引起）：起病急骤，高热（可达 $40\sim 41^{\circ}\text{C}$ ），头痛，头晕，食欲不振，恶心呕吐，关节酸痛，呼吸急促或困难。病情若继续发展，可出现感染性休克。化验室检查：白细胞计数增加（可达 $2\sim 3$ 万），中性粒细胞在80%以上，幼稚型白细胞明显增多。

【处理方法】

局限性化脓性感染的处理：宜令病人患部休息少动，以减少疼痛及炎症扩散，千万不可挤压患处。可用鱼石脂软膏或金黄膏外敷，日换1次，局部及其周围尚可配合热敷、理疗（多用艾条熏灸局部，痛者以灸至不痛为度，未化脓者能予消散，将化脓者可促使化脓，已成脓者可促使破头）。适当应用消炎止痛、清热解毒的中西药，如中药用五味消毒饮煎服，每日1剂，或牛黄解毒片，成人每次4~5片，日3次；西药用青霉素，成人每次80万单位肌注（先作皮试），每日2次，或四环素每次0.25克口服，每日4次。

全身化脓性感染的处理：应选择抗菌谱广的抗菌药物，或两种抗生素联用，要求剂量宜大、疗程应长，并可加用清热解毒、养阴凉血的中药汤剂。注意给患者充分补充水分、蛋白质和营养，纠正电解质代谢失调和酸中毒，必要时输入新鲜血液。病情严重者，

可考虑使用冬眠疗法或激素治疗。此外，病人应卧床休息，减少活动，注意对患处的护理。

【穴位层次解剖（以大都* 为例）】

1. 皮肤：由桡神经的指背神经分布，到达穴区的神经纤维由第6颈神经组成（注：上都同大都；中都及下都均由尺神经的指背神经所分布）。

2. 皮下组织：有上述皮神经及手背静脉网通过。

3. 第1骨间背侧肌：该肌由尺神经深支支配，到肌肉的神经纤维由第8颈神经和第1胸神经组成。

4. 拇收肌：其神经支配同第1骨间背侧肌。

【操作要点】

为了预防针刺不当引起伤口感染，术者一定要建立正确的无菌观念，执行严格的消毒制度，做好针具和穴位的消毒工作，这是防止感染的关键；其次，对有感染病灶的部位，应尽量避免施术；注意保持针刺部位的清洁，在2个小时内不要用生水洗涤；出针后如果发现遗留针孔较大或有出血现象，应用消毒干棉球轻轻揉按，使其止血及闭合；最后，感染局部切忌挤压、针刺，或过早切开排脓，以防止毒素或细菌侵入血液；感染应尽早治疗，防止其扩散，以免导致严重后果。

十八、推拿不当致前臂骨折

【案例】

蔡××，男性，46岁，职员。左前臂桡、尺骨双骨折3月余，经多次闭合复位成功，以管形石膏外固定8周，经X线摄片复查：对位、对线尚可，有少量骨痂生长。拆除石膏后嘱加强患肢功能锻炼，1月来收效甚微，肘关节屈伸运动和前臂旋转功能均明显受限，前来门诊推拿治疗。专科检查：左肘关节屈曲畸形，关节屈伸活动度仅只有 $10^{\circ}\sim 20^{\circ}$ 左右，前臂旋转功能极差，前臂肌肉废用

* 临床上将八邪（单手）从外向内分别名曰大都、上都、中都和下都。

性萎缩，腕关节运动受限，手部握力减弱。拟诊：前臂骨折后遗症。施行推拿治疗时，为了使肘关节尽快恢复正常运动功能，医生与病人相对而坐，用胸部抵住患臂远端的背侧，双手紧紧地搂抱病人的双肩，相对用力，急速地产生被动屈肘运动，当即一声巨响，失去阻力，病人剧痛难忍，面色苍白，再次出现畸形外观，经X线摄片证实桡、尺骨双骨折^[9]。

【讨论】

推拿不当造成前臂双骨折多发生于前臂骨折后遗症的病人。前臂由桡、尺二骨组成，尺骨上端大而下端小，是构成肘关节的重要组成部分；桡骨相反，上端小而下端大，是构成腕关节的重要组成部分。桡、尺二骨借上、下桡尺关节及两骨之间的骨间膜紧密相连，其联合运动，则构成前臂所独有的旋转功能。而桡、尺骨干双骨折，常发生在青少年，由于前臂骨折，采用超关节的长期固定后，易出现肘、腕关节的屈伸和前臂旋转功能的障碍，这主要原因是因肌肉的长期不活动，产生了静脉和淋巴液的郁滞，血液循环缓慢，组织发生水肿，浆液纤维素性渗出物的形成、增多，产生了关节囊和肌肉间的粘连，从而导致活动功能的障碍。推拿疗法对康复运动系统的功能障碍确实是具有较理想的效果的，但是在具体治疗时（正如本案例所述），因缺乏对疾病的正确认识和有效的治疗措施，若单纯靠力相求，想以力取胜，那么结果是适得其反，引起再度骨折的意外。

【临床表现】

局部肿胀、疼痛，肢体畸形，旋转功能障碍，完全骨折者可有骨擦音，纵向叩击征阳性。前臂正、侧位X线摄片（应包括肘、腕关节）检查，可明确骨折类型及移位程度，并注意有无关节脱位情况。

【处理方法】

凡属闭合性前臂双骨折者，不论其部位、类型，都可应用手法整复，夹板或石膏固定治疗。若遇患肢肿胀严重，可先外敷消肿膏，临时夹板固定，抬高患肢，密切观察，数日后待肿胀消退，再做整复固定。

【操作要点】

为了避免骨折事故的发生,对骨折后遗症进行推拿治疗时,术者应以手法为主,关节运动法为辅,治疗重点应该放在相应的肌肉、筋膜等软组织上,而骨、关节只作辅助治疗即可。此外,术者对骨折愈合的过程和成人常见骨折临床愈合时间(尺、桡骨干骨折的愈合时间为1.5~2个月,桡骨下端骨折的愈合时间为1~1.5个月),应该有一个比较清楚的认识,在骨折尚未愈合的时间里,千万不要给予推拿治疗,更不要去做各类的关节运动法。

十九、四肢腧穴施术不慎致晕针

【案例 1】

刘××,男性,74岁。于1980年10月15日来诊。主诉:近日因生气,自觉头痛、头晕,伴左侧肢体麻木、行动不便,前来我院求诊。诊断:中风先兆。治疗:嘱病人平坐,俯伏于桌面,暴露针刺部位,常规消毒后,取左侧上肢肩髃、曲池、手三里、外关,下肢环跳、风市、阳陵泉、悬钟、丰隆、太冲。由于患者年龄偏大,手法过重,取穴亦稍多,故刺人不长时间,即感觉难受,大汗淋漓,恶心欲吐,有大小便之意。迅速拔掉所刺之针,抱病人平躺于床上,此时病人已不省人事,急刺其人中、少商、中冲、内关、足三里诸穴,1小时后病人恢复正常^[1]。

【案例 2】

某一女性患者,57岁,农民。因齿残根疼痛2天,剧烈疼痛半天就诊。由于牙齿Ⅱ°松动,准备在指针合谷作针麻下拔除。当用指针时,病人即感到酸胀,同时出现头晕、恶心、心慌、眼花、胸部闷重,脉细弱,75次/分,面色苍白等。在此情况下,也只好将残根一下拔除,侧卧半小时后病人才逐渐恢复正常^[2]。

【案例 3】

某一3岁的男性患儿,于1989年9月20日就诊。因腹泻3天,每天4~6次,质稀色黄,稍带有粘液,有时哭闹不安,由儿科转来针灸治疗。穴取合谷、足三里穴。先针合谷穴,予中等刺

激量，不留针，拔针后（足三里穴尚未针）小儿马上出现大汗淋漓、面色苍白，脉细弱每分钟 154 次，心音弱，呼之不应，四肢松软，眼睑不睁，眼球呆滞。立刻将患儿放平，按压其涌泉穴，遂逐渐恢复，10 分钟之后开始哭泣，1 小时后完全恢复。第 2 天复诊时腹泻亦止。

【案例 4】

某一男性患者，1978 年 5 月 7 日初诊。3 个月前因劳动面腰部挫伤，疼痛酸楚，直至腿膝。检查：第 4 腰椎压痛，腰肌紧张，活动受限，直腿抬高试验阴性，舌淡，苔白腻，左脉弦滑，右脉涩。治宜通络消瘀。取穴以左后溪为主，此系小肠经之输穴，也是八脉交会穴，通督脉，配腰扭伤穴。进针得气后，行烧山火手法，患者即感头晕、恶心，面色苍白，不省人事。马上出针，让病人平卧，灌热茶 1 杯，过半小时苏醒，大汗淋漓，自感第 4 腰椎一阵短时间的发热、麻胀。随后从腹股沟外侧在足阳明胃经髀关穴偏外 1 寸处，出现一条宽约 0.6 厘米的丘疹线，这条丘疹线沿相当于胃经路线下行，过膝至上巨虚处消失。出现丘疹样线时，病人发冷，约 10 多分钟后症状消失^[26]。

【案例 5】

某一女性患者，44 岁。于 1986 年 8 月 10 日初诊。患者于 1 小时前与人争吵，随即发生胃脘胀闷，攻撑作痛，脘痛连胁，嗳气频繁，曾用解痉止痛之西药，但胃痛仍未能缓解。既往无胃病史或神经官能症史。检查：患者呈痛苦面容，汗出呻吟，双手扪腹，胃脘部压痛，无肌紧张及反跳痛，舌淡红，苔薄白，脉沉弦。证属肝气犯胃，治宜舒肝和胃。穴位选取内关、中脘、足三里、太冲。毫针刺入并得气后，行针约 5 分钟，患者胃痛即止。此后，当其与旁人谈起争吵之事时，深感不平，随即发生手足痉挛，马上拔针，痉挛转为抽搐，经局部按摩后抽搐转为肌肉颤动不止，经用艾卷在患部往返灸治，经日乃愈。类似情况，笔者曾耳闻目睹共 7 例，故古训“大怒无刺，已刺勿怒”是有道理的^[27]。

【案例 6】

蔡××，女性，57 岁，退休工人。于 1989 年 11 月初诊。自

诉与家属争吵后而致胃脘作痛，暖气频频，痛连双胁，纳眠欠佳，二便失调。诊断为胃痛（肝胃不和型）。即予针刺双侧内关、足三里、太冲等穴，得气后行泻法，留针 20 分钟，患者自感胃痛明显减轻，暖气停作，但在针刺过程中神情忧郁，频频叹息。出针后患者突然面色苍白，出冷汗，头晕目眩，恶心欲吐，四肢厥冷。即令病人平卧休息，经询问陪同之人得知，病人因心情不畅，加之胃痛，未食早餐即来针灸，随即予以静脉注射葡萄糖液，约半小时后症状消失^[28]。

【讨论】

晕针是针灸临床上最常见的意外事故之一，虽然目前对晕针的发生机理尚无统一解释，但绝大多数人都同意这一观点，即应属于血管抑制性的晕厥。以上诸个病例，或是患者体质虚弱，或是疲劳过度，或是精神紧张，或是刺激过强，或是选取穴位过多，或是体位不当，或是情志改变等，均可导致晕针现象的发生。

【临床表现】

晕针大多发生在针灸过程中，但也有少数病人在取针后数分钟始出现症状，典型的晕针一般可分为三期，详细内容请参见前述。

【处理方法】

1. 常规护理：迅速拔出所有的毫针，将患者扶至空气流通处，并让其仰卧在床上，头低脚高位；及时松解患者的衣带，热天注意通风，冷天注意保暖；立刻测量其呼吸、血压、脉搏及心率，了解生命体征情况。

2. 轻者一般静卧片刻即可，如患者仍感不适，可给予温糖水或热茶口服，并注意使之安静和休息，约经 3~5 分钟后即可逐渐恢复。

3. 重者可在上述处理的基础上，用指掐或针刺人中、素髻、足三里、涌泉，或艾灸百会、关元、气海等穴；嗅以氨水；必要时可用肾上腺素 1 毫升、阿托品 1 毫克肌注，25% 葡萄糖 40 毫升静脉推注等。

【操作要点】

为防止晕针事故的发生，应注意以下几个方面：①要做好心理预防工作；②要注意消除各种容易导致晕针的诱因，如饥饿病人针前应适当进食，过度饱食者亦需待食物有所消化后方可施术，过度疲劳或激烈活动后都应让其稍加休息待其体力基本恢复才用针，大病后或大汗后病人，在针灸时要注意掌握刺激量，手法不宜过强，取穴亦不宜过多，并尽量采用卧位针刺；③选取腧穴时要慎重，凡是针刺某些针感较强而又特殊的穴位，如合谷之酸胀感、内关之闷胀感、十二井穴或十宣穴之锐痛感、肩髃之麻胀感等，均易引起晕针；④要注意改善环境和气候的不利因素，如气压低之闷热季节，诊室中空气混浊、人声喧杂等，亦可促使晕针的发生；⑤起针以后，最好让病人在诊室休息 10~20 分钟。

二十、针刺手背折针

【案例】

女性，29 岁，护士。于 1970 年 10 月 13 日，因 4|急性尖周炎剧痛，用一般止痛剂无效，以 2%利多卡因局部封闭或经翼腭管阻滞上颌神经，亦仅能止痛 0.5~2 小时许。遂在右手背牙痛穴针刺，强捻针约半分钟即止痛，即将针在手背皮肤外约 1 厘米处剪断，并在皮外 2 毫米处以蚊式钳尖夹针，使皮外段于该处弯成直角，再以胶布贴皮外固定，行“埋针”疗法。次日复诊，牙痛已缓解，但诉晨起床时已见胶布脱落，却未见针脱出。拍右手 X 线片，见第 3、4 掌骨区有成角状弯曲之针影，当时未行特别处理，嘱继续观察。1 周后复诊，述近日来觉右手温度低于左手，肤色暗红，轻度无力。嘱患者试以左手食指指尖自右手背进针处不时往掌面推压，如发现断针“露头”即来就诊。两天后患者发现断针在掌面两横纹之间已有“露头”，遂以酒精棉球擦拭，已能挂下棉纤维，当即来我科。即消毒其掌面，以左手食指指尖自背面原进针区施力按压，并以小蚊式钳尖张开之尖端向背侧施压，当针尖露出约 1 毫米时，夹紧向掌面顺利拔出。此后右手皮色、温度逐渐恢复正常。经多年随访，无后遗症^[29]。

【讨论】

折针是指针刺过程中发生针身折断（或被剪断）的现象。由于现代针具质量的提高，目前这种情况较为少见，但仍有个别案例陆续报道，故临床对折针意外仍须注意。究其发生的原因，临床上常见的有以下几个方面：一是针具原因，即针体质量过于粗劣，或针具使用过久或次数过频，有屈折、斑痕等，或放置过久，针具因氧化生锈而发硬变脆；二是医者原因，如操作不熟练，动作粗暴，或针刺过程中手法过重，捻转角度过大，频率过快等，均易使肌肉剧烈收缩而可能折针；三是患者原因，由于精神紧张恐惧，或针刺时不能耐受强烈的酸胀感，或留针过程中体位突然大幅度变动等，均可导致肌肉痉挛而折针。此外，随着各种穴位刺激法的不断涌现，折针的情况愈来愈复杂，如在电针疗法中，针体可因电针仪输出的直流成分电解电蚀而折断；穴位注射时若操作不当，注射针头也会断入穴内；头针疗法，因针体进入头皮内较长，加之捻转频率过快，亦可发生断针；穴位埋线结扎法，亦易造成缝合针在体内折断等。本节案例虽然针体被剪断是有意识的，且埋针时已做了些预防工作（如已将皮外段的针弯成直角，并以胶布贴敷固定），但由于埋针后胶布出现脱落，而致针体陷入组织内。

【临床表现】

非重要脏器或关节部位折针：一般多不产生重大后果，其共同特征是，折针局部有压痛，并逐渐减轻，有时折针处有重压感，活动时偶可出现疼痛，但往往无运动障碍。当折针涉及周围神经时，则局部疼痛明显，其末梢处有麻木感，痛觉减退。

关节内折针：凡在大小关节内折针，都会呈现严重的运动障碍和疼痛。如肋间关节断针，多可出现呼吸困难，胸痛；脊柱关节断针，长时间活动后有剧烈的疼痛及运动障碍。

脏器内折针：此类情况往往比较严重，常因脏器和折针部位的不同，可引起程度不等的功能障碍和疼痛。若肺部断针，则有咳嗽频数，呼吸困难，并有肋间神经痛发作样疼痛；心脏内断针，则有剧烈的心绞痛样疼痛，呼吸困难，并可迅速进入休克状态；膀

腕内断针，则可引起小便短数，排出困难，或有血尿。如果针断入于血管，则可能随血液流动，自动静脉进入较小血管，出现疼痛或有栓塞的危险。

一般说来，折针临床上最常见的情况有，一是针身折断，残端尚露在皮肤之外，二是残端完全陷入皮肉内。其结局亦大致有4种类型：一是折针移动后，引起有关脏器组织疼痛或功能障碍，最后只能以手术取出；二是自动向体外排出，皮肤和结缔组织的折针，许多情况下可自行从体表或从肠道（和粪便一起）排出；三是在体内各种理化因子的作用下，折断之针逐步发生溶解，但这通常需要相当长的时间；四是断针位于机体内相对静止的部位，或因刺激周围组织发生感染，针体可为结缔组织或纤维组织所包裹，长期留在体内不变。

【处理方法】

当折针发生时，患者不可惊慌乱动，医者更不能紧张失措。应让患者尽可能保持原体位，以免针体向肌肉深层陷入，给处理造成困难。

如果折针残端尚在体外，则可用手指或镊子夹住取出：若残端与皮肤表面相平，肉眼可见而又不能用指甲捏出时，可用手指将断针两旁的皮肤向下按压，使残端露出体外，然后用镊子取出。如果针体折断在重要脏器附近，或虽非重要脏器而患者自觉不适伴有功能障碍者，或由于针具、穴位皮肤消毒不严，断针带入细菌而在针道内生长繁殖已成为脓肿者，应请外科会诊，以手术取出为宜。

【操作要点】

为预防折针的意外事故发生，术者在操作时要注意：①检查针具，不使用弯曲、生锈或有其他损伤的针具。应用电针时尽量不用直流电针仪，且宜经常更新毫针，针具使用时间过久者即使外表完整也要定期更换；②术中操作要小心谨慎，进针时宜用双手进针法，将针徐徐送入；当病人咳嗽或变动体位时，应停止进针或将针向上拔；在刺入或拔针过程中，遇到阻力时，不要强行进针或拔出，可改变方向刺入或稍待片刻再拔针；针刺到所需的

深度后，无论行针或留针，都不能将针体全部插入穴内，至少应留 5 毫米左右于皮肤外面；遇到滞针、弯针等情况，应细心缓慢地拔出，切忌使用暴力；③医者和患者应密切配合，凡遇精神紧张或不乐意接受针灸治疗者，应先予心理上的安慰，争取合作；针刺之前，最好充分揉按穴区，以解除精神紧张患者的局部痉挛；凡欲留针，必须告诉患者不得随便移动体位，医生也应随时观察，小儿患者则须令家长配合固定体位。

二十一、针刺四缝穴引发感染

【案例 1】

陈××，女性，5 岁。因右手肿痛 8 天，于 1978 年 3 月 15 日就诊。患儿 8 天前发热、咳嗽，曾针刺四缝穴（双手）给予治疗，针后双手被污水污染，2 天后又发热，右手中指肿痛，不能活动，口服消炎药无效，3 月 11 日曾去当地卫生院诊治，诊为“腱鞘炎”，肌注青、链霉素和局部切开引流仍无好转，遂来我院就诊。检查：右手中指掌侧第 2、第 3 指横纹正中，有纵形切口，内有油纱布条引流，去除油纱布可见肌腱浸泡在血性脓液中，掌侧、背侧均肿胀，压痛明显。诊断为针刺并发感染（腱鞘炎并发指骨骨髓炎）。给予青、链霉素肌注，并在掌中间隙沿尺侧掌斜纹处、中指掌指关节两旁近指蹼处，做切开引流和对口切开引流，20 天后炎症逐渐消退，并于患指切口处取出 1.5 厘米死骨 1 块，伤口于 6 月 3 日愈合。但患指第 1 指关节抓握、握拳等活动消失，中指功能明显障碍，造成中指残疾^[2]。

【案例 2】

胡××，女性，2 岁。入院前 7 天，曾请当地一老妪用未经消毒且已生锈的缝衣针，针刺四缝穴治疗“疳积”。治疗后，因其出现张口困难、间歇性抽搐、角弓反张 1 天，于 1988 年 8 月 13 日入××县人民医院住院治疗。入院诊断：破伤风。患儿系第 1 胎，足月顺产，在当地医院住院分娩，既往身体健康，无外伤史及家畜咬伤史，未进行过预防接种。体格检查：体温 37.3℃，脉搏 100

次/分，呼吸 30 次/分，苦笑面容，全身皮肤及粘膜无出血点或黄染，表浅淋巴结未触及，舌尖有咬伤痕，颈项强直，双肺呼吸音清，心律齐，心率 100 次/分，未闻杂音，腹平软，肝、脾未扪及，巴氏征阳性。实验室检查：血红蛋白 117g/L，红细胞 $3.9 \times 10^{13}/L$ ，白细胞 $20.3 \times 10^9/L$ ，中性 82%，淋巴 18%；血液生化检查结果，氯化物 110mmol/L， K^+ 5.0mmol/L， Na^+ 140mmol/L， Ca^{2+} 8.1mmol/L；脑脊液常规检查，压力正常，白细胞 150/ μ l。治疗经过：予破伤风抗毒素 6 万单位静脉滴注，青霉素钠盐大剂量静滴，安定、鲁米那等镇静、抗惊厥治疗，吸氧，行气管切开插管、使用人工呼吸机等。入院 4 天后终因呼吸衰竭而死亡^[30]。

【讨论】

因针刺不当导致的感染，是临床上最为常见的针灸意外之一，它包括了针刺损伤所致的外科感染和针刺传播两类，这里主要是讨论前者。例 1 是由于患儿在针刺后未能保护好伤口，被污水污染后造成感染，形成腱鞘炎，又未经妥善及时治疗，炎症蔓延到指骨而引起指骨骨髓炎，最后造成中指残疾。例 2 是因穴位消毒不好，加上针具未经消毒且已生锈，针后造成破伤风杆菌感染，发生破伤风（一切开放性损伤甚至细小伤口均有发生的可能），最后导致死亡。

【穴位层次解剖（以食指上的穴位为例）】

1. 皮肤：由来自正中神经的指掌侧固有神经分布，到达穴区的神经纤维由第 6 颈神经组成（中指穴位的神经分布与之相同，无名指穴位的神经分布由正中神经和尺神经的指掌侧固有神经双重分布，小指穴位的神经分布均来自尺神经的指掌侧固有神经）。

2. 皮下组织：有上述皮神经及同名动脉、指皮下静脉通过。

3. 指深屈肌腱：示指、中指的该肌腱由正中神经支配，其纤维由第 7、8 颈神经和第 1 胸神经组成。到无名指、小指的该肌腱由尺神经支配，其纤维由第 8 颈神经和第 1 胸神经组成。

【操作要点】

为预防各种针刺感染的发生，要注意：①术者应建立正确的无菌观念，注意严格消毒和无菌操作，所用的针具都应经煮沸或

酒精消毒，术者的双手要洗净，穴位要用碘酒和酒精依次消毒；②在有感染病灶的部位，应尽量避免针刺；出针后如遗留针孔较大或有出血现象，要用消毒干棉球轻轻揉按，使其止血及闭合；针刺部位要保持清洁，在2个小时内不要接触生水；③感染患处切忌挤压、针刺，或过早切开排脓，以防止毒素或细菌侵入血液；感染灶应该尽早治疗，防止其扩散。

二十二、针刺不慎引起再度脑出血

【案例】

陈××，男性，73岁，退休工人，住院号1536。于1991年11月24日，因脑出血致右侧肢体瘫痪，收入院治疗。入院时，右侧肢体瘫痪2周，吐字不清，口角左歪，左眼睑下垂，纳差，舌淡，苔薄白，脉弦细。体格检查：体温37.6℃，脉搏62次/分，呼吸20次/分，血压17/9千帕，神志清楚。头颅CT示：脑出血。住院后，经益气活血通络，兼以化痰除湿治疗2个月（前未用针刺），方药用补阳还五汤合温胆汤，病情明显好转，右侧肢体功能基本恢复，右手触鼻自如，能单独行走、站立，口角歪斜消失，胃纳可，二便正常。于1992年1月13日上午（尚未出院），患者自己申请，前往门诊部针灸科诊治。针灸医师诊视后，嘱其取卧位，选曲池、合谷、环跳、足三里、绝骨为主，配阳白、四白穴，得气后采取补患侧、泻健侧之法进行针刺，10分钟后取针。患者突然呼之不应，当时测血压24/14千帕，心率70次/分，律不齐，血压比当时查房时升高了8千帕（16/9千帕），医务人员随即将他抬送急诊室，采用利血平肌注，高渗葡萄糖、甘露醇静滴等进行强心、降血压、降颅内压及输液，体检见血压稍下降24/10千帕，心率62次/分，心律不齐，瞳孔散大不等（左2毫米，右3毫米），对光反射不灵敏，右膝反射亢进。同日下午，内科主任进行会诊后，确诊为脑出血再度发生，按原方案继续抢救，但病情仍逐渐恶化，于下午4点50分，因抢救无效而死亡^[31]。

【讨论】

根据临床实验得知,针灸对人体的血压具有双向调节作用,原血压水平高者针灸后可降低,原血压水平低者针灸后可使之升高,这种效应与患者本身的状况有着密切的关系。而针刺升高血压的内在机制,国内外许多学者都认为,可能是由于针刺刺激通过相应的穴位传入神经,将冲动传至中枢(主要是脑干网状结构),然后通过植物神经,尤其是交感神经的兴奋,反射性地引起内脏、平滑肌、皮肤血管的收缩,外周阻力增加,以致血压升高。对于脑血管意外的患者,这种升压效应会更加明显。如果施术的时机、手法不当时,极易再次造成中风。本节案例显系术者不够谨慎,选取穴位过多(且感应均较强),手法亦过于强烈,导致血压急剧上升,在原有脑血管破裂尚未修复的情况下,造成脑出血的再度发生。

【临床表现】

多出现在针刺过程之中,或针后不久,其典型症候为:起病突然,常有头痛、呕吐、昏迷、大小便失禁、呃逆等,可伴有发热、四肢瘫痪。体征:血压骤然升高,瞳孔不等大,对光反射、角膜反射减弱或消失,颈硬,面肌、舌肌瘫痪,肌张力降低,偏身或交叉性感觉障碍,腹壁反射、提睾反射减弱或消失,腱反射先消失后亢进,同时出现病理征,视网膜出血,视乳头水肿。脑脊液压力增高,常为血性,脑超声波可显示中线波移位,头颅CT示出血、水肿等。临床上尚可根据不同症状的表现特征,将脑出血分为大脑半球出血、桥脑出血和小脑出血。

【处理方法】

1. 防止再出血:保持安静,尽量减少对病人不必要的搬动,躁动者可予以适当镇静剂。调整血压,过高者可肌注利血平1毫克,将血压维持在20.0~21.3/12.0~13.3千帕为宜。可根据具体情况,短期使用止血药。

2. 降低颅内压:可选用20%甘露醇或25%山梨醇250毫升快速静滴;速尿20~40毫克溶于50%葡萄糖液20~40毫升中静注;利尿酸钠25毫克静脉推注;10%甘油葡萄糖250~500毫升静滴。上述脱水剂和利尿剂可交替使用,每6~8小时使用1次为

宜。

3. 降温疗法：一般以冰块或冰帽作头部局部降温为主，这样可降低脑代谢率和耗氧量，有利于减轻脑水肿及脑细胞功能的恢复。

4. 防治并发症：注意保持患者呼吸道的通畅，防治褥疮、胃出血、尿道感染和循环功能紊乱等并发症。

5. 维持营养及水、电解质和酸碱平衡：昏迷病者可先禁食1~2天，从静脉内补充营养和水分；每日总量1500~2500毫升为宜；以后如无呕吐或消化道出血，可酌情开始鼻饲，并随时注意补充电解质、维生素、脑细胞功能活化剂，及时纠正酸碱平衡失调等。

6. 中医治疗：若闭证可鼻饲至宝丹或苏合香丸，脱证可用参附龙牡汤或独参汤。针灸治疗，闭证可取人中、涌泉、太冲、内关、曲池、丰隆、十二井等穴，脱证取关元、神阙、足三里、气海等穴；耳针疗法，可选取耳尖、心、肝、肾、皮质下、相应肢体；水针疗法，穴位选取与体针相同，药物常选当归注射液、复方丹参注射液、田七注射液、维生素B族注射液、胞二磷胆碱针剂等。

7. 血肿穿刺引流：若无开颅手术条件，可行颅骨钻孔血肿穿刺引流术。

8. 手术治疗：本法目的在于清除血肿，降低颅内压，缓解脑疝，改善脑血液循环，故当出现手术适应证时应尽早施行手术。但对高龄、生命体征不稳定、出血位于丘脑及脑干、脑疝晚期、血压过高未经控制、高热、严重消化道出血或内脏疾病、血压下降或休克者，均不宜进行手术治疗。

二十三、环跳穴位注射引起坐骨神经损伤

【案例1】

王××，女性，60岁，于1965年10月26日初诊。患者自诉80天前因患疟疾，由当地医生在左环跳穴处注射奎宁1针，约20

分钟后，其左下肢完全麻木，不能走路，被他人背着回家，以后左下肢由麻木转为火灼样疼痛，呻吟不止，严重影响生活。曾住院治疗1个月，但未见改善。来诊时，由人扶持进诊疗室，弯腰、屈左膝，左足不敢着地，坐时也只能用健侧贴着座位，被动伸直左腿则嚎叫，拉氏征 30° ，呈强阳性，肌肉松弛，左腿较右侧瘦小，环跳、殷门、委中等穴处压痛明显，皮肤感觉过敏。于是针刺上述痛点各1针，予中等刺激，每天1次。第1次后疼痛减轻，当夜能入睡；第2次后能自己起床活动；第3次后疼痛完全消失，但左腿行走仍乏力。3个月后复诊，疼痛已除，走路有力。2年后再次来诊，左大腿周径较右侧细2厘米，小腿细1.2厘米，仍有乏力感，但已不疼痛^[2]。

【案例2】

患者因患左侧坐骨神经痛，用醋酸氢化可的松25毫克加1%普鲁卡因2毫升行环跳穴封闭，当时无任何反应，于第3天开始，左小腿外侧及足背皮肤麻木疼痛，逐日加重，第5天出现烧灼样痛，并发生足下垂。这可能与氢化可的松的酒精成分有关，使坐骨神经髓鞘发生变性，治疗7个月后有显著好转，但留有明显后遗症^[32]。

【案例3】

患者因接受环跳穴水针注射，当即有触电样感觉传至脚尖，引起坐骨神经损伤，腓总神经功能完全丧失，呈绝对电变性反应，右足下垂已8年余，经多方治疗无效^[32]。

【讨论】

坐骨神经为全身最粗、最长的神经（含有运动和感觉两种纤维，支配股后肌群、小腿和足肌的运动，并司管小腿和足的感觉），从梨状肌下缘穿出坐骨大孔到达臀部，在臀大肌的深面经股骨大转子和坐骨结节之间降至大腿后面，并在股二头肌与半腱肌、半膜肌之间下行至腘窝，一般在腘窝上方分为胫神经和腓总神经。坐骨神经与膀胱经、胆经的关系最为密切，如膀胱经的秩边、承扶、殷门，胆经的环跳，以及经外奇穴坐骨、闭孔等，都正当或傍及坐骨神经主干，针灸时很容易伤及，其中以环跳穴致伤最为

常见。而针灸临床上发生的坐骨神经损伤，绝大部分是因为穴位注射时药液过分接近或压迫坐骨神经干，或所注药物刺激性太大，致使神经干发生一系列理、化反应，或毫针刺及坐骨神经后持续强烈捻捣等所造成。以上几个案例正是由于针刺操作不当，或快速推注刺激性较大的药物，导致上述意外发生。

【临床表现】

损伤侧沿坐骨神经通路和其分布区域出现疼痛，运动时牵引坐骨神经致使症状加剧，行走时膝关节强直过伸，并有下肢麻木、软弱无力等症，甚至完全性瘫痪。检查时可见大腿后群肌（如腓后肌等）出现肌肉弛软，足下垂，膝反射、腱反射、跟腱反射消失，小腿外侧浅感觉减退等症状。稍久可能会出现肌肉萎缩的现象。

【处理方法】

1. 针灸疗法：以足太阳膀胱经穴为主，适当配合足少阳胆经和局部穴位。主穴一般选用环跳、秩边、承扶、承山、大肠俞、腰₄~₅华佗夹脊，并可根据具体情况酌配阳陵泉、悬钟、足三里、坐骨等穴，每次选用主、配穴各2~3个，用毫针刺法或电针法（急性期用高频，慢性期用低频），予中、弱刺激，每次10~15分钟，每日1次，10次为1个疗程。

2. 理疗：中波透热，每日或隔日1次，10~15次为1疗程；或短波，每日1次，10~20次为1疗程；或微波，每日1次，5~10次为1疗程。以上各法任选一种，每次治疗10~20分钟。此外，可用1%~2%普鲁卡因离子透入，每日1次，10~20次为1疗程。

3. 中药：用党参15克，红花、当归、赤芍、白芍各10克，川芎8克，桂枝3克（以上为成人量，小儿酌减），水煎服，每日1剂，中成药可用舒筋活血片口服，每次3片，每日3次。

4. 西药：急性期因有水肿压迫等情况，可使用强的松5毫克口服，每日3次。维生素B族，每日肌肉注射1次（维生素B₁100毫克，或B₆50毫克，或B₁₂500~1000微克），或每日口服3次（维生素B₁10毫克及B₆10毫克）。若局部疼痛较甚者，可口服A、P、C0.5克或安乃近0.5克，每日3次。

5. 治疗期间可作局部的热敷、按摩，并注意配合功能锻炼，以

助早日康复。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：由臀上皮神经分布，到该穴皮肤的神经纤维来自第2腰神经后支的分支。臀部皮肤有丰富的皮脂腺和汗腺。

2. 皮下组织：有上述皮神经的分支分布，此处纤维脂肪组织特别丰富。

3. 臀大肌：是人体中最大而肥厚的肌肉，形成特有的臀部膨隆，由臀下神经支配，到该肌的神经纤维来自第5腰神经和第1、2骶神经。

4. 坐骨神经：是人体中最大最长的周围神经，由第4、5腰神经及第1至第3骶神经的前支纤维构成。该神经正当穴位处，若进针准确时常可刺中。

5. 股后皮神经和臀下动、静脉。

6. 股方肌：由骶丛分出的股方肌神经支配，到该肌的神经纤维来自第4、5腰神经和第1骶神经（坐骨神经在该肌的浅面通过）。

【操作要点】

为预防坐骨神经受损，临床于环跳穴施术时要注意几个问题：①术者应熟悉坐骨神经的解剖部位，以及环跳穴局部的层次解剖，根据病情合理选用治疗方法；②选择针具要细，毫针以28号为宜；穴位注射用针头，浅表用4号，深部用5号齿科针头，不应使用较粗针头，否则易伤及深部神经干；③要小心操作，切勿为了获得较好的得气感而反复提插探寻。如病人在术中出现有麻电感向大腿后而、小腿后外侧、足趾传导，一般为针尖触及坐骨神经所致，此时应将针退出部分，待此现象消失后再继续施术；④本病多因穴位注射不慎引起，故要尽量避免使用刺激性大、酸碱度过高、药物浓度过高或过低的药物，如安乃近、异丙嗪、复方奎宁、氯丙嗪、醋酸可的松、普鲁卡因等，多选择些浓度适中及刺激性较小的、酸碱度接近中性范围的药物。

二十四、环跳穴位注射引起经络不良反应

【案例】

姜××，女性，56岁。因慢性腰腿痛急性发作，于1975年4月23日来我科治疗。当时予以0.5%普鲁卡因注射液5毫升加维生素B₁₂1毫升混合后，注射于右环跳穴（患者曾作过普鲁卡因过敏试验，阴性），在推药过程中，患者自觉一股酸胀感自注入处，沿大腿外侧缓慢传导至足背外侧。取针后20分钟，酸胀感聚集于足外踝前下；半小时后，在右丘墟穴附近出现一拇指大肿物；第2日，患者来诊时，其肿物已肿至半个乒乓球大小，颜色青紫，压之疼痛，并诉腿外侧（相当于胆经循行线路）仍酸胀难禁。即以三棱针刺络拔罐，拔出恶血15毫升左右，顿觉轻松。6日后，于相当阳陵泉穴处又出现一直径约7厘米的圆形青紫瘀斑，复以上法刺络拔罐，外敷“治伤散”。自此，或3日，或5日，反复出现同类瘀血斑共6个，且沿胆经线路由下向上，异常感觉亦逐渐上移。于5月20日，患者自觉环跳穴处酸胀强烈，但局部未见异常，仍以刺络拔罐，拔去恶血7毫升左右。此后，右腿十分轻松，功能障碍消失。随访3年，未见复发^[33]。

【讨论】

经络不良反应，亦有人称之为循经感传的劣性效应，是指在针灸（包括各种穴位刺激）激发下，于循经感传中或气至病所后所出现的一些损伤性反应。自70年代起，这种情况日益增多，它不仅可给机体带来一定的功能障碍，而且也会造成某些器质性病变。目前对这种现象的机理尚不能作出圆满解释，其确切原因亦不清楚。据有关资料显示，可能包括下列因素：刺激量（多见于应用激发循经感传或气至病所的手法时，其刺激量往往较一般针刺的刺激量要强）、年龄（据观察此类现象多见于10岁以内儿童）、体质（针刺诱发的一些可见的经络不良反应，如皮丘带、循经皮疹等，以循经感传显著而又有皮肤过敏史者多见）。

【临床表现】

经络不良反应主要有下列两类情况：一是功能性障碍。出现循经的抽痛、麻木、抽搐，并可呈现或伴有内脏功能失调，如上传至膀胱则有尿急，至腹部时则有腹痛，到胃区时则有胃部灼热、恶心呕吐，到胸部时则见呼吸困难、胸胁紧闷、心悸、胸痛等，至颈项部则有吞咽困难、咽干，到眼睛时则有头晕目眩、视物不清。还有，循经感传到术区，创痛加剧，有节律性跳痛，并感到循经感传通不过切口时，有强烈的冲击感；二是器质性病变。目前以皮肤出现循经性病理改变最为多见，如循经皮疹（包括扁平苔藓样皮疹，湿疹样皮疹和密集性小水疱样皮疹）、循经出血带（往往是先形成带状红斑，进而形成丘疹，最后发生循经血管脆性改变，红细胞渗出，而成为循经出血带）、循经皮丘带（即循经产生荨麻疹样改变），与此同时还可伴全身发热、体温升高 $0.5\sim 1^{\circ}\text{C}$ 、多汗、脉快等。

【处理方法】

功能性障碍：本病症多为一过性的、可逆的。当症状出现后只要立即停止刺激，即可迅速或逐渐消失，不需特殊处理。

器质性病变：可采用病损的对侧本经穴位，或同名经交叉对应点进行针刺治疗。若疗效不满意时，宜配合穴位注氧、耳穴压丸或贴磁、头针及病侧循经取穴治疗等方法。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：由臀上皮神经分布，到该穴皮肤的神经纤维来自第2腰神经后支的皮支。臀部皮肤有丰富的皮脂腺和汗腺。

2. 皮下组织：此处纤维脂肪组织特别丰富，并有上述皮神经的分支。

3. 臀大肌：是人体中最大而肥厚的肌肉，由臀下神经支配，到该肌的神经纤维来自第5腰神经和第1、2骶神经。

4. 坐骨神经：该神经正当穴位，为人体中最大最长的周围神经，由第4、第5腰神经及第1、2、3骶神经的前支纤维构成。

5. 股后皮神经和臀下动、静脉。

6. 股方肌：由骶丛分出的股方肌神经支配，到该肌的神经纤维来自第4、5腰神经和第1骶神经，坐骨神经在该肌的浅面通过。

【操作要点】

由于对经络不良反应的确切原因尚不明瞭，故目前还无有效的预防方法。一般可试着采取以下措施，尽量减少这类反应：①对循经感传敏感且有体质过敏者，应避免采用激发经气至病所的针刺手法；②经络不良反应可反复诱发，故有此反应史者，亦应慎用激发循经感传的方法或手法。

二十五、臀部深刺引起臀上动脉破裂出血

【案例】

某患者，男性，22岁，工人，住院号190812。于1月14日因左侧臀部酸痛（无外伤史），而前来接受针刺治疗，穴位选取秩边、环跳、阿是穴等，先作提插刺激，后再接电针仪20分钟。当晚自觉左侧臀部疼痛加剧，伴畏寒、发热，体温38℃，经口服安乃近，肌注青霉素、链霉素数日，症状未见缓解，疼痛范围反而扩大，致左下肢行走不便，体温高达39.5℃，并伴有乏力、纳差等症状。于本月22日来我院急诊，行局部穿刺术，抽出约0.5毫升脓液。涂片化验：红细胞40~50个，白细胞100个。拟诊左侧臀部深部脓肿而入院。体格检查：体温38℃，一般情况尚可，发育正常。左下肢活动受限，左臀部明显较右臀为肿，表面皮肤略烫，深部有压痛，波动感不明显。化验：白细胞 $11.5 \times 10^9/L$ ，中性81%。根据以上情况，考虑为左侧臀部深部感染和深部脓肿可能。治疗以抗感染为主。患者入院后17天中，曾作左侧臀部穿刺术3次，均未抽及脓液，仅抽出血液约20毫升，穿刺液培养未见细菌生长。于2月7日在局麻下再行穿刺术，抽出暗褐色血液，再考虑为血肿感染，并即刻在腰麻下行血肿切开引流术，引出脓性血液约500毫升，术后在两处切口各置一根空心雪茄引流。但之后又有两次因走动等原因导致伤口出血（出血量分别为300毫升和400毫升）。遂请骨科会诊，考虑出血原因可能为大血管破裂，即施行手术。术中发现，臀大肌的深层、梨状肌水平以上，有大

量血块，组织水肿，血肿底部达坐骨结节。清除血肿后，发现活动性出血来自臀上动脉，即予缝合结扎止血，同时输血 800 毫升。术后体温逐渐下降，食欲增加，23 天后痊愈出院。病理诊断：左臀上动脉假性动脉瘤^[34]。

【讨论】

动脉瘤在病理上分为真性与假性两种。针刺所引起的为外伤性假性动脉瘤，乃针刺时损伤体内的重要动脉或其分支，导致大量出血，而周围组织对溢出的血液包围、限制形成一个搏动性血肿，其中血小板、纤维蛋白进行机化包裹，形成瘤壁，由于血压的关系，血液可继续流出，瘤体不断扩大，从而形成越来越大的动脉瘤。本例显系术者针刺臀部阿是穴（胞育穴旁开 2 厘米处左右）时，由于超过规定的针刺深度及大幅度提插，加上病人本身可能存在臀上动脉畸形，结果损伤臀上动脉，引起臀部肌肉内大量出血。此外，由于出血发生在肌层丰厚的深部，不易确诊。开始认为感染和深部脓肿，后经多次穿刺又考虑是血肿，直至最后手术方发现为动脉破裂。

【临床表现】

由于针刺损伤的程度，血管的类型及其所处部位的不同，临床表现各有不同：浅表小静脉、毛细血管损伤，则表现为较小的出血斑块或少量的鲜血自针孔流出，但很快可自行停止。如损伤小的动脉，则起针后有血液流出，或积于皮下形成血肿。如损伤四肢浅表较大的动脉，则可见血液喷射或短时间形成较大的血肿。当血管位于肌肉深层（如臀上动脉），特别是动脉血管，往往会引起较大的内出血，出现大血肿，血管愈主要，破裂愈严重，血肿程度愈明显，甚至形成假性动脉瘤。对针刺所致的动脉瘤，根据血管部位有针刺史，针治后局部出现搏动性肿块，并产生疼痛、发热等，且有局部压迫症状（如在臀部会造成行走不便，在颈部因压迫气管而出现呼吸困难等），肿块还伴有收缩期震颤及吹风样杂音等即可诊断。另外，选择性动脉造影术，对判明动脉瘤的起源，侧支循环的代偿情况有一定帮助。

【处理方法】

浅表点滴出血：只需用消毒干棉球压迫针孔数分钟，一般即可止住，无需特殊处理。皮肤局部出现瘀肿，应先给予冷敷，待出血止住后再用热毛巾外敷，每次 20 分钟左右，以促进溢出血液的消散吸收。瘀肿可在 3~5 天、最多 7~10 天内自行吸收。

深部大血管的破裂出血：若血管较重要或裂口较大，用一般止血方法不奏效，且有手术指标时，应及时转外科施行手术治疗（结扎或修补）。当失血过多，出现休克症状时，要先行抗休克治疗。

【操作要点】

为预防针刺损伤血管形成假性动脉瘤，临床施术时要注意：①熟悉所选取穴位的局部解剖，由于人体上有不少的穴位都处在血管之上，在血管附近的穴位就为数更多，故针刺的时候应该尽量避开血管，针刺手法宜轻，切忌乱捻乱捣，在有较大血管分布的区域，更需细心体会手感，如针尖遇到有坚韧光滑的阻力感，或病人主诉疼痛时，即宜退针变换方向；②要选择好针具，施术时多用体直、光滑、有弹性、无折痕锈蚀、针尖不带钩毛的针具，在大动脉处针刺忌用三棱针、圆利针、缝衣针、注射针、大针等，因为它们针体过粗、头部太尖，不仅针刺时疼痛，且容易出血，故不宜使用；③出针后应用干棉球压迫针孔，使其迅速闭合，如发现有出血现象者，宜密切观察，必要时请外科处理；④对有血管病变者，应尽量不选用可能伤及主要血管的穴位。特别对有严重的凝血机能障碍等的出血性疾病患者，更要劝其采取其他中西医疗法治疗。

二十六、下肢腧穴施术不当导致过敏反应

【案例 1】

据报道，曾用促肾上腺皮质激素穴位注射配合针刺、热疗等综合措施，治疗脊髓灰质炎后遗症 30 余例，有 1 例穴位注射后，出现对称性红疹，约半小时后即消失^[35]。

【案例 2】

某一女性患者，30岁。妊娠8个月，双下肢轻度浮肿，胎心音正常，臀位，每日晨、晚做膝胸卧位20分钟。某次例行产前检查后，医生嘱其可用灸法治疗。翌日晚，患者自用艾卷熏灸至阴穴20分钟，约1小时后，自觉胸、背、四肢瘙痒，至翌晨眼睑、口唇、面部皆浮肿且痒，胸、背、腰及四肢发生风团样丘疹，瘙痒难忍。拟诊为急性荨麻疹。予中药荆芥、防风各9克，银花、白藓皮、地肤子各15克，苍耳子、当归各12克，蝉衣6克，每日1剂，共3剂；并暂停艾灸。停灸后，症状消失。至夜间又自灸至阴穴，上述症状再次发作，且较前更重，并出现胸闷、呼吸困难，外阴部肿，排尿困难等症。平素无过敏史。处方：羌活、苦参、荆芥、当归各9克，蒲公英、紫花地丁、白藓皮、地肤子、薏米各15克，苍耳子12克，丹皮6克，每日1剂，6剂后症状消失。此种症状两次发生都为艾灸所引起，且无其他可疑过敏史，症状皆相同，故认为患者对艾灸过敏^[36]。

【案例3】

某一女性患者，43岁，工人。因坐骨神经痛用维生素B₁、B₁₂各1支，注射于左侧大肠俞、环跳、委中穴，注射毕后在回家途中，即感双手心发痒、发红，伴见胸闷、腹痛、便意、恶心呕吐、出冷汗，继而不能支持，到家时离注射后已20分钟，送回科内复诊。体检：急性痛苦面容，呻吟不止，辗转卧位，心音低钝，律齐，双肺正常，呼吸略急促，腹软，脉微速。即针内关穴（双侧），并用25%葡萄糖水40毫升加维生素C500毫克静脉注射。2小时后恢复常态，自行回家。以后改用针刺治疗。1周后重复应用维生素B₁、B₁₂穴注于左侧肾俞、承扶、承山，注射后约3分钟，患者即诉不适，急于平卧，面色苍白、冷汗淋漓、四肢发冷、脉细弱而数不清。即皮下注射肾上腺素1支，仍呻吟不止，掌心发麻，吐出胃内容物两大碗，腹痛，有便意；又静脉注射25%葡萄糖40毫升，至10时30分，脉转平稳，心率每分钟80次；下午3时仍有双手震颤。10小时之后诸症方消失^[37]。

【案例4】

甘××，女性，11岁。于1984年11月16日就诊，自诉右侧

腹股沟及右髋关节疼痛，向右下肢后侧放散1年，曾在某军医院诊为“右股骨头无菌性坏死”、“右髋关节炎”，经中西药治疗无效，转我科治疗。体检：局部无红肿压痛，右下肢较左下肢短2厘米，余无异常发现。实验室检查：血、尿、大便常规检查均正常，血沉33毫米/小时，抗“O”<333单位。腰、骶椎正侧位片及双侧髋关节无异常发现。无药物及其他物质过敏史，亦未行过针灸治疗。

即取右侧环跳、殷门、委中、承山，行平补平泻手法，得气后留针15分钟，针后疼痛明显缓解。当晚8时许，患者右下肢出现以针眼为中心、直径约8厘米的圆形红斑，略高于皮肤，有剧痒，而同日在本院注射室注射维生素B₁的针眼处却未见此类红斑，当时未作任何处理。3天后红斑消退。为了验证此红斑是否确由针刺所致，于11月20日下午再次为患者针刺，取穴及针刺手法均同前次，所用毫针均选用经高压消毒的新针，局部用75%的酒精常规消毒。针刺后局部无任何变化，嘱停服一切中西药物，当晚8时左右，患者又出现类似前次的红斑，且面积更大，红斑处甚痒，未作任何处理，3天后红斑自行消退^[38]。

【案例5】

黄××，女性，59岁，教师。于1990年3月8日初诊。患者左膝关节肿痛2个月余，遇寒及活动加甚，来我院诊治。检查：左膝关节肿痛，左膝眼触痛（+），血沉16毫米/小时。用夏天无注射液2毫升在膝眼、足三里穴位注射，每穴1毫升，每日1次。于3月10日穴注第3针，约3小时后局部皮肤出现皮疹，而部轻度瘙痒，停药2天，未做任何处理，皮疹及而部瘙痒消除。又于3月13日再次穴注夏天无针剂1支，1小时后全身起皮疹，疹子呈点片状，色鲜红，无痒感^[39]。

【讨论】

案例1、3、5均系因穴位注射的药液（致敏抗体）进入人体后，诱发产生IgE类抗体，并与血管周围肥大细胞和血循环中嗜碱性细胞结合，引起肥大细胞膜层结构稳定性改变及其内部的一系列生化改变，促使脱颗粒和过敏介质的释放，导致毛细血管扩张，产生风团、瘙痒等过敏症状。案例2、4的病入均属过敏体质，在

灸或针的刺激下，引发过敏反应。

【临床表现】

一般情况下，过敏反应多发生于施术过程中或施术完毕后不久，临床表现以过敏性皮疹最常见，即穴位周围区域的局限性红色小疹，或全身性的风团样丘疹，往往浑身发热，瘙痒难忍。根据其形态的不同，临床上又可将它们分为固定性红斑、麻疹样红斑、猩红热样红斑、剥脱性皮炎等几种。严重者可伴有胸闷，呼吸困难，面色苍白，大汗淋漓等，甚则出现过敏性休克。

【处理方法】

有局部或全身过敏性皮疹者，一般于停止该疗法后不久可自然消退，在这期间应多饮水，并可用抗组胺、维生素C等药物，或注射高渗葡萄糖以加强排泄。若兼见奇痒、口干、发烧、烦躁不安等症状时，可适当用皮质类激素，如强的松10毫克，每日3次；或中药清热凉血、祛风止痒方剂，效果亦不错，拟方鲜生地20克，丹皮、赤芍各9克，蒲公英、板蓝根各30克，苦参、茯苓、山栀、车前子各12克，生甘草3克，水煎服，每日1剂。

当表现为面色苍白，大汗淋漓，脉象细微时，除了肌肉注射抗组胺药物外，还可肌注或静注肾上腺素，必要时注射肾上腺皮质激素等药物。

【操作要点】

为预防针灸过程中发生过敏反应，术者在施术前应仔细询问病人的病史，了解有无过敏史，特别是对穴位注射是否过敏；对一些已知可引起过敏反应的药物，如青霉素、链霉素、普鲁卡因等，均应先作过敏试验，证明无反应者方可使用。这里要特别指出，某些中药制剂引起的过敏反应，临床上亦不罕见，故使用时应该小心谨慎。在治疗时，应注意观察病人情况，一旦出现过敏反应的先兆时，宜马上停止穴位注射，及时给予相应处理。

二十七、推拿不当导致股骨干骨折

【案例1】

吴××，女性，30岁，农民。因肢体远端小关节对称性疼痛3年余，有晨僵史，呈缓进型发展，关节运动功能日趋受限，行走不便，给生活带来极大痛苦而求诊。检查：双侧手腕关节肿胀，屈伸、尺偏、桡偏运动均受限制；指间关节有不同程度的梭形肿胀，屈伸运动受阻；步履艰难，双髋关节轻度屈曲，内收畸形，髋关节运动障碍，“4”字试验（+）；双踝关节肿胀，压痛。类风湿乳胶试验阳性，红细胞沉降率 >40 毫米/小时。X线摄片见：构成诸关节骨组织均有不同程度的骨质疏松，关节间隙明显变窄。拟诊断：类风湿性关节炎。

治疗经过：该病人自从接受推拿治疗后，自觉有一种比较轻松的感觉。但是，最后一次强行做髋关节被动屈曲、外展、外旋时，患者取仰卧位，患肢呈“4”字试验状，医师的一手在患肢股前内侧的近端用揉法治疗，另一手放置在患肢的膝部作好向下按压的准备；另一助手按压住对侧髌前上棘，以免发生身体的晃动。准备就绪后，医师猛力向下按压膝部，一声巨响，病者剧痛难忍，即刻股部出现肿胀，畸形外观和畸形运动。急送××医院骨科，经X线摄片检查，明确诊断为左侧股骨中段斜形骨折^[9]。

【案例2】

某男性患者，20岁，农民，于1970年秋某日门诊。自诉两个月前因车祸，造成左侧股骨中段横形骨折，在外院曾作髓内钉固定术，术后左膝关节屈伸运动受限，行走不便，希望能早日恢复正常功能，故要求推拿治疗。门诊检查：体格健壮，跛行，原手术切口愈合良好，股四头肌萎缩明显，膝关节屈伸运动范围只有 $10^{\circ}\sim 15^{\circ}$ 左右，有僵硬感。X线摄片提示：股骨对位、对线及髓内钉固定均属良好，骨折断端已具有少量骨痂生长，骨折线模糊，膝关节间隙正常。

推拿治疗：病人取仰卧位，医师站在患侧，先在股四头肌用揉法、按揉法、拿法、擦法治疗。尔后以一手的前臂置于患肢的腘窝部，另一手紧握患肢的踝前部，双手作相反方向的对称用力，猛烈被动屈曲膝关节，随着一声骨响，病人疼痛不堪，患肢再次出现畸形和肿胀。经××医院急诊，X线摄片证实：股骨中段原骨

折处再次出现骨折，向前成角，原髓内钉亦向前成角弯曲^[9]。

【讨论】

股骨是人体中最长的管状骨，骨干由厚而坚强的圆柱形皮质骨所构成，一般正常人的股骨干比较坚强，非强大暴力不易造成骨折。但在推拿临床工作中，由于术者对引起髋、膝关节强直的原因及其病理基础认识不足，故在治疗时手法和关节运动法容易使用得不正确，最后使股骨所受的杠杆力量和扭曲力量过大，造成股骨斜形或螺旋形骨折，酿成医源性股骨干骨折的医疗事故。本案例1患者类风湿性关节炎3年余，已发生髋关节强直和局部骨质疏松等病理改变，不需很大的力量就能够使其造成骨折，更何况是使用较强大的扭曲力量（对关节运动有限制者，可通过充分的手法治疗和热敷方法来逐渐改善关节活动度，这样会比较安全、有效）。案例2是股骨干横形骨折手术髓内钉固定的病人，在手术治疗后由于股四头肌与股骨干发生粘连，从而影响了膝关节的正常活动，通常需半年到1年的治疗并加功能锻炼，方能恢复正常功能。其中推拿治疗的重点应是“以软组织为主，关节屈伸为辅”，但术者却违反此原则，施术后造成股骨干再骨折，连髓内钉亦随之向前成角弯曲。

【临床表现】

损伤后局部剧痛、肿胀、皮下瘀斑或血肿，患肢不能活动，若出血较多时可发生休克。患肢可有缩短、成角、旋转畸形及异常活动，有压痛和骨擦音，叩听诊时患肢骨传导音明显减低。X线摄片可显示骨折的具体部位和类型。

【处理方法】

1. 一般治疗：严禁翻身或做不必要的检查。送医院前的合理就地固定患肢非常重要。由于病人多完全丧失站立或步行的能力，不适当的搬运常可引起更多的神经、软组织损伤，故应做好急救阶段的处理（最简易的固定方法是将患肢与健肢用布条或绷带绑在一起，或在患肢的内外侧各放一条木板，内侧抵住会阴部，外侧超过骨盆平面，用布条或绷带绑住）。

2. 整复治疗：①整复：木板固定法（仅适用于横形骨折）。由

于股部肌肉较丰厚，不同部位的骨折受牵拉的肌肉不相同，能产生不同的骨折移位，徒手整复往往比较困难，所以常应用麻醉的方法，在肌肉得到充分松弛的情况下进行手法整复；②悬吊骨牵引：木板固定法（适用于粉碎骨折、斜形或螺旋形骨折）。一般只要牵引方向和牵引重量合适，木板和纸垫位置恰当即可达满意的复位，等骨折复位后，就应及时减轻牵引重量，避免过度牵引。粉碎骨折如碎片过于分散，可在牵引的早期，在骨折局部施挤压手法，使碎片互相接近；斜形骨折如两斜面互不相对时，可用回旋手法使远段由前或由后绕过近段，使远近两骨折端的斜面相对，然后再按上法进行骨牵引和固定；③功能锻炼：从复位后第2天起即可开始，练习股四头肌收缩及踝关节背伸和跖屈活动。

3. 整复治疗失败者，患肢有 $10^{\circ}\sim 15^{\circ}$ 以上成角畸形者，旋转畸形在 30° 以上，重叠畸形超过2~3厘米，或骨折不愈合者，均可采用手术方法治疗。

【操作要点】

为预防推拿不慎面导致股骨干骨折的意外事故，术者在实际操作时应注意下面几个问题：①推拿时应尽可能避免对股骨干施行强大、猛烈的杠杆力量和扭曲力量；②要掌握类风湿性关节炎疾病的病理改变，了解推拿作为一种外治疗法，在病变已达到骨性强直阶段时若想完全恢复关节运动功能则是徒劳的，往往不需很大的力量即可使其发生骨折。所以在推拿时要掌握好力度，尤其俩人协同治疗时要特别注意配合默契；③要提高对骨折愈合机理的认识，明确推拿疗法可作为骨折后运动系统康复的一种治疗手段，其重点是以软组织为主、关节屈伸运动为辅，对于损伤后时间太短，或尚未完全骨性愈合，或不坚固的骨性愈合（如棉絮状骨痂，或密度较低的板样骨痂），暂时不宜进行推拿治疗，更不应做猛烈的手法推拿；④对骨折后遗症的病人，施行推拿治疗之前，一定要做X线摄片检查，并认真阅读其结果，再决定能否进行治疗，不要贸然允诺，以免发生意外。

二十八、下肢穴位注射不当导致 肢端坏死

【案例 1】

某男性患儿，5 岁。因排血性粘液脓性大便，每日 10 余次，伴里急后重并发热，于 1972 年 7 月 4 日就诊。大便检查有多量红细胞、粘液、脓细胞。遂行双侧足三里穴位封闭，药液选用 12.5% 氯霉素，每穴 0.25 毫升，症状逐日缓解。但于 3 天后，发现左足穴位封闭处红、肿、疼痛，左胫骨前中段皮肤苍白、坏死，1 个月后摄片，发现胫骨已有死骨形成，最后经手术治愈^[40]。

【案例 2】

某男性患儿，6 岁。因排粘液血便，每日 10 余次，伴里急后重、腹痛，于 1973 年 6 月 10 日来诊。大便常规检查：红细胞（卅），粘液（卅），白细胞（卅），诊断为细菌痢疾。用 12.5% 氯霉素 0.5 毫升作左侧足三里穴位封闭，次日感觉左下肢疼痛，穴位封闭处明显红肿，剧烈疼痛，并发现左足趾苍白。5 日后足趾全部呈干性坏死，遂行坏死肢端切除术^[40]。

【案例 3】

徐××，男性，42 岁，农民。平素有胃病史，近日又复发，胃痛明显，伴恶心、呕吐、吐酸水、食欲减退，曾去某公社医院诊治，给硫酸阿托品 1 支封闭足三里，胃痛立止，其他症状减轻。次日自觉封闭处红肿微痛，逐日加重，第 5 天除红肿疼痛外，还伴有恶寒战栗、体温升高，再去诊治，诊断为注射感染，予青霉素、链霉素注射等无效。局部疼痛剧烈，体温 40℃ 以上，封闭处红肿蔓延至整个小腿及膝部，乃转来我院治疗。诊断为气性坏疽。因病情凶险，保守治疗无效，经高位截肢才保住其性命^[41]。

【案例 4】

某一男性患者，26 岁。因左下肢背侧放射性疼痛，在当地医院用氢化可的松 100 毫克、0.25% 普鲁卡因 20 毫升，50% 葡萄糖 15 毫升混合，等量分别注入阳陵泉、承山、环跳 3 穴。约 4、5 小时后，自觉左小腿剧痛、肿胀，给予一般止痛处理不仅无效，且

病情急剧加重，出现高热，小腿剧烈疼痛、肿胀，但当时未注意有无气体，而给予四环素 1 克加入 10% 葡萄糖 1000 毫升中静脉滴入，仍未见好转。第 3 天下午出现休克，血压 8.3/6 千帕，并发现左下肢皮下大量积气，即快速静脉滴入右旋糖酐及其他药物，血压稍回升，后转院。入院体检：体温 39℃，脉搏每分钟 144 次，呼吸每分钟 40 次，血压 9.45/6.75 千帕，神清，急性痛苦面容，坐卧不安，大汗淋漓，瞳孔等圆，对光反射灵敏。左下肢自腹股沟韧带及臀线以下均明显肿胀，膝以上均可触及捻发音，膝以下坚硬如石，触痛剧烈，皮温较另侧明显低，捻发音不明显，踝部可见 3 处血性疮，周边暗紫色，足背动脉摸不到，足前端暗紫色，厥冷，知觉明显减退。血象：白细胞 24400/mm³，中性 96%；尿呈粉红色，蛋白阳性。诊断为气性坏疽。即输入等渗盐溶液，右旋糖酐，5% 碳酸氢钠，全血等积极抗体克。小腿切开减压，切开皮肤有大量气体溢出，恶臭，切开深筋膜见肌肉呈砖红色，腐烂液化，且有恶臭气体溢出。鉴于小腿前外侧肌群均严重破坏，且切开减压后，足背动脉摸不着，足端循环未见改善，遂行大腿中段开放性截肢。术中发现气性坏疽已侵及股后侧肌群，与之一并切开，残端创面以双氧水湿敷。截肢后给予青霉素每日 1000 万单位，氢化可的松 300 毫克及足量液体，全身情况逐渐改善，残肢皮下积气逐日减少，创面肉芽新鲜。于第 14 日作二期缝合，伤口大部愈合，残留少许肉芽创面，继续换药，住院 46 天基本痊愈而出院^[42]。

【案例 5】

某男性患儿，1 岁半。因腹泻日久不愈，用氯霉素 1 毫升（内含 0.125 克），作双侧足三里穴位注射，次日发现其左小腿肿胀，治疗 10 余天后好转。出院后数日，左下肢不能站立，拒按，哭闹不安，继面左足趾变黑，足背肿胀。检查：左小腿肌肉萎缩，周径比右侧小 2.5 厘米，左足 1、3、5 趾已呈干性坏死，2、4 趾端发黑，足背趾红肿胀，左足背与胫后动脉搏动消失，腘动脉搏动亦明显减弱。右下肢脉搏正常。入院第 3 天合并麻疹，全身情况较差，此时患肢 5 个足趾全部干性坏死，足背、足跖红肿紫暗，皮肤亦部分发黑。治疗用“707”注射液与通塞脉 1 号片及抗生素，

约半个月左右，在左下肢的足背、跖前 1/3 处出现分界线，于是切除坏死部分，保留足弓功能，又续用上药 3 个月，痊愈出院^[43]。

【案例 6】

男性患儿，4 岁。于 1972 年 4 月 25 日，因呕吐、发热、解粘液脓血大便，伴里急后重，每日 20 余次而来诊。大便常规：红细胞（卅），白细胞（卅），粘液（卅）。诊断为细菌性痢疾。用 12.5% 氯霉素 0.5 毫升行右足三里封闭，次日发现右下肢疼痛，封闭穴处红、肿，压痛明显，自右踝关节以下肢端苍白，足背动脉搏动未能触及。1 周后于踝关节以下 5 厘米处，肢端呈干性坏死，遂行坏死肢端切除手术，1 个月后伤口愈合^[44]。

【讨论】

穴位注射不慎最终导致下肢肢端坏死，这种情况临床上所见虽然不多，但因给病人带来终身痛苦（绝大多数病人需要作截肢手术），在施术时必须给予高度重视。究其产生的原因，最常见的有下面 3 种：一是穴位原因，由于穴区内有较大的血管通过或周围分布较丰富的血管，或刺激位于多肌腱、韧带等致密组织附近的腧穴，妨碍了药物吸收，刺激着血管壁，引起血管内膜炎症，形成血栓，管腔变闭塞，最后导致肢端坏死；二是药物原因，由于选择的药物刺激性过大，可反射性地引起局部供血障碍，或注射量偏大，或反复在一个穴位注射，亦可刺激血管壁，形成全血管炎并形成血栓，导致肢端坏死；三是操作原因，主要是施术时未按常规，引起血管痉挛，产生非感染性的血管全层性炎症，管腔内血栓形成并逐步机化，最后血管闭塞，肢体坏死。本节案例 1、2、5、6 共 4 个病例，都是在氯霉素注射剂（油剂，临床一般用于静脉滴注，稀释后浓度很低）未加稀释的情况下直接注射，浓度过高，由于药物的刺激作用，局部可能形成炎症，引起局部血管痉挛，或压迫血管使血管闭塞，继而出现血流缓滞等血液动力学及血液流变学的改变，形成动脉血行障碍，局部缺血，而导致肢体坏死。案例 3、4 主要是由于针具及穴位皮肤等消毒不严，气性坏疽病原菌以针为媒介进入机体，在病人抵抗力低下的情况下生长、繁殖，迅速出现坏疽症状的一种严重的急性特异性感染，从

而给病人造成极大的危害。

【临床表现】

初期在注射部位（气性坏疽多发生在下肢和臀部等肌肉丰厚处）可出现肿胀、疼痛，该穴区皮肤呈紫红、潮红或苍黄色，皮肤表面干燥，局部压痛明显，肢端苍白、发凉、麻木。患肢动脉搏动减弱以至消失，夜间往往因持续性剧痛而不能入睡。随着血液循环障碍的愈来愈重，上述症状逐步加重，穴位注射处的皮肤、肌肉大片坏死，轻压针孔周围皮肤有“捻发”音，并出现水肿、发亮等，患趾发黑、干瘪、坏疽。病人极度虚弱，面色苍白，出冷汗，高热，脉细速。实验室检查，红细胞计数可迅速降至100万～200万。X线片检查，肌群内有积气影。

【处理方法】

1. 药物治疗：早期应用大剂量青霉素或四环素，青霉素总量每日为1000万单位，四环素静脉滴注每日总量2～4克。并应用扩张血管、促进侧支循环的药物，如妥拉苏林、烟酸、25%硫酸镁，以及右旋糖酐（初期病情急性发展时不宜使用）。尚可应用多价气性坏疽抗毒血清，用量为预防剂量的3～5倍，肌肉或静脉注射。并注意支持疗法，适当配合补液、输血，多给予高蛋白、高热量、高维生素饮食，以加强病人抵抗力。

2. 中药治疗：治以凉血解毒、清热利湿之法，拟方为，紫花地丁、生甘草各30克，赤芍15克，丹皮、黄芩、生山栀、黄柏、防己、川牛膝各9克，黄连4.5克，草薢、生苡仁各12克，鲜生地30克。若口渴者加生石膏30克（打），竹叶4.5克；若便秘者，加川军9克（后下），枳实6克。如果合并走黄时，宜凉血开窍、清热利湿，上方去生苡仁、黄芩，加安宫牛黄丸2粒分2次化服，或紫雪丹3克分2次吞服。此外，尚可配合当归注射液、复方丹参注射液等注射。

3. 辅助治疗：嘱患者平卧，抬高患肢到45°角，并维持1～2分钟，然后令患肢下垂2～5分钟，同时向上、下、内、外等方向运动10分钟，再将患肢放平休息2分钟。每回宜重复上述动作5次以上，每日数回。

1. 局部处理：对于性坏疽者，应细心保护患处，并使之干燥，待坏疽边界清楚时，可在无菌条件下截除患趾，或作清创术。如果坏疽严重，继发感染不断扩大而无法控制时，则必须马上行高位截肢术，以抢救生命。

【操作要点】

为了尽量避免因穴位注射不慎而导致患者肢端坏死的意外发生，术者在操作时一定要充分注意以下几点：①要合理使用药物，避免选用刺激性强烈的药物（如清热镇静药、油剂等）或高浓度的药物（如氯霉素、氯丙嗪等）作穴位注射，如果必须使用时，则要通过稀释等法，使药物的浓度适中、酸碱度接近人体内酸碱度，同时减少注射剂量，这样方可提高其安全度；②应严格掌握操作规程，除了取穴、针刺正确外，还要尽量减少将药液误注于血管内的可能性，即每次注射前都要回抽一下，在无回血的情况下方可将药物缓慢推入。同时，术者还要注意针感情况，当针尖触及动、静脉血管壁，病人往往会有疼痛感，此时须将针体上提少许，稍变换方向再刺入；③要注意穴位的选择，尽量少取那些局部有较大血管通过或周围分布较丰富血管的腧穴，或位于多肌腱、韧带等致密组织附近的腧穴，而且千万不能在同一穴位上反复注射刺激性过大的药物，如氯霉素、氯丙嗪等，尤其是对小儿患者更应慎重；④治疗期间应认真观察病人的情况，注射部位一旦出现红肿等现象，则要做进一步的检查，不可马虎从事当作一般感染处理，以免贻误病情。

二十九、足三里穴施术不当致腓神经损伤

【案例 1】

某男性患儿，1岁。因不规则发热3个多月而入院，诊断为急性血行性播散性肺结核。曾用抗结核药、中药、针灸等中西医结合治疗，疗效尚佳。但于9月某日在右下肢行针刺足三里穴后，第3日发现患儿右足下垂，踝关节肿胀，经有关科室会诊，用热敷、

针灸、按摩、维生素 B 等综合治疗，症状逐渐好转^[11]。

【案例 2】

李×，14 岁。主诉高烧 6 天于晚间急诊入院。体温 39.2℃，诊断为肺部感染（后经胸部 X 线检查证实）。予氨基比林 1 支（2 毫升）肌肉注射，半小时后体温仍不退，即在患儿右侧足三里穴位注射冬非合剂半量（即氯丙嗪 25 毫克加异丙嗪 25 毫克），10 分钟后患儿安静入睡，体温降至 36.2℃。但第 2 天，病区医生发现患儿行走时步态不稳，右足下垂并轻度内翻。检查：右足和趾不能背屈（伸趾肌和胫骨前肌瘫痪），趾屈良好，小腿前部外侧面及足背的温、触、痛觉减弱。诊断为穴位注射引起右腓深神经损伤。采取针灸、穴位按摩和注射三磷酸腺苷、辅酶 A 等综合疗法治疗 2 个月，腓深神经损伤基本恢复，行走正常^[45]。

【案例 3】

邱×，男性，1.5 岁。入院前 4 天，因腹泻、发热多天，由某卫生所合霉素 250 毫克（12.5% 溶液），等分在双侧足三里穴位注射，每日 1 次，注射深度约 1~2 厘米。注射 2 天后，腹泻减少，每日 2~3 次，但见患儿两下肢活动不灵活，行路呈跛行，易跌倒，并有垂足现象。拟诊为脊髓灰质炎而转来本院。该患儿足月顺产，智力及体力发育均良好，既往未患过任何传染病，近来也无脊髓灰质炎或其他传染病接触史。体格检查：发育良好，神志清楚，体温正常，全身浅表淋巴结不肿大，五官正常，心肺正常。皮肤无皮疹或出血点。两侧足三里穴处各有注射针孔 2 个，双足关节运动欠灵活，并有垂足及踇趾不能背曲现象，以左侧为重，局部皮肤无感觉过敏或减退现象，但双下肢肌张力无明显减退，髋、膝关节运动正常。实验室检查：红细胞 413 万，血红蛋白 11.8 克%，白细胞计数为 16000，中性白细胞 36%，淋巴细胞 63%，嗜酸性白细胞 1%。腰穿：脑脊液正常。感应电检查：两侧股四头肌及腓骨肌、短肌正常，胫前肌有轻度变性反应。综合以上病史及检查，拟诊为合霉素穴位注射引起的双侧腓深神经损伤性瘫痪。治疗：口服维生素 B₁ 10 毫克、维生素 C 50 毫克，每日 3 次；维生素 B₁₂ 500 毫微克肌肉注射，隔日 1 次；结合直流电和感应电治疗。经 3 周

后，两足下垂消失。1个月后，右脚趾背屈运动恢复。1个半月后，左侧脚趾也逐渐恢复了背屈运动。感应电检查：两侧胫前肌肌点兴奋性恢复正常^[46]。

【案例4】

某一胆道蛔虫症患者，因腹部疼痛难忍，护士用盐酸氯丙嗪50毫克分别注入双侧足三里穴，病人很快入睡。但12天后，病人发现右下肢小腿外侧疼痛，足内翻，踝关节行动不便，外三趾皮肤感觉障碍。诊断为腓总神经部分损伤，系注射盐酸氯丙嗪所致，曾采用各种方法治疗，但功能未能恢复^[47]。

【案例5】

据报道，曾收治2例腓总神经损伤者。1例因急性肠炎，经当地医生用黄连素针1毫升（含黄连素10克）注射于双侧足三里及天枢穴，2次后即发觉病人下肢跛行，左轻右重，伴右足下垂，小腿外侧及足1、2趾感觉消失，小腿前外侧肌肉萎缩。在上级医院确诊为腓总神经麻痹，经对症治疗1个月后，左下肢跛行消失，右下肢肌肉萎缩、跛行未减轻，加用针灸、按摩及中药连续治疗半年余，但右下肢跛行依旧，遗留终身残疾。1例因左膝关节疼痛，用维生素B₁₂2毫升注射于患侧足三里等穴，第3次穴位注射时，病人觉穴位局部剧痛，并放散至足背，随即出现跛行，中止穴位注射后，改用维生素B₁100毫克加维生素B₁₂500毫微克肌肉注射，配合局部热敷，内服活血化瘀中药，经3月余跛行消失^[24]。

【案例6】

杨×，女性，3.5岁。因右足下垂、行走跛行9天，于1973年8月19日来诊。患儿8月2日晚，因高热、烦躁、抽搐、面色发绀而急诊入某院，经治疗后体温逐渐下降。次日出现腹泻，便色黄，外观无脓血，入院第3天腹泻加重，每日10余次，呈淡红色粘液稀便，体温36.5℃，大便检查见红细胞（卅）、脓细胞（卅）、粘液（卅）。经西药治疗，收效不显。后某天值班医生用6号注射针头，在患儿双侧足三里穴位注射氯霉素各0.5毫升，并请中医科会诊加服中药，当晚患儿大便次数减少，但次晨发现患儿右下肢站立不稳，走路时跌倒，经治疗观察1周症状仍未见改

善，即转诊求治。经当地多间医院检查，排除脊髓灰质炎、脑膜炎等疾病，确诊为“右腓深神经损伤”。治疗经过：以针灸为主，局部和循经取穴相配合，用浅刺补法，不留针；加用氢溴酸加兰他敏、维生素 B₁、维生素 B₁₂ 小剂量穴位注射。治疗 2 个多月，患儿右足跗及足趾活动基本自如，行走基本恢复正常，但右胫前肌、腓肠肌肌张力减弱，右小腿肌群轻度萎缩。先后针灸治疗半年多。1 年后随访，患儿右下肢活动功能完全恢复^[14]。

【讨论】

腓总神经为坐骨神经的分支，从腘窝的外侧缘下行，沿股二头肌腱深部向外下行至腓骨颈，在腓骨颈的前面分为腓深神经和腓浅神经。腓深神经伴随胫前动脉穿行腓骨长肌和趾长屈肌到小腿前肌群深面，下行到足背，支配小腿前肌群和足背肌肉，虽然其循行部位较深，但因其体表投影区有不少针灸临床常用的穴位，所以临床上腓深神经损伤是最多见的。根据解剖发现，胃经的足三里、上巨虚、下巨虚、条口、解溪，胆经的阳陵泉，经外奇穴的阑尾穴等，均紧靠或正处于腓深神经干上，如果穴位注射操作不当（所注药物刺激性过大，致使神经发生一系列理化反应，或注射时药液过分接近或压迫腓深神经等），或针刺后在腓深神经干上作过频、过强的手法，都可损伤该神经。又因上述诸穴中，以足三里穴在临床上应用范围最广，使用频率远较其他穴位为高，所以足三里穴施术不慎引起腓深神经损伤也就最为多见。以上几个案例均说明了这一点。

【临床表现】

损伤侧出现下肢乏力，活动不灵活，足和足趾不能背屈和外翻，提足扬趾，形成足下垂，行走时足不能举起，呈跨阈步态，久则可见有关肌肉萎缩。在小腿的前外侧和足背部分有感觉障碍。

【处理方法】

1. 针灸疗法：以循经取穴为主，配以局部取穴，常用穴位有上巨虚、阳陵泉、丰隆、承山、悬钟、解溪、委中、血海等，每次选用 2~4 穴，用毫针刺法或电针法，予中、弱刺激，每次 15~20 分钟，每天 1 次，10 次为 1 个疗程。

2. 理疗：中波透热，每日或隔日 1 次，10~15 次为 1 疗程；或短波，每日 1 次，10~15 次为 1 疗程；或微波，每日 1 次，5~10 次为 1 疗程。以上各法可任选一种，每次治疗 10~20 分钟。此外，还可选用 1%~2% 普鲁卡因离子透入，每日 1 次，10~20 次为 1 个疗程。

3. 中药：用党参 15 克，红花、当归、赤芍、白芍各 10 克，川芎 8 克，桂枝 3 克（以上均为成人量，小儿酌减），水煎服，每日 1 剂。中成药可用舒筋活血片口服，每次 3 片，每日 3 次。

4. 西药：可配合口服维生素 B₁、B₆、B₁₂，辅酶 A 及三磷酸腺苷等，以营养损伤的神经，促进其尽快恢复。

5. 治疗期间可作局部的热敷、按摩，并注意配合功能锻炼，以助早日康复。若经过半年以上治疗无效，或局部有硬结、条索形成，则可考虑手术治疗。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：由腓肠外侧皮神经支配（该皮神经由腓总神经自腘窝处分出），到该穴皮肤的神经纤维来自第 5 腰神经。

2. 皮下组织：内有上述皮神经的分支。

3. 胫骨前肌：位于小腿前外侧皮下，紧贴胫骨的外面，由腓深神经支配，到该肌的神经纤维来自第 4、5 腰神经和第 1 骶神经。此肌外侧有胫前动、静脉。

4. 小腿骨间膜：为一坚韧的纤维膜，连结胫腓两骨的骨间嵴之间，膜的前面由腓深神经的分支支配，膜的后面由胫神经的分支支配。

5. 胫骨后肌：位于骨间膜后面，趾长屈肌和踇长屈肌之间，由胫神经支配，到该肌的神经纤维来自第 5 腰神经和第 1 骶神经。

6. 胫后神经和胫后动、静脉。

【操作要点】

为预防损伤腓总（深）神经，施术时要注意几点：首先，应做好术前准备。术者要熟悉腓总神经的分布部位，以及足三里穴的局部层次解剖；根据病情合理选用治疗方法，使用毫针法时所用毫针多以 28 号为主，穴位注射法时所用针头以 4 或 5 号齿科针

头为多；其次，要小心操作，切勿为了获得较好的得气感而在神经干上反复提插探寻，或者进针过深，当病人出现穴区疼痛、发热及上通下达之触电感时，应即将针上提少许，待此类现象消失后，再行手法或注入药物；最后，本病多因穴位注射不慎引起，所以为了减轻药物的理化性刺激，应尽量避免使用药物浓度过高或过低、刺激性过大、酸碱度过高的药物（如氯丙嗪、普鲁卡因、醋酸可的松等），宜选择浓度适中、刺激性较小、酸碱度接近中性范围的药物。若必须选择前者，可适当减少剂量，或使药液浓度与组织渗透压相接近（一般而言，药液浓度过高时用注射用水稀释，过低时适当用生理盐水增加浓度）；同时，避免将药物注入神经干而引起直接损害。

三十、委中穴放血导致晕针

【案例】

汪××，35岁，男性，猎人。因打猎时追赶野猪跌跤，背部着地，右侧腰部碰在石头上，外表稍有擦伤，肌肉疼痛。患者自认为是瘀血所致，坚决要求术者给予刺血疗法治疗。在其同侧委中的下方有浅表浮络，怒张充血，故嘱取站立位，用细三棱针刺之，令其出血约1毫升。病人并未见血，诉说心里难受，不能支持，随即就地平卧，面色苍白，汗出肢冷，问话不答，脉细缓，每分钟59次，心音弱，示意要吐，但未吐出。经指压百会穴7分钟后，逐渐恢复，15分钟后坐起，再休息15分钟，稍有头晕感，但行动自如^[2]。

【讨论】

晕针是针灸临床上最常见的意外事故之一，虽然目前对晕针的发生机理尚无统一解释，但绝大多数人都同意这一观点，即它应属于血管抑制性晕厥。本节案例病人为初诊，情绪不稳定，当用三棱针刺血治病时，由于站立位的地心引力对血流静力压的影响，使流注于下肢的血量增多，影响了静脉回流和右心的充填，使心输出量和动脉压降低，脑的血流量减少，从而易于发生晕厥

(晕针)现象。

【临床表现】

晕针大多发生在针灸施术过程中，典型的晕针一般可分为以下3期：①先兆期。病人有各种感觉的错乱，如眼花，耳鸣，头昏，心悸，出冷汗，打呵欠，全身不适等，有时可伴见面色苍白、恶心欲呕等；②发作期。轻者头晕胸闷，恶心呕吐，肢体发软发凉，摇晃不稳，或伴瞬间意识丧失；重者突然昏迷仆地，唇甲青紫，大汗淋漓，面色灰白，双眼上翻，二便失禁，少数病人可伴有惊厥发作；③恢复期。轻症仅有轻度不适，多数病人可有疲倦，头昏，嗜睡，汗出及全身不适感，短则几分钟，长则几小时，症状才能逐渐消除。

【处理方法】

1. 常规护理：马上停止治疗，将病人扶至空气流通处，并让其仰卧在床上（头低脚高位）；及时松解病人的衣带，热天注意通风，冷天注意保暖；立刻测量他的呼吸、心率、脉搏、血压，了解生命体征情况。

2. 轻者一般静卧片刻即可，如患者仍感不适，可给予温糖水或热茶口服，并注意使之安静和休息，约3~5分钟后即可逐渐恢复。

3. 重者可在上述处理的基础上，用指掐或针刺人中、素髻、足三里、涌泉，或艾灸百会、关元、气海等；必要时可用肾上腺素1毫升、阿托品1毫克肌注，25%葡萄糖40毫升静注等。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：由股后皮神经分布，到该穴皮肤的神经纤维来自第2骶神经。

2. 皮下组织：内有小隐静脉和股后皮神经的分布。

3. 腓肠肌内、外侧头：该肌两头均有胫神经支配（针体通过该肌两头之间），到该肌的神经纤维来自第1、2骶神经。

4. 腓肠内侧皮神经（起始端）：它刚由胫神经分支，伴小隐静脉下行到小腿后面。

5. 胫神经：它是坐骨神经的两终支之一，由第4、5腰神经和第1、2、3骶神经的纤维组成。该神经干正当穴位。

6. 腘动、静脉：腘动脉位于腘静脉的深面，是股动脉经大收肌腱裂孔后的直接延续。腘静脉比腘动脉浅，经大收肌腱裂孔后直接延续为股静脉。

【操作要点】

为了防止晕针，应注意下面几点：①要做好病人心理的预防工作，充分予以解释疏导；②注意消除各种容易导致晕针的诱因；③选取腧穴时要慎重，某些针感较强的穴位应小心使用。此外，操作毫针泻法、耳针法、透刺法、点刺放血法时要提高警惕；④尽量减少环境和气候对病人的不利影响。以上各点的详细内容请参见前述。

三十一、膝部穴位施术不当致晕针

【案例 1】

某男性患者，75 岁。因双膝部酸痛、上下楼梯困难 1 年余，于 1983 年 4 月 9 日就诊。检查全身健康，心肺无特殊，血压 120/70 毫米汞柱（16.0/9.3 千帕），双膝关节活动尚可。嘱患者取坐位，用毫针快速刺入双侧犊鼻穴，施提插手法，予中等量刺激并留针。约至 5 分钟时，患者诉说心里难受，头晕恶心，面色苍白，出冷汗，脉搏稍弱，65 次/分，血压 105/60 毫米汞柱（14.0/8.0 千帕）。即时令其平卧，未作处理，10 分钟后好转，30 分钟后恢复正常。第 2、3 次复诊时取卧位，不再晕针。2 周后复诊，膝痛显著减轻^[2]。

【案例 2】

某患者因慢性风湿性关节炎（膝），当地医生用当归注射液 4 毫升（浓度不详），用 6 号注射针头刺入双侧膝眼穴约 3 厘米深，注射完毕后患者即感局部剧烈疼痛，大汗淋漓，双膝关节不能屈伸，脉搏细弱，血压下降至 80/40 毫米汞柱（10.7/5.3 千帕），呈休克状，经用杜冷丁等急救，疼痛稍缓解，血压升至 100/70 毫米汞柱（13.3/9.3 千帕），2 小时后局部疼痛又加剧且伴休克状。反复发作约 10 小时，疼痛有所缓解，双膝关节仍不能屈伸。经 3 周

卧床休息，局部热敷，以及口服活血祛瘀之中药 20 剂，疼痛消失，双膝关节功能恢复^[24]。

【案例 3】

石××，女性，21 岁，职工。于 1988 年 6 月 20 日上午来诊。自诉右侧膝关节疼痛 3 天，前来本科要求给予 TDP 灯照射治疗，随即给予右膝关节照射（患者取坐位），约 15 分钟后自诉头痛、头晕、恶心欲吐，检查见额上冷汗、四肢软冷，脉搏 65 次/分，呼吸 16 次/分，血压 12/7.5 千帕。立即停止照射，让患者平卧，休息 30 分钟后，即自行恢复正常^[48]。

【案例 4】

蔡×，男性，72 岁。于 1984 年 3 月 21 日来诊。自诉双膝关节肿痛而要求针灸治疗，坐于无靠背椅子进行扎针，当施术过程中，突发现病人唇白，说话声音变细，似睡，即停止治疗，但还来不及把针拔完（尚余下 1 针），患者已经倒下，出现小便失禁、脉细等一系列晕针现象。立刻使患者平卧，头位稍低，并将余针拔出，进行手法按摩后恢复^[49]。

【讨论】

晕针多由于患者的体质虚弱，或精神紧张，或体位不当，或术者的施术手法过重过强，或选取某些特殊腧穴等，而导致发生。以上诸案例，亦是因术者未能根据病人具体情况，临床施术不当，导致晕针意外。

【临床表现】

晕针大多发生在针灸过程中，但也有少数病者在施术完毕后数分钟始出现症状。典型的晕针表现请参见前文所述。

【处理方法】

1. 常规护理：迅速拔出所有的针具，将患者扶至空气流通处，让其仰卧在床上，头低脚高位；及时松解患者的衣带，热天注意通风，冷天注意保暖；立刻为病者测量呼吸、血压、脉搏、心率，了解其生命体征情况。

2. 轻者一般静卧片刻即可，如病人仍感不适，可给予温糖水或热茶口服，并注意使之安静和休息，约 3~5 分钟后即可逐渐恢

复。

3. 重者可在上述处理的基础上,用指掐或针刺人中、素髻、足三里、涌泉,或艾灸百会、关元、气海等穴;必要时可用肾上腺素 1 毫升、阿托品 1 毫克肌注,25%葡萄糖 40 毫升静脉推注。

【操作要点】

为防止晕针,临床施术时应注意以下几点:①做好心理预防工作;②注意消除各种容易引发晕针的诱因;③选用腧穴时应慎重并谨慎从事,使用刺激性较强的针法,如三棱针点刺、芒针透刺、耳针法、穴位注射时宜多加小心;④尽量消除环境和气候对病人的不利影响。

三十二、阳陵泉穴位注射不慎损伤腓总神经

【案例 1】

蔡××,男性,29岁,干部。因左侧腰腿疼痛、行走不利2周,在门诊进行药物穴位注射疗法。检查:左直腿抬高40°,加强试验阳性,左梨状肌紧张试验阳性,左侧环跳、阳陵泉等处均有压痛,右侧下肢正常。腰椎X片示“腰椎未见明显异常”。用当归注射液4毫升加天麻注射液4毫升混合,分别注射于左侧阳陵泉、阿是穴、环跳等。经过一段时间治疗,左腰腿痛明显减轻。但在某次的复诊中,仍用上述药物,以局麻针头刺入左侧阳陵泉穴约1寸多,并于较多次提插,患者亦多次自诉有触电感向小腿部位放射,术者却未予重视,没有退针即注入药物,出针后病人自觉左小腿疼痛加重,伴左小腿麻木,左足背屈乏力,行走困难。拟诊为“腓总神经损伤”。给予左侧阳陵泉穴悬灸,每次15分钟,每日2次,1周后局部疼痛及麻木消失^[50]。

【案例 2】

王××,女性,6岁。于1989年6月25日就诊。患儿1个月前曾在当地卫生院施行阳陵泉穴位注射氯霉素(药量不详),后即感注射处局部疼痛,随之足不能行走,治疗无效。经省××医院

诊断为药物所致腓总神经损伤。初诊时，患儿右足下垂、内翻，足背屈困难，跛行。检查：右下肢肌肉松弛发凉，肌肉萎缩明显（腘上5厘米和腘下5厘米测量，患肢比健肢细1.5厘米），小腿外侧及足背感觉障碍。即选取足三里、阳陵泉、环跳、绝骨、解溪、委中等穴，每次2~4穴，针刺后加用低频脉冲治疗仪，用疏密波，电流强度以能引起瘫痪肌肉出现明显收缩为标准，每次10~15分钟，每天1次，10次为1个疗程，休息5天再重复治疗，经8个疗程而痊愈。5年后随访，患肢与健肢无差异。

【讨论】

腓总神经为坐骨神经的分支，从腘窝的外侧缘下行，沿股二头肌腱深部向外下行至腓骨颈，在腓骨颈的前面分为腓深神经和腓浅神经。腓深神经伴随胫前动脉穿行腓骨长肌和趾长屈肌到小腿前肌群深面，下行到足背，支配小腿前肌群和足背肌肉。其循行部位虽然较深，但体表投影区内有不少针灸常用的穴位（如胃经的足三里、上巨虚、下巨虚、条口、解溪，胆经的上巨虚，经外奇穴的阑尾穴等），所以临床上以腓深神经损伤较为多见。皮支仅布于跗趾和第2趾背面的相对缘。当施行穴位注射时，如果所注药物的刺激性过大，或注射时药物过分接近或压迫腓深神经，则会使神经发生一系列理化反应，导致神经损伤。阳陵泉穴位于腓总神经体表最浅处，上述两个案例正是由于穴位注射时，针尖反复刺激神经以及不适当的药物刺激，导致腓总神经的损伤。

【临床表现】

损伤侧出现下肢乏力，活动不灵活，足和足趾不能背屈和外翻，提足扬趾，形成足下垂，行走时足不能举起，呈跨阈步态，久则可见有关肌肉萎缩。在小腿的前外侧和足背部分有感觉障碍。

【处理方法】

1. 针灸疗法：以循经取穴为主，配以局部取穴，常用穴位有足三里、上巨虚、丰隆、承山、悬钟、解溪、血海、环跳等，每次选取2~4穴，用毫针刺法或电针法，给予中、弱刺激，每次15~20分钟，每天1次，10次为1个疗程。

2. 理疗：中波透热，每日或隔日1次，10~15次为1疗程；

或短波，每日1次，10~15次为1疗程；或微波，每日1次，5~10次为1疗程。以上各法可任选一种，每次治疗10~20分钟。此外，还可选用1%~2%普鲁卡因离子透入，每日1次，10~20次为1个疗程。

3. 中药：用党参15克，红花、当归、赤芍、白芍各10克，川芎8克，桂枝3克（以上均为成人量，小儿酌减），水煎服，每日1剂。中成药可用舒筋活血片口服，每次3片，每日3次。

4. 西药：可配合口服维生素B₁、B₆、B₁₂，辅酶A及三磷酸腺苷等，以营养受损伤的神经，促进其尽快恢复。

5. 治疗期间可作局部的热敷、按摩，并注意配合功能锻炼，以助早日康复。若经过半年上述治疗仍无效，或局部有硬结、条索形成者，则应考虑手术治疗。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：由腓肠外侧皮神经分布，到该穴皮肤的神经纤维来自第5腰神经。

2. 皮下组织：内有上述皮神经和浅静脉。

3. 腓骨长肌：由腓浅神经分布，到该肌的神经来自第4腰神经至第1骶神经。

4. 趾长伸肌：位于腓骨长肌的内侧，由腓深神经支配，到该肌的神经纤维来自第4腰神经至第1骶神经。

5. 胫腓关节：若直刺时碰到的硬性阻力即胫腓关节。

【操作要点】

为预防损伤腓总神经的事故发主，施术时要注意几点：首先，应做好术前准备工作。术者要熟悉腓总神经的解剖部位，以及阳陵泉穴的局部层次解剖；根据病情确定所选用的治疗方法，使用针具时应以细小者为佳，如毫针多用28号者，穴位注射的针头多以4或5号齿科针头为主；其次，要小心操作，切勿为了获得较好的得气感而在神经干上反复提插探寻，或者进针深度过大。当病人出现穴区疼痛、发热及上通下达之触电感时，应即刻将针上提少许，待此类现象消失后，再行手法注入药物；最后，本病多因穴位注射不慎引起，故为了减轻药物的理化性刺激，应尽量避

免使用药物浓度过高或过低、刺激性太大、酸碱度过高的药物（如氯丙嗪、氯霉素、普鲁卡因等），选择浓度适中、刺激性较小、酸碱性接近中性范围的药物。若必须选择前者药物，可适当减少剂量，或使药液浓度与组织渗透压相接近（一般而言，药液浓度过高时用注射用水稀释，过低时适当用生理盐水增加浓度）。同时，要注意分清刺中神经干或分支与激发出循经感传现象之间的区别，勿将神经传导误认为针感，结果将药物注入了神经干，造成对神经的直接损害。

三十三、阳陵泉穴折针

【案例】

赵××，男性，48岁，工人。因患腰腿痛4、5年，加重半个月，于1972年6月就诊。自诉左腿疼痛，且从腰胯部沿大腿外后侧向下放射，灼痛难忍，活动受限。检查脊椎无侧弯，左直腿抬高试验30°（阳性），坐骨神经激惹征（+），左踝反射弱。诊断为左坐骨神经痛。取穴环跳、绝骨、阳陵泉，按处方要求，施术者应先针环跳、后针阳陵泉，但术者却先针阳陵泉、后针环跳。由于环跳穴针感较强，入针时下肢突然抽动，肌肉强烈收缩，致使阳陵泉穴上的针由根部锈蚀处折断，残端未露出皮外。立即请外科会诊，手术后仍未能将之取出。X线透视，残端针已游走于小腿胫腓骨之间。即收住院治疗观察。住院后病人走动时无明显疼痛感，半个月后一次走路时，针尖由小腿后部意外地被顶出皮外，随之拔出获愈^[47]。

【讨论】

折针是指针刺过程中发生针身折断的现象。究其产生的原因，较常见的有以下几个方面：一是针具原因，即针体质量过于粗劣，或针具使用过久或次数过频，有屈折、斑痕等，或放置过久，针具因氧化生锈面发硬变脆；二是医者原因，如操作不熟练，动作粗暴，或针刺过程中手法过重，捻转角度过大，频率过快等，均易使肌肉剧烈收缩而可能断针；三是患者原因，由于其精神紧张、

恐惧，或针刺时不能耐受强烈的酸胀感，或留针过程中体位突然大幅度变动等，均可导致肌肉痉挛而断针。此外，随着现代各种治疗方法的不断出现，断针的情况愈来愈复杂，如电针疗法中，针体可因电解电蚀而折断；穴位注射时，因术者操作不当，注射针头断入穴内；头针疗法，因针体进入头皮内较长，加之捻转频率过快，亦可发生断针等。本节案例显因术者未按处方要求，先在阳陵泉穴处针刺并留针，待针刺环跳穴时，由于手法过重，导致病人下肢肌肉的强烈收缩，从而发生针体的折断。

【临床表现】

非重要脏器或关节部位断针：一般多不产生严重后果，其共同的特征是，断针局部有压痛，可逐渐减轻，有时断针处有重压感，活动时偶可出现疼痛，但往往无运动障碍。

关节内断针：都会呈现出严重的运动障碍和疼痛。如肋间关节断针，多可出现呼吸困难，胸痛；脊柱关节断针，长时间活动后有剧烈疼痛及运动障碍。

脏器内断针：此类情况往往比较严重，常因脏器和断针部位的不同，而引起程度不等的功能障碍和疼痛。

【处理方法】

当断针情况发生时，病人不可惊慌乱动，术者更不能紧张失措，应让病人尽可能保持原体位，以免针体向深层陷入，给处理造成困难。

如果断针残端尚在体外，则可用手指或镊子夹住取出；若残端与皮肤表面相平，肉眼可见而又不能用指甲镊出时，可用手指将断针两旁的皮肤向下按压，使残端充分露出针外，然后用镊子取出。如果针体折断在重要脏器附近，或虽非重要脏器而病人自觉不适伴有功能障碍者，应请外科会诊，以X线透视或正侧位摄片准确定位，然后用手术取出。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：由腓肠外侧皮神经分布，到该穴皮肤的神经纤维来自第5腰神经。

2. 皮下组织：内有上述皮神经和浅静脉。

3. 腓骨长肌：由腓浅神经支配，到该肌的神经来自第4腰神经至第1骶神经。

4. 趾长伸肌：位于腓骨长肌的内侧，由腓深神经支配，到该肌的神经纤维来自第4腰神经至第1骶神经。

5. 胫腓关节。

【操作要点】

为了预防断针事故的发生，术者在操作时要注意：①仔细检查和选择针具，不使用弯曲、生锈或有其他损伤的针具，针具使用时间过久者即使外表完整也要定期更换；应用电针时尽量不用直流电针仪，且宜经常更新其毫针。其次，术中操作要小心谨慎，进针时最好用双手进针法，将针徐徐送入；当病人咳嗽或变动体位时，应停止进针或将针向上拔；在刺入或拔针过程中，遇到阻力时，不要强行操作，可改变方向刺入或稍待片刻再拔针；针刺到所需的深度后，无论行针或留针，都不能将针体全部插入穴内，至少应留5毫米左右于皮肤外面；遇到滞针、弯针等情况，应细心缓慢地拔出，切忌使用暴力；③医者和患者应密切配合，凡遇精神紧张或不乐意接受针灸治疗者，应先予心理上的安慰，争取合作；针刺之前，最好充分揉按穴区，以解除局部痉挛；凡欲留针，必须告诉病人不得随便移动体位，医生也应随时观察，小儿患者则须令家长配合固定体位。

三十四、深刺涌泉穴引起中风患者死亡

【案例】

某一女性患者，47岁。其丈夫代诉：患者有高血压史数年，4日前突然中风，出现肢体偏瘫，口眼歪斜。证见面色潮红，舌质红而少津，头眩头痛，舌强，语言不清，四肢抽搐，脉弦细长，血压24.0/16.0千帕（180/120毫米汞柱）。此为阴虚肝旺，水不涵木，风中于经。治拟滋阴潜阳、平肝熄风、活络化痰。方以天麻钩藤汤配九转还魂丹、苏合香丸、生姜汁冲汤并服。连服3天，诸症悉减，神志渐清，语言略出，建议转送脑内科作进一步诊治，并

再三叮嘱其家属，切勿施针刺疗法。转诊后第2天上班时，病人家属来门诊，诉说昨晚某朋友来看望病人，并自告奋勇给予针刺帮助康复，穴取涌泉等，结果当捻针涌泉穴时，病人心跳突然停止，抢救无效而死亡^[51]。

【讨论】

根据临床实验得知，针灸对人体的血压具有双向调节作用，原血压水平高者针灸后可降低，原血压水平低者针灸后可使之升高，这种效应与病者本身的状况有着密切的关系。对于脑血管意外的病人，针灸的升压效应会更加明显，如果施术的时机、手法不当时，极易再次引起中风。本病例经服用中药后病情已有转机，但尚未稳定，施术者未能根据病情，选取涌泉等人体最为敏感的穴位，而且给予深刺的强烈手法，使病人血压急剧升高（实验已证明涌泉穴有明显的加压效应），在原有脑血管病变尚未修复的情况下，导致再次形成中风而死亡。

【临床表现】

多出现在针刺过程中或针后不久。一般典型症候为：起病突然，常有头痛、呕吐、昏迷、大小便失禁、呃逆等，可伴有发热、肢体瘫痪。体征：血压骤然升高，瞳孔不等大，对光反射、角膜反射减弱或消失，颈硬，舌肌瘫痪，肌张力降低，偏身或交叉性感觉障碍，腹壁反射、提睾反射减弱或消失，腱反射先消失后亢进，同时出现病理征，视网膜出血，视乳头水肿。

【处理方法】

1. 保持安静，尽量减少对病人不必要的搬运。躁动者可予以适当镇静剂；血压过高者，可肌注利血平1毫克，使血压维持在20.0~21.3/12.0~13.3千帕之间；持续低流量吸氧。

2. 降低颅内压。可选用20%甘露醇或25%山梨醇250毫升快速静滴；速尿20~40毫克溶于50%葡萄糖液20~40毫升中静脉推注；10%甘油葡萄糖250~500毫升静滴。上述脱水剂和利尿剂可交替使用，每6~8小时使用1次为宜。

3. 降温疗法：一般以冰块或冰帽作头部局部降温为主，这样可降低脑代谢率和耗氧量，有利于减轻脑水肿及促进脑细胞功能

的恢复。

4. 防治并发症：注意保持病人呼吸道的通畅，防治胃出血、褥疮、尿道感染和循环功能紊乱等并发症。

5. 维持营养及水、电解质和酸碱平衡：昏迷病人可先禁食1~2天，从静脉内补充营养和水分，每日总量1500~2000毫升为宜；以后如无呕吐或消化道出血，可酌情开始鼻饲，并随时注意补充电解质、维生素、脑细胞功能活化剂，及时纠正酸碱平衡失调等。

6. 中医治疗：若闭证可鼻饲至宝丹或苏合香丸，脱证可用参附龙牡汤或独参汤。针灸治疗，闭证可取人中、内关、太冲、曲池、十二井穴等，脱证取关元、神阙、足三里、气海等穴；耳针疗法，可选取耳尖、心、肝、肾、皮质下、相应肢体；水针疗法，穴位选取与体针相同，药物常用当归注射液、复方丹参注射液、田七注射液、维生素B族注射液，胞二磷胆碱针等。

7. 手术治疗：本法目的在于清除血肿，降低颅内压，缓解脑疝，改善脑血液循环。因此，当出现手术适应证时，应尽早施行手术，但对高龄、生命体征不稳定、出血部位在丘脑及脑干、脑疝晚期、血压过高未经控制、高热、严重消化道出血或内脏疾病、血压下降过速或休克者，均不宜进行手术治疗。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：由足底内、外侧神经的皮支分布，此两神经均是胫神经所属的分支，到该穴皮肤的神经纤维来自第1骶神经。该部皮肤较厚。

2. 皮下组织：内有上述神经的分支，并有众多的纤维束，外连皮肤，内连足底腱膜。

3. 足底腱膜：是足底筋膜的浅层，发达而坚韧，由足底内、外侧神经支配。

4. 第2趾足底总神经和第2趾底动、静脉。

5. 第2蚓状肌：由足底外侧神经支配。

【操作要点】

为了预防中风病人针刺后出现再中风的意外事故，术者在操

作时要注意两个方面：一，谨慎选择病人，对血压过高且不稳定的有动脉硬化的病人，特别是有中风史者，一般暂勿针刺，待血压平稳后，再施行针灸疗法；二，要小心操作，对于中风病人，一般选择穴位宜少而精（尽量少用那些人体较敏感的穴位，如涌泉、人中、井穴等），避免进针疼痛（对初次接受针灸或情绪易于波动，有畏惧心理者，针前应多作解释，以解除其思想负担），施术时手法不可过重过强烈（以轻、弱刺激为宜），留针时间宜短些。此外，在针刺过程中，应严密观察病人，若有异常情况则马上给予及时处理。

三十五、经期针刺三阴交穴引起阴道大出血

【案例】

张××，女性，28岁，小学教师，已婚。患者两腿乏力、走路费劲已2年余，曾用针灸治疗，一度好转。后经某医院诊断为脊柱结核。现在走路时仍下肢沉重拖地，有时胃部不适。检查除右下肢运动不便外，余皆正常。行针灸治疗1个疗程，症状缓解，停针2周后复诊，自述以往经来，两腿必痛，腰酸，但最近不痛。服用雷米封后，胃部不适，也不思饮食，同时睡眠不好，下肢沉重，遂刺双侧足三里及绝骨穴，至16日复诊，谓睡眠依然不好，头脑昏沉。当日为月经来第3天，未尽，但量比以前少，当即刺激三阴交穴，进针8分，麻胀感传至足踝关节，行针15分钟左右，患者突然感到下腹部抽痛，特别在两侧输卵管附近更为明显，在其不能再坚持的情况下取针。出针后病人表现异常痛苦，情绪也非常紧张，并冷汗频出，手指发凉，匍匐在床上，自觉下腹板硬并鼓起，抽痛如绞，拒绝检查，遂入厕，见有大量血液由阴道流出，色暗红，并伴有紫色血块。出血后疼痛逐渐缓解、消失，20分钟后已能行走，腰部恢复常态，腹部已完全不痛。4天后复诊，自诉回家后情况良好，再无特殊情况^[52]。

【讨论】

根据临床实践证明，针刺人体某些穴位，可以引起子宫收缩，

从而加重经期腹痛和出血。据报道（浙江医科大学中医研究所针麻研究组等，科技简报医药卫生部分，1973；（6）：1），用手捻针刺法或电针法刺激三阴交穴，留针15~20分钟，使用71型宫缩描记仪，作针刺前后20分钟间的连续宫缩记录并计算宫缩M值。结果认为，针刺后一般经过20分钟左右的潜伏期，宫缩开始增加；宫缩M值曲线高峰，大多在起针后10分钟左右，在起针后10~20分钟内出现V波上升支（它有较长的潜伏期，并能持续一个相当时间）。以上特点说明三阴交穴有较强的促进子宫蠕动的功用，重刺该穴后，使经血排出量明显增加并引起腹部抽痛便是可能的，这个案例正是最好的证明。

【临床表现】

在针刺过程中，病人正常的月经，突然出现大量血液由阴道流出，色暗红或鲜红，其一次失血量可达200~300毫升，伴有较大血块，腹痛明显。流血量多者可伴有轻重不等的贫血症状，如头晕眼花，口渴烦躁，汗出心悸，而色苍白，呼吸困难，血压降低甚至休克。

【处理方法】

1. 一般治疗：解除病人顾虑，避免精神紧张，并注意休息，保证充分的睡眠；增加营养，尽快止血，纠正贫血等。出血严重者住院治疗。

2. 药物治疗：可用性激素止血法，如雌激素（乙蔗酚2~5毫克肌注，4小时1次，血止后改用口服）、孕激素（黄体酮20毫克肌注，1次/日，连续5天）、雄激素（如丙酸睾丸酮25~50毫克肌注，1次/日，3天后改每周2次，后逐渐停药）。

3. 刮宫术：用于流血多且服药治疗无效者。

4. 中医治疗：可根据病情辨证配方，并加用旱莲草、仙鹤草、侧柏叶、大小蓟、血余炭、地榆炭、阿胶、三七粉等止血药。针灸，取断红穴，灸2壮，效佳；亦可灸神阙、隐白等。

【穴位层次解剖】

1. 皮肤：由小腿内侧皮神经分布，到该穴皮肤的神经纤维来自第4腰神经。

2. 皮下组织：内有小腿内侧皮神经和大隐静脉。

3. 趾长屈肌：由胫神经支配，到该肌的神经纤维来自第5腰神经和第1骶神经。

4. 胫骨后肌：其神经支配同趾长屈肌。

5. 踇长屈肌：此肌位于胫骨后肌的后外侧，其神经支配同上两肌。

【操作要点】

为了预防经期针刺引起阴道大出血的事故，术者应注意下面几个问题：一是除了调经等特殊要求外，在妇女的月经期间，一般最好不予针刺，以免扰乱病人的正常月经；二是如果要施行针灸法，则应尽量避免选用下腹部（如关元、中极等）、腰骶部（如肾俞、大肠俞、次髎等）以及能引起子宫收缩的腧穴（如三阴交、合谷、昆仑、至阴等）；三是要严密观察，若出现阴道大出血时应马上给予处理，不得贻误。

参 考 文 献

- [1] 王振龙·中国针灸 总78：22
- [2] 高忻洙，等·针灸意外及其防治 湖南科学技术出版社，1993年7月（第1版）
- [3] 龙炜·广西赤脚医生 1978；（10）：19
- [4] 彭玉格·江西中医药 1982；（3）：49
- [5] 董藿，等·陕西中医 1993；（2）：77
- [6] 田晓伟·甘肃中医学院学报 1993；（12）：30
- [7] 陈秀兰·中华理疗杂志 1981；（3）：27
- [8] 卫庆兰·辽宁中级医刊 1978；（6）：28
- [9] 刘岚庆，等·推拿意外的预防及处理 上海科学技术出版社，1991年8月（第1版）
- [10] 王灵召·上海医学 1978；（10）：19
- [11] 成志芳，等·江苏中医 1963；（10）：27
- [12] 管遵惠·江苏中医 1966；（1）：20
- [13] 王黎·上海针灸杂志 1991；（2）：45
- [14] 管遵惠·福建中医药 1991；（3）：42

- [15] 王树藩. 新医学 1980; (11) : 527
- [16] 申倬彬. 针灸实验录 陕西科技出版社, 1983年5月(第1版)
- [17] 刘水渠, 等. 新医学 1973; (11) : 557
- [18] 张文亮. 危重晕针3例报道(内部资料)
- [19] 上官存民. 陕西新医药 1979; (8) : 60
- [20] 杨宇璇, 等. 新医学 1980; (6) : 301
- [21] 邓德芳, 等. 中华护理学会全国经验学术会议论文资料汇编 1987年
- [22] 胡谱绵. 中华儿科杂志 1980; (4) : 225
- [23] 欧良树, 等. 安徽中医学院学报 1989; (3) : 40
- [24] 舒敬宗, 等. 中医杂志 1990; (12) : 618
- [25] 邵建彬. 天津医药 1977; (12) : 613
- [26] 王振龙. 中国针灸 总78 : 22
- [27] 高淦纹. 北京中医 1988; (5) : 54
- [28] 史国屏, 等. 针灸临床杂志 1994; (5) : 38
- [29] 辜祖谦. 上海针灸杂志 1982; (2) : 30
- [30] 杨炳荣, 等. 中国乡村医生杂志 1990; (2) : 31
- [31] 糜军. 黑龙江中医药 1993; (6) : 31
- [32] 练汉文. 中华理疗杂志 1979; (2) : 112
- [33] 张仁. 石医资料 1978; (2) : 81
- [34] 秦亮甫, 等. 上海中医药杂志 1986; (12) : 22
- [35] 陈俊鸿. 福建省针灸学术论文选编, 1964年
- [36] 哈孝贤. 天津医药 1976; (11) : 封底
- [37] 沈维素. 安徽省针灸学会交流资料, 1981年
- [38] 栾聪. 江西中医药 1989; (6) : 52
- [39] 周海燕, 等. 新疆中医药 1992; (2) : 26
- [40] 江西省乐平县人民医院外科. 天津医药 1978; (5) : 23
- [41] 肖素兰. 广西赤脚医生 1978; (10) : 19
- [42] 王志成. 江苏中医 1981; (4) : 43
- [43] 谢志雄. 中国农村医学 1983; (3) : 45
- [44] 黄邦显, 等. 新医学 1983; (8) : 112
- [45] 袁家明. 辽宁医药 1977; (6) : 23
- [46] 张中一. 解放军医学杂志 1965; (2) : 185
- [47] 王秀英. 山东中医杂志 1983; (6) : 20
- [48] 陈敬, 等. 上海针灸杂志 1991; (2) : 15

- [49] 朱秋娇·福建中医药 1992; (6) : 31
- [50] 夏晨·针灸临床杂志 1993; (2、3) : 75
- [51] 王文荣·广西赤脚医生 1978; (3) : 24
- [52] 杨楣良·上海中医药杂志 1958; (9) : 18

附录 常用腧穴简易定位法

一、手太阴肺经常用穴

中 府 (LU1)

【标准定位】 在胸前壁的外上方，云门穴下1寸，平第1肋间隙，距前正中线6寸。

【简易定位法】 男性或未婚女性的乳头外侧旁开2横指，往上直推3条肋骨处即是该穴。

【刺灸法】

刺法：针尖向外斜刺0.5~1.0寸，局部有酸胀感，可向前胸及上肢放散。注意针尖不宜向内深刺，以免误入胸腔，刺伤肺脏。

灸法：艾炷灸3~7壮，艾条温灸10~20分钟。若强身保健则温灸至局部有温热感。

云 门 (LU2)

【标准定位】 在胸前壁的外上方，肩胛骨喙突上方，锁骨下窝凹陷处，距前正中线6寸。

【简易定位法】 病人两手叉腰直立，其胸廓上部锁骨外侧端下缘的三角形凹窝正中处即是该穴。

【刺灸法】

刺法：针尖向外斜刺或横刺0.5~1寸，局部有酸胀感，可向前胸及腋下放散。针刺时不可向内深刺，以防刺伤肺脏。

灸法：艾炷灸3~5壮，艾条悬灸5~10分钟左右。

尺 泽 (LU5)

【标准定位】 在肘横纹中，肱二头肌腱桡侧凹陷处。

【简易定位法】 病人手掌朝上方微屈其肘部，触及肘弯里肱二头肌腱的桡侧，与肘横纹的交点即是。

【刺灸法】

刺法：①直刺 0.5～1 寸，局部有酸胀感，或有麻电感向前臂放散；②用粗毫针或三棱针点刺浅表静脉放血 3～5 滴。

灸法：艾炷灸 5～7 壮，艾条灸或温针灸 10～20 分钟。注意本穴慎用灸法。

孔 最 (LU6)

【标准定位】 在前臂掌面桡侧，当尺泽与太渊连线上，腕横纹上 7 寸。

【简易定位法】 在尺泽穴与太渊穴的连线上，肘横纹下 5 寸处即是该穴。

【刺灸法】

刺法：直刺 0.5～1 寸，局部有酸胀沉重感，可向前臂扩散。

灸法：艾炷灸 3～7 壮，艾条悬灸或温针灸 10～20 分钟。

列 缺 (LU7)

【标准定位】 在前臂桡侧缘，桡骨茎突上方，腕横纹上 1.5 寸，当肱桡肌与拇长展肌腱之间。

【简易定位法】 病人两手张开，虎口垂直交叉，其一侧食指压在另一侧的腕后桡侧高突处，当食指尖所指处，赤白肉际处即是。

【刺灸法】

刺法：针尖向上斜刺 0.3～0.5 寸，局部有酸胀沉重感，可向肘部放射。若用于治疗手腕部疾病时可向下斜刺 0.5～0.8 寸。

灸法：艾炷灸 3～5 壮，艾条悬灸 10～15 分钟，或采用药物天灸。

太 渊 (LU9)

【标准定位】 在腕掌侧横纹桡侧，桡动脉搏动处。

【简易定位法】 病人掌心向上将手置于台面，在手掌后桡侧可触及一小圆骨，其外侧下缘当掌后第1横纹有动脉搏动处即是。

【刺灸法】

刺法：针尖避开桡动脉，直刺0.3~0.5寸，局部有酸胀感。

灸法：艾炷灸3~5壮（因靠近桡动脉，故一般不宜用疤痕灸），或艾条悬灸10~20分钟。

鱼 际 (LU10)

【标准定位】 在手指本节（第1掌指关节）后凹陷处，约当第1掌骨中点桡侧，赤白肉际处。

【简易定位法】 病人立掌屈肘，手掌桡侧掌指关节后第1掌骨中央，赤白肉际处即是。

【刺灸法】

刺法：①直刺0.5~1寸，局部可有酸麻胀痛感；②用三棱针点刺出血，或用挑治法。

灸法：艾炷灸5~7壮（因该穴位暴露，且手常处于活动状态，故一般不宜施疤痕灸），或艾条悬灸5~10分钟。

少 商 (LU11)

【标准定位】 在手指末节桡侧，距指甲角0.1寸。

【简易定位法】 病人伏掌在台面上，沿其拇指指甲底部所引平行线与桡侧缘所引垂线的交点处即是。

【刺灸法】

刺法：①用毫针浅刺0.1~0.2寸，局部有胀痛感；②用粗毫针或三棱针点刺挤压出血。

灸法：米粒大艾灸1~3壮，或艾条悬灸5~10分钟。

二、手阳明大肠经常用穴

商 阳 (LI1)

【标准定位】 在手食指末节桡侧，距指甲角 0.1 寸。

【简易定位法】 病人伏掌在台面上，沿其食指指甲底部所引平行线与桡侧缘所引垂线的交点处即是。

【刺灸法】

刺法：①用毫针浅刺 0.1~0.2 寸，局部有胀痛感；②用粗毫针或三棱针点刺挤压出血。

灸法：米粒大艾灸 1~3 壮，或艾条悬灸 5~10 分钟。

合 谷 (LI4)

【标准定位】 在手背，第 1、2 掌骨间，当第 2 掌骨桡侧的中心处。

【简易定位法】 病人拇、食指张开，使虎口拉紧，另一手的拇指关节横纹压在虎口上，拇指关节向前弯曲压在对侧的拇食指蹼上，拇指尖所指处即是。

【刺灸法】

刺法：①直刺 0.5~1 寸，局部有酸胀感；②垂直深刺 2~3 寸，透向劳宫或后溪时，可出现手掌酸麻并向指端放散；③针尖向腕部斜刺 1~1.5 寸，局部酸胀并可向上扩散，有时可到肘、肩、面部。操作时针尖不宜偏向腕侧，以免刺破手背静脉网和掌深动脉弓而引起出血，或提插幅度不宜过大，以免伤及血管引起血肿。本穴孕妇禁针。

灸法：艾炷灸 5~9 壮，或艾条悬灸和温针灸 10~20 分钟，或药物灸。本穴一般不施疤痕灸，以防因疤痕而影响活动和美观。

阳 溪 (LI5)

【标准定位】 在腕背横纹桡侧，手拇指向上翘起时，当拇短伸肌腱与拇长伸肌腱之间的凹陷中。

【简易定位法】 病人拇指向上伸展时，其腕横纹前则可显露出两条筋（即拇长伸肌腱和拇短伸肌腱），此两筋与腕骨、桡骨茎突所形成的凹陷正中即是。

【刺灸法】

刺法：直刺 0.5～0.8 寸，局部可有酸胀感。

灸法：艾炷灸 3～5 壮（因本穴处于关节、肌腱附近，故不宜施疤痕灸），或艾条悬灸 10～20 分钟。

偏 历 (LI6)

【标准定位】 屈肘，在前臂背面桡侧，当阳溪与曲池连线上，腕横纹上 3 寸。

【简易定位法】 病人张开双手，两虎口垂直交叉，当中指端所指处有一凹陷处即是。

【刺灸法】

刺法：直刺 0.3～0.5 寸，局部可有酸胀感。

灸法：艾炷灸 3～5 壮，艾条悬灸或温针灸 10～15 分钟。

温 溜 (LI7)

【标准定位】 屈肘，在前臂背面桡侧，当阳溪与曲池连线上，腕横纹上 5 寸。

【简易定位法】 在阳溪穴与曲池穴的连线上，其中点向手腕部下移 1 横指处即是。

【刺灸法】

刺法：直刺 0.5～0.8 寸，局部有酸胀感。

灸法：艾炷灸 3～5 壮，艾条悬灸或温针灸 5～10 分钟。

手 三 里 (LI10)

【标准定位】 在前臂背面桡侧，当阳溪与曲池连线上，肘横纹下 2 寸。

【简易定位法】 病人仰掌屈肘成 45°角，肘横纹桡侧末端直往前 2 横指处即是。

【刺灸法】

刺法：直刺 1~1.5 寸，局部有酸胀沉重感，可扩散至手背侧部。

灸法：艾炷灸 5~7 壮，艾条悬灸或温针灸 5~10 分钟。

曲 池 (LI11)

【标准定位】 在肘横纹外侧端，屈肘，当尺泽与肱骨外上髁连线中点。

【简易定位法】 病人横肱仰掌，屈肘成 45°角，其肘关节桡侧的肘横纹头即是。

【刺灸法】

刺法：①直刺 1~1.5 寸，深刺时可透少海穴，局部有酸麻重胀感，并可扩散至肩部或手指；②可用三棱针点刺挤压出血。

灸法：艾炷灸 5~9 壮，艾条悬灸或温针灸 10~20 分钟。若强身保健则可温灸至皮肤红晕为度，每日 1 次。

臂 臑 (LI14)

【标准定位】 在上臂外侧，三角肌止点处，当曲池与肩髃连线上，曲池上 7 寸。

【简易定位法】 病人屈肘并紧握拳，上肢用力令其紧张，肩部三角肌下端的偏内侧处即是。

【刺灸法】

刺法：①直刺 0.5~1 寸，也可在进针后，沿肱骨前后缘透刺 1~1.5 寸；②针尖向上斜刺 1~2 寸，透入三角肌中，局部有酸胀感，并可传至肩部。

灸法：艾炷灸 5~7 壮，艾条悬灸或温针灸 10~20 分钟。

肩 髃 (LI15)

【标准定位】 在肩部，三角肌上，臂外展，或向前平伸时，当肩峰前下方凹陷处。

【简易定位法】 病人上臂外展至水平位时，在肩部高骨（锁

骨肩峰端)外,肩关节上出现两个凹陷,前面的凹陷即是。

【刺灸法】

刺法:①针尖与皮肤垂直进针,直刺0.5~0.8寸,局部有酸胀感,并可扩散至肩部;②针尖与穴位下外的皮肤呈50°角向内稍偏下斜刺1.5~2寸,或与穴位上内的皮肤呈50°角向下斜刺1.5~2寸,或向前内下及后下进行透刺。

灸法:艾炷灸5~7壮,艾条悬灸或温针灸10~20分钟。本穴不宜疤痕灸,以防日后因疤痕面影响肩关节的活动。

迎 香 (LI20)

【标准定位】 在鼻翼外缘中点旁,当鼻唇沟中。

【简易定位法】 病人取仰卧位或仰靠位,鼻唇沟平鼻翼外缘中点处即是。

【刺灸法】

刺法:①针尖向内上方平刺0.5~1寸,透向鼻通穴,局部有酸胀感并可扩散至鼻部;②针尖向外上平刺1~1.5寸,透向四白穴,用治胆道蛔虫症,局部有酸痛感,有时流泪。

灸法:艾条悬灸5~10分钟,本穴不宜施直接疤痕灸,因它处于面部三角区。

三、足阳明胃经常用穴

承 泣 (ST1)

【标准定位】 在面部,瞳孔直下,当眼球与眶下缘之间。

【简易定位法】 病人目正视,瞳孔直下,下眼睑缘与眶下缘之间即是。

【刺灸法】

刺法:①嘱病人闭眼并眼球朝上,术者左手推之固定,右手持针沿眶下缘缓缓刺入,宜浅刺0.3~0.5寸,若深刺时针尖应略朝内后上方(即朝眶尖方向,而不可紧贴眶下壁刺入,否则易伤

及眶下动、静脉)，深约1~1.5寸，局部有酸胀感，并可致流泪；
②针尖刺入眼睑皮下后，平刺0.5~0.8寸，透向内眦角处。本穴施术时一般不宜提插、捻转，同时要避免深刺，以防刺入颅腔；出针后要压迫局部片刻，以防出血。

灸法：本穴禁用灸法。

四 白 (ST2)

【标准定位】 在面部，瞳孔直下，当眶下孔凹陷处。

【简易定位法】 病人以其拇指横放于眼睛下方，拇指掌指关节横纹垂直正对瞳孔，横纹上端在眼眶骨下缘中点，横纹下端即是。

【刺灸法】

刺法：直刺0.2~0.3寸，或向外上方斜刺0.5~0.8寸，局部有酸胀感，可有麻电感放射至上唇部。本穴因正对眶下孔，故不可深刺，以防针尖刺入眼眶内而损伤眼球。

灸法：本穴极少用灸法。

地 仓 (ST4)

【标准定位】 在面部，口角外侧，上直瞳孔。

【简易定位法】 病人正坐平视，其瞳孔直下垂线与口角水平线相交点即是。

【刺灸法】

刺法：针尖平刺1.5~2寸，透向颊车穴或迎香穴，局部或半侧面部有酸胀麻痛感，有时会出现口角牵掣感。

灸法：艾条悬灸5~10分钟，本穴禁用艾炷灸。

大 迎 (ST5)

【标准定位】 在下颌角前方，咬肌附着部的前缘，当面动脉搏动处。

【简易定位法】 病人闭口鼓腮，在其下颏骨骨侧边缘，面颊部可见一凹沟，其中间凹陷，用手按之有动脉搏动处即是。

【刺灸法】

刺法：直刺 0.3~0.5 寸，局部有酸胀感。本穴针刺时须避开前方的面动、静脉。

灸法：艾条悬灸 5~10 分钟，本穴禁用艾炷灸。若美容则可悬灸至皮肤微见红晕为度，每日 1 次。

颊 车 (ST6)

【标准定位】 在面颊部，下颌角前上方约 1 横指，当咀嚼时咬肌隆起，按之凹陷处。

【简易定位法】 病人以其中指第 1 指指关节宽度，由下颌角前上方量 1 横指处即是。

【刺灸法】

刺法：直刺 0.5~0.8 寸，或针尖透地仓平刺 1~2 寸，或针尖向上齿或下齿方向刺，局部有酸胀感，并向周围扩散。

灸法：艾炷灸 3~5 壮，艾条悬灸或温针灸 10~20 分钟。本穴禁用疤痕灸。

下 关 (ST7)

【标准定位】 在面部耳前方，当颧弓与下颌切迹所形成的凹陷中。

【简易定位法】 病人闭口，以其食指第 1 指指关节宽度，由耳屏向前 1 横指处即是。

【刺灸法】

刺法：①略向下直刺 1~1.5 寸（治疗三叉神经痛多用），周围有酸胀或麻电感，并放射至下颌部；②向后斜刺 1~1.5 寸（治疗耳病多用），局部有酸胀感，可扩散至耳区；③沿下颌骨外向上、下齿平刺 1.5~2 寸（治疗牙痛多用），有酸胀感扩散至上、下齿；④向前斜刺 0.5~1 寸（治疗下颌关节病变多用），局部有酸胀感，并扩散至整个颞下颌关节；⑤向下斜刺 1.5~2 寸（治疗咬肌痉挛多用），局部有酸胀感。

灸法：艾炷灸 5~7 壮（本穴不宜施疤痕灸），艾条悬灸或温

针灸 10~20 分钟。若美容除皱则可温灸至皮肤温热舒适为度，每日 1 次。

头 维 (ST8)

【标准定位】 在头侧部，当额角发际上 0.5 寸，头正中线旁 4.5 寸。

【简易定位法】 病人耳前鬓角前缘向上直线与前发际交点上 0.5 寸（约半横指）处即是。

【刺灸法】

刺法：向后平刺 0.5~1 寸，局部有胀痛感，可向周围扩散。

灸法：艾条悬灸 5~10 分钟，本穴不宜施直接灸。

人 迎 (ST9)

【标准定位】 在颈部，结喉旁，当胸锁乳突肌的前缘，颈总动脉搏动处。

【简易定位法】 摸病人颈部动脉搏动之内侧缘，平喉结处即是。

【刺灸法】

刺法：病人取仰卧位，术者用左手拇指将其颈总动脉轻轻推压至胸锁乳突肌，右手持针直刺或向内斜刺 0.5~1 寸，不宜过多提插、捻转（以免伤及血管或引起颈动脉窦反射亢进，导致不良后果），局部有酸胀感，可向肩部放散。

灸法：本穴一般不施灸法。

缺 盆 (ST12)

【标准定位】 在锁骨上窝中央，距前正中线 4 寸。

【简易定位法】 病人取正坐位或仰卧位，在锁骨上窝的中点处，约与乳头相对（男性）即是。

【刺灸法】

刺法：斜刺 0.3~0.5 寸，局部有酸胀感，并可向上臂放散。本穴不宜针刺过深，以免针尖刺伤肺尖而引起气胸。

灸法：艾炷灸 3~5 壮，艾条悬灸 10 分钟。

乳 根 (ST18)

【标准定位】 在胸部，当乳头直下，乳房根部，第 5 肋间隙，距前正中线 4 寸。

【简易定位法】 病人仰卧位，由其乳头（男性）直下 1 肋间隙处即是。

【刺灸法】

刺法：直刺 0.3~0.5 寸或斜刺 0.5~0.8 寸，局部有酸胀感，可扩散至乳房。本穴不宜深刺，以防引起气胸；左侧内有心脏，更严禁深刺。

灸法：艾炷灸 3~5 壮，艾条悬灸 10 分钟。

天 枢 (ST25)

【标准定位】 在腹中部，距脐中 2 寸。

【简易定位法】 病人仰卧位，从其脐中作一垂直于腹正中线的水平线，再由两乳头各作与前正中线平行的直线，两者（过乳头平行线与过脐水平线）之交点，再取本交点与脐中的连线中点即是。

【刺灸法】

刺法：直刺 1~1.5 寸，局部有酸胀感，并可扩散至同侧腹部。本穴切忌深刺，或猛力快速提插，以免刺伤腹腔脏器（小肠），尤其肠麻痹患者更须谨慎。

灸法：艾炷灸 5~9 壮，艾条悬灸或温针灸 10~20 分钟。若强身保健则温灸至皮肤有温热舒适感或皮肤稍见红晕为度，每日 1 次。

归 来 (ST29)

【标准定位】 在下腹部，当脐中下 4 寸，距前正中线 2 寸。

【简易定位法】 病人仰卧位，耻骨联合上缘上 1 横指，前正中线旁外 2 横指处即是。

【刺灸法】

刺法：直刺1~1.5寸，或向耻骨联合处平刺1~2寸，局部有酸胀感，并可扩散至小腹及外生殖器。本穴针刺时要掌握好角度、方向和深度，以防刺伤肠管。

灸法：艾炷灸5~9壮，艾条悬灸或温针灸10~20分钟。

髀 关 (ST31)

【标准定位】 在大腿前面，当髌前上棘与髌底外侧端的连线上，屈股时，平会阴，居缝匠肌外侧凹陷处。

【简易定位法】 病人仰卧伸直下肢，其髌前上棘与髌骨外侧缘的连线，相交于腹股沟处定为一点，由此点直下2横指处即是。

【刺灸法】

刺法：①直刺1.5~2寸（治股外侧皮神经炎多用），局部有酸胀感，并可向股外侧部扩散；②斜刺2~3寸（针尖向上时多用治髌关节痛，针尖向内时多用治下肢瘫痪），局部有酸胀感，并可向整个髌部扩散或向膝部放散。

灸法：艾炷灸5~7壮，艾条悬灸或温针灸10~20分钟。

伏 兔 (ST32)

【标准定位】 在大腿前面，当髌前上棘与髌底外侧端的连线上，髌底上6寸。

【简易定位法】 病人取正坐位，且屈膝成90°角，术者以手掌后第1横纹中点按在髌骨上缘中点，手指并拢押在大腿上，当中指尖端所到达处即是。

【刺灸法】

刺法：直刺2~3寸，局部有酸胀感，并可向膝部外侧扩散（若感应较差者，可旁开0.5寸取穴再针）。

灸法：艾炷灸5~7壮，艾条悬灸或温针灸10~20分钟。

梁 丘 (ST34)

【标准定位】 屈膝，在大腿前面，当髌前上棘与髌底外侧端

的连线上，髌底上 2 寸。

【简易定位法】 当病人下肢用力蹬直时，髌骨外上缘上方可见一凹陷（即股外直肌与股直肌之间的结合部）该凹陷正中即是。

【刺灸法】

刺法：直刺 1～1.5 寸，局部有酸胀感，并可扩散至膝关节。

灸法：艾炷灸 5～9 壮，艾条悬灸或温针灸 10～20 分钟。

犊 鼻 (ST35)

【标准定位】 屈膝，在膝部，髌骨与髌韧带外侧凹陷中。

【简易定位法】 屈膝，髌骨下缘，髌韧带（髌骨与胫骨之间大筋）两侧凹陷，外侧凹陷正中即是。

【刺灸法】

刺法：①从前外向后内或从前内向后外直刺，深约 1.5～2 寸，局部有发胀感，有时可向下扩散；②斜刺 2～2.5 寸，向内膝眼透刺，局部有酸胀感。

灸法：艾炷灸 5～9 壮，艾条悬灸或温针灸 10～20 分钟。本穴不宜行疤痕灸。

足 三 里 (ST36)

【标准定位】 在小腿前外侧，当犊鼻下 3 寸，距胫骨前缘 1 横指（中指）。

【简易定位法】 屈膝成 90°角，由外膝眼（犊鼻）往下 4 横指，小腿两骨（胫、腓骨）之间，距胫骨约 1 横指处即是。

【刺灸法】

刺法：直刺（稍偏向胫骨方向）1～2 寸，或向下斜刺 2～3 寸，酸麻胀感向足背放射，有时可向上扩散至膝部。

灸法：艾炷灸 9～15 壮，艾条悬灸或温针灸 15～20 分钟。若强身保健可采用化脓灸，每年 1 次，或累计灸，每月灸百余壮（累计），有时亦可采用药物天灸。

上 巨 虚 (ST37)

【标准定位】 在小腿前外侧，当犊鼻下 6 寸，距胫骨前缘 1 横指（中指）。

【简易定位法】 犊鼻穴向下直量两次 4 横指处，当胫、腓骨之间即是。

【刺灸法】

刺法：直刺 1~2 寸，局部有酸胀感，可扩散至足背或膝部。本穴深刺时须防止刺伤胫前动、静脉。

灸法：艾炷灸 5~9 壮，艾条悬灸或温针灸 10~20 分钟。

丰 隆 (ST40)

【标准定位】 在小腿前外侧，当外踝尖上 8 寸，条口外，距胫骨前缘 2 横指（中指）。

【简易定位法】 犊鼻穴与外踝前缘（平外踝尖处）连线的中点，距胫骨前缘约 2 横指处即是。

【刺灸法】

刺法：直刺 1~2 寸，局部有酸胀感，向上可扩散到大腿部，向下可扩散至足背部。

灸法：艾炷灸 5~7 壮，艾条悬灸或温针灸 10~20 分钟。

解 溪 (ST41)

【标准定位】 在足背与小腿交界处的横纹中央凹陷中，当踇长伸肌腱与趾长伸肌腱之间。

【简易定位法】 病人仰卧位，嘱其背屈足部，踝关节前横纹中两条大筋（踇长伸肌腱与趾长伸肌腱）之间的凹陷处，与第 2 足趾正对处即是。

【刺灸法】

刺法：①直刺 0.3~0.5 寸，刺入关节腔，局部有酸胀感；②斜刺 0.5~1 寸，透向丘墟穴或商丘穴，局部酸胀感，有时可扩散至整个踝部。

灸法：艾炷灸 3~5 壮，艾条悬灸或温针灸 5~10 分钟。本穴一般不行疤痕灸，否则日后可能影响关节的功能活动。

内 庭 (ST44)

【标准定位】 在足背，当第 2、3 趾间，趾蹼缘后方赤白肉际处。

【简易定位法】 病人足背，第 2、3 趾缝纹端正中后上 5 分（约半横指），在第 2、3 跖趾关节前凹陷中即是。

【刺灸法】

刺法：向上斜刺 0.3~0.5 寸，局部有酸胀感。

灸法：米粒灸 3~5 壮，艾条悬灸 5~10 分钟。本穴禁行疤痕灸。

厉 兑 (ST45)

【标准定位】 在足第 2 趾末节外侧，距趾甲角 0.1 寸（指寸）。

【简易定位法】 病人足部的第 2 趾，沿其趾甲底部所引平行线，与外侧缘所引垂线的交点处即是。

【刺灸法】

刺法：①毫针浅刺 0.1~0.2 寸，局部有胀痛感；②用三棱针点刺挤压出血。

灸法：米粒灸 1~3 壮，艾条悬灸 5 分钟。

四、足太阴脾经常用穴

隐 白 (SP1)

【标准定位】 在足大趾末节内侧，距趾甲角 0.1 寸（指寸）。

【简易定位法】 病人足大脚趾内侧，沿其趾甲底部所引平行线，与内侧缘所引垂线的交点处即是。

【刺灸法】

刺法：①毫针浅刺 0.1~0.2 寸，局部有胀痛感；②用三棱针点刺挤压出血。

灸法：米粒灸 1~3 壮，艾条悬灸 5 分钟。

公 孙 (SP4)

【标准定位】 在足内侧缘，当第 1 跖骨基底的前下方。

【简易定位法】 从病人足大脚趾内侧后一关节（第 1 跖趾关节）往后用手推有一弓形骨，弓形骨后端下缘的凹陷（第 1 跖骨基底内侧前下方）即是。

【刺灸法】

刺法：直刺 1~2 寸，向涌泉穴透刺，局部有酸胀感，可扩散至足底。

灸法：艾炷灸 3~5 壮，艾条悬灸 10 分钟。

三 阴 交 (SP6)

【标准定位】 在小腿内侧，当足内踝尖上 3 寸，胫骨内侧缘后方。

【简易定位法】 嘱病人手四指并拢，小指下边缘紧靠内踝尖上，食指上缘所在水平线在胫骨后缘的交点即是。

【刺灸法】

刺法：①直刺 1~1.5 寸，透向绝骨穴，局部有酸胀感；②向下斜刺 1.5~2 寸，局部酸胀，可有麻电感向足底放射，有时还会扩散向上至膝部。本穴孕妇禁针。

灸法：艾炷灸 5~9 壮，艾条悬灸或温针灸 10~20 分钟。若强身保健，可采用疤痕灸，每年 1 次，或累计灸百余壮（温灸至皮肤温热舒适稍见红晕），隔日 1 次。

阴 陵 泉 (SP9)

【标准定位】 在小腿内侧，当胫骨内侧髁后下方凹陷处。

【简易定位法】 病人取坐位，用拇指沿小腿内侧骨内缘（即

胫骨内侧)由下往上推,至拇指抵膝关节下时,胫骨向内上弯曲之凹陷即是。

【刺灸法】

刺法:沿胫骨后缘直刺1~2寸,局部有酸胀感,可沿小腿内侧向下扩散。

灸法:艾炷灸5~9壮,艾条悬灸或温针灸10~20分钟。

血 海 (SP10)

【标准定位】 屈膝,在大腿内侧,髌底内侧端上2寸,当股四头肌内侧头的隆起处。

【简易定位法】 病人取坐位,屈膝成90°角,医者立于病人对面,以左手掌心对准右髌骨中央,手掌伏于膝盖上,其拇指尖所指处即是。

【刺灸法】

刺法:直刺1~2寸,局部有酸胀感,可向髌部扩散。

灸法:艾炷灸5~7壮,艾条悬灸或温针灸10~20分钟。

大 横 (SP15)

【标准定位】 在腹中部,距脐中4寸。

【简易定位法】 病人取仰卧位,从其两乳头向下作前正中线的平行线,再由脐中央作一水平线,这三线的两个交点即是。

【刺灸法】

刺法:直刺1~1.5寸或向神阙穴透刺,局部有酸胀感,可扩散至同侧腹部。该穴施术时宜注意缓慢下针,以避免升、降结肠,切忌猛力和快速提插,免伤肠管。

灸法:艾炷灸5~7壮,艾条悬灸或温针灸10~20分钟。

大 包 (SP21)

【标准定位】 在侧胸部,腋中线上,当第6肋间隙处。

【简易定位法】 嘱病人举臂,从其乳头(男性)往下推2个肋间隙即为第6肋间隙,它与腋中线的相交处即是。

【刺灸法】

刺法：斜刺 0.5~1 寸，局部有酸胀感。本穴不可深刺，以防引起气胸。

灸法：艾炷灸 5~7 壮，艾条悬灸 10~20 分钟。

五、手少阴心经常用穴

极 泉 (HT1)

【标准定位】 在腋窝顶点，腋动脉搏动处。

【简易定位法】 病人上肢外展平伸，腋窝中央有动脉搏动，其内侧即是。

【刺灸法】

刺法：避开腋动脉，向肩髃方向直刺 0.5~1 寸，整个腋窝有酸胀感，有时麻电感可向前臂指端放散。本穴施术时不可大幅度提插，以免刺伤腋部血管，引起腋内大血肿。

灸法：艾条悬灸 5~10 分钟。本穴一般极少用灸法。

少 海 (HT3)

【标准定位】 屈肘，在肘横纹内侧端与肱骨内上髁连线的中心处。

【简易定位法】 病人仰掌并屈肘成直角，肘横纹头的尺侧（内侧）端即是。

【刺灸法】

刺法：直刺 1~1.5 寸，局部有酸麻重胀感，可有向指端放射的触电感。

灸法：艾炷灸 3~5 壮，艾条悬灸或温针灸 10~20 分钟。

阴 郄 (HT6)

【标准定位】 在前臂掌侧，当尺侧腕屈肌腱的桡侧缘，腕横纹上 0.5 寸。

【简易定位法】 病人仰掌屈肘，在手掌小鱼际上角有一突起圆骨，其后缘向上可摸到一条大筋（即尺侧腕屈肌），沿着此筋的外侧缘向上1横指作一标记，再取这一标记与腕横纹连线的中点即是。

【刺灸法】

刺法：直刺0.5~0.8寸，局部有酸胀感，有时可向下传导。本穴针刺时宜注意避开尺动、静脉。

灸法：艾炷灸3~5壮，艾条悬灸或温针灸10~20分钟。本穴不宜行疤痕灸。

少 府 (HT8)

【标准定位】 在手掌面，第4、5掌骨之间，握拳时，当小指尖处。

【简易定位法】 病人仰掌呈半握拳状，除拇指外，其余4指轻压手掌心，小指尖所指处即是。

【刺灸法】

刺法：直刺0.3~0.5寸，局部有胀痛感。

灸法：艾炷灸3~5壮，艾条悬灸或温针灸5~10分钟。本穴不宜行疤痕灸。

少 冲 (HT9)

【标准定位】 在手小指末节桡侧，距指甲角0.1寸（指寸）。

【简易定位法】 病人伏掌于台面上，沿其小指指甲底部所引平行线，与桡侧缘所引垂线的交点处即是。

【刺灸法】

刺法：①毫针浅刺0.1~0.2寸，局部有酸痛感；②用三棱针点刺挤压出血。

灸法：艾炷灸1~3壮，艾条悬灸5~10分钟。

六、手太阳小肠经常用穴

少 泽 (SI1)

【标准定位】 在手小指末节尺侧，距指甲角 0.1 寸（指寸）。

【简易定位法】 病人伏掌于台面上，沿其小指指甲底部所引平行线，与尺侧缘所引垂线的交点处即是。

【刺灸法】

刺法：①毫针浅刺 0.1～0.2 寸，局部有酸痛感；②用三棱针点刺挤压出血。

灸法：艾炷灸 1～3 壮，艾条悬灸 5～10 分钟。

后 溪 (SI3)

【标准定位】 在手掌尺侧，微握拳，当小指本节（第 5 掌指关节）后的远侧掌横纹赤白肉际。

【简易定位法】 病人仰掌握拳，其第 5 掌指关节后，有一皮肤皱襞突起，其尖端即是。

【刺灸法】

刺法：沿掌骨前缘直刺 0.5～1 寸，或向合谷穴透刺，局部有酸胀沉痛感，并可放散至整个手部。

灸法：艾炷灸 3～5 壮，艾条悬灸或温针灸 5～10 分钟。该穴不宜行疤痕灸。

腕 骨 (SI4)

【标准定位】 在手掌尺侧，当第 5 掌骨基底与钩骨之间的凹陷处，赤白肉际。

【简易定位法】 病人伏掌于台面上，在手背尺侧的豌豆骨凹陷中。

【刺灸法】

刺法：直刺 0.5～0.8 寸，局部有酸胀感，有时可扩散至掌

部。

灸法：艾炷灸 3~5 壮，艾条悬灸或温针灸 5~10 分钟。该穴不宜行疤痕灸。

养 老 (SI6)

【标准定位】 在前臂背面尺侧，当尺骨小头近端桡侧凹陷中。

【简易定位法】 病人掌心先向下伏于台面，另一手食指捺在尺骨小头最高点，然后掌心对胸，此手指随尺骨小头滑动而摸至骨边缘，所指处即是。

【刺灸法】

刺法：向上斜刺 0.5~0.8 寸，手腕部有酸麻胀感，并可向肩肘部扩散。

灸法：艾炷灸 3~7 壮，艾条悬灸 10~20 分钟。若强身保健，则温灸至局部皮肤稍见红晕为度，每日 1 次。

天 宗 (SI11)

【标准定位】 在肩胛部，当冈下窝中央凹陷处，与第 4 胸椎相平。

【简易定位法】 病人自然垂臂，由肩胛冈下缘中点至肩胛下角作连线，上 1/3 与下 2/3 交点处即是，用力按压有明显酸痛感。

【刺灸法】

刺法：直刺或向四周斜刺 0.5~1 寸，局部有酸胀感，并可扩散至整个肩胛部。

灸法：艾炷灸 5~7 壮，艾条悬灸或温针灸 10~20 分钟。

曲 垣 (SI13)

【标准定位】 在肩胛部，冈上窝内侧端，当臑俞与第 2 胸椎棘突连线的中点处。

【简易定位法】 肩胛骨冈上窝的内侧凹陷处即是。

【刺灸法】

刺法：直刺 0.3~0.5 寸，局部有酸胀感。本穴针刺一般比较安全，但针尖不能向脊柱方向偏斜，以免刺伤肺膜造成气胸。

灸法：艾炷灸 3~5 壮，艾条悬灸或温针灸 10~20 分钟。

肩 外 俞 (SI14)

【标准定位】 在背部，当第 1 胸椎棘突下，旁开 3 寸。

【简易定位法】 先取大椎穴（第 7 颈椎棘突下），由大椎穴往下推 1 个椎骨之棘突下即为第 1 胸椎棘突下，由此向双侧各旁开 4 横指处，当肩胛骨内侧缘处即是。

【刺灸法】

刺法：向外斜刺 0.5~0.8 寸，局部有酸胀感。本穴不可深刺，以防发生气胸。

灸法：艾炷灸 3~5 壮，艾条悬灸或温针灸 5~10 分钟。

肩 中 俞 (SI15)

【标准定位】 在背部，当第 7 颈椎棘突下，旁开 2 寸。

【简易定位法】 先取大椎穴，由大椎穴向双侧旁开 2 横指（约 2 寸）处即是。

【刺灸法】

刺法：向内斜刺 0.5~0.8 寸，局部有酸胀感。本穴不可深刺，以防导致气胸。

灸法：艾炷灸 3~5 壮，艾条悬灸或温针灸 10~20 分钟。

颧 髎 (SI18)

【标准定位】 在面部，当目外眦直下，颧骨下缘凹陷处。

【简易定位法】 病人正坐位或仰卧位，从其眼外角引一与前正中线平行的直线，再从鼻翼外缘端引一与前正中线垂直的直线，这两线的相交点即是。

【刺灸法】

刺法：直刺 0.5~1 寸，局部有酸胀感，可扩散至半侧颜面部。

灸法：艾炷灸 3~5 壮（本穴不宜行疤痕灸），艾条悬灸或温针灸 5~10 分钟。若美容除皱，则温灸至皮肤温热舒适为度，每日 1 次。

听 宫 (SI19)

【标准定位】 在面部，耳屏前，下颌骨髁状突的后方，张口时呈凹陷处。

【简易定位法】 病人侧卧位，与外耳道相平，间隔耳屏。取穴时，嘱其张口，耳屏前微下凹陷处，下颌髁状突后，该处即是。

【刺灸法】

刺法：针尖微向下直刺 0.5~1 寸，局部有酸胀感，可扩散至耳周部和半侧面部，有时有鼓膜向外鼓胀之感。本穴深刺时应注意避免刺伤颈内动、静脉。

灸法：艾条悬灸或温针灸 10~20 分钟，本穴不宜行直接行艾炷灸。

七、足太阳膀胱经常用穴

睛 明 (BL1)

【标准定位】 在面部，目内眦角稍上方凹陷处。

【简易定位法】 病人正坐闭眼，目内眦角内侧 1 分并向上 1 分处，即眼眶内缘与眼睑内侧之间即是。

【刺灸法】

刺法：嘱病人闭眼，术者以左手食指轻推其眼球向外侧固定，右手持针接近眶内侧壁（勿紧贴），略朝后外呈 85°角，缓慢刺入 0.5~1 寸，不宜提插或大幅度捻转。局部有酸胀感，并扩散至眼球及其周围。本穴针刺时要注意针下感觉，正常情况下，针尖透过眼睑后应始终有空松感；若遇到坚硬阻力，则为刺到眶壁，若遇到弹性阻力，则为刺到眼球壁和血管，均应立即退针，调整方向再继续进针。本穴不可深刺，以免刺入颅腔，损伤颅中窝的大脑

颞叶等重要结构。退针后还要用干棉球压迫针孔 2~3 分钟，以防出血。

灸法：本穴禁灸。

攒 竹 (BL2)

【标准定位】 在面部，当眉头陷中，眶上切迹处。

【简易定位法】 病人皱起眉头时，可见眉毛内侧端隆起处即是。

【刺灸法】

刺法：①直刺 0.2~0.3 寸，局部有胀感；②向下斜刺 0.5~0.8 寸，透向睛明穴（治眼病多用），局部及眼眶周围有酸胀感；③平刺 1~1.5 寸，透向鱼腰穴（治面瘫或头痛多用），局部有胀痛感，时有麻电感向前额放散；④用三棱针点刺挤压出血。

灸法：本穴禁灸。

天 柱 (BL10)

【标准定位】 在项部，大筋（斜方肌）外缘之后发际凹陷中，约当后发际正中旁开 1.3 寸。

【简易定位法】 病人低头或俯卧，由后发际正中直上 0.5 寸处是哑门穴，由此穴旁开约 2 横指，在项部大筋（斜方肌）的外缘处即是。

【刺灸法】

刺法：直刺 0.5~1 寸，局部有酸胀感，可扩散至后头部，有时可向前扩散至眼部。本穴针刺时不宜向内上方深刺，以免刺伤延髓。

灸法：艾条悬灸 5~10 分钟，本穴极少用灸法。

大 杼 (BL11)

【标准定位】 在背部，当第 1 胸椎棘突下，旁开 1.5 寸。

【简易定位法】 病人低头，可见颈背部交界处椎骨有一高突并能随颈部左右摆动而转动者即是第 7 颈椎，由此往下再推 1 个

椎骨的棘突下，旁开 2 横指处即是。

【刺灸法】

刺法：向内斜刺（因其内侧的肌肉较丰厚，较为安全）0.5～1 寸，局部有酸胀感，可向肋间放散。本穴不可深刺，直刺和向外斜刺（穴区深面及外侧部肌肉较薄）易经肋间隙刺穿胸壁，造成气胸，故宜注意。

灸法：艾炷灸 5～7 壮，艾条悬灸或温针灸 10～20 分钟。

风 门 (BL12)

【标准定位】 在背部，当第 2 胸椎棘突下，旁开 1.5 寸。

【简易定位法】 取法类似大杼，从第 7 颈椎往下推 2 个椎骨，其棘突下旁开 2 横指处即是。

【刺灸法】

刺法：向内斜刺 0.5～1 寸，局部有酸胀感，可向肋间放散。本穴不可深刺，以免造成气胸。

灸法：艾炷灸 5～7 壮，艾条悬灸或温针灸 10～20 分钟，或药物天灸。若强身保健，则温灸至局部皮肤温热舒适或稍见红晕为度，每日 1 次。

肺 俞 (BL13)

【标准定位】 在背部，当第 3 胸椎棘突下，旁开 1.5 寸。

【简易定位法】 取法类似大杼，从第 7 颈椎往下推 3 个椎骨，其棘突下双侧旁开 2 横指处即是。

【刺灸法】

刺法：向内斜刺 0.5～1 寸，局部有酸胀感，可向肋间放散。本穴不可深刺，以免导致气胸。

灸法：艾炷灸 5～9 壮，艾条悬灸或温针灸 10～20 分钟，或药物天灸。若强身保健，则温灸至皮肤稍见红晕或隔姜盐（3～7 壮），每日 1 次。

心 俞 (BL15)

【标准定位】 在背部，当第5胸椎棘突下，旁开1.5寸。

【简易定位法】 病人俯坐位，由平双肩胛骨下角的椎骨（第7胸椎）往上推两个椎骨，其棘突下双侧各旁开2横指处即是。

【刺灸法】

刺法：向内斜刺0.5~1寸，局部有酸胀感，可向肋间扩散。本穴不可深刺，以免导致气胸。

灸法：艾炷灸5~7壮，艾条悬灸或温针灸10~20分钟，或药物天灸。若强身保健，则温灸至皮肤稍见红晕为度，每日1次。

膈 俞 (BL17)

【标准定位】 在背部，当第7胸椎棘突下，旁开1.5寸。

【简易定位法】 病人正坐位或俯卧位，从肩胛骨下角水平摸到第7胸椎，由其棘突下旁开2横指处即是。

【刺灸法】

刺法：向内斜刺0.5~1寸，局部有酸胀感，可向肋间扩散。本穴不可深刺，以免导致气胸。

灸法：艾炷灸5~9壮，艾条悬灸或温针灸10~20分钟，或药物天灸。若强身保健，则温灸至皮肤温热舒适为度，每日1次；若治疗血液病，多采用累计灸法。

肝 俞 (BL18)

【标准定位】 在背部，当第9胸椎棘突下，旁开1.5寸。

【简易定位法】 取穴类似膈俞，由第7胸椎再向下摸两个椎骨，其棘突下双侧各旁开2横指处即是。

【刺灸法】

刺法：向内斜刺0.5~1寸，局部有酸胀感，可向肋间扩散。本穴不可深刺，以免导致气胸。

灸法：艾炷灸5~9壮，艾条悬灸或温针灸10~20分钟。若强身保健，则温灸至局部温热舒适，皮肤稍见红晕为度，每日1次。

胆 俞 (BL19)

【标准定位】 在背部，当第10胸椎棘突下，旁开1.5寸。

【简易定位法】 取法类似膈俞，由第7胸椎再向下摸3个椎骨（即第10胸椎），其棘突下双侧各旁开2横指处即是。

【刺灸法】

刺法：向内斜刺0.5~1寸，局部有酸胀感，可向肋间扩散。本穴不可深刺，以免导致气胸。

灸法：艾炷灸5~9壮，艾条悬灸或温针灸10~20分钟，或药物天灸。若强身保健，则温灸至皮肤温热舒适为度，每日1次；若治疗肝胆病，则多采用累计灸法。

脾 俞 (BL20)

【标准定位】 在背部，当第11胸椎棘突下，旁开1.5寸。

【简易定位法】 与肚脐中相对应处即为第2腰椎（参考命门穴定位法），由此往上摸3个椎骨，即为第11胸椎，其棘突下双侧各旁开2横指处即是。

【刺灸法】

刺法：向内斜刺0.5~1寸，局部有酸麻胀感，并向腰部扩散。本穴针刺时要注意掌握好角度、方向和深度，以防刺穿胸壁导致气胸，或者伤及肝脏、肾脏等重要器官。

灸法：艾炷灸5~9壮，艾条悬灸或温针灸10~20分钟。若强身保健，则温灸至局部温热舒适为度，每日1次，或采用累计灸百余壮。

胃 俞 (BL21)

【标准定位】 在背部，当第12胸椎棘突下，旁开1.5寸。

【简易定位法】 取穴法类似脾俞，从第2腰椎向上摸两个椎骨，即为第12胸椎，由其棘突下双侧各旁开2横指处即是。

【刺灸法】

刺法：向内斜刺0.5~1寸，局部有酸麻胀感，并可向腰部及

腹部放散。本穴的深面为腹后壁，与肝、肾等器官较邻近，深刺或向外斜刺过深时易伤及，故不宜深刺。

灸法：艾炷灸 5~9 壮，艾条悬灸或温针灸 10~20 分钟。若强身保健，则温灸至皮肤温热舒适为度，每日 1 次。

三 焦 俞 (BL22)

【标准定位】 在腰部，当第 1 腰椎棘突下，旁开 1.5 寸。

【简易定位法】 取穴法类似脾俞，由第 2 腰椎向上摸 1 个椎骨，即为第 1 腰椎，由其棘突下双侧各旁开 2 横指处即是。

【刺灸法】

刺法：直刺 0.5~1 寸，局部有酸胀麻感，并可向腰部及腹部放射。本穴针刺时针尖不宜向外侧深刺，以防刺穿腹腔后壁面损伤肾脏。

灸法：艾炷灸 5~7 壮，艾条悬灸或温针灸 10~20 分钟。

肾 俞 (BL23)

【标准定位】 在腰部，当第 2 腰椎棘突下，旁开 1.5 寸。

【简易定位法】 与肚脐中相对应的椎体即为第 2 腰椎（参考命门穴定位法），由其棘突下旁开双侧各 2 横指处即是。

【刺灸法】

刺法：直刺 1~1.5 寸，局部有酸麻胀感，可有麻电感向臀部及下肢放散。本穴不宜深刺，因穴位深面与肝、肾等器官较邻近，故针刺过深时易伤及这些器官。

灸法：艾炷灸 5~9 壮，艾条悬灸或温针灸 10~20 分钟，或药物天灸。若强身保健，则采用疤痕灸，每年 1 次，或隔附子饼灸 5~7 壮，或温灸至皮肤稍见红晕，每日 1 次，或累计灸百余壮。

大 肠 俞 (BL25)

【标准定位】 在腰部，当第 4 腰椎棘突下，旁开 1.5 寸。

【简易定位法】 病人髂嵴最高点之连线与脊柱之交点即为第 4 腰椎，其棘突下旁开双侧 2 横指处即是。

【刺灸法】

刺法：①直刺1~2寸（治疗腰腿疾病多用），局部有酸胀感，并可有麻电感向臀部及下肢放散；②向下平刺2~2.5寸（治疗骶髂关节炎多用），透向小肠俞，局部有酸胀麻感，可扩散至骶髂关节。

灸法：艾炷灸5~9壮，艾条悬灸或温针灸10~20分钟，或药物天灸。若强身保健，则温灸至皮肤稍见红晕为度，每日1次。

关 元 俞 (BL26)

【标准定位】 在腰部，当第5腰椎棘突下，旁开1.5寸。

【简易定位法】 定位法类似大肠俞，由第4腰椎往下推1个椎骨，即为第5腰椎，其棘突下旁开双侧2横指处即是。

【刺灸法】

刺法：直刺1.5~2.5寸，局部有酸胀感，可有麻电感向下肢放散。

灸法：艾炷灸5~7壮，艾条悬灸或温针灸10~20分钟。若强身保健，则温灸至皮肤稍见红晕为度，每日1次。

小 肠 俞 (BL27)

【标准定位】 在骶部，当骶正中嵴旁1.5寸，平第1骶后孔。

【简易定位法】 病人俯卧位，先摸骶后上棘内缘，其与背脊正中线之间为第1骶后孔，平齐该孔的椎体为第1骶椎，由此旁开双侧2横指处即是。

【刺灸法】

刺法：①直刺1~1.5寸（治疗腰骶痛多用），局部有酸胀感；②向下斜刺1.5~2.5寸（治疗骶髂关节炎和盆腔疾患多用），使酸胀麻感扩散至骶髂关节。

灸法：艾炷灸5~7壮，艾条悬灸或温针灸10~20分钟。

膀胱俞 (BL28)

【标准定位】 在骶部，当骶正中嵴旁 1.5 寸，平第 2 骶后孔。

【简易定位法】 病人俯卧位，先摸到髂后上棘内缘下，其与背脊正中线之间为第 2 骶后孔，平齐该孔的椎体为第 2 骶椎，由此旁开双侧 2 横指处即是。

【刺灸法】

刺法：直刺 1~1.5 寸，局部有酸胀感，可向臀部扩散。

灸法：艾炷灸 5~7 壮，艾条悬灸或温针灸 10~20 分钟。若强身保健，则温灸至皮肤稍见红晕为度，每日 1 次。

次髎 (BL32)

【标准定位】 在骶部，当髂后上棘内下方，适对第 2 骶后孔处。

【简易定位法】 病人俯卧位，骨盆后面，从髂嵴最高点向内下方骶角两侧循摸一高骨突起，此处即是髂后上棘，与之平齐，骶骨正中突起处是第 1 骶椎棘突，髂后上棘与第 2 骶椎棘突之间则是第 2 骶后孔，即次髎穴。

【刺灸法】

刺法：直刺 1~1.5 寸，局部有酸胀感，可扩散至腰骶部。

灸法：艾炷灸 3~5 壮，艾条悬灸或温针灸 5~10 分钟。

承扶 (BL36)

【标准定位】 在大腿后面，臀下横纹的中点。

【简易定位法】 病人大腿上部后侧，臀部下缘横纹中央。

【刺灸法】

刺法：直刺 2~3 寸，局部有酸胀感，可有麻电感向下肢放散。

灸法：艾炷灸 5~7 壮，艾条悬灸或温针灸 10~20 分钟。

殷 门 (BL37)

【标准定位】 在大腿后面，当承扶与委中的连线上，承扶下6寸。

【简易定位法】 病人仰卧位，取其臀后横纹中点及腘横纹中点的连线之中央，由此往上1横指处即是。

【刺灸法】

刺法：直刺2~3寸，局部有酸胀感，可有麻电感向下肢放射。本穴深部分布有坐骨神经，若刺中后不可反复行提插捻转手法，以免损伤坐骨神经干。

灸法：艾炷灸5~7壮，艾条悬灸或温针灸10~20分钟。

委 阳 (BL39)

【标准定位】 在腘横纹外侧端，当股二头肌腱的内侧。

【简易定位法】 病人俯卧位，其腘横纹的中点向外侧旁开1横指处即是。

【刺灸法】

刺法：直刺1~1.5寸，局部有酸胀感，可向大腿和小腿扩散。

灸法：艾炷灸3~5壮，艾条悬灸或温针灸10~20分钟。该穴不宜行疤痕灸。

委 中 (BL40)

【标准定位】 在腘横纹中点，当股二头肌腱与半腱肌肌腱的中间。

【简易定位法】 病人俯卧位，微屈其膝，腘窝横纹的正中央即是。

【刺灸法】

刺法：①直刺0.5~1寸，局部有酸胀感，可有麻电感传至足底；②三棱针刺破浅表静脉或点刺出血。本穴用三棱针刺破浅静脉放血时，以刺破静脉外侧管壁为度，不要刺入太深，以防刺穿腘动、静脉，造成内出血。

灸法：艾炷灸 5~7 壮，艾条悬灸或温针灸 5~10 分钟。本穴不宜行疤痕灸。

膏 肓 (BL43)

【标准定位】 在背部，当第 4 胸椎棘突下，旁开 3 寸。

【简易定位法】 定穴法类似大杼，从第 7 颈椎往下推 4 个椎体，即为第 4 胸椎，其棘突下双侧旁开 4 横指处即是。

【刺灸法】

刺法：向外斜刺 0.5~0.8 寸，局部有酸胀感，有时可扩散至肩胛部。本穴不可深刺，以免损伤脏肺而致气胸。

灸法：艾炷灸 5~9 壮，艾条悬灸或温针灸 10~20 分钟，或药物天灸。若强身保健，可采用疤痕灸，每年 1 次，或温灸至局部温热舒适为度，每日 1 次，或采用累计灸法百余壮。

志 室 (BL52)

【标准定位】 在腰部，当第 2 腰椎棘突下，旁开 3 寸。

【简易定位法】 病人俯卧位，与其肚脐中相对应的椎体即是第 2 腰椎，其棘突下旁开双侧各 4 横指处即是。

【刺灸法】

刺法：直刺 1~1.5 寸，局部有酸胀感，有时可向臀部放散。本穴不可深刺，免伤肾脏。

灸法：艾炷灸 5~7 壮，温针灸或艾条悬灸 10~20 分钟。

秩 边 (BL54)

【标准定位】 在臀部，平第 4 骶后孔，骶正中嵴旁开 3 寸。

【简易定位法】 病人侧卧位，其脊椎最下端有一高骨即是尾骨，由此向上可以摸到黄豆大小的圆骨即骶角，左右各 1 个，两者下缘连线之中点处有一凹陷，即是腰俞穴，由此穴向双侧水平各旁开 4 横指处即是。

【刺灸法】

刺法：①直刺 2~2.5 寸（治疗坐骨神经痛多用），局部有酸

胀感，可有麻电感向下肢放散；②向内斜刺2~3寸，有酸胀麻电感向外生殖器或肛门放散（治疗泌尿生殖系统疾病、肛周疾病多用）；③平刺2~3寸（治臀肌劳损多用），透向环跳穴。本穴针刺时若刺中坐骨神经，则不可再继续猛力提插，以免刺伤神经干。

灸法：艾炷灸3~5壮，艾条悬灸或温针灸10~20分钟。

承 山 (BL57)

【标准定位】 在小腿后面正中，委中与昆仑之间，当伸直小腿或足跟上提时腓肠肌肌腹下出现尖角凹陷处。

【简易定位法】 病人直立，足尖着地，足跟用力上提，小腿后正中，肌肉紧张而出现“人”字形纹，其“人”字尖下凹陷处即是。

【刺灸法】

刺法：直刺1~2寸，局部酸胀感，可扩散到腘窝，或有麻电感向足底放散。本穴若行深刺时，须防止刺伤胫后动、静脉。

灸法：艾炷灸5~7壮，艾条悬灸或温针灸10~20分钟。

飞 扬 (BL58)

【标准定位】 在小腿后面，当外踝后，昆仑穴直上7寸，承山外下方1寸处。

【简易定位法】 病人的腘窝横纹至外踝尖的中点往下方外侧1横指，当小腿腓骨后缘处即是。

【刺灸法】

刺法：直刺1.5~2寸，局部酸麻重胀，可向下传导至踝部。

灸法：艾炷灸3~5壮，艾条悬灸或温针灸10~20分钟。

昆 仑 (BL60)

【标准定位】 在足部外踝后方，当外踝尖与跟腱之间的凹陷处。

【简易定位法】 外踝尖水平线与跟腱外侧的交点，对外踝尖与该交点间的中点即是。

【刺灸法】

刺法：①直刺 0.5~1 寸，透向太溪穴，局部酸胀麻重，并可向足趾放散；②向上斜刺 2~3 寸（治甲状腺肿大多用），透向跗阳穴，局部酸胀，可扩散至足跟部。本穴孕妇禁针。

灸法：艾炷灸 5~9 壮，艾条悬灸或温针灸 10~20 分钟。本穴不宜疤痕灸。

申 脉 (BL62)

【标准定位】 在足外侧部，外踝直下方凹陷中。

【简易定位法】 病人外踝尖直下，外踝下缘凹陷处即是。

【刺灸法】

刺法：直刺 0.3~0.5 寸，局部有酸胀重感。

灸法：艾炷灸 3~5 壮，艾条悬灸 5~10 分钟。本穴不宜疤痕灸。

至 阴 (BL67)

【标准定位】 在足小趾末节外侧，距趾甲角 0.1 寸（指寸）。

【简易定位法】 病人足小趾外侧，由小趾趾甲外侧缘所引一平行线，与其下缘所引一垂直线，这两线的交点即是。

【刺灸法】

刺法：①毫针浅刺 0.1~0.2 寸，局部有胀痛感；②三棱针点刺挤压出血。本穴孕妇禁针。

灸法：艾炷灸 3~5 壮，艾条悬灸 10 分钟。

八、足少阴肾经常用穴

涌 泉 (KI1)

【标准定位】 在足底部，卷足时足前部凹陷处，约当足底 2、3 趾趾缝纹头与足跟连线的前 1/3 与后 2/3 交点上。

【简易定位法】 病人仰卧位或俯卧位，5个足趾屈曲，屈足掌，当足底掌心前面（约足底中线前1/3处）正中之凹陷处即是。

【刺灸法】

刺法：直刺0.5~0.8寸，局部胀痛，可扩散至整个足底部。本穴针刺时要防止刺伤足底动脉弓。

灸法：艾炷灸3~5壮，艾条悬灸5~10分钟，或药物天灸。本穴不宜疤痕灸。

太 溪 (KI3)

【标准定位】 在足内侧，内踝后方，当内踝尖与跟腱之间的凹陷处。

【简易定位法】 病人内踝尖水平线与跟腱内侧的交点，则内踝尖与该交点间的中点即是。

【刺灸法】

刺法：直刺0.5~1寸，可透向昆仑穴，局部有酸胀感，可有麻电感向足底放散。

灸法：艾炷灸5~9壮，艾条悬灸或温针灸10~20分钟。

照 海 (KI6)

【标准定位】 在足内侧，内踝尖下方凹陷处。

【简易定位法】 病人取坐位，由内踝尖往下推，至其下缘凹陷处即是。

【刺灸法】

刺法：直刺0.3~0.5寸，局部有酸胀感，可扩散至整个踝部。本穴针刺时，针尖不宜偏向后侧，以免刺破胫后动、静脉。

灸法：艾炷灸3~5壮，艾条悬灸5~10分钟。本穴一般不行疤痕灸。

复 溜 (KI17)

【标准定位】 在小腿内侧，太溪直上2寸，跟腱的前

方。

【简易定位法】 病人取坐位，足内踝尖与跟腱内侧连线的中点，由此向上2横指处即是。

【刺灸法】

刺法：直刺1~1.5寸，局部有酸胀麻感，可向足底放散。本穴深刺时，须注意避开胫后动、静脉，以防刺破血管。

灸法：艾炷灸3~5壮，艾条悬灸或温针灸10~20分钟，或药物天灸。

阴 谷 (KI10)

【标准定位】 在腘窝内侧，屈膝时，当半腱肌肌腱与半膜肌肌腱之间。

【简易定位法】 病人坐位，屈膝成90°角，膝内高骨（胫骨内侧髁）后缘，腘窝横纹内侧端的两条筋（半膜肌腱、半腱肌腱）之间即是。

【刺灸法】

刺法：直刺1~1.5寸，局部有酸胀感，可扩散至腘窝部。

灸法：艾炷灸3~5壮，艾条悬灸或温针灸10~20分钟。本穴不宜行疤痕灸。

俞 府 (KI27)

【标准定位】 在胸部，当锁骨下缘，前正中线旁开2寸。

【简易定位法】 病人坐位或仰卧位，前正中线与乳头（男性）连线的中点，由此点引一平行线（与前正中线平行）上，锁骨的下缘处即是。

【刺灸法】

刺法：斜刺0.5~0.8寸，局部有酸胀感。该穴不可深刺，以防导致气胸。

灸法：艾炷灸3~5壮，艾条悬灸5~10分钟。

九、手厥阴心包经常用穴

天 池 (PC1)

【标准定位】 在胸部，当第4肋间隙，乳头外1寸，前正中线旁开5寸。

【简易定位法】 病人乳头（男性）所在肋间为第4肋间，在乳头旁开外侧1横指处即是。

【刺灸法】

刺法：向外斜刺0.5~0.8寸，局部有酸胀感。本穴不可深刺，以免伤肺而致气胸。

灸法：艾炷灸3~5壮，艾条悬灸5分钟。

天 泉 (PC2)

【标准定位】 在臂内侧，当腋前纹头下2寸，肱二头肌的长、短头之间。

【简易定位法】 病人垂臂屈肘仰掌，腋前纹头下约2横指，当上臂大骨（肱骨）内侧缘处即是。

【刺灸法】

刺法：直刺0.5~1寸，局部有酸胀感，可扩散至肩部。

灸法：艾炷灸3~5壮，艾条悬灸或温针灸5~10分钟。

曲 泽 (PC3)

【标准定位】 在肘横纹中，当肱二头肌腱的尺侧缘。

【简易定位法】 病人微屈肘部，在其肘关节处可摸及一大筋（即肱二头肌腱），此大筋的内侧与肘横纹的交点即是。

【刺灸法】

刺法：①直刺0.5~1寸，局部酸胀，有麻电感向前臂发散至指端；②用三棱针刺破浅表静脉放血。本穴针刺时要注意避开肱动、静脉，以防损伤血管。

灸法：艾炷灸3~5壮，艾条悬灸或温针灸10~20分钟。

郄 门 (PC4)

【标准定位】 在前臂掌侧，当曲泽与大陵的连线上，腕横纹上 5 寸。

【简易定位法】 病人仰掌微屈腕，在掌后第 1 横纹上可见两条大筋，取肘横纹与腕横纹之中点，由此向下 1 横指，当在这两筋处即是。

【刺灸法】

刺法：直刺 1~1.5 寸，局部有酸胀感，可有麻电感向指端放散。

灸法：艾炷灸 3~5 壮，艾条悬灸或温针灸 10~20 分钟。

间 使 (PC5)

【标准定位】 在前臂掌侧，当曲泽与大陵的连线上，腕横纹上 3 寸，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间。

【简易定位法】 病人仰掌，微屈腕关节，从掌后第 1 横纹上 4 横指，当两条大筋之间处即是。

【刺灸法】

刺法：直刺 0.5~1 寸，深刺可透向支沟穴，局部有酸胀感，可见麻电感向指端放散。

灸法：艾炷灸 3~5 壮，艾条悬灸或温针灸 10~20 分钟。

内 关 (PC6)

【标准定位】 在前臂掌侧，当曲泽与大陵的连线上，腕横纹上 2 寸，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间。

【简易定位法】 病人仰掌，微屈腕关节，从掌后第 1 横纹上约 2 横指，当两条大筋之间即是。

【刺灸法】

刺法：直刺 0.5~1.5 寸，深刺透向外关穴，局部有酸胀麻重感，可见麻电感向指端或肘、胸部放散。

灸法：艾炷灸 5~7 壮，艾条悬灸或温针灸 10~20 分钟。该

穴不宜行疤痕灸。

大 陵 (PC7)

【标准定位】 在腕掌横纹的中点处，当掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间。

【简易定位法】 病人仰掌，微屈腕关节，在掌后第1横纹上，当所出现两筋之间即是。

【刺灸法】

刺法：①直刺0.3~0.5寸，或向后斜刺1.5~2寸，透向外关穴，局部有酸胀感，可向上扩散至肘、腋部，向下扩散至指端；②用三棱针点刺出血。

灸法：艾炷灸3~5壮，艾条悬灸或温针灸10~20分钟。本穴不宜行疤痕灸。

劳 宫 (PC8)

【标准定位】 在手掌心，当第2、3掌骨之间偏于第3掌骨，握拳屈指时中指尖处。

【简易定位法】 病人半握拳，食、中、无名、小指4指轻压掌心，当中指与无名指两指间即是。

【刺灸法】

刺法：直刺0.3~0.5寸，局部有酸胀感，可扩散至整个手掌。本穴孕妇慎刺。

灸法：艾条悬灸5分钟。本穴极少用灸法。

中 冲 (PC9)

【标准定位】 在手中指末节尖端中央。

【简易定位法】 病人手中指指尖端的中央，距离指甲约1分（1粒米大小）处即是。

【刺灸法】

刺法：①用毫针浅刺0.1~0.2寸，局部有胀痛感；②用三棱针点刺挤压出血。

灸法：艾炷灸 3～5 壮，艾条悬灸 5～10 分钟。

十、手少阳三焦经常用穴

关 冲 (SJ1)

【标准定位】 在手环指末节尺侧，距指甲角 0.1 寸（指寸）。

【简易定位法】 病人伏掌于台面，在无名指的外侧（尺侧），沿无名指底部所引一平行线，与外侧缘所引垂线之交点处即是。

【刺灸法】

刺法：①用毫针浅刺 0.1～0.2 寸，局部有胀痛感；②用三棱针点刺挤压出血。

灸法：艾炷灸 3～5 壮，艾条悬灸 10 分钟。

中 渚 (SJ3)

【标准定位】 在手背部，当环指本节（掌指关节）的后方，第 4、5 掌骨间凹陷处。

【简易定位法】 病人握拳俯掌，在其手背第 4、5 掌骨小头之间，掌指关节后方凹陷处即是。

【刺灸法】

刺法：①直刺 0.3～0.5 寸，局部有酸胀感，可有麻电感向指端放散；②向上斜刺 0.5～1 寸，局部酸胀，可向腕部扩散。

灸法：艾炷灸 3～5 壮，艾条悬灸或温针灸 5～10 分钟。本穴不宜行疤痕灸。

阳 池 (SJ4)

【标准定位】 在腕背横纹中，当指总伸肌腱的尺侧缘凹陷处。

【简易定位法】 病人腕关节背面，由第 4 掌骨向上到腕关节横纹处有一凹陷处（即腕部正中筋的尺侧），或简单地说是腕背

横纹中点即是。

【刺灸法】

刺法：①直刺 0.5~0.8 寸，可深透向大陵，局部酸胀；②平刺 0.5~1 寸，向左、右平刺（治腕关节疾病多用），局部酸胀，可扩散至整个手部。

灸法：艾炷灸 3~5 壮，艾条悬灸或温针灸，每日 1 次。

外 关 (SJ5)

【标准定位】 在前臂背侧，当阳池与肘尖的连线上，腕背横纹上 2 寸，尺骨与桡骨之间。

【简易定位法】 病人立掌，腕背横纹中点直上 2 横指，前臂两骨之间处即是。

【刺灸法】

刺法：直刺 0.5~1.5 寸（可透内关穴），或向上斜刺 1.5~2 寸，局部有酸胀感，可有麻电感向指端或肘肩部扩散。

灸法：艾炷灸 3~5 壮，艾条悬灸或温针灸 10~20 分钟。

支 沟 (SJ6)

【标准定位】 在前臂背侧，当阳池与肘尖的连线上，腕背横纹上 3 寸，尺骨与桡骨之间。

【简易定位法】 病人腕背横纹的中点直上 4 横指，前臂两骨（桡骨和尺骨）之间即是。

【刺灸法】

刺法：直刺 1~1.5 寸，局部有酸胀感，可向上扩散至肘部，或有麻电感向指端放散。

灸法：艾炷灸 3~5 壮，艾条悬灸或温针灸 10~20 分钟。

肩 髃 (SJ14)

【标准定位】 在肩部，肩髃后方，当臂外展时，于肩峰后下方呈现凹陷处。

【简易定位法】 病人用力握拳，屈肘，肘尖向前上，用力时

三角肌鼓起，其后下缘凹沟中，当肩峰直下处即是。

【刺灸法】

刺法：①直刺 1.5～2.5 寸，手臂外展，针尖沿肩峰与肱骨大结节之间进针，深刺可透极泉，局部有酸胀感，可扩散至整个关节腔；②向下斜刺 2～3 寸，针尖可向两侧探索，局部有酸胀感，可有向上肢远端放射的触电感。

灸法：艾炷灸 5～7 壮，艾条悬灸或温针灸 10～20 分钟。本穴一般不行疤痕灸。

翳 风 (SJ17)

【标准定位】 在耳垂后方，当乳突与下颌角之间凹陷处。

【简易定位法】 将病人耳垂向后捺，其耳垂的边缘即是。

【刺灸法】

刺法：①直刺 0.5～1 寸（治疗面瘫、腮腺炎多用），耳底有酸胀感，可扩散至舌前部及半侧面部；②向前内下方斜刺 1.5～2 寸，（治聋哑多用），局部有酸胀感，有时可向咽部扩散，使咽部出现发紧发热感。

灸法：艾炷灸 3～5 壮，艾条悬灸和温针灸 5～10 分钟。本穴不宜行疤痕灸。

角 孙 (SJ20)

【标准定位】 在头部，折耳郭向前，当耳尖直上人发际处。

【简易定位法】 将病人耳郭向前折叠，其耳尖直上人发际且与之（耳尖）相平处即是。

【刺灸法】

刺法：平刺 0.3～0.5 寸，局部有酸胀感，可扩散至耳周。

灸法：艾条悬灸 5～10 分钟或灯草灸。

耳 门 (SJ21)

【标准定位】 在面部，当耳屏上切迹的前方，下颌骨髁突后缘，张口有凹陷处。

【简易定位法】 病人耳屏上切迹之前方与下颌髁状突稍上方之凹陷处，张口用手掐切时有一凹陷，闭口时穴位关闭，该处即是。

【刺灸法】

刺法：张口，直刺 0.5～1 寸，局部有酸胀感，可扩散至半侧面部。

灸法：艾条悬灸或温针灸 10～20 分钟。本穴一般不施艾炷灸。

丝 竹 空 (SJ23)

【标准定位】 在面部，当眉梢凹陷处。

【简易定位法】 病人眉毛外端，略入眉毛处即是。

【刺灸法】

刺法：①向后沿皮平刺 0.5～0.8 寸，局部有酸胀感；②用三棱针点刺出血。

灸法：艾条悬灸 5～10 分钟。若美容除皱，则温灸至局部温热舒适为度，每日 1 次。本穴不宜行艾炷灸。

十一、足少阳胆经常用穴

瞳 子 髎 (GB1)

【标准定位】 在面部，目外眦旁，当眶外侧缘处。

【简易定位法】 病人侧卧位，由其眼外角向外循摸，在眼眶骨外侧缘有一凹陷处，距眼外角 5 分处即是。

【刺灸法】

刺法：向后方平刺 0.5～1 寸，可透向太阳穴，局部有酸胀感，可放散至耳道。

灸法：艾条悬灸 5～10 分钟。若美容除皱，则温灸至皮肤温热舒适为度，每日 1 次。本穴不宜行疤痕灸。

听 会 (GB2)

【标准定位】 在面部，当耳屏间切迹的前方，下颌骨髁突的后缘，张口有凹陷处。

【简易定位法】 先取听宫穴，由它直下，耳屏微前下凹陷处，与耳屏间切迹相平，用手掐按，该处张口时有一凹陷，闭口时则穴位关闭，该处即是。

【刺灸法】

刺法：张口，直刺 0.5~1 寸，局部酸胀感。

灸法：艾条悬灸或温针灸 10~20 分钟。本穴不宜艾炷灸，且灸法一般少用。

率 谷 (GB8)

【标准定位】 在头部，当耳尖直上人发际 1.5 寸，角孙直上方。

【简易定位法】 病人正坐平视，用同侧食、中指将耳郭卷起，对侧手臂绕头颅后侧至取穴侧耳尖，食、中指并拢，其第 1、2 节间背侧横纹垂直于耳尖，于中指第 1、2 节间背侧横纹颞处即是。

【刺灸法】

刺法：平刺 0.5~1 寸，局部有酸胀感，可扩散至颞侧头部。

灸法：艾条悬灸 5~10 分钟。本穴不宜施艾炷灸。

阳 白 (GB14)

【标准定位】 在前额部，当瞳孔直上，眉上 1 寸。

【简易定位法】 病人正坐，平视前方，由眉毛中点直上 1 横指处即是。

【刺灸法】

刺法：平刺 1~1.5 寸，或向下透鱼腰，或向左右透攒竹、丝竹空，局部有酸胀感，可扩散至头顶部或眼眶。

灸法：艾炷灸 3~5 壮，艾条悬灸 5~10 分钟。若美容除皱，

则温灸至局部皮肤温热舒适为度，每日1次。本穴不宜行疤痕灸。

风 池 (GB20)

【标准定位】 在项部，当枕骨之下，与风府相平，胸锁乳突肌与斜方肌上端之间的凹陷处。

【简易定位法】 病人俯伏坐位，医者以拇食两指从枕骨粗隆两侧向下推按，当至枕骨下缘凹陷处与乳突之间，即斜方肌与胸锁乳突肌之间，用力按有酸胀麻感处即是。

【刺灸法】

刺法：①向对侧眼内眦方向直刺0.5~1寸，局部有酸胀感，并向头顶、颞部、前额和眼扩散；②平刺2~3寸，透向对侧风池穴，局部有酸胀感，并可扩散至头顶部。本穴施术时一定要慎重，直刺时其深度不超过1.2寸较为安全，且针刺方向不宜朝向对侧眼外眦（因其深面一般正对延髓），或偏向同侧眼内眦（因其深面一般正对同侧的椎动脉），以防导致意外发生。

灸法：温针灸或艾条悬灸10~20分钟，该穴不宜施艾炷直接灸。

肩 井 (GB21)

【标准定位】 在肩上，前直乳中，当大椎与肩峰端连线的中点上。

【简易定位法】 病人坐位低头，其项后上背部脊柱最上方突起之椎骨为第7颈椎，它的下缘凹陷处即为大椎穴，大椎与肩峰最高点连线之中点即是。

【刺灸法】

刺法：向后斜刺0.5~0.8寸，局部有酸胀感，并可扩散至肩部。本穴不可深刺，以防刺伤肺尖，导致气胸。

灸法：艾炷灸3~7壮，艾条悬灸10~20分钟。

日 月 (GB24)

【标准定位】 在上腹部，当乳头直下，第7肋间隙，前正中

线旁开4寸。

【简易定位法】 病人仰卧位，由乳头直下，与肋弓上缘之交点，即当第7、8肋软骨之间处即是。

【刺灸法】

刺法：斜刺0.5~0.8寸，局部有酸胀感，可扩散至胸肋部。因本穴部位胸壁较薄，深面又有重要脏器（右侧有肝脏，左侧有胃），所以不宜直刺或深刺，以免损伤肝、胃或造成气胸。

灸法：艾炷灸3~7壮，艾条悬灸10~20分钟。

京 门 (GB25)

【标准定位】 在侧腰部，章门后1.8寸，当第12肋骨游离端的下方。

【简易定位法】 病人侧卧位，先找到第1腰椎棘突下，由此作一水平线向胁、腹部延伸，取其与腋中线之交点，这一交点与第1腰椎棘突下之间连线之外1/3与内2/3（内指接近正中线处，外指两侧远离前后正中线处）的交点即是。

【刺灸法】

刺法：斜刺0.5~1寸，局部有酸胀感，可扩散至腰背部。本穴操作时要掌握好针刺的方向、角度及深度，以防损伤肾脏。

灸法：艾炷灸5~9壮，艾条悬灸10~20分钟。

带 脉 (GB26)

【标准定位】 在侧腹部，章门下1.8寸，当第11肋骨游离端下方垂线与脐水平线的交点上。

【简易定位法】 病人仰卧位，其腋中线与通过脐中的水平线交叉点即是。

【刺灸法】

刺法：直刺1~1.5寸，局部有酸胀感，并可扩散至侧腰部。本穴不宜深刺，切忌猛力快速提插，以防刺破肠管。

灸法：艾炷灸5~7壮，艾条悬灸或温针灸10~20分钟。

环 跳 (GB30)

【标准定位】 在股外侧部，侧卧屈股，当股骨大转子最凸点与髂管裂孔连线的外1/3与中1/3交点处。

【简易定位法】 病人侧卧位，嘱其下面的腿伸直、上面的腿弯曲，以拇指指关节横纹，按在大转子头上，拇指指向脊柱，当拇指尖所指处即是。

【刺灸法】

刺法：直刺（向外生殖器方向或髋关节方向）2~3寸，局部酸胀，有麻电感向下肢放射。该穴深刺至坐骨神经干，可引起触电样放射感，故不宜长期反复刺激，以免损伤神经干。

灸法：艾炷灸5~7壮，艾条悬灸或温针灸10~20分钟。

风 市 (GB31)

【标准定位】 在大腿外侧部的中线上，当膕横纹上7寸。

【简易定位法】 病人直立，两肩水平，两手下垂，大腿外侧正中线上，当中指尖端所到之处即是。

【刺灸法】

刺法：直刺1.5~2.5寸，局部有酸胀感，可向下扩散。

灸法：艾炷灸3~5壮，艾条悬灸或温针灸10~20分钟。

膝 阳 关 (GB33)

【标准定位】 在膝外侧，当阳陵泉上3寸，股骨外上髁上方的凹陷处。

【简易定位法】 病人取坐位，屈膝成90°角，膝上外侧突起之高骨即股骨外上髁的上方凹陷处，当股骨后大筋（股二头肌腱）前处即是。

【刺灸法】

刺法：直刺1~2寸，局部有酸胀感，并可扩散至膝部或大腿外侧。

灸法：艾炷灸3~5壮，艾条悬灸或温针灸10~20分钟。本

穴不宜行疤痕灸。

阳 陵 泉 (GB34)

【标准定位】 在小腿外侧，当腓骨头前下方凹陷处。

【简易定位法】 病人取坐位，屈膝成 90°角，膝关节外下方，腓骨小头前缘与下缘交叉处有一凹陷即是。

【刺灸法】

刺法：①直刺 1~3 寸，深刺可透阴陵泉，局部有酸胀感；②向后下方斜刺 1~2 寸，局部酸胀，有麻电感向足背部放射。

灸法：艾炷灸 5~7 壮，艾条悬灸或温针灸 10~20 分钟，或药物天灸。若强身保健，则温灸至皮肤温热舒适为度，每日 1 次。

光 明 (GB37)

【标准定位】 在小腿外侧，当外踝尖上 5 寸，腓骨前缘。

【简易定位法】 病人站位，从腓横纹与外踝尖连线（16 寸）分成 4 等分，由下 1/4 向上量 1 横指（拇指），当腓骨前缘处即是。

【刺灸法】

刺法：直刺 0.5~1 寸，局部有酸胀感，可向膝关节或足背外侧扩散。本穴深刺时，须注意避免刺伤胫前动、静脉，以防造成出血。

灸法：艾炷灸 3~5 壮，艾条悬灸或温针灸 10~20 分钟。

悬 钟 (GB39)

【标准定位】 在小腿外侧，当外踝尖上 3 寸，腓骨前缘。

【简易定位法】 病人坐位或立位，由其外踝尖直上量 4 横指，当腓骨前缘处即是。

【刺灸法】

刺法：直刺 1~2 寸，深刺可透三阴交，局部有酸胀感，可向足底发散。

灸法：艾炷灸 5~7 壮，艾条悬灸或温针灸 10~20 分钟。若

强身保健，可采用疤痕灸，每年1次，或温灸至皮肤温热舒适为度，每日1次。

侠 溪 (GB43)

【标准定位】 在足背外侧，当第4、5趾间，趾蹼缘后方赤白肉际处。

【简易定位法】 足背部，当第4、5足趾缝纹端赤白肉际处即是。

【刺灸法】

刺法：向上斜刺0.5~0.8寸，局部有酸胀感。

灸法：艾炷灸3~5壮，艾条悬灸或温针灸5~10分钟。本穴不宜疤痕灸。

足 窍 阴 (GB44)

【标准定位】 在足第4趾末节外侧，距趾甲角0.1寸。

【简易定位法】 病人第4足趾外侧，由趾甲根正中至趾关节外侧上作一“田”字，“田”字的中央即是。

【刺灸法】

刺法：①毫针浅刺0.1~0.2寸，局部胀痛；②用三棱针点刺挤压出血。

灸法：艾炷灸1~3壮，艾条悬灸5~10分钟。

十二、足厥阴肝经常用穴

大 敦 (LR1)

【标准定位】 在足大趾末节外侧，距趾甲角0.1寸。

【简易定位法】 病人足大脚趾外侧，由趾甲根正中至趾关节外侧上作一“田”字，“田”字的中央即是。

【刺灸法】

刺法：①毫针浅刺0.1~0.2寸，局部有胀痛感；②用三棱针

点刺挤压出血。

灸法：艾炷灸 1~3 壮，艾条悬灸 5~10 分钟。

行 间 (LR2)

【标准定位】 在足背侧，当第 1、2 趾间，趾蹼缘的后方赤白肉际处。

【简易定位法】 在病人足背内侧，第 1、2 两趾之间连接处之缝纹头即是。

【刺灸法】

刺法：向上斜刺 0.5~0.8 寸，局部有酸胀感，可扩散至足背。

灸法：艾炷灸 3~5 壮，艾条悬灸或温针灸 5~10 分钟。本穴不宜疤痕灸。

太 冲 (LR3)

【标准定位】 在足背侧，当第 1 跖骨间隙的后方凹陷处。

【简易定位法】 病人足背，由第 1、2 趾间缝纹头向足背上推，至其两骨联合前缘凹陷中（约缝纹头上 2 横指）处即是。

【刺灸法】

刺法：向上斜刺 0.5~1 寸或向外下（透涌泉）斜刺 1~1.5 寸，局部有酸胀感，有时会出现麻电感向足底放散。本穴深透涌泉时，不宜猛力提插，以免损伤足底动、静脉。

灸法：艾炷灸 3~5 壮，艾条悬灸或温针灸 10~20 分钟。本穴一般不行疤痕灸。

中 封 (LR4)

【标准定位】 在足背侧，当足内踝前，商丘与解溪连线之间，胫骨前肌腱的内侧凹陷处。

【简易定位法】 病人仰卧位，足跟用力蹬，足背内侧上可见一大筋（即胫骨前肌腱），其内侧位于足关节内侧（内踝）前下方处之凹陷即是。

【刺灸法】

刺法：直刺 0.5~1 寸，局部有酸胀感。

灸法：艾炷灸 3~5 壮，艾条悬灸或温针灸 5~10 分钟，本穴不宜疤痕灸。

蠡 沟 (LR5)

【标准定位】 在小腿内侧，当足内踝尖上 5 寸，胫骨内侧面的中央。

【简易定位法】 取腓横纹至内踝尖之中点，再由此向下 4 横指，当胫骨内侧面正中即是。

【刺灸法】

刺法：平刺 0.5~1 寸，局部有酸胀感，可扩散至前阴部。

灸法：艾炷灸 3~5 壮，艾条悬灸 5~10 分钟。本穴一般不行疤痕灸。

曲 泉 (LR8)

【标准定位】 在膝内侧，屈膝，当膝关节内侧面横纹内侧端，股骨内侧面髁的后缘，半腱肌、半膜肌止端的前缘凹陷处。

【简易定位法】 病人正坐屈膝，当膝内侧高骨（股骨内上髁）后缘，位于两筋前方，腓横纹头上方处即是。

【刺灸法】

刺法：直刺 1~1.5 寸，局部有酸胀感，可扩散至膝关节，或有麻电感向下传导。

灸法：艾炷灸 3~5 壮，艾条悬灸或温针灸 10~20 分钟。本穴不宜疤痕灸。

章 门 (LR13)

【标准定位】 在侧腹部，当第 11 肋游离端的下方。

【简易定位法】 病人仰卧位，由脐上 2 横指、乳头旁外 2 横指各作一水平线及垂直线，这两条直线的交点即是。

【刺灸法】

刺法：斜刺 0.5~1 寸，侧腹部有酸胀感，并可向腹后壁传导。

本穴不可深刺，尤其是对肝脾肿大病人，以防刺伤肝、脾、结肠。

灸法：艾炷灸 5~7 壮，艾条悬灸 10~20 分钟，或药物天灸。

期 门 (LR14)

【标准定位】 在胸部，当乳头直下，第 6 肋间隙，前正中线旁开 4 寸。

【简易定位法】 病人取仰卧位，由乳头直下往下数两根肋骨处即是。

【刺灸法】

刺法：斜刺 0.5~0.8 寸，局部有胀痛感，可向腹后壁放散。本穴操作时要慎重，掌握好针刺的方向、角度和深度，以免刺伤肝、胃和造成气胸。

十三、任脉常用穴

会 阴 (RN1)

【标准定位】 在会阴部，男性当阴囊根部与肛门连线的中点，女性当大阴唇后联合与肛门连线的中点。

【简易定位法】 病人仰卧位，分开大腿部，取肛门上缘与阴囊根部（女性取大阴唇下缘联接处）之中点即是。

【刺灸法】

刺法：直刺 0.5~1 寸，局部有胀痛感，可扩散至前后二阴。本穴针前宜嘱病人排空大小便，且不宜深刺，以防损伤盆腔内臓器。孕妇应慎用本穴。

灸法：艾炷灸 3~5 壮，艾条悬灸或温针灸 5~10 分钟。本穴不宜行疤痕灸。

中 极 (RN3)

【标准定位】 在下腹部，前正中线上，当脐中下 4 寸。

【简易定位法】 病人仰卧位，前正中线延长至下腹部之耻骨

联合处，由耻骨联合上1横指（拇指）即是。

【刺灸法】

刺法：直刺0.5~1寸，局部有酸胀感，可放散至外生殖器及会阴部。本穴针刺前应嘱病人排空膀胱，并缓慢下针，以防刺伤膀胱及肠管。

灸法：艾炷灸5~9壮，艾条悬灸或温针灸10~20分钟，或药物灸。

关 元 (RN4)

【标准定位】 在下腹部，前正中线上，当脐中下3寸。

【简易定位法】 病人仰卧位，前正中线上，肚脐正中直下4横指处即是。

【刺灸法】

刺法：直刺0.5~1寸，局部有酸胀感，可放散至外生殖器和会阴部。本穴针刺前应嘱病人排空膀胱，并缓慢进针，切忌猛力快速提插，以防刺伤膀胱和小肠。

灸法：艾炷灸5~9壮，艾条悬灸或温针灸10~20分钟，或药物天灸。若强身保健，可采用疤痕灸，每年1次，或温灸至局部温热舒适为度，每日1次，亦可用累计灸百余壮。

气 海 (RN6)

【标准定位】 在下腹部，前正中线上，当脐中下1.5寸。

【简易定位法】 病人仰卧位，前正中线上，肚脐正中直下两横指（约1.5寸）处即是。

【刺灸法】

刺法：直刺0.5~1寸，局部有酸胀感，可放散至外生殖器和会阴部。本穴针刺前应嘱病者排空膀胱，并缓慢进针，切忌猛力快速提插，以防刺伤小肠。

灸法：艾炷灸5~9壮，艾条悬灸或温针灸10~20分钟，或药物天灸。若强身保健，可采用疤痕灸，每年1次，或温灸至局部温热舒适为度，每日1次，亦可采用累计灸百余壮。

神 阙 (RN8)

【标准定位】 在腹中部，脐中央。

【简易定位法】 病人仰卧位，肚脐中央即是。

【刺灸法】

刺法：本穴禁针。

灸法：艾炷灸 5~9 壮，艾条悬灸 10~20 分钟，或药物天灸。若强身保健，则宜隔盐或隔姜灸 5~9 壮，或温灸至局部温热舒适为度，每日 1 次。本穴禁用直接灸。

水 分 (RN9)

【标准定位】 在上腹部，前正中线上，当脐中上 1 寸。

【简易定位法】 病人仰卧位，前正中线上，肚脐正中直上 1 横指（拇指）处即是。

【刺灸法】

刺法：直刺 0.5~1 寸。局部有酸胀感。本穴针刺时要缓慢进针，切忌猛力快速提插，以防刺伤小肠。

灸法：艾炷灸 3~5 壮，艾条悬灸或温针灸 10~20 分钟。

下 脘 (RN10)

【标准定位】 在上腹部，前正中线上，当脐中上 2 寸。

【简易定位法】 病人仰卧位，前正中线上，肚脐正中直上 2 横指处即是。

【刺灸法】

刺法：直刺 0.5~1 寸，局部有酸胀感。该穴不宜深刺，亦忌猛力快速提插，以防刺破胃肠。

灸法：艾炷灸 5~7 壮，艾条悬灸或温针灸 10~20 分钟。

中 脘 (RN12)

【标准定位】 在上腹部，前正中线上，当脐中上 4 寸。

【简易定位法】 病人仰卧位，从肚脐正中与胸骨体下缘两点

之中央即是。

【刺灸法】

刺法：直刺 0.3～0.5 寸，亦可向四周斜刺，上腹部可有胀闷沉重感或胃部有收缩感。若胃充盈时本穴严禁针刺。本穴针刺时要注意掌握好角度和深度，过度深刺易伤及胃、肝。

灸法：艾炷灸 5～9 壮，艾条悬灸或温针灸 10～20 分钟，或药物天灸。若强身保健，可采用疤痕灸，每年 1 次，或温灸至局部皮肤稍见红晕为度，每日 1 次。

上 脘 (RN13)

【标准定位】 在上腹部，前正中线上，当脐中上 5 寸。

【简易定位法】 病人仰卧位，前正中线上，由胸骨体下缘往下 4 横指（3 寸）处即是。

【刺灸法】

刺法：直刺 0.5～1 寸，局部有酸胀感，可扩散至上腹部。本穴针刺时，应避免针尖向上深刺，以防损伤肝胃。

灸法：艾炷灸 5～7 壮，艾条悬灸或温针灸 10～20 分钟。

巨 阙 (RN14)

【标准定位】 在上腹部，前正中线上，当脐中上 6 寸。

【简易定位法】 病人仰卧位，前正中线上，由胸骨体下缘往下 2 横指（约 2 寸）即是。

【刺灸法】

刺法：直刺 0.5～1 寸，局部有酸胀感，可向上或向下扩散。本穴不宜直向深刺，或针尖向上深刺，以防刺入腹腔或胸腔，损伤肝、胃和心脏。

灸法：艾炷灸 5～7 壮，艾条悬灸或温针灸 10～20 分钟。

鸠 尾 (RN15)

【标准定位】 在上腹部，前正中线上，当胸剑结合部下 1 寸。

【简易定位法】 病人仰卧位，前正中线上，由胸骨体下缘往

下1横指（拇指）处即是。

【刺灸法】

刺法：向下斜刺0.5~1寸，局部有酸胀感。因本穴深面是肝脏，上方则膈肌对心脏，故针刺时除不宜深刺，以防刺伤肝脏外，也不可向上斜刺，否则易刺伤心脏而亡。

膻 中 (RN17)

【标准定位】 在胸部，当前正中线上，平第4肋间，两乳头连线的中点。

【简易定位法】 病人仰卧位，两乳头之间中央即是。

【刺灸法】

刺法：针尖向上或向乳房两侧平刺0.3~0.5寸，局部酸胀感或前胸沉重感。

灸法：艾炷灸5~7壮，艾条悬灸10~20分钟。若强身保健，则温灸至皮肤稍见红晕为度，每日1次。

天 突 (RN22)

【标准定位】 在颈部，当前正中线上，胸骨上窝中央。

【简易定位法】 病人仰靠坐位，胸骨上端的凹陷中即是。

【刺灸法】

刺法：①浅刺法，即直刺0.3~0.5寸，儿童宜浅刺；②深刺法（常用），即先直刺约0.3寸后，将针体贴近颈前部皮肤，朝胸骨柄后方，向下缓慢刺入1~1.5寸，病人可有咽喉部紧张感。本穴针刺时要掌握好深度和角度，不可直刺太深，以免刺中气管；也不可向左右两侧斜刺，以免刺中肺前界；更不要偏后深刺，以防伤及主动脉弓等大动脉。

灸法：艾炷灸5~7壮，艾条悬灸10~20分钟，或用灯草灸，或用药物天灸。

廉 泉 (RN23)

【标准定位】 在颈部，当前正中线上，结喉上方，舌骨上缘

凹陷处。

【简易定位法】 医者把拇指指关节横纹放在病人下颏骨中点，拇指指尖正指向喉结部，当拇指尖所到达之处即是。

【刺灸法】

刺法：直刺 0.5~0.8 寸，局部有发胀感，并可扩散至舌部。本穴针刺时不宜久留针，以防因吞咽动作而折针。

灸法：艾条悬灸 10~20 分钟。本穴一般极少采用艾炷灸。

承 浆 (RN24)

【标准定位】 在面部，当颏唇沟的正中凹陷处。

【简易定位法】 病人正坐仰头位，微张口，可见颏唇沟较明显，下唇下方正中之凹陷即是。

【刺灸法】

刺法：向上斜刺 0.3~0.5 寸，局部有酸胀感，可扩散至整个口唇。

灸法：艾炷灸 5~7 壮，艾条悬灸 5~10 分钟。本穴不宜行疤痕灸。

十四、督脉常用穴

长 强 (DU1)

【标准定位】 在尾骨端下，当尾骨端与肛门连线的中点处。

【简易定位法】 病人俯卧位，嘱其翘起臀部，尾骨尖与肛门的中央即是。

【刺灸法】

刺法：①沿尾骨和直肠之间缓慢直刺 0.5~1 寸，局部有酸胀感，并可扩散至肛门；②用三棱针点刺出血。

灸法：艾炷灸 3~5 壮，艾条悬灸 5~10 分钟。本穴不宜疤痕灸。

腰 阳 关 (DU3)

【标准定位】 在腰部，当后正中线上，第4腰椎棘突下凹陷中。

【简易定位法】 病人俯卧位，先摸及两胯骨最高点，平这两个最高点的脊椎即第4腰椎，其棘突下凹陷处即是。

【刺灸法】

刺法：向上斜刺0.5~1.5寸，局部有酸胀感，可有麻电感向双下肢放散。

灸法：艾炷灸5~7壮，艾条悬灸或温针灸10~20分钟。

命 门 (DU4)

【标准定位】 在腰部，当后正中线上，第2腰椎棘突下凹陷中。

【简易定位法】 病人正立，由其肚脐正中作线环绕身体一周，该线与后正中线的交点即是。

【刺灸法】

刺法：稍向上斜刺0.5~0.8寸，局部有酸胀感，可有麻电感向臀部及下肢放散。本穴针刺时若针尖向上斜刺过深，将可能刺伤脊髓，故要慎重小心。

灸法：艾炷灸5~9壮，艾条悬灸或温针灸10~20分钟，或药物天灸。若强身保健，可采用疤痕灸，每年1次，或隔附子饼灸3~5壮，或温灸至皮肤稍见红晕为度，每日1次。

至 阳 (DU9)

【标准定位】 在背部，当后正中线上，第7胸椎棘突下凹陷中。

【简易定位法】 病人正立自然垂臂，平两肩胛骨的下角水平线的椎体为第7胸椎，其棘突下凹陷处即是。

【刺灸法】

刺法：稍向上斜刺0.5~0.8寸，局部有酸胀感，并可向下背

部或前胸部放散。本穴不宜深刺，以防刺伤脊髓。

灸法：艾炷灸 3~5 壮，艾条悬灸或温针灸 10~20 分钟。

大 椎 (DU14)

【标准定位】 在后正中线上，第 7 颈椎棘突下凹陷中。

【简易定位法】 病人坐位低头，项后上背部脊柱最上方突起之椎体为第 7 颈椎（其特点是突起椎体用手按住时能感觉到随颈部左右摇头而活动），其下缘凹陷处即是。

【刺灸法】

刺法：①微斜向上直刺 0.5~1 寸，局部有酸胀感，可向下或向两肩部扩散；②用三棱针点刺挤压出血。本穴不宜过度深刺，有针感即可，以防刺伤脊髓。

灸法：艾炷灸 5~9 壮，艾条悬灸或温针灸 10~20 分钟，或药物天灸。若强身保健，则采用疤痕灸，每年 1 次，或温灸至皮肤稍见红晕为度，每日 1 次。

哑 门 (DU15)

【标准定位】 在项部，当后发际正中直上 0.5 寸，第 1 颈椎下。

【简易定位法】 病人坐位，头伏于桌而，其后发际中央往上 5 分（约 1 个小指横指大小）处即是。

【刺灸法】

刺法：囟病者头微前倾，向下颌方向缓慢斜刺 0.5~1 寸，局部有酸胀感。本穴针刺时要掌握好深度和角度，因本穴深而有脊髓等重要结构，故针刺不宜过深（千万不可超过 1.5 寸），否则易导致脊髓损伤和蛛网膜下腔出血；又因其深面还正对延髓，故针刺时切勿朝鼻的方向，否则易造成延髓损伤。

灸法：本穴极少用灸法。

风 府 (DU16)

【标准定位】 在项部，当后发际正中直上 1 寸，枕外隆凸直

下，两侧斜方肌之间凹陷中。

【简易定位法】 病人坐位，头伏于桌面，其后发际中央直上1横指（拇指）处即是。

【刺灸法】

刺法：囟病者头微前倾，向下颌方向缓慢斜刺0.5~1寸，局部有酸胀感。针刺本穴时要注意深度和角度，进针深度不得超过1.5寸，否则易伤其深面的延髓等重要结构；针刺方向若略朝外侧易刺伤椎动脉，若向喉结方向则易碰在椎骨上而难进针；并严禁大幅度的提插捻转。

灸法：本穴极少用灸法。

百 会 (DU20)

【标准定位】 在头部，当前发际正中直上5寸，或两耳尖连线的中点处。

【简易定位法】 病人将两耳郭向前对折，由两个耳尖连线跨越头顶，其与头部前正中线的交点即是。

【刺灸法】

刺法：向前、后、左、右平刺0.5~1寸，可透四神聪，局部有麻、胀、痛感，可扩散至头顶部。本穴退针后要用于棉球按压针孔片刻，以免出血。

灸法：艾炷灸9~15壮，艾条悬灸10~20分钟。若强身保健，则隔姜灸5~7壮，或温灸至有温热舒适感为度，每日1次。

上 星 (DU23)

【标准定位】 在头部，当前发际正中直上1寸。

【简易定位法】 病人低头，其前发际正中直上1横指（拇指）处即是。

【刺灸法】

刺法：平刺0.5~0.8寸，局部有酸胀感。

灸法：艾炷灸3~5壮，艾条悬灸10分钟。

神 庭 (DU24)

【标准定位】 在头部，当前发际正中直上 0.5 寸。

【简易定位法】 病人低头，其前发际中央直上 1 横指（小指）处即是。

【刺灸法】

刺法：平刺 0.5～0.8 寸，局部有酸胀感。

灸法：艾炷灸 3～5 壮，艾条悬灸 10 分钟。

素 髅 (DU25)

【标准定位】 在面部，当鼻尖的正中央。

【简易定位法】 病人鼻子尖端即是。

【刺灸法】

刺法：①向上斜刺 0.3～0.5 寸，局部有酸麻胀痛感，可向鼻腔和鼻根扩散；②用三棱针点刺挤压出血。

灸法：本穴禁灸。

水 沟 (DU26)

【标准定位】 在面部，当人中沟的上 1/3 与中 1/3 的交点处。

【简易定位法】 病人仰卧位，将其人中沟平分成 3 等分。上 1/3 与下 2/3 之交点处即是。

【刺灸法】

刺法：①向上斜刺 0.5～1 寸，局部胀痛为主，捻转时亦有酸胀感；②三透法，即先向鼻中隔斜刺入 0.5～1 寸，然后将针退至皮下，再向左、右鼻翼方向斜刺，局部胀痛感明显；③用三棱针点刺挤压出血；④用指甲按掐法（常用于没有任何设备面需急救时）。

灸法：本穴禁灸。

图 15

注：腧穴的标准位置（定位）根据中华人民共和国国家标准（GB12346—90）确定（1990—06—07 发布；1991—01—01 实施）。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名= 针灸意外案例选析

作者= 伦新 荣莉

页数= 4 0 8

S S 号= 1 0 0 5 8 3 5 1

出版日期= 1 9 9 7 年 1 0 月第 1 版